Preguntas por código Perfil V3 · respaldo

729 preguntas de práctica agregadas a las clases y 111 del banco para los códigos que ninguna clase enseña. Cubren los códigos del Perfil V3 que no tenían ninguna pregunta. Pendientes de revisión médica. La alternativa correcta va en verde.

Cirugía

1 cirugia-09 · Perfil V3 1.01.5.005 · Intubación traqueal · *Práctica*

Un motociclista de 25 años ingresa tras un choque. Tiene Glasgow de 7 (O1 V2 M4), respiración ruidosa y saturación de 90% con mascarilla de alto flujo. Se mantiene la restricción de movimiento cervical.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía aérea?

A) Mantener la mascarilla de alto flujo y realizar TAC de encéfalo

B) Intubación orotraqueal con secuencia rápida, manteniendo la restricción del movimiento cervical

C) Cánula nasofaríngea y observación

D) Traqueostomía electiva

E) Ventilación no invasiva

> **Respuesta B.** Un Glasgow de 8 o menos indica incapacidad de proteger la vía aérea y es indicación de vía aérea definitiva. En trauma se realiza intubación orotraqueal con secuencia rápida y restricción del movimiento cervical en línea. La ventilación no invasiva está contraindicada con compromiso de conciencia; la vía quirúrgica se reserva si falla la intubación.

2 cirugia-14 · Perfil V3 1.02.4.003 · Albúmina plasmática · *Práctica*

Un hombre de 68 años será operado de una colectomía electiva. Ha bajado 10% de su peso en 3 meses. En el preoperatorio, su albúmina plasmática es 2,6 g/dL, sin proteinuria ni daño hepático.

¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?

A) La albúmina es normal y se opera sin cambios

B) La albúmina refleja cambios nutricionales en 24 horas

C) La albúmina baja indica deshidratación y basta con hidratar

D) Es un marcador de desnutrición y de mayor riesgo de complicaciones: optimizar el estado nutricional antes de la cirugía

E) Indicar infusión de albúmina como tratamiento nutricional

> **Respuesta D.** La hipoalbuminemia sin pérdidas renales ni daño hepático, junto a baja de peso, indica desnutrición y se asocia a más dehiscencias, infecciones y mortalidad postoperatoria. Se recomienda soporte nutricional por 7 a 14 días antes de una cirugía electiva. La albúmina tiene vida media de unos 20 días y su infusión no nutre.

3 cirugia-14 · Perfil V3 1.02.5.002 · Evaluacion nutricional subjetiva · *Práctica*

Un hombre de 66 años será operado de un cáncer gástrico. En la evaluación nutricional subjetiva global refiere baja de peso de 12% en 6 meses, ingesta reducida a la mitad hace 1 mes, náuseas frecuentes y capacidad funcional disminuida; al examen tiene pérdida de grasa subcutánea y de masa muscular temporal.

¿Cómo se clasifica según la evaluación subjetiva global y qué implica?

A) A (bien nutrido): operar sin intervención nutricional

B) B (moderadamente desnutrido): no requiere intervención

C) Requiere exámenes de laboratorio para poder clasificarlo

D) No es aplicable en pacientes oncológicos

E) C (severamente desnutrido): iniciar soporte nutricional preoperatorio

> **Respuesta E.** La evaluación subjetiva global es clínica (anamnesis y examen), sin exámenes: considera cambio de peso, ingesta, síntomas digestivos, capacidad funcional, estrés metabólico y signos físicos. Una baja sobre 10% en 6 meses con pérdida de grasa y músculo clasifica como C, desnutrición severa, y justifica soporte nutricional preoperatorio por 7 a 14 días.

4 cirugia-18 · Perfil V3 1.04.3.002 · Mordeduras de animales · *Práctica*

Hombre de 30 años es mordido en el dorso de la mano por su perro, que está vacunado y es observable. Consulta 3 horas después con dos heridas punzantes de 0,5 cm, sin compromiso tendíneo. Tiene esquema antitetánico completo, con refuerzo hace 3 años.

Además del aseo profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Sutura primaria de las heridas y alta sin antibióticos

B) Vacunación antirrábica inmediata

C) Dejar las heridas abiertas, indicar amoxicilina con ácido clavulánico profiláctica y observar al perro por 10 días

D) Cefadroxilo oral y cierre con adhesivo tisular

E) Inmunoglobulina antitetánica y vacuna antitetánica

> **Respuesta C.** Las mordeduras en la mano y las heridas punzantes tienen alto riesgo de infección, por lo que no se suturan y se indica amoxicilina con ácido clavulánico, que cubre Pasteurella y anaerobios. Con un perro vacunado y observable no se vacuna contra la rabia: se observa al animal 10 días. Con refuerzo antitetánico hace 3 años no requiere profilaxis.

5 cirugia-17 · Perfil V3 1.04.4.002 · Cultivo de heridas o abscesos · *Práctica*

Una mujer de 62 años, diabética, presenta al 6° día postoperatorio una herida abdominal con eritema, induración y salida de pus. Se abre la herida y se drena.

¿Cuál es la forma más adecuada de obtener una muestra para cultivo?

A) Tórula superficial de la piel alrededor de la herida

B) No tomar cultivos en infecciones de herida

C) Cultivo de la gasa del apósito

D) Hemocultivos solamente

E) Aspirado de pus o biopsia de tejido profundo, tras limpiar la superficie

> **Respuesta E.** El cultivo de heridas y abscesos se toma por aspiración del pus o biopsia de tejido profundo, previa limpieza de la superficie con suero, para evitar la flora colonizante de la piel. Las tórulas superficiales y los apósitos dan resultados poco confiables. La muestra se envía rápido al laboratorio, idealmente antes de iniciar antibióticos.

6 cirugia-16 · Perfil V3 1.04.4.012 · Proteína C reactiva · *Práctica*

Un hombre de 60 años cursa su 4° día postoperatorio de una resección de colon con anastomosis. Su PCR fue de 140 mg/L al 2° día y hoy sube a 290 mg/L, con febrícula y taquicardia de 110 por minuto.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Es la respuesta inflamatoria normal a la cirugía y no requiere estudio

B) La PCR solo sirve en infecciones virales

C) Una PCR en ascenso después del 3er día sugiere una complicación infecciosa, como filtración anastomótica, y obliga a estudiar (ej. TAC de abdomen)

D) Indica con certeza un tromboembolismo pulmonar

E) Se debe a la anestesia

> **Respuesta C.** La PCR sube tras cualquier cirugía, con un máximo cercano a las 48 horas, y luego desciende. Si en vez de bajar sigue subiendo entre el 3° y 5° día, sugiere una complicación infecciosa (filtración anastomótica, absceso, infección de herida) y obliga a estudiar, habitualmente con TAC de abdomen y pelvis con contraste.

7 cirugia-10 · Perfil V3 1.05.2.014 · Traumatismo torácico simple · *Práctica*

Un hombre de 45 años cae de su altura y se golpea el hemitórax derecho. Consulta por dolor al respirar. Está hemodinámicamente estable, con saturación de 97% y murmullo pulmonar simétrico. La radiografía muestra fractura no desplazada del 7° arco costal derecho, sin neumotórax ni hemotórax.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Instalación de tubo pleural

B) Vendaje torácico compresivo

C) Analgesia adecuada, ejercicios respiratorios y control ambulatorio con signos de alarma

D) Fijación quirúrgica de la costilla

E) Hospitalización en UCI

> **Respuesta C.** Una fractura costal única sin complicaciones (neumotórax, hemotórax, tórax volante) en un paciente estable es un traumatismo torácico simple. Se maneja en forma ambulatoria con analgesia efectiva, que permite respirar profundo y toser, previniendo atelectasias y neumonía. El vendaje compresivo está contraindicado porque restringe la ventilación.

8 cirugia-09 · Perfil V3 1.05.5.003 · Cricoidostomía · *Práctica*

Un hombre de 30 años ingresa tras un accidente de tránsito con trauma facial grave, fractura mandibular y sangrado orofaríngeo masivo. Está desaturando a 75%, no se logra ventilar con bolsa-mascarilla y fracasan 2 intentos de intubación orotraqueal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Nuevo intento de intubación con un laringoscopio de otro tamaño

B) Traqueostomía reglada en pabellón

C) Cricotiroidotomía quirúrgica de urgencia

D) Intubación nasotraqueal a ciegas

E) Ventilación no invasiva

> **Respuesta C.** La situación de 'no puedo intubar, no puedo oxigenar' indica una vía aérea quirúrgica de urgencia: cricotiroidotomía a través de la membrana cricotiroidea, rápida y con pocas estructuras vasculares. La traqueostomía es más lenta y compleja en urgencia, y la intubación nasotraqueal se evita en trauma facial grave. En menores de 12 años se prefiere la cricotiroidotomía por punción.

9 cirugia-03 · Perfil V3 1.06.1.017 · Enfermedad diverticular no complicada · *Práctica*

Mujer de 62 años, asintomática, se realiza colonoscopía de tamizaje que muestra múltiples divertículos en el colon sigmoides, sin signos inflamatorios ni pólipos. Nunca ha tenido dolor abdominal ni sangrado.

¿Cuál es la recomendación más adecuada?

A) Mesalazina oral de mantención

B) Evitar semillas, nueces y maíz

C) Dieta rica en fibra y actividad física

D) Ciprofloxacino y metronidazol en ciclos mensuales

E) Sigmoidectomía electiva

> **Respuesta C.** La diverticulosis asintomática no requiere tratamiento específico: se recomienda dieta rica en fibra, actividad física y evitar tabaquismo y obesidad. La restricción de semillas y nueces no tiene respaldo. Mesalazina y antibióticos cíclicos no previenen la diverticulitis, y la cirugía electiva no está indicada en la enfermedad no complicada.

10 cirugia-04 · Perfil V3 1.06.4.001 · Radiografía simple de abdomen · *Práctica*

Hombre de 78 años, postrado y con constipación crónica, presenta distensión abdominal marcada, dolor cólico y ausencia de eliminación de gases y deposiciones de 2 días. La radiografía simple de abdomen muestra un asa colónica muy dilatada en forma de U invertida (grano de café), que nace en la pelvis y se proyecta hacia el hipocondrio derecho.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Íleo biliar

B) Vólvulo de ciego

C) Obstrucción de intestino delgado por bridas

D) Megacolon tóxico

E) Vólvulo de sigmoides

> **Respuesta E.** El signo del grano de café, una U invertida que nace de la pelvis, es característico del vólvulo de sigmoides, típico de adultos mayores postrados y constipados. Sin signos de isquemia se intenta la devolvulación endoscópica. El vólvulo de ciego proyecta el asa hacia el hipocondrio izquierdo y el íleo biliar muestra aerobilia.

11 cirugia-12 · Perfil V3 1.10.1.002 · Compromiso de conciencia · *Práctica*

Hombre de 35 años tras un accidente de tránsito: abre los ojos solo ante estímulo doloroso, emite sonidos incomprensibles y retira la extremidad ante el dolor.

¿Cuál es su puntaje en la escala de Glasgow y la conducta respecto de la vía aérea?

A) Glasgow 6; solo ventilación con mascarilla

B) Glasgow 10; observar

C) Glasgow 8; requiere intubación para proteger la vía aérea

D) Glasgow 12; oxígeno por naricera

E) Glasgow 9; cánula orofaríngea y alta

> **Respuesta C.** Apertura ocular al dolor suma 2, sonidos incomprensibles 2 y retiro ante el dolor 4: Glasgow 8. Un Glasgow de 8 o menos define un compromiso de conciencia grave y es indicación de intubación para proteger la vía aérea, con protección de la columna cervical. Luego se realiza TAC de cerebro.

12 cirugia-12 · Perfil V3 1.10.2.009 · Hipertensión endocraneana · *Práctica*

Hombre de 45 años con TEC grave y contusiones cerebrales, intubado. Evoluciona con presión arterial 190/100, frecuencia cardíaca 48, respiración irregular y midriasis derecha arreactiva. Se coordina con neurocirugía.

¿Cuál es la medida inicial más adecuada mientras tanto?

A) Administrar labetalol para normalizar la presión arterial

B) Administrar atropina por la bradicardia

C) Hiperventilar en forma prolongada hasta PaCO2 de 25

D) Realizar punción lumbar para medir la presión

E) Elevar la cabecera a 30 grados, asegurar oxigenación y normoventilación, y administrar manitol o suero hipertónico

> **Respuesta E.** Hipertensión, bradicardia y respiración irregular son la tríada de Cushing, signo de hipertensión endocraneana con herniación inminente. Se trata con cabecera a 30 grados, oxigenación y normoventilación, y osmoterapia con manitol o suero hipertónico. La hipertensión es compensatoria y no se debe bajar; la punción lumbar está contraindicada.

13 cirugia-12 · Perfil V3 1.10.2.020 · Traumatismo encefalocraneano grave · *Práctica*

Mujer de 30 años se golpea la cabeza contra un mueble. No perdió el conocimiento, no ha vomitado, no tiene cefalea intensa ni amnesia. No usa anticoagulantes. Glasgow 15, examen neurológico normal, sin signos de fractura de base de cráneo. Vive acompañada.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar TAC de cerebro sin contraste

B) Alta con indicaciones de signos de alarma y vigilancia por un adulto responsable

C) Solicitar radiografía de cráneo

D) Hospitalizar en observación por 24 horas

E) Solicitar resonancia magnética de cerebro

> **Respuesta B.** TEC leve de bajo riesgo: Glasgow 15, sin pérdida de conciencia, vómitos, amnesia, anticoagulación, edad avanzada ni focalidad. No requiere imágenes: se da de alta con signos de alarma, como cefalea progresiva, vómitos, somnolencia o focalidad, y vigilancia por un adulto. La radiografía de cráneo no tiene rol.

14 cirugia-09 · Perfil V3 1.10.2.021 · Traumatismo raquimedular · *Práctica*

Hombre de 24 años cae de 4 metros de altura y llega con collar cervical. Está vigil, con vía aérea permeable y ventilación adecuada. Presenta tetraplejia flácida con nivel sensitivo en C6, PA 78/40 mmHg, FC 50/min y piel tibia y seca en extremidades. Eco-FAST negativa y radiografía de pelvis normal.

¿Cuál es la causa más probable de la hipotensión y su manejo inicial?

A) Shock hipovolémico; transfusión masiva

B) Shock cardiogénico; dobutamina

C) Shock neurogénico; fluidos endovenosos y vasopresor (noradrenalina), con atropina si la bradicardia es sintomática

D) Taponamiento cardíaco; pericardiocentesis

E) Shock séptico; antibióticos de amplio espectro

> **Respuesta C.** La lesión medular cervical o torácica alta interrumpe el tono simpático y produce shock neurogénico: hipotensión con bradicardia y piel tibia, a diferencia del hipovolémico, que es frío y taquicárdico. Tras descartar sangrado, se trata con fluidos y vasopresores (atropina si la bradicardia es sintomática), manteniendo restricción de movimiento de la columna.

15 cirugia-12 · Perfil V3 1.10.4.001 · TAC de encefalo y columna · *Práctica*

Hombre de 76 años, usuario de acenocumarol por fibrilación auricular, se cae en su casa y se golpea la cabeza. Está con Glasgow 15, sin focalidad neurológica, con un hematoma en la región frontal.

¿Cuál es el examen más adecuado?

A) Radiografía de cráneo

B) TAC de cerebro con contraste

C) TAC de cerebro sin contraste

D) Resonancia magnética de cerebro

E) No requiere imágenes por tener Glasgow 15

> **Respuesta C.** Edad mayor de 65 años y anticoagulación son factores de alto riesgo de hemorragia intracraneana aun con Glasgow 15. El examen de elección en trauma es la TAC de cerebro sin contraste: rápida, disponible y muestra la sangre aguda como hiperdensa. El contraste podría confundirse con sangre.

16 cirugia-06 · Perfil V3 2.01.1.090 · Hernia inguinal · *Práctica*

Un lactante de 3 meses, nacido de término, presenta un aumento de volumen inguinal derecho que aparece con el llanto y desaparece en reposo. Al examen la tumoración es blanda, reductible e indolora, y no transilumina. El testículo derecho está en el escroto.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observar hasta los 2 años, porque suele cerrarse espontáneamente

B) Puncionar para descartar hidrocele

C) Indicar braguero

D) Cirugía solo si se atasca

E) Cirugía electiva precoz (herniotomía) en los próximos días a semanas

> **Respuesta E.** La hernia inguinal pediátrica es indirecta, por persistencia del conducto peritoneovaginal, y no se cierra sola. Por el alto riesgo de atascamiento en lactantes debe operarse en forma electiva y precoz, apenas se diagnostica. A diferencia de la hernia umbilical y el hidrocele comunicante, no se observa. El braguero no está indicado y la punción está contraindicada.

17 cirugia-09 · Perfil V3 2.01.2.021 · Politraumatismos · *Práctica*

Un niño de 7 años, de 25 kg, es atropellado. Llega con vía aérea permeable, FR 30/min y saturación 96% con oxígeno. Está pálido, con FC 150/min, llene capilar de 4 segundos y extremidades frías. Se instalan dos vías venosas.

¿Cuál es la reposición inicial más adecuada?

A) Albúmina al 20% como primera elección

B) Suero glucosado al 5% de mantención

C) Bolo de cristaloide tibio de 20 mL/kg y reevaluar

D) Restringir fluidos hasta tener la TAC

E) Bolo de 60 mL/kg de cristaloide en 5 minutos sin reevaluar

> **Respuesta C.** En el niño politraumatizado, la taquicardia y la mala perfusión son signos precoces de shock hemorrágico; la hipotensión es tardía. Tras asegurar vía aérea y ventilación, se da un bolo de cristaloide isotónico tibio de 20 mL/kg y se reevalúa; si persiste, segundo bolo y transfusión precoz de glóbulos rojos (10 a 20 mL/kg).

18 cirugia-12 · Perfil V3 2.01.2.026 · Traumatismo encéfalo- craneano · *Práctica*

Un niño de 7 años cae de su bicicleta sin casco y se golpea la cabeza. Tuvo pérdida de conciencia de 1 minuto y ha vomitado 3 veces. En urgencia tiene Glasgow 14 persistente, con cefalea, sin focalidad neurológica.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Radiografía de cráneo

B) TAC de cerebro sin contraste

C) Alta con indicaciones de alarma

D) Observación domiciliaria por 24 horas

E) Resonancia magnética de cerebro electiva

> **Respuesta B.** Un TEC con Glasgow menor a 15, pérdida de conciencia y vómitos repetidos es de alto riesgo de lesión intracraneana según los criterios PECARN, y requiere TAC de cerebro sin contraste. La radiografía de cráneo no descarta lesiones intracraneanas. El alta con indicaciones corresponde solo a TEC leve sin factores de riesgo.

19 cirugia-12 · Perfil V3 2.01.4.005 · Radiografía de cráneo · *Práctica*

Un niño de 3 años se cae de una silla de 50 cm de altura y se golpea la frente. No perdió la conciencia, no ha vomitado, está activo, juega con normalidad, tiene Glasgow 15 y solo un pequeño hematoma frontal.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la radiografía de cráneo?

A) Solicitar radiografía de cráneo para descartar fractura

B) Solicitar radiografía y TAC de cerebro

C) Solicitar radiografía de cráneo y, si es normal, dar el alta

D) Solicitar radiografía de cráneo y columna cervical

E) No solicitar radiografía: observar y dar indicaciones de alarma

> **Respuesta E.** La radiografía de cráneo no se recomienda en el TEC pediátrico: una radiografía normal no descarta lesión intracraneana y una fractura no siempre la implica. En un TEC leve de bajo riesgo (mecanismo menor, Glasgow 15, sin pérdida de conciencia, vómitos ni hematoma no frontal), se observa y se educa sobre signos de alarma.

20 cirugia-17 · Perfil V3 4.01.1.011 · Fístulas del intestino delgado · *Práctica*

Hombre de 55 años, al quinto día de una resección intestinal por obstrucción, presenta salida de contenido bilioso por la herida operatoria, de aproximadamente 600 mL al día. Está afebril, hemodinámicamente estable y sin signos de peritonitis difusa.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Reoperación inmediata para cierre de la fístula

B) Régimen liviano y alta con curaciones

C) Reposo digestivo, reposición hidroelectrolítica, nutrición parenteral y protección de la piel

D) Solo antibióticos de amplio espectro

E) Sonda nasogástrica y alta precoz

> **Respuesta C.** Una fístula enterocutánea de alto débito (más de 500 mL al día) sin sepsis se maneja inicialmente en forma conservadora: reposo digestivo, corrección de volumen y electrolitos, nutrición parenteral, control del débito y cuidado de la piel. Muchas cierran espontáneamente; reoperar precozmente un abdomen inflamado tiene alta morbilidad.

21 cirugia-03 · Perfil V3 4.01.1.013 · Enfermedad diverticular no complicada · *Práctica*

Hombre de 60 años, asintomático, se realiza una colonoscopía de tamizaje que muestra múltiples divertículos en el colon sigmoides, sin signos inflamatorios ni otras lesiones.

¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Sigmoidectomía electiva
B) Colonoscopía de control anual
C) Ciprofloxacino y metronidazol por 7 días
D) Evitar estrictamente semillas y frutos secos
E) Dieta rica en fibra, sin controles específicos por los divertículos

> **Respuesta E.** La diverticulosis asintomática no requiere tratamiento ni seguimiento específico; se recomienda dieta rica en fibra, actividad física y evitar el sobrepeso. No hay evidencia para restringir semillas o frutos secos, y la cirugía electiva no está indicada en la enfermedad no complicada.

22 cirugia-02 · Perfil V3 4.01.1.025 · Colecistitis crónica · *Práctica*

Mujer de 42 años refiere, desde hace 1 año, episodios recurrentes de dolor en el hipocondrio derecho después de comidas copiosas, de 2 a 3 horas de duración, que ceden espontáneamente. Actualmente está asintomática. La ecografía muestra múltiples cálculos vesiculares y pared de 4 mm, sin dilatación de la vía biliar. Pruebas hepáticas normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Colecistectomía laparoscópica electiva
B) Ácido ursodesoxicólico por 6 meses
C) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
D) Control ecográfico anual
E) Hospitalizar e iniciar antibióticos

> **Respuesta A.** Los cólicos biliares recurrentes con colelitiasis corresponden a una colecistitis crónica litiásica sintomática; el tratamiento es la colecistectomía laparoscópica electiva, que previene complicaciones como colecistitis aguda, coledocolitiasis y pancreatitis. El ácido ursodesoxicólico tiene baja eficacia y alta recurrencia, y la CPRE solo se indica si hay coledocolitiasis.

23 cirugia-08 · Perfil V3 4.01.1.053 · Tumores benignos de partes blandas · *Práctica*

Hombre de 45 años consulta por un aumento de volumen en la espalda que ha crecido muy lentamente en 3 años. Al examen se palpa una masa de 4 cm, blanda, móvil, indolora, no adherida a la piel ni a planos profundos, sin punto central ni signos inflamatorios.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste epidérmico
B) Liposarcoma
C) Lipoma
D) Absceso subcutáneo
E) Linfadenopatía

> **Respuesta C.** Masa subcutánea blanda, móvil, indolora, de crecimiento lento y no adherida a la piel es un lipoma, el tumor benigno de partes blandas más frecuente. El quiste epidérmico está adherido a la piel y suele tener un poro central. Masas mayores de 5 cm, profundas, duras o de crecimiento rápido obligan a descartar sarcoma.

24 cirugia-08 · Perfil V3 4.01.1.055 · Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones · *Práctica*

Mujer de 32 años, sin enfermedades crónicas, consulta por 4 días de dolor y aumento de volumen en el glúteo derecho. Al examen hay una masa de 4 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con mínimo eritema perilesional. Está afebril y en buen estado general.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibiótico oral por 10 días y control

B) Hospitalizar para antibióticos endovenosos

C) Calor local y observar si drena espontáneamente

D) Solicitar ecografía de partes blandas antes de cualquier tratamiento

E) Drenaje quirúrgico con anestesia local, aseo de la cavidad y curaciones

> **Respuesta E.** Un absceso fluctuante se trata drenándolo: incisión con anestesia local, vaciamiento y aseo de la cavidad, y curaciones. Los antibióticos por sí solos no penetran la colección y se reservan para celulitis extensa, compromiso sistémico o inmunosupresión.

25 cirugia-18 · Perfil V3 4.01.1.057 · Cicatrices viciosas · *Práctica*

Mujer de 20 años consulta por una lesión firme, brillante y pruriginosa en el lóbulo de la oreja izquierda, que apareció 4 meses después de una perforación para aros y ha seguido creciendo, sobrepasando los límites de la herida original.

¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Resección quirúrgica simple aislada

B) Infiltración intralesional de corticoides

C) Crema antibiótica

D) Observación, porque regresa espontáneamente

E) Radioterapia exclusiva

> **Respuesta B.** Una cicatriz que crece más allá de los bordes de la herida original y no regresa es un queloide; la cicatriz hipertrófica se limita a la herida y tiende a mejorar. El tratamiento inicial es la infiltración intralesional de corticoides, asociada a presoterapia o láminas de silicona. La resección aislada tiene una recurrencia muy alta.

26 cirugia-05 · Perfil V3 4.01.2.002 · Abdomen agudo · *Práctica*

Mujer de 24 años consulta por 8 horas de dolor en el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha. Afebril, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 92. Tiene dolor a la palpación profunda de la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales. Su última menstruación fue hace 7 semanas y no usa anticoncepción.

¿Cuál es el primer examen que se debe solicitar?

A) TAC de abdomen y pelvis con contraste

B) Amilasa y lipasa

C) Radiografía simple de abdomen

D) Subunidad beta de gonadotrofina coriónica

E) Colonoscopía

> **Respuesta D.** En toda mujer en edad fértil con abdomen agudo, lo primero es descartar embarazo con subunidad beta. Con atraso menstrual, un embarazo ectópico debe descartarse antes que cualquier otra causa, y el resultado además condiciona el uso de radiación como la TAC.

27 cirugia-07 · Perfil V3 4.01.2.009 · Prolapso rectal · *Práctica*

Mujer de 78 años, multípara, consulta por una masa que protruye por el ano al pujar, de varios meses de evolución, con secreción mucosa e incontinencia fecal leve. Al pedirle que puje, se observa una protrusión de 6 cm, de mucosa rojiza con pliegues circulares concéntricos.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hemorroides internas grado IV

B) Cáncer de recto

C) Pólipo rectal pediculado prolapsado

D) Prolapso mucoso parcial

E) Prolapso rectal completo

> **Respuesta E.** Una protrusión de todo el espesor de la pared rectal muestra pliegues circulares concéntricos, mientras que el prolapso hemorroidal o mucoso presenta pliegues radiales. Es típico de mujeres mayores multíparas, con piso pélvico débil, y se asocia a incontinencia. El tratamiento es quirúrgico (rectopexia abdominal o técnicas perineales en pacientes de alto riesgo).

28 cirugia-18 · Perfil V3 4.01.2.014 · Heridas de cara · *Práctica*

Hombre de 25 años consulta 2 horas después de una caída en bicicleta con una herida cortante limpia de 2 cm en el labio superior, que cruza el borde bermellón. No hay compromiso dentario ni otras lesiones.

¿Cuál es el paso más importante en la reparación de esta herida?

A) Dejar cicatrizar por segunda intención

B) Colocar el primer punto alineando exactamente el borde bermellón

C) Afrontar con cianoacrilato

D) Suturar solo la mucosa con material reabsorbible

E) Diferir la sutura 72 horas para disminuir el riesgo de infección

> **Respuesta B.** En las heridas de cara que cruzan el borde bermellón, el primer punto debe alinear exactamente la unión cutáneo-mucosa, porque un desnivel de apenas 1 mm produce una deformidad visible. La cara tiene excelente irrigación, por lo que estas heridas pueden suturarse en forma primaria incluso hasta 24 horas o más.

29 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.2.020 · Traumatismo raquimedular · *Práctica*

Hombre de 28 años sufre una caída de 5 metros. Ingresa con vía aérea permeable, sin lesiones torácicas ni abdominales evidentes y eco-FAST negativa. Presenta PA 80/45 mmHg, FC 52 lpm, piel tibia y seca, y paraplejia con arreflexia de las cuatro extremidades.

¿Cuál es el tipo de shock más probable?

A) Shock hipovolémico hemorrágico

B) Shock séptico

C) Shock cardiogénico

D) Shock neurogénico

E) Shock obstructivo por neumotórax a tensión

> **Respuesta D.** La lesión medular cervical o torácica alta interrumpe el tono simpático: hipotensión con bradicardia y piel tibia y seca caracterizan al shock neurogénico, a diferencia del hemorrágico, que cursa con taquicardia y piel fría. Se maneja con volumen prudente y vasopresores, inmovilización espinal y búsqueda activa de hemorragia oculta antes de atribuir todo a la médula.

30 cirugia-18 · Perfil V3 4.01.2.025 · Heridas y contusiones menores · *Práctica*

Hombre de 40 años consulta por una herida cortante de 5 cm en la pierna, producida con un vidrio sucio hace 20 horas. Los bordes están levemente eritematosos, con restos de tierra, sin compromiso de estructuras profundas. Tiene esquema antitetánico completo con refuerzo hace 2 años.

¿Cuál es el manejo más adecuado de la herida?

A) Sutura primaria inmediata tras un aseo breve

B) Antibiótico oral y sutura primaria

C) Cierre con adhesivo tisular

D) Aseo quirúrgico con debridamiento, no cerrar en forma primaria, curaciones y cierre diferido o por segunda intención

E) Vendaje compresivo sin aseo

> **Respuesta D.** Una herida contaminada y de más de 12 a 24 horas de evolución, en zona no facial, tiene alto riesgo de infección si se cierra primariamente. Se realiza aseo profuso y debridamiento, se deja abierta con curaciones y se cierra en forma diferida o por segunda intención.

31 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.2.031 · Shock · *Práctica*

Hombre de 35 años, de 70 kg, ingresa tras un accidente de tránsito con fractura expuesta de fémur. Presenta FC 135 lpm, PA 80/50 mmHg, FR 32 por minuto, llene capilar enlentecido y está ansioso y confuso. Diuresis escasa por sonda.

Según la clasificación ATLS del shock hemorrágico, ¿qué clase presenta y cuál es su manejo?

A) Clase I; solo observación

B) Clase II; cristaloides exclusivamente

C) Clase III; reposición de volumen y transfusión de hemoderivados

D) Clase I; vasopresores

E) Clase II; noradrenalina

> **Respuesta C.** Taquicardia sobre 120, hipotensión, taquipnea, confusión y oliguria corresponden a un shock hemorrágico clase III (pérdida de 30 a 40% de la volemia, aproximadamente 1.500 a 2.000 mL). Requiere control de la hemorragia, cristaloides tibios limitados y transfusión precoz de glóbulos rojos y hemoderivados. Los vasopresores no tienen rol en el shock hemorrágico inicial.

32 cirugia-17 · Perfil V3 4.01.3.003 · Asepsia y antisepsia · *Práctica*

Hombre de 45 años será sometido a una hernioplastía inguinal electiva. Presenta abundante vello en la zona operatoria.

¿Cuál es la medida de preparación de la piel más adecuada para prevenir la infección de sitio quirúrgico?

A) Rasurado con navaja la noche anterior

B) Rasurado con navaja en el pabellón

C) No retirar el vello y pintar con povidona acuosa

D) Si es necesario, cortar el vello con máquina eléctrica (clipper) inmediatamente antes de la cirugía y aplicar clorhexidina alcohólica

E) Aplicar alcohol al 70% como único antiséptico, 24 horas antes

> **Respuesta D.** El vello solo se retira si interfiere con la cirugía, y con máquina cortadora inmediatamente antes, porque el rasurado con navaja produce microlesiones que se colonizan y aumentan la infección de sitio quirúrgico, más aún si se hace la noche anterior. La antisepsia de elección es la clorhexidina en solución alcohólica.

33 cirugia-03 · Perfil V3 4.01.3.004 · Colostomías · *Práctica*

Hombre de 70 años con diverticulitis aguda Hinchey IV (peritonitis fecaloídea) es sometido a una cirugía de urgencia. Se realiza una sigmoidectomía, cierre del muñón rectal y abocamiento del colon descendente a la piel.

¿Cómo se denomina esta cirugía y qué tipo de ostomía se dejó?

A) Operación de Miles con colostomía definitiva

B) Colostomía en asa sin resección

C) Hemicolectomía derecha con ileostomía en asa

D) Resección anterior baja con anastomosis primaria

E) Operación de Hartmann con colostomía terminal

> **Respuesta E.** La operación de Hartmann consiste en resecar el segmento enfermo, cerrar el muñón rectal y abocar el cabo proximal como colostomía terminal; es la técnica clásica en la peritonitis diverticular fecaloídea o en pacientes inestables. Se puede reconstruir el tránsito en un segundo tiempo. La operación de Miles reseca el recto y el ano, con colostomía definitiva.

34 cirugia-14 · Perfil V3 4.01.3.006 · Concepto de paciente quirúrgico ambulatorio · *Práctica*

Se evalúan pacientes para colecistectomía laparoscópica en un programa de cirugía mayor ambulatoria.

¿Cuál de los siguientes pacientes NO es candidato a cirugía ambulatoria?

A) Mujer de 40 años, ASA I, que vive a 20 minutos del hospital con su pareja

B) Hombre de 55 años, ASA II, hipertenso controlado, acompañado por su hijo

C) Mujer de 70 años, ASA IV, con insuficiencia cardíaca descompensada, que vive sola

D) Hombre de 35 años, ASA I, con índice de masa corporal de 28

E) Mujer de 60 años, ASA II, con diabetes tipo 2 bien controlada, con cuidador en casa

> **Respuesta C.** La cirugía mayor ambulatoria requiere un procedimiento de bajo riesgo, pacientes ASA I a II (o III estables), un adulto responsable que lo acompañe las primeras 24 horas y acceso rápido a un centro de salud. Un paciente ASA IV con enfermedad descompensada, que además vive solo, no cumple criterios.

35 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.3.008 · Conceptos de manejo en situación de catástrofe (triage, extricación, inmovilización y transporte) · *Práctica*

En un accidente de bus con múltiples víctimas, usted aplica el triage START. Un paciente no puede caminar, respira espontáneamente con una frecuencia de 34 por minuto y tiene pulso radial palpable.

¿Qué categoría de triage le corresponde?

A) Verde (diferido, puede esperar)

B) Amarillo (urgente, no inmediato)

C) Negro (fallecido o expectante)

D) Rojo (inmediato)

E) Blanco (sin lesiones)

> **Respuesta D.** En el triage START, quien camina es verde. En quien no camina se evalúa la respiración: si no respira tras abrir la vía aérea es negro; si respira con frecuencia mayor de 30 por minuto es rojo. Luego se evalúan la perfusión (llene capilar mayor de 2 segundos o sin pulso radial: rojo) y la obediencia a órdenes simples.

36 cirugia-13 · Perfil V3 4.01.3.011 · Conceptos generales sobre injertos y colgajos · *Práctica*

Hombre de 40 años sufre un accidente con una máquina que le produce una pérdida de piel en el dorso del pie, con exposición del tendón extensor sin paratendón y de hueso sin periostio. El lecho está limpio tras el aseo quirúrgico.

¿Cuál es la opción de cobertura más adecuada?

A) Injerto de piel parcial

B) Injerto de piel total

C) Sustituto dérmico sin cobertura posterior

D) Cierre por segunda intención con curaciones

E) Colgajo

> **Respuesta E.** Un injerto carece de irrigación propia y depende del lecho receptor para nutrirse, por lo que no prende sobre hueso sin periostio, tendón sin paratendón, cartílago sin pericondrio ni material de osteosíntesis expuesto. En esos casos se requiere un colgajo, que lleva su propio pedículo vascular. Los injertos son ideales sobre lechos bien vascularizados, como el tejido de granulación.

37 cirugia-14 · Perfil V3 4.01.3.014 · Evaluación nutricional · *Práctica*

Hombre de 64 años con cáncer gástrico resecable, programado para gastrectomía. Ha bajado 12% de su peso en los últimos 6 meses, tiene un índice de masa corporal de 18 kg/m2 y albúmina plasmática de 2,8 g/dL.

¿Cuál es la conducta más adecuada desde el punto de vista nutricional?

A) Soporte nutricional preoperatorio, de preferencia enteral, por 7 a 14 días

B) Operar de inmediato, porque el estado nutricional no influye en la evolución

C) Postergar la cirugía 6 meses hasta normalizar la albúmina

D) Solo suplementar vitaminas por vía oral

E) Nutrición parenteral exclusiva por 3 meses

> **Respuesta A.** Una baja de peso mayor de 10% en 6 meses, IMC menor de 18,5 y albúmina menor de 3 g/dL indican desnutrición grave, que aumenta las complicaciones postoperatorias (dehiscencias, infecciones). Está indicado un soporte nutricional preoperatorio de 7 a 14 días, preferentemente por vía enteral, sin retrasar en exceso una cirugía oncológica.

38 cirugia-17 · Perfil V3 4.01.3.016 · Infección quirúrgica e intrahospitalaria · *Práctica*

Mujer de 55 años, operada hace 5 días de una colectomía por laparotomía. Presenta fiebre de 38 grados y la herida operatoria muestra eritema, calor, induración y salida de pus entre los puntos, sin dehiscencia aponeurótica. Abdomen sin signos peritoneales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Abrir la herida retirando puntos, drenar, tomar cultivo y realizar curaciones

B) Antibiótico oral y mantener los puntos

C) Reoperar de urgencia por sospecha de filtración

D) Aplicar compresas frías y observar

E) Cerrar nuevamente la herida con puntos de refuerzo

> **Respuesta A.** Es una infección superficial del sitio quirúrgico, típica entre el quinto y séptimo día. El tratamiento principal es abrir la herida, drenar, cultivar y curar, dejándola cerrar por segunda intención. Los antibióticos se agregan solo si hay celulitis extensa o compromiso sistémico significativo.

39 cirugia-15 · Perfil V3 4.01.3.017 · Manejo del dolor · *Práctica*

Mujer de 55 años, en su primer día postoperatorio de una laparotomía por histerectomía, refiere dolor EVA 8/10 pese a paracetamol y ketorolaco endovenosos en horario. No tiene contraindicaciones ni alergias.

¿Cuál es la conducta analgésica más adecuada?

A) Mantener el mismo esquema y esperar que el dolor ceda

B) Suspender todo y usar solo dipirona

C) Agregar un segundo AINE

D) Agregar un opioide, como morfina endovenosa titulada, manteniendo la analgesia multimodal

E) Indicar diazepam para disminuir la ansiedad

> **Respuesta D.** El dolor postoperatorio severo que no cede con analgesia no opioide requiere agregar un opioide (por ejemplo, morfina endovenosa titulada o en bomba de analgesia controlada por el paciente), manteniendo paracetamol y AINE como base multimodal para reducir la dosis de opioide. Combinar dos AINE no mejora la analgesia y aumenta la toxicidad.

40 cirugia-04 · Perfil V3 4.01.4.002 · Radiografía simple de abdomen · *Práctica*

Hombre de 78 años, postrado y con constipación crónica, consulta por 2 días de distensión abdominal marcada, dolor cólico y ausencia de eliminación de gases. Está hemodinámicamente estable, sin signos peritoneales. La radiografía simple de abdomen muestra un asa colónica muy dilatada en forma de U invertida, que nace de la pelvis y se proyecta hacia el hipocondrio derecho, con aspecto de grano de café.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vólvulo de sigmoides

B) Obstrucción de intestino delgado por bridas

C) Íleo biliar

D) Megacolon tóxico

E) Íleo paralítico

> **Respuesta A.** El signo del grano de café, un asa sigmoidea gigante en U invertida que nace de la pelvis, es el hallazgo radiológico clásico del vólvulo de sigmoides, típico del adulto mayor postrado y constipado. Sin necrosis ni peritonitis se intenta primero la desvolvulación endoscópica.

41 cirugia-12 · Perfil V3 4.01.4.003 · Radiografía de cráneo · *Práctica*

Hombre de 40 años sufre un golpe en la cabeza en una caída de escalera. Ingresa con Glasgow 13, cefalea intensa y 2 vómitos. No tiene déficit focal.

¿Cuál es el examen de imagen de elección?

A) Radiografía de cráneo AP y lateral

B) Resonancia magnética de cerebro con gadolinio

C) TAC de cerebro sin contraste

D) Ecografía transfontanelar

E) Observación sin imágenes

> **Respuesta C.** En el traumatismo encéfalo-craneano con Glasgow menor de 15, vómitos repetidos o cefalea intensa, el examen de elección es la TAC de cerebro sin contraste, que detecta hematomas, contusiones y fracturas. La radiografía de cráneo tiene un rol muy limitado: una fractura no descarta ni confirma lesión intracraneana. La resonancia es más lenta y menos práctica en urgencia.

42 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.4.004 · Radiografía de columna cervical · *Práctica*

Hombre de 30 años, motociclista, ingresa con dolor cervical posterior tras un choque. Está inmovilizado con collar cervical. La radiografía lateral de columna cervical solo permite visualizar hasta el borde inferior de C6, sin lesiones evidentes.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el collar, porque la radiografía es normal

B) Solicitar electromiografía

C) Solicitar radiografía con proyecciones en flexión y extensión

D) Mantener el collar y repetir la radiografía en 1 semana

E) Solicitar TAC de columna cervical

> **Respuesta E.** Una radiografía lateral cervical es adecuada solo si se visualizan las 7 vértebras cervicales y la unión C7-T1, sitio frecuente de lesiones. Si no se visualiza, se debe completar el estudio: actualmente la TAC de columna cervical es el examen de elección en el trauma. Las radiografías dinámicas están contraindicadas en el paciente agudo con dolor.

43 cirugia-02 · Perfil V3 4.01.4.011 · Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal · *Práctica*

Hombre de 62 años, cirrótico con ascitis, consulta por dolor en el hipocondrio derecho. En la ecografía se observan dos imágenes anecogénicas en esa región: una bajo el borde hepático y otra rodeando el hígado.

¿Qué hallazgo permite identificar cuál de ellas corresponde a la vesícula biliar y no a líquido libre?

A) Ser completamente anecogénica

B) Ubicarse en el espacio hepatorrenal de Morrison

C) Tener bordes angulados que se amoldan entre los órganos

D) Desplazarse hacia las zonas declives al cambiar de posición al paciente

E) Tener forma ovalada con pared propia bien definida, ubicada en el lecho vesicular y que puede contener cálculos o barro

> **Respuesta E.** Ambos son anecogénicos. La vesícula es una estructura ovalada con pared propia, en su lecho bajo el hígado, y puede tener cálculos o barro. El líquido libre no tiene pared, forma ángulos agudos entre los órganos, se ubica en zonas declives como Morrison o la pelvis y se redistribuye con los cambios de posición.

44 cirugia-11 · Perfil V3 4.01.4.011 · Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal · *Práctica*

Hombre de 30 años sufre un trauma abdominal cerrado por accidente de tránsito. Presión arterial 92/60, frecuencia cardíaca 118. En el Eco-FAST, en la ventana del hipocondrio derecho, se observa una banda anecogénica de bordes angulados entre el hígado y el riñón derecho; aparte, bajo el borde hepático, se ve una estructura ovalada anecogénica de pared fina y bien definida.

¿Cuál es la interpretación correcta?

A) La banda entre hígado y riñón es líquido libre en el espacio de Morrison, y la estructura ovalada es la vesícula

B) Ambas imágenes corresponden a la vesícula biliar normal

C) La banda corresponde a un quiste renal simple

D) La estructura ovalada corresponde a hemoperitoneo

E) Ambas imágenes son artefactos sin significado clínico

> **Respuesta A.** El líquido libre no tiene pared propia, forma ángulos que se amoldan entre los órganos y se acumula en zonas declives como el espacio de Morrison. La vesícula es ovalada, con pared propia y está en su lecho bajo el hígado. En un paciente inestable, un FAST positivo indica laparotomía.

45 cirugia-04 · Perfil V3 4.01.4.015 · TAC de abdomen y pelvis · *Práctica*

Mujer de 74 años, sin cirugías abdominales previas, consulta por 24 horas de dolor cólico, vómitos y detención del tránsito de gases. Está estable, afebril, sin hernias palpables. La radiografía simple de abdomen muestra asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos.

¿Cuál es el examen más útil para definir la causa de la obstrucción y buscar signos de sufrimiento intestinal?

A) Tránsito intestinal con bario

B) Colonoscopía

C) TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso

D) Ecografía abdominal

E) Repetir la radiografía simple en 24 horas

> **Respuesta C.** Sin cirugía previa las bridas son poco probables, por lo que hay que buscar otra causa. La TAC con contraste muestra el punto de transición, la causa, como tumor, hernia interna o íleo biliar, y signos de isquemia o perforación. El bario está contraindicado ante sospecha de perforación.

46 cirugia-15 · Perfil V3 4.01.5.001 · Anestesia local por infiltración · *Práctica*

Hombre de 60 kg con una herida cortante de 6 cm en el antebrazo, que requiere sutura. Se usará lidocaína al 1% sin epinefrina para anestesia local por infiltración. Recuerde que la solución al 1% contiene 10 mg por mL.

¿Cuál es el volumen máximo aproximado que se puede infiltrar?

A) 5 mL

B) 10 mL

C) 100 mL

D) 60 mL

E) 27 mL

> **Respuesta E.** La dosis máxima de lidocaína sin epinefrina es de 4,5 mg/kg, con techo de 300 mg. En 60 kg son 270 mg, que al 1% equivalen a 27 mL. Al infiltrar se aspira antes de inyectar para evitar inyección intravascular, y se vigilan pródromos de toxicidad como sabor metálico o parestesias peribucales.

47 cirugia-15 · Perfil V3 4.01.5.002 · Anestesia troncular de dedos y ortejos · *Práctica*

Hombre de 30 años requiere sutura de una herida en el pulpejo del dedo índice. Se decide realizar una anestesia troncular digital con lidocaína.

¿Cuál es la técnica correcta?

A) Infiltrar directamente en el pulpejo, alrededor de la herida

B) Infiltrar solo en la cara dorsal de la falange distal

C) Infiltrar en la muñeca a nivel del nervio radial exclusivamente

D) Infiltrar en la base del dedo, en ambas caras laterales (dorsolateral y palmar-lateral), donde transcurren los nervios digitales

E) Infiltrar en forma circular completa con gran volumen, como un anillo apretado

> **Respuesta D.** La anestesia troncular digital bloquea los 4 nervios colaterales (2 dorsales y 2 palmares), que corren por las caras laterales del dedo: se infiltra en la base del dedo, a ambos lados. Se usan volúmenes pequeños, porque los anillos de gran volumen comprimen las arterias digitales; tradicionalmente se recomienda lidocaína sin vasoconstrictor.

48 cirugia-07 · Perfil V3 4.01.5.003 · Anoscopía · *Práctica*

Hombre de 32 años consulta por rectorragia de sangre roja fresca, que gotea al final de la defecación, indolora, de 2 semanas de evolución. Sin baja de peso ni antecedentes familiares de cáncer de colon. El tacto rectal es normal.

¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

A) Anoscopía

B) Colonoscopía total urgente

C) TAC de abdomen y pelvis

D) Enema baritado

E) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados

> **Respuesta A.** En un adulto joven con rectorragia indolora de sangre roja que gotea al final de la deposición, la causa más probable son las hemorroides internas, que no se palpan en el tacto rectal. La anoscopía es el examen inicial que permite visualizarlas. Si no se encuentra la causa o hay signos de alarma, se complementa con colonoscopía.

49 cirugia-17 · Perfil V3 4.01.5.004 · Ayudantía quirúrgica (nociones básicas) · *Práctica*

Un interno se prepara para participar como ayudante en una laparotomía. Ya realizó el lavado quirúrgico de manos y se colocó delantal y guantes estériles.

¿Cuál de las siguientes zonas de su delantal se considera estéril durante la cirugía?

A) La parte anterior desde el tórax hasta la cintura y las mangas hasta 5 cm sobre el codo

B) La espalda completa

C) Todo el delantal, incluyendo bajo la cintura

D) Solo los hombros y el cuello

E) Ninguna zona, solo los guantes

> **Respuesta A.** Por convención, en el delantal quirúrgico solo se considera estéril la cara anterior desde el tórax hasta el nivel de la mesa (cintura) y las mangas desde los puños hasta unos 5 cm sobre el codo. La espalda, los hombros, el cuello y lo bajo la cintura no son estériles; por eso las manos se mantienen frente al tórax.

50 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.5.007 · Cricoidostomía · *Práctica*

Niño de 7 años, víctima de un accidente de tránsito con trauma facial grave, presenta obstrucción de la vía aérea con desaturación progresiva. Fracasan la intubación orotraqueal y la ventilación con bolsa-mascarilla.

¿Cuál es el procedimiento de rescate de la vía aérea más adecuado?

A) Cricotiroidotomía quirúrgica

B) Traqueostomía reglada en pabellón

C) Cricotiroidotomía por punción con aguja y ventilación en jet

D) Intubación nasotraqueal a ciegas

E) Esperar al anestesiólogo manteniendo oxígeno por mascarilla

> **Respuesta C.** Ante un escenario de no intubable y no oxigenable, se requiere una vía aérea quirúrgica. En menores de 12 años la cricotiroidotomía quirúrgica está relativamente contraindicada por riesgo de estenosis subglótica, y se prefiere la punción cricotiroidea con aguja y ventilación en jet. La intubación nasal está contraindicada en trauma facial grave.

51 cirugia-13 · Perfil V3 4.01.5.008 · Curación básica de quemaduras · *Práctica*

Hombre de 35 años se quema el antebrazo con agua hirviendo hace 2 horas. Presenta una quemadura de espesor parcial superficial, rosada, húmeda y dolorosa, con flictenas rotas, que compromete cerca del 3% de la superficie corporal. No tiene otras lesiones.

¿Cuál es el manejo local más adecuado?

A) Aplicar hielo directo y dejar la herida descubierta

B) Lavar con suero fisiológico, retirar las flictenas rotas, cubrir con apósito no adherente y controlar en 48 a 72 horas

C) Aplicar pomada de corticoides y vendaje compresivo

D) Iniciar antibiótico oral profiláctico y dejar las flictenas intactas sin cubrir

E) Derivar de inmediato a un centro de grandes quemados

> **Respuesta B.** La curación básica de una quemadura pequeña de espesor parcial consiste en enfriar con agua o suero a temperatura ambiente, lavar con suero, retirar el tejido desvitalizado y las flictenas rotas, y cubrir con apósito no adherente, con controles cada 48 a 72 horas. No se usan antibióticos profilácticos ni hielo.

52 cirugia-18 · Perfil V3 4.01.5.009 · Curación de heridas, sutura y aseo · *Práctica*

Mujer de 25 años con una herida cortante limpia de 2 cm en la mejilla, producida hace 2 horas, que se sutura con puntos simples de material no absorbible fino.

¿En cuántos días se deben retirar los puntos?

A) Entre 5 y 7 días

B) Entre 10 y 12 días

C) Entre 14 y 21 días

D) A los 30 días

E) No se retiran porque se reabsorben

> **Respuesta A.** En la cara, por su excelente irrigación, los puntos se retiran a los 5 a 7 días, lo que evita las marcas de los puntos. El cuero cabelludo se retira a los 7 a 10 días, el tronco y las extremidades entre 10 y 14, y sobre articulaciones hasta 14 días. El material no absorbible sí debe retirarse.

53 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.5.010 · Denudación venosa · *Práctica*

Hombre de 40 años en shock hemorrágico tras un politraumatismo. No ha sido posible canalizar dos vías venosas periféricas y no se dispone de dispositivo intraóseo. Se decide realizar una denudación venosa.

¿Cuál es el sitio clásico de elección para este procedimiento en el adulto?

A) Vena yugular externa

B) Vena cefálica en el surco deltopectoral

C) Vena femoral en el triángulo de Scarpa

D) Vena subclavia

E) Vena safena interna, anterior al maléolo medial

> **Respuesta E.** La denudación venosa es una técnica de acceso vascular de rescate cuando fracasan las vías periféricas y la vía intraósea. El sitio clásico es la vena safena interna en el tobillo, aproximadamente 2 cm anterior y superior al maléolo medial, por su ubicación constante y superficial. Hoy se prefiere la vía intraósea o central, más rápidas.

54 cirugia-08 · Perfil V3 4.01.5.011 · Drenaje de lesiones superficiales · *Práctica*

Hombre de 30 años, sano, consulta por una lesión dolorosa en el glúteo de 5 días. Al examen presenta un nódulo de 3 cm, eritematoso, caliente y fluctuante, sin celulitis extensa. Está afebril y sin compromiso del estado general.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Antibióticos orales exclusivos por 10 días

B) Incisión y drenaje, con aseo de la cavidad

C) Compresas tibias y control en 1 semana

D) Punción con aguja fina y alta

E) Resección en bloque del nódulo

> **Respuesta B.** Un absceso cutáneo fluctuante se trata con incisión y drenaje amplio, rompiendo tabiques y aseando la cavidad. En abscesos simples, sin celulitis extensa, fiebre ni inmunosupresión, el drenaje suele ser suficiente; los antibióticos solos no penetran adecuadamente la colección. La punción simple tiene alta recurrencia.

55 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.5.014 · Evaluación primaria en trauma · *Práctica*

Hombre de 30 años, motociclista, llega tras una colisión de alta energía. Presenta ronquido y respiración ruidosa, Glasgow 8, presión arterial 90/60 y frecuencia cardíaca 120. Tiene deformidad del muslo derecho, sin sangrado externo activo.

¿Cuál es la primera acción que se debe realizar?

A) Instalar dos vías venosas gruesas e iniciar cristaloides

B) Permeabilizar y asegurar la vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical

C) Solicitar TAC de cerebro

D) Alinear e inmovilizar la fractura de fémur

E) Solicitar radiografía de pelvis

> **Respuesta B.** La evaluación primaria sigue el orden ABCDE: primero vía aérea con protección cervical. El ronquido y el Glasgow 8 indican una vía aérea comprometida, que mata antes que la hipovolemia. Recién después se evalúa ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición.

56 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.5.015 · Evaluación secundaria en trauma · *Práctica*

Hombre de 40 años cae desde 4 metros. Se completa la evaluación primaria: vía aérea permeable, ventilación normal, presión arterial 120/80 tras 1 litro de cristaloides, Glasgow 15 y sin lesiones evidentes a la exposición. Se mantiene estable.

¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?

A) Realizar la evaluación secundaria: anamnesis dirigida y examen físico completo de cabeza a pies, incluido el dorso

B) Dar de alta con analgesia y control en 48 horas

C) Realizar laparotomía exploradora

D) Repetir solo la evaluación primaria cada 5 minutos sin otro examen

E) Iniciar la evaluación secundaria antes de terminar la evaluación primaria

> **Respuesta A.** La evaluación secundaria comienza solo cuando la primaria está completa y el paciente estabilizado. Incluye anamnesis dirigida, con alergias, medicamentos, antecedentes, última comida y mecanismo, y un examen de cabeza a pies, incluido el dorso con rotación en bloque, para pesquisar lesiones no evidentes.

57 cirugia-12 · Perfil V3 4.01.5.019 · Intubación nasogástrica · *Práctica*

Hombre de 35 años ingresa tras un accidente de tránsito con traumatismo encéfalo-craneano. Presenta equimosis periorbitaria bilateral (ojos de mapache), equimosis retroauricular y salida de líquido claro por la nariz. Se requiere descomprimir el estómago.

¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo?

A) Sonda nasogástrica

B) Sonda nasoyeyunal

C) Sonda orogástrica

D) Gastrostomía percutánea de urgencia

E) No descomprimir el estómago

> **Respuesta C.** Los signos de fractura de base de cráneo (ojos de mapache, signo de Battle, rinorrea u otorraquia de líquido cefalorraquídeo) contraindican la instalación de sondas por vía nasal, por riesgo de que la sonda ingrese a la cavidad craneana a través de la lámina cribosa. En estos casos la descompresión gástrica se realiza por vía orogástrica.

58 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.5.022 · Manejo de vía aérea y columna cervical en trauma · *Práctica*

Mujer de 35 años, traída tras un volcamiento, está inconsciente y con ronquido. Se sospecha lesión de columna cervical. No tiene trauma facial ni sangre en la boca.

¿Cuál es la maniobra inicial más adecuada para permeabilizar la vía aérea?

A) Hiperextensión del cuello con elevación del mentón

B) Intubación nasotraqueal a ciegas

C) Retirar el collar cervical para evaluar el cuello

D) Tracción mandibular manteniendo inmovilización manual alineada de la columna cervical

E) Colocar a la paciente en posición lateral de seguridad

> **Respuesta D.** En trauma con sospecha de lesión cervical, la vía aérea se abre con tracción mandibular, o elevación del mentón sin extender el cuello, manteniendo la inmovilización manual alineada. La hiperextensión puede agravar una lesión medular. Si no se logra una vía aérea adecuada, se avanza a cánula y vía aérea definitiva.

59 cirugia-10 · Perfil V3 4.01.5.026 · Drenaje pleural · *Práctica*

Hombre de 30 años con herida por arma blanca en el hemitórax derecho, hemodinámicamente estable. La radiografía de tórax muestra un hemotórax moderado. Se decide instalar un tubo de drenaje pleural.

¿Cuál es el sitio y la técnica correctos de inserción?

A) Segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, por el borde inferior de la costilla superior

B) Cuarto espacio intercostal paraesternal, junto al esternón

C) Octavo espacio intercostal, línea escapular, por el borde inferior de la costilla

D) Quinto espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media, por el borde superior de la costilla inferior

E) Cualquier espacio intercostal donde se palpe mejor el derrame

> **Respuesta D.** El tubo pleural se instala en el triángulo de seguridad: quinto espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media, rasando el borde superior de la costilla inferior, porque el paquete vasculonervioso corre por el borde inferior de cada costilla. El segundo espacio medioclavicular es el sitio de punción descompresiva clásica.

60 cirugia-09 · Perfil V3 4.01.5.031 · Traslado del traumatizado · *Práctica*

Mujer de 25 años, víctima de un volcamiento, se encuentra consciente, con dolor cervical y parestesias en ambas manos. El equipo prehospitalario debe extraerla y trasladarla al servicio de urgencia.

¿Cuál es la forma más adecuada de traslado?

A) Sentada en el asiento del vehículo de emergencia

B) Inmovilización con collar cervical rígido y tabla espinal, movilizándola en bloque

C) Permitir que camine hasta la ambulancia si puede hacerlo

D) Trasladarla en decúbito lateral sin collar

E) Retirar el casco y el collar para facilitar la evaluación durante el traslado

> **Respuesta B.** Ante sospecha de lesión de columna (mecanismo de alta energía, dolor cervical, síntomas neurológicos), la paciente debe trasladarse con restricción de movimiento espinal: collar cervical rígido, tabla espinal o camilla de cuchara, y movilización en bloque con varios rescatadores, manteniendo la alineación del eje cabeza-cuello-tronco hasta descartar la lesión en el hospital.

61 cirugia-18 · Perfil V3 4.02.2.009 · Heridas de la mano no complicadas · *Práctica*

Hombre de 30 años se corta la palma de la mano con un cuchillo de cocina hace 2 horas. Herida lineal limpia de 2 cm en la eminencia tenar, sangrado controlado con compresión. La flexión y extensión de todos los dedos contra resistencia es normal, la sensibilidad de los pulpejos (discriminación de 2 puntos) está conservada y el llene capilar es normal. Vacuna antitetánica completa hace 4 años.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Vacuna antitetánica y gammaglobulina antitetánica

B) Derivar a cirugía de mano para exploración en pabellón

C) Dejar la herida abierta para cierre por segunda intención

D) Cierre con puntos y cefazolina oral por 7 días

E) Aseo, exploración bajo anestesia local y sutura con puntos simples de nylon

> **Respuesta E.** Una herida limpia de la mano, reciente, con tendones, nervios digitales y perfusión indemnes es una herida no complicada: se maneja en urgencia con aseo, exploración bajo anestesia local y sutura. No requiere antibióticos. Con vacuna completa hace menos de 5 años no necesita refuerzo antitetánico.

62 cirugia-09 · Perfil V3 4.02.2.015 · Trauma raquimedular · *Práctica*

Hombre de 25 años se lanza de cabeza a una piscina poco profunda. Llega inmovilizado con collar cervical. Vía aérea permeable, respira con patrón diafragmático, PA 80/45 mmHg, FC 52 lpm, piel tibia y seca. No mueve las 4 extremidades, tiene anestesia bajo las clavículas y priapismo. FAST negativo y sin otras lesiones evidentes.

¿Cuál es la causa más probable de la hipotensión?

A) Shock neurogénico por lesión medular cervical

B) Shock hemorrágico por lesión abdominal oculta

C) Shock espinal sin repercusión hemodinámica

D) Neumotórax a tensión

E) Taponamiento cardíaco

> **Respuesta A.** Hipotensión con bradicardia y piel tibia en un trauma cervical con tetraplejia es shock neurogénico: pérdida del tono simpático. Se maneja con volumen cauteloso y vasopresores, manteniendo restricción de movimiento de la columna. El shock hemorrágico da taquicardia y piel fría; el shock espinal es la arreflexia transitoria, no un estado hemodinámico.

63 cirugia-09 · Perfil V3 4.02.3.007 · Triage · *Práctica*

Se produce un choque de un bus con múltiples víctimas. Usted llega primero al lugar y aplica triage START. Un hombre adulto no puede caminar, respira espontáneamente con una frecuencia de 24 por minuto, tiene llene capilar menor de 2 segundos y obedece órdenes simples.

¿Qué categoría de triage le corresponde?

A) Verde (leve, puede esperar)

B) Amarilla (diferible)

C) Roja (inmediata)

D) Negra (fallecido o no recuperable)

E) Roja, porque no puede caminar

> **Respuesta B.** En START, quien camina es verde. Si no camina, se evalúa: sin respiración tras abrir la vía aérea es negra; frecuencia respiratoria mayor de 30, llene capilar mayor de 2 segundos (o sin pulso radial) o no obedece órdenes es roja. Este paciente no camina pero pasa todos los criterios: amarilla.

64 cirugia-13 · Perfil V3 6.01.2.011 · Quemadura solar · *Práctica*

Mujer de 22 años consulta 12 horas después de pasar 6 horas en la playa sin fotoprotector. Tiene eritema intenso, doloroso y edema en espalda y hombros, con algunas ampollas pequeñas en los hombros. Está afebril, hidratada, sin compromiso del estado general.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hospitalización y reanimación con fórmula de Parkland

B) Compresas frías, hidratación oral, AINE para el dolor, emolientes, no romper las ampollas y fotoprotección estricta

C) Corticoide sistémico en dosis altas

D) Antibiótico oral profiláctico

E) Aplicar pasta de dientes o mantequilla sobre la quemadura

> **Respuesta B.** La quemadura solar es una quemadura superficial (eritema) o intermedia superficial (ampollas) por radiación UV. Sin compromiso sistémico se maneja ambulatoriamente con frío local, analgesia (AINE), hidratación, emolientes, cuidado de ampollas y evitar el sol. Se hospitaliza si es extensa con ampollas, hay deshidratación, fiebre o compromiso general, sobre todo en niños.

65 cirugia-12 · Perfil V3 6.03.2.015 · Otorragia · *Práctica*

Hombre de 30 años sufre un TEC por caída de altura. Glasgow 14. Presenta otorragia derecha, equimosis retroauricular derecha (signo de Battle) e hipoacusia derecha. La otoscopía muestra sangre en el conducto auditivo externo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lavado de oído para visualizar el tímpano

B) Taponamiento compacto del conducto auditivo

C) Gotas óticas de ciprofloxacino y alta

D) No manipular ni lavar el oído; TAC de cerebro y de hueso temporal por sospecha de fractura de base de cráneo y evaluación de parálisis facial

E) Aspirar el conducto en el servicio de urgencia

> **Respuesta D.** La otorragia postraumática con signo de Battle sugiere fractura del hueso temporal (base de cráneo media), que puede asociarse a fístula de LCR, lesión del oído medio o interno y parálisis facial. No se debe lavar ni taponar el oído (riesgo de meningitis). Se estudia con TAC de cerebro y de peñasco, se evalúa el nervio facial y la audición.

66 cirugia-09 · Perfil V3 6.03.5.008 · Intubacion traqueal · *Práctica*

Se realiza intubación orotraqueal de un paciente con insuficiencia respiratoria en el servicio de urgencia. Tras pasar el tubo, se ausculta murmullo pulmonar solo en el hemitórax derecho y la capnografía muestra curva presente con valores adecuados.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el tubo y reintubar porque está en el esófago

B) Mantener sin cambios

C) Avanzar más el tubo

D) Instalar drenaje pleural izquierdo de inmediato

E) Desinflar el cuff y retirar el tubo unos centímetros hasta auscultar murmullo bilateral, y confirmar con radiografía de tórax

> **Respuesta E.** La capnografía con curva persistente confirma ubicación traqueal. El murmullo solo derecho indica intubación selectiva del bronquio principal derecho por tubo muy profundo: se desinfla el cuff, se retira hasta lograr murmullo simétrico y se fija (adulto, unos 21 a 23 cm en la comisura). La radiografía confirma la punta 2 a 4 cm sobre la carina.

Dermatología

67 derma-16 · Perfil V3 1.04.4.003 · Cultivos de hongos · *Práctica*

Un hombre de 55 años consulta por engrosamiento, color amarillento y desprendimiento distal de las uñas de ambos ortejos mayores, de 2 años de evolución. Desea tratamiento oral.

¿Cuál es la conducta más adecuada antes de iniciar terbinafina oral?

A) Iniciar terbinafina sin estudio

B) Confirmar con examen micológico directo (KOH) y cultivo de hongos de la uña

C) Biopsia de la matriz ungueal en todos los casos

D) Radiografía del ortejo

E) Hemocultivos

> **Respuesta B.** Hasta la mitad de las distrofias ungueales no son micóticas (psoriasis, trauma, liquen). Antes de un tratamiento oral prolongado (terbinafina por 12 semanas en pies), con costo y riesgo hepático, se confirma la onicomicosis con examen directo con KOH y cultivo micológico, que además identifica el agente: dermatofito, levadura o moho.

68 derma-02 · Perfil V3 2.01.1.104 · Acné · *Práctica*

Una adolescente de 13 años consulta por lesiones en la frente y la nariz desde hace 6 meses. Al examen se observan numerosos comedones abiertos y cerrados, sin pápulas inflamatorias, pústulas ni nódulos.

¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Isotretinoína oral

B) Doxiciclina oral

C) Anticonceptivos orales

D) Retinoide tópico (ej. adapaleno)

E) Corticoide tópico

> **Respuesta D.** Acné comedoniano (no inflamatorio) leve: el tratamiento de elección es un retinoide tópico (adapaleno o tretinoína), que normaliza la queratinización folicular; puede asociarse peróxido de benzoilo. Los antibióticos orales se reservan para acné inflamatorio moderado y la isotretinoína para acné grave, nodular o refractario. Los corticoides tópicos empeoran el acné.

69 derma-16 · Perfil V3 2.01.1.110 · Infecciones micóticas de piel y fanéreos · *Práctica*

Un niño de 6 años, que tiene un perro, presenta desde hace 3 semanas una placa en el cuero cabelludo con pelos cortados a pocos milímetros de la piel y descamación. En los últimos días la lesión se volvió inflamatoria, dolorosa, con pústulas y supuración, y tiene adenopatías occipitales.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Clotrimazol tópico

B) Corticoide tópico

C) Cefadroxilo oral

D) Drenaje quirúrgico

E) Griseofulvina oral por 6 a 8 semanas

> **Respuesta E.** Placa alopécica con pelos cortados y descamación es tiña capitis (Microsporum canis, frecuente por contacto con mascotas). La forma inflamatoria con pústulas y supuración es el querion de Celso, una reacción inmune y no una infección bacteriana. La tiña capitis siempre requiere antifúngico oral (griseofulvina o terbinafina por semanas), porque el tópico no penetra el folículo. El drenaje está contraindicado.

70 derma-07 · Perfil V3 6.01.1.005 · Dermatitis del pañal · *Práctica*

Lactante de 7 meses con eritema en la zona del pañal de 10 días que no mejoró con pasta de óxido de zinc. Al examen hay eritema rojo intenso, brillante, que compromete los pliegues inguinales, con pápulas y pústulas satélites en la periferia.

¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento más adecuado?

A) Dermatitis irritativa del pañal; corticoide de alta potencia

B) Psoriasis del pañal; calcipotriol

C) Dermatitis del pañal sobreinfectada por Candida; antifúngico tópico (clotrimazol o nistatina) y medidas de cuidado del pañal

D) Impétigo; cefadroxilo oral

E) Dermatitis seborreica; ketoconazol oral

> **Respuesta C.** La dermatitis irritativa del pañal respeta los pliegues. El compromiso de pliegues con eritema intenso y lesiones satélites indica sobreinfección por Candida, frecuente tras más de 3 días de evolución. Se trata con antifúngico tópico, cambios frecuentes, aseo suave y pasta barrera. Los corticoides potentes están contraindicados en esta zona.

71 derma-07 · Perfil V3 6.01.1.006 · Dermatitis seborreica infantil y del adulto · *Práctica*

Hombre de 40 años consulta por descamación y enrojecimiento facial de 1 año, que empeora en invierno y en períodos de estrés. Al examen hay placas eritematosas mal delimitadas cubiertas por escamas amarillentas de aspecto oleoso en los surcos nasogenianos, las cejas y la región retroauricular, además de caspa en el cuero cabelludo.

¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

A) Terbinafina oral por 6 semanas

B) Isotretinoína oral

C) Ketoconazol al 2% tópico en crema y champú

D) Prednisona oral en dosis bajas por 1 mes

E) Peróxido de benzoílo en gel

> **Respuesta C.** Escamas amarillentas oleosas en zonas seborreicas, como surcos nasogenianos, cejas, retroauricular y cuero cabelludo, con brotes por frío y estrés, son una dermatitis seborreica del adulto. La base del tratamiento son los antifúngicos tópicos contra Malassezia, como ketoconazol en crema y champú; los corticoides tópicos de baja potencia solo en ciclos cortos.

72 derma-01 · Perfil V3 6.01.1.009 · Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin · *Práctica*

Mujer de 25 años consulta por nódulos dolorosos, eritemato-violáceos, calientes, de 2 a 4 cm, en la cara anterior de ambas piernas, de 1 semana. No se ulceran. Refiere odinofagia hace 3 semanas. Usa anticonceptivos orales.

¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial más adecuado?

A) Eritema indurado de Bazin; biopsia y PPD

B) Trombosis venosa superficial; ecografía Doppler

C) Vasculitis leucocitoclástica; biopsia urgente

D) Celulitis bilateral; antibióticos endovenosos

E) Eritema nodoso; estudio etiológico con ASO o cultivo faríngeo, radiografía de tórax y PPD

> **Respuesta E.** El eritema nodoso es una paniculitis septal reactiva: nódulos dolorosos en cara anterior de piernas que no se ulceran y curan sin cicatriz. Causas: estreptococo, fármacos (anticonceptivos), sarcoidosis, TBC, EII. Se busca la causa (ASO, radiografía de tórax, PPD). El eritema indurado de Bazin es lobulillar, en pantorrillas y tiende a ulcerarse.

73 derma-05 · Perfil V3 6.01.1.015 · Líquen plano · *Práctica*

Mujer de 45 años con pápulas planas, poligonales, violáceas y muy pruriginosas en la cara flexora de muñecas y tobillos, de 2 meses. En su superficie se observan finas estrías blanquecinas. Aparecieron nuevas lesiones sobre una excoriación lineal. En la mucosa yugal tiene un retículo blanquecino.

¿Cuál es el diagnóstico y qué examen de laboratorio conviene solicitar?

A) Liquen plano; serología de virus hepatitis C

B) Psoriasis; perfil lipídico

C) Pitiriasis rosada; VDRL

D) Lupus discoide; ANA

E) Prurigo nodular; IgE total

> **Respuesta A.** Pápulas planas, poligonales, púrpuras, pruriginosas con estrías de Wickham, fenómeno de Koebner y lesiones reticuladas en mucosa oral son liquen plano (las 6 P). Se asocia a hepatitis C, por lo que se solicita su serología. Se trata con corticoides tópicos potentes; el liquen plano oral erosivo crónico requiere seguimiento por riesgo de carcinoma.

74 derma-13 · Perfil V3 6.01.1.017 · Melanoma maligno · *Práctica*

Mujer de 50 años, sin metástasis demostradas, recibe el informe de la biopsia excisional de una lesión pigmentada del dorso que confirma un melanoma de extensión superficial.

¿Cuál es el factor pronóstico más importante en este melanoma localizado?

A) El diámetro de la lesión en la superficie

B) El número de colores de la lesión

C) El espesor tumoral de Breslow

D) La edad de la paciente

E) El tiempo de evolución referido por la paciente

> **Respuesta C.** En el melanoma localizado, el factor pronóstico más importante es el espesor de Breslow, medido en milímetros desde la capa granular hasta la célula tumoral más profunda. Define el estadio, los márgenes de ampliación y la indicación de biopsia de ganglio centinela. La ulceración es el segundo factor relevante.

75 derma-16 · Perfil V3 6.01.1.019 · Pediculosis · *Práctica*

Mujer de 32 años, madre de dos escolares con pediculosis, consulta por prurito del cuero cabelludo de 2 semanas. Al examen se observan piojos vivos y liendres firmemente adheridas al tallo del pelo, cerca de la raíz, en la región occipital y retroauricular. No está embarazada.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Ivermectina oral como primera línea y rapado del cabello

B) Corticoide tópico y antihistamínico oral

C) Champú de ketoconazol por 4 semanas

D) Permetrina al 1% en loción aplicada en el cuero cabelludo, repetida a los 7 a 10 días, con retiro mecánico de liendres y tratamiento de los convivientes afectados

E) Lavado diario de cabello con agua y vinagre como única medida

> **Respuesta D.** La pediculosis capitis se trata con pediculicida tópico, de elección permetrina al 1%, repitiendo a los 7 a 10 días porque no es completamente ovicida. Se agrega retiro de liendres con peineta fina, tratamiento simultáneo de los convivientes afectados y lavado de ropa de cama y peinetas.

76 derma-16 · Perfil V3 6.01.1.023 · Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos · *Práctica*

Niño de 4 años con lesiones muy pruriginosas de 1 semana, tras vacaciones en el campo. Al examen hay pápulas eritematosas con vesícula central y excoriaciones agrupadas en zonas descubiertas (piernas y antebrazos), algunas en línea de 3. Nadie más en la casa tiene prurito y no hay lesiones en pliegues interdigitales ni genitales.

¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?

A) Prúrigo agudo infantil por picadura de insectos; antihistamínico oral, corticoide tópico de baja o mediana potencia y control de insectos

B) Escabiosis; permetrina a toda la familia

C) Varicela; aciclovir

D) Impétigo; mupirocina

E) Dermatitis atópica; inmunomoduladores tópicos

> **Respuesta A.** Pápulas seropápulas pruriginosas agrupadas en zonas expuestas, en brotes estacionales y en grupos de 3 (desayuno, almuerzo y cena), corresponden a prúrigo por picadura de insectos (pulgas, mosquitos), una reacción de hipersensibilidad. Se maneja con antihistamínicos, corticoide tópico, repelentes y control ambiental. La sarna afecta pliegues y a los convivientes.

77 derma-09 · Perfil V3 6.01.1.025 · Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija) · *Práctica*

Mujer de 30 años consulta por tercera vez en un año por una mancha redonda de 3 cm en el dorso de la mano, eritematoviolácea, con ardor, que aparece siempre en el mismo sitio unas horas después de tomar ibuprofeno por dismenorrea. Al resolverse deja una mancha café grisácea. No tiene compromiso de mucosas ni fiebre.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Eritema multiforme menor

B) Dermatitis de contacto alérgica

C) Urticaria aguda

D) Síndrome de Stevens-Johnson

E) Eritema pigmentado fijo

> **Respuesta E.** La toxidermia fija o eritema pigmentado fijo es una placa eritematoviolácea que reaparece siempre en el mismo sitio tras reexponerse al mismo fármaco, típicamente AINEs, cotrimoxazol o tetraciclinas, y deja hiperpigmentación residual. El tratamiento es suspender y evitar el fármaco.

78 derma-01 · Perfil V3 6.01.1.032 · Vitiligo · *Práctica*

Mujer de 30 años con manchas blancas de 1 año, simétricas, en dorso de manos, alrededor de la boca y en ambos codos. Son máculas acrómicas de bordes netos, sin descamación, que se acentúan con la luz de Wood. Tiene hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pitiriasis versicolor

B) Lepra tuberculoide

C) Hipopigmentación postinflamatoria

D) Pitiriasis alba

E) Vitiligo

> **Respuesta E.** Máculas acrómicas (sin melanina), de bordes netos, simétricas en zonas periorificiales y acrales, que se intensifican con luz de Wood, son vitiligo, enfermedad autoinmune asociada a tiroiditis, diabetes tipo 1 y anemia perniciosa. Se trata con corticoides o inhibidores de calcineurina tópicos y fototerapia. La pitiriasis versicolor es hipocrómica y descama al rascado.

79 derma-08 · Perfil V3 6.01.2.001 · Angioedema de Quinque · *Práctica*

Hombre de 28 años consulta 30 minutos después de comer mariscos por hinchazón progresiva de labios y lengua, con voz ronca y sensación de cierre de la garganta. Presión arterial 118/76, frecuencia cardíaca 104, saturación 95%. No tiene habones.

¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Clorfenamina oral y observación

B) Inhibidor C1 esterasa endovenoso

C) Prednisona oral y control al día siguiente

D) Adrenalina 0,5 mg intramuscular en la cara anterolateral del muslo

E) Alta con loratadina por 7 días

> **Respuesta D.** Angioedema alérgico de labios y lengua con disfonía y sensación de cierre faríngeo indica compromiso de la vía aérea: es una emergencia. El tratamiento inmediato es adrenalina intramuscular, 0,5 mg en el adulto, en el muslo, repetible a los 5 a 15 minutos. Antihistamínicos y corticoides son coadyuvantes y no la reemplazan.

80 derma-05 · Perfil V3 6.01.2.004 · Eritrodermia · *Práctica*

Hombre de 55 años con psoriasis en placas, que suspendió bruscamente prednisona oral indicada por un médico particular. Consulta por eritema y descamación de más del 90% de la superficie corporal, calofríos, temperatura de 38 °C y edema de extremidades.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Manejo ambulatorio con corticoide tópico de alta potencia en todo el cuerpo

B) Antihistamínico oral y control en 1 mes

C) Reiniciar prednisona en dosis altas y alta

D) Hospitalización para manejo de soporte (control de temperatura, balance hídrico y electrolítico, prevención de infecciones) y tratamiento por dermatología

E) Fototerapia ambulatoria

> **Respuesta D.** La eritrodermia (eritema y descamación en más del 90% de la superficie) es una urgencia dermatológica: pérdida de calor, agua y proteínas, insuficiencia cardíaca de alto gasto e infección. Requiere hospitalización, soporte, emolientes, corticoide tópico de baja potencia y tratamiento de la causa (aquí psoriasis desencadenada por suspensión de corticoides sistémicos, que no deben usarse en psoriasis).

81 derma-09 · Perfil V3 6.01.2.014 · Síndrome de piel escaldada por estafilococos · *Práctica*

Niño de 3 años con fiebre e irritabilidad de 2 días tras una conjuntivitis purulenta. Presenta eritema difuso, doloroso al tacto, más intenso en pliegues y periorificial, con costras radiadas alrededor de la boca y ampollas flácidas que se rompen dejando áreas denudadas. Nikolsky positivo. Las mucosas oral y conjuntival no tienen erosiones.

¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

A) Síndrome de piel escaldada por estafilococo; hospitalización y cloxacilina (o cefazolina) endovenosa con soporte

B) Necrólisis epidérmica tóxica; suspender fármacos e inmunoglobulina

C) Impétigo ampollar localizado; mupirocina

D) Escarlatina; amoxicilina oral

E) Pénfigo vulgar; corticoides sistémicos

> **Respuesta A.** En niños pequeños, una toxina exfoliativa del S. aureus produce despegamiento intraepidérmico superficial (granuloso) a distancia del foco: eritema doloroso, Nikolsky positivo y costras periorificiales, sin compromiso de mucosas. Se hospitaliza y trata con antiestafilocócico endovenoso y soporte (hidratación, analgesia). En la NET hay mucosas comprometidas y antecedente de fármaco.

82 derma-08 · Perfil V3 6.01.2.016 · Urticaria y angioedema · *Práctica*

Mujer de 30 años presenta, 1 hora después de tomar ibuprofeno, habones pruriginosos generalizados y edema de labios y párpados. No tiene disfonía, estridor, disnea, sibilancias, vómitos ni hipotensión. PA 120/75 mmHg, saturación 98%.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Adrenalina intramuscular y hospitalización en UCI

B) Concentrado de inhibidor de C1 esterasa

C) Intubación orotraqueal profiláctica

D) Suspender el AINE, antihistamínico H1 de segunda generación y eventual curso corto de corticoide oral, con observación y educación sobre signos de anafilaxia

E) Antibiótico oral

> **Respuesta D.** Urticaria aguda con angioedema sin compromiso de vía aérea, respiratorio, digestivo ni hemodinámico no es anafilaxia: se suspende el desencadenante y se indican antihistamínicos H1 de segunda generación (pueden aumentarse hasta 4 veces la dosis), con corticoide oral breve si es extensa. La adrenalina IM se reserva para anafilaxia o angioedema laríngeo.

83 derma-14 · Perfil V3 6.01.3.001 · Fotoprotección · *Práctica*

Madre consulta en control sano sobre medidas de fotoprotección para su hijo de 4 años y para ella, que tiene fototipo II.

¿Cuál es la recomendación más adecuada?

A) Usar fotoprotector solo los días soleados de verano

B) Evitar la exposición entre las 10 y 16 horas, usar ropa, sombrero y lentes con filtro UV, y fotoprotector FPS 30 o más, reaplicado cada 2 a 3 horas y tras bañarse

C) Aplicar fotoprotector una vez al día en la mañana es suficiente

D) Las camas solares previas al verano protegen contra quemaduras

E) En lactantes menores de 6 meses se recomienda fotoprotector químico abundante como primera medida

> **Respuesta B.** La fotoprotección se basa en evitar el sol del mediodía, medidas físicas (sombra, ropa, sombrero, lentes) y fotoprotector de amplio espectro FPS 30 o más, aplicado 30 minutos antes y reaplicado cada 2 a 3 horas y tras el agua, incluso nublado. Las camas solares aumentan el riesgo de melanoma. Bajo 6 meses priman las medidas físicas.

84 derma-16 · Perfil V3 6.01.4.001 · Acarotest · *Práctica*

Hombre de 35 años con prurito intenso de predominio nocturno de 3 semanas. Su pareja tiene síntomas similares. Al examen se observan pápulas excoriadas en espacios interdigitales, muñecas, ombligo y genitales, y algunos surcos lineales finos.

¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico?

A) Micológico directo con KOH

B) Test de Tzanck

C) Biopsia de piel con inmunofluorescencia

D) IgE total

E) Acarotest: raspado de un surco con observación microscópica del ácaro, huevos o deyecciones

> **Respuesta E.** Prurito nocturno, convivientes afectados, distribución en pliegues interdigitales, muñecas, ombligo y genitales y surcos acarinos sugieren escabiosis. El acarotest (raspado del surco y microscopía) confirma al observar Sarcoptes scabiei, huevos o fecas; tiene alta especificidad pero sensibilidad limitada, por lo que un resultado negativo no descarta y se trata ante clínica sugerente.

85 derma-13 · Perfil V3 6.01.4.002 · Dermatoscopía · *Práctica*

Mujer de 40 años con múltiples nevos consulta por un nevo en la espalda que su pareja nota diferente a los demás. Mide 7 mm, es asimétrico, de bordes irregulares y con 2 tonos de marrón.

¿Cuál es la principal utilidad de la dermatoscopía en este caso?

A) Aumenta la sensibilidad y especificidad del examen clínico para identificar lesiones sospechosas de melanoma y decidir cuáles biopsiar

B) Reemplaza a la biopsia como diagnóstico definitivo de melanoma

C) Mide la profundidad de Breslow

D) Detecta metástasis ganglionares

E) Solo sirve para diagnosticar micosis

> **Respuesta A.** La dermatoscopía es un examen no invasivo con aumento y luz polarizada que permite ver estructuras pigmentarias no visibles a simple vista (retículo atípico, velo azul-blanquecino, puntos irregulares). Mejora la precisión diagnóstica del melanoma respecto al ojo desnudo y orienta qué lesiones extirpar; el diagnóstico definitivo y el Breslow los da la histología.

86 derma-16 · Perfil V3 6.01.4.004 · Micológico directo de piel, pelos y uñas · *Práctica*

Hombre de 35 años consulta por una placa anular de 4 cm en el tronco, pruriginosa, con borde eritematoso descamativo activo y centro más claro, de 3 semanas de evolución. No ha usado ningún tratamiento.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Examen micológico directo con hidróxido de potasio y cultivo de escamas obtenidas del borde activo

B) Biopsia de piel del centro de la lesión

C) Prueba del parche

D) Inmunoglobulina E sérica

E) Cultivo bacteriano de la lesión

> **Respuesta A.** La sospecha es una tiña corporis. Se confirma con micológico directo: se raspan escamas del borde activo, donde están las hifas, y se observan con hidróxido de potasio, complementado con cultivo para identificar la especie. Si el paciente ya usó antifúngicos, conviene suspenderlos 1 a 2 semanas antes para evitar falsos negativos.

87 derma-12 · Perfil V3 6.01.4.006 · Test TZANCK · *Práctica*

Mujer de 25 años con vesículas agrupadas sobre base eritematosa en el labio superior, precedidas de ardor. Se realiza raspado de la base de una vesícula reciente con tinción de Giemsa (test de Tzanck).

¿Qué hallazgo se espera y cuál es su principal limitación?

A) Células gigantes multinucleadas; no distingue entre virus herpes simple y varicela-zóster

B) Hifas tabicadas; no distingue dermatofitos

C) Cocos gram positivos en racimos; no distingue S. aureus de S. epidermidis

D) Ácaros; baja sensibilidad

E) Células de Sézary; requiere citometría

> **Respuesta A.** El test de Tzanck muestra queratinocitos acantolíticos y células gigantes multinucleadas en lesiones por herpes simple y varicela-zóster, pero no diferencia entre ellos y tiene sensibilidad moderada. La PCR viral es hoy el examen de elección. También muestra células acantolíticas en el pénfigo vulgar.

88 derma-11 · Perfil V3 6.01.5.001 · Biopsia de piel · *Práctica*

Hombre de 72 años presenta hace 3 semanas ampollas tensas de contenido seroso sobre placas eritematosas en el abdomen y las caras internas de los muslos, con prurito intenso y sin compromiso de mucosas. Se sospecha una enfermedad ampollar autoinmune.

¿Cuál es el estudio más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Cultivo del contenido de la ampolla

B) Biopsia de una ampolla reciente para histología y biopsia de piel perilesional para inmunofluorescencia directa

C) Test de Tzanck

D) Biopsia del centro de una erosión antigua

E) Examen micológico directo

> **Respuesta B.** En enfermedades ampollares autoinmunes se toman dos muestras: una ampolla reciente e intacta para histología, que muestra el nivel de separación, y piel perilesional sana para inmunofluorescencia directa, que muestra el depósito de anticuerpos. Las erosiones antiguas no sirven porque el tejido está destruido.

Diabetes

89 diab-02 · Perfil V3 1.01.1.023 · Síndrome metabólico · *Práctica*

Un hombre de 48 años asiste a control de salud. Tiene circunferencia de cintura de 106 cm, presión arterial 136/86 mmHg, glicemia de ayuno 108 mg/dL, triglicéridos 190 mg/dL y colesterol HDL 36 mg/dL. No usa fármacos.

¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A) Diabetes mellitus tipo 2

B) Síndrome metabólico

C) Hipertensión arterial etapa 1

D) Hipercolesterolemia familiar

E) Síndrome de Cushing

> **Respuesta B.** Cumple los 5 criterios de síndrome metabólico (bastan 3): obesidad abdominal, PA ≥130/85 mmHg, glicemia de ayuno ≥100 mg/dL, triglicéridos ≥150 mg/dL y HDL bajo 40 mg/dL en hombres. No tiene diabetes (ayuno bajo 126) ni hipertensión (bajo 140/90). Implica alto riesgo cardiovascular.

90 diab-05 · Perfil V3 1.01.3.001 · Alimentación saludable · *Práctica*

Un hombre de 50 años, normotenso, con IMC de 26 kg/m², consulta para recibir consejería alimentaria de prevención cardiovascular. Refiere que agrega sal a las comidas y consume pan, embutidos y snacks a diario.

¿Cuál es el consumo máximo diario de sal recomendado para un adulto?

A) 1 g/día

B) 15 g/día

C) 10 g/día

D) Menos de 5 g/día (una cucharadita)

E) No hay límite si la presión arterial es normal

> **Respuesta D.** La OMS y las guías chilenas recomiendan menos de 5 g de sal al día (unos 2 g de sodio). Reducir la sal baja la presión arterial, también en normotensos, y disminuye el riesgo cardiovascular. La mayor parte proviene de alimentos procesados como pan y embutidos, no solo del salero.

91 diab-05 · Perfil V3 1.01.3.004 · Obesidad y sobrepeso · *Práctica*

Una mujer de 40 años pesa 78 kg y mide 1,60 m. Su circunferencia de cintura es de 94 cm. No tiene comorbilidades conocidas.

¿Cómo se clasifica su estado nutricional según el IMC?

A) Normal

B) Obesidad grado I

C) Sobrepeso

D) Obesidad grado II

E) Obesidad mórbida

> **Respuesta B.** IMC = 78 / (1,60)² ≈ 30,5 kg/m². En adultos: 18,5-24,9 normal, 25-29,9 sobrepeso, 30-34,9 obesidad I, 35-39,9 obesidad II y ≥40 obesidad mórbida. Además, una cintura sobre 88 cm en mujeres indica obesidad abdominal y mayor riesgo cardiometabólico.

92 diab-05 · Perfil V3 1.01.3.006 · Sedentarismo vs actividad física · *Práctica*

Un hombre de 45 años, oficinista, sedentario y sin enfermedades, pregunta cuánta actividad física necesita para reducir su riesgo cardiovascular.

¿Cuál es la recomendación mínima de actividad física para adultos?

A) 30 minutos de caminata una vez por semana

B) Solo actividad física si tiene sobrepeso

C) 20 minutos diarios de elongación

D) 60 minutos de ejercicio intenso todos los días, sin excepción

E) 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, más fortalecimiento muscular 2 días por semana

> **Respuesta E.** La OMS recomienda al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (o 75 a 150 vigorosa), más ejercicios de fuerza 2 o más días por semana, y reducir el tiempo sentado. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular independiente, incluso con peso normal.

93 diab-23 · Perfil V3 1.01.4.013 · Perfil lipídico · *Práctica*

Un hombre de 50 años se realiza un perfil lipídico con 12 horas de ayuno: colesterol total 260 mg/dL, HDL 40 mg/dL y triglicéridos 600 mg/dL. El laboratorio no informa el LDL calculado.

¿Por qué no se informa el colesterol LDL?

A) Porque el ayuno fue insuficiente

B) Porque el LDL solo se mide en diabéticos

C) Porque el HDL es bajo

D) Porque el colesterol total es normal

E) Porque la fórmula de Friedewald no es válida con triglicéridos sobre 400 mg/dL

> **Respuesta E.** El LDL suele calcularse con Friedewald: LDL = CT – HDL – TG/5. Con triglicéridos sobre 400 mg/dL la fórmula pierde validez y se mide el LDL directo o se usa el colesterol no-HDL (CT – HDL), aquí 220 mg/dL. Con TG sobre 500, la prioridad es bajarlos para prevenir pancreatitis.

94 diab-10 · Perfil V3 1.02.1.010 · Nefropatía incipiente · *Práctica*

Mujer de 54 años con DM2 de 7 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 7,0 %, PA 124/76 mmHg. En su control anual se pide una muestra de orina matinal: razón albúmina/creatinina (RAC) de 48 mg/g. Creatinina 0,8 mg/dL, VFG 90 mL/min. No tiene fiebre, infección urinaria ni ha hecho ejercicio intenso.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la RAC hasta completar 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses

B) Iniciar losartán por nefropatía diabética

C) Derivar a nefrología para biopsia renal

D) Solicitar orina de 24 horas para proteinuria y repetir en un año

E) Iniciar restricción proteica y control en un año

> **Respuesta A.** La albuminuria varía mucho de un día a otro. La nefropatía incipiente (RAC 30–300 mg/g) se confirma con 2 de 3 muestras alteradas en un plazo de 3 a 6 meses, descartando infección, fiebre o ejercicio. Confirmada, se indica IECA o ARA II.

95 diab-22 · Perfil V3 1.02.1.011 · Neuropatía diabética · *Práctica*

Hombre de 59 años con DM2 de 12 años de evolución, HbA1c 8,1 %. Asintomático. En su control anual en el CESFAM se examinan los pies: piel íntegra, sin deformidades, pulsos pedios presentes. No percibe el monofilamento de 10 g en 4 de 10 puntos plantares de cada pie y tiene la sensibilidad vibratoria disminuida con diapasón de 128 Hz.

¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?

A) Polineuropatía diabética con pérdida de sensibilidad protectora: pie de alto riesgo, educación, calzado adecuado y controles frecuentes

B) Examen normal; repetir en un año

C) Enfermedad arterial periférica; solicitar índice tobillo-brazo urgente

D) Iniciar pregabalina para prevenir úlceras

E) Derivar a neurología para electromiografía antes de clasificar el riesgo

> **Respuesta A.** La pérdida de sensibilidad al monofilamento de 10 g demuestra polineuropatía con pérdida de la sensibilidad protectora, el principal factor de riesgo de úlcera. Se clasifica como pie de riesgo: educación en autocuidado, calzado adecuado, podología y control más frecuente. La electromiografía no es necesaria y la pregabalina es solo para el dolor neuropático.

96 diab-05 · Perfil V3 1.02.1.013 · Obesidad mórbida · *Práctica*

Una mujer de 38 años, con IMC de 42 kg/m², hipertensa y con DM2, ha intentado bajar de peso por más de 2 años con dieta, ejercicio y apoyo farmacológico, sin éxito. No tiene trastorno psiquiátrico descompensado ni consumo de alcohol o drogas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Insistir solo con dieta hipocalórica estricta

B) Indicar liposucción

C) Indicar ayuno intermitente prolongado

D) Iniciar levotiroxina para aumentar el gasto energético

E) Derivar a evaluación multidisciplinaria para cirugía bariátrica

> **Respuesta E.** Con IMC ≥40 kg/m², o ≥35 con comorbilidades, y fracaso del tratamiento médico, la cirugía bariátrica (manga gástrica o bypass) es la terapia más eficaz para bajar de peso en forma sostenida y mejora la diabetes y la HTA. Requiere evaluación multidisciplinaria previa. La liposucción no trata la obesidad ni sus comorbilidades.

97 diab-21 · Perfil V3 1.02.1.015 · Retinopatía diabética · *Práctica*

Mujer de 63 años con DM2 de 14 años de evolución, HbA1c 8,4 %, hipertensa. Consulta por visión borrosa progresiva del ojo derecho de 3 meses, sin dolor ni ojo rojo. Agudeza visual 20/60 en el ojo derecho. El fondo de ojo muestra microaneurismas, exudados duros en anillo y engrosamiento retinal que compromete el centro de la fóvea, sin neovasos. La tomografía de coherencia óptica confirma edema macular.

¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Panfotocoagulación con láser

B) Inyecciones intravítreas de anti-VEGF

C) Vitrectomía

D) Solo optimizar el control glicémico y repetir fondo de ojo en un año

E) Corticoides tópicos

> **Respuesta B.** El edema macular es la causa más frecuente de baja visual moderada en la diabetes. Cuando compromete el centro de la fóvea, la primera línea son las inyecciones intravítreas de anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept). La panfotocoagulación con láser se reserva para la retinopatía proliferativa, con neovasos.

98 diab-22 · Perfil V3 1.02.1.019 · Vasculopatía periférica · *Práctica*

Un hombre de 64 años, diabético y fumador, refiere dolor en ambas pantorrillas al caminar 200 metros, que cede a los pocos minutos de reposo. Los pulsos pedios están disminuidos y el índice tobillo-brazo es 0,7.

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Cesación tabáquica, ejercicio supervisado, estatina y antiagregante plaquetario

B) Revascularización quirúrgica inmediata

C) Anticoagulación oral

D) Amputación infracondílea

E) Reposo absoluto en cama

> **Respuesta A.** Claudicación intermitente con ITB bajo 0,9 confirma enfermedad arterial periférica. El manejo inicial es reducir el riesgo cardiovascular (dejar de fumar, estatina de alta intensidad, antiagregante, control de diabetes y PA) más ejercicio supervisado, que aumenta la distancia de marcha. La revascularización se reserva para isquemia crítica o claudicación invalidante.

99 diab-07 · Perfil V3 1.02.2.001 · Acidosis láctica · *Práctica*

Hombre de 71 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas desde hace 8 años, sin controles recientes. Consulta por 3 días de vómitos, dolor abdominal difuso y decaimiento. Está taquipneico, con respiración profunda, PA 95/60 mmHg. Glicemia 165 mg/dL, cetonemia negativa, creatinina 3,4 mg/dL (VFG 18 mL/min), pH 7,08, HCO3 7 mEq/L, anión gap 26, lactato 11 mmol/L.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cetoacidosis diabética

B) Hipoglicemia por metformina

C) Estado hiperglicémico hiperosmolar

D) Acidosis tubular renal

E) Acidosis láctica asociada a metformina

> **Respuesta E.** Acidosis metabólica grave con anión gap elevado, lactato alto, cetonas negativas y glicemia casi normal en un usuario de metformina con falla renal: acidosis láctica asociada a metformina. Se suspende la metformina y la hemodiálisis corrige la acidosis y elimina el fármaco.

100 diab-16 · Perfil V3 1.02.2.003 · Coma hiperosmolar · *Práctica*

Mujer de 80 años con DM2, ingresada en coma por estado hiperglicémico hiperosmolar: glicemia 950 mg/dL, Na 142 mEq/L, osmolaridad efectiva 360 mOsm/L, sin cetosis. Recibió 4 litros de suero fisiológico en 3 horas e insulina en bomba a 0,14 UI/kg/h, sin agregar suero glucosado. A las 6 horas la glicemia es de 210 mg/dL; tras recuperar parcialmente la conciencia, presenta cefalea, bradicardia, vómitos y una convulsión tónico-clónica.

¿Cuál es la causa más probable del deterioro?

A) Hipoglicemia por la infusión de insulina

B) Accidente cerebrovascular hemorrágico por hipertensión

C) Hipernatremia por el suero fisiológico

D) Cetoacidosis diabética sobreagregada

E) Edema cerebral por descenso demasiado rápido de la osmolaridad

> **Respuesta E.** En el coma hiperosmolar la neurona se adaptó al medio hiperosmolar. Si la glicemia y la osmolaridad caen bruscamente (aquí 740 mg/dL en 6 horas), el agua entra a la célula y aparece edema cerebral. La glicemia debe bajar 50 a 75 mg/dL por hora, con suero glucosado al llegar a 300 mg/dL.

101 diab-24 · Perfil V3 1.02.2.005 · Hipertrigliceridemia grave · *Práctica*

Hombre de 47 años, con obesidad, DM2 en tratamiento con metformina y consumo de 5 cervezas diarias. Asintomático. En un control se informa suero lactescente, triglicéridos 1.450 mg/dL, colesterol total 310 mg/dL, HDL 26 mg/dL. Lipasa normal. Examen abdominal sin dolor.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar atorvastatina 80 mg/día

B) Solo dieta y control en 6 meses, ya que está asintomático

C) Iniciar ezetimibe y controlar en 3 meses

D) Iniciar fibrato, suspender completamente el alcohol y dieta muy baja en grasas

E) Agregar gemfibrozilo a una estatina en dosis alta

> **Respuesta D.** Triglicéridos sobre 1.000 mg/dL: hipertrigliceridemia grave con alto riesgo de pancreatitis aguda. La prioridad deja de ser el LDL; se inicia de inmediato un fibrato, se suspende totalmente el alcohol y se indica una dieta prácticamente sin grasas, además de optimizar el control glicémico. El gemfibrozilo no se combina con estatinas.

102 diab-15 · Perfil V3 1.02.2.007 · Síndrome hiperosmolar no cetósico · *Práctica*

Hombre de 78 años con DM2 en tratamiento con metformina, traído por 5 días de poliuria, sed intensa y decaimiento, con escasa ingesta de líquidos. Está somnoliento pero responde, mucosas secas, PA 100/60 mmHg, FC 108 lpm. Glicemia 780 mg/dL, Na 146 mEq/L, nitrógeno ureico 58 mg/dL, pH 7,35, HCO3 21 mEq/L, cetonemia negativa. Osmolaridad efectiva calculada 336 mOsm/L. Potasio 4,6 mEq/L.

¿Cuál es la primera medida terapéutica?

A) Bolo de insulina cristalina endovenosa de 0,1 UI/kg

B) Bicarbonato de sodio endovenoso

C) Suero glucosado al 5 %

D) Solución fisiológica al 0,9 % 1 a 1,5 litros en la primera hora

E) Suero hipotónico al 0,45 % en bolo rápido

> **Respuesta D.** Estado hiperglicémico hiperosmolar: glicemia sobre 600 mg/dL, osmolaridad sobre 320 mOsm/L, sin cetosis ni acidosis importante. El déficit de agua es enorme, así que lo primero es solución fisiológica al 0,9 %. La insulina se inicia después de hidratar y con potasio sobre 3,3 mEq/L.

103 diab-17 · Perfil V3 1.02.2.007 · Síndrome hiperosmolar no cetósico · *Práctica*

Hombre de 74 años en tratamiento por estado hiperglicémico hiperosmolar (glicemia de ingreso 840 mg/dL, sin cetosis). Ya recibió la reposición inicial de volumen y está con NaCl 0,45 % e insulina cristalina en infusión endovenosa continua. K 4,2 mEq/L. A las 8 horas la glicemia es de 290 mg/dL, la osmolaridad efectiva 326 mOsm/L y aún está somnoliento.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar suero glucosado al 5 % y reducir la infusión de insulina

B) Suspender la insulina hasta que la glicemia vuelva a subir

C) Mantener la misma infusión hasta lograr glicemia bajo 150 mg/dL

D) Pasar a insulina NPH subcutánea

E) Administrar un bolo de insulina para acelerar la corrección

> **Respuesta A.** En el estado hiperosmolar, cuando la glicemia llega a 300 mg/dL se agrega suero glucosado al 5 % y se reduce la insulina a 0,02–0,05 UI/kg/h, manteniendo la glicemia entre 250 y 300 mg/dL hasta que la osmolaridad baje de 315 y el paciente esté lúcido. Así se evita una caída brusca de la osmolaridad.

104 diab-18 · Perfil V3 1.02.2.007 · Síndrome hiperosmolar no cetósico · *Práctica*

Mujer de 76 años con DM2, hospitalizada hace 30 horas por estado hiperglicémico hiperosmolar, con insulina cristalina en infusión endovenosa y suero glucosado. Control actual: glicemia 240 mg/dL, Na 141 mEq/L, osmolaridad efectiva 309 mOsm/L, pH 7,38, K 4,0 mEq/L. Está lúcida, orientada como antes del cuadro, y pide comer.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener la infusión endovenosa hasta lograr glicemia bajo 140 mg/dL

B) Administrar insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa 1 a 2 horas más antes de suspenderla

C) Suspender la bomba y controlar con hemoglucotest sin insulina

D) Suspender la bomba y administrar solo insulina cristalina subcutánea según hemoglucotest

E) Mantener régimen cero y la infusión por 24 horas más

> **Respuesta B.** El estado hiperosmolar está resuelto: osmolaridad efectiva bajo 315 mOsm/L, glicemia bajo 250–300 mg/dL y paciente lúcida que tolera la vía oral. Se pasa a insulina subcutánea traslapando: se inyecta la basal y la bomba se mantiene 1 a 2 horas, porque la insulina endovenosa dura solo minutos.

105 diab-19 · Perfil V3 1.02.2.007 · Síndrome hiperosmolar no cetósico · *Práctica*

Hombre de 81 años, postrado, con DM2, hospitalizado por estado hiperglicémico hiperosmolar secundario a una neumonía: glicemia 920 mg/dL, osmolaridad efectiva 352 mOsm/L, sin cetosis. Se inicia hidratación con suero fisiológico, insulina en infusión endovenosa y antibióticos. Plaquetas 210.000/mm³, sin sangrado activo ni contraindicaciones.

Además del tratamiento indicado, ¿qué medida corresponde agregar?

A) Bicarbonato de sodio endovenoso

B) Fosfato de potasio endovenoso de rutina

C) Profilaxis de trombosis venosa con heparina de bajo peso molecular

D) Manitol profiláctico

E) Restricción de líquidos para evitar edema cerebral

> **Respuesta C.** La deshidratación extrema, la hiperviscosidad y la inmovilidad hacen del estado hiperosmolar un cuadro con alto riesgo trombótico, tanto venoso como arterial. Se indica profilaxis con heparina de bajo peso molecular salvo contraindicación. El bicarbonato no se usa porque no hay acidosis, y el fosfato solo se repone si es menor de 1 mg/dL.

106 diab-05 · Perfil V3 1.02.3.001 · Alimentación saludable · *Práctica*

Una mujer de 35 años, sana, solicita orientación sobre alimentación saludable para su familia.

Según las Guías Alimentarias para la Población Chilena, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es correcta?

A) Preferir jugos de fruta azucarados a la fruta entera

B) Consumir pescado solo una vez al mes

C) Consumir legumbres al menos 2 veces por semana

D) Consumir 1 porción de frutas y verduras al día

E) Evitar completamente los lácteos en adultos

> **Respuesta C.** Las Guías Alimentarias chilenas recomiendan legumbres y pescado al menos 2 veces por semana, 5 porciones diarias de frutas y verduras de distintos colores, 3 porciones de lácteos bajos en grasa y azúcar, 6 a 8 vasos de agua y evitar alimentos con sellos 'ALTO EN'. La fruta entera se prefiere a los jugos.

107 diab-05 · Perfil V3 1.02.3.003 · Diabetes y riesgo cardiovascular · *Práctica*

Hombre de 52 años con DM2 de 2 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 6,9 %. No fuma. Presión arterial 128/80 mmHg. Sin antecedentes de infarto ni ACV. Perfil lipídico: colesterol total 196 mg/dL, LDL 112 mg/dL, HDL 44 mg/dL, triglicéridos 180 mg/dL. Creatinina normal.

Según el Programa de Salud Cardiovascular del MINSAL, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a su riesgo cardiovascular?

A) No requiere estatina, porque su LDL es menor de 130 mg/dL

B) Calcular el riesgo con tablas y repetir perfil lipídico en un año

C) Iniciar gemfibrozilo por la hipertrigliceridemia

D) Iniciar aspirina 100 mg/día como prevención primaria

E) Iniciar atorvastatina, porque la diabetes lo clasifica como alto riesgo cardiovascular

> **Respuesta E.** En el Programa de Salud Cardiovascular, la persona con diabetes mayor de 40 años se clasifica directamente como alto riesgo cardiovascular, sin necesidad de tablas, y se le indica estatina independiente del LDL. La aspirina no se indica de rutina en prevención primaria.

108 diab-04 · Perfil V3 1.02.3.005 · Prevención de complicaciones crónicas de la diabetes · *Práctica*

Hombre de 58 años con DM2 de 6 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 7,2 %. Presión arterial 126/78 mmHg. En su control anual se detecta una razón albúmina/creatinina urinaria de 85 mg/g, que se confirma en una segunda muestra 2 meses después. Creatinina 0,9 mg/dL, VFG 88 mL/min.

¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la progresión de la nefropatía?

A) Cambiar la metformina por glibenclamida

B) Restringir las proteínas a 0,4 g/kg/día

C) Iniciar enalapril o losartán

D) Controlar la albuminuria en un año, ya que la presión es normal

E) Agregar amlodipino

> **Respuesta C.** Albuminuria moderadamente elevada confirmada (30–300 mg/g) en diabético: se indica IECA o ARA II aunque la presión sea normal, porque reducen la albuminuria y retrasan la nefropatía. La restricción proteica extrema no se recomienda y el amlodipino no tiene efecto antiproteinúrico.

109 diab-23 · Perfil V3 1.02.3.007 · Prevención de dislipidemias · *Práctica*

Un hombre de 42 años, con colesterol LDL de 145 mg/dL, sin otros factores de riesgo y con riesgo cardiovascular bajo, pregunta qué cambio alimentario reduce más su LDL.

¿Cuál es la medida dietética más efectiva para reducir el colesterol LDL?

A) Suprimir todas las grasas, incluidos el aceite de oliva y los frutos secos

B) Eliminar completamente los huevos

C) Aumentar el consumo de azúcares simples

D) Consumir más carnes rojas procesadas

E) Reducir las grasas saturadas y trans, reemplazándolas por grasas insaturadas

> **Respuesta E.** Las grasas saturadas (carnes grasas, mantequilla, embutidos) y trans son los principales determinantes dietéticos del LDL. Reemplazarlas por grasas insaturadas (aceite de oliva o canola, frutos secos, pescado), sumando fibra soluble y actividad física, es la base de la prevención. El colesterol del huevo influye menos.

110 diab-22 · Perfil V3 1.02.3.009 · Prevención de pié diabético · *Práctica*

En el control de una mujer de 60 años con DM2 de 12 años de evolución, el examen con monofilamento de 10 g muestra pérdida de sensibilidad en ambos pies. No tiene úlceras ni deformidades y los pulsos son normales.

¿Cuál es la medida preventiva más adecuada?

A) Indicar caminar descalza para fortalecer los pies

B) Educación en autocuidado con inspección diaria de los pies, calzado adecuado y control podológico periódico

C) Remojar los pies en agua caliente diariamente

D) Amputación profiláctica de ortejos

E) Controlar los pies solo si aparece una úlcera

> **Respuesta B.** La pérdida de sensibilidad protectora al monofilamento aumenta el riesgo de ulceración. Se indica educación (inspección diaria, secado entre ortejos, no andar descalza, no remojar en agua caliente), calzado adecuado, podología y controles periódicos. Todo diabético debe tener evaluación de riesgo de pie al menos una vez al año.

111 diab-24 · Perfil V3 1.02.3.011 · Regímenes dietéticos para dislipidemias · *Práctica*

Un hombre de 46 años, obeso, consume 4 a 5 latas de cerveza diarias y bebidas azucaradas. Su perfil lipídico muestra triglicéridos de 650 mg/dL y LDL de 110 mg/dL. No tiene antecedente de pancreatitis.

Además del tratamiento farmacológico, ¿cuál es la medida dietética más importante?

A) Aumentar el consumo de pan blanco

B) Aumentar el consumo de jugos de fruta

C) Dieta rica en grasas saturadas y baja en proteínas

D) Eliminar exclusivamente el huevo

E) Suspender el alcohol y reducir azúcares simples y carbohidratos refinados

> **Respuesta E.** La hipertrigliceridemia responde especialmente a suprimir el alcohol, reducir azúcares simples (bebidas, jugos, dulces) y carbohidratos refinados, bajar de peso y hacer ejercicio. Con triglicéridos sobre 500 mg/dL se agrega fibrato por riesgo de pancreatitis, y sobre 1.000 mg/dL, restricción estricta de grasas. El huevo influye poco.

112 diab-05 · Perfil V3 1.02.3.012 · Regímenes dietéticos para obesidad · *Práctica*

Una mujer de 45 años, con IMC de 32 kg/m², desea bajar de peso. Su gasto energético estimado es de 2.000 kcal/día.

¿Cuál es la prescripción dietética más adecuada para iniciar?

A) Dieta de 600 kcal/día sin supervisión

B) Ayuno total por 2 semanas

C) Dieta libre de carbohidratos en forma indefinida

D) Dieta con déficit de 500 a 750 kcal/día respecto de su gasto, balanceada y sostenible

E) Mantener la ingesta y agregar diuréticos

> **Respuesta D.** Un déficit de 500 a 750 kcal/día (unas 1.200-1.500 kcal en mujeres) produce una baja de 0,5 a 1 kg por semana. La meta inicial es bajar 5 a 10% del peso en 6 meses, lo que ya mejora presión, glicemia y lípidos. Lo clave es la adherencia; las dietas de muy bajo aporte requieren supervisión estricta.

113 diab-23 · Perfil V3 1.02.3.013 · Riesgo cardiovascular global · *Práctica*

Mujer de 46 años, no fumadora, sin diabetes, consulta en el CESFAM para ingresar al Programa de Salud Cardiovascular. En 3 controles distintos tiene presión arterial promedio de 166/104 mmHg. Perfil lipídico: colesterol total 205 mg/dL, HDL 52 mg/dL, LDL 128 mg/dL. Creatinina 0,7 mg/dL, sin albuminuria.

Según el MINSAL, ¿cómo se clasifica su riesgo cardiovascular?

A) Bajo, porque es mujer menor de 50 años y no fuma

B) Moderado, según las tablas de Framingham adaptadas a Chile

C) No se puede clasificar sin una prueba de esfuerzo

D) Alto, directamente, sin necesidad de usar tablas, por presión arterial de 160/100 mmHg o más

E) Alto solo si el LDL supera 190 mg/dL

> **Respuesta D.** En el Programa de Salud Cardiovascular algunas condiciones clasifican directamente como alto riesgo, sin tablas: enfermedad cardiovascular previa, diabetes, ERC etapa 3b o más, LDL 190 mg/dL o más y presión arterial persistente de 160/100 mmHg o más. En los demás se usa la tabla de Framingham adaptada a Chile.

114 diab-05 · Perfil V3 1.02.3.014 · Síndrome metabólico · *Práctica*

Un hombre de 50 años tiene diagnóstico de síndrome metabólico: cintura de 104 cm, triglicéridos 180 mg/dL, HDL 38 mg/dL y glicemia de ayuno 110 mg/dL. Su presión arterial es 128/82 mmHg.

¿Cuál es la intervención de primera línea?

A) Metformina, fenofibrato y losartán desde el inicio

B) Cambios de estilo de vida, con meta de bajar 5 a 10% del peso, dieta saludable y actividad física

C) Cirugía bariátrica

D) Insulina NPH nocturna

E) Control anual sin intervención

> **Respuesta B.** El tratamiento de primera línea del síndrome metabólico es el cambio de estilo de vida: bajar 5 a 10% del peso, dieta saludable, al menos 150 minutos semanales de actividad física y no fumar. Esto mejora todos sus componentes a la vez. Los fármacos se agregan según cada componente que lo requiera, no por el diagnóstico.

115 diab-22 · Perfil V3 1.02.4.001 · Arteriografia extremidades inferiores · *Práctica*

Un hombre de 70 años, diabético, presenta dolor en reposo en el pie derecho que lo despierta en la noche y una úlcera en el primer ortejo que no cicatriza hace 6 semanas. No tiene pulsos poplíteo ni pedio derechos y el índice tobillo-brazo es 0,3.

¿Cuál es el examen más adecuado para planificar el tratamiento?

A) Arteriografía (o angioTAC) de extremidades inferiores

B) Radiografía de pie

C) Electromiografía

D) Cintigrama óseo

E) Repetir el índice tobillo-brazo en 6 meses

> **Respuesta A.** Dolor de reposo y úlcera que no cicatriza con ITB muy bajo es isquemia crítica de la extremidad, con alto riesgo de amputación. Requiere estudio anatómico arterial (arteriografía o angioTAC) para planificar la revascularización endovascular o quirúrgica; la arteriografía además puede ser terapéutica (angioplastía). Esperar implica perder la extremidad.

116 diab-20 · Perfil V3 1.02.4.004 · Relación albuminuria / creatininuria · *Práctica*

Mujer de 61 años con DM2 de 9 años de evolución, PA 126/78 mmHg, sin albuminuria en controles previos. En su control anual se solicita razón albúmina/creatinina urinaria (RAC) en orina matinal: 140 mg/g. Ese día refiere disuria, polaquiuria y fiebre de 38,2 °C desde hace 2 días; el sedimento urinario muestra abundantes leucocitos y bacterias.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la RAC?

A) Iniciar losartán por albuminuria moderadamente elevada

B) Derivar a nefrología por nefropatía diabética

C) Solicitar orina de 24 horas para proteinuria

D) Tratar la infección urinaria y repetir la RAC una vez resuelta

E) Suspender la metformina por daño renal

> **Respuesta D.** La RAC en orina matinal aislada es el examen de tamizaje de la nefropatía diabética, pero se eleva transitoriamente con infección urinaria, fiebre, ejercicio intenso, hiperglicemia marcada o insuficiencia cardíaca descompensada. Se trata la infección y se repite la RAC; solo 2 de 3 muestras alteradas confirman albuminuria.

117 diab-15 · Perfil V3 1.02.4.006 · Cuerpos cetónicos en orina (semicuantitativo) · *Práctica*

Un paciente de 25 años con DM1 ingresa con vómitos, dolor abdominal y respiración de Kussmaul. Glicemia 480 mg/dL, pH 7,10, bicarbonato 8 mEq/L y anión gap de 24. La cetonuria con tira reactiva (nitroprusiato) es solo débilmente positiva (+).

¿Cuál es la explicación más probable de la cetonuria débil?

A) Descarta una cetoacidosis diabética

B) Indica un estado hiperosmolar puro

C) La tira detecta acetoacetato y acetona, pero no el beta-hidroxibutirato, que predomina en la cetoacidosis

D) Se debe a que la glicemia es muy alta

E) Indica exclusivamente acidosis láctica

> **Respuesta C.** El nitroprusiato detecta acetoacetato y acetona, no beta-hidroxibutirato, que predomina en la cetoacidosis grave. Por eso la cetonuria puede subestimar la cetosis y se prefiere medir beta-hidroxibutirato en sangre. Con acidosis metabólica de anión gap alto e hiperglicemia, el diagnóstico de cetoacidosis se mantiene.

118 diab-22 · Perfil V3 1.02.4.008 · Doppler vascular periférico · *Práctica*

Un hombre de 72 años, con DM2 de 20 años y enfermedad renal crónica, refiere claudicación de pantorrillas. Sus pulsos pedios son débiles, pero el índice tobillo-brazo resulta 1,5.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Descartar enfermedad arterial, porque el índice es normal

B) Solicitar electromiografía

C) Indicar amputación

D) Considerar el índice no confiable por calcificación arterial y realizar ecografía Doppler arterial o índice dedo-brazo

E) Repetir el mismo índice en 1 año

> **Respuesta D.** Un ITB sobre 1,3-1,4 indica arterias no compresibles por calcificación de la media, frecuente en diabéticos y en enfermedad renal, y no es confiable. Con claudicación y pulsos débiles se estudia con ecografía Doppler arterial (morfología de onda, estenosis) o índice dedo-brazo, porque las arterias digitales suelen respetarse.

119 diab-17 · Perfil V3 1.02.4.009 · Electrocardiograma · *Práctica*

Un paciente de 30 años con DM1 ingresa con cetoacidosis diabética: glicemia 520 mg/dL, pH 7,08 y bicarbonato 6 mEq/L. Se inicia hidratación con suero fisiológico. El potasio aún no está disponible, pero el ECG muestra ondas T aplanadas, depresión del ST y ondas U prominentes.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la insulina?

A) Postergar la insulina y reponer potasio, porque el ECG sugiere hipokalemia

B) Iniciar insulina en bolo inmediatamente

C) Administrar bicarbonato antes de todo

D) Administrar gluconato de calcio por hiperkalemia

E) Iniciar insulina subcutánea

> **Respuesta A.** Ondas T aplanadas, depresión del ST y ondas U sugieren hipokalemia. La insulina introduce potasio a las células y puede precipitar arritmias graves. Mientras llega el potasio, el ECG orienta: si sugiere hipokalemia (o K bajo 3,3 mEq/L) se repone potasio antes de iniciar insulina. Las T picudas sugerirían hiperkalemia.

120 diab-09 · Perfil V3 1.02.4.015 · Glicemia capilar · *Práctica*

Gestante de 30 semanas con diabetes gestacional, en plan de alimentación hace 2 semanas. Trae su registro de hemoglucotest: glicemias de ayuno entre 98 y 108 mg/dL en 6 de 14 mediciones; glicemias 1 hora postprandiales entre 112 y 132 mg/dL en todas las mediciones. Ecografía con circunferencia abdominal fetal en percentil 60.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener la dieta, ya que los postprandiales están en meta

B) Iniciar insulina NPH nocturna

C) Iniciar insulina rápida antes de cada comida

D) Iniciar glibenclamida en la mañana

E) Aumentar la frecuencia de hemoglucotest y reevaluar en un mes

> **Respuesta B.** Metas de glicemia capilar en la diabetes gestacional: ayuno bajo 90–95 mg/dL y 1 hora postprandial bajo 140 mg/dL. Aquí el 43 % de los ayunos está fuera de meta (más del 20 %) y los postprandiales están bien: se indica insulina NPH nocturna, que corrige el ayuno.

121 diab-14 · Perfil V3 1.02.4.015 · Glicemia capilar · *Práctica*

Mujer de 38 años, sin diabetes ni otros antecedentes, consulta por episodios de temblor, sudoración y palpitaciones 2 a 3 horas después de comer, que ceden al ingerir alimentos. Trae un registro de un glucómetro prestado con valores de 58, 62 y 64 mg/dL durante los síntomas. Examen físico normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar una hipoglicemia?

A) Diagnosticar hipoglicemia reactiva con el registro del glucómetro

B) Iniciar dieta fraccionada sin más estudio

C) Documentar una glicemia plasmática venosa baja durante los síntomas, que se corrijan al normalizarla

D) Solicitar hemoglobina glicosilada

E) Solicitar insulinemia basal de ayuno

> **Respuesta C.** En una persona sin diabetes, la hipoglicemia se confirma con la tríada de Whipple usando glicemia plasmática (bajo 55 mg/dL), no con glucómetro, que es impreciso en rangos bajos. La glicemia capilar sirve para el automonitoreo y la urgencia del diabético, no para diagnosticar hipoglicemia en un no diabético.

122 diab-02 · Perfil V3 1.02.4.016 · Glicemia venosa · *Práctica*

Un hombre de 52 años, asintomático, se realiza en un examen preventivo una glicemia venosa de ayuno, que resulta 132 mg/dL.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la glicemia venosa de ayuno otro día para confirmar

B) Diagnosticar diabetes e iniciar insulina

C) Diagnosticar prediabetes

D) Solicitar una glicemia capilar para confirmar

E) Descartar diabetes por estar asintomático

> **Respuesta A.** El diagnóstico de diabetes requiere glicemia venosa de ayuno ≥126 mg/dL en 2 ocasiones en días distintos, o glicemia al azar ≥200 mg/dL con síntomas, o PTGO a las 2 horas ≥200 mg/dL. En un asintomático con un solo valor alterado se confirma repitiendo la glicemia venosa. La glicemia capilar no sirve para diagnosticar.

123 diab-04 · Perfil V3 1.02.4.017 · Hemoglobina glicosilada · *Práctica*

Mujer de 52 años con DM2 de 3 años de evolución, en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas. Antecedente de mioma uterino con metrorragia abundante, por lo que recibió 2 unidades de glóbulos rojos hace 3 semanas. Trae HbA1c de 6,1 %, pero su registro de glicemias capilares de ayuno muestra valores entre 180 y 220 mg/dL.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Está en meta; mantener el tratamiento

B) La HbA1c está falsamente baja por la transfusión y la pérdida de sangre

C) El glucómetro está mal calibrado; confiar en la HbA1c

D) Debe reducirse la metformina por riesgo de hipoglicemia

E) La HbA1c está falsamente alta por la anemia ferropénica

> **Respuesta B.** La HbA1c refleja la glucosa unida a la hemoglobina durante la vida del glóbulo rojo. La hemorragia y la transfusión reciente renuevan los eritrocitos y la bajan falsamente. Aquí manda el registro de glicemias capilares; se repite la HbA1c en 2–3 meses.

124 diab-06 · Perfil V3 1.02.4.017 · Hemoglobina glicosilada · *Práctica*

Mujer de 49 años con DM2 recién diagnosticada, HbA1c inicial 7,8 %. Asintomática, sin baja de peso. Se indica plan de alimentación, actividad física y metformina 850 mg cada 12 horas. Tolera bien el tratamiento y pregunta cuándo debe volver a medirse la HbA1c para saber si el tratamiento funcionó.

¿Cuándo corresponde controlar la HbA1c para evaluar la respuesta?

A) A las 2 semanas

B) Al mes

C) A los 12 meses

D) A los 3 meses

E) No es necesario; basta con la glicemia de ayuno

> **Respuesta D.** La HbA1c refleja el promedio glicémico de los 2–3 meses previos, que es la vida media útil del glóbulo rojo. Medirla antes no muestra el efecto real del cambio de tratamiento. Se controla a los 3 meses y, si no está en meta, se intensifica.

125 diab-20 · Perfil V3 1.02.4.019 · Microalbuminuria · *Práctica*

Una mujer de 55 años con DM2 de 6 años, sin síntomas urinarios ni ejercicio intenso reciente, tiene en su control una relación albúmina/creatinina urinaria (RAC) de 85 mg/g, con VFG estimada de 80 mL/min/1,73 m². Es la primera vez que resulta alterada.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Diagnosticar nefropatía diabética e iniciar diálisis

B) Confirmar repitiendo la RAC: se requieren 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses

C) Solicitar biopsia renal

D) Descartar el hallazgo porque la VFG es normal

E) Solicitar solo una ecografía renal

> **Respuesta B.** Una RAC de 30 a 300 mg/g es albuminuria moderadamente elevada (antes 'microalbuminuria'), marcador precoz de nefropatía diabética y de riesgo cardiovascular. Por su variabilidad (ejercicio, fiebre, ITU, descompensación) se confirma con 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses. Confirmada, se indica IECA o ARA II y se considera iSGLT2.

126 diab-23 · Perfil V3 1.02.4.021 · Perfil lipídico · *Práctica*

Hombre de 52 años con obesidad y consumo diario de alcohol, en control de salud. Perfil lipídico en ayunas de 12 horas: colesterol total 260 mg/dL, HDL 34 mg/dL, triglicéridos 520 mg/dL. El informe del laboratorio no entrega el valor de LDL.

¿Cuál es la interpretación más adecuada respecto al colesterol LDL?

A) Calcular el LDL con la fórmula de Friedewald: 122 mg/dL

B) El LDL no tiene importancia en este paciente

C) Repetir el perfil sin ayuno para obtener el LDL

D) El LDL es igual al colesterol total menos el HDL

E) Con triglicéridos sobre 400 mg/dL la fórmula de Friedewald no es válida; se usa LDL medido en forma directa o el colesterol no HDL

> **Respuesta E.** La fórmula de Friedewald (LDL = colesterol total – HDL – triglicéridos/5) solo es válida con triglicéridos bajo 400 mg/dL. Sobre ese valor sobreestima las VLDL y subestima el LDL. Se pide LDL directo o se usa el colesterol no HDL (aquí 226 mg/dL). Además, con triglicéridos sobre 500 la prioridad es prevenir la pancreatitis.

127 diab-03 · Perfil V3 1.02.4.024 · Test de tolerancia a la glucosa · *Práctica*

Embarazada de 33 años, multípara de 2, cursando 32 semanas. Glicemia de ayuno de ingreso 84 mg/dL. PTGO con 75 g a las 26 semanas: 82 mg/dL basal y 128 mg/dL a las 2 horas. En la ecografía actual el feto está en percentil 95 de peso y el ILA es de 26 cm.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la PTGO con 75 g ahora

B) Mantener control prenatal habitual

C) Iniciar insulina NPH nocturna

D) Solicitar hemoglobina glicosilada

E) Solicitar glicemia de ayuno cada 2 semanas

> **Respuesta A.** La PTGO de las 24–28 semanas fue normal, pero aparecen factores de alto riesgo: feto grande y polihidramnios. En ese caso se repite la PTGO entre las 32 y 34 semanas para no pasar por alto una diabetes gestacional tardía. Sin diagnóstico no corresponde iniciar insulina.

128 diab-22 · Perfil V3 1.02.5.001 · Curaciones básicas del pié diabético · *Práctica*

Mujer de 66 años con DM2 y polineuropatía. Úlcera plantar de 1,5 cm bajo la cabeza del 2.º metatarsiano, superficial, con bordes de hiperqueratosis y fondo con algo de tejido esfacelado. Sin eritema, calor ni secreción purulenta; estilete óseo negativo. Pulsos pedios presentes.

¿Cuál es el manejo local más adecuado de la úlcera?

A) Lavado con povidona yodada y agua oxigenada, y gasa seca

B) Antibiótico tópico y dejar la úlcera expuesta al aire

C) Lavado con suero fisiológico, desbridamiento del esfacelo y la hiperqueratosis, apósito que mantenga un ambiente húmedo y descarga de la zona

D) Cefadroxilo oral por 14 días y reposo

E) Hospitalizar para desbridamiento quirúrgico

> **Respuesta C.** Úlcera neuropática Wagner 1 sin infección: manejo ambulatorio con curación avanzada. Se lava con suero fisiológico, se retira el tejido desvitalizado y la callosidad, se usa un apósito que mantenga un ambiente húmedo fisiológico y se descarga la zona. Los antisépticos dañan el tejido de granulación y sin infección no se indican antibióticos.

129 diab-21 · Perfil V3 1.02.5.003 · Fondo de ojo · *Práctica*

Joven de 19 años con DM1 diagnosticada a los 16 años, en esquema basal-bolo, HbA1c 7,4 %. Nunca se ha realizado un fondo de ojo. Su padre, DM2 diagnosticado la semana pasada a los 50 años, también consulta. Ninguno refiere síntomas visuales.

¿Cuándo corresponde realizar el primer fondo de ojo de tamizaje a cada uno?

A) Ambos de inmediato

B) Al hijo de inmediato y al padre en 5 años

C) Al hijo a los 30 años y al padre a los 5 años del diagnóstico

D) Ambos solo si presentan síntomas visuales

E) Al hijo a los 5 años del debut, es decir a los 21 años, y al padre de inmediato

> **Respuesta E.** En la DM2 el fondo de ojo se realiza al momento del diagnóstico, porque la enfermedad pudo llevar años sin detectarse, y luego cada año. En la DM1 el tamizaje parte a los 5 años del debut, ya que la retinopatía no aparece antes. La retinopatía es silenciosa: se busca, no se espera a los síntomas.

130 diab-04 · Perfil V3 1.07.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2 · *Práctica*

Hombre de 84 años con DM2 de 20 años de evolución, demencia moderada, dependencia para actividades básicas y caídas frecuentes. Usa metformina y glibenclamida. Su HbA1c es 6,4% y su cuidadora refiere episodios matinales de sudoración y confusión.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener el tratamiento, ya que la HbA1c está en meta

B) Suspender la glibenclamida y aceptar una meta de HbA1c cercana a 8%

C) Agregar insulina NPH nocturna

D) Aumentar la glibenclamida para lograr una HbA1c menor de 6%

E) Reemplazar la metformina por glibenclamida en dosis máxima

> **Respuesta B.** En el adulto mayor frágil, con demencia y dependencia, la meta de HbA1c se relaja a cerca de 8% para evitar hipoglicemias, que causan caídas, arritmias y deterioro cognitivo. Sus síntomas sugieren hipoglicemias por glibenclamida, una sulfonilurea de acción prolongada que debe suspenderse. Una HbA1c de 6,4% aquí refleja sobretratamiento.

131 diab-23 · Perfil V3 1.09.3.002 · Control de factores de riesgo de enfermedad vascular · *Práctica*

Hombre de 58 años con DM2, hipertensión y tabaquismo activo, sin eventos cardiovasculares previos, tiene colesterol LDL de 132 mg/dL. Se clasifica como de riesgo cardiovascular alto.

¿Cuál es la meta de colesterol LDL más adecuada para este paciente?

A) Menor de 190 mg/dL

B) Menor de 160 mg/dL

C) Menor de 130 mg/dL

D) Menor de 70 mg/dL

E) No requiere meta de LDL, solo control glicémico

> **Respuesta D.** En pacientes de riesgo cardiovascular alto, como diabéticos con otros factores de riesgo, la meta de LDL es menor de 70 mg/dL, idealmente con una reducción de al menos 50%, usando estatinas de alta intensidad. El control integral de factores de riesgo incluye cesación tabáquica, control de presión y glicemia; dejar de fumar es la medida aislada de mayor impacto.

132 diab-23 · Perfil V3 2.01.1.002 · Dislipidemias · *Práctica*

Un niño de 11 años es derivado por colesterol LDL de 205 mg/dL, confirmado en dos mediciones. Su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 42 años. Lleva 6 meses con dieta y actividad física supervisadas, con LDL de control de 198 mg/dL. Su IMC es normal y no tiene otras enfermedades.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener solo dieta y controlar en un año

B) Indicar suplementos de omega 3 como única medida

C) Iniciar fibratos

D) Esperar hasta los 18 años para iniciar fármacos

E) Iniciar una estatina en dosis baja manteniendo la dieta

> **Respuesta E.** LDL de 190 mg/dL o más persistente tras 6 meses de dieta, en un niño de 10 años o más, sugiere hipercolesterolemia familiar y es indicación de estatina, sobre todo con antecedente de enfermedad coronaria precoz. Se inicia en dosis baja, manteniendo cambios de estilo de vida y vigilando CK y transaminasas. Los fibratos son para hipertrigliceridemia.

133 diab-14 · Perfil V3 2.01.2.004 · Compromiso de conciencia · *Práctica*

Un niño de 3 años es traído a urgencia por somnolencia progresiva desde hace 1 hora. No tiene fiebre ni trauma conocido. Al examen tiene Glasgow 10, pupilas normales y reactivas, sin signos meníngeos ni focalidad, y signos vitales estables.

Después de asegurar vía aérea, ventilación y circulación, ¿cuál es el primer examen a realizar?

A) Glicemia capilar (hemoglucotest)

B) TAC de cerebro

C) Punción lumbar

D) Electroencefalograma

E) Niveles de amonio

> **Respuesta A.** En todo niño con compromiso de conciencia, tras el ABC, debe medirse de inmediato la glicemia capilar, porque la hipoglicemia es frecuente (ayuno, intoxicaciones, errores del metabolismo), rápida de diagnosticar y tratable con glucosa endovenosa. Luego se orienta el estudio: tóxicos, electrolitos, gases, neuroimagen o punción lumbar según la sospecha.

134 diab-23 · Perfil V3 2.01.4.019 · Perfil lipídico · *Práctica*

En el control de salud de un niño de 5 años, sano y con IMC normal, la madre refiere que el padre del niño tuvo un infarto agudo al miocardio a los 45 años y tiene colesterol total de 320 mg/dL.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) No solicitar exámenes hasta los 18 años

B) Solicitar solo glicemia

C) Iniciar estatina empírica

D) Solicitar perfil lipídico en ayunas

E) Solicitar perfil lipídico solo si desarrolla obesidad

> **Respuesta D.** Se recomienda tamizaje selectivo con perfil lipídico desde los 2 años en niños con antecedente familiar de enfermedad cardiovascular precoz (hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65) o dislipidemia familiar, además de un tamizaje universal entre los 9 y 11 años. Así se pesquisa la hipercolesterolemia familiar, que requiere manejo precoz. Las estatinas no se usan sin diagnóstico.

135 diab-05 · Perfil V3 7.01.3.032 · Estrategias de control de enfermedades crónicas prioritarias (cáncer, cardiovasculares) · *Práctica*

El Ministerio de Salud busca reducir la mortalidad cardiovascular del país y evalúa distintas medidas. Siguiendo a Geoffrey Rose, distingue entre estrategias dirigidas a individuos de alto riesgo y estrategias poblacionales.

¿Cuál de las siguientes corresponde a una estrategia poblacional?

A) Realizar angioplastía precoz en el infarto agudo

B) Indicar estatinas a pacientes con riesgo cardiovascular alto

C) Ingresar a los hipertensos al Programa de Salud Cardiovascular

D) Reducir el contenido de sodio del pan mediante un acuerdo con la industria panificadora

E) Prescribir antiagregantes a pacientes con enfermedad coronaria

> **Respuesta D.** La estrategia poblacional desplaza la distribución del factor de riesgo en toda la población, como reducir la sal del pan, la ley de etiquetado de alimentos o los impuestos al tabaco. Logra gran impacto porque la mayoría de los eventos ocurre en personas de riesgo moderado. Las demás opciones son estrategias de alto riesgo o tratamiento individual.

Endocrinología

136 endo-09 · Perfil V3 1.03.1.001 · Bocio · *Práctica*

Una mujer de 35 años consulta por aumento de volumen cervical anterior difuso, indoloro y de crecimiento lento. No tiene síntomas de hipo ni de hipertiroidismo, ni síntomas compresivos. Al examen la tiroides está aumentada de tamaño en forma simétrica, blanda, sin nódulos palpables.

¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

A) TSH

B) Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de tiroides

C) Cintigrama tiroideo

D) TAC de cuello

E) Tiroglobulina

> **Respuesta A.** Ante todo bocio, lo primero es evaluar la función tiroidea con TSH (y T4 libre si está alterada), porque define la conducta. La ecografía tiroidea complementa la evaluación morfológica y de nódulos. La PAAF solo se indica en nódulos según criterios ecográficos, y el cintigrama en hipertiroidismo con TSH suprimida.

137 endo-18 · Perfil V3 1.03.1.019 · Osteoporosis secundaria · *Práctica*

Un hombre de 45 años presenta una fractura vertebral por aplastamiento tras un esfuerzo mínimo. La densitometría muestra un Z-score de –3,0 en columna. No tiene antecedentes conocidos ni usa fármacos.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar bifosfonato sin otro estudio, porque es osteoporosis primaria

B) Repetir la densitometría en 2 años

C) Indicar solo calcio y vitamina D

D) Buscar causas secundarias: calcio, fósforo, PTH, vitamina D, TSH, testosterona, función renal y hepática, hemograma y electroforesis de proteínas

E) Iniciar terapia con estrógenos

> **Respuesta D.** Osteoporosis en un hombre joven o con Z-score bajo –2 obliga a buscar causas secundarias: hipogonadismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing o corticoides, déficit de vitamina D, malabsorción (enfermedad celíaca), alcoholismo o mieloma, entre otras. Tratar la causa es parte central del manejo, junto al antirresortivo.

138 endo-15 · Perfil V3 1.03.1.022 · Incidentaloma suprarrenal · *Práctica*

A una mujer de 55 años, normotensa, se le encuentra en una TAC solicitada por cólico renal una masa suprarrenal izquierda de 2,5 cm, homogénea, de 8 UH sin contraste. No tiene signos de síndrome de Cushing.

¿Cuál es el estudio hormonal mínimo más adecuado?

A) Ningún estudio, por ser pequeño y homogéneo

B) Test de supresión con 1 mg de dexametasona y metanefrinas plasmáticas o urinarias

C) Solo cortisol libre urinario

D) Biopsia percutánea de la masa

E) Solo aldosterona y renina plasmáticas

> **Respuesta B.** Todo incidentaloma suprarrenal requiere estudio funcional: supresión nocturna con 1 mg de dexametasona (Cushing subclínico) y metanefrinas (feocromocitoma); aldosterona y renina se agregan si hay HTA o hipokalemia. Menos de 10 UH sugiere adenoma rico en lípidos. La biopsia no se recomienda y es peligrosa si es feocromocitoma.

139 endo-18 · Perfil V3 1.03.3.002 · Prevención de osteoporosis · *Práctica*

Mujer de 54 años, menopáusica hace 3 años, fumadora de 10 cigarrillos al día, sedentaria, IMC 21. Ingiere un solo lácteo al día. Sin fracturas previas ni uso de corticoides. Su densitometría muestra T-score –1,4 en columna y –1,2 en cadera, con riesgo de fractura a 10 años bajo según FRAX.

¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Alendronato 70 mg semanal

B) Asegurar 1.000–1.200 mg/día de calcio, idealmente con la dieta, vitamina D, ejercicio con carga, suspender el tabaco y moderar el alcohol

C) Ácido zoledrónico anual

D) Solo control densitométrico en 6 meses

E) Calcitonina nasal

> **Respuesta B.** Osteopenia con riesgo de fractura bajo: no tiene indicación de fármacos antirresortivos. Corresponde la prevención: aporte de calcio de 1.000–1.200 mg/día, idealmente con la dieta, vitamina D suficiente, ejercicio con carga y de fuerza, dejar el tabaco, moderar el alcohol y prevenir caídas. La densitometría de control se repite en 2 a 3 años, no a los 6 meses.

140 endo-13 · Perfil V3 1.03.3.003 · Complicaciones del tratamiento esteroidal · *Práctica*

Un hombre de 60 años usa prednisona 20 mg/día desde hace 8 meses por una enfermedad pulmonar intersticial. Suspendió el fármaco bruscamente hace 4 días por miedo a sus efectos adversos. Consulta por náuseas, vómitos y debilidad intensa. PA 80/50 mmHg, natremia 131 mEq/L.

¿Cuál es la complicación más probable y su manejo?

A) Síndrome de Cushing: suspender corticoides

B) Hipotiroidismo: levotiroxina

C) Hiperaldosteronismo: espironolactona

D) Feocromocitoma: bloqueo alfa

E) Insuficiencia suprarrenal aguda secundaria por supresión del eje: hidrocortisona endovenosa y volumen

> **Respuesta E.** Los corticoides en dosis suprafisiológicas por más de 3 semanas suprimen el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, y su suspensión brusca puede causar insuficiencia suprarrenal aguda. Se trata con hidrocortisona endovenosa (100 mg en bolo) y suero fisiológico, sin esperar exámenes. Por eso los corticoides prolongados se retiran en forma gradual.

141 endo-09 · Perfil V3 1.03.4.001 · Ecografía tiroídea · *Práctica*

Mujer de 44 años, eutiroidea (TSH 1,8 mUI/L), sin antecedentes de radiación. Se palpa un nódulo en el lóbulo izquierdo. La ecografía tiroidea muestra un nódulo sólido de 1,3 cm, marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, de bordes irregulares y con microcalcificaciones, sin adenopatías cervicales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control ecográfico en 12 meses, porque mide menos de 2 cm

B) Iniciar levotiroxina para frenar el crecimiento

C) Cintigrafía tiroidea

D) Tiroidectomía total sin estudio citológico

E) Punción aspirativa con aguja fina guiada por ecografía

> **Respuesta E.** La ecografía es el examen que estratifica el riesgo del nódulo. Hipoecogenicidad marcada, forma más alta que ancha, bordes irregulares y microcalcificaciones son signos de sospecha alta (TI-RADS 5): se indica PAAF desde 1 cm. La cintigrafía solo se pide con TSH baja, y no se opera sin citología.

142 endo-18 · Perfil V3 1.03.4.002 · Densitometría ósea · *Práctica*

Mujer de 38 años, con menstruaciones regulares, en tratamiento con prednisona 10 mg/día hace 14 meses por lupus. Se solicita densitometría ósea (DEXA): columna lumbar T-score –2,7 y Z-score –2,4; cuello femoral T-score –2,1 y Z-score –2,0. No tiene fracturas.

¿Cuál es la interpretación correcta de la densitometría?

A) Osteoporosis, porque el T-score es menor de –2,5

B) Osteopenia, porque el cuello femoral está sobre –2,5

C) Densitometría normal

D) Densidad mineral ósea baja para la edad, según el Z-score, que es el índice que se usa en mujeres premenopáusicas

E) Osteoporosis severa

> **Respuesta D.** El T-score compara con el adulto joven y diagnostica osteoporosis (≤ –2,5) en posmenopáusicas y hombres de 50 años o más. En premenopáusicas y hombres menores de 50 se usa el Z-score, que compara con la misma edad: ≤ –2,0 es densidad baja para la edad y obliga a buscar una causa secundaria, aquí los corticoides.

143 endo-02 · Perfil V3 1.03.4.003 · TSH, T4, T3 · *Práctica*

Mujer de 45 años operada hace 8 meses de un macroadenoma hipofisario no funcionante. Consulta por astenia, intolerancia al frío y constipación. FC 58 lpm, piel seca. Exámenes: TSH 0,9 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 0,45 ng/dL (VN 0,8–1,8). Cortisol plasmático matinal normal.

¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?

A) Hipotiroidismo central; iniciar levotiroxina y controlar con T4 libre

B) Hipotiroidismo primario; ajustar la levotiroxina según la TSH

C) Eje tiroideo normal, porque la TSH es normal

D) Síndrome del eutiroideo enfermo; repetir en 6 semanas

E) Hipertiroidismo subclínico; observar

> **Respuesta A.** Una T4 libre baja con TSH normal o baja, no elevada, indica hipotiroidismo central, aquí por daño hipofisario. La TSH deja de servir para el control: la levotiroxina se ajusta con la T4 libre, buscando la mitad superior del rango normal. Antes de iniciarla debe descartarse insuficiencia suprarrenal, ya resuelto en este caso.

144 endo-06 · Perfil V3 1.03.4.003 · TSH, T4, T3 · *Práctica*

Hombre de 58 años con palpitaciones, temblor fino y baja de 5 kg en 2 meses. FC 112 lpm, nódulo tiroideo palpable de 3 cm en el lóbulo derecho. Exámenes: TSH 0,01 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 1,6 ng/dL (VN 0,8–1,8).

¿Cuál es el examen más adecuado para completar la evaluación de la función tiroidea?

A) Repetir la TSH en 6 semanas, ya que la T4 libre es normal

B) Solicitar anticuerpos antitiroperoxidasa

C) Solicitar T3 total o libre

D) Solicitar tiroglobulina

E) Solicitar T3 reversa

> **Respuesta C.** TSH suprimida con T4 libre normal en un paciente con clínica de tirotoxicosis obliga a medir la T3: probable T3-toxicosis, frecuente en el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Si la T3 también es normal, se trata de un hipertiroidismo subclínico. Luego la cintigrafía define la etiología.

145 endo-02 · Perfil V3 1.03.4.005 · Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiiroperoxidasa) · *Práctica*

Una mujer de 32 años, asintomática, tiene TSH de 7,2 μUI/mL con T4 libre normal, confirmados en 2 mediciones. No está embarazada ni lo planifica.

¿Qué examen ayuda más a estimar el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico?

A) Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO)

B) Tiroglobulina

C) Cintigrama tiroideo

D) T3 total

E) Calcitonina

> **Respuesta A.** En el hipotiroidismo subclínico, los anticuerpos anti-TPO positivos indican tiroiditis de Hashimoto y aproximadamente duplican el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico (cerca de 4% al año). Ayudan a decidir tratamiento y frecuencia de controles. La tiroglobulina es marcador tumoral del cáncer diferenciado tratado, y la calcitonina del carcinoma medular.

146 endo-11 · Perfil V3 1.03.4.006 · Cortisol plasmático · *Práctica*

Hombre de 46 años con obesidad, hipertensión y DM2 de difícil control. Su médico sospecha síndrome de Cushing y solicita un cortisol plasmático a las 8 h, que resulta 21 mcg/dL (VN 5–25). Al examen no tiene estrías violáceas, miopatía proximal ni equimosis.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de este resultado?

A) Descarta el síndrome de Cushing

B) No sirve para el tamizaje; se debe solicitar test de Nugent, cortisol libre urinario de 24 horas o cortisol salival nocturno

C) Confirma el síndrome de Cushing

D) Indica insuficiencia suprarrenal relativa

E) Obliga a solicitar TC de suprarrenales

> **Respuesta B.** Un cortisol plasmático matinal aislado no diagnostica ni descarta Cushing: en la mañana el cortisol normal está en su peak y se superpone con el hipercortisolismo. El Cushing pierde la supresión y el ritmo circadiano, por eso se tamiza con Nugent, cortisol libre urinario o cortisol salival nocturno. El cortisol matinal sirve en la insuficiencia suprarrenal.

147 endo-11 · Perfil V3 1.03.4.007 · Cortisol libre 24 horas · *Práctica*

Mujer de 28 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados hace 3 años, consulta por aumento de peso, acné e hipertensión reciente. Se sospecha síndrome de Cushing. Test de Nugent (1 mg de dexametasona a las 23 h): cortisol a las 8 h de 3,4 mcg/dL. No es posible suspender los anticonceptivos por 6 semanas.

¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el tamizaje?

A) Cortisol libre urinario de 24 horas

B) Cortisol plasmático a las 8 horas

C) Repetir el test de Nugent con 2 mg de dexametasona

D) ACTH plasmática

E) Resonancia magnética de silla turca

> **Respuesta A.** Los estrógenos elevan la globulina transportadora de cortisol (CBG) y el cortisol plasmático total, dando falsos positivos en el test de Nugent. El cortisol libre urinario de 24 horas mide la fracción libre y no se afecta; se piden 2 muestras con creatininuria. La ACTH y la imagen van después de confirmar el hipercortisolismo.

148 endo-21 · Perfil V3 1.03.4.008 · FSH, estradiol y prolactina · *Práctica*

Mujer de 34 años con amenorrea secundaria de 7 meses, bochornos, sudoración nocturna y sequedad vaginal. No usa fármacos ni anticonceptivos. Beta-hCG negativa, TSH 2,1 mUI/L, prolactina 14 ng/mL (VN menor de 25). FSH 68 mUI/mL, estradiol 12 pg/mL. Se repite la FSH a las 4 semanas: 72 mUI/mL.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Amenorrea hipotalámica funcional

B) Prolactinoma

C) Síndrome de Sheehan

D) Síndrome de ovario poliquístico

E) Insuficiencia ovárica prematura

> **Respuesta E.** En la amenorrea, tras descartar embarazo, se piden TSH, prolactina y FSH con estradiol. FSH elevada (sobre 25–40 mUI/mL en 2 muestras separadas por 4 semanas) con estradiol bajo en una mujer menor de 40 años indica insuficiencia ovárica prematura: hipogonadismo hipergonadotropo. La amenorrea hipotalámica y el Sheehan tienen FSH baja o normal.

149 endo-16 · Perfil V3 1.03.4.010 · PTH, calcemia · *Práctica*

Mujer de 79 años, hospitalizada por desnutrición y una neumonía, sin síntomas neuromusculares. Signos de Chvostek y Trousseau negativos. Exámenes: calcio plasmático total 7,8 mg/dL (VN 8,5–10,5), albúmina 2,0 g/dL, fósforo 3,5 mg/dL, magnesio 2,0 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de la calcemia?

A) Hipocalcemia verdadera; iniciar gluconato de calcio endovenoso

B) Déficit de vitamina D; iniciar colecalciferol en dosis altas

C) Hipoparatiroidismo; solicitar PTH e iniciar calcitriol

D) Calcemia corregida normal (cerca de 9,4 mg/dL), por hipoalbuminemia; no requiere tratamiento de calcio

E) Hipocalcemia por hipomagnesemia

> **Respuesta D.** El calcio total se une en un 40 % a la albúmina. Calcio corregido = calcio medido + 0,8 × (4 – albúmina) = 7,8 + 1,6 = 9,4 mg/dL: normal. Es una pseudohipocalcemia por hipoalbuminemia, asintomática; si hay duda, se mide el calcio iónico. La PTH solo se estudia ante una hipocalcemia verdadera.

150 endo-17 · Perfil V3 1.03.4.010 · PTH, calcemia · *Práctica*

Hombre de 66 años, fumador de 45 paquetes-año, con 3 semanas de constipación, poliuria, baja de peso y somnolencia. Calcio total 13,2 mg/dL con albúmina 4,0 g/dL, fósforo 2,4 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. PTH intacta 6 pg/mL (VN 15–65). La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha.

¿Cuál es el mecanismo más probable de la hipercalcemia?

A) Hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo

B) Intoxicación por vitamina D

C) Secreción de péptido relacionado con la PTH (PTHrP) por un carcinoma escamoso pulmonar

D) Hiperparatiroidismo terciario

E) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar

> **Respuesta C.** El primer paso ante una hipercalcemia es medir la PTH. PTH elevada o inapropiadamente normal indica hiperparatiroidismo primario; PTH suprimida indica una causa no paratiroidea, y en un fumador con masa pulmonar lo más probable es la hipercalcemia humoral maligna por PTHrP, típica del carcinoma escamoso. El PTHrP no se detecta en el ensayo de PTH intacta.

151 endo-18 · Perfil V3 1.07.1.015 · Osteoporosis · *Práctica*

Mujer de 74 años consulta por dolor dorsal tras levantar una bolsa de compras. La radiografía muestra una fractura por aplastamiento de la vértebra T12. No tiene antecedente de cáncer y la calcemia es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de su osteoporosis?

A) Esperar el resultado de la densitometría para decidir si tratar

B) Solo calcio y vitamina D, porque el bisfosfonato es para T-score menor de -3

C) Iniciar bisfosfonato (alendronato) más calcio y vitamina D

D) Iniciar terapia de reemplazo hormonal

E) Reposo en cama por 6 semanas

> **Respuesta C.** Una fractura vertebral por fragilidad establece el diagnóstico clínico de osteoporosis, independiente del T-score, y obliga a tratar con bisfosfonato (alendronato), calcio y vitamina D, además de prevenir caídas. La densitometría sirve como basal, pero no condiciona el inicio. La terapia hormonal no se usa con este fin a esta edad y el reposo prolongado acelera la pérdida ósea.

152 endo-14 · Perfil V3 1.09.2.006 · Hipokalemia · *Práctica*

Mujer de 68 años, hipertensa, en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg/día, con 4 días de diarrea acuosa. Consulta por debilidad muscular marcada y palpitaciones. Está lúcida, PA 120/70 mmHg. K 2,3 mEq/L, Na 136 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. ECG: ondas U prominentes, depresión del ST y extrasístoles ventriculares frecuentes.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cloruro de potasio oral y control ambulatorio en 1 semana

B) Bolo endovenoso directo de cloruro de potasio

C) Cloruro de potasio endovenoso diluido en solución fisiológica, a no más de 10–20 mEq/h, con monitorización cardíaca, más corregir el magnesio

D) Cloruro de potasio diluido en suero glucosado al 5 %

E) Insulina con glucosa para mejorar el potasio

> **Respuesta C.** Hipokalemia severa (menor de 2,5 mEq/L) con cambios en el ECG: KCl endovenoso diluido en suero fisiológico, máximo 10–20 mEq/h por vía periférica, con monitorización, suspendiendo la tiazida y corrigiendo el magnesio. El suero glucosado libera insulina y empeora la hipokalemia; el bolo directo puede causar paro.

153 endo-20 · Perfil V3 1.10.4.004 · Campo visual · *Práctica*

Hombre de 50 años consulta por cefalea y por chocar con frecuencia con objetos a ambos lados al caminar. La resonancia muestra un macroadenoma hipofisario de 2,5 cm con extensión supraselar.

¿Cuál es la alteración del campo visual más esperable?

A) Hemianopsia homónima derecha

B) Hemianopsia bitemporal

C) Escotoma central unilateral

D) Cuadrantanopsia superior homónima

E) Amaurosis monocular transitoria

> **Respuesta B.** Un macroadenoma con extensión supraselar comprime el quiasma óptico desde abajo, afectando las fibras nasales que se cruzan, y produce hemianopsia bitemporal, que típicamente se inicia en los cuadrantes superiores. Por eso todo macroadenoma requiere campimetría. La hemianopsia homónima indica una lesión retroquiasmática, y la amaurosis transitoria, isquemia retiniana.

154 endo-19 · Perfil V3 2.01.4.018 · Perfil bioquímico · *Práctica*

Un lactante de 14 meses, de piel oscura, con lactancia materna exclusiva prolongada sin suplementación de vitamina D, presenta piernas arqueadas, ensanchamiento de muñecas y rosario costal.

¿Qué alteración del perfil bioquímico es la más esperable?

A) Fosfatasa alcalina baja y fósforo alto

B) Todas las pruebas normales

C) Calcio muy elevado y PTH baja

D) Fosfatasa alcalina elevada, fósforo bajo y calcio normal o bajo

E) Fosfatasa alcalina normal y fósforo alto

> **Respuesta D.** El raquitismo carencial por déficit de vitamina D produce menor absorción de calcio, hiperparatiroidismo secundario con fosfaturia y, por ello, hipofosfemia con calcio normal o bajo. La fosfatasa alcalina se eleva marcadamente por el aumento de actividad osteoblástica, y es el marcador más útil. La 25-OH vitamina D está baja.

155 endo-04 · Perfil V3 2.01.4.024 · Pruebas tiroideas · *Práctica*

El programa de tamizaje neonatal informa que un recién nacido de 7 días tiene TSH elevada en la muestra de sangre en papel filtro. Está asintomático.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el tamizaje en papel filtro a los 2 meses

B) Solicitar cintigrafía tiroidea antes de cualquier tratamiento

C) Esperar la aparición de síntomas para tratar

D) Citar de inmediato para confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa e iniciar levotiroxina sin esperar síntomas

E) Iniciar propiltiouracilo

> **Respuesta D.** El hipotiroidismo congénito suele ser asintomático al nacer y es una causa prevenible de discapacidad intelectual. Ante un tamizaje alterado se confirma de inmediato con TSH y T4 libre séricas y, si se confirma, se inicia levotiroxina idealmente antes de los 15 días de vida. Los estudios etiológicos (ecografía, cintigrafía) no deben retrasar el tratamiento.

156 endo-06 · Perfil V3 6.02.3.006 · Orbitopatía tiroidea · *Práctica*

Mujer de 41 años, fumadora de 15 cigarrillos al día, con enfermedad de Graves diagnosticada hace 2 meses, en tratamiento con tiamazol, actualmente eutiroidea. Refiere sensación de arenilla, lagrimeo y retracción palpebral leve bilateral, sin diplopía y con agudeza visual normal. Sin edema de papila ni alteración de la visión de colores.

¿Cuál es la medida que más disminuye el riesgo de progresión de su orbitopatía?

A) Radioyodo de inmediato para eliminar el hipertiroidismo

B) Suspender completamente el tabaco

C) Descompresión orbitaria quirúrgica

D) Bolos de metilprednisolona endovenosa

E) Aumentar el tiamazol hasta lograr TSH suprimida

> **Respuesta B.** El tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable de aparición y progresión de la orbitopatía de Graves. En la orbitopatía leve se indica cesación del tabaco, lubricantes, selenio y mantener el eutiroidismo. El radioyodo puede empeorarla; los corticoides EV se reservan para la forma activa moderada a severa y la descompresión para la neuropatía óptica.

157 endo-20 · Perfil V3 6.02.5.002 · Campo visual por confrontación · *Práctica*

Hombre de 50 años con cefalea de meses y choques frecuentes con objetos a ambos lados. Al examinar el campo visual por confrontación, sentado frente a él a 1 metro, el paciente no detecta los dedos del examinador en las mitades temporales de ambos campos visuales.

¿Qué lesión sugiere este hallazgo?

A) Lesión del quiasma óptico, como un macroadenoma hipofisario

B) Lesión del nervio óptico derecho

C) Lesión de la cintilla óptica izquierda

D) Lesión del lóbulo occipital derecho

E) Glaucoma crónico

> **Respuesta A.** El campo visual por confrontación compara el campo del paciente con el del examinador, cada ojo por separado y por cuadrantes. La hemianopsia bitemporal indica compresión del quiasma (cruce de fibras nasales), típicamente por macroadenoma hipofisario o craneofaringioma; se estudia con resonancia selar y campimetría computarizada. Las lesiones retroquiasmáticas dan hemianopsias homónimas.

Gastroenterología

158 gastro-13 · Perfil V3 1.01.4.012 · Perfil bioquímico · *Práctica*

Un hombre de 72 años, asintomático, tiene en su perfil bioquímico fosfatasa alcalina de 420 U/L (normal hasta 120), con GGT, bilirrubina, transaminasas, calcio y fósforo normales. Refiere dolor leve en la tibia derecha, que se ve arqueada.

¿Cuál es el origen más probable de la elevación de la fosfatasa alcalina?

A) Colestasia intrahepática

B) Obstrucción de la vía biliar

C) Hepatitis aguda

D) Origen óseo, sugerente de enfermedad de Paget

E) Metástasis hepáticas

> **Respuesta D.** La fosfatasa alcalina proviene de hígado y hueso; si la GGT es normal, el origen es óseo. En un adulto mayor con fosfatasa alcalina aislada, calcio normal y tibia arqueada, sugiere enfermedad de Paget, que se confirma con radiografías y cintigrama óseo. La colestasia elevaría también la GGT.

159 gastro-15 · Perfil V3 1.02.3.010 · Regímenes dietéticos fundamentales · *Práctica*

Un hombre de 58 años con cirrosis hepática por alcohol presenta ascitis moderada, sin encefalopatía. Su natremia es 136 mEq/L.

¿Cuál es el régimen dietético más adecuado?

A) Restricción hídrica bajo 500 mL/día

B) Restricción proteica estricta, bajo 0,5 g/kg/día

C) Régimen hiposódico (unos 2 g de sodio al día) con aporte proteico normal

D) Régimen hipersódico para expandir el volumen

E) Ayuno hasta resolver la ascitis

> **Respuesta C.** En la ascitis cirrótica el pilar dietético es la restricción de sodio (unos 2 g de sodio, o 5 g de sal, al día) junto a diuréticos. El aporte proteico debe ser normal (1,2-1,5 g/kg/día), porque suelen estar desnutridos; la restricción proteica ya no se recomienda. La restricción hídrica solo se indica con natremia bajo 125 mEq/L.

160 gastro-14 · Perfil V3 1.02.4.002 · Ecotomografia abdominal · *Práctica*

Un hombre de 48 años, con IMC de 33 kg/m², DM2 y triglicéridos elevados, tiene transaminasas 1,5 veces sobre lo normal en un control. No consume alcohol y las serologías de hepatitis B y C son negativas.

¿Cuál es el examen de imagen inicial más adecuado?

A) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

B) Colangiorresonancia

C) TAC de abdomen con contraste

D) Biopsia hepática de entrada

E) Ecotomografía abdominal

> **Respuesta E.** Se sospecha enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. La ecotomografía abdominal es el examen inicial: barata, sin radiación, muestra el hígado hiperecogénico (esteatosis) y descarta otras causas. Luego se estima fibrosis con FIB-4 o elastografía. La biopsia se reserva para casos dudosos o sospecha de fibrosis avanzada.

161 gastro-14 · Perfil V3 1.02.4.011 · Estudio funcional hepático · *Práctica*

Un hombre de 50 años, que bebe 6 vasos de vino diarios, tiene GOT 180 U/L, GPT 70 U/L, GGT 420 U/L, bilirrubina 1,2 mg/dL y tiempo de protrombina 85%. No usa fármacos.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hepatitis viral aguda

B) Coledocolitiasis

C) Daño hepático por alcohol

D) Hepatitis autoinmune

E) Hemocromatosis

> **Respuesta C.** Una relación GOT/GPT mayor de 2, con transaminasas bajo 300 U/L y GGT muy elevada, es el patrón típico del daño hepático alcohólico. La hepatitis viral aguda suele dar transaminasas sobre 1.000 U/L con predominio de GPT, y la coledocolitiasis da un patrón colestásico con fosfatasa alcalina alta y dolor.

162 gastro-23 · Perfil V3 1.04.4.011 · Parasitológico de deposiciones · *Práctica*

Un niño de 5 años, que asiste a jardín infantil, presenta deposiciones blandas, malolientes y esteatorreicas, distensión abdominal y baja de peso de 6 semanas de evolución.

¿Cuál es el examen más adecuado para el diagnóstico etiológico más probable?

A) Coprocultivo

B) Test de Graham

C) Examen parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días distintos)

D) Colonoscopía

E) Antígeno de rotavirus en deposiciones

> **Respuesta C.** Diarrea crónica esteatorreica con distensión y baja de peso en un preescolar de jardín infantil sugiere giardiasis. El parasitológico seriado (3 muestras en días alternos, con fijador) mejora la sensibilidad porque la eliminación de quistes es intermitente. El test de Graham busca Enterobius ante prurito anal. Se trata con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida.

163 gastro-26 · Perfil V3 1.05.2.011 · Neumotórax hipertensivo · *Práctica*

Hombre de 25 años, motorista, tras un choque presenta disnea intensa. FR 36 por minuto, SatO2 82 %, PA 75/40 mmHg, FC 140 por minuto, ingurgitación yugular, tráquea desviada a la derecha, murmullo pulmonar abolido e hipersonoridad en el hemitórax izquierdo.

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Radiografía de tórax urgente para confirmar

B) TAC de tórax

C) Intubación y ventilación a presión positiva antes de descomprimir

D) Pericardiocentesis

E) Descompresión inmediata del hemitórax izquierdo con aguja o toracostomía digital, seguida de tubo pleural

> **Respuesta E.** El neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico: shock, ingurgitación yugular, desviación traqueal contralateral, murmullo abolido e hipersonoridad. Se descomprime de inmediato, sin esperar imágenes, con aguja o toracostomía digital, y luego se instala tubo pleural. Ventilar a presión positiva antes de descomprimir lo agrava.

164 gastro-08 · Perfil V3 1.06.1.011 · Diarrea crónica · *Práctica*

Mujer de 45 años con 4 meses de diarrea acuosa, 4 a 5 veces al día, que la despierta en la noche, con baja de 6 kg. No ha viajado. Al examen hay palidez leve. Hemoglobina 10,5 g/dL y VCM 76 fL.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Diagnosticar síndrome de intestino irritable e indicar dieta baja en FODMAP

B) Loperamida y control en 3 meses

C) Coprocultivo como único examen

D) Estudio de diarrea crónica orgánica, con exámenes de laboratorio y colonoscopía con biopsias

E) Metronidazol empírico por 7 días

> **Respuesta D.** Diarrea de más de 4 semanas con signos de alarma —nocturna, baja de peso y anemia— es orgánica hasta demostrar lo contrario. Se estudia con laboratorio (hemograma, PCR, serología celíaca, parasitológico) y colonoscopía con biopsias. El intestino irritable no despierta en la noche ni produce anemia.

165 gastro-14 · Perfil V3 1.06.1.021 · Hepatitis crónica · *Práctica*

Mujer de 38 años con astenia. Sus exámenes muestran GPT 180 U/L y GOT 140 U/L, elevadas en forma persistente por 8 meses, con bilirrubina normal. AgHBs y anticuerpos anti-VHC negativos; no consume alcohol ni fármacos. Tiene IgG sérica elevada y anticuerpos antinucleares y anti-músculo liso positivos.

¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?

A) Hepatitis C crónica; antivirales de acción directa

B) Hepatitis autoinmune; prednisona con o sin azatioprina

C) Esteatohepatitis metabólica; baja de peso

D) Enfermedad de Wilson; penicilamina

E) Hepatitis A prolongada; manejo de soporte

> **Respuesta B.** Hepatitis de más de 6 meses en una mujer, con hipergammaglobulinemia IgG y anticuerpos antinucleares y anti-músculo liso positivos, es una hepatitis autoinmune tipo 1. Se confirma con biopsia hepática y se trata con corticoides, solos o con azatioprina. La serología negativa descarta virus B y C.

166 gastro-15 · Perfil V3 1.06.1.022 · Insuficiencia hepática crónica · *Práctica*

Hombre de 59 años con cirrosis hepática alcohólica, en control en policlínico. Se desea estimar su pronóstico mediante la clasificación de Child-Pugh.

¿Cuál de los siguientes parámetros NO forma parte de la clasificación de Child-Pugh?

A) Bilirrubina total

B) Creatinina plasmática

C) Tiempo de protrombina o INR

D) Albúmina plasmática

E) Presencia y grado de ascitis

> **Respuesta B.** Child-Pugh incluye bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina o INR, ascitis y encefalopatía. La creatinina no forma parte de Child-Pugh: está en el MELD (bilirrubina, INR, creatinina y sodio en el MELD-Na), que se usa para priorizar el trasplante hepático.

167 gastro-09 · Perfil V3 1.06.1.023 · Intolerancia a la lactosa · *Práctica*

Hombre de 24 años con distensión, meteorismo, dolor cólico y deposiciones líquidas que aparecen 1 a 2 horas después de tomar leche o comer helado. No tiene baja de peso, sangre en las deposiciones ni anemia. Los anticuerpos anti-transglutaminasa son negativos.

¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?

A) Test de D-xilosa

B) Biopsia duodenal

C) Colonoscopía con biopsias

D) Elastasa fecal

E) Test de hidrógeno espirado con carga de lactosa

> **Respuesta E.** Síntomas osmóticos y fermentativos ligados a los lácteos, sin signos de alarma, sugieren intolerancia a la lactosa por hipolactasia. Se confirma con el test de hidrógeno espirado tras una carga de lactosa, o con la exclusión y reintroducción de lácteos. Se trata reduciendo la lactosa o con lactasa, sin eliminar todo el calcio.

168 gastro-23 · Perfil V3 1.06.1.026 · Parasitosis intestinales · *Práctica*

Niña de 5 años que asiste a jardín infantil presenta prurito anal de predominio nocturno hace 3 semanas, con sueño intranquilo. Al examen se observan lesiones por grataje perianal. El test de Graham es positivo.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Metronidazol a la paciente por 7 días

B) Crema de corticoide perianal

C) Praziquantel en dosis única a la paciente

D) Mebendazol a la paciente y a todo el grupo familiar, repitiendo la dosis a las 2 semanas

E) Nitazoxanida solo a la paciente

> **Respuesta D.** El test de Graham positivo confirma oxiuriasis por Enterobius vermicularis. Se trata a todo el grupo familiar con mebendazol o albendazol, repitiendo a las 2 semanas por el ciclo de autoinfección, junto con medidas de higiene como uñas cortas y lavado de ropa de cama. Metronidazol es para protozoos y praziquantel para teniasis.

169 gastro-19 · Perfil V3 1.06.2.001 · Abdomen agudo · *Práctica*

Hombre de 72 años, fumador e hipertenso, consulta por dolor abdominal y lumbar súbito e intenso de 1 hora de evolución. Está pálido y sudoroso, con PA 80/50 mmHg y FC 125 por minuto. Se palpa una masa pulsátil periumbilical.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reanimación con hipotensión permisiva y traslado inmediato a pabellón

B) TAC de abdomen con contraste antes de decidir

C) Pielografía por sospecha de cólico renal

D) Analgesia y observación

E) Ecografía renal y urocultivo

> **Respuesta A.** Dolor abdominal o lumbar súbito, shock y masa pulsátil es un aneurisma aórtico abdominal roto hasta demostrar lo contrario. En el paciente inestable no se espera la TAC: se reanima con hipotensión permisiva y se lleva de inmediato a pabellón. Confundirlo con un cólico renal es el error clásico.

170 gastro-20 · Perfil V3 1.06.2.001 · Abdomen agudo · *Práctica*

Mujer de 68 años, con antecedente de histerectomía, consulta por 24 horas de dolor abdominal cólico, vómitos y ausencia de eliminación de gases. Abdomen distendido y timpánico, con ruidos de lucha, sin signos peritoneales. Afebril, FC 92 por minuto, leucocitos y lactato normales. Radiografía: asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos.

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Laparotomía de urgencia inmediata

B) Régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y reevaluación seriada

C) Enema evacuante y proquinéticos

D) Colonoscopía descompresiva

E) Alta con analgesia y control en 48 horas

> **Respuesta B.** Es una obstrucción de intestino delgado por bridas sin signos de estrangulación. El manejo inicial es régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación y corrección electrolítica, con reevaluación seriada. Se opera si aparecen fiebre, peritonismo, leucocitosis o lactato elevado, o si no resuelve en 48 a 72 horas. Los proquinéticos están contraindicados.

171 gastro-14 · Perfil V3 1.06.2.009 · Insuficiencia hepática aguda · *Práctica*

Mujer de 28 años sin enfermedad hepática previa presenta ictericia de 10 días. Hoy su familia la nota somnolienta y desorientada, con asterixis. Exámenes: GPT 3.200 UI/L, bilirrubina total 12 mg/dL, INR 2,8, glicemia 62 mg/dL. HBsAg e IgM anti-core positivos.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Manejo ambulatorio con control de pruebas hepáticas en 48 horas

B) Hospitalizar en sala y administrar vitamina K hasta normalizar el INR

C) Ingreso a UCI y contacto precoz con un centro de trasplante hepático

D) Plasma fresco congelado para normalizar el INR antes de cualquier evaluación

E) Corticoides en dosis altas

> **Respuesta C.** Encefalopatía más INR de 1,5 o más en una paciente sin hepatopatía previa define insuficiencia hepática aguda, aquí por virus hepatitis B. Requiere UCI y contacto precoz con un centro de trasplante, además de antiviral. El plasma no se usa para corregir el INR sin sangrado porque oculta el pronóstico; la vitamina K no revierte una falla de síntesis.

172 gastro-09 · Perfil V3 1.06.3.002 · Manejo dietético en enfermos digestivos · *Práctica*

Mujer de 30 años con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca, confirmada con anticuerpos antitransglutaminasa y biopsia duodenal. Consulta por orientación dietética.

¿Cuál de los siguientes alimentos puede consumir libremente?

A) Pan de centeno

B) Arroz y maíz

C) Cerveza de cebada

D) Galletas de trigo integral

E) Sémola de trigo

> **Respuesta B.** La enfermedad celíaca se trata con una dieta estricta y de por vida libre de gluten: se excluyen trigo, cebada y centeno, y la avena contaminada. Arroz, maíz, papa, legumbres, carnes, frutas y verduras son naturalmente libres de gluten. En productos procesados conviene buscar el logo de alimento libre de gluten.

173 gastro-05 · Perfil V3 1.06.3.003 · Epidemiología de los cánceres digestivos · *Práctica*

En una reunión clínica de un CESFAM se revisa la epidemiología de los cánceres digestivos en Chile para priorizar la derivación de pacientes con epigastralgia.

¿Cuál es el cáncer digestivo que causa más muertes en hombres en Chile?

A) Cáncer colorrectal

B) Cáncer de esófago

C) Cáncer gástrico

D) Cáncer de vesícula biliar

E) Hepatocarcinoma

> **Respuesta C.** El cáncer gástrico es la principal causa de muerte por cáncer digestivo en hombres chilenos, con mayor incidencia en el centro-sur del país; por eso existe el GES y la endoscopía precoz ante epigastralgia en mayores de 40 años. El cáncer de vesícula es característico de mujeres chilenas y el colorrectal va en aumento.

174 gastro-11 · Perfil V3 1.06.3.004 · Métodos de tamizaje para cáncer de colon y hepatocarcinoma · *Práctica*

Hombre de 55 años, asintomático, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer ni de pólipos, consulta en su CESFAM para un examen preventivo.

¿Cuál es el método de tamizaje de cáncer colorrectal recomendado en este paciente?

A) Colonoscopía virtual por TAC cada 2 años

B) Antígeno carcinoembrionario anual

C) Test inmunológico de sangre oculta en deposiciones y, si es positivo, colonoscopía

D) Tacto rectal anual

E) Enema baritado cada 5 años

> **Respuesta C.** En población de riesgo promedio desde los 50 años, el tamizaje en Chile se hace con test inmunológico de hemorragia oculta en deposiciones; si es positivo, colonoscopía. El CEA no sirve para tamizaje, solo para seguimiento del cáncer tratado. En hepatocarcinoma, en cambio, se tamiza al cirrótico con ecografía cada 6 meses.

175 gastro-03 · Perfil V3 1.06.4.002 · Tránsito esófago-estómago-duodeno · *Práctica*

Hombre de 74 años consulta por disfagia alta de 1 año de evolución, regurgitación de alimentos no digeridos horas después de comer, halitosis y tos nocturna. Al deglutir se escucha un gorgoteo cervical.

¿Cuál es el examen inicial de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Manometría esofágica de alta resolución

B) Tránsito esófago-estómago-duodeno (esofagograma con bario)

C) pH-metría de 24 horas

D) TAC de cuello con contraste

E) Endoscopía digestiva alta con biopsias

> **Respuesta B.** La clínica sugiere un divertículo de Zenker. El esofagograma baritado lo demuestra como una bolsa posterior en la unión faringoesofágica y orienta la cirugía. La endoscopía no es el examen inicial porque al intubar a ciegas puede perforar el divertículo. La manometría es clave en la acalasia, no aquí.

176 gastro-25 · Perfil V3 1.06.4.003 · Enema barritada · *Práctica*

Lactante de 2 meses con constipación desde el nacimiento y eliminación de meconio después de las 48 horas de vida. Presenta distensión abdominal y, al tacto rectal, ampolla vacía con salida explosiva de deposiciones y gases.

Si se realiza un enema baritado, ¿qué hallazgo apoya el diagnóstico más probable?

A) Signo de la cuerda en íleon terminal

B) Microcolon con imagen en miga de pan en íleon

C) Zona de transición entre un recto estrecho y un colon proximal dilatado

D) Imagen en muelle enrollado en colon transverso

E) Colon completamente normal

> **Respuesta C.** La sospecha es enfermedad de Hirschsprung. El enema baritado muestra el segmento distal agangliónico estrecho, una zona de transición y el colon proximal dilatado, con retención del contraste a las 24 horas. Se confirma con biopsia rectal sin células ganglionares. El muelle enrollado es de invaginación y el microcolon con miga de pan, del íleo meconial.

177 gastro-17 · Perfil V3 1.06.4.004 · Colangiografía endoscópica · *Práctica*

Mujer de 50 años con dolor en hipocondrio derecho e ictericia de 3 días, sin fiebre. Bilirrubina total 5 mg/dL, de predominio directo. La ecografía muestra colelitiasis y un colédoco de 12 mm con un cálculo de 8 mm en su porción distal.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?

A) Colangiorresonancia para confirmar el cálculo

B) Ácido ursodesoxicólico

C) Colecistectomía sola, sin tratar la vía biliar

D) CPRE con papilotomía y extracción del cálculo, seguida de colecistectomía

E) TAC de abdomen con contraste

> **Respuesta D.** Si la ecografía ya demuestra el cálculo en el colédoco, la sospecha es alta y no se necesita colangiorresonancia: la CPRE es diagnóstica y terapéutica, con papilotomía y extracción. Luego se realiza la colecistectomía, idealmente en el mismo ingreso. La colangiorresonancia se reserva para la sospecha intermedia, sin cálculo visible.

178 gastro-18 · Perfil V3 1.06.4.005 · TAC abdominal · *Práctica*

Mujer de 45 años ingresa con dolor epigástrico intenso irradiado en cinturón, lipasa 8 veces el valor normal y ecografía con colelitiasis. A las 12 horas está hemodinámicamente estable, con buena respuesta a la analgesia y a la hidratación.

¿Cuándo está indicada la TAC de abdomen con contraste en esta paciente?

A) De inmediato, para confirmar el diagnóstico

B) Antes de iniciar la hidratación

C) Siempre a las 24 horas, para calcular el índice de Balthazar

D) Nunca, porque el contraste empeora la pancreatitis

E) Solo si hay duda diagnóstica o mala evolución, idealmente después de 72 horas

> **Respuesta E.** El diagnóstico ya está hecho con 2 de 3 criterios (dolor típico y lipasa sobre 3 veces lo normal), por lo que la TAC no se necesita al ingreso. Se pide ante duda diagnóstica o mala evolución, después de 72 horas, cuando la necrosis ya es evaluable y se puede calcular el índice de Balthazar.

179 gastro-13 · Perfil V3 1.06.4.006 · Ecotomografía abdominal · *Práctica*

Mujer de 45 años con ictericia, coluria y prurito de 1 semana. Bilirrubina total 6 mg/dL, de predominio directo, con FA y GGT elevadas y transaminasas levemente alteradas.

¿Cuál es el primer examen de imagen que se debe solicitar?

A) Ecografía abdominal

B) Colangiorresonancia

C) CPRE

D) TAC de abdomen con contraste

E) Cintigrafía hepatobiliar

> **Respuesta A.** Ante una ictericia con patrón colestásico, la ecografía abdominal es el primer examen: es barata, inocua y distingue la colestasia extrahepática (vía biliar dilatada) de la intrahepática (vía no dilatada), además de mostrar cálculos. Según su resultado se decide colangiorresonancia, TAC o CPRE.

180 gastro-01 · Perfil V3 1.06.4.007 · Endoscopía digestiva alta y baja · *Práctica*

Hombre de 56 años con 2 años de pirosis que trata con omeprazol a demanda. Hace 2 meses siente que los sólidos se le quedan detenidos tras el esternón y ha bajado 5 kg. Hemoglobina 11,2 g/dL.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Duplicar la dosis de omeprazol por 8 semanas

B) Radiografía de tórax

C) pH-metría esofágica de 24 horas

D) Manometría esofágica

E) Endoscopía digestiva alta con biopsias

> **Respuesta E.** Disfagia, baja de peso, anemia e inicio después de los 50 años son signos de alarma: obligan a endoscopía digestiva alta con biopsias para descartar cáncer, Barrett o estenosis. Escalar el IBP sin estudiar retrasa el diagnóstico; la pH-metría y la manometría no muestran la mucosa.

181 gastro-02 · Perfil V3 1.06.4.007 · Endoscopía digestiva alta y baja · *Práctica*

Hombre de 61 años consulta por melena. La endoscopía digestiva alta muestra una úlcera gástrica de 2 cm en la curvatura menor, sin sangrado activo. Las biopsias son negativas para neoplasia y el test de ureasa es positivo. Se indica erradicación de Helicobacter pylori y omeprazol.

¿Cuál es el seguimiento más adecuado?

A) Endoscopía digestiva alta de control con nuevas biopsias a las 8 a 12 semanas

B) Test de aire espirado como único control

C) Alta sin controles, ya que la biopsia fue negativa

D) Serología para Helicobacter pylori a las 4 semanas

E) TAC de abdomen a los 6 meses

> **Respuesta A.** Toda úlcera gástrica se controla con endoscopía y nuevas biopsias a las 8–12 semanas hasta confirmar su cicatrización, porque una biopsia inicial negativa no descarta cáncer. Ese control permite además verificar la erradicación. La úlcera duodenal no complicada no requiere endoscopía de control.

182 gastro-10 · Perfil V3 1.06.4.007 · Endoscopía digestiva alta y baja · *Práctica*

Mujer de 29 años con colitis ulcerosa conocida consulta por 10 deposiciones con sangre al día, fiebre de 38,6 °C y FC 115 por minuto. Abdomen distendido y sensible. La radiografía de abdomen muestra el colon transverso dilatado a 7 cm.

Respecto de la endoscopía, ¿cuál es la conducta correcta?

A) Colonoscopía total urgente para evaluar la extensión

B) No realizar colonoscopía; hospitalizar con corticoides endovenosos y evaluación quirúrgica precoz

C) Colonoscopía con biopsias para descartar citomegalovirus antes de tratar

D) Enema baritado de doble contraste

E) Endoscopía digestiva alta para descartar compromiso gástrico

> **Respuesta B.** Es un megacolon tóxico: colon de más de 6 cm con toxicidad sistémica. La colonoscopía y el enema baritado están contraindicados por el alto riesgo de perforación. Se hospitaliza con régimen cero, corticoides endovenosos y evaluación quirúrgica precoz; a lo más, una rectoscopía cuidadosa con mínima insuflación.

183 gastro-21 · Perfil V3 1.06.4.007 · Endoscopía digestiva alta y baja · *Práctica*

Hombre de 60 años, usuario de antiinflamatorios por artrosis, consulta por 2 episodios de melena. Al ingreso FC 110 por minuto y PA 100/60 mmHg; tras la reanimación con cristaloides, FC 88 por minuto y PA 120/70 mmHg. Hemoglobina 9,8 g/dL. Se inicia IBP endovenoso.

¿Cuál es el momento más adecuado para la endoscopía digestiva alta?

A) En forma electiva a las 4 a 6 semanas

B) Inmediatamente, antes de iniciar la reanimación

C) Dentro de las primeras 24 horas, una vez estabilizado

D) Solo si vuelve a sangrar

E) Después de una colonoscopía, para descartar origen bajo

> **Respuesta C.** En la hemorragia digestiva alta no variceal la endoscopía se realiza dentro de las 24 horas, después de estabilizar: identifica la causa, permite terapia endoscópica y estratifica el riesgo de resangrado con la clasificación de Forrest. Endoscopiar sin reanimar aumenta las complicaciones; en la sospecha variceal se busca hacerla dentro de 12 horas.

184 gastro-14 · Perfil V3 1.06.4.008 · Biopsia hepática · *Práctica*

Hombre de 52 años con hepatopatía crónica de causa no precisada pese a un estudio serológico completo. Se plantea biopsia hepática. Presenta ascitis moderada, INR de 1,9 y plaquetas de 60.000/mm3.

¿Cuál es la vía más adecuada para obtener la biopsia?

A) Percutánea guiada por ecografía

B) Percutánea a ciegas tras transfundir plaquetas

C) Laparotomía exploradora

D) No está indicada; diagnosticar solo con transaminasas

E) Transyugular

> **Respuesta E.** La biopsia hepática percutánea está relativamente contraindicada con ascitis, INR mayor de 1,5 o plaquetas bajas, por riesgo de sangrado. En estos casos se usa la vía transyugular, que obtiene tejido desde la vena hepática sin perforar la cápsula y permite medir el gradiente de presión portal.

185 gastro-11 · Perfil V3 1.06.4.009 · Sangre oculta en deposiciones · *Práctica*

Hombre de 56 años, asintomático y sin antecedentes familiares de cáncer, participa en un programa de tamizaje de cáncer colorrectal. El test inmunoquímico de sangre oculta en deposiciones resulta positivo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el test en 1 año

B) Repetir el test en 3 muestras más y decidir según el resultado

C) Solicitar antígeno carcinoembrionario

D) Colonoscopía completa

E) Rectoscopía rígida

> **Respuesta D.** Un test de sangre oculta positivo en tamizaje obliga a colonoscopía completa, que identifica pólipos o cáncer y permite resecar y biopsiar. Repetir el test o pedir CEA retrasa el diagnóstico, y el CEA no sirve para tamizaje. La rectoscopía solo explora el recto y no descarta lesiones proximales.

186 gastro-15 · Perfil V3 1.06.4.011 · Estudio de función hepática · *Práctica*

Paciente de 45 años con cirrosis hepática conocida presenta una descompensación aguda. Se desea evaluar precozmente la capacidad de síntesis del hígado.

¿Cuál es el parámetro que refleja más rápidamente los cambios en la función de síntesis hepática?

A) Tiempo de protrombina o INR

B) Albúmina plasmática

C) Transaminasas (GOT y GPT)

D) Fosfatasa alcalina

E) GGT

> **Respuesta A.** Los factores de coagulación tienen vida media de horas (el factor VII, cerca de 6 horas), por lo que el tiempo de protrombina o INR refleja precozmente la función de síntesis. La albúmina tiene vida media cercana a 20 días y cambia lentamente. Las transaminasas indican necrosis hepatocelular, y FA y GGT, colestasia.

187 gastro-09 · Perfil V3 1.06.4.013 · Laboratorio inicial de síndrome de malabsorción · *Práctica*

Hombre de 50 años con 5 meses de deposiciones voluminosas, pálidas y malolientes, que flotan y cuesta eliminar del inodoro, con baja de 7 kg. Usted sospecha un síndrome de malabsorción.

¿Cuál es el examen inicial más útil para confirmar la esteatorrea?

A) Sudán III en deposiciones o esteatocrito

B) Coprocultivo

C) Test de sangre oculta en deposiciones

D) Leucocitos fecales

E) Calprotectina fecal

> **Respuesta A.** El primer paso ante sospecha de malabsorción es objetivar la esteatorrea con Sudán III o esteatocrito; el estándar es la grasa fecal de 72 horas. Luego se busca la causa: D-xilosa para distinguir mucosa de páncreas, serología celíaca y elastasa fecal. Calprotectina y leucocitos fecales miden inflamación, no grasa.

188 gastro-17 · Perfil V3 1.06.4.015 · Colangiografía por resonancia magnética · *Práctica*

Mujer de 48 años, colecistectomizada hace 2 años, consulta por dolor intermitente en hipocondrio derecho. Afebril, sin ictericia. Exámenes: bilirrubina total 1,8 mg/dL, FA 280 UI/L, GGT 310 UI/L. La ecografía abdominal muestra un colédoco de 8 mm sin cálculos visibles.

¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)

B) Repetir ecografía en 6 meses

C) Colangiorresonancia

D) TAC de abdomen sin contraste

E) Exploración quirúrgica de la vía biliar

> **Respuesta C.** Colédoco dilatado y colestasia, sin cálculo visible ni colangitis, configuran un riesgo intermedio de coledocolitiasis: corresponde colangiorresonancia, no invasiva y muy sensible. La CPRE se reserva para riesgo alto o cálculo confirmado, por su riesgo de pancreatitis. La TAC sin contraste es poco sensible para cálculos coledocianos.

189 gastro-15 · Perfil V3 1.06.5.001 · Paracentesis · *Práctica*

Hombre de 61 años con cirrosis y ascitis presenta dolor abdominal difuso, fiebre de 38 °C y leve confusión. Se realiza paracentesis diagnóstica.

¿Qué hallazgo del líquido ascítico confirma peritonitis bacteriana espontánea?

A) Recuento de polimorfonucleares de 250/mm3 o más

B) Proteínas mayores de 2,5 g/dL

C) Gradiente de albúmina suero-ascitis mayor de 1,1 g/dL

D) Glucosa menor de 50 mg/dL con múltiples gérmenes en el Gram

E) Recuento de glóbulos rojos mayor de 10.000/mm3

> **Respuesta A.** La PBE se define por 250 o más polimorfonucleares por mm3 en el líquido ascítico, sin foco quirúrgico. Se trata con cefotaxima o ceftriaxona y albúmina. Un GASA mayor de 1,1 indica hipertensión portal, no infección. Glucosa baja con flora polimicrobiana sugiere peritonitis secundaria por perforación, que requiere TAC y cirugía.

190 gastro-08 · Perfil V3 1.07.1.002 · Constipación y fecalomas · *Práctica*

Mujer de 86 años, postrada y usuaria de opioides por artrosis, es traída por "diarrea" de 5 días: escurrimiento de deposiciones líquidas en pequeña cantidad, con distensión y dolor abdominal leve. No elimina deposiciones formadas hace 10 días. Al tacto rectal se palpa una masa de deposiciones duras en la ampolla.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Loperamida

B) Coprocultivo y ciprofloxacino

C) Colonoscopía urgente

D) Desimpactación (extracción manual y enemas) seguida de laxantes osmóticos

E) Ayuno y suero endovenoso

> **Respuesta D.** Es un fecaloma con diarrea por rebalse: el líquido escurre alrededor de la impactación. Se trata con desimpactación (extracción digital y enemas) y luego laxantes osmóticos regulares, revisando fármacos constipantes como los opioides. La loperamida empeoraría el cuadro y los antibióticos no tienen indicación.

191 gastro-20 · Perfil V3 1.07.2.001 · Abdomen agudo en adulto mayor · *Práctica*

Mujer de 83 años con fibrilación auricular sin anticoagulación consulta por dolor abdominal intenso de 6 horas. Al examen el abdomen está blando, levemente sensible, sin signos peritoneales. Lactato 4,2 mmol/L, leucocitos 16.000/mm3.

¿Cuál es el examen más adecuado?

A) Angio-TAC de abdomen

B) Radiografía simple de abdomen

C) Ecografía abdominal

D) Endoscopía digestiva alta

E) Observación y control de exámenes en 24 horas

> **Respuesta A.** En el adulto mayor, el abdomen agudo suele tener un examen engañosamente benigno. Dolor desproporcionado al examen, fibrilación auricular y lactato elevado sugieren isquemia mesentérica aguda embólica, cuyo examen de elección es la angio-TAC. Observar retrasa el diagnóstico de una patología de alta mortalidad, y la radiografía y la ecografía son poco sensibles.

192 gastro-16 · Perfil V3 1.08.5.003 · Biopsia hepática · *Práctica*

Hombre de 63 años con cirrosis por virus hepatitis C, en seguimiento con ecografía semestral, presenta un nódulo hepático de 3 cm. En la TAC trifásica la lesión muestra hiperrealce en fase arterial y lavado en fases portal y tardía.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del diagnóstico?

A) Biopsia hepática percutánea obligatoria antes de tratar

B) Control con ecografía en 6 meses

C) Diagnóstico de carcinoma hepatocelular sin necesidad de biopsia y derivar para tratamiento

D) Medir CA 19-9 para confirmar

E) Biopsia transyugular

> **Respuesta C.** En un cirrótico, un nódulo mayor de 1 cm con hiperrealce arterial y lavado en fase portal o tardía en TAC o RM permite diagnosticar carcinoma hepatocelular sin biopsia. La biopsia se reserva para lesiones con imagen atípica o hígado no cirrótico, por su riesgo de sangrado y siembra tumoral. El CA 19-9 se usa en colangiocarcinoma.

193 gastro-15 · Perfil V3 1.10.2.006 · Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc) · *Práctica*

Hombre de 63 años con cirrosis alcohólica, abstinente, es traído por somnolencia y desorientación de 2 días. Al examen tiene asterixis, sin fiebre ni dolor abdominal, y refiere constipación de 5 días. Glicemia y electrolitos normales. La paracentesis no muestra signos de infección.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Flumazenil

B) Restricción proteica absoluta

C) Benzodiacepinas para la agitación

D) Lactulosa oral para lograr 2 a 3 deposiciones blandas al día

E) Furosemida endovenosa

> **Respuesta D.** Un compromiso de conciencia con asterixis en un cirrótico es una encefalopatía hepática, aquí precipitada por constipación. Se buscan y corrigen los precipitantes (infección, hemorragia, diuréticos, alteraciones electrolíticas) y se indica lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones blandas al día, agregando rifaximina si recurre. La restricción proteica ya no se recomienda y las benzodiacepinas la empeoran.

194 gastro-24 · Perfil V3 2.01.1.041 · Dolor abdominal recurrente · *Práctica*

Escolar de 8 años con 6 meses de episodios de dolor periumbilical varias veces por semana, que no lo despiertan en la noche y suelen aparecer antes de ir al colegio. Crece en percentil 50 de peso y talla. Examen físico, hemograma, VHS, orina completa y parasitológico seriado normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Endoscopía digestiva alta con biopsias

B) TAC de abdomen y pelvis

C) Omeprazol empírico por 3 meses

D) Diagnosticar dolor abdominal funcional, educar a la familia y abordar los factores psicosociales

E) Erradicación empírica de Helicobacter pylori

> **Respuesta D.** Dolor periumbilical recurrente, sin signos de alarma (dolor nocturno o lejos del ombligo, baja de peso, vómitos, sangrado, fiebre) y con exámenes básicos normales es un dolor abdominal funcional. Se maneja con educación, validación del síntoma y apoyo psicosocial, evitando estudios invasivos innecesarios.

195 gastro-14 · Perfil V3 2.01.1.045 · Insuficiencia hepática aguda · *Práctica*

Un niño de 6 años con hepatitis A confirmada hace 8 días presenta mayor ictericia, vómitos persistentes y somnolencia. Exámenes: bilirrubina total 14 mg/dL, GPT 2.800 UI/L, glicemia 58 mg/dL e INR 2,4, que no corrige tras administrar vitamina K.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar y contactar precozmente a un centro con trasplante hepático

B) Hospitalizar en sala común y repetir exámenes en 72 horas

C) Manejo ambulatorio con reposo y control en una semana

D) Iniciar corticoides endovenosos

E) Administrar plasma fresco congelado y dar el alta al corregir el INR

> **Respuesta A.** Coagulopatía (INR 2 o más, o 1,5 o más con encefalopatía) que no corrige con vitamina K, en un niño sin hepatopatía previa, define insuficiencia hepática aguda; la hepatitis A es una causa frecuente en Chile. Requiere hospitalización en unidad crítica, manejo de hipoglicemia y encefalopatía, y contacto precoz con un centro de trasplante, porque puede progresar rápidamente.

196 gastro-25 · Perfil V3 2.01.4.002 · Radiografía de abdomen simple · *Práctica*

Un recién nacido con síndrome de Down presenta, a las 12 horas de vida, vómitos biliosos sin distensión abdominal. La madre tuvo polihidroamnios. La radiografía simple de abdomen muestra dos burbujas de aire (estómago y duodeno proximal) sin aire distal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atresia duodenal

B) Estenosis hipertrófica del píloro

C) Enfermedad de Hirschsprung

D) Íleo meconial

E) Enterocolitis necrotizante

> **Respuesta A.** El signo de la doble burbuja sin aire distal en la radiografía simple de abdomen, con vómitos biliosos precoces, polihidroamnios y síndrome de Down (asociación frecuente) es atresia duodenal. Se maneja con sonda nasogástrica, hidratación y duodeno-duodenostomía. La estenosis pilórica da vómitos no biliosos a las 3 a 6 semanas; Hirschsprung e íleo meconial dan distensión y múltiples asas dilatadas.

197 gastro-25 · Perfil V3 2.01.4.009 · Radiografía esófago- estómago- duodeno · *Práctica*

Un lactante de 3 semanas, previamente sano, presenta en forma brusca vómitos biliosos (verdes), irritabilidad y leve distensión abdominal. Está hemodinámicamente estable.

¿Cuál es el examen más adecuado para descartar la causa más grave?

A) Radiografía de esófago, estómago y duodeno con contraste (tránsito intestinal alto)

B) Ecografía pilórica

C) pH-metría esofágica

D) Endoscopía digestiva alta

E) Control ambulatorio en 48 horas

> **Respuesta A.** Vómitos biliosos en un lactante son una emergencia quirúrgica hasta descartar malrotación intestinal con vólvulo del intestino medio, que puede llevar a necrosis intestinal en horas. El examen de elección, si el paciente está estable, es la radiografía de esófago, estómago y duodeno con contraste, que muestra la posición anormal del ángulo de Treitz o la imagen en sacacorchos.

198 gastro-23 · Perfil V3 2.01.4.017 · Parasitológico de deposiciones · *Práctica*

Un niño de 4 años que asiste a jardín infantil presenta deposiciones blandas, malolientes y flotantes, distensión abdominal y meteorismo desde hace 4 semanas, con baja de peso leve. Hay casos similares en su sala.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico más probable?

A) Coprocultivo

B) Test de Graham

C) Parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras)

D) Rotavirus en deposiciones

E) Colonoscopía

> **Respuesta C.** Diarrea crónica malabsortiva (esteatorreica, maloliente) con meteorismo en un niño de jardín, con casos en su sala, sugiere giardiasis, la parasitosis intestinal más frecuente en Chile. Se diagnostica con parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días alternos, por la excreción intermitente de quistes) o antígeno en deposiciones. Se trata con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida.

199 gastro-24 · Perfil V3 2.01.5.007 · Proctoclisis · *Práctica*

Un niño de 5 años con constipación crónica presenta dolor abdominal y escurrimiento fecal. Al examen se palpa masa fecal en hipogastrio y el tacto rectal confirma impactación fecal. Se planifica desimpactación con proctoclisis (enema).

¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la proctoclisis?

A) Constipación funcional con fecaloma

B) Escurrimiento fecal (encopresis por rebalse)

C) Neutropenia grave por quimioterapia

D) Antecedente de fisura anal cicatrizada

E) Dieta pobre en fibra

> **Respuesta C.** La desimpactación fecal puede hacerse con polietilenglicol oral en dosis altas o por vía rectal (proctoclisis o enemas). La manipulación rectal está contraindicada en pacientes neutropénicos o inmunosuprimidos (riesgo de bacteriemia), con sospecha de abdomen agudo u obstrucción, enterocolitis o cirugía colorrectal reciente. El escurrimiento por rebalse es justamente una indicación de desimpactar.

200 gastro-03 · Perfil V3 4.01.1.002 · Divertículos esofágicos · *Práctica*

Hombre de 78 años, autovalente, con disfagia alta, regurgitación de alimentos no digeridos, halitosis y 2 neumonías aspirativas en el último año. El esofagograma con bario confirma un divertículo de Zenker de 4 cm.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Observación y dieta blanda

B) Omeprazol a permanencia

C) Dilatación endoscópica con balón

D) Miotomía del cricofaríngeo con resección o sección endoscópica del divertículo

E) Gastrostomía definitiva

> **Respuesta D.** El Zenker sintomático, sobre todo con aspiración, se trata con cirugía: la clave es la miotomía del cricofaríngeo, asociada a diverticulectomía o a diverticulotomía endoscópica. Ni los IBP ni la dilatación corrigen el mecanismo. Ojo: la endoscopía o la sonda a ciegas pueden perforar el divertículo.

201 gastro-25 · Perfil V3 4.01.1.003 · Divertículo de Meckel · *Práctica*

Niño de 2 años, previamente sano, con rectorragia abundante de sangre rojo oscura, indolora. Está pálido, con FC 140 por minuto, abdomen blando e indoloro. La endoscopía digestiva alta es normal.

¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico más probable?

A) Colonoscopía

B) Ecografía abdominal

C) Cintigrafía con pertecnetato de tecnecio 99m

D) Enema baritado

E) Radiografía simple de abdomen

> **Respuesta C.** Hemorragia digestiva baja abundante e indolora en un niño pequeño sugiere divertículo de Meckel con mucosa gástrica ectópica, que ulcera el íleon vecino. La cintigrafía con pertecnetato detecta esa mucosa. El tratamiento es la resección quirúrgica. Regla de los 2: 2 % de la población, a 2 pies de la válvula ileocecal, síntomas antes de los 2 años.

202 gastro-03 · Perfil V3 4.01.1.005 · Cáncer del esofágo · *Práctica*

Hombre de 66 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor intenso, con 3 meses de disfagia progresiva, primero para sólidos y ahora también para papillas, con baja de 9 kg. Al examen está enflaquecido, sin adenopatías palpables.

¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?

A) Endoscopía digestiva alta con biopsias

B) Esofagograma con bario

C) Manometría esofágica

D) TAC de tórax y abdomen

E) PET-CT

> **Respuesta A.** Disfagia lógica y progresiva con baja de peso en un fumador y bebedor sugiere cáncer escamoso de esófago. El diagnóstico se confirma con endoscopía y biopsia; la TAC y el PET-CT sirven después para etapificar, y el esofagograma solo orienta.

203 gastro-05 · Perfil V3 4.01.1.005 · Cáncer del esofágo · *Práctica*

Hombre de 58 años, obeso, con 15 años de pirosis mal controlada. La endoscopía muestra una lesión ulcerada y estenosante en el tercio distal del esófago, cercana a la unión gastroesofágica.

Si la biopsia confirma un cáncer, ¿cuál es el tipo histológico más probable y su principal factor de riesgo?

A) Carcinoma escamoso; tabaco y alcohol

B) Adenocarcinoma; esófago de Barrett por reflujo crónico

C) Adenocarcinoma; infección por Helicobacter pylori

D) Carcinoma escamoso; acalasia

E) Linfoma; inmunosupresión

> **Respuesta B.** El adenocarcinoma se ubica en el tercio distal y nace sobre un esófago de Barrett, consecuencia del reflujo crónico; la obesidad también es factor de riesgo. El escamoso predomina en los tercios superior y medio y se asocia a tabaco, alcohol, cáusticos y acalasia. H. pylori no causa cáncer esofágico.

204 gastro-06 · Perfil V3 4.01.1.006 · Hernia hiatal · *Práctica*

Mujer de 72 años con plenitud y dolor torácico después de comer, más anemia ferropénica. La endoscopía y el estudio con bario muestran una hernia hiatal paraesofágica (tipo II), con el fondo gástrico en el tórax y la unión gastroesofágica en su posición normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Omeprazol a permanencia y control clínico

B) Observación, ya que es frecuente en adultos mayores

C) Reparación quirúrgica electiva

D) Dilatación endoscópica

E) Proquinéticos y medidas posturales

> **Respuesta C.** La hernia paraesofágica sintomática tiene indicación quirúrgica por el riesgo de vólvulo, estrangulación y sangrado por lesiones de Cameron, que explican la anemia. La hernia por deslizamiento (tipo I), en cambio, se maneja como reflujo con IBP y solo se opera si fracasa el tratamiento médico.

205 gastro-05 · Perfil V3 4.01.1.007 · Tumores gástricos benignos · *Práctica*

Mujer de 58 años, en estudio por dispepsia, se realiza una endoscopía digestiva alta que muestra un pólipo sésil de 2 cm en el antro. La biopsia informa adenoma tubular con displasia de bajo grado. Test de ureasa negativo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control endoscópico en 5 años

B) Erradicación de Helicobacter pylori y alta

C) Gastrectomía subtotal

D) Inhibidor de bomba de protones y control en 1 año

E) Resección endoscópica completa del pólipo

> **Respuesta E.** Los pólipos adenomatosos gástricos son lesiones premalignas: deben resecarse completos por vía endoscópica para obtener la histología definitiva, seguidos de vigilancia endoscópica. La gastrectomía es excesiva para un adenoma sin cáncer invasor, y el simple control deja una lesión con riesgo de transformación maligna.

206 gastro-21 · Perfil V3 4.01.1.009 · Tumores del intestino delgado · *Práctica*

Hombre de 62 años presenta anemia ferropénica, test de hemorragia oculta positivo y episodios intermitentes de melena. Una endoscopía digestiva alta y una colonoscopía completa, con buena preparación, son normales.

¿Cuál es el siguiente examen más adecuado?

A) Repetir la colonoscopía en 3 años

B) Enema baritado

C) Cápsula endoscópica

D) Ecografía abdominal

E) Laparotomía exploradora

> **Respuesta C.** Con endoscopía alta y colonoscopía normales, el sangrado probablemente proviene del intestino delgado (angiodisplasias o tumores como GIST, adenocarcinoma o neuroendocrinos). La cápsula endoscópica es el examen de elección para estudiarlo, y puede seguirse de enteroscopía o enteroTAC. Una laparotomía sin localización previa no corresponde.

207 gastro-16 · Perfil V3 4.01.1.022 · Hidatidosis hepática · *Práctica*

Hombre de 40 años, criador de ovejas en la Región de Aysén, asintomático. En una ecografía solicitada por otro motivo se detecta un quiste hepático de 8 cm con membranas internas desprendidas y vesículas hijas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Punción diagnóstica percutánea del quiste

B) Biopsia hepática

C) Observación, por estar asintomático

D) Metronidazol y drenaje percutáneo

E) Albendazol perioperatorio y cirugía

> **Respuesta E.** Un quiste con vesículas hijas en zona ganadera es un quiste hidatídico activo; se apoya con serología. Los quistes grandes o complicados se tratan con cirugía y albendazol antes y después, para reducir el riesgo de siembra. La punción sin protección puede causar anafilaxia y diseminación; la técnica PAIR solo en casos seleccionados.

208 gastro-16 · Perfil V3 4.01.1.023 · Quistes y abscesos hepáticos · *Práctica*

Hombre de 62 años, diabético, con 10 días de fiebre de 39 °C, calofríos y dolor en hipocondrio derecho. Leucocitos 19.000/mm³ y PCR 220 mg/L. La ecografía muestra una lesión hepática hipoecogénica de 7 cm, de contenido líquido con detritus.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Hepatectomía de urgencia

B) Albendazol y cirugía

C) Antibióticos orales y control ecográfico en 3 meses

D) Antibióticos endovenosos y drenaje percutáneo guiado por imagen

E) Observación, ya que es un quiste simple

> **Respuesta D.** Fiebre, dolor en hipocondrio derecho y una colección hepática en un diabético es un absceso hepático piógeno. Se trata con antibióticos endovenosos que cubran gramnegativos y anaerobios, por ejemplo ceftriaxona y metronidazol, más drenaje percutáneo si mide más de 5 cm. Hay que buscar el origen, a menudo biliar.

209 gastro-16 · Perfil V3 4.01.1.024 · Tumores hepáticos · *Práctica*

Hombre de 63 años con cirrosis hepática por alcohol, en seguimiento con ecografía semestral, presenta un nódulo hepático nuevo de 3 cm. La TAC trifásica muestra captación intensa de contraste en fase arterial y lavado en las fases portal y tardía.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hemangioma hepático

B) Hiperplasia nodular focal

C) Metástasis de cáncer colorrectal

D) Hepatocarcinoma

E) Absceso hepático

> **Respuesta D.** En un paciente cirrótico, un nódulo mayor de 1 cm con hiperrealce arterial y lavado en fase portal o tardía es diagnóstico de hepatocarcinoma por imagen, sin necesidad de biopsia. El hemangioma muestra relleno periférico globular centrípeto, y la hiperplasia nodular focal aparece en mujeres jóvenes con hígado sano.

210 gastro-18 · Perfil V3 4.01.1.029 · Pancreatitis crónica · *Práctica*

Hombre de 50 años, con consumo excesivo de alcohol desde hace 15 años, consulta por dolor epigástrico crónico irradiado al dorso, baja de peso de 8 kg y deposiciones abundantes, aceitosas y fétidas. Glicemia en ayunas de 160 mg/dL. La TAC muestra calcificaciones pancreáticas difusas y un conducto pancreático irregular.

Además de suspender el alcohol y el tabaco, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la esteatorrea?

A) Dieta sin gluten

B) Enzimas pancreáticas junto con las comidas

C) Metronidazol

D) Octreotide

E) Pancreatectomía total

> **Respuesta B.** Dolor, esteatorrea y diabetes con calcificaciones pancreáticas definen una pancreatitis crónica con insuficiencia exocrina y endocrina. La esteatorrea se trata con enzimas pancreáticas administradas junto con las comidas. La dieta sin gluten trata la enfermedad celíaca, que no explica las calcificaciones.

211 gastro-13 · Perfil V3 4.01.1.030 · Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares · *Práctica*

Hombre de 66 años presenta ictericia progresiva e indolora de 1 mes, coluria, acolia, prurito y baja de peso de 7 kg. Al examen se palpa una vesícula distendida e indolora. La TAC con contraste muestra un tumor de 2 cm en la región periampular, sin compromiso vascular ni metástasis.

¿Cuál es la cirugía con intención curativa?

A) Colecistectomía

B) Pancreatoduodenectomía (operación de Whipple)

C) Derivación biliodigestiva

D) Pancreatectomía distal con esplenectomía

E) Prótesis biliar por CPRE

> **Respuesta B.** Los tumores periampulares (cabeza de páncreas, ampolla de Vater, colédoco distal y duodeno) se presentan con ictericia indolora y vesícula palpable (Courvoisier-Terrier). Si son resecables, el tratamiento curativo es la pancreatoduodenectomía. La derivación biliodigestiva y la prótesis son paliativas; la pancreatectomía distal es para tumores de cuerpo y cola.

212 gastro-13 · Perfil V3 4.01.1.031 · Cáncer de páncreas · *Práctica*

Hombre de 70 años, fumador, consulta por ictericia indolora de 3 semanas, prurito, baja de peso de 6 kg y diabetes diagnosticada hace 4 meses. La ecografía muestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y del conducto de Wirsung, sin cálculos.

¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Biopsia hepática percutánea

B) CPRE diagnóstica

C) Cintigrafía hepatobiliar

D) TAC de abdomen trifásica con protocolo de páncreas

E) Repetir la ecografía en 1 mes

> **Respuesta D.** Ictericia indolora con dilatación de colédoco y Wirsung (signo del doble conducto), baja de peso y diabetes de reciente inicio en un fumador mayor sugieren cáncer de cabeza de páncreas. La TAC trifásica es el examen de elección para diagnosticar, etapificar y evaluar resecabilidad. La CPRE es terapéutica y no se usa para el diagnóstico inicial.

213 gastro-04 · Perfil V3 4.01.2.001 · Esofagitis cáustica · *Práctica*

Mujer de 24 años llega a urgencias 2 horas después de ingerir, con intención suicida, un vaso de destapador de cañerías a base de soda cáustica. Presenta sialorrea, odinofagia y dolor retroesternal. PA 120/75 mmHg, FC 104 por minuto, sin enfisema subcutáneo ni signos peritoneales. Radiografía de tórax y abdomen sin aire libre.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el vómito y administrar carbón activado

B) Neutralizar con vinagre diluido por sonda nasogástrica

C) Esofagectomía de urgencia

D) Endoscopía digestiva alta diferida a las 3 semanas

E) Régimen cero, hidratación endovenosa, analgesia y endoscopía digestiva alta en las primeras 12 a 24 horas

> **Respuesta E.** Sin signos de perforación, se estabiliza con régimen cero y se hace endoscopía precoz (12–24 h, evitando el período de mayor fragilidad entre el día 3 y la semana 3) para graduar la lesión y definir el manejo. No se induce vómito, no se neutraliza ni se usa carbón. Requiere además evaluación psiquiátrica.

214 gastro-21 · Perfil V3 4.01.2.004 · Hemorragia digestiva alta · *Práctica*

Hombre de 58 años, usuario de ibuprofeno por lumbago, consulta por hematemesis y melena. Ingresa con FC 110 lpm y PA 95/60 mmHg; se reanima con cristaloides y se inicia omeprazol endovenoso. La endoscopía a las 12 horas muestra una úlcera duodenal de 1,5 cm con un vaso visible no sangrante.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener solo omeprazol oral y dar de alta

B) Cirugía de urgencia con vagotomía y piloroplastía

C) Terapia endoscópica combinada (adrenalina más método térmico o clips) y omeprazol endovenoso

D) Embolización arterial como primera opción

E) Repetir la endoscopía en 1 semana sin tratamiento endoscópico

> **Respuesta C.** Un vaso visible no sangrante (Forrest IIa) tiene alto riesgo de resangrado, por lo que requiere terapia endoscópica, idealmente combinada (adrenalina asociada a método térmico o mecánico), seguida de inhibidor de bomba de protones endovenoso en altas dosis. La cirugía y la embolización se reservan para el fracaso del tratamiento endoscópico.

215 gastro-17 · Perfil V3 4.01.2.012 · Colangitis · *Práctica*

Mujer de 70 años con colelitiasis conocida consulta por dolor en el hipocondrio derecho, fiebre de 39 °C con calofríos e ictericia. Se inician antibióticos endovenosos y fluidos. A las 6 horas está confusa, con PA 80/50 mmHg pese a la reposición de volumen. La ecografía muestra colédoco de 12 mm.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Drenaje urgente de la vía biliar, idealmente por CPRE

B) Colecistectomía laparoscópica de urgencia

C) Mantener antibióticos y observar 48 horas

D) Colangiorresonancia electiva

E) Cambiar el antibiótico y repetir la ecografía al día siguiente

> **Respuesta A.** La pentada de Reynolds (tríada de Charcot más compromiso de conciencia e hipotensión) define una colangitis grave. Además del soporte y los antibióticos, requiere drenaje biliar urgente, de preferencia endoscópico por CPRE (o percutáneo si no está disponible). La colecistectomía no descomprime el colédoco y se difiere hasta resolver el cuadro.

216 gastro-18 · Perfil V3 4.01.2.013 · Pancreatitis aguda · *Práctica*

Mujer de 45 años es hospitalizada por pancreatitis aguda leve de origen biliar. Evoluciona favorablemente: al tercer día no tiene dolor, tolera régimen oral y sus pruebas hepáticas se normalizan. La ecografía muestra colelitiasis múltiple sin dilatación de la vía biliar.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la colelitiasis?

A) Ácido ursodesoxicólico y control

B) Colecistectomía electiva en 6 meses

C) CPRE con papilotomía y alta

D) Colecistectomía laparoscópica durante la misma hospitalización

E) No operar, porque el cuadro ya se resolvió

> **Respuesta D.** En la pancreatitis biliar leve, la colecistectomía debe realizarse durante la misma hospitalización, una vez resuelto el cuadro, porque diferirla aumenta significativamente el riesgo de recurrencia de pancreatitis y otras complicaciones biliares. En la pancreatitis grave con colecciones, en cambio, se difiere. La CPRE solo se indica ante colangitis o coledocolitiasis persistente.

217 gastro-18 · Perfil V3 4.01.3.001 · Alimentación en enfermedades digestivas · *Práctica*

Hombre de 50 años cursa con una pancreatitis aguda grave de origen alcohólico. Al tercer día persiste con dolor, íleo leve e intolerancia a la vía oral; está hemodinámicamente estable.

¿Cuál es la forma de soporte nutricional más adecuada?

A) Nutrición enteral por sonda nasogástrica o nasoyeyunal

B) Nutrición parenteral total como primera opción

C) Ayuno prolongado hasta que normalice la amilasa

D) Régimen oral completo hipergrasos

E) Solo suero glucosado por 2 semanas

> **Respuesta A.** En la pancreatitis aguda grave, la nutrición enteral precoz (por sonda nasogástrica o nasoyeyunal) es preferible a la parenteral: mantiene la barrera intestinal, reduce la translocación bacteriana, las infecciones y la mortalidad. La nutrición parenteral se reserva para cuando la vía enteral no es posible o es insuficiente; el ayuno prolongado no está indicado.

218 gastro-15 · Perfil V3 4.01.3.009 · Conceptos generales de hipertensión portal · *Práctica*

Hombre de 58 años con ascitis de reciente aparición. Se realiza una paracentesis diagnóstica: albúmina en líquido ascítico 1,0 g/dL, con albúmina plasmática de 3,2 g/dL. Proteínas totales del líquido 1,5 g/dL y 100 células/mm3.

¿Qué indica el gradiente de albúmina sérica-ascítica de este paciente?

A) Ascitis por carcinomatosis peritoneal

B) Ascitis por hipertensión portal

C) Ascitis por tuberculosis peritoneal

D) Ascitis pancreática

E) Peritonitis bacteriana secundaria

> **Respuesta B.** El gradiente de albúmina sérica-ascítica es 3,2 menos 1,0, es decir 2,2 g/dL. Un gradiente de 1,1 g/dL o más indica hipertensión portal (cirrosis, insuficiencia cardíaca, síndrome de Budd-Chiari); uno menor de 1,1 sugiere causas peritoneales como carcinomatosis, tuberculosis o pancreatitis. Las proteínas bajas orientan a cirrosis más que a causa cardíaca.

219 gastro-05 · Perfil V3 4.01.3.013 · Epidemiología del cáncer. · *Práctica*

En una charla sobre epidemiología del cáncer en Chile, se analiza la mortalidad por tumores malignos en hombres.

¿Cuál es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile?

A) Cáncer gástrico

B) Cáncer de próstata

C) Cáncer de pulmón

D) Cáncer colorrectal

E) Cáncer de vesícula biliar

> **Respuesta A.** En Chile, los tumores malignos son una de las principales causas de muerte, y en hombres el cáncer gástrico ocupa históricamente el primer lugar de mortalidad oncológica, seguido por próstata y pulmón. Por eso existe la garantía GES de endoscopía en mayores de 40 años con epigastralgia persistente, para diagnosticarlo precozmente.

220 gastro-10 · Perfil V3 4.01.3.015 · Ileostomías · *Práctica*

Mujer de 32 años con colitis ulcerosa grave refractaria es sometida a colectomía total con ileostomía terminal. Al cuarto día postoperatorio, la ileostomía drena 2.000 mL al día. Presenta sed, mareos, sequedad de mucosas y creatinina que sube de 0,7 a 1,6 mg/dL.

¿Cuál es la complicación más probable?

A) Obstrucción intestinal por hernia paraestomal

B) Deshidratación con insuficiencia renal aguda prerrenal por ileostomía de alto débito

C) Necrosis del estoma

D) Síndrome de intestino corto

E) Infección de sitio quirúrgico

> **Respuesta B.** Las ileostomías pierden agua y sodio, y un débito mayor de 1,5 a 2 L al día produce deshidratación, hiponatremia, hipokalemia e insuficiencia renal aguda prerrenal, la complicación metabólica precoz más frecuente. Se maneja con reposición hidroelectrolítica, soluciones de rehidratación oral, restricción de líquidos hipotónicos y antidiarreicos como loperamida.

221 gastro-04 · Perfil V3 4.01.4.008 · Radiografías contrastadas (EED, trànsito intestinal, · *Práctica*

Hombre de 60 años presenta dolor retroesternal intenso, fiebre y enfisema subcutáneo cervical pocas horas después de vómitos violentos tras una comida copiosa con alcohol. Se sospecha una perforación esofágica.

Si se decide realizar un estudio contrastado del esófago, ¿qué medio de contraste debe utilizarse inicialmente?

A) Bario, por su mejor definición de la mucosa

B) No se usa contraste: basta una radiografía simple

C) Aire, mediante endoscopía con insuflación

D) Gadolinio

E) Contraste hidrosoluble (yodado)

> **Respuesta E.** Ante sospecha de perforación del tubo digestivo, el estudio contrastado debe hacerse con contraste hidrosoluble, porque el bario que escapa al mediastino o peritoneo produce una mediastinitis o peritonitis granulomatosa grave. Hoy la TAC con contraste oral hidrosoluble es el examen de elección en el síndrome de Boerhaave.

222 gastro-13 · Perfil V3 4.01.4.012 · Hemograma, perfil bioquímico, pefil hepático. · *Práctica*

Mujer de 52 años consulta por ictericia y prurito. Exámenes: bilirrubina total 6,2 mg/dL (directa 5,0), fosfatasa alcalina 680 U/L (VN hasta 120), GGT 520 U/L, GOT 85 U/L y GPT 95 U/L. Hemograma normal.

¿Cuál es el patrón de laboratorio y el siguiente examen más adecuado?

A) Patrón hepatocelular; serología de hepatitis viral

B) Hemólisis; test de Coombs directo

C) Patrón colestásico; ecografía abdominal

D) Síndrome de Gilbert; ningún examen adicional

E) Patrón hepatocelular; biopsia hepática

> **Respuesta C.** Predominio de bilirrubina directa con fosfatasa alcalina y GGT muy elevadas, y transaminasas solo levemente aumentadas, configura un patrón colestásico. El primer examen es la ecografía abdominal, que distingue colestasia extrahepática (vía biliar dilatada) de intrahepática. En la hemólisis y el síndrome de Gilbert predomina la bilirrubina indirecta.

223 gastro-11 · Perfil V3 4.01.5.006 · Colonoscopía · *Práctica*

Hombre de 55 años, asintomático, se realiza un test inmunoquímico de sangre oculta en deposiciones como tamizaje de cáncer colorrectal, que resulta positivo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el test en 1 año

B) Colonoscopía completa

C) Rectosigmoidoscopía flexible exclusiva

D) TAC de abdomen y pelvis

E) Antígeno carcinoembrionario

> **Respuesta B.** Un test de sangre oculta positivo en el tamizaje de cáncer colorrectal obliga a realizar una colonoscopía completa, que permite visualizar todo el colon, tomar biopsias y resecar pólipos en el mismo procedimiento. La rectosigmoidoscopía no evalúa el colon proximal, y el antígeno carcinoembrionario no sirve para diagnóstico ni tamizaje.

224 gastro-02 · Perfil V3 4.01.5.012 · Endoscopía digestiva alta · *Práctica*

Mujer de 48 años consulta por epigastralgia de 1 mes de evolución, sin respuesta a medidas generales. No tiene baja de peso, anemia ni vómitos. No usa antiinflamatorios.

¿Cuál es la conducta más adecuada según la guía GES de cáncer gástrico?

A) Endoscopía digestiva alta con test de ureasa

B) Tratamiento empírico con omeprazol por 3 meses sin estudio

C) Ecografía abdominal

D) Serología para Helicobacter pylori y tratamiento si es positiva

E) Radiografía esófago-estómago-duodeno con bario

> **Respuesta A.** En Chile, por la alta incidencia de cáncer gástrico, la guía GES indica endoscopía digestiva alta en personas de 40 años o más con epigastralgia de más de 15 días, aun sin síntomas de alarma, con biopsias y test de ureasa. Probar y tratar Helicobacter pylori sin endoscopía se reserva para menores de 40 años sin signos de alarma.

225 gastro-15 · Perfil V3 4.01.5.025 · Paracentesis · *Práctica*

Hombre de 60 años con cirrosis y ascitis a tensión refractaria a diuréticos. Se realiza una paracentesis evacuadora, extrayendo 7 litros de líquido ascítico sin incidentes.

¿Qué medida es fundamental para prevenir la disfunción circulatoria postparacentesis?

A) Administrar furosemida endovenosa en dosis altas

B) Administrar albúmina endovenosa, 6 a 8 g por litro extraído

C) Administrar 3 litros de suero fisiológico

D) Restringir completamente el sodio por 48 horas

E) No se requiere ninguna medida adicional

> **Respuesta B.** En paracentesis de más de 5 litros se debe reponer albúmina endovenosa, 6 a 8 g por cada litro extraído, para prevenir la disfunción circulatoria postparacentesis, que se asocia a hiponatremia, insuficiencia renal (síndrome hepatorrenal) y mayor mortalidad. Los cristaloides son menos eficaces como expansores en este contexto.

226 gastro-24 · Perfil V3 5.01.1.027 · Encopresis · *Práctica*

Niño de 6 años, controla esfínteres desde los 3 años. Desde hace 4 meses ensucia su ropa interior casi a diario con deposiciones blandas. Defeca deposiciones duras y voluminosas cada 5 días, con dolor. Al examen se palpa masa fecal en hipogastrio y el tacto rectal muestra ampolla llena de heces duras.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Loperamida para controlar el escurrimiento

B) Desimpactación fecal, luego polietilenglicol de mantención y entrenamiento de hábito defecatorio

C) Psicoterapia exclusiva, sin tratamiento laxante

D) Dieta sin gluten

E) Biopsia rectal por sospecha de enfermedad de Hirschsprung

> **Respuesta B.** La encopresis retentiva es la más frecuente: la constipación funcional con fecaloma produce escurrimiento de heces por rebalse. Se trata con desimpactación (polietilenglicol en dosis altas o enemas), mantención con polietilenglicol por meses, educación sin castigo y hábito defecatorio postprandial. El Hirschsprung se sospecha con inicio neonatal y ampolla vacía.

227 gastro-24 · Perfil V3 5.01.1.032 · Trastorno somatización en niños · *Práctica*

Niña de 9 años con 4 meses de dolor abdominal periumbilical y cefalea recurrentes, que aparecen en las mañanas de días de colegio y ceden los fines de semana. Ha faltado mucho a clases. Coincide con la separación de sus padres. Crecimiento normal, sin baja de peso, fiebre, sangrado ni despertar nocturno por dolor. Examen físico, hemograma y orina normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Explicar el origen funcional, validar los síntomas y abordar los estresores con la familia y el colegio, favoreciendo el retorno a clases

B) Solicitar endoscopía digestiva alta

C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

D) Indicar reposo en casa hasta que ceda el dolor

E) Iniciar benzodiacepinas

> **Respuesta A.** En niños, la somatización se expresa típicamente con dolor abdominal y cefalea recurrentes, ligados a estrés (escuela, conflictos familiares). Sin signos de alarma no se piden más estudios. Se legitima el dolor, se explica su naturaleza, se trabajan los estresores y se promueve la asistencia escolar; el ausentismo refuerza el cuadro.

228 gastro-03 · Perfil V3 6.03.1.032 · Trastorno de deglución · *Práctica*

Hombre de 75 años, 3 semanas después de un ACV isquémico, presenta tos y voz húmeda al beber líquidos, y tuvo una neumonía hace 1 semana. Está alerta y cooperador.

¿Cuál es la conducta más adecuada para evaluar la deglución?

A) Evaluación fonoaudiológica de la deglución y estudio instrumental (videofluoroscopía o evaluación endoscópica de la deglución)

B) Endoscopía digestiva alta

C) Manometría esofágica

D) Radiografía de tórax de control solamente

E) Indicar gastrostomía de inmediato

> **Respuesta A.** La tos o voz húmeda con líquidos y la neumonía aspirativa tras un ACV indican disfagia orofaríngea con aspiración. Se evalúa con tamizaje y evaluación fonoaudiológica, y se confirma con videofluoroscopía o FEES, que definen consistencias seguras y maniobras compensatorias. La endoscopía digestiva y la manometría evalúan la disfagia esofágica.

Ginecología

229 gin-12 · Perfil V3 1.03.1.011 · Síndrome climatérico · *Práctica*

Mujer de 53 años, con menopausia hace 2 años, consulta por bochornos intensos, unos 10 al día, que alteran su sueño y su trabajo. Tiene antecedente de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, operado hace 4 años, en tratamiento con anastrozol.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para sus bochornos?

A) Estradiol transdérmico más progesterona micronizada

B) Venlafaxina

C) Tibolona

D) Estrógenos conjugados orales solos

E) Esperar, porque los bochornos ceden solos en 6 meses

> **Respuesta B.** El cáncer de mama hormonodependiente contraindica toda terapia hormonal, incluida la tibolona, que aumenta la recurrencia. Para bochornos moderados a severos se usan alternativas no hormonales: venlafaxina, ISRS (evitando paroxetina si usa tamoxifeno) o gabapentina, junto a medidas generales.

230 gin-01 · Perfil V3 1.03.3.001 · Pubertad normal · *Práctica*

Una niña de 10 años es llevada a control porque la madre notó un 'bultito' bajo la areola derecha hace 2 meses, levemente sensible. No tiene vello púbico ni ha menstruado. Su crecimiento es normal.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Pubertad precoz que requiere estudio urgente

B) Tumor mamario que requiere biopsia

C) Inicio normal de la pubertad: la telarquia es el primer signo puberal en las niñas

D) Ginecomastia

E) Hiperprolactinemia

> **Respuesta C.** En niñas la pubertad normal comienza entre los 8 y 13 años, y su primer signo es la telarquia (botón mamario), que puede ser unilateral y sensible al inicio. Luego vienen pubarquia, estirón y menarquia. En niños el primer signo es el aumento testicular (≥4 mL). Pubertad precoz en niñas es antes de los 8 años.

231 gin-01 · Perfil V3 1.03.4.008 · FSH, estradiol y prolactina · *Práctica*

Mujer de 20 años, corredora de fondo, con amenorrea secundaria de 6 meses. Entrena 70 km por semana y bajó 7 kg en el último año; IMC 17,5. Beta-hCG negativa, TSH 1,9 mUI/L, prolactina 11 ng/mL. FSH 2,1 mUI/mL, LH 0,9 mUI/mL, estradiol 14 pg/mL. Prueba de progesterona negativa.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Amenorrea hipotalámica funcional

B) Síndrome de ovario poliquístico

C) Insuficiencia ovárica prematura

D) Síndrome de Asherman

E) Hiperprolactinemia

> **Respuesta A.** FSH y LH bajas o normales bajas con estradiol bajo: hipogonadismo hipogonadotropo. En una deportista con bajo peso y déficit energético, la causa es la amenorrea hipotalámica funcional, con riesgo de pérdida de masa ósea. La insuficiencia ovárica tiene FSH alta; el SOP tiene estrógenos normales y prueba de progesterona positiva.

232 gin-07 · Perfil V3 1.03.4.009 · LH, testosterona · *Práctica*

Un hombre de 28 años consulta por infertilidad conyugal de 2 años. Es alto, con escaso vello corporal, ginecomastia leve y testículos pequeños y firmes (3 mL). El espermiograma muestra azoospermia y la testosterona total es baja (180 ng/dL).

¿Qué resultado de LH y FSH es esperable y cuál es el diagnóstico más probable?

A) LH y FSH bajas: hipogonadismo hipogonadotrópico (Kallmann)

B) LH y FSH normales: obstrucción de conductos deferentes

C) LH y FSH elevadas: hipogonadismo primario, probable síndrome de Klinefelter

D) LH baja y FSH alta: prolactinoma

E) LH alta y FSH baja: uso de esteroides anabólicos

> **Respuesta C.** Testículos pequeños y firmes, azoospermia, ginecomastia y hábito eunucoide con testosterona baja y gonadotropinas elevadas (hipogonadismo hipergonadotrópico) sugieren síndrome de Klinefelter (47,XXY), que se confirma con cariograma. En el hipogonadismo central (Kallmann, tumor hipofisario) LH y FSH están bajas o inapropiadamente normales; los anabólicos las suprimen.

233 gin-12 · Perfil V3 1.07.3.010 · Sexualidad en personas mayores · *Práctica*

Mujer de 67 años, con pareja estable, consulta por dolor en las relaciones sexuales y sequedad vaginal de 1 año. Al examen se observa mucosa vaginal pálida, delgada y con pérdida de pliegues. No tiene sangrado ni flujo anormal.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Explicar que la actividad sexual no es esperable a esta edad

B) Biopsia de vulva

C) Terapia hormonal sistémica con estrógenos y progestágeno

D) Clotrimazol vaginal

E) Estrógenos vaginales en dosis bajas, además de lubricantes

> **Respuesta E.** La dispareunia por síndrome genitourinario de la menopausia (atrofia vulvovaginal) se trata con lubricantes, hidratantes y estrógenos vaginales en dosis bajas, de mínima absorción sistémica. La sexualidad sigue siendo una dimensión vigente en las personas mayores y debe abordarse sin prejuicios. La terapia sistémica no se indica solo por síntomas vaginales a esta edad.

234 gin-04 · Perfil V3 1.09.5.006 · Tacto ginecológico para masas u alteraciones obstructivas · *Práctica*

Mujer de 46 años consulta por dificultad para orinar, sensación de vaciado incompleto y pesadez pélvica de meses, con menstruaciones abundantes. Al tacto vaginal bimanual se palpa un útero aumentado de tamaño, irregular y de consistencia firme, que ocupa la pelvis y desplaza el cuello hacia anterior.

¿Cuál es la causa más probable de sus síntomas urinarios?

A) Compresión vesical o uretral por miomatosis uterina

B) Vejiga neurogénica

C) Cistitis intersticial

D) Incontinencia urinaria de esfuerzo

E) Litiasis vesical

> **Respuesta A.** El tacto ginecológico bimanual permite detectar masas pélvicas que comprimen la vía urinaria. Un útero aumentado, irregular y firme con sangrado abundante sugiere miomatosis; los miomas grandes, cervicales o de cara posterior pueden comprimir la vejiga o la uretra y causar retención. Se confirma con ecografía transvaginal y se evalúan el residuo y la hidronefrosis.

235 gin-09 · Perfil V3 2.01.1.106 · Candidiasis urogenital · *Práctica*

Una adolescente de 16 años, sin actividad sexual, terminó hace una semana un tratamiento antibiótico por una faringoamigdalitis. Consulta por prurito vulvar intenso y flujo vaginal blanco, grumoso, sin mal olor. Al examen hay eritema y edema vulvar. El pH vaginal es 4,2.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Metronidazol oral

B) Clotrimazol vaginal

C) Ceftriaxona intramuscular

D) Corticoide tópico de alta potencia

E) Doxiciclina oral

> **Respuesta B.** Prurito intenso, flujo blanco grumoso "como leche cortada", sin mal olor y con pH normal (menor a 4,5), tras uso de antibióticos, es candidiasis vulvovaginal. No es una ITS. Se trata con azol tópico (clotrimazol vaginal) o fluconazol oral en dosis única. El metronidazol es para vaginosis bacteriana y tricomoniasis, que elevan el pH.

236 gin-03 · Perfil V3 2.01.1.129 · Alteraciones menstruales · *Práctica*

Una adolescente de 13 años tuvo su menarquia hace 10 meses. Desde entonces sus ciclos son irregulares, cada 25 a 50 días, con duración de 4 a 7 días y sangrado moderado. No tiene anemia, hirsutismo, acné importante ni galactorrea, y su IMC es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar anticonceptivos orales para regular el ciclo

B) Solicitar ecografía pélvica y perfil hormonal completo

C) Solicitar estudio de coagulación

D) Tranquilizar y controlar con calendario menstrual

E) Iniciar progestágeno cíclico

> **Respuesta D.** En los primeros 2 a 3 años tras la menarquia es frecuente la irregularidad menstrual por inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario (ciclos anovulatorios). Se consideran normales ciclos de 21 a 45 días aproximadamente. Sin anemia, sangrado abundante ni signos de hiperandrogenismo, la conducta es educar, llevar calendario y controlar.

237 gin-09 · Perfil V3 2.01.1.130 · Leucorrea y vulvovaginitis · *Práctica*

Una niña de 6 años presenta flujo vaginal amarillento escaso, prurito y eritema vulvar de 2 semanas. Usa ropa interior sintética, se baña en tina con espuma y se limpia de atrás hacia adelante. No hay sangrado, cuerpo extraño visible, lesiones sugerentes de abuso ni oxiuros.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Medidas de higiene: limpieza de adelante hacia atrás, ropa de algodón, evitar baños de espuma

B) Metronidazol oral

C) Vaginoscopía bajo anestesia

D) Óvulos de clotrimazol

E) Ceftriaxona intramuscular

> **Respuesta A.** La vulvovaginitis inespecífica es la causa más frecuente de flujo en niñas prepuberales, por mucosa hipoestrogénica delgada, cercanía al ano y mala higiene. El manejo inicial son medidas higiénicas. La candidiasis es rara antes de la pubertad salvo uso de pañal o antibióticos. Si persiste o hay sangrado, se cultiva el flujo y se descarta cuerpo extraño o abuso.

238 gin-05 · Perfil V3 3.01.1.014 · Dolor pelviano y dismenorrea · *Práctica*

Adolescente de 16 años, menarquia a los 12 años, con ciclos regulares cada 28 días. Desde hace un año presenta dolor hipogástrico tipo cólico que comienza el primer día de la menstruación y dura 48 horas, con náuseas, que la obliga a faltar al colegio. No ha iniciado actividad sexual. No tiene dolor fuera de la menstruación ni dispareunia. Examen abdominal y ecografía pelviana transabdominal normales.

¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Laparoscopía diagnóstica

B) Opioides en los días de dolor

C) Análogos de GnRH

D) Dienogest continuo

E) Antiinflamatorios no esteroidales iniciados al comienzo del dolor o 1 a 2 días antes de la menstruación

> **Respuesta E.** Dolor que coincide con la menstruación, desde poco después de la menarquia, con examen y ecografía normales: dismenorrea primaria, por exceso de prostaglandinas endometriales. La primera línea son los AINE (ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico); si no responden o necesita anticoncepción, anticonceptivos combinados. La laparoscopía se reserva para la dismenorrea refractaria con sospecha de endometriosis.

239 gin-08 · Perfil V3 3.01.3.006 · Métodos naturales para la regulación de la fecundidad · *Práctica*

Mujer de 28 años, con ciclos regulares, que por convicciones personales desea usar un método natural de regulación de la fecundidad. Le explican uno basado en que ella reconozca diariamente los cambios del moco cervical, que se vuelve abundante, transparente y elástico en el período fértil.

¿A qué método corresponde?

A) Método del calendario (Ogino-Knaus)

B) Coito interrumpido

C) Método de la temperatura basal

D) Método de la lactancia y amenorrea (MELA)

E) Método de la ovulación (Billings)

> **Respuesta E.** El método de Billings identifica el período fértil por la autoobservación del moco cervical, que con el alza estrogénica preovulatoria se vuelve filante y transparente. El calendario usa la duración de ciclos previos y la temperatura basal detecta el alza térmica posovulatoria por progesterona. Todos tienen alta tasa de falla con uso típico.

240 gin-15 · Perfil V3 3.01.4.005 · Ecotomografía ginecológica · *Práctica*

Mujer de 28 años, asintomática, con ciclos regulares, se realiza una ecografía transvaginal de control que muestra un quiste en el ovario derecho de 4 cm, unilocular, anecoico, de pared fina, sin tabiques, papilas ni flujo al Doppler. El útero y el ovario izquierdo son normales y el test de embarazo es negativo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Laparoscopía con quistectomía

B) Solicitar CA-125 y resonancia magnética de pelvis

C) Control con ecografía transvaginal en 6 a 8 semanas, en la primera fase del ciclo

D) Punción ecoguiada del quiste

E) Anticonceptivos orales por 6 meses como tratamiento obligatorio

> **Respuesta C.** Un quiste simple (unilocular, anecoico, pared fina, sin papilas ni flujo) menor de 5 cm en edad fértil es casi siempre funcional y se resuelve solo. Se controla con ecografía transvaginal en 6 a 8 semanas, en fase folicular. La cirugía se reserva para persistencia, crecimiento o rasgos sospechosos.

241 gin-13 · Perfil V3 3.01.4.007 · Papanicolau · *Práctica*

Mujer de 31 años, asintomática, se toma su Papanicolau de tamizaje en el CESFAM al cuarto día de su menstruación. El informe dice: muestra insatisfactoria para evaluación, por abundante sangre que oscurece las células.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Colposcopía inmediata

B) Test de VPH y conización si resulta positivo

C) Control en 3 años, como un Papanicolau normal

D) Repetir el Papanicolau fuera de la menstruación, sin relaciones, duchas ni óvulos en las 48 horas previas

E) Biopsia endometrial

> **Respuesta D.** Una muestra insatisfactoria no es normal ni anormal: no permitió evaluar las células. Se repite el Papanicolau, idealmente a mitad de ciclo, sin sangrado y sin relaciones, duchas ni óvulos en las 48 horas previas, tomando exocérvix con espátula y endocérvix con cepillo.

242 gin-09 · Perfil V3 3.01.5.007 · Examen ginecológico, especuloscopia y tacto bimanual · *Práctica*

Mujer de 30 años consulta por flujo vaginal anormal. Corresponde además tomar su citología cervical (PAP) de tamizaje.

¿Cuál es la secuencia correcta del examen ginecológico?

A) Inspección de genitales externos, especuloscopia con toma de muestras y luego tacto bimanual

B) Tacto bimanual, luego especuloscopia y toma de muestras

C) Especuloscopia con abundante lubricante y luego inspección vulvar

D) Tacto rectal, luego especuloscopia y finalmente inspección vulvar

E) Toma de muestras sin especuloscopia y tacto bimanual

> **Respuesta A.** El examen se inicia con la inspección de genitales externos, sigue con la especuloscopia (idealmente lubricando solo con agua o suero) para visualizar el cuello y tomar muestras de flujo y PAP, y termina con el tacto bimanual. Hacer el tacto antes altera las muestras y el lubricante interfiere con la citología.

243 gin-09 · Perfil V3 3.01.5.008 · Flujo vaginal (pH) · *Práctica*

Mujer de 29 años consulta por flujo vaginal de mal olor de 1 semana. Se toma una muestra con tórula del tercio medio de la pared lateral de la vagina y se aplica sobre una tira de pH, que marca 5,0. Al agregar KOH al 10% a la muestra se libera olor a pescado.

¿Cuál es la interpretación correcta?

A) pH elevado con test de aminas positivo, compatible con vaginosis bacteriana

B) El pH es normal y descarta una vaginosis bacteriana

C) Es el pH ácido característico de la candidiasis

D) La muestra debe tomarse del endocérvix para ser válida

E) El test de aminas positivo confirma una tricomoniasis

> **Respuesta A.** El pH vaginal normal es 3,8 a 4,5. Medido en la pared lateral de la vagina, sin moco cervical, sangre ni semen, un pH sobre 4,5 con aminas positivas apoya vaginosis bacteriana (criterios de Amsel). El moco cervical es alcalino y falsea el resultado; la candidiasis tiene pH normal.

244 gin-13 · Perfil V3 3.01.5.013 · Taponaje vaginal · *Práctica*

Mujer de 48 años, con cáncer cervicouterino etapa IIIB en espera de radioterapia, consulta por metrorragia abundante. Tras volemización está hemodinámicamente estable, pero el sangrado desde el tumor cervical persiste pese a ácido tranexámico endovenoso.

¿Cuál es la medida inmediata más adecuada para controlar el sangrado?

A) Alta con anticonceptivos orales combinados

B) Histerectomía radical de urgencia

C) Legrado uterino

D) Conización cervical

E) Taponamiento vaginal compresivo con gasa

> **Respuesta E.** El sangrado de un cáncer cervicouterino avanzado se controla de inmediato con taponamiento vaginal compresivo, habitualmente con sonda Foley, que se retira o recambia en 24 a 48 horas, mientras se coordina radioterapia hemostática o embolización. La cirugía no está indicada en etapa IIIB y el legrado o la conización aumentan el sangrado.

245 gin-13 · Perfil V3 3.01.5.014 · Toma de Papanicolau (incluye hacer el frotis) · *Práctica*

Mujer de 35 años acude al CESFAM para su citología cervical de tamizaje. No está menstruando y no ha tenido relaciones sexuales ni usado óvulos en las últimas 48 horas.

¿Cuál es la técnica correcta para tomar el PAP?

A) Muestra solo del fondo de saco vaginal posterior con tórula

B) Muestra de exocérvix con espátula de Ayre y de endocérvix con cepillo, extendido delgado en el portaobjetos y fijación inmediata

C) Tomar la muestra después del tacto bimanual, usando abundante lubricante

D) Extender la muestra y dejarla secar al aire 10 minutos antes de fijarla

E) Extender la muestra en capa gruesa para aumentar la celularidad

> **Respuesta B.** El PAP debe incluir la zona de transformación: exocérvix con espátula de Ayre y endocérvix con cepillo. Se extiende en capa delgada y uniforme y se fija de inmediato, en menos de 10 segundos, para evitar artefactos por desecación. El lubricante, la sangre y el tacto previo alteran la muestra.

Hematología

246 hem-14 · Perfil V3 1.08.1.005 · Coagulopatías adquiridas · *Práctica*

Hombre de 66 años con ictericia indolora progresiva de 5 semanas, coluria, acolia y prurito. Baja de 8 kg. Ecografía: dilatación de la vía biliar intra y extrahepática; TAC con masa en cabeza de páncreas. Se programa drenaje biliar. Hb 12,9 g/dL, plaquetas 280.000/μL, TP 42 % (INR 2,0), TTPK 38 s (control 30 s), fibrinógeno 380 mg/dL, albúmina 3,6 g/dL. Sin sangrado activo.

¿Cuál es la causa más probable de la alteración de la coagulación y su manejo?

A) Déficit de vitamina K por colestasis; vitamina K por vía parenteral y controlar el TP

B) Insuficiencia hepática; transfundir plasma fresco congelado

C) Coagulación intravascular diseminada; iniciar heparina

D) Hemofilia adquirida; solicitar inhibidor del factor VIII

E) Enfermedad de von Willebrand adquirida; desmopresina

> **Respuesta A.** La colestasis impide absorber vitaminas liposolubles: falta vitamina K y bajan los factores II, VII, IX y X, prolongando sobre todo el TP. Con albúmina, plaquetas y fibrinógeno normales, no es insuficiencia hepática ni CID. Se corrige con vitamina K parenteral (no oral, por la malabsorción), con mejoría del TP en 24–48 horas.

247 hem-17 · Perfil V3 1.08.1.014 · Reacción leucemoide · *Práctica*

Hombre de 65 años hospitalizado por neumonía grave presenta leucocitos de 58.000/mm3 con neutrofilia y desviación a izquierda, con baciliformes y algunos mielocitos, sin blastos ni basofilia. No tiene esplenomegalia.

¿Cuál hallazgo apoya más una reacción leucemoide en lugar de una leucemia mieloide crónica?

A) Fosfatasa alcalina leucocitaria elevada

B) Presencia de cromosoma Filadelfia

C) Basofilia marcada

D) Esplenomegalia masiva

E) Gen de fusión BCR-ABL positivo

> **Respuesta A.** La reacción leucemoide es una leucocitosis reactiva mayor de 50.000 con desviación a izquierda, secundaria a infección grave, inflamación o neoplasia, que se resuelve al tratar la causa. Cursa con fosfatasa alcalina leucocitaria elevada y granulaciones tóxicas. La LMC tiene fosfatasa baja, basofilia, esplenomegalia y BCR-ABL (cromosoma Filadelfia) positivo.

248 hem-20 · Perfil V3 1.08.1.015 · Síndrome leucoeritroblástico · *Práctica*

Mujer de 63 años con antecedente de cáncer de mama tratado hace 5 años consulta por dolor óseo y fatiga. Hemoglobina 8,9 g/dL, plaquetas 95.000/mm3. El frotis muestra eritroblastos circulantes, mielocitos y metamielocitos, y dacriocitos (glóbulos rojos en lágrima).

¿Cuál es la interpretación más adecuada del frotis?

A) Anemia ferropénica por pérdida digestiva

B) Anemia por déficit de vitamina B12

C) Anemia hemolítica autoinmune

D) Reacción leucemoide por infección

E) Síndrome leucoeritroblástico sugerente de infiltración medular

> **Respuesta E.** Precursores eritroides y mieloides inmaduros en sangre periférica, con dacriocitos, constituyen un síndrome leucoeritroblástico, que indica ocupación o fibrosis de la médula ósea. En esta paciente sugiere metástasis óseas de cáncer de mama; otras causas son mielofibrosis, linfomas y tuberculosis. Se estudia con biopsia de médula ósea e imágenes.

249 hem-20 · Perfil V3 1.08.1.017 · Síndromes mielodisplásicos · *Práctica*

Hombre de 76 años, no bebedor, con astenia y disnea de esfuerzos progresiva de 6 meses. Sin visceromegalias ni adenopatías. Hb 8,6 g/dL, VCM 104 fL, reticulocitos 0,5 %, leucocitos 2.900/μL (RAN 1.200/μL), plaquetas 98.000/μL. Vitamina B12, folato, TSH y pruebas hepáticas normales. Frotis: neutrófilos hipogranulares con núcleos bilobulados (pseudo-Pelger-Huët), sin blastos.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Vitamina B12 intramuscular empírica y control en 2 meses

B) Coombs directo y haptoglobina

C) Electroforesis de proteínas séricas

D) Eritropoyetina subcutánea sin más estudio

E) Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético

> **Respuesta E.** Adulto mayor con citopenias y macrocitosis arregenerativa, sin déficit de B12 ni folato, hipotiroidismo o daño hepático, y con displasia en el frotis: sospecha de síndrome mielodisplásico. Se confirma con mielograma y biopsia de médula ósea (displasia, porcentaje de blastos) más citogenética, que define el riesgo (IPSS-R) y el tratamiento.

250 hem-22 · Perfil V3 1.08.2.007 · Síndrome de compresión medular · *Práctica*

Hombre de 71 años con cáncer de próstata con metástasis óseas conocidas. Hace 3 semanas presenta dorsalgia progresiva que empeora al acostarse y lo despierta de noche. Desde hace 24 horas tiene debilidad de ambas piernas y dificultad para orinar. Examen: paraparesia 4/5, hipoestesia con nivel sensitivo en T10, reflejos aumentados en extremidades inferiores y globo vesical.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Radiografía de columna dorsal y analgesia con opioides en domicilio

B) Cintigrafía ósea ambulatoria

C) Punción lumbar para citología

D) Dexametasona EV, resonancia magnética de toda la columna urgente y evaluación por radioterapia y neurocirugía

E) Iniciar bloqueo androgénico y control en 1 semana

> **Respuesta D.** Dolor dorsal en un paciente oncológico con déficit motor, nivel sensitivo y retención urinaria: compresión medular metastásica, una emergencia. Se inicia dexametasona EV de inmediato, se solicita RM de toda la columna (puede haber varios niveles) y se decide radioterapia o descompresión quirúrgica en horas. El pronóstico depende de la función motora al inicio.

251 hem-12 · Perfil V3 1.08.2.009 · Trombopenia severa · *Práctica*

Hombre de 40 años, previamente sano, consulta en urgencia por epistaxis profusa que no cede con taponamiento anterior, gingivorragia y hematuria macroscópica de 12 horas. PA 118/72 mmHg, FC 98 lpm, lúcido, sin focalidad neurológica. Petequias y equimosis diseminadas, sin adenopatías ni esplenomegalia. Hb 11,8 g/dL, leucocitos 7.200/μL, plaquetas 4.000/μL (confirmadas en frotis, sin esquistocitos). TP y TTPK normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Prednisona 1 mg/kg/día oral y control ambulatorio en una semana

B) Hospitalizar, metilprednisolona EV en dosis altas, inmunoglobulina EV y transfusión de plaquetas

C) Esplenectomía de urgencia

D) Plasmaféresis urgente

E) Transfundir plasma fresco congelado

> **Respuesta B.** Trombocitopenia aislada severa con frotis sin esquistocitos y coagulación normal: PTI con sangrado mucoso activo de riesgo. Es una urgencia: se hospitaliza, se dan corticoides EV en dosis altas más inmunoglobulina EV y, por el sangrado activo, plaquetas. El manejo ambulatorio solo corresponde sin sangrado relevante; la plasmaféresis es para PTT.

252 hem-06 · Perfil V3 1.08.3.001 · Alcoholismo y asociación con carencias nutricionales · *Práctica*

Hombre de 52 años con consumo diario de 1 litro de vino desde hace años y dieta muy pobre consulta por fatiga. Hemoglobina 10,2 g/dL, VCM 112 fL, neutrófilos hipersegmentados. Sin síntomas neurológicos. Transaminasas levemente elevadas.

¿Cuál es la carencia nutricional más probablemente responsable de su anemia?

A) Ácido fólico

B) Hierro

C) Vitamina B12 por anemia perniciosa

D) Vitamina C

E) Zinc

> **Respuesta A.** En el alcoholismo crónico, la carencia que más frecuentemente produce anemia megaloblástica es el déficit de ácido fólico, por dieta pobre, malabsorción y efecto tóxico del alcohol; los neutrófilos hipersegmentados confirman la megaloblastosis. El alcoholismo también causa déficit de tiamina, que debe suplementarse. La B12 tiene reservas para años y su déficit suele dar síntomas neurológicos.

253 hem-15 · Perfil V3 1.08.3.005 · Indicaciones de uso de componentes sanguíneos · *Práctica*

Hombre de 58 años con cirrosis hepática alcohólica Child B, hospitalizado por una hemorragia digestiva alta variceal. Mientras se prepara la endoscopía persiste con hematemesis. PA 96/60 mmHg tras cristaloides y glóbulos rojos. Hb 7,4 g/dL, plaquetas 82.000/μL, TP 38 % (INR 2,1), TTPK 52 s (control 30 s), fibrinógeno 160 mg/dL.

Respecto del plasma fresco congelado, ¿en cuál de las siguientes situaciones está mejor indicado?

A) Corregir un INR de 1,8 en un cirrótico estable sin sangrado ni procedimiento programado

B) Tratar una hipoalbuminemia de 2,0 g/dL

C) Expandir volumen en un shock hipovolémico sin coagulopatía

D) Sangrado activo con déficit de múltiples factores (TP y TTPK prolongados sobre 1,5 veces el control), como en este paciente

E) Revertir la anticoagulación por dabigatrán

> **Respuesta D.** El plasma fresco congelado aporta todos los factores y se indica ante sangrado activo, o procedimiento invasivo, con déficit de múltiples factores (TP o TTPK sobre 1,5 veces). No se usa como expansor de volumen ni para tratar la albúmina, ni para corregir un INR sin sangrado. El dabigatrán se revierte con idarucizumab.

254 hem-24 · Perfil V3 1.08.3.005 · Indicaciones de uso de componentes sanguíneos · *Práctica*

Hombre de 58 años, sin cardiopatía, hospitalizado en sala por una neumonía adquirida en la comunidad, en su tercer día de antibióticos y con buena evolución. Asintomático en reposo. PA 124/76 mmHg, FC 84 lpm, SatO2 96 % ambiental. Sin sangrado. Hb 7,6 g/dL (al ingreso 8,9 g/dL), VCM 86 fL, plaquetas 210.000/μL.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la transfusión?

A) Transfundir 2 unidades de glóbulos rojos para llevar la Hb sobre 10 g/dL

B) Iniciar eritropoyetina subcutánea

C) Transfundir 1 unidad de glóbulos rojos con furosemida

D) Transfundir plasma fresco congelado

E) No transfundir: controlar la Hb, estudiar la anemia y tratar su causa

> **Respuesta E.** En pacientes hospitalizados estables y sin cardiopatía isquémica activa se usa una estrategia restrictiva: se transfunde con Hb menor de 7 g/dL (menor de 8 g/dL en cardiópatas o cirugía cardíaca y ortopédica) o ante síntomas. Con Hb 7,6 y asintomático no se transfunde; se estudia la anemia. Buscar Hb sobre 10 no mejora el pronóstico.

255 hem-14 · Perfil V3 1.08.3.006 · Interacción de drogas y anticoagulantes orales · *Práctica*

Mujer de 74 años con fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarol, con INR estable entre 2 y 3 durante el último año y sin cambios en su dieta. Consulta por gingivorragia y equimosis en los brazos. INR 6,4. Hace 6 días se le inició un nuevo fármaco.

¿Cuál de los siguientes fármacos explica mejor este hallazgo?

A) Rifampicina

B) Carbamazepina

C) Cotrimoxazol

D) Fenobarbital

E) Espironolactona

> **Respuesta C.** El cotrimoxazol inhibe el metabolismo hepático (CYP2C9) del cumarínico y además altera la flora productora de vitamina K, elevando bruscamente el INR. Rifampicina, carbamazepina y fenobarbital son inductores enzimáticos: aceleran el metabolismo y bajan el INR. Al iniciar un fármaco que interactúa, se debe controlar el INR en 3 a 5 días.

256 hem-18 · Perfil V3 1.08.4.001 · Radiografía de tórax · *Práctica*

Mujer de 22 años con fiebre vespertina, sudoración nocturna, prurito y baja de peso de 3 meses. Al examen presenta adenopatías supraclaviculares indoloras, de consistencia gomosa. Se solicita radiografía de tórax.

¿Cuál es el hallazgo radiológico más esperable?

A) Ensanchamiento del mediastino por masa mediastínica anterior

B) Cavitación en el lóbulo superior derecho

C) Patrón intersticial reticular basal bilateral

D) Nódulo pulmonar periférico calcificado

E) Neumotórax espontáneo

> **Respuesta A.** Una mujer joven con síntomas B, prurito y adenopatías supraclaviculares orienta a linfoma de Hodgkin esclerosis nodular, que con frecuencia presenta masa mediastínica anterior, vista como ensanchamiento del mediastino. Una masa voluminosa empeora el pronóstico y debe evaluarse antes de sedar por riesgo de compresión de la vía aérea. El diagnóstico requiere biopsia excisional del ganglio.

257 hem-23 · Perfil V3 1.08.4.006 · Estudio de trombofilia · *Práctica*

Mujer de 25 años con trombosis venosa profunda poplítea izquierda no provocada, confirmada por eco-Doppler. No usa anticonceptivos ni ha tenido cirugías, viajes o inmovilización. Su madre tuvo una embolia pulmonar a los 38 años. Se inicia enoxaparina y se planifica el estudio de trombofilia.

Respecto del estudio de trombofilia, ¿cuál es la afirmación correcta?

A) Se debe medir proteína C, proteína S y antitrombina hoy, antes de la primera dosis de heparina

B) Las pruebas genéticas de factor V Leiden y mutación G20210A de la protrombina pueden realizarse en cualquier momento, aun con anticoagulación

C) El estudio está indicado en todo paciente con una primera trombosis provocada por cirugía

D) Las proteínas C y S se miden de forma confiable durante el tratamiento con acenocumarol

E) El anticoagulante lúpico se interpreta de forma confiable durante la infusión de heparina

> **Respuesta B.** Las mutaciones (factor V Leiden, protrombina G20210A) se estudian por ADN y no se alteran con la trombosis ni con anticoagulantes. En cambio, proteína C, S y antitrombina se consumen en la fase aguda, la heparina baja la antitrombina y los cumarínicos bajan C y S: se miden lejos del evento y sin esos fármacos.

258 hem-11 · Perfil V3 1.08.4.007 · Estudio de trombopatías · *Práctica*

Mujer de 27 años con epistaxis recurrentes desde la infancia, gingivorragia al cepillarse y menstruaciones abundantes. No usa AINE ni antiagregantes. Hemograma normal con plaquetas 260.000/μL y frotis sin plaquetas gigantes. TP 12 s, TTPK 30 s, fibrinógeno 310 mg/dL. Factor von Willebrand antigénico y actividad normales, factor VIII 95 %.

¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Mielograma

B) Tiempo de trombina

C) Anticuerpos antiplaquetarios

D) Estudio de agregación plaquetaria (agregometría) con distintos agonistas

E) Dosificación de factores IX y XI

> **Respuesta D.** Sangrado mucocutáneo con recuento plaquetario, coagulación y estudio de von Willebrand normales: sospecha de trombopatía (defecto de función plaquetaria). Se estudia con agregometría frente a ADP, colágeno, epinefrina y ristocetina, previa suspensión de fármacos que alteran la función plaquetaria. Mielograma y anticuerpos son para trombocitopenias.

259 hem-05 · Perfil V3 1.08.5.001 · Biopsia de médula ósea · *Práctica*

Hombre de 28 años con pancitopenia: hemoglobina 7,1 g/dL, leucocitos 1.500/mm3 con 400 neutrófilos/mm3, plaquetas 12.000/mm3 y reticulocitos 0,2%. Sin esplenomegalia ni adenopatías. El aspirado de médula ósea es escaso, con muy pocas células (punción seca).

¿Cuál es el examen que permite confirmar el diagnóstico más probable?

A) Repetir el aspirado en 1 mes

B) TAC de tórax

C) Electroforesis de hemoglobina

D) Test de Coombs directo

E) Biopsia de médula ósea

> **Respuesta E.** Pancitopenia con reticulocitos bajos, sin visceromegalias y aspirado hipocelular sugiere aplasia medular. El aspirado no permite evaluar la celularidad ni la fibrosis; la biopsia de médula ósea es indispensable para confirmar la hipocelularidad (menor de 25%) y descartar infiltración o mielofibrosis, que también producen punción seca.

260 hem-16 · Perfil V3 1.08.5.005 · Mielograma · *Práctica*

Niño de 4 años con palidez, fiebre, petequias y dolor óseo de 3 semanas. Hemoglobina 6,8 g/dL, leucocitos 32.000/mm3 con 60% de blastos, plaquetas 18.000/mm3.

¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y clasificar la enfermedad?

A) Mielograma con inmunofenotipo por citometría de flujo

B) Biopsia de ganglio linfático

C) TAC de tórax, abdomen y pelvis

D) Punción lumbar como primer examen

E) Electroforesis de proteínas

> **Respuesta A.** La sospecha es leucemia linfoblástica aguda, el cáncer más frecuente en la infancia. Se confirma con mielograma (aspirado de médula ósea) con 20% o más de blastos, complementado con inmunofenotipo por citometría de flujo y citogenética para clasificar y estratificar el riesgo. La punción lumbar se hace después, para evaluar compromiso del SNC.

261 hem-16 · Perfil V3 1.08.5.008 · Quimioterapia intratecal · *Práctica*

Niña de 7 años con leucemia linfoblástica aguda en fase de inducción. Según el protocolo, debe recibir profilaxis del sistema nervioso central.

¿Cuál es el fármaco que se administra por vía intratecal con este fin?

A) Vincristina

B) Doxorrubicina

C) Metotrexato

D) L-asparaginasa

E) Imatinib

> **Respuesta C.** El SNC es un santuario donde la quimioterapia sistémica penetra poco, por lo que en la LLA se administra quimioterapia intratecal, principalmente metotrexato, solo o con citarabina e hidrocortisona. La vincristina es mortal por vía intratecal y solo se usa endovenosa; por eso ambos fármacos se preparan y administran por separado, con doble chequeo.

262 hem-06 · Perfil V3 1.10.1.023 · Síndromes sensitivos · *Práctica*

Mujer de 66 años, vegana estricta desde hace 15 años y usuaria de metformina, consulta por hormigueo en pies y manos e inestabilidad al caminar en la oscuridad. Al examen tiene pérdida de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva en extremidades inferiores, Romberg positivo y reflejos aquilianos disminuidos. Hemoglobina 11,2 g/dL, VCM 104 fL.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polineuropatía diabética

B) Degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12

C) Ataxia cerebelosa alcohólica

D) Síndrome de Guillain-Barré

E) Esclerosis múltiple

> **Respuesta B.** Compromiso de cordones posteriores (pérdida vibratoria y propioceptiva, Romberg positivo, ataxia sensitiva) con macrocitosis en una vegana usuaria de metformina sugiere déficit de vitamina B12. Se confirma con niveles de B12 y ácido metilmalónico y se trata con B12 parenteral. La polineuropatía diabética no explica la macrocitosis, y la ataxia cerebelosa tiene Romberg negativo.

263 hem-22 · Perfil V3 1.10.2.011 · Paraplejia aguda · *Práctica*

Hombre de 72 años con cáncer de próstata metastásico presenta dolor dorsal de 3 semanas que empeora en decúbito y, desde hace 24 horas, debilidad de ambas piernas, con nivel sensitivo en T10 y retención urinaria.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar opioides y control en 1 semana

B) Radiografía de columna y control ambulatorio

C) Punción lumbar

D) Kinesioterapia motora

E) Dexametasona endovenosa y resonancia magnética urgente de toda la columna

> **Respuesta E.** Una paraplejia aguda con nivel sensitivo y alteración esfinteriana en un paciente oncológico es una compresión medular neoplásica, emergencia oncológica. Se inicia dexametasona de inmediato y se realiza una resonancia urgente de toda la columna para definir radioterapia o cirugía descompresiva. El pronóstico funcional depende del estado neurológico al iniciar el tratamiento.

264 hem-18 · Perfil V3 2.01.1.033 · Linfomas · *Práctica*

Un adolescente de 15 años consulta por una adenopatía supraclavicular izquierda indolora, de consistencia elástica, de 3 cm, que crece desde hace 6 semanas. Refiere sudoración nocturna y baja de 5 kg de peso. La radiografía de tórax muestra ensanchamiento mediastínico.

¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico?

A) Punción aspirativa con aguja fina del ganglio

B) Mielograma

C) TAC de tórax, abdomen y pelvis

D) Serología para virus Epstein-Barr

E) Biopsia excisional del ganglio

> **Respuesta E.** Adenopatía supraclavicular, síntomas B y masa mediastínica en un adolescente sugieren linfoma de Hodgkin. El diagnóstico requiere biopsia excisional del ganglio completo, que permite ver la arquitectura y las células de Reed-Sternberg. La punción con aguja fina no basta para clasificar un linfoma. El TAC y el PET sirven para etapificar, después de confirmar.

265 hem-11 · Perfil V3 2.01.4.021 · Pruebas de coagulación · *Práctica*

Un niño de 3 años con equimosis fáciles tiene recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA prolongado. Se realiza una prueba de mezcla con plasma normal y el TTPA se corrige completamente.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Presencia de un inhibidor (anticoagulante lúpico o anticuerpo contra un factor)

B) Déficit de un factor de la vía intrínseca (ej. VIII, IX o XI)

C) Déficit de factor VII

D) Trombocitopenia inmune

E) Coagulación intravascular diseminada

> **Respuesta B.** El TTPA evalúa la vía intrínseca (XII, XI, IX, VIII) y común; el TP la vía extrínseca (VII) y común. Si el TTPA prolongado se corrige al mezclar con plasma normal, falta un factor (el plasma normal lo aporta): en un niño con sangrado sugiere hemofilia A o B, y se dosifican factores VIII y IX.

266 hem-11 · Perfil V3 4.01.4.013 · Pruebas de coagulación · *Práctica*

Hombre de 60 años hospitalizado por una trombosis venosa profunda inicia tratamiento con heparina no fraccionada en infusión endovenosa continua.

¿Qué examen de laboratorio se utiliza para monitorizar la dosis de este fármaco?

A) Tiempo de protrombina expresado como INR

B) Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA)

C) Recuento de plaquetas exclusivamente

D) Tiempo de sangría

E) Dímero D

> **Respuesta B.** La heparina no fraccionada potencia la antitrombina e inhibe principalmente la vía intrínseca y común; su efecto se monitoriza con el TTPA, buscando 1,5 a 2,5 veces el valor control (o niveles anti-Xa). El INR controla los antagonistas de vitamina K. El recuento de plaquetas se vigila por riesgo de trombocitopenia inducida por heparina.

Infectología

267 infecto-07 · Perfil V3 1.01.5.003 · Cateterismo venoso central · *Práctica*

Se instala un catéter venoso central por vía subclavia derecha a un paciente de 60 años en UCI. A los 20 minutos presenta disnea súbita, taquicardia y saturación de 88%, con murmullo pulmonar abolido en el hemitórax derecho.

¿Cuál es la complicación más probable?

A) Neumotórax iatrogénico

B) Embolia gaseosa

C) Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter

D) Trombosis venosa asociada al catéter

E) Arritmia por catéter en el ventrículo

> **Respuesta A.** La punción subclavia es la vía con mayor riesgo de neumotórax. Disnea, desaturación y murmullo abolido ipsilateral tras la instalación lo sugieren; por eso siempre se toma radiografía de tórax post procedimiento, que además verifica la punta del catéter. La infección asociada a catéter aparece días después, no a los minutos.

268 infecto-04 · Perfil V3 1.04.1.001 · Adenitis, adenoflegmón · *Práctica*

Un niño de 3 años presenta aumento de volumen cervical derecho de 4 días, doloroso, con fiebre de 38,5 °C. Al examen hay un ganglio submandibular de 3 cm, eritematoso, caliente y fluctuante al centro. Tuvo un impétigo facial reciente.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Observación y control en 1 mes

B) PPD y tratamiento antituberculoso

C) Biopsia excisional para descartar linfoma

D) Drenaje del adenoflegmón y antibiótico con cobertura antiestafilocócica

E) Antiviral oral

> **Respuesta D.** La adenitis cervical aguda unilateral con signos inflamatorios en un preescolar se debe en general a S. aureus o S. pyogenes, a menudo tras impétigo o faringitis. Con fluctuación (adenoflegmón) se requiere drenaje más antibiótico antiestafilocócico (ej. cefadroxilo o flucloxacilina). La biopsia se reserva para adenopatías persistentes, duras, indoloras o con síntomas B.

269 infecto-10 · Perfil V3 1.04.1.005 · Candidiasis oral y esofágica · *Práctica*

Un hombre de 34 años con VIH, CD4 de 90 células/mm³ y sin terapia antirretroviral, consulta por odinofagia y disfagia de 1 semana. Al examen tiene placas blanquecinas en la mucosa oral que se desprenden con un bajalenguas.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Nistatina tópica

B) Endoscopía con biopsia antes de cualquier tratamiento

C) Aciclovir endovenoso

D) Ganciclovir

E) Fluconazol oral

> **Respuesta E.** Muguet más odinofagia en un paciente con VIH y CD4 bajo 200 es, con alta probabilidad, candidiasis esofágica. Se trata empíricamente con fluconazol oral por 14 a 21 días; la endoscopía se reserva si no mejora en pocos días, para buscar CMV o herpes. La nistatina tópica solo sirve en la candidiasis oral leve.

270 infecto-20 · Perfil V3 1.04.1.006 · Celulitis bacteriana · *Práctica*

Hombre de 58 años, diabético, con 3 días de eritema caliente y doloroso, de bordes difusos, en la pierna izquierda, que se extiende desde una fisura interdigital. T° 38,8 °C, FC 108 por minuto, PA 125/75 mmHg. Sin crepitación ni dolor desproporcionado; la ecografía no muestra colecciones.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cefadroxilo oral y control ambulatorio en 48 horas

B) Aciclovir oral

C) Desbridamiento quirúrgico de urgencia

D) Mupirocina tópica

E) Hospitalizar y tratar con cefazolina endovenosa, además de manejar la puerta de entrada

> **Respuesta E.** Celulitis con compromiso sistémico, fiebre y taquicardia, en un diabético requiere hospitalización y antibiótico endovenoso contra estreptococo y estafilococo, como cefazolina; además se trata la puerta de entrada, el intertrigo. El cefadroxilo oral sirve para la celulitis leve sin toxicidad. El desbridamiento se reserva para la fasceítis necrotizante.

271 infecto-08 · Perfil V3 1.04.1.007 · Cólera · *Práctica*

Hombre de 35 años regresó hace 2 días de Haití. Presenta diarrea acuosa muy abundante, con aspecto de agua de arroz, sin fiebre ni dolor importante, y vómitos. PA 80/50 mmHg, FC 125 por minuto, mucosas secas y signo del pliegue positivo.

¿Cuál es la medida más importante del tratamiento?

A) Esperar el coprocultivo antes de iniciar el tratamiento

B) Loperamida para frenar las pérdidas

C) Ciprofloxacino como única medida

D) Rehidratación endovenosa enérgica con Ringer lactato

E) Vancomicina oral

> **Respuesta D.** Diarrea acuosa profusa tipo agua de arroz después de estar en zona endémica sugiere cólera. Lo que salva la vida es la rehidratación: endovenosa enérgica con Ringer lactato si hay shock y luego sales orales. El antibiótico, como doxiciclina o azitromicina en dosis única, solo acorta la diarrea. Es de notificación inmediata.

272 infecto-18 · Perfil V3 1.04.1.017 · Leptospirosis · *Práctica*

Hombre de 30 años, trabajador de arrozales con abundantes roedores, inicia hace 6 días fiebre de 39 °C, cefalea, mialgias intensas en las pantorrillas y sufusión conjuntival. Hoy presenta ictericia y oliguria. Creatinina 3,2 mg/dL, bilirrubina total 8 mg/dL, plaquetas 60.000/mm³ y transaminasas levemente elevadas.

¿Cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?

A) Doxiciclina más rifampicina por 6 semanas

B) Albendazol

C) Penicilina G sódica o ceftriaxona endovenosa

D) Aciclovir endovenoso

E) Solo soporte, porque es una hepatitis viral

> **Respuesta C.** Fiebre, mialgias de pantorrillas y sufusión conjuntival tras exposición a agua contaminada con orina de roedores sugiere leptospirosis; ictericia con falla renal es el síndrome de Weil. La forma grave se trata con penicilina G sódica o ceftriaxona endovenosa; la leve, con doxiciclina oral. La hepatitis viral no da sufusión conjuntival ni falla renal.

273 infecto-24 · Perfil V3 1.04.1.024 · Síndrome febril prolongado · *Práctica*

Una mujer de 50 años presenta fiebre sobre 38,3 °C de 4 semanas de evolución. Tras una semana de estudio hospitalizada (hemograma, perfil bioquímico, examen de orina, hemocultivos, urocultivo, radiografía de tórax y VIH) no se ha encontrado la causa.

¿Cuál es el grupo de causas clásicamente más frecuente de este síndrome en adultos?

A) Infecciones (como tuberculosis, endocarditis y abscesos)

B) Fiebre facticia

C) Fármacos, exclusivamente

D) Enfermedades genéticas

E) Simulación

> **Respuesta A.** Fiebre sobre 38,3 °C por más de 3 semanas sin diagnóstico tras un estudio inicial adecuado define el síndrome febril prolongado. Sus causas se agrupan en infecciones (clásicamente las más frecuentes: tuberculosis, abscesos, endocarditis), neoplasias (linfomas), enfermedades inflamatorias no infecciosas (arteritis de células gigantes, Still) y misceláneas.

274 infecto-03 · Perfil V3 1.04.2.001 · Absceso cerebral · *Práctica*

Hombre de 45 años con una sinusitis frontal mal tratada hace 3 semanas consulta por cefalea progresiva, fiebre de 38 °C y paresia del brazo derecho. La TAC de cerebro con contraste muestra una lesión frontal izquierda hipodensa, con captación de contraste en anillo y edema perilesional.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Aciclovir endovenoso

B) Corticoides en monoterapia

C) Punción lumbar inmediata para cultivo

D) Radioterapia por sospecha de glioblastoma

E) Ceftriaxona y metronidazol endovenosos, más evaluación neuroquirúrgica para drenaje

> **Respuesta E.** Lesión con captación en anillo, fiebre y un foco contiguo como la sinusitis es un absceso cerebral. Se trata con antibióticos endovenosos que cubran estreptococos y anaerobios, como ceftriaxona más metronidazol, y aspiración o drenaje neuroquirúrgico. La punción lumbar está contraindicada por el efecto de masa.

275 infecto-06 · Perfil V3 1.04.2.009 · Tétanos · *Práctica*

Hombre de 68 años, agricultor sin registro de vacunas, se hirió el pie con una herramienta hace 10 días. Consulta por dificultad para abrir la boca, rigidez de cuello y abdomen, y espasmos dolorosos generalizados que se desencadenan con ruidos. Está lúcido y afebril.

Además del aseo quirúrgico de la herida, ¿cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Inmunoglobulina antitetánica, metronidazol, benzodiazepinas y manejo en UCI, más inicio de la vacunación

B) Solo vacuna dT

C) Penicilina benzatina y alta

D) Fenitoína por crisis convulsivas

E) Bloqueo neuromuscular ambulatorio

> **Respuesta A.** Trismus, rigidez y espasmos con conciencia conservada es un tétanos generalizado. Se maneja en UCI: inmunoglobulina antitetánica para neutralizar la toxina libre, metronidazol, benzodiazepinas para los espasmos, control de la vía aérea y ambiente tranquilo. La enfermedad no deja inmunidad, por lo que también se inicia la vacunación.

276 infecto-13 · Perfil V3 1.04.3.003 · Prevención de enfermedades de transmisión sexual · *Práctica*

Una mujer de 24 años consulta 24 horas después de una relación sexual sin preservativo con una pareja ocasional de estado VIH desconocido y con conductas de riesgo. Está asintomática.

Además de la anticoncepción de emergencia y el tamizaje de ITS, ¿cuál es la medida preventiva más adecuada?

A) Penicilina benzatina como única medida

B) Esperar una serología de VIH a los 6 meses, sin otra medida

C) Vacuna contra el VIH

D) Profilaxis post exposición (PEP) para VIH, iniciada antes de 72 horas y mantenida por 28 días

E) Ninguna medida, por tratarse de una exposición única

> **Respuesta D.** Tras una exposición sexual de riesgo, la profilaxis post exposición con antirretrovirales debe iniciarse lo antes posible, siempre antes de 72 horas, por 28 días. Se complementa con tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis B y C, vacuna de hepatitis B si no está inmunizada, consejería en uso de preservativo y PrEP si mantiene conductas de riesgo.

277 infecto-08 · Perfil V3 1.04.3.004 · Prevención de enfermedades entéricas · *Práctica*

En una comunidad rural sin red de agua potable se registra un aumento de casos de diarrea aguda y de hepatitis A en niños.

¿Cuál es la medida de prevención más efectiva a nivel poblacional?

A) Antibióticos profilácticos a todos los niños

B) Antiparasitarios mensuales a toda la población

C) Vacuna BCG

D) Suplementación con hierro

E) Acceso a agua potable y saneamiento, con lavado de manos e higiene de los alimentos

> **Respuesta E.** Las enfermedades entéricas (diarreas bacterianas y virales, hepatitis A, fiebre tifoidea) se transmiten por vía fecal-oral. Lo más efectivo es el agua potable y la eliminación sanitaria de excretas, junto a lavado de manos, cocción y lavado de alimentos. La vacuna de hepatitis A del PNI refuerza la prevención; los antibióticos profilácticos no están indicados.

278 infecto-05 · Perfil V3 1.04.3.010 · Profilaxis en contactos de infecciones meningocócicas · *Práctica*

Escolar de 9 años es hospitalizado por meningococcemia. Vive con sus padres y un hermano de 6 años. Una compañera de curso se sentó a su lado en clases, sin contacto con sus secreciones.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la quimioprofilaxis?

A) Indicarla a todo el colegio con amoxicilina

B) Indicarla a los contactos intradomiciliarios, idealmente en las primeras 24 horas, con rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona

C) Indicarla solo al personal de salud que lo atendió

D) Indicarla a los contactos solo si presentan fiebre

E) No indicarla, porque basta con vacunar

> **Respuesta B.** La quimioprofilaxis se indica a contactos íntimos: convivientes, contactos de sala cuna o jardín infantil y personal de salud expuesto a secreciones sin protección, idealmente antes de 24 horas. Se usa rifampicina por 2 días, ciprofloxacino en dosis única en adultos o ceftriaxona en dosis única. Los compañeros de curso escolares no la requieren de rutina.

279 infecto-06 · Perfil V3 1.04.3.012 · Vacunas especiales (neumococo, influenza, hepatitis A y B, varicela, rabia, meningococo) · *Práctica*

Hombre de 40 años será sometido a una esplenectomía electiva por un púrpura trombocitopénico inmune refractario a tratamiento médico.

¿Qué vacunas se deben indicar, idealmente al menos 2 semanas antes de la cirugía?

A) Solo la vacuna contra la influenza

B) BCG y fiebre amarilla

C) Neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b

D) Rabia y hepatitis A

E) Ninguna; se vacuna solo si presenta infecciones después de la cirugía

> **Respuesta C.** El asplénico tiene riesgo de sepsis fulminante por bacterias capsuladas: neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b. Se vacuna al menos 2 semanas antes de la esplenectomía programada, o 2 semanas después si fue de urgencia, y se agrega influenza anual. Las vacunas vivas como la BCG no tienen indicación aquí.

280 infecto-10 · Perfil V3 1.04.4.004 · Detección de antígeno de Cryptococcus en LCR y test de tinta china · *Práctica*

Un hombre de 38 años con VIH sin tratamiento y CD4 de 40 células/mm³ presenta cefalea progresiva de 2 semanas, fiebre baja y vómitos, sin signos focales. La TAC de encéfalo es normal. La punción lumbar muestra presión de apertura de 35 cmH2O, 20 células/mm³ de predominio linfocitario, glucosa baja y proteínas levemente elevadas.

¿Cuál es el examen más sensible y específico para confirmar el diagnóstico más probable?

A) Antígeno de Cryptococcus en LCR

B) Tinta china en LCR

C) Gram de LCR

D) ADA en LCR

E) Cultivo de Koch

> **Respuesta A.** Meningitis subaguda con hipertensión intracraneana en VIH con CD4 bajo 100 sugiere criptococosis. El antígeno criptocócico en LCR (o suero) tiene sensibilidad y especificidad sobre 95%, superior a la tinta china (sensibilidad cercana a 70-80%). Se trata con anfotericina B más flucitosina y punciones evacuadoras si la presión está elevada.

281 infecto-02 · Perfil V3 1.04.4.006 · Estudio citoquímico de LCR · *Práctica*

Hombre de 30 años con 5 días de cefalea, fiebre de 38 °C y rigidez de nuca, sin compromiso de conciencia ni focalidad. LCR: claro, 180 células/mm³ con 90 % de linfocitos, proteínas 0,7 g/L, glucosa 60 mg/dL con glicemia de 100 mg/dL, y Gram sin bacterias.

¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Enterovirus

B) Streptococcus pneumoniae

C) Mycobacterium tuberculosis

D) Listeria monocytogenes

E) Neisseria meningitidis

> **Respuesta A.** LCR claro con pleocitosis linfocitaria moderada, proteínas levemente elevadas y glucosa normal (índice LCR/plasma 0,6) es un patrón de meningitis viral, y el agente más frecuente es enterovirus. La bacteriana da neutrófilos y glucosa baja; la tuberculosa, linfocitos con glucosa muy baja y proteínas muy altas.

282 infecto-01 · Perfil V3 1.04.4.009 · Hemocultivo · *Práctica*

Un hombre de 70 años llega a urgencia con fiebre de 39 °C, confusión, PA 85/50 mmHg, FC 120 por minuto y lactato de 4 mmol/L. Se sospecha shock séptico de foco urinario.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de los hemocultivos?

A) Iniciar antibióticos y tomar hemocultivos al día siguiente si persiste la fiebre

B) Esperar el peak febril para tomar los hemocultivos

C) Tomar 1 solo hemocultivo para ahorrar recursos

D) Tomar 2 sets de hemocultivos de sitios distintos antes del antibiótico, sin retrasar su inicio más allá de la primera hora

E) Tomar los hemocultivos desde la sonda urinaria

> **Respuesta D.** En sepsis se toman al menos 2 sets de hemocultivos por punciones separadas antes del antibiótico, pero sin retrasarlo: en shock séptico debe darse dentro de la primera hora. No es necesario esperar el peak febril, y tomarlos tras el antibiótico reduce su rendimiento. Un solo set dificulta distinguir contaminantes.

283 infecto-21 · Perfil V3 1.04.4.010 · Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS) · *Práctica*

Un estudiante de 18 años presenta, desde hace 1 semana, fiebre, odinofagia intensa con exudado amigdalino, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia leve.

¿Qué hallazgo del hemograma es más característico del diagnóstico más probable?

A) Neutrofilia con desviación a izquierda

B) Policitemia

C) Eosinofilia marcada

D) Pancitopenia con blastos

E) Linfocitosis con más de 10% de linfocitos atípicos (reactivos)

> **Respuesta E.** Fiebre, faringitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia en un adolescente sugieren mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. El hemograma muestra linfocitosis con más de 10% de linfocitos atípicos y suele haber alza leve de transaminasas. Se confirma con anticuerpos heterófilos o IgM anti-VCA. La neutrofilia orientaría a infección bacteriana.

284 infecto-20 · Perfil V3 1.04.5.001 · Drenaje de abscesos superficiales · *Práctica*

Un hombre de 30 años presenta un absceso de 3 cm en el muslo, fluctuante, con eritema alrededor de 1 cm, sin fiebre ni compromiso sistémico. No es diabético ni inmunosuprimido.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Antibiótico oral solamente por 10 días

B) Punción con aguja fina sin drenaje

C) Compresas frías y observación

D) Incisión y drenaje bajo anestesia local, con lavado de la cavidad

E) Hospitalizar para antibiótico endovenoso

> **Respuesta D.** El tratamiento fundamental de un absceso cutáneo fluctuante es la incisión y drenaje: incisión amplia sobre la zona de mayor fluctuación, ruptura de tabiques, lavado con suero y curaciones. Sin celulitis extensa, compromiso sistémico ni inmunosupresión, el antibiótico no es indispensable; sin drenaje, el antibiótico solo no resuelve la colección.

285 infecto-02 · Perfil V3 1.04.5.002 · Punción lumbar · *Práctica*

Mujer de 70 años con fiebre de 39 °C, cefalea y rigidez de nuca, que además presenta una crisis convulsiva y hemiparesia derecha. Glasgow 12.

Respecto de la punción lumbar, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Punción lumbar inmediata y antibióticos según el Gram

B) Hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos, y luego TAC de cerebro antes de la punción lumbar

C) TAC de cerebro y esperar su resultado para iniciar antibióticos

D) Contraindicar definitivamente la punción lumbar

E) Punción lumbar con la paciente sentada, sin imágenes previas

> **Respuesta B.** Focalidad neurológica, convulsiones, compromiso de conciencia, inmunosupresión o papiledema obligan a TAC antes de la punción por riesgo de herniación. Pero el antibiótico no se retrasa: hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos primero; luego TAC y, si no hay efecto de masa, punción lumbar.

286 infecto-02 · Perfil V3 1.04.5.003 · Sembrar muestras para cultivo · *Práctica*

Se realiza una punción lumbar a las 3 de la madrugada a un paciente de 25 años con sospecha de meningitis bacteriana. El laboratorio de microbiología procesará la muestra en 2 horas.

¿Cuál es el manejo más adecuado de la muestra de LCR para cultivo?

A) Mantenerla a temperatura ambiente (o en estufa a 35-37 °C) y enviarla lo antes posible

B) Refrigerarla a 4 °C hasta su procesamiento

C) Congelarla

D) Agregarle suero fisiológico para conservarla

E) Sembrarla al día siguiente

> **Respuesta A.** El LCR para cultivo no se refrigera, porque N. meningitidis y H. influenzae son lábiles al frío. Se envía de inmediato a temperatura ambiente o se mantiene en estufa a 35-37 °C. En cambio, la orina para urocultivo sí se refrigera si no se siembra dentro de 2 horas, para evitar la multiplicación bacteriana.

287 infecto-13 · Perfil V3 1.04.5.004 · Tinción de Gram · *Práctica*

Un hombre de 25 años consulta por secreción uretral purulenta abundante y disuria de 3 días, tras una relación sexual sin preservativo. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral.

¿Qué hallazgo confirma el diagnóstico de uretritis gonocócica?

A) Cocos grampositivos en racimos

B) Bacilos grampositivos

C) Diplococos gramnegativos intracelulares dentro de polimorfonucleares

D) Levaduras con pseudohifas

E) Ausencia de leucocitos

> **Respuesta C.** En hombres con uretritis sintomática, el Gram de la secreción con diplococos gramnegativos intracelulares en polimorfonucleares tiene alta sensibilidad y especificidad para gonorrea. Leucocitos sin diplococos indican uretritis no gonocócica (Chlamydia, Mycoplasma). Se trata con ceftriaxona más cobertura de Chlamydia, como doxiciclina.

288 infecto-11 · Perfil V3 1.05.1.013 · Derrame pleural por tuberculosis · *Práctica*

Hombre de 28 años con 4 semanas de fiebre vespertina, tos seca, dolor pleurítico derecho y baja de 4 kg. Radiografía: derrame pleural derecho moderado. Toracocentesis: exudado con 85 % de linfocitos, glucosa 70 mg/dL, ADA 78 U/L y escasas células mesoteliales. Baciloscopía del líquido negativa.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibióticos para neumonía y control en 2 semanas

B) Esperar el cultivo de Koch del líquido, de 6 a 8 semanas

C) Pleurodesis con talco

D) Iniciar tratamiento antituberculoso

E) Toracoscopía con biopsia pleural antes de tratar

> **Respuesta D.** Exudado linfocitario con ADA alto (sobre 60 U/L) en un adulto joven es diagnóstico de pleuresía tuberculosa y basta para iniciar tratamiento. La baciloscopía y el cultivo del líquido suelen ser negativos porque es una forma paucibacilar. La biopsia pleural se reserva para ADA dudoso o sospecha de cáncer.

289 infecto-11 · Perfil V3 1.05.1.037 · Tuberculosis pulmonar (fracaso de tratamiento) · *Práctica*

Mujer de 40 años en tratamiento antituberculoso supervisado, con buena adherencia documentada. Sus baciloscopías de control fueron negativas en el 2.º y 3.º mes, pero vuelven a ser positivas en el 4.º y 5.º mes.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar cultivo con estudio de susceptibilidad y prueba molecular de resistencia, y derivar al especialista del programa

B) Prolongar el mismo esquema por 3 meses más

C) Agregar levofloxacino al esquema actual

D) Suspender el tratamiento y repetir las baciloscopías en un mes

E) Cambiar a isoniazida en monoterapia

> **Respuesta A.** Baciloscopías que se repositivizan después de negativizarse, desde el 4.º mes, definen fracaso de tratamiento y hacen sospechar resistencia. Se solicita cultivo con test de susceptibilidad y prueba molecular, y el caso lo maneja el especialista del Programa de Tuberculosis. Nunca se agrega un solo fármaco a un esquema que falla: genera más resistencia.

290 infecto-05 · Perfil V3 1.05.4.011 · PPD · *Práctica*

Un hombre de 35 años con VIH, en terapia antirretroviral y con CD4 de 350 células/mm³, es contacto intradomiciliario de un caso de tuberculosis pulmonar bacilífera. Está asintomático y su radiografía de tórax es normal. El PPD resulta de 7 mm.

¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?

A) PPD negativo: no requiere intervención

B) El PPD no es interpretable en personas con VIH

C) PPD dudoso: repetirlo en 1 año

D) PPD positivo: iniciar tratamiento con 4 fármacos

E) PPD positivo (≥5 mm en VIH): iniciar terapia preventiva de tuberculosis

> **Respuesta E.** En personas con VIH u otra inmunosupresión, un PPD de 5 mm o más se considera positivo (en inmunocompetentes, 10 mm o más). Con radiografía normal y sin síntomas se descarta tuberculosis activa y se indica terapia preventiva (isoniacida o esquemas cortos con rifamicinas). El tratamiento con 4 fármacos se reserva para la enfermedad activa.

291 infecto-10 · Perfil V3 1.06.1.012 · Diarrea en inmunosuprimidos · *Práctica*

Hombre de 34 años con infección por VIH sin tratamiento, con CD4 de 45 células/mm3, consulta por diarrea acuosa abundante de 6 semanas, sin sangre, y baja de peso de 7 kg. El coprocultivo y el examen parasitológico seriado habitual de deposiciones son negativos.

¿Cuál es el examen más útil para continuar el estudio?

A) Elastasa fecal

B) Test de hidrógeno espirado

C) Anticuerpos antitransglutaminasa

D) Sangre oculta en deposiciones

E) Tinción de Ziehl-Neelsen modificada en deposiciones

> **Respuesta E.** Con CD4 bajo 100, la diarrea crónica acuosa sugiere protozoos oportunistas (Cryptosporidium, Cystoisospora, Cyclospora), que no se ven en el parasitológico habitual y requieren tinción de Ziehl-Neelsen modificada. El tratamiento clave es iniciar TARV. Si el estudio es negativo, sigue la colonoscopía con biopsias buscando citomegalovirus o micobacterias.

292 infecto-01 · Perfil V3 1.07.3.001 · Alteración de la termoregulación · *Práctica*

Hombre de 85 años es traído por confusión de 1 día. Temperatura axilar 37,1 °C, FR 24/min, PA 92/58 mmHg, FC 104/min. Orina turbia, con leucocituria y nitritos positivos. Lactato 3 mmol/L.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Sin fiebre se descarta una infección grave y debe buscarse otra causa de la confusión

B) El adulto mayor puede no hacer fiebre por alteración de la termorregulación; corresponde manejarlo como sepsis de foco urinario

C) Es una bacteriuria asintomática que no debe tratarse

D) La confusión es esperable a esta edad y no requiere estudio

E) Debe esperarse la curva febril antes de iniciar antibióticos

> **Respuesta B.** En el adulto mayor la respuesta febril está atenuada por alteración de la termorregulación, y muchas infecciones graves cursan sin fiebre, manifestándose como confusión, caídas o taquipnea. Con hipotensión, taquipnea, lactato elevado y foco urinario corresponde manejar como sepsis: hemocultivos, urocultivo, antibióticos precoces y fluidos.

293 infecto-10 · Perfil V3 1.08.3.010 · Prevención de infecciones con énfasis en inmunosuprimidos · *Práctica*

Mujer de 38 años con diagnóstico reciente de infección por VIH, asintomática, con CD4 de 140 células/mm3 e IgG para Toxoplasma positiva. Inicia terapia antirretroviral.

¿Cuál es la profilaxis más adecuada?

A) No requiere profilaxis hasta que el CD4 baje de 50

B) Fluconazol diario

C) Azitromicina semanal

D) Aciclovir diario

E) Cotrimoxazol diario

> **Respuesta E.** Con CD4 bajo 200 se indica profilaxis primaria de Pneumocystis jirovecii con cotrimoxazol, que con CD4 bajo 100 y Toxoplasma IgG positivo también previene la toxoplasmosis cerebral. Se suspende cuando el CD4 se mantiene sobre 200 con TARV. Azitromicina para MAC ya no se indica si se inicia TARV, y fluconazol y aciclovir no son profilaxis primaria rutinaria.

294 infecto-07 · Perfil V3 1.08.5.004 · Cateterismo venoso central · *Práctica*

Paciente de 55 años en UCI requiere un catéter venoso central para drogas vasoactivas. Se instala por vía yugular interna derecha guiado por ecografía, con técnica estéril completa.

¿Qué debe hacerse antes de usarlo para la infusión de drogas vasoactivas?

A) Hemocultivo a través del catéter

B) Antibiótico profiláctico

C) Cambio del catéter a las 72 horas

D) Radiografía de tórax para confirmar la posición de la punta y descartar neumotórax

E) TAC de cuello

> **Respuesta D.** Tras instalar un catéter venoso central yugular o subclavio, la radiografía de tórax confirma que la punta esté en la vena cava superior, cerca de su unión con la aurícula derecha, y descarta neumotórax. No se recomiendan antibiótico profiláctico ni recambio programado: la prevención de infección se basa en técnica aséptica y retiro oportuno.

295 infecto-02 · Perfil V3 1.08.5.006 · Punción lumbar · *Práctica*

Hombre de 45 años con fiebre, cefalea y rigidez de nuca de 12 horas. Al examen presenta paresia braquiocrural izquierda y papiledema. Glasgow 14.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Punción lumbar inmediata y luego antibióticos según el Gram

B) Hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos inmediatos, y luego TAC de cerebro antes de la punción lumbar

C) TAC de cerebro y esperar el resultado para iniciar antibióticos

D) Resonancia magnética y punción lumbar al día siguiente

E) Punción lumbar sin TAC porque el Glasgow es mayor de 13

> **Respuesta B.** Ante déficit focal, papiledema, convulsiones, inmunosupresión o compromiso de conciencia se hace TAC antes de la punción lumbar por riesgo de herniación. Pero los antibióticos y la dexametasona no deben retrasarse: se toman hemocultivos y se inicia tratamiento empírico antes del TAC, porque retrasar el antibiótico aumenta la mortalidad.

296 infecto-05 · Perfil V3 1.08.5.007 · Punción venosa · *Práctica*

Una interna de medicina realiza una punción venosa para tomar exámenes a un paciente hospitalizado. Al terminar, tiene en la mano la aguja usada.

¿Cuál es la conducta correcta para prevenir un accidente cortopunzante?

A) Reencapsular la aguja con ambas manos antes de desecharla

B) Eliminarla en la bolsa de basura común

C) Doblar la aguja antes de botarla

D) Dejar la aguja en la bandeja para eliminarla al final del turno

E) Desechar de inmediato la aguja, sin reencapsular, en un contenedor rígido para cortopunzantes cercano

> **Respuesta E.** La principal causa de accidentes cortopunzantes es el reencapsulado y la manipulación de agujas usadas. Según las precauciones estándar, la aguja se desecha de inmediato, sin reencapsular, doblar ni romper, en un contenedor rígido ubicado cerca del punto de uso. Si ocurre una punción, se lava con agua y jabón y se notifica para evaluar profilaxis.

297 infecto-07 · Perfil V3 1.09.5.004 · Instalación y cuidado de sonda Foley · *Práctica*

Hombre de 74 años hospitalizado por neumonía tiene una sonda Foley instalada desde su ingreso a urgencia hace 5 días para control de diuresis. Actualmente está estable, deambula y puede orinar con ayuda.

¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir la infección urinaria asociada a catéter?

A) Cambiar la sonda cada 3 días

B) Desconectar la bolsa recolectora cada vez que se vacía

C) Irrigación vesical diaria con suero

D) Profilaxis antibiótica mientras tenga sonda

E) Retirar la sonda lo antes posible, ya que no tiene indicación vigente

> **Respuesta E.** El principal factor de riesgo de infección urinaria asociada a catéter es la duración del cateterismo. Lo más eficaz es instalar la sonda solo con indicación precisa y retirarla apenas deja de ser necesaria, usando técnica aséptica, sistema cerrado y bolsa bajo el nivel de la vejiga. No se recomiendan irrigación, profilaxis ni cambios programados.

298 infecto-02 · Perfil V3 1.10.2.016 · Síndromes meníngeos con meningitis purulenta o bacteriana · *Práctica*

Hombre de 68 años, diabético, presenta fiebre de 39 °C, cefalea intensa, rigidez de nuca y somnolencia de 12 horas, sin déficit focal. Punción lumbar: líquido turbio, 2.800 leucocitos/mm3 con 90% polimorfonucleares, proteínas 210 mg/dL y glucosa 15 mg/dL (glicemia 160 mg/dL).

¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado?

A) Ceftriaxona sola

B) Penicilina sódica sola

C) Aciclovir endovenoso

D) Ceftriaxona más ampicilina, junto con dexametasona

E) Ciprofloxacino oral

> **Respuesta D.** Un LCR con pleocitosis neutrofílica, proteínas altas y glucosa muy baja confirma una meningitis bacteriana. En mayores de 50 años, embarazadas o inmunosuprimidos se agrega ampicilina a la ceftriaxona para cubrir Listeria, junto con dexametasona antes o con la primera dosis; vancomicina se suma según la resistencia local del neumococo. El aciclovir corresponde a encefalitis herpética.

299 infecto-09 · Perfil V3 2.01.1.012 · Infecciones por HIV · *Práctica*

Una mujer con infección por VIH, con carga viral detectable al término del embarazo, tiene un parto por cesárea. El recién nacido de término está en buenas condiciones.

Respecto de la alimentación del recién nacido, ¿cuál es la indicación correcta?

A) Lactancia materna exclusiva, porque los anticuerpos maternos protegen al niño

B) Suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula láctea

C) Lactancia materna solo si la madre recibe terapia antirretroviral

D) Lactancia mixta durante los primeros 6 meses

E) Extraer y pasteurizar la leche en el hogar

> **Respuesta B.** En Chile, la prevención de la transmisión vertical del VIH incluye terapia antirretroviral materna, cesárea según carga viral, profilaxis antirretroviral al recién nacido y suspensión de la lactancia materna, que se reemplaza por fórmula láctea entregada por el programa. La leche materna transmite el virus, por lo que la lactancia está contraindicada.

300 infecto-02 · Perfil V3 2.01.2.016 · Meningococcemia · *Práctica*

Una niña de 4 años presenta fiebre de 39,5 °C de 8 horas de evolución, decaimiento y lesiones purpúricas que no blanquean a la presión, que se extienden rápidamente en tronco y extremidades. Al examen tiene FC 160/min, llene capilar de 4 segundos y extremidades frías.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar punción lumbar antes de iniciar antibióticos

B) Administrar ceftriaxona endovenosa de inmediato y reanimar con fluidos

C) Esperar el resultado del hemograma y la PCR

D) Indicar amoxicilina oral y control en 24 horas

E) Solicitar TAC de cerebro antes de cualquier tratamiento

> **Respuesta B.** Fiebre con púrpura que progresa rápidamente y signos de shock es meningococcemia (enfermedad meningocócica invasora) hasta demostrar lo contrario, con alta mortalidad en horas. Se inicia ceftriaxona endovenosa (o intraósea) de inmediato, sin esperar exámenes ni punción lumbar, junto con reanimación con fluidos. Es de notificación inmediata y requiere quimioprofilaxis de contactos cercanos.

301 infecto-09 · Perfil V3 3.01.1.031 · VIH en ginecobstetricia · *Práctica*

Puérpera de 27 años, con infección por VIH en terapia antirretroviral desde el primer trimestre y carga viral indetectable a las 36 semanas. Tuvo un parto vaginal hace 2 horas, con recién nacido sano de término. Pregunta si puede amamantar.

¿Cuál es la recomendación más adecuada según la norma chilena de transmisión vertical?

A) Suspender la lactancia materna, inhibirla con cabergolina y alimentar con fórmula

B) Lactancia materna exclusiva, ya que la carga viral es indetectable

C) Lactancia mixta durante los primeros 3 meses

D) Extraer la leche y administrarla tras congelarla

E) Lactancia materna exclusiva si el recién nacido recibe zidovudina

> **Respuesta A.** En Chile la norma de prevención de transmisión vertical del VIH contraindica la lactancia materna aun con carga viral indetectable, porque el riesgo no es cero y existe alternativa segura. Se inhibe la lactancia con cabergolina, se entrega fórmula láctea y el recién nacido recibe profilaxis antirretroviral.

302 infecto-13 · Perfil V3 3.01.3.010 · Prevención de enfermedades de transmisión sexual · *Práctica*

Joven de 19 años, que inició actividad sexual hace un año y ha tenido 3 parejas, consulta en el CESFAM porque quiere saber cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Usa anticonceptivos orales combinados.

¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir la transmisión sexual de estas infecciones?

A) Mantener los anticonceptivos orales combinados

B) Uso correcto y consistente del preservativo en cada relación

C) Ducha vaginal después de cada relación

D) Antibiótico profiláctico después de cada relación sexual

E) Cambiar a un dispositivo intrauterino de cobre

> **Respuesta B.** El preservativo, usado de forma correcta y en todas las relaciones, es el método de barrera que reduce eficazmente la transmisión del VIH y de la mayoría de las ITS. Los anticonceptivos hormonales y el DIU previenen embarazo, pero no ITS. Se complementa con vacunación contra VPH y hepatitis B y testeo periódico.

303 infecto-17 · Perfil V3 4.01.1.037 · Hidatidosis pulmonar · *Práctica*

Hombre de 35 años, de zona rural de la Región de La Araucanía, consulta por tos y dolor torácico. La radiografía de tórax muestra una imagen redondeada de 7 cm, de bordes nítidos, en el lóbulo inferior derecho. La serología para hidatidosis es positiva.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Albendazol como tratamiento exclusivo

B) Punción y aspiración percutánea del quiste

C) Neumonectomía derecha

D) Observación con radiografía semestral

E) Cirugía conservadora (quistectomía con capitonaje) asociada a albendazol

> **Respuesta E.** El quiste hidatídico pulmonar se trata con cirugía conservadora del parénquima (quistectomía o periquistectomía, cierre de bronquios y capitonaje), con albendazol perioperatorio para reducir siembra y recurrencia. La punción percutánea del quiste pulmonar está contraindicada por riesgo de anafilaxia y siembra, y las resecciones extensas son innecesarias.

304 infecto-20 · Perfil V3 4.01.1.055 · Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones · *Práctica*

Hombre de 32 años, sin comorbilidades, con 5 días de un nódulo doloroso en la axila derecha. Al examen hay una lesión de 3 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con mínima celulitis alrededor. Está afebril.

¿Cuál es el tratamiento principal?

A) Compresas tibias y control en 1 semana

B) Cefadroxilo oral como única medida

C) Incisión y drenaje del absceso

D) Hospitalizar para vancomicina endovenosa

E) Punción con aguja fina para cultivo y observar

> **Respuesta C.** Una colección fluctuante es un absceso y su tratamiento fundamental es la incisión y el drenaje. En un paciente sano, afebril y sin celulitis extensa, el antibiótico no es necesario; se agrega si hay compromiso sistémico, celulitis importante, inmunosupresión o una ubicación de riesgo. El antibiótico solo no resuelve una colección.

305 infecto-13 · Perfil V3 4.01.1.058 · Condilomas · *Práctica*

Mujer de 24 años, cursando un embarazo de 20 semanas, consulta por múltiples verrugas exofíticas pequeñas e indoloras en la vulva. El resto del examen es normal.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Podofilina tópica

B) Crioterapia o ácido tricloroacético

C) Imiquimod tópico

D) Cesárea programada por los condilomas

E) Aciclovir oral

> **Respuesta B.** Los condilomas acuminados, por VPH 6 y 11, se tratan en la embarazada con métodos locales físicos o químicos: crioterapia, ácido tricloroacético o resección. La podofilina y la podofilotoxina están contraindicadas por toxicidad fetal, y el imiquimod no se recomienda. La cesárea solo se indica si las lesiones obstruyen el canal o hay riesgo de sangrado.

306 infecto-01 · Perfil V3 4.01.2.029 · Septicemia · *Práctica*

Mujer de 72 años con pielonefritis aguda ingresa con T° 39 °C, FC 118 lpm, PA 78/40 mmHg y lactato de 4,5 mmol/L. Se toman hemocultivos, se inicia ceftriaxona y se administran 30 mL/kg de cristaloides en la primera hora. Persiste con presión arterial media de 55 mmHg.

¿Cuál es la siguiente medida más adecuada?

A) Nuevo bolo de 30 mL/kg de cristaloides

B) Transfundir glóbulos rojos

C) Iniciar dobutamina

D) Administrar bicarbonato de sodio

E) Iniciar noradrenalina para lograr presión arterial media de al menos 65 mmHg

> **Respuesta E.** Hipotensión que persiste tras la reanimación con volumen y lactato elevado definen un shock séptico. El vasopresor de elección es la noradrenalina, titulada para mantener una presión arterial media de al menos 65 mmHg, idealmente por vía central (puede iniciarse por vía periférica). Insistir con grandes volúmenes aumenta el riesgo de sobrecarga.

307 infecto-11 · Perfil V3 4.03.1.016 · Infección urinaria específica · *Práctica*

Hombre de 45 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada hace 10 años, consulta por disuria, polaquiuria y hematuria intermitente de 4 meses. Ha recibido 2 cursos de antibióticos sin mejoría. El sedimento urinario muestra leucocituria abundante con orina ácida, y los urocultivos convencionales han sido repetidamente negativos.

¿Cuál es el estudio más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Urocultivo con antibiograma nuevamente

B) Citología urinaria

C) Cultivo de orina para Mycobacterium tuberculosis (Koch) en muestras seriadas de primera orina de la mañana

D) PCR para Chlamydia trachomatis en orina

E) Ecografía testicular

> **Respuesta C.** La piuria estéril (leucocituria con urocultivo convencional negativo) con orina ácida, hematuria y síntomas irritativos persistentes sugiere tuberculosis urogenital, más aún con antecedente de TBC. Se confirma con baciloscopía y cultivo de Koch en al menos 3 a 6 muestras seriadas de la primera orina matinal (o PCR para M. tuberculosis), y se estudia con uroTAC.

308 infecto-13 · Perfil V3 4.03.3.004 · Factores de riesgo y prevención de ETS · *Práctica*

Joven de 19 años consulta para orientación sobre prevención de infecciones de transmisión sexual. Tiene 2 parejas sexuales en el último año y uso inconsistente de preservativo.

¿Cuál es la medida de prevención más efectiva frente a la mayoría de las ITS bacterianas y el VIH en su caso?

A) Vacuna contra VPH, que previene todas las ITS

B) Lavado genital después de cada relación

C) Uso de anticonceptivos orales

D) Uso correcto y consistente del preservativo en todas las relaciones sexuales

E) Antibiótico profiláctico mensual

> **Respuesta D.** El preservativo usado de forma correcta y consistente es la medida de barrera más efectiva contra VIH, gonorrea, clamidia y otras ITS. Se complementa con reducción de parejas, tamizaje periódico (VIH, sífilis), vacunas contra VPH y hepatitis B, y PrEP en personas con alto riesgo. Los anticonceptivos orales y el lavado genital no protegen.

309 infecto-12 · Perfil V3 6.01.1.008 · Enfermedades de transmisión sexual · *Práctica*

Hombre de 28 años consulta por lesiones en palmas y plantas de 2 semanas, no pruriginosas. Al examen se observan máculas y pápulas eritemato-cobrizas descamativas en palmas y plantas, placas blanquecinas en la mucosa oral y adenopatías generalizadas. Refiere una úlcera genital indolora que desapareció sola hace 2 meses.

¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección?

A) Eritema multiforme; antihistamínicos

B) Pitiriasis rosada; observación

C) Psoriasis palmoplantar; corticoide tópico

D) Sífilis secundaria; penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular dosis única

E) Sífilis terciaria; penicilina sódica endovenosa por 14 días

> **Respuesta D.** Exantema de palmas y plantas cobrizo, lesiones mucosas y adenopatías tras un chancro indoloro autolimitado es sífilis secundaria. Se confirma con VDRL o RPR y prueba treponémica (MHA-TP), y se trata con penicilina benzatina 2,4 millones UI IM dosis única. Debe estudiarse VIH y notificar y tratar contactos.

310 infecto-20 · Perfil V3 6.01.2.002 · Ántrax · *Práctica*

Hombre de 60 años, diabético mal controlado, consulta por una placa indurada, muy dolorosa, de 6 cm en la nuca, con múltiples orificios por los que drena pus (aspecto en espumadera), de 5 días. Tiene fiebre de 38,5 °C.

¿Cuál es el diagnóstico y el manejo más adecuado?

A) Forúnculo simple; calor local

B) Carbunco por Bacillus anthracis; ciprofloxacino y notificación

C) Ántrax (carbunco estafilocócico); drenaje quirúrgico, antibiótico sistémico antiestafilocócico y control de la glicemia

D) Quiste epidérmico infectado; exéresis electiva

E) Hidradenitis supurativa; doxiciclina

> **Respuesta C.** El ántrax es la confluencia de varios forúnculos (S. aureus) que forman una placa inflamatoria con múltiples bocas de drenaje, típico en nuca y espalda de diabéticos. Es una infección profunda que requiere drenaje y antibiótico sistémico (cloxacilina o cefazolina, o según riesgo de SAMR) y compensación metabólica. El carbunco por B. anthracis es una escara negra indolora.

311 infecto-04 · Perfil V3 6.01.2.005 · Fasceitis necrotizante · *Práctica*

Mujer de 50 años, diabética, con una herida en la pierna hace 3 días. Consulta por dolor intenso, desproporcionado a los hallazgos, con eritema mal delimitado, edema que se extiende más allá del eritema, ampollas violáceas y crépito a la palpación. Temperatura 39 °C, PA 90/55 mmHg, FC 120 lpm.

¿Cuál es la conducta más importante?

A) Antibiótico oral y control en 48 horas

B) Resonancia magnética antes de decidir conducta

C) Elevación de la extremidad y cefazolina endovenosa

D) Reanimación, antibióticos endovenosos de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico urgente

E) Hospitalizar y observar la evolución de los bordes marcados

> **Respuesta D.** Dolor desproporcionado, edema más allá del eritema, ampollas violáceas, crépito y shock son signos de fasceitis necrotizante. Es una emergencia quirúrgica: el desbridamiento precoz es el principal determinante de sobrevida, junto con antibióticos amplios (incluyendo clindamicina por efecto antitoxina) y reanimación. Las imágenes no deben retrasar la cirugía.

312 infecto-12 · Perfil V3 6.01.2.012 · Sífilis congénita · *Práctica*

Recién nacido de término, hijo de madre con VDRL reactivo 1:32 en el parto, sin control prenatal ni tratamiento. Al examen tiene hepatoesplenomegalia, rinitis serosanguinolenta persistente y lesiones ampollares descamativas en palmas y plantas.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Penicilina benzatina intramuscular dosis única

B) Observación y VDRL a los 3 meses

C) Ceftriaxona intramuscular por 3 días

D) Azitromicina oral por 5 días

E) Penicilina sódica endovenosa por 10 días, previo estudio con VDRL en sangre y LCR

> **Respuesta E.** Un recién nacido con signos clínicos (hepatoesplenomegalia, coriza, pénfigo sifilítico palmoplantar) de madre con sífilis no tratada tiene sífilis congénita. Se estudia con VDRL en sangre y LCR, hemograma, radiografía de huesos largos y fondo de ojo, y se trata con penicilina sódica endovenosa por 10 días. La benzatina no alcanza niveles en el sistema nervioso central.

313 infecto-20 · Perfil V3 6.01.4.003 · Gram y cultivo · *Práctica*

Hombre de 45 años con un absceso de 4 cm en el muslo, fluctuante, recurrente por tercera vez en el año. Su pareja tuvo forúnculos recientemente. Se drena en urgencia.

¿Qué examen debe solicitarse de la secreción obtenida y por qué?

A) Ninguno, el drenaje es suficiente en todos los casos

B) Gram y cultivo con antibiograma, para identificar S. aureus y su susceptibilidad (incluida resistencia a meticilina) por la recurrencia

C) Baciloscopía

D) PCR para virus herpes

E) Micológico directo

> **Respuesta B.** En abscesos y piodermias recurrentes, extensos, con compromiso sistémico, en inmunosuprimidos o con falla de tratamiento, el Gram y el cultivo con antibiograma de la secreción identifican al agente (habitualmente S. aureus) y su susceptibilidad, incluida la resistencia a meticilina comunitaria, lo que orienta el antibiótico y la descolonización.

314 infecto-12 · Perfil V3 6.01.4.007 · VDRL - MHATP · *Práctica*

Embarazada de 12 semanas en su primer control. VDRL reactivo 1:2. Se solicita MHA-TP, que resulta no reactivo. No tiene lesiones ni antecedentes de sífilis. Tiene diagnóstico reciente de lupus eritematoso sistémico.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Sífilis latente precoz; penicilina benzatina

B) Sífilis primaria en período de ventana

C) Sífilis tratada previamente (cicatriz serológica)

D) Falso positivo biológico del VDRL, probablemente asociado al lupus

E) Neurosífilis

> **Respuesta D.** El VDRL es una prueba no treponémica, sensible y útil para seguimiento, pero con falsos positivos (habitualmente títulos bajos) en LES, síndrome antifosfolípido, embarazo, infecciones virales y otras. Las pruebas treponémicas (MHA-TP, FTA-Abs) confirman y quedan positivas de por vida. VDRL reactivo con treponémica negativa es un falso positivo biológico.

Nefrología

315 nefro-18 · Perfil V3 1.02.4.005 · Creatininemia · *Práctica*

Una mujer de 84 años, de 45 kg y con sarcopenia, tiene creatinina plasmática de 1,0 mg/dL. Se calcula su velocidad de filtración glomerular estimada (VFGe) en 50 mL/min/1,73 m².

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Tiene disminución de la función renal, que la creatinina sola subestima por su baja masa muscular

B) Su función renal es normal, porque la creatinina está en rango normal

C) La creatinina sobreestima el daño renal en los adultos mayores

D) Debe medirse solo la creatinina en orina de 24 horas

E) La VFGe no es aplicable en mayores de 70 años

> **Respuesta A.** La creatinina depende de la masa muscular: en adultos mayores con poca masa muscular, una creatinina normal puede ocultar una VFG disminuida. Por eso se usa la VFG estimada (CKD-EPI), que ajusta por edad y sexo. Es clave para ajustar dosis de fármacos y para etapificar la enfermedad renal crónica.

316 nefro-21 · Perfil V3 1.02.4.014 · Examen de orina semicuantitativa · *Práctica*

Una mujer de 30 años consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 1 día. Refiere que orina cada 30 minutos. La tira reactiva de orina muestra leucocitos (+++) y nitritos negativos.

¿Cuál es la interpretación más adecuada del resultado de nitritos?

A) Descarta una infección urinaria

B) Indica que la infección es viral

C) Indica infección por E. coli

D) Indica contaminación de la muestra

E) Un nitrito negativo no descarta infección, porque requiere tiempo de permanencia de la orina en la vejiga y bacterias reductoras de nitratos

> **Respuesta E.** Los nitritos se forman cuando enterobacterias como E. coli reducen nitratos, lo que requiere unas 4 horas de orina en la vejiga. Con polaquiuria intensa o gérmenes no reductores (Enterococcus, S. saprophyticus) pueden ser negativos. Es específico pero poco sensible: un nitrito negativo no descarta ITU.

317 nefro-13 · Perfil V3 1.02.4.022 · Proteiuniria 24 horas · *Práctica*

Un hombre de 35 años presenta edema progresivo de extremidades inferiores y palpebral de 3 semanas. Tiene orina espumosa, albúmina plasmática de 2,1 g/dL y colesterol total de 340 mg/dL. El sedimento urinario no muestra cilindros hemáticos.

¿Qué resultado de proteinuria de 24 horas confirma el síndrome nefrótico?

A) Mayor de 3,5 g/24 h

B) 500 mg/24 h

C) 1,5 g/24 h

D) 150 mg/24 h

E) Proteinuria negativa

> **Respuesta A.** El síndrome nefrótico del adulto se define por proteinuria mayor de 3,5 g/24 horas, hipoalbuminemia bajo 3 g/dL, edema y dislipidemia. La proteinuria normal es menor de 150 mg/24 horas. Una alternativa práctica es el índice proteína/creatinina en orina aislada mayor de 3 a 3,5 g/g.

318 nefro-21 · Perfil V3 1.02.4.025 · Urocultivo y antibiograma · *Práctica*

Una mujer de 62 años, diabética, presenta fiebre de 39 °C, calofríos, dolor lumbar derecho y puño percusión positiva. Está hemodinámicamente estable. Hace 3 meses recibió ciprofloxacino por una cistitis.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del urocultivo?

A) Iniciar antibiótico sin solicitar urocultivo

B) Solicitar urocultivo solo si no responde en 1 semana

C) Esperar el resultado del urocultivo (48 a 72 horas) para iniciar antibiótico

D) Tomar urocultivo con antibiograma antes de iniciar el antibiótico empírico, y ajustar según el resultado

E) Usar la orina recolectada el día anterior

> **Respuesta D.** En una pielonefritis, especialmente en diabéticos o con uso reciente de antibióticos, se toma urocultivo con antibiograma (segundo chorro, previo aseo) antes del primer antibiótico, sin retrasar el tratamiento empírico. El antibiograma permite ajustar ante resistencia, frecuente a quinolonas en Chile. Esperar el resultado para tratar es peligroso.

319 nefro-12 · Perfil V3 1.05.4.010 · Gases en sangre arterial · *Práctica*

Mujer de 40 años, sin enfermedad pulmonar, con 4 días de vómitos por gastroenteritis. Gases arteriales: pH 7,50, pCO2 48 mmHg, HCO3 36 mEq/L. Na 137 mEq/L, Cl 90 mEq/L, K 3,1 mEq/L.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de los gases?

A) Acidosis respiratoria crónica compensada

B) Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria agregada

C) Alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria agregada

D) Alcalosis metabólica con compensación respiratoria adecuada

E) Alcalosis respiratoria aguda

> **Respuesta D.** pH alto y bicarbonato alto: alcalosis metabólica primaria. La pCO2 esperada es 0,7 × (36 – 24) + 40 = 48 mmHg (± 2). La medida es 48: compensación adecuada, trastorno simple. Una pCO2 mayor de 50 indicaría acidosis respiratoria agregada.

320 nefro-21 · Perfil V3 1.09.1.005 · Bacteriuria asintomática · *Práctica*

Mujer de 72 años, diabética, sin síntomas urinarios ni fiebre, se realiza un urocultivo de rutina que muestra Escherichia coli con más de 100.000 UFC/mL en 2 muestras. No está embarazada ni tiene procedimientos urológicos programados.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Nitrofurantoína por 7 días

B) No tratar la bacteriuria

C) Ciprofloxacino por 14 días

D) Profilaxis antibiótica permanente

E) Ecografía renal y cistoscopía

> **Respuesta B.** La bacteriuria asintomática en adultas mayores y diabéticas no se trata: no reduce las infecciones sintomáticas ni las complicaciones y favorece resistencia y efectos adversos. Solo se trata en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa, como la resección transuretral. Tampoco requiere estudio de imágenes.

321 nefro-20 · Perfil V3 1.09.1.008 · Hipertensión arterial esencial · *Práctica*

Hombre de 50 años, sin comorbilidades y no fumador, presenta en el perfil de presión arterial promedios de 164/102 mmHg. Examen físico, creatinina, potasio, orina completa y ECG normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solo cambios de estilo de vida por 6 meses y reevaluar

B) Ecografía doppler de arterias renales antes de tratar

C) Atenolol como primera línea

D) Cambios de estilo de vida e inicio inmediato de un antihipertensivo, como losartán o amlodipino

E) Repetir el perfil de presión arterial en 1 año

> **Respuesta D.** Con PA de 160/100 o más (etapa 2) se inicia tratamiento farmacológico de inmediato junto con cambios de estilo de vida, usando IECA o ARA II, calcioantagonista o tiazida, idealmente en combinación si está muy sobre la meta. Los betabloqueadores no son primera línea sin una indicación específica, y sin claves de HTA secundaria no corresponde doppler renal.

322 nefro-21 · Perfil V3 1.09.1.011 · Infección urinaria baja (cistitis) · *Práctica*

Mujer de 26 años, sana y no embarazada, consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 1 día. Está afebril, sin dolor lumbar ni flujo vaginal. Tira reactiva de orina: leucocitos y nitritos positivos.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Nitrofurantoína 100 mg cada 12 horas por 5 días, sin urocultivo

B) Urocultivo y esperar el resultado para tratar

C) Ceftriaxona intramuscular por 3 días

D) Ecografía renal y vesical

E) Ciprofloxacino por 14 días

> **Respuesta A.** Es una cistitis aguda no complicada: en una mujer joven con síntomas típicos no se requiere urocultivo y se trata empíricamente con nitrofurantoína por 5 días (alternativas: fosfomicina en dosis única o cefalosporina oral), considerando la resistencia local de E. coli. Las quinolonas se reservan, y 14 días o la vía parenteral corresponden a pielonefritis.

323 nefro-21 · Perfil V3 1.09.1.016 · Pielonefritis aguda no complicada · *Práctica*

Mujer de 27 años, sana, no embarazada, con 2 días de disuria, fiebre de 38,7 °C y dolor lumbar derecho. Puño percusión derecha positiva. Tolera la vía oral, PA 115/70 mmHg, FC 98 lpm. Orina con leucocituria y nitritos positivos. Resistencia local de E. coli a quinolonas menor de 10 %.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas por 5 días

B) Urocultivo y ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 7 días, ambulatorio

C) Hospitalizar y ceftriaxona más ampicilina endovenosa

D) Fosfomicina 3 g en dosis única

E) TAC de abdomen y pelvis antes de iniciar antibiótico

> **Respuesta B.** Pielonefritis no complicada en mujer sana que tolera la vía oral: manejo ambulatorio, urocultivo previo y ciprofloxacino 7 días si la resistencia local es baja (alternativa: cefalosporina oral). Nitrofurantoína y fosfomicina no alcanzan niveles en el parénquima renal y sirven solo para cistitis.

324 nefro-18 · Perfil V3 1.09.1.017 · Progresión de la IRC · *Práctica*

Hombre de 61 años, hipertenso, con ERC en control en CESFAM. Hace 1 año TFGe 58 mL/min/1,73 m²; hoy 45 mL/min/1,73 m², confirmada en 2 mediciones. RAC 420 mg/g. PA 136/84 mmHg con losartán 50 mg/día. K 4,6 mEq/L.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener el control anual en atención primaria

B) Iniciar preparación para diálisis con fístula arteriovenosa

C) Suspender el losartán por la caída de la TFG

D) Derivar a nefrología por progresión acelerada y albuminuria severa

E) Solicitar biopsia renal en atención primaria

> **Respuesta D.** Una caída de la TFG mayor de 5 mL/min/1,73 m² en un año define progresión acelerada, y una RAC sobre 300 mg/g es albuminuria severa: ambos son criterios de derivación a nefrología. Mientras, se optimiza el bloqueo del sistema renina-angiotensina y la PA bajo 130/80 mmHg.

325 nefro-13 · Perfil V3 1.09.2.003 · Edema generalizado grave (anasarca) · *Práctica*

Hombre de 42 años con síndrome nefrótico por glomerulopatía membranosa presenta anasarca: edema de extremidades, pared abdominal y escroto, con ascitis. Proteinuria 9 g/24 h, albúmina 1,9 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, PA 140/88 mmHg.

¿Cuál es el manejo más adecuado del edema?

A) Albúmina endovenosa diaria como tratamiento único

B) Restricción de sodio y diurético de asa (furosemida)

C) Restricción estricta de líquidos a 500 mL/día

D) Paracentesis evacuadora diaria

E) Espironolactona como única medida

> **Respuesta B.** El edema nefrótico se maneja con restricción de sodio y diuréticos de asa en dosis altas, porque la hipoalbuminemia y la proteína tubular reducen su efecto; puede asociarse tiazida y, en casos refractarios, albúmina con furosemida. Además se indica IECA o ARA II para reducir la proteinuria y se evalúa anticoagulación por la albúmina muy baja.

326 nefro-01 · Perfil V3 1.09.2.004 · Enfermedad tubular aguda · *Práctica*

Hombre de 64 años, al tercer día de una colectomía, cursó con shock séptico por filtración anastomótica que requirió noradrenalina por 36 horas y recibió amikacina. Hoy diuresis de 300 mL en 24 horas. Creatinina 3,8 mg/dL (basal 1,0). Sodio urinario 58 mEq/L, FeNa 3,2 %. Sedimento: abundantes cilindros granulosos pardos y células epiteliales tubulares.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Insuficiencia renal aguda prerrenal

B) Glomerulonefritis rápidamente progresiva

C) Nefritis intersticial aguda por fármacos

D) Necrosis tubular aguda isquémica y nefrotóxica

E) Insuficiencia renal aguda obstructiva

> **Respuesta D.** Shock prolongado más aminoglucósido, FeNa mayor de 2 %, sodio urinario alto y cilindros granulosos pardos (barro) son el perfil de la necrosis tubular aguda: el túbulo dañado ya no reabsorbe sodio. En lo prerrenal el sodio urinario es bajo y el sedimento es blando.

327 nefro-01 · Perfil V3 1.09.2.009 · Insuficiencia renal aguda obstructiva · *Práctica*

Hombre de 79 años con síntomas prostáticos de años, consulta por 2 días de goteo urinario, dolor hipogástrico y confusión leve. PA 150/90 mmHg. Al examen: masa hipogástrica suprapúbica mate y dolorosa. Creatinina 3,1 mg/dL (basal 1,1 hace 3 meses), K 5,3 mEq/L.

¿Cuál es la primera conducta?

A) Furosemida 40 mg IV

B) Hidratación con 2 litros de suero fisiológico

C) Hemodiálisis de urgencia

D) Pielografía de eliminación

E) Instalar sonda vesical y medir el residuo

> **Respuesta E.** El globo vesical en un hombre con prostatismo indica obstrucción baja: la sonda vesical es diagnóstica y terapéutica, y suele revertir la falla renal. Después se vigila la poliuria posobstructiva. Los diuréticos y el contraste no tienen lugar.

328 nefro-19 · Perfil V3 1.09.3.003 · Desnutrición en insuficiencia renal crónica · *Práctica*

Hombre de 66 años en hemodiálisis trisemanal hace 2 años presenta baja de peso, albúmina 3,1 g/dL e inapetencia. Mantiene una dieta con restricción proteica de 0,6 g/kg/día indicada antes de iniciar diálisis.

¿Cuál es la recomendación proteica más adecuada en esta etapa?

A) Aumentar a 1,0-1,2 g/kg/día

B) Reducir a 0,4 g/kg/día

C) Mantener 0,6 g/kg/día

D) Dieta sin proteínas los días de diálisis

E) Eliminar toda restricción de sodio y potasio

> **Respuesta A.** La desnutrición calórico-proteica es frecuente en la ERC y predice mortalidad. Antes de diálisis se indica una restricción moderada (0,6-0,8 g/kg/día) para retardar la progresión, pero en hemodiálisis la pérdida de aminoácidos y el catabolismo obligan a aumentar a 1,0-1,2 g/kg/día, manteniendo restricción de sodio, potasio, fósforo y líquidos.

329 nefro-03 · Perfil V3 1.09.3.004 · Diálisis y complicaciones · *Práctica*

Hombre de 58 años con enfermedad renal crónica sin control previo, BUN 190 mg/dL y creatinina 14 mg/dL, inicia hemodiálisis de urgencia por catéter con una sesión de 4 horas a flujo alto. Al final de la sesión presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, desorientación y una convulsión generalizada. Glicemia 105 mg/dL, Na 138 mEq/L, K 4,0 mEq/L.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipoglicemia por la diálisis

B) Síndrome de desequilibrio dialítico

C) Hemorragia intracraneana por heparina

D) Encefalopatía urémica que no ha respondido

E) Embolia gaseosa por el catéter

> **Respuesta B.** En el primer tratamiento con urea muy alta, la remoción rápida crea un gradiente osmótico entre plasma y cerebro, con edema cerebral: cefalea, vómitos, confusión y convulsiones. Se previene con primeras sesiones cortas, de bajo flujo. Glicemia y electrolitos normales descartan las otras causas metabólicas.

330 nefro-18 · Perfil V3 1.09.3.004 · Diálisis y complicaciones · *Práctica*

Mujer de 57 años en diálisis peritoneal ambulatoria continua hace 2 años. Consulta por 24 horas de dolor abdominal difuso y líquido de drenaje turbio. T° 37,9 °C, abdomen sensible sin signos de perforación. Recuento del efluente: 850 leucocitos/mm³ con 82 % de polimorfonucleares.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tomar cultivo del efluente e iniciar antibióticos intraperitoneales empíricos

B) Retirar el catéter peritoneal de inmediato

C) Laparotomía exploradora de urgencia

D) Cambiar a hemodiálisis y observar sin antibióticos

E) Ciprofloxacino oral y control en 1 semana

> **Respuesta A.** Peritonitis asociada a diálisis peritoneal: efluente turbio con más de 100 leucocitos/mm³ y más de 50 % de PMN. Se cultiva el líquido y se inician antibióticos intraperitoneales que cubran grampositivos y gramnegativos. El catéter se retira solo si es refractaria o fúngica.

331 nefro-21 · Perfil V3 1.09.3.006 · Higiene para prevención de infección urinaria · *Práctica*

Mujer de 24 años ha tenido 4 episodios de cistitis no complicada en el último año, la mayoría 1 a 2 días después de tener relaciones sexuales. Examen físico y ecografía renal normales.

¿Cuál es la medida higiénica de prevención más adecuada?

A) Duchas vaginales diarias

B) Orinar después de las relaciones sexuales y mantener buena hidratación

C) Usar espermicidas

D) Restringir líquidos para orinar menos veces

E) Aseo genital de atrás hacia adelante

> **Respuesta B.** En la cistitis recurrente asociada al coito se recomienda orinar después de las relaciones, beber abundantes líquidos, no retener la orina y asearse de adelante hacia atrás. Los espermicidas y las duchas vaginales alteran la flora y aumentan el riesgo. Si las medidas fallan, se considera profilaxis antibiótica poscoital.

332 nefro-08 · Perfil V3 1.09.3.009 · Terapia diurética · *Práctica*

Hombre de 56 años con cirrosis alcohólica Child-Pugh B, en abstinencia, consulta por aumento progresivo del perímetro abdominal. Ascitis moderada sin signos de peritonitis; paracentesis diagnóstica con GASA 1,8 g/dL y 90 PMN/mm³. Creatinina 0,8 mg/dL, Na 136 mEq/L, K 4,1 mEq/L.

¿Cuál es el esquema diurético inicial más adecuado, junto a la restricción de sodio?

A) Furosemida 80 mg/día en monoterapia

B) Hidroclorotiazida 50 mg/día

C) Espironolactona 100 mg/día más furosemida 40 mg/día

D) Acetazolamida 250 mg cada 12 horas

E) Paracentesis evacuadora semanal sin diuréticos

> **Respuesta C.** En la ascitis cirrótica el motor es el hiperaldosteronismo secundario, por eso la base es la espironolactona; se combina con furosemida en proporción 100:40 para mantener el potasio y acelerar la respuesta. La furosemida sola es poco eficaz y produce hipokalemia, que precipita encefalopatía.

333 nefro-20 · Perfil V3 1.09.3.010 · Tratamiento no medicamentoso de la hipertensión arterial · *Práctica*

Hombre de 45 años con hipertensión etapa 1, IMC 31 kg/m2, sedentario y con alto consumo de pan, embutidos y alimentos procesados, consulta por medidas no farmacológicas.

¿Cuál es la recomendación correcta sobre el consumo de sal?

A) Eliminar totalmente el sodio de la dieta

B) Menos de 12 g de sal al día

C) Menos de 5 g de sal al día

D) La sal no influye en la presión arterial

E) Reemplazar la sal por caldo en cubos

> **Respuesta C.** La OMS y el MINSAL recomiendan consumir menos de 5 g de sal al día, cerca de 2 g de sodio, lo que baja la PA sistólica en 4-5 mmHg. También ayudan bajar de peso, la dieta DASH, el ejercicio aeróbico y moderar el alcohol. Los caldos en cubo, los embutidos y el pan son fuentes ocultas de sodio.

334 nefro-20 · Perfil V3 1.09.4.001 · Angiografia renal · *Práctica*

Mujer de 27 años con hipertensión de difícil manejo pese a 3 fármacos. Al examen se ausculta un soplo abdominal paraumbilical. La ecografía doppler sugiere estenosis de la arteria renal derecha.

¿Cuál es el examen de referencia para confirmar el diagnóstico?

A) Renina plasmática

B) Cintigrama renal con captopril

C) Pielografía de eliminación

D) Ecografía renal simple

E) Angiografía renal por sustracción digital

> **Respuesta E.** En una mujer joven con HTA resistente y soplo abdominal se sospecha displasia fibromuscular de la arteria renal. La angiografía renal es el examen de referencia: muestra la imagen en collar de perlas y permite tratar con angioplastia en el mismo acto. La angio-TAC y la angio-RM son alternativas no invasivas, y el cintigrama con captopril está en desuso.

335 nefro-11 · Perfil V3 1.09.4.008 · Anion gap · *Práctica*

Hombre de 52 años con cirrosis alcohólica descompensada y peritonitis bacteriana espontánea. PA 85/50 mmHg. Na 138 mEq/L, Cl 108 mEq/L, HCO3 16 mEq/L, albúmina 2,0 g/dL. pH 7,30, pCO2 32 mmHg.

¿Cuál es la interpretación más adecuada del trastorno ácido-base?

A) Acidosis metabólica con anion gap normal, hiperclorémica

B) Alcalosis respiratoria primaria

C) Acidosis metabólica con anion gap elevado al corregir por la albúmina

D) Acidosis respiratoria aguda

E) Trastorno ácido-base ausente

> **Respuesta C.** Anion gap = 138 – (108 + 16) = 14, aparentemente normal. Pero la albúmina es el principal anión no medido: por cada g/dL bajo 4 se suman 2,5. Corregido: 14 + 5 = 19, elevado, compatible con acidosis láctica por hipoperfusión séptica. Sin corregir se pierde el diagnóstico.

336 nefro-18 · Perfil V3 1.09.4.009 · Clearence de creatinina · *Práctica*

Hombre de 60 años con enfermedad renal crónica. Se estima su función renal con el clearance de creatinina en orina de 24 horas y se compara con la filtración glomerular medida por un método de referencia.

¿Por qué el clearance de creatinina tiende a sobreestimar la filtración glomerular real, especialmente en ERC avanzada?

A) Porque la creatinina se reabsorbe en el túbulo

B) Porque la creatinina se metaboliza en el hígado

C) Porque una fracción de la creatinina se secreta en el túbulo proximal

D) Porque la creatinina no se filtra libremente

E) Porque la orina de 24 horas siempre se recolecta en exceso

> **Respuesta C.** La creatinina se filtra libremente y, además, se secreta en el túbulo proximal, fracción que aumenta a medida que cae la filtración; por eso el clearance sobreestima la VFG en la ERC avanzada. Su principal error práctico es la recolección incompleta de orina. Hoy se prefieren ecuaciones de estimación como CKD-EPI.

337 nefro-09 · Perfil V3 1.09.4.010 · Electrolitos plasmáticos · *Práctica*

Hombre de 62 años, asintomático, con policitemia vera y trombocitosis de 1.100.000/mm³. En exámenes de control, K 6,7 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, HCO3 24 mEq/L. No usa fármacos que eleven el potasio. ECG: ritmo sinusal, sin ondas T picudas ni alteraciones del QRS.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el potasio en plasma con heparina, sin torniquete prolongado

B) Insulina con glucosa IV y salbutamol nebulizado

C) Hemodiálisis de urgencia

D) Gluconato de calcio IV de inmediato

E) Iniciar resinas de intercambio y dieta sin potasio

> **Respuesta A.** Hiperkalemia sin causa, con función renal y ECG normales, en un paciente con trombocitosis extrema: sospechar seudohiperkalemia, porque las plaquetas liberan potasio al coagular la muestra en el tubo. Se confirma midiendo potasio en plasma (tubo heparinizado), que será normal. Tratar sin confirmar es un error.

338 nefro-10 · Perfil V3 1.09.4.010 · Electrolitos plasmáticos · *Práctica*

Hombre de 44 años con hipertensión arterial de difícil manejo pese a amlodipino 10 mg y losartán 100 mg diarios; no usa diuréticos. Refiere calambres ocasionales. PA 168/102 mmHg. K 3,0 mEq/L, Na 143 mEq/L, HCO3 31 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. Potasio urinario 45 mEq/L.

¿Cuál es el estudio más adecuado a continuación?

A) Metanefrinas plasmáticas

B) Aldosterona y actividad de renina plasmáticas

C) Cortisol libre urinario de 24 horas

D) Ecografía Doppler renal como único estudio

E) TSH y T4 libre

> **Respuesta B.** Hipertensión resistente con hipokalemia espontánea, alcalosis metabólica y pérdida renal de potasio (K urinario mayor de 20 a 30 mEq/L) es la tríada del hiperaldosteronismo primario. El tamizaje es la razón aldosterona/renina. Corregir el potasio antes, porque la hipokalemia falsea la aldosterona.

339 nefro-02 · Perfil V3 1.09.4.012 · Examen de orina y sedimento urinario · *Práctica*

Hombre de 24 años consulta 36 horas después de una competencia de crossfit por mialgias intensas y orina color coca-cola. Creatinina 1,8 mg/dL, CK 48.000 U/L. Orina completa: tira reactiva con sangre +++; sedimento con 0 a 2 glóbulos rojos por campo y cilindros granulosos pigmentados.

¿Cuál es la interpretación del examen de orina?

A) Hematuria glomerular por glomerulonefritis aguda

B) Mioglobinuria por rabdomiólisis

C) Hemoglobinuria por hemólisis intravascular

D) Hematuria de origen urológico

E) Error de laboratorio; repetir la muestra

> **Respuesta B.** La tira detecta el grupo hemo, tanto de hemoglobina como de mioglobina. Tira con sangre positiva y sedimento sin glóbulos rojos, con CK muy elevada tras ejercicio extremo, es mioglobinuria por rabdomiólisis. La hemólisis no explica la CK ni las mialgias.

340 nefro-15 · Perfil V3 1.09.4.012 · Examen de orina y sedimento urinario · *Práctica*

Mujer de 34 años con hematuria microscópica persistente en 3 exámenes. PA 138/88 mmHg. Creatinina 1,0 mg/dL. Se evalúa el sedimento urinario para definir el origen del sangrado.

¿Cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor especificidad un origen glomerular?

A) Cilindros hemáticos

B) Hematuria con coágulos

C) Leucocituria con piuria

D) Cilindros hialinos

E) Cristales de oxalato de calcio

> **Respuesta A.** Los cilindros hemáticos se forman en el túbulo con glóbulos rojos que atravesaron el capilar glomerular: son patognomónicos de hematuria glomerular, igual que los acantocitos mayores de 5 %. Los coágulos orientan a sangrado de vía urinaria, donde no hay plasma con actividad anticoagulante.

341 nefro-20 · Perfil V3 1.09.4.013 · Holter de presión arterial: conocimientos básicos · *Práctica*

Mujer de 52 años presenta PA de 152/94 mmHg en 3 consultas médicas. En su casa, con un equipo validado, registra promedios de 122/76 mmHg. No tiene daño de órgano blanco.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar o descartar hipertensión?

A) Ecocardiograma

B) Monitoreo ambulatorio de presión arterial (Holter de presión) de 24 horas

C) Prueba de esfuerzo

D) Iniciar tratamiento sin más estudio

E) Fondo de ojo

> **Respuesta B.** La diferencia entre la PA en consulta y en domicilio sugiere hipertensión de bata blanca. El monitoreo ambulatorio de 24 horas confirma el diagnóstico: hay hipertensión con un promedio de 24 horas de 130/80 o más, diurno de 135/85 o más o nocturno de 120/70 o más. También detecta hipertensión enmascarada y ausencia de descenso nocturno.

342 nefro-01 · Perfil V3 1.09.4.014 · Nitrogeno ureico (relación bun/creatinina · *Práctica*

Mujer de 80 años con vómitos y diarrea de 3 días, mucosas secas y PA 95/60 mmHg. Exámenes: BUN 64 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL (basal 0,9) y sodio urinario 12 mEq/L.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Glomerulonefritis rápidamente progresiva

B) Necrosis tubular aguda establecida

C) Obstrucción urinaria

D) Lesión renal aguda prerrenal por hipovolemia

E) Nefritis intersticial aguda

> **Respuesta D.** Una relación BUN/creatinina mayor de 20 (aquí 40) indica mayor reabsorción de urea, propia de la falla prerrenal por hipovolemia, y el sodio urinario bajo 20 confirma la conservación tubular de sodio. La NTA establecida muestra relación menor de 15 y sodio urinario alto. La hemorragia digestiva alta y los corticoides también elevan esta relación.

343 nefro-13 · Perfil V3 1.09.4.015 · Proteinuria · *Práctica*

Hombre de 19 años, sano, en examen preocupacional presenta proteínas 1+ en la tira reactiva. La muestra se tomó en la tarde, tras un partido de fútbol. PA 118/72 mmHg, sin edema. Sedimento sin glóbulos rojos ni cilindros. Creatinina 0,8 mg/dL.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Biopsia renal

B) Iniciar enalapril para reducir la proteinuria

C) Derivar a nefrología como síndrome nefrótico

D) Solicitar ANA, C3 y C4

E) Repetir el examen en la primera orina de la mañana, en reposo

> **Respuesta E.** En un joven sano la proteinuria aislada suele ser transitoria (ejercicio, fiebre) u ortostática. Se repite en la primera orina matinal: si es negativa, el pronóstico es benigno y no requiere estudio. Solo la proteinuria persistente en reposo merece cuantificación y estudio.

344 nefro-01 · Perfil V3 1.09.4.016 · Sodio urinario · *Práctica*

Mujer de 71 años, hipertensa, usuaria de furosemida 40 mg/día (última dosis esta mañana). Consulta por 5 días de vómitos e ingesta oral escasa. PA 95/60 mmHg con ortostatismo, mucosas secas. Creatinina 2,2 mg/dL (basal 0,8). Sodio urinario 46 mEq/L, FeNa 2,1 %, FeUrea 24 %. Sedimento normal.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Insuficiencia renal prerrenal: la furosemida eleva el sodio urinario y la FeUrea bajo 35 % lo confirma

B) Necrosis tubular aguda, porque la FeNa es mayor de 2 %

C) Nefritis intersticial aguda por furosemida

D) Insuficiencia renal obstructiva

E) Síndrome hepatorrenal

> **Respuesta A.** Los diuréticos aumentan el sodio urinario y la FeNa aunque el riñón esté hipoperfundido. En ese caso se usa la fracción excretada de urea: menor de 35 % confirma lo prerrenal. Clínica de hipovolemia y sedimento normal apoyan.

345 nefro-05 · Perfil V3 1.09.4.016 · Sodio urinario · *Práctica*

Mujer de 82 años, autovalente, con 4 días de diarrea acuosa y escasa ingesta de líquidos. Está lúcida, sin focalidad. PA 100/60 mmHg con ortostatismo, mucosas secas. No usa diuréticos. Na 126 mEq/L, K 3,5 mEq/L, glicemia 95 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. Sodio urinario 9 mEq/L.

¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?

A) SIADH; restricción hídrica

B) Insuficiencia suprarrenal; hidrocortisona

C) Pérdida renal de sal; tabletas de NaCl

D) Polidipsia primaria; restricción de agua libre

E) Hiponatremia hipovolémica por pérdidas extrarrenales; suero fisiológico 0,9 %

> **Respuesta E.** Sodio urinario menor de 20 a 30 mEq/L en una paciente deshidratada indica que el riñón ahorra sodio: la pérdida es extrarrenal, aquí la diarrea. Se repone volumen con suero fisiológico. En el SIADH y en la pérdida renal el sodio urinario es alto.

346 nefro-06 · Perfil V3 1.09.4.016 · Sodio urinario · *Práctica*

Hombre de 74 años con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, en control irregular, que suspendió sus diuréticos hace 1 mes. Consulta por disnea y aumento de volumen de piernas. Ingurgitación yugular, crépitos bibasales, edema hasta las rodillas. Na 127 mEq/L, K 4,4 mEq/L, creatinina 1,2 mg/dL. Sodio urinario 11 mEq/L.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de la hiponatremia?

A) SIADH, por ser una hiponatremia con orina concentrada

B) Hiponatremia hipovolémica por pérdidas digestivas

C) Pérdida renal de sal por nefropatía

D) Hiponatremia hipervolémica por bajo volumen circulante efectivo

E) Seudohiponatremia por hiperlipidemia

> **Respuesta D.** Edema con sodio urinario bajo: el riñón percibe hipoperfusión (volumen circulante efectivo bajo) y retiene sodio y agua por aldosterona y hormona antidiurética. Es la hiponatremia hipervolémica de la insuficiencia cardíaca o la cirrosis. Se maneja con restricción hídrica y diurético de asa, no con suero.

347 nefro-21 · Perfil V3 1.09.4.017 · Urocultivo y antibiograma · *Práctica*

Mujer de 45 años, no embarazada, sin diabetes ni patología urológica, asintomática. En un chequeo de rutina se solicitó urocultivo, que informa más de 100.000 UFC/mL de E. coli sensible a nitrofurantoína.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Nitrofurantoína por 5 días

B) Ciprofloxacino por 7 días

C) No tratar: es una bacteriuria asintomática

D) Repetir el urocultivo cada mes

E) Ecografía renal y cistoscopía

> **Respuesta C.** Bacteriuria asintomática en mujer no embarazada: no se trata, porque no reduce infecciones sintomáticas y genera resistencia. Se trata solo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa. El urocultivo se pide ante síntomas, no como tamizaje general.

348 nefro-20 · Perfil V3 2.01.1.061 · Hipertensión arterial · *Práctica*

Un niño de 6 años, asintomático, presenta presión arterial sobre el percentil 95 para su edad, sexo y talla en tres controles separados. Su IMC es normal.

¿Cuál es la causa más probable de su hipertensión?

A) Enfermedad del parénquima renal

B) Hipertensión esencial

C) Feocromocitoma

D) Hipertiroidismo

E) Hiperaldosteronismo primario

> **Respuesta A.** En niños pequeños, sobre todo menores de 10 años y sin obesidad, la hipertensión suele ser secundaria, y la causa más frecuente es la enfermedad renal parenquimatosa (cicatrices por pielonefritis, glomerulopatías, displasias), seguida de la renovascular y la coartación aórtica. La hipertensión esencial predomina en adolescentes con obesidad o antecedentes familiares. El estudio inicial incluye orina, creatinina y ecografía renal.

349 nefro-01 · Perfil V3 2.01.1.063 · Insuficiencia renal aguda · *Práctica*

Un niño de 3 años presentó diarrea con sangre hace una semana, ya resuelta. Ahora está pálido, decaído y orina poco. Exámenes: hemoglobina 7,5 g/dL con esquistocitos en el frotis, plaquetas 45.000/mm3, LDH elevada, Coombs directo negativo y creatinina 2,1 mg/dL.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénica inmune

B) Glomerulonefritis postestreptocócica

C) Síndrome hemolítico urémico

D) Anemia hemolítica autoinmune

E) Deshidratación con falla prerrenal

> **Respuesta C.** Anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos, LDH alta, Coombs negativo), trombocitopenia e injuria renal aguda tras una diarrea disentérica es síndrome hemolítico urémico, por E. coli productora de toxina Shiga. Es la principal causa de injuria renal aguda intrínseca en preescolares en Chile. Manejo de soporte; los antibióticos no están indicados.

350 nefro-18 · Perfil V3 2.01.1.064 · Insuficiencia renal crónica · *Práctica*

En un policlínico de nefrología infantil se revisa la etiología de los niños con enfermedad renal crónica.

¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en niños?

A) Nefropatía diabética

B) Nefropatía hipertensiva

C) Nefropatía por IgA

D) Malformaciones congénitas del riñón y vía urinaria (uropatías obstructivas y displasias)

E) Enfermedad renal poliquística autosómica dominante

> **Respuesta D.** En pediatría, especialmente en menores de 5 años, la principal causa de enfermedad renal crónica son las anomalías congénitas del riñón y la vía urinaria: hipoplasia o displasia renal, uropatías obstructivas como válvulas de uretra posterior y reflujo vesicoureteral con nefropatía. Las glomerulopatías ganan importancia en escolares y adolescentes; la diabetes y la hipertensión son causas del adulto.

351 nefro-13 · Perfil V3 2.01.1.066 · Síndrome edematoso · *Práctica*

Un niño de 5 años consulta por edema palpebral matinal de 5 días, que luego se extiende a las piernas. No tiene disnea, ictericia ni diarrea. Al examen la presión arterial es normal y el edema es blando, con fóvea.

¿Cuál es el examen inicial más útil para orientar la causa del edema?

A) Ecocardiograma

B) TSH y T4 libre

C) Pruebas hepáticas

D) Ecografía abdominal

E) Examen de orina completa con proteinuria

> **Respuesta E.** En un niño con edema generalizado sin síntomas cardíacos ni hepáticos, la causa más frecuente es el síndrome nefrótico. El primer examen es la orina completa: proteinuria marcada (y luego índice proteinuria/creatininuria) junto con albuminemia y perfil lipídico. La hematuria e HTA orientan a síndrome nefrítico. Las causas cardíacas, hepáticas o por desnutrición se buscan si la orina es normal.

352 nefro-11 · Perfil V3 2.01.1.070 · Trastornos del equilibrio ácido-base · *Práctica*

Un lactante de 10 meses con diarrea acuosa abundante de 3 días llega deshidratado. Gases venosos: pH 7,24, PCO2 30 mmHg, HCO3- 13 mEq/L. Electrolitos: Na+ 137 mEq/L, K+ 3,2 mEq/L y Cl- 112 mEq/L.

¿Cuál es el trastorno ácido-base?

A) Acidosis metabólica con anión gap normal (hiperclorémica)

B) Acidosis metabólica con anión gap aumentado

C) Acidosis respiratoria

D) Alcalosis metabólica hipoclorémica

E) Trastorno mixto: acidosis respiratoria y alcalosis metabólica

> **Respuesta A.** pH bajo con bicarbonato bajo es acidosis metabólica, con compensación respiratoria (PCO2 baja). Anión gap = 137 - (112 + 13) = 12, normal: acidosis hiperclorémica, típica de la pérdida digestiva de bicarbonato en la diarrea. Si hubiera shock con hipoperfusión se agregaría acidosis láctica con gap aumentado. Los vómitos, en cambio, dan alcalosis hipoclorémica.

353 nefro-15 · Perfil V3 2.01.2.007 · Emergencia hipertensiva · *Práctica*

Un niño de 8 años, con faringitis hace 2 semanas, presenta orinas oscuras, edema y cefalea intensa. En urgencia presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. La presión arterial es 165/110 mmHg y la glicemia es normal.

Una vez controlada la convulsión, ¿cuál es el manejo más adecuado de la presión arterial?

A) Normalizar la presión arterial en la primera hora

B) Solo restricción de sal y líquidos

C) Observar sin tratamiento hasta que mejore la función renal

D) Captopril oral y control ambulatorio

E) Descenso gradual con antihipertensivo endovenoso, bajando no más de 25% en las primeras 8 horas

> **Respuesta E.** Hipertensión grave con daño de órgano blanco (encefalopatía hipertensiva con convulsión) en una glomerulonefritis postestreptocócica es una emergencia hipertensiva. Se trata en unidad de paciente crítico con antihipertensivo endovenoso titulable (labetalol o nicardipino) y furosemida por la sobrecarga de volumen, bajando la PA en forma gradual (no más de 25% en 8 horas) para evitar isquemia cerebral.

354 nefro-07 · Perfil V3 2.01.4.013 · Electrolitos plasmáticos · *Práctica*

Un lactante de 6 meses con diarrea de 4 días llega irritable, con piel pastosa y signos de deshidratación moderada. Los electrolitos plasmáticos muestran Na+ 162 mEq/L, K+ 3,8 mEq/L y Cl- 128 mEq/L.

¿Cuál es el principio más importante del tratamiento?

A) Corregir el sodio en 4 a 6 horas con suero glucosado al 5%

B) Administrar bicarbonato de sodio

C) Administrar furosemida

D) Restringir completamente el aporte de agua

E) Descenso lento del sodio, no más de 10 a 12 mEq/L por día, por riesgo de edema cerebral

> **Respuesta E.** En la deshidratación hipernatrémica, las neuronas generan osmoles idiógenos para protegerse. Si el sodio baja rápidamente, entra agua a las células y se produce edema cerebral y convulsiones. Por ello la corrección debe ser lenta: descenso máximo de 10 a 12 mEq/L en 24 horas, reponiendo el déficit en 48 a 72 horas, con controles frecuentes de electrolitos.

355 nefro-18 · Perfil V3 2.01.4.022 · Pruebas de función renal · *Práctica*

Un niño de 8 años, con talla de 125 cm, tiene creatinina plasmática de 0,9 mg/dL. Se quiere estimar su velocidad de filtración glomerular.

¿Qué método es el más adecuado para estimarla en pediatría?

A) Fórmula de Schwartz (talla y creatinina)

B) Fórmula de Cockcroft-Gault

C) Ecuación CKD-EPI

D) Solo el nitrógeno ureico

E) La creatinina sola, comparada con valores del adulto

> **Respuesta A.** En niños, la filtración glomerular se estima con la fórmula de Schwartz modificada: VFG = 0,413 × talla (cm) / creatinina (mg/dL). En este caso, 0,413 × 125 / 0,9 = 57 mL/min/1,73 m2, es decir, disminuida. Las fórmulas del adulto (CKD-EPI, Cockcroft-Gault) no son válidas en niños, y la creatinina normal varía con la edad y la masa muscular.

356 nefro-11 · Perfil V3 4.01.4.014 · Gases arteriales y electrolitos plasmáticos · *Práctica*

Hombre de 30 años con diabetes tipo 1 ingresa con vómitos y respiración profunda. Gases arteriales: pH 7,20; pCO2 26 mmHg; HCO3 10 mEq/L. Electrolitos: Na 138 mEq/L, Cl 100 mEq/L, K 5,2 mEq/L.

¿Cuál es la interpretación correcta?

A) Acidosis metabólica con anión gap normal

B) Acidosis metabólica con acidosis respiratoria agregada

C) Acidosis respiratoria aguda

D) Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria

E) Acidosis metabólica con anión gap aumentado y compensación respiratoria adecuada

> **Respuesta E.** pH bajo con bicarbonato bajo indica acidosis metabólica. El anión gap es 138 menos (100 más 10), es decir 28, aumentado (normal alrededor de 12), compatible con cetoacidosis. La pCO2 esperada según Winter es 1,5 por 10 más 8, es decir 23 más o menos 2; 26 está en el límite, por lo que la compensación respiratoria se considera adecuada.

357 nefro-18 · Perfil V3 4.03.3.006 · Trasplante renal, indicaciones y complicaciones · *Práctica*

Mujer de 45 años, trasplantada renal hace 4 meses, en tratamiento con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Consulta por fiebre de 38 °C, tos y disnea progresiva de 1 semana. Radiografía con infiltrado intersticial bilateral. LDH elevada. Suspendió por su cuenta la profilaxis con cotrimoxazol hace 1 mes.

¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Pneumocystis jirovecii

B) Streptococcus pneumoniae

C) Mycoplasma pneumoniae

D) Legionella pneumophila

E) Rechazo agudo del injerto

> **Respuesta A.** Entre el primer y sexto mes postrasplante predominan las infecciones oportunistas (CMV, Pneumocystis), por la inmunosupresión máxima. Neumonía intersticial bilateral con LDH alta e hipoxemia, sin profilaxis con cotrimoxazol, sugiere Pneumocystis jirovecii. Se trata con cotrimoxazol en dosis altas. Por eso la profilaxis se mantiene al menos 6 meses.

358 nefro-01 · Perfil V3 4.03.4.006 · Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis) · *Práctica*

Hombre de 75 años con creatinina de 3,2 mg/dL (basal desconocida), sin síntomas urinarios claros. Se solicita ecografía renal.

¿Qué hallazgo ecográfico orienta más a enfermedad renal crónica que a injuria renal aguda?

A) Riñones de tamaño normal con hidronefrosis bilateral

B) Riñones aumentados de tamaño

C) Riñones pequeños (menores de 9 cm), con corteza adelgazada y aumento de la ecogenicidad

D) Asimetría renal mayor de 1,5 cm por uno grande

E) Vejiga distendida

> **Respuesta C.** La ecografía renal permite distinguir cronicidad: riñones pequeños, de corteza delgada e hiperecogénicos indican ERC avanzada. Además descarta obstrucción (hidronefrosis), la principal causa reversible, y detecta asimetrías (mayor de 1,5 cm sugiere enfermedad renovascular). Excepciones de ERC con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis y VIH.

Neurología y Geriatría

359 neuro-02 · Perfil V3 1.01.2.003 · Embolia cardiogénica · *Práctica*

Una mujer de 74 años, hipertensa, presenta afasia y hemiparesia derecha de inicio súbito. Al examen tiene pulso irregular de 110 por minuto. El ECG muestra fibrilación auricular, que desconocía. La TAC de encéfalo no muestra hemorragia y la RM confirma un infarto cortical en el territorio de la arteria cerebral media izquierda.

Una vez superada la fase aguda, ¿cuál es la medida más eficaz para prevenir un nuevo evento?

A) Aspirina 100 mg/día

B) Clopidogrel más aspirina por 1 año

C) Anticoagulación oral

D) Endarterectomía carotídea

E) Control de frecuencia con atenolol solamente

> **Respuesta C.** Un infarto cortical con fibrilación auricular es una embolia cardiogénica. La prevención secundaria es la anticoagulación oral (anticoagulantes directos o acenocumarol), iniciada precozmente según el tamaño del infarto. Los antiplaquetarios son claramente inferiores para prevenir embolias de origen auricular.

360 neuro-22 · Perfil V3 1.02.1.001 · Desnutrición · *Práctica*

Un hombre de 80 años, que vive solo, ha bajado 8 kg en 4 meses (de 64 a 56 kg). Come una vez al día, tiene la prótesis dental en mal estado y menor fuerza de prensión. Su IMC actual es 19 kg/m² y la albúmina es 3,1 g/dL. La evaluación inicial no muestra signos de cáncer.

¿Cuál es el diagnóstico nutricional más adecuado?

A) Estado nutricional normal, porque el IMC es mayor de 18,5

B) Sobrepeso

C) Obesidad sarcopénica

D) Desnutrición proteico-calórica, por pérdida de peso significativa

E) Caquexia neoplásica confirmada

> **Respuesta D.** Una pérdida mayor al 5% en 3 meses o al 10% en 6 meses es significativa: él perdió 12,5% en 4 meses. En el adulto mayor un IMC bajo 23 ya se considera enflaquecido. Se suman baja ingesta, problemas dentales, aislamiento y menor fuerza: desnutrición, con manejo multidimensional y social.

361 neuro-19 · Perfil V3 1.02.4.010 · Electromiografía · *Práctica*

Una mujer de 52 años, diabética, refiere parestesias nocturnas en el pulgar, índice y medio de la mano derecha que la despiertan y mejoran al sacudir la mano. Tiene signos de Phalen y Tinel positivos y leve atrofia tenar.

¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y evaluar su severidad?

A) Radiografía de muñeca

B) Ecocardiograma

C) RM de columna cervical

D) Hemoglobina glicosilada

E) Electromiografía con velocidad de conducción nerviosa

> **Respuesta E.** El cuadro es un síndrome del túnel carpiano (atrapamiento del nervio mediano), más frecuente en diabéticos. La electromiografía con estudio de conducción nerviosa confirma la lesión, mide su severidad y la diferencia de una radiculopatía C6-C7 o de la polineuropatía diabética. Con atrofia tenar, la indicación es quirúrgica.

362 neuro-01 · Perfil V3 1.07.1.006 · Enfermedad cerebro-vascular · *Práctica*

Mujer de 84 años, autovalente e hipertensa, presenta hemiparesia derecha y afasia de inicio hace 90 minutos. PA 175/95 mmHg, glicemia 130 mg/dL. La TAC de cerebro sin contraste no muestra hemorragia ni hipodensidad extensa.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) No trombolizar por ser mayor de 80 años

B) Trombolisis endovenosa, evaluando además trombectomía si hay oclusión de gran vaso

C) Aspirina 300 mg y observar

D) Bajar la presión a menos de 120/80 mmHg antes de decidir

E) Heparina endovenosa en infusión

> **Respuesta B.** La edad avanzada no contraindica la trombolisis: una paciente autovalente con ACV isquémico dentro de 4,5 horas y sin hemorragia en la TAC se beneficia de trombolisis endovenosa, y de trombectomía si hay oclusión proximal. Basta una PA bajo 185/110. La aspirina se inicia 24 horas después y la heparina no está indicada.

363 neuro-23 · Perfil V3 1.07.1.010 · Hipotensión postural · *Práctica*

Hombre de 76 años, usuario de doxazosina por hiperplasia prostática, consulta por mareos al ponerse de pie y una caída reciente. Se mide la presión arterial en decúbito y luego de 3 minutos de pie.

¿Cuál de los siguientes resultados confirma hipotensión ortostática?

A) Caída de la PA sistólica de 10 mmHg con aumento de la FC de 5/min

B) Aumento de la PA sistólica de 20 mmHg

C) Caída de la PA diastólica de 5 mmHg

D) Caída de la PA sistólica de 25 mmHg

E) Aumento de la FC de 30/min sin cambios en la PA

> **Respuesta D.** La hipotensión ortostática se define como una caída de la PA sistólica de al menos 20 mmHg o de la diastólica de al menos 10 mmHg dentro de 3 minutos de bipedestación. Es causa frecuente de caídas, y los alfabloqueadores como la doxazosina son un gatillante clásico. Un alza aislada de FC sin hipotensión sugiere taquicardia postural.

364 neuro-24 · Perfil V3 1.07.1.012 · Incontinencia urinaria · *Práctica*

Mujer de 73 años, autovalente, consulta por 8 meses de pérdidas de orina precedidas de un deseo súbito e imperioso de orinar, que no alcanza a contener; orina cada 1 a 2 horas en pequeña cantidad y se levanta 3 veces en la noche. No pierde orina al toser. Examen ginecológico sin prolapso significativo, orina completa y urocultivo normales, residuo posmiccional de 40 mL.

¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Oxibutinina oral

B) Sonda Foley permanente

C) Entrenamiento vesical con micción programada, ejercicios de piso pélvico y manejo de líquidos y cafeína

D) Cirugía con cinta suburetral

E) Uso de pañal como única medida

> **Respuesta C.** Urgencia, frecuencia y nicturia con orina normal y residuo bajo: incontinencia de urgencia por vejiga hiperactiva. El tratamiento inicial es conductual: entrenamiento vesical, micción programada, ejercicios de piso pélvico y reducir cafeína y líquidos nocturnos. Si no basta, se prefiere mirabegrón, ya que la oxibutinina es anticolinérgica (Beers). La cinta es para incontinencia de esfuerzo.

365 neuro-22 · Perfil V3 1.07.1.013 · Inmovilidad · *Práctica*

Hombre de 81 años, autovalente, se hospitaliza por neumonía. Al tercer día está estable y afebril, pero permanece todo el día en cama, con sonda Foley instalada "por comodidad".

¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir el síndrome de inmovilidad?

A) Movilización precoz, con sedestación en sillón y marcha asistida diaria, retirando la sonda innecesaria

B) Reposo absoluto hasta el alta para evitar caídas

C) Colchón antiescaras como única medida

D) Suplemento de vitamina D en dosis altas

E) Contención física nocturna

> **Respuesta A.** La inmovilidad del adulto mayor hospitalizado produce pérdida rápida de fuerza muscular, úlceras por presión, trombosis, delirium y deterioro funcional. Lo más eficaz es la movilización precoz con sedestación y marcha asistida, y retirar dispositivos innecesarios como sondas, que atan al paciente a la cama. Las contenciones y el reposo prolongado agravan la inmovilidad.

366 neuro-22 · Perfil V3 1.07.1.014 · Malnutrición · *Práctica*

Mujer de 80 años que vive sola, viuda reciente, es evaluada en el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Refiere menor apetito y ha bajado 4 kg en 3 meses.

¿Cuál es el instrumento validado más adecuado para tamizar malnutrición en esta paciente?

A) Índice de Barthel

B) Escala de Tinetti

C) Escala de Yesavage

D) Test de Pfeiffer

E) Mini Nutritional Assessment (MNA)

> **Respuesta E.** El Mini Nutritional Assessment es el instrumento validado para tamizar malnutrición o riesgo nutricional en adultos mayores: considera ingesta, pérdida de peso, movilidad, estrés, estado neuropsicológico e IMC. Barthel mide funcionalidad, Yesavage depresión, Pfeiffer cognición y Tinetti marcha y equilibrio. Su baja de peso obliga además a descartar depresión y causas orgánicas.

367 neuro-13 · Perfil V3 1.07.1.016 · Temblor · *Práctica*

Mujer de 76 años consulta por temblor de ambas manos de 2 meses, que aparece al sostener la taza y al escribir y desaparece en reposo. Refiere además palpitaciones, insomnio y baja de 3 kg. Usa levotiroxina 150 µg/día, cuya dosis se aumentó hace 3 meses. Examen: temblor postural fino y simétrico, sin rigidez ni bradicinesia, FC 104 lpm. TSH 0,04 mUI/L (VN 0,4–4,5).

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar propranolol de forma indefinida por temblor esencial

B) Iniciar levodopa/carbidopa

C) Reducir la dosis de levotiroxina y controlar la TSH en 6 a 8 semanas

D) Solicitar RM de encéfalo

E) Iniciar clonazepam nocturno

> **Respuesta C.** Ante un temblor postural de inicio reciente en una persona mayor, primero se buscan causas secundarias: fármacos (levotiroxina, salbutamol, litio, valproato), hipertiroidismo, cafeína o abstinencia. Aquí la TSH suprimida tras subir la levotiroxina explica un temblor fisiológico exagerado: se ajusta la dosis. No es Parkinson (sin reposo ni bradicinesia) y no corresponde rotularlo como esencial.

368 neuro-23 · Perfil V3 1.07.1.017 · Trastornos de la marcha · *Práctica*

Hombre de 76 años con 1 año de alteración progresiva de la marcha: pasos cortos, base amplia, como si los pies estuvieran pegados al suelo, con dificultad para iniciar la marcha y girar. En los últimos meses tiene urgencia e incontinencia urinaria y lentitud para pensar. Sin temblor de reposo; braceo conservado. TAC de encéfalo: ventriculomegalia desproporcionada respecto de los surcos corticales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar levodopa/carbidopa

B) Solo kinesiterapia motora

C) Iniciar donepezilo

D) Punción lumbar evacuadora (tap test) y derivación a neurocirugía

E) RM de columna lumbar por sospecha de canal estrecho

> **Respuesta D.** Marcha magnética, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo (tríada de Hakim) con ventriculomegalia sin atrofia proporcional: hidrocefalia normotensiva, causa tratable de trastorno de la marcha y demencia. Se realiza punción lumbar evacuadora de 30 a 50 mL; si la marcha mejora, predice buena respuesta a la derivación ventrículo-peritoneal. La marcha es lo que mejor responde.

369 neuro-21 · Perfil V3 1.07.3.002 · Complicaciones en el adulto mayor hospitalizado · *Práctica*

Mujer de 82 años se hospitaliza para cirugía de fractura de cadera. Usa lentes y audífonos y tiene deterioro cognitivo leve. El equipo quiere reducir el riesgo de la complicación más frecuente del adulto mayor hospitalizado en este contexto.

¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir el delirium?

A) Haloperidol profiláctico nocturno

B) Benzodiacepina para asegurar el sueño

C) Medidas no farmacológicas: reorientación, uso de lentes y audífonos, movilización precoz, higiene del sueño e hidratación

D) Contención física preventiva

E) Mantener la luz encendida toda la noche para vigilancia

> **Respuesta C.** El delirium es la complicación más frecuente del adulto mayor hospitalizado, sobre todo tras una fractura de cadera. Las intervenciones no farmacológicas multicomponente (reorientación, lentes y audífonos, movilización, sueño nocturno, hidratación, evitar sondas y contenciones) reducen su incidencia en cerca de un tercio. El haloperidol profiláctico no ha demostrado beneficio y las benzodiacepinas lo precipitan.

370 neuro-22 · Perfil V3 1.07.3.004 · Ejercicio en personas mayores · *Práctica*

Hombre de 70 años, autovalente, con hipertensión controlada y sin cardiopatía, consulta en APS porque desea mantenerse activo. Hoy solo camina 15 minutos 2 veces por semana. Examen físico y EFAM normales.

¿Cuál es la recomendación de actividad física más adecuada?

A) Caminar 20 minutos 3 veces por semana como única actividad

B) Al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, ejercicios de fuerza 2 o más días y de equilibrio 3 o más días por semana

C) Evitar los ejercicios de fuerza por el riesgo de lesión

D) Solo actividad aeróbica intensa, sin fuerza ni equilibrio

E) Mantener su nivel actual, ya que a esta edad el ejercicio no modifica el riesgo

> **Respuesta B.** En las personas mayores se recomienda al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, ejercicios de fortalecimiento muscular 2 o más días y actividad multicomponente con énfasis en equilibrio 3 o más días por semana, para prevenir caídas, sarcopenia y dependencia. El entrenamiento de fuerza es seguro y especialmente útil a esta edad.

371 neuro-22 · Perfil V3 1.07.3.008 · Nutrición en las personas mayores · *Práctica*

Hombre de 78 años, autovalente y sin enfermedad renal, presenta sarcopenia leve en la valoración geriátrica. Su dieta es pobre en carnes y lácteos.

¿Cuál es el aporte proteico diario recomendado para este paciente?

A) 1,0 a 1,2 g/kg/día

B) 0,6 g/kg/día

C) 0,4 g/kg/día

D) 2,5 a 3 g/kg/día

E) No requiere proteínas adicionales, solo vitaminas

> **Respuesta A.** Las personas mayores necesitan más proteínas que los adultos jóvenes para mantener la masa muscular, por resistencia anabólica: se recomienda 1,0 a 1,2 g/kg/día, y hasta 1,5 en enfermedad aguda o sarcopenia, salvo enfermedad renal avanzada. Debe combinarse con ejercicio de resistencia. Un aporte de 0,6 corresponde a restricción en enfermedad renal crónica.

372 neuro-22 · Perfil V3 1.07.3.009 · Prevención del deterioro funcional · *Práctica*

Hombre de 84 años, autovalente, camina sin ayuda y vive con su esposa. Se hospitaliza en sala por una neumonía; al segundo día está estable, afebril, lúcido y tolera la vía oral. El equipo de enfermería propone medidas para la estadía.

¿Cuál de las siguientes medidas previene mejor el deterioro funcional asociado a la hospitalización?

A) Movilización precoz, sentarlo fuera de la cama y caminar diariamente, con nutrición adecuada

B) Instalar sonda Foley para evitar que se levante de noche

C) Reposo absoluto en cama hasta completar los antibióticos

D) Sujeción mecánica nocturna para prevenir caídas

E) Benzodiacepina nocturna para asegurar el sueño

> **Respuesta A.** En la persona mayor hospitalizada el reposo en cama produce pérdida rápida de masa muscular y funcionalidad, incluso en pocos días. Se previene con movilización precoz y diaria, aporte proteico, uso de lentes y audífonos, y orientación. Sondas, sujeciones y benzodiacepinas favorecen inmovilidad, delirium y caídas, y deben evitarse.

373 neuro-23 · Perfil V3 1.07.3.011 · Adecuación del entorno para personas mayores · *Práctica*

Mujer de 81 años con osteoporosis ha tenido 2 caídas en su casa durante el último año, ambas de noche al ir al baño. Vive en una casa con alfombras sueltas y escalones sin baranda.

¿Cuál es la medida de adecuación del entorno más adecuada?

A) Indicar una benzodiacepina para que no se levante de noche

B) Mantener la casa en penumbra para no alterar el sueño

C) Indicarle que camine de noche con calcetines de lana

D) Retirar alfombras sueltas, instalar iluminación nocturna y barras de apoyo en el baño

E) Restringir la ingesta de agua durante todo el día

> **Respuesta D.** Adecuar el entorno es eficaz para prevenir caídas: retirar alfombras sueltas y obstáculos, iluminar de noche el trayecto al baño, instalar barras de apoyo, pisos antideslizantes y barandas. Las benzodiacepinas aumentan el riesgo de caídas, igual que los calcetines sin suela antideslizante y la penumbra. Restringir líquidos predispone a deshidratación.

374 neuro-22 · Perfil V3 1.07.5.001 · Valoración afectiva · *Práctica*

Mujer de 77 años es evaluada en el examen de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM). Su hija refiere que la nota más aislada y desganada desde hace meses.

¿Cuál es el instrumento más adecuado para la valoración afectiva?

A) Mini-Mental State Examination

B) Escala de depresión geriátrica de Yesavage

C) Índice de Katz

D) Escala de Lawton y Brody

E) Timed Up and Go

> **Respuesta B.** La escala de depresión geriátrica de Yesavage, en su versión de 15 preguntas (más de 5 puntos sugiere depresión), es el instrumento de tamizaje afectivo recomendado en la valoración geriátrica integral. El MMSE evalúa cognición, Katz y Lawton miden actividades básicas e instrumentales, y el Timed Up and Go evalúa marcha y riesgo de caídas.

375 neuro-23 · Perfil V3 1.07.5.003 · Valoración de la marcha · *Práctica*

Mujer de 79 años acude a su EMPAM en el CESFAM. Refiere una caída en el último año. Como parte de la evaluación del riesgo de caídas se le aplicará el test Timed Up and Go.

¿Cómo se realiza correctamente este test?

A) Se cronometra el tiempo que tarda en levantarse de una silla con apoyabrazos, caminar 3 metros, girar, volver y sentarse, a su paso habitual

B) Se mide la distancia que camina en 6 minutos

C) Se cronometra el tiempo que logra mantenerse sobre un pie con los ojos abiertos

D) Se cuenta cuántas veces se levanta de la silla en 30 segundos sin usar los brazos

E) Se mide el tiempo que tarda en caminar 10 metros en línea recta lo más rápido posible

> **Respuesta A.** El Timed Up and Go evalúa en una sola prueba la transferencia, la marcha y el giro: la persona se levanta de una silla con apoyabrazos, camina 3 metros a su ritmo habitual (con su ayuda técnica si la usa), gira, vuelve y se sienta. Un tiempo prolongado indica riesgo de caídas. Las demás opciones describen otros tests.

376 neuro-22 · Perfil V3 1.07.5.004 · Valoración funcional · *Práctica*

Mujer de 81 años, viuda, vive sola. Su hija relata que en los últimos 6 meses olvida pagar las cuentas, se equivoca al tomar sus medicamentos y ya no usa el transporte público sola. Se baña, se viste, come y va al baño sin ayuda, y es continente.

¿Qué instrumento es el más adecuado para cuantificar el compromiso funcional descrito?

A) Índice de Barthel

B) Test de Pfeiffer

C) Índice de Katz

D) Escala de depresión geriátrica de Yesavage

E) Escala de Lawton y Brody

> **Respuesta E.** Manejar dinero, medicamentos, transporte, teléfono y compras son actividades instrumentales de la vida diaria, que se evalúan con la escala de Lawton y Brody; suelen ser las primeras en perderse. Barthel y Katz miden actividades básicas (baño, vestido, alimentación, continencia), que aquí están conservadas. Yesavage tamiza depresión y Pfeiffer, deterioro cognitivo.

377 neuro-01 · Perfil V3 1.10.1.004 · Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores · *Práctica*

Hombre de 70 años presenta en forma súbita un habla fluente pero sin sentido, con parafasias y neologismos. No comprende órdenes simples, no logra repetir frases y no parece darse cuenta de su déficit. No tiene paresia.

¿Cuál es la localización más probable de la lesión?

A) Circunvolución frontal inferior izquierda (área de Broca)

B) Lóbulo parietal derecho

C) Porción posterior de la circunvolución temporal superior izquierda (área de Wernicke)

D) Cerebelo

E) Tronco encefálico

> **Respuesta C.** Una afasia fluente con mala comprensión, mala repetición, parafasias y anosognosia es una afasia de Wernicke, por lesión de la porción posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, típicamente por un ACV de la división inferior de la arteria cerebral media izquierda. La afasia de Broca es no fluente, con comprensión relativamente conservada.

378 neuro-20 · Perfil V3 1.10.1.018 · Síndrome atáxico · *Práctica*

Hombre de 68 años, hipertenso, presenta en forma súbita vértigo, vómitos, cefalea occipital e imposibilidad de mantenerse de pie. Al examen tiene dismetría en la prueba índice-nariz y disdiadococinesia derechas, marcha con lateralización a derecha y nistagmo que cambia de dirección con la mirada.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Maniobra de Epley

B) Betahistina y control ambulatorio

C) Corticoides por neuronitis vestibular

D) Audiometría

E) Neuroimagen urgente (TAC o resonancia de cerebro) por sospecha de lesión cerebelosa

> **Respuesta E.** Un síndrome atáxico agudo con dismetría y disdiadococinesia ipsilaterales, cefalea y nistagmo que cambia de dirección es de origen central: debe descartarse hemorragia o infarto cerebeloso con neuroimagen urgente, porque el edema puede comprimir el tronco y causar hidrocefalia, requiriendo cirugía. Epley y betahistina son para cuadros periféricos.

379 neuro-10 · Perfil V3 1.10.1.022 · Síndromes convulsivos sintomáticos · *Práctica*

Hombre de 62 años, diabético usuario de insulina, presenta una crisis tónico-clónica generalizada en su casa. Al llegar el SAMU tiene glicemia capilar de 28 mg/dL; se administra glucosa endovenosa y recupera completamente la conciencia. Examen neurológico normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la crisis?

A) Iniciar ácido valproico de mantención

B) Diagnosticar epilepsia del adulto

C) Iniciar levetiracetam por al menos 2 años

D) Resonancia y electroencefalograma antes de reiniciar la insulina

E) Corregir la causa y ajustar el tratamiento de la diabetes, sin fármaco antiepiléptico crónico

> **Respuesta E.** Una crisis desencadenada por una alteración metabólica aguda (hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, abstinencia alcohólica) es una crisis sintomática aguda, no epilepsia. Se trata corrigiendo la causa y previniendo que se repita; no requiere antiepiléptico de mantención, porque el riesgo de recurrencia depende de la causa.

380 neuro-20 · Perfil V3 1.10.1.025 · Síndromes vertiginosos periféricos · *Práctica*

Mujer de 57 años con 5 días de episodios de vértigo rotatorio intenso de menos de 1 minuto, que aparecen al darse vuelta en la cama o al mirar hacia arriba, con náuseas. Sin hipoacusia, tinnitus ni síntomas neurológicos. Examen neurológico normal. Maniobra de Dix-Hallpike derecha: tras una latencia de 5 segundos, nistagmo torsional geotrópico y vertical hacia arriba, que dura 20 segundos y se agota al repetirla.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Betahistina 24 mg cada 12 horas por 3 meses

B) Dimenhidrinato diario por 3 semanas

C) RM de encéfalo urgente

D) Prednisona oral por 10 días

E) Maniobra de reposición de Epley

> **Respuesta E.** Vértigo posicional breve con Dix-Hallpike positivo (latencia, nistagmo torsional geotrópico, duración menor de 1 minuto y fatigable): vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior derecho. Se trata con la maniobra de reposición de Epley, efectiva en la mayoría con 1 o 2 sesiones. Los sedantes vestibulares retrasan la compensación; no requiere imagen.

381 neuro-04 · Perfil V3 1.10.2.001 · Cefalea aguda en urgencia · *Práctica*

Mujer de 34 años consulta en urgencia por cefalea holocránea de 10 días, progresiva, que empeora al toser y al acostarse, con vómitos matinales. Usa anticonceptivos orales. Afebril, PA 124/78 mmHg, sin rigidez de nuca ni déficit motor.

¿Cuál de los siguientes hallazgos es una bandera roja que obliga a neuroimagen urgente?

A) Fotofobia y náuseas

B) Antecedente familiar de migraña

C) Edema de papila bilateral en el fondo de ojo

D) Dolor opresivo bilateral

E) Alivio parcial con paracetamol

> **Respuesta C.** Una cefalea nueva o progresiva con banderas rojas (SNOOP: síntomas sistémicos, signos neurológicos como edema de papila, inicio súbito, inicio después de los 50 años, cambio de patrón o empeoramiento con Valsalva y decúbito) obliga a neuroimagen. El edema de papila indica hipertensión endocraneana. Fotofobia, náuseas y dolor opresivo son propios de cefaleas primarias.

382 neuro-06 · Perfil V3 1.10.2.001 · Cefalea aguda en urgencia · *Práctica*

Mujer de 30 años con migraña sin aura diagnosticada hace 8 años consulta en urgencia por una crisis igual a las habituales, de 10 horas de evolución, hemicránea pulsátil con fotofobia y vómitos repetidos que le impiden tomar medicamentos orales. Afebril, PA 118/74 mmHg, examen neurológico normal, sin rigidez de nuca.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) TAC de encéfalo urgente antes de tratar

B) Morfina EV

C) Punción lumbar

D) Hidratación EV, ketorolaco EV y metoclopramida EV, sin neuroimagen

E) Sumatriptán oral y alta inmediata

> **Respuesta D.** Crisis migrañosa típica, igual a las previas y sin banderas rojas: no requiere imagen. Con vómitos se usa la vía parenteral: AINE EV (ketorolaco) más antiemético antidopaminérgico (metoclopramida), con hidratación; el sumatriptán subcutáneo es alternativa. Los opioides se evitan por cefalea de rebote y recurrencia; la vía oral fallará con vómitos.

383 neuro-21 · Perfil V3 1.10.2.004 · Estado confusional agudo (alcohólico, tóxico metabólico) · *Práctica*

Hombre de 52 años, bebedor de 1 litro de destilado al día, desnutrido, es traído a urgencia por 2 días de confusión e inestabilidad. Desorientado, apático, con nistagmo horizontal, paresia bilateral del recto lateral y ataxia de marcha que le impide caminar sin ayuda. Afebril, PA 128/80 mmHg, glicemia 94 mg/dL, sin signos de abstinencia.

¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Suero glucosado al 30 % EV en bolo

B) Haloperidol 5 mg IM

C) Tiamina EV en dosis altas, antes o junto con cualquier aporte de glucosa

D) Lorazepam EV como única medida

E) Punción lumbar urgente

> **Respuesta C.** Confusión, oftalmoplejía y ataxia en un alcohólico desnutrido: encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, una emergencia que basta sospechar. Se administra tiamina EV en dosis altas (por ejemplo, 500 mg cada 8 horas) antes o junto con la glucosa, ya que la glucosa sin tiamina puede precipitar o agravar el cuadro y evolucionar a síndrome de Korsakoff.

384 neuro-03 · Perfil V3 1.10.2.009 · Hipertensión endocraneana · *Práctica*

Hombre de 47 años con 3 semanas de cefalea progresiva de predominio matinal y vómitos. Hoy su familia lo encuentra somnoliento. Glasgow 10, pupila derecha de 5 mm hiporreactiva, hemiparesia izquierda. PA 186/94 mmHg, FC 52 lpm, respiración irregular. TAC de encéfalo: masa frontotemporal derecha con extenso edema vasogénico y desviación de la línea media de 9 mm.

¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Punción lumbar para medir la presión de apertura

B) Cabecera a 30°, asegurar la vía aérea, manitol EV, dexametasona EV y evaluación neuroquirúrgica urgente

C) Hiperventilación sostenida con meta de $PaCO_2$ de 25 mmHg durante 48 horas

D) Suero glucosado al 5 % para hidratación

E) Nitroprusiato EV para llevar la PA sistólica bajo 100 mmHg

> **Respuesta B.** Hipertensión endocraneana con signos de herniación (sopor, midriasis ipsilateral, tríada de Cushing) por un tumor con edema: cabecera a 30°, vía aérea segura, osmoterapia (manitol o suero hipertónico), dexametasona por el edema vasogénico y neurocirugía urgente. La punción lumbar puede precipitar herniación; los sueros hipotónicos y la hipotensión empeoran el daño.

385 neuro-16 · Perfil V3 1.10.2.012 · Síndrome cuadraplégico agudo · *Práctica*

Mujer de 34 años con diarrea hace 2 semanas presenta debilidad progresiva de 4 días, que comenzó en las piernas y ahora compromete los brazos, con arreflexia generalizada y parestesias distales. Hoy refiere dificultad para respirar al acostarse.

¿Cuál es el parámetro más importante a monitorizar en forma seriada?

A) Capacidad vital forzada

B) Creatinquinasa (CK)

C) Saturación de oxígeno como único parámetro

D) Velocidad de sedimentación

E) Glicemia

> **Respuesta A.** Una tetraparesia aguda arrefléctica tras una diarrea sugiere síndrome de Guillain-Barré. El riesgo vital es la insuficiencia respiratoria neuromuscular, por lo que se monitoriza en forma seriada la capacidad vital forzada: valores menores de 20 mL/kg indican necesidad de UCI e intubación. La saturación cae tardíamente. El tratamiento es inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis.

386 neuro-06 · Perfil V3 1.10.2.018 · Status migrañoso · *Práctica*

Mujer de 32 años con migraña sin aura conocida presenta una crisis de cefalea pulsátil, con náuseas y fotofobia, de 4 días de duración continua, que no ha cedido con naproxeno ni sumatriptán. Examen neurológico normal, sin fiebre ni signos meníngeos.

¿Cuál es el manejo más adecuado en el servicio de urgencia?

A) Morfina endovenosa

B) Hidratación, metoclopramida y ketorolaco endovenosos, considerando dexametasona

C) Ergotamina más un segundo triptán

D) Propranolol oral y alta

E) Punción lumbar inmediata

> **Respuesta B.** Una crisis de migraña de más de 72 horas es un status migrañoso. En urgencia se trata con hidratación, un antiemético antidopaminérgico como metoclopramida, un AINE endovenoso como ketorolaco y dexametasona para reducir recurrencias. Los opioides favorecen la cefalea por abuso de medicamentos, ergotamina y triptán no deben combinarse, y el propranolol es profilaxis, no tratamiento agudo.

387 neuro-01 · Perfil V3 1.10.3.002 · Prevención de factores de riesgo cerebrovascular · *Práctica*

Hombre de 66 años, hipertenso y dislipidémico, egresa tras un infarto cerebral lacunar capsular izquierdo con buena recuperación. Fuma 10 cigarrillos al día. Ritmo sinusal en Holter de 24 horas y eco-Doppler carotídeo sin estenosis significativa. PA 148/92 mmHg con enalapril, LDL 142 mg/dL, HbA1c 5,6 %.

¿Cuál es la estrategia de prevención secundaria más adecuada?

A) Anticoagulación oral con acenocumarol de por vida

B) AAS 100 mg/día, estatina de alta intensidad con meta de LDL menor de 70 mg/dL, PA menor de 130/80 mmHg y cesación tabáquica

C) AAS más clopidogrel en forma indefinida

D) Solo optimizar la PA, ya que el infarto lacunar no requiere antiagregante

E) Estatina solo si el LDL supera 190 mg/dL

> **Respuesta B.** Infarto no cardioembólico (ritmo sinusal, sin estenosis carotídea): antiagregación con AAS a largo plazo, estatina de alta intensidad con meta de LDL menor de 70 mg/dL, PA menor de 130/80 mmHg, cese del tabaco y actividad física. La anticoagulación es para cardioembolia; la doble antiagregación indefinida aumenta el sangrado sin beneficio.

388 neuro-01 · Perfil V3 1.10.4.001 · TAC de encefalo y columna · *Práctica*

Mujer de 72 años, hipertensa, es traída a urgencia 50 minutos después de iniciar en forma súbita hemiparesia izquierda faciobraquiocrural y disartria. PA 178/96 mmHg, glicemia capilar 132 mg/dL, NIHSS 9. Se activa el código ACV.

¿Cuál es el examen de imagen que debe realizarse en primer lugar?

A) Resonancia magnética de encéfalo con gadolinio

B) TAC de encéfalo con contraste

C) TAC de encéfalo sin contraste urgente

D) Eco-Doppler carotídeo

E) Electroencefalograma

> **Respuesta C.** Ante un déficit focal agudo, el primer examen es el TAC de encéfalo sin contraste, rápido y disponible, cuyo objetivo principal es descartar hemorragia antes de trombolisis. En las primeras horas el infarto suele no verse, por lo que un TAC normal es compatible con isquemia. El contraste dificulta ver sangre; la RM no debe retrasar el tratamiento.

389 neuro-03 · Perfil V3 1.10.4.001 · TAC de encefalo y columna · *Práctica*

Mujer de 69 años, hipertensa mal controlada, presenta cefalea brusca, vómitos y hemiparesia derecha de instalación en minutos. PA 210/118 mmHg, Glasgow 13. Se realiza TAC de encéfalo sin contraste a los 40 minutos del inicio.

¿Qué hallazgo del TAC sin contraste confirma una hemorragia intracerebral aguda?

A) Hiperdensidad espontánea intraparenquimatosa en los ganglios basales izquierdos

B) Hipodensidad córtico-subcortical en el territorio de la arteria cerebral media

C) Lesión con realce en anillo tras la administración de contraste

D) Pequeñas hipodensidades lacunares en la cápsula interna

E) Hiperdensidad lineal de la arteria cerebral media (signo de la arteria hiperdensa)

> **Respuesta A.** En el TAC sin contraste la sangre aguda es hiperdensa (blanca) desde el primer minuto, por eso es el examen de elección para descartar hemorragia. La hipodensidad en territorio arterial es un infarto establecido (de horas); la arteria hiperdensa es un trombo intraluminal en un ACV isquémico; el realce en anillo sugiere absceso o tumor.

390 neuro-05 · Perfil V3 1.10.4.002 · Resonancia magnética de encéfalo y columna · *Práctica*

Mujer de 32 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados y fumadora, consulta por 5 días de cefalea holocránea progresiva que empeora con el decúbito, con vómitos y visión borrosa transitoria. Fondo de ojo: edema de papila bilateral. Sin déficit focal. TAC de encéfalo sin contraste: normal.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico más probable?

A) Resonancia magnética de encéfalo con venografía por resonancia

B) Punción lumbar con medición de presión de apertura

C) Electroencefalograma

D) Repetir el TAC sin contraste en 48 horas

E) Eco-Doppler carotídeo

> **Respuesta A.** Cefalea progresiva con hipertensión endocraneana en una mujer con anticonceptivos y tabaco: sospecha de trombosis venosa cerebral. El TAC sin contraste suele ser normal; se confirma con RM más venografía por RM (o angio-TAC venoso), que muestran el seno trombosado. La punción lumbar no se hace antes de la imagen adecuada, y no diagnostica la trombosis.

391 neuro-18 · Perfil V3 1.10.4.002 · Resonancia magnética de encéfalo y columna · *Práctica*

Mujer de 31 años con 10 días de parestesias y debilidad de la pierna derecha. Hace 2 años tuvo una neuritis óptica izquierda que se recuperó. Examen: paresia 4/5 de la extremidad inferior derecha con hiperreflexia y Babinski derecho. Se solicita RM de encéfalo y médula con gadolinio.

¿Qué hallazgo de la RM apoya con mayor fuerza el diagnóstico más probable?

A) Lesiones ovoides hiperintensas en T2 periventriculares, perpendiculares al cuerpo calloso, más lesiones yuxtacorticales, infratentoriales y medulares

B) Infartos lacunares múltiples en los ganglios basales

C) Atrofia hipocampal bilateral

D) Lesión única con realce en anillo y edema perilesional

E) Hiperintensidad simétrica de ambos tálamos

> **Respuesta A.** Dos episodios separados en tiempo y espacio en una mujer joven: esclerosis múltiple. La RM es el examen clave: lesiones desmielinizantes ovoides periventriculares (dedos de Dawson), yuxtacorticales, infratentoriales y medulares cumplen diseminación en espacio; la coexistencia de lesiones que captan y no captan gadolinio cumple diseminación en tiempo (criterios de McDonald).

392 neuro-04 · Perfil V3 1.10.4.003 · Angiografía · *Práctica*

Mujer de 48 años con cefalea súbita, "la peor de su vida", de 6 horas de evolución. La TAC de cerebro sin contraste muestra hemorragia subaracnoidea en las cisternas basales.

¿Cuál es el examen de referencia para identificar y caracterizar el aneurisma?

A) Angiografía cerebral por sustracción digital

B) Electroencefalograma

C) Punción lumbar

D) Doppler transcraneal

E) Resonancia magnética sin contraste

> **Respuesta A.** Confirmada la hemorragia subaracnoidea, debe identificarse el aneurisma. La angiografía cerebral por sustracción digital es el estándar de referencia: lo localiza, lo caracteriza y permite tratarlo con embolización endovascular en el mismo procedimiento. La angio-TAC es una alternativa inicial no invasiva, y el doppler transcraneal sirve para vigilar el vasoespasmo.

393 neuro-08 · Perfil V3 1.10.4.005 · Electroencefalograma · *Práctica*

Niña de 7 años, con buen desarrollo, es derivada porque su profesora nota que varias veces al día se queda con la mirada fija por unos 10 segundos, con parpadeo, sin caerse, y retoma la actividad sin confusión. En la consulta se reproduce un episodio al pedirle que hiperventile.

¿Qué hallazgo del electroencefalograma es esperable?

A) Trazado normal, que descarta epilepsia

B) Hipsarritmia

C) Puntas centrotemporales que aumentan con el sueño

D) Complejos periódicos de ondas agudas

E) Descargas generalizadas de punta-onda a 3 Hz

> **Respuesta E.** Desconexiones breves y frecuentes, sin período postictal y gatilladas por hiperventilación: epilepsia de ausencia infantil. El EEG característico muestra descargas generalizadas y simétricas de punta-onda a 3 Hz. La hipsarritmia corresponde al síndrome de West; las puntas centrotemporales a la epilepsia rolándica; los complejos periódicos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

394 neuro-10 · Perfil V3 1.10.4.005 · Electroencefalograma · *Práctica*

Hombre de 31 años, sano, presenta una primera crisis tónico-clónica generalizada no provocada, presenciada, con mordedura lateral de lengua y confusión postictal de 20 minutos. Examen neurológico y exámenes generales normales; RM de encéfalo normal. El EEG interictal de rutina, realizado a los 5 días, es normal.

¿Cuál es la interpretación más adecuada del EEG?

A) No descarta epilepsia: un EEG interictal es normal en una proporción relevante de pacientes, y puede repetirse con privación de sueño

B) Descarta epilepsia y permite dar el alta sin controles

C) Confirma una crisis psicógena no epiléptica

D) Indica que la crisis fue un síncope convulsivo

E) Obliga a iniciar fenitoína de inmediato

> **Respuesta A.** El EEG interictal de rutina detecta descargas epileptiformes solo en una parte de los pacientes con epilepsia; su sensibilidad aumenta con registros repetidos, privación de sueño o video-EEG. Un EEG normal no descarta epilepsia, y uno anormal tras una primera crisis aumenta el riesgo de recurrencia y apoya iniciar tratamiento. El diagnóstico sigue siendo clínico.

395 neuro-04 · Perfil V3 1.10.4.007 · Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico) · *Práctica*

Hombre de 45 años con cefalea súbita de máxima intensidad en segundos, iniciada hace 10 horas durante el ejercicio. Examen neurológico normal. TAC de encéfalo sin contraste a las 8 horas: normal. Se realiza punción lumbar a las 10 horas del inicio.

¿Qué hallazgo del líquido cefalorraquídeo confirma una hemorragia subaracnoídea?

A) Glóbulos rojos que disminuyen progresivamente del primer al cuarto tubo

B) Bandas oligoclonales de IgG

C) Proteínas elevadas con celularidad normal

D) Glucosa baja con predominio de neutrófilos

E) Xantocromía del sobrenadante tras centrifugar

> **Respuesta E.** La xantocromía (sobrenadante amarillo por bilirrubina de la degradación de la hemoglobina) aparece desde las 6 a 12 horas y confirma sangre previa en el espacio subaracnoídeo. Los glóbulos rojos que disminuyen entre tubos sugieren punción traumática. Glucosa baja con neutrófilos es meningitis bacteriana; las bandas oligoclonales orientan a esclerosis múltiple.

396 neuro-16 · Perfil V3 1.10.4.007 · Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico) · *Práctica*

Mujer de 42 años con 10 días de parestesias en manos y pies y debilidad ascendente simétrica, precedida por una gastroenteritis. Examen: tetraparesia de predominio proximal y arreflexia generalizada, sin nivel sensitivo y con esfínteres conservados. Se realiza punción lumbar.

¿Cuál es el resultado del líquido cefalorraquídeo más compatible con el diagnóstico más probable?

A) Proteínas 180 mg/dL, 850 células/mm³ con 90 % de neutrófilos y glucosa 20 mg/dL

B) Proteínas 160 mg/dL, 3 células/mm³ y glucosa normal

C) Líquido xantocrómico con 12.000 glóbulos rojos/mm³

D) Proteínas 40 mg/dL, 2 células/mm³ y glucosa normal, con bandas oligoclonales

E) Proteínas 90 mg/dL, 120 células/mm³ de predominio linfocitario y glucosa normal

> **Respuesta B.** Debilidad ascendente arrefléctica tras una infección: síndrome de Guillain-Barré. El LCR típico muestra disociación albúmino-citológica, con proteínas elevadas y menos de 10 células/mm³, más evidente desde la segunda semana. Una pleocitosis mayor de 50 células obliga a buscar otra causa (VIH, linfoma, poliomielitis, enfermedad de Lyme); neutrófilos con glucosa baja es meningitis bacteriana.

397 neuro-18 · Perfil V3 1.10.4.007 · Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico) · *Práctica*

Hombre de 28 años con 1 semana de diplopía e inestabilidad de la marcha. Examen: oftalmoplejía internuclear derecha y ataxia de extremidades. RM: lesiones desmielinizantes periventriculares y en el pedúnculo cerebeloso medio. Se realiza punción lumbar para apoyar el diagnóstico.

¿Qué hallazgo del líquido cefalorraquídeo apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple?

A) Glucosa en LCR de 20 mg/dL

B) Pleocitosis de 600 células/mm³ con predominio de neutrófilos

C) Bandas oligoclonales de IgG presentes en el LCR y ausentes en el suero

D) Proteínas de 450 mg/dL

E) Xantocromía

> **Respuesta C.** En la esclerosis múltiple el LCR suele ser casi normal (proteínas y células normales o levemente elevadas), pero muestra síntesis intratecal de IgG: bandas oligoclonales en el LCR ausentes en el suero, presentes en más del 90 % de los casos. Según McDonald 2017, pueden reemplazar la diseminación en tiempo. Neutrófilos, glucosa baja o proteínas muy altas sugieren otra causa.

398 neuro-14 · Perfil V3 1.10.5.003 · Aplicación de tests neurocognitivos de screening · *Práctica*

Mujer de 74 años, autovalente, acude a su Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) en el CESFAM. Su hija refiere que en el último año olvida conversaciones recientes. En el Minimental abreviado obtiene 11 puntos (de un máximo de 19).

¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?

A) Diagnosticar demencia e iniciar donepezilo

B) Solicitar RM de encéfalo como único estudio

C) Repetir el Minimental abreviado en 2 años

D) Aplicar el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer a un informante

E) Derivar a psiquiatría por probable depresión

> **Respuesta D.** En el EMPAM, un Minimental abreviado menor de 13 puntos es alterado y se complementa con el cuestionario de Pfeffer, respondido por un familiar: un puntaje de 6 o más indica compromiso funcional y sospecha de demencia, que se confirma con evaluación clínica y estudio de causas reversibles. Un test de screening por sí solo no diagnostica demencia.

399 neuro-19 · Perfil V3 1.11.1.023 · Síndrome de túnel carpiano · *Práctica*

Mujer de 48 años, costurera, con 4 meses de parestesias en pulgar, índice y dedo medio derechos, que la despiertan en la noche y mejoran al sacudir la mano. Examen: signos de Phalen y Tinel positivos en la muñeca derecha, fuerza conservada y sin atrofia de la eminencia tenar. TSH y glicemia normales.

¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Liberación quirúrgica del túnel carpiano de inmediato

B) Resonancia magnética de columna cervical

C) Prednisona 60 mg/día por 2 semanas

D) Férula nocturna de muñeca en posición neutra y modificación de actividades

E) Gabapentina en dosis altas como único tratamiento

> **Respuesta D.** Túnel carpiano leve a moderado (síntomas sensitivos, sin déficit motor ni atrofia tenar): manejo conservador con férula nocturna en posición neutra, pausas y modificación de la actividad; puede agregarse infiltración con corticoide. La cirugía se indica si hay atrofia o debilidad tenar, denervación en la electromiografía o falla del tratamiento conservador.

400 neuro-10 · Perfil V3 2.01.1.053 · Síncope · *Práctica*

Una adolescente de 14 años, sana, presentó pérdida de conciencia de 20 segundos mientras estaba de pie en un acto escolar con calor. Antes sintió náuseas, calor, visión borrosa y palidez; tras caer se recuperó completamente en segundos, sin confusión. No tiene antecedentes familiares de muerte súbita. Su examen cardiovascular y neurológico y el electrocardiograma son normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar electroencefalograma

B) Solicitar TAC de cerebro

C) Solicitar Holter de ritmo y ecocardiograma

D) Educar sobre síncope vasovagal: hidratación y maniobras de contrapresión

E) Iniciar ácido valproico

> **Respuesta D.** Pérdida de conciencia breve, con gatillante (bipedestación prolongada, calor), pródromo autonómico y recuperación rápida sin período postictal, con examen y ECG normales, es un síncope vasovagal, la causa más frecuente en adolescentes. Se maneja con educación, hidratación, sal y maniobras de contrapresión.

401 neuro-09 · Perfil V3 2.01.2.027 · Estatus convulsivo en el niño · *Práctica*

Un niño de 4 años, con antecedente de epilepsia, lleva 6 minutos con una convulsión tónico-clónica generalizada. Se aseguró la vía aérea y recibe oxígeno, y la glicemia capilar es normal. No ha sido posible instalar una vía venosa.

¿Cuál es el fármaco más adecuado en este momento?

A) Fenitoína endovenosa

B) Midazolam bucal, intranasal o intramuscular

C) Ácido valproico oral

D) Fenobarbital oral

E) Esperar 30 minutos para definir status epiléptico

> **Respuesta B.** Una convulsión de más de 5 minutos debe tratarse como status epiléptico inminente. La primera línea es una benzodiacepina: lorazepam o diazepam endovenoso si hay vía; sin vía, midazolam bucal, intranasal o intramuscular (o diazepam rectal). Si persiste tras dos dosis, se usa fármaco de segunda línea endovenoso (fenitoína, levetiracetam o valproato). La vía oral no es segura.

402 neuro-02 · Perfil V3 4.01.1.046 · Insuficiencia cerebro vascular · *Práctica*

Hombre de 66 años, hipertenso, presenta un episodio de 30 minutos de debilidad de la mano derecha y dificultad para hablar, con recuperación completa. La TAC de cerebro es normal. La ecografía Doppler carotídea muestra una estenosis de 80% de la carótida interna izquierda.

Además del tratamiento médico óptimo, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Anticoagulación con heparina y luego warfarina

B) Control con Doppler carotídeo en 6 meses

C) Endarterectomía carotídea izquierda precoz, idealmente dentro de 2 semanas

D) Endarterectomía carotídea derecha

E) Trombólisis endovenosa

> **Respuesta C.** Un AIT del territorio carotídeo izquierdo con estenosis sintomática ipsilateral de 70 a 99% tiene indicación de endarterectomía carotídea (o angioplastia con stent en casos seleccionados), idealmente dentro de 2 semanas, cuando el riesgo de recurrencia es mayor. La trombólisis no corresponde porque el déficit ya se resolvió.

403 neuro-22 · Perfil V3 4.01.1.052 · Escaras · *Práctica*

Mujer de 84 años, postrada tras un accidente cerebrovascular, con incontinencia urinaria y desnutrición, vive con su hija. En la visita domiciliaria se observa eritema que no blanquea a la presión en la zona sacra, con piel indemne.

¿Cuál es la medida más importante para evitar la progresión de la lesión?

A) Masaje enérgico de la zona enrojecida

B) Curación con apósito y decúbito supino permanente

C) Antibiótico tópico en la zona

D) Flotador o rosca bajo el sacro

E) Cambios de posición programados cada 2 horas y superficie que redistribuya la presión

> **Respuesta E.** Eritema no blanqueable con piel intacta corresponde a una úlcera por presión categoría 1. La medida clave es aliviar la presión: cambios posturales programados, colchón antiescaras, manejo de la humedad y apoyo nutricional. El masaje de la zona y los flotadores o roscas están contraindicados porque aumentan el daño tisular.

404 neuro-14 · Perfil V3 5.01.1.015 · Trastornos neurocognitivos · *Práctica*

Mujer de 76 años, traída por su hija por olvidos progresivos de 2 años de evolución. Desde hace 6 meses ya no puede manejar sus finanzas ni sus medicamentos y se ha perdido en su barrio. Está vigil, sin fluctuaciones de conciencia ni focalidad neurológica. MoCA 16/30, tamizaje de depresión negativo y exámenes metabólicos normales.

¿Cuál es el diagnóstico sindromático más adecuado?

A) Trastorno neurocognitivo leve

B) Pseudodemencia depresiva

C) Delirium

D) Trastorno neurocognitivo mayor (demencia)

E) Envejecimiento cognitivo normal

> **Respuesta D.** Según DSM-5, el trastorno neurocognitivo mayor es un declive cognitivo significativo que interfiere con la independencia en actividades instrumentales (finanzas, medicamentos). En el leve hay declive objetivo pero se conserva la autonomía. La evolución insidiosa, sin fluctuaciones ni alteración de conciencia, descarta delirium.

405 neuro-22 · Perfil V3 5.01.3.007 · Maltrato en el adulto mayor · *Práctica*

Mujer de 82 años, con demencia moderada, vive con su hijo, que es su único cuidador. Consulta por una caída. Al examen tiene hematomas en distintas etapas de evolución en ambos brazos, baja de peso y mala higiene. El hijo responde todas las preguntas por ella y se niega a dejarla sola con el equipo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Entrevistarla a solas, registrar detalladamente las lesiones, activar la red de protección y realizar la denuncia

B) Atribuir los hematomas a fragilidad capilar propia de la edad

C) Indicar control en 3 meses

D) Pedir explicaciones al hijo y dar el alta si son coherentes

E) Solicitar pruebas de coagulación y no tomar otras medidas

> **Respuesta A.** Hematomas en distintas etapas, desnutrición, mala higiene y un cuidador controlador son señales de maltrato y negligencia. Se debe entrevistar a la persona mayor a solas, documentar en la ficha, evaluar riesgo y activar la red de protección, con denuncia, ya que el maltrato a personas mayores es violencia intrafamiliar según la ley chilena.

406 neuro-14 · Perfil V3 5.01.5.004 · Mini mental test, MoCA test · *Práctica*

Hombre de 70 años, profesor universitario jubilado, consulta por quejas de memoria de 1 año, corroboradas por su esposa. Es completamente autónomo. Su Minimental (MMSE) es de 29/30.

¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para evaluar un posible deterioro cognitivo leve?

A) Solicitar PET cerebral

B) Repetir el Minimental en una semana

C) Tranquilizarlo, ya que el Minimental es normal

D) Solicitar electroencefalograma

E) Aplicar el test MoCA

> **Respuesta E.** El Minimental tiene efecto techo y baja sensibilidad para deterioro cognitivo leve, sobre todo en personas de alta escolaridad. El MoCA evalúa mejor funciones ejecutivas y atención, y es más sensible para detectarlo (punto de corte habitual 26, con un punto adicional si la escolaridad es 12 años o menos). Ante quejas corroboradas no basta con un MMSE normal.

407 neuro-04 · Perfil V3 6.02.2.009 · Parálisis III par + midriasis · *Práctica*

Mujer de 48 años consulta por cefalea intensa retroocular derecha de 1 día y visión doble. Al examen tiene ptosis palpebral derecha, ojo desviado hacia abajo y afuera y pupila derecha midriática arrefléctica. Sin rigidez de nuca.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Diagnosticar parálisis microvascular del III par y controlar en 3 meses

B) Angio-TAC o angiorresonancia cerebral urgente por sospecha de aneurisma de la arteria comunicante posterior

C) Iniciar corticoides por neuritis

D) Indicar parche ocular y control con oftalmología

E) Prueba de hielo para miastenia

> **Respuesta B.** Una parálisis del III par con midriasis (compromiso pupilar) y cefalea sugiere compresión de las fibras parasimpáticas periféricas por un aneurisma de la comunicante posterior, con riesgo de rotura: requiere angio-TAC o angiorresonancia urgente. La parálisis microvascular (diabetes, HTA) típicamente respeta la pupila. La miastenia nunca compromete la pupila.

Obstetricia

408 ob-05 · Perfil V3 1.09.2.012 · Pre eclampsia · *Práctica*

Primigesta de 34 semanas, sin antecedentes, presenta PA 148/96 mmHg confirmada en 2 tomas separadas por 4 horas. Está asintomática. Plaquetas, transaminasas y creatinina normales.

¿Cuál de los siguientes hallazgos confirma preeclampsia?

A) Proteinuria de 150 mg en orina de 24 horas

B) Edema de extremidades inferiores

C) Ácido úrico de 5 mg/dL

D) Aumento de peso de 2 kg en una semana

E) Proteinuria de 350 mg en orina de 24 horas

> **Respuesta E.** La preeclampsia es hipertensión de inicio después de las 20 semanas con proteinuria de 300 mg o más en 24 horas (o índice proteinuria/creatininuria de 0,3 o más) o, sin proteinuria, compromiso de órgano blanco. El edema y el alza de peso no son criterios diagnósticos. El ácido úrico puede elevarse, pero no define el cuadro.

409 ob-05 · Perfil V3 1.09.3.005 · Función renal en el embarazo · *Práctica*

Embarazada de 30 semanas, normotensa y asintomática, presenta en exámenes de rutina una creatinina plasmática de 1,0 mg/dL. Antes del embarazo tenía 0,8 mg/dL.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Es normal, porque la creatinina aumenta en el embarazo

B) Es esperable por aumento de la masa muscular

C) Indica una deshidratación leve sin importancia

D) Está elevada para el embarazo y debe estudiarse una alteración de la función renal

E) Solo debe repetirse después del parto

> **Respuesta D.** En el embarazo el flujo plasmático renal y la filtración glomerular aumentan cerca de 50%, por lo que la creatinina baja normalmente a 0,4-0,8 mg/dL. Un valor de 1,0 o más, aunque sería normal fuera del embarazo, sugiere deterioro de la función renal y obliga a estudiar preeclampsia, nefropatía u obstrucción.

410 ob-10 · Perfil V3 3.01.2.001 · Aborto provocado · *Práctica*

Mujer de 24 años, con 10 semanas de amenorrea, consulta en urgencia por metrorragia abundante, fiebre de 38,9 °C y dolor hipogástrico. Reconoce haberse introducido comprimidos de misoprostol comprados por internet hace 3 días. PA 95/60 mmHg, FC 112 lpm. Útero sensible, flujo de mal olor por el orificio cervical abierto.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dar de alta con misoprostol adicional para completar el aborto

B) Denunciar a Fiscalía y diferir el tratamiento hasta su declaración

C) Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro y evacuar el útero, resguardando el secreto profesional

D) Indicar antibióticos orales y control en 7 días

E) Realizar histerectomía de urgencia como primera medida

> **Respuesta C.** Es un aborto séptico por un aborto provocado: hospitalizar, estabilizar, antibióticos endovenosos (por ejemplo clindamicina más gentamicina) y evacuación uterina. La atención no puede condicionarse a una confesión ni a una denuncia; rige el secreto profesional. La histerectomía queda para la falla del tratamiento.

411 ob-02 · Perfil V3 3.01.4.003 · Ecotomografía obstétrica normal · *Práctica*

Primigesta de 12 semanas, sana, sin factores de riesgo, con embarazo único intrauterino y edad gestacional confirmada. Consulta en su control prenatal sobre cuándo se le realizarán las ecografías de rutina durante el embarazo.

¿Cuál es el esquema de ecografías de rutina recomendado para un embarazo de bajo riesgo?

A) Solo una ecografía a las 20 semanas

B) Ecografías a las 11 a 14, 22 a 24 y 30 a 34 semanas

C) Una ecografía mensual hasta el parto

D) Solo ecografía en el tercer trimestre para estimar el peso

E) Ecografías a las 7, 20 y 40 semanas

> **Respuesta B.** Según la Guía Perinatal MINSAL, en el embarazo de bajo riesgo se realizan ecografías de rutina a las 11 a 14 semanas (datación, translucencia nucal, Doppler de uterinas), a las 22 a 24 semanas (anatomía fetal y longitud cervical) y a las 30 a 34 semanas (crecimiento, placenta y líquido amniótico). Más ecografías no mejoran los resultados en bajo riesgo.

412 ob-11 · Perfil V3 3.01.4.008 · HCG cuantitativa · *Práctica*

Mujer de 27 años, con 5 semanas de amenorrea, consulta por spotting sin dolor. Está hemodinámicamente estable y el abdomen es blando. La beta-hCG cuantitativa es 900 UI/L. La ecografía transvaginal muestra útero sin saco gestacional, anexos normales y sin líquido libre.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Metotrexato intramuscular a dosis única

B) Salpingectomía laparoscópica

C) Legrado uterino diagnóstico

D) Repetir la beta-hCG cuantitativa en 48 horas

E) Dar de alta: el útero vacío descarta el embarazo

> **Respuesta D.** Con beta-hCG bajo la zona discriminatoria (1.500 a 2.000 UI/L) es esperable no ver el saco. Se repite a las 48 horas: si se duplica, sugiere embarazo normal; si sube poco, se estanca o hay útero vacío sobre la zona, se sospecha ectópico. Tratar ahora sería prematuro.

413 ob-12 · Perfil V3 3.01.4.008 · HCG cuantitativa · *Práctica*

Mujer de 28 años, a quien se le realizó aspiración endouterina por mola hidatiforme completa hace 6 semanas. Está asintomática, usando anticonceptivos orales. Sus controles semanales de beta-hCG cuantitativa en las últimas 3 semanas fueron: 1.250, 1.230, 1.260 y 1.240 UI/L.

¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?

A) Descenso normal; continuar controles mensuales

B) Neoplasia trofoblástica gestacional; etapificar e iniciar quimioterapia

C) Nuevo embarazo; ecografía obstétrica

D) Resultado falso positivo; suspender el seguimiento

E) Mola residual; histerectomía inmediata

> **Respuesta B.** Tras evacuar una mola, la beta-hCG debe caer hasta negativizarse. Cuatro valores en meseta durante 3 semanas (o un alza en 2 semanas) definen neoplasia trofoblástica gestacional: se etapifica y se trata con quimioterapia, habitualmente metotrexato. No es descenso normal ni embarazo, porque usa anticoncepción.

414 ob-02 · Perfil V3 3.01.5.001 · Amniocentesis · *Práctica*

Embarazada de 38 años, Rh positivo, con tamizaje de primer trimestre de alto riesgo para trisomía 21 (translucencia nucal aumentada). Hoy cursa 16 semanas y desea un diagnóstico definitivo.

¿Cuál es el procedimiento más adecuado?

A) Cordocentesis

B) Biopsia de vellosidades coriales

C) Amniocentesis para estudio genético fetal

D) Repetir la medición de translucencia nucal

E) Ecografía Doppler de arterias uterinas

> **Respuesta C.** El diagnóstico definitivo de aneuploidía requiere estudio invasivo. A las 16 semanas el procedimiento indicado es la amniocentesis, realizable desde las 15 semanas, con riesgo de pérdida cercano a 0,5%. La biopsia de vellosidades se realiza entre las 11 y 14 semanas; la cordocentesis tiene mayor riesgo. En Rh negativas se administra inmunoglobulina anti-D.

415 ob-13 · Perfil V3 3.01.5.002 · Cesárea · *Práctica*

Paciente de 32 años, multípara de 2 partos vaginales, cursando embarazo de 34 semanas, asintomática y sin sangrado. La ecografía muestra una placenta previa oclusiva total. Bienestar fetal normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la vía y momento del parto?

A) Programar cesárea electiva a las 36-37 semanas

B) Programar inducción del parto a las 39 semanas

C) Permitir parto vaginal con monitorización continua

D) Realizar cesárea de urgencia hoy

E) Esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto

> **Respuesta A.** La placenta previa oclusiva es indicación absoluta de cesárea, ya que el parto vaginal produciría hemorragia masiva. En la paciente estable y sin sangrado se programa cesárea electiva a las 36-37 semanas, antes de que aparezcan contracciones. No hay indicación de cesárea urgente sin sangrado ni compromiso fetal.

416 ob-03 · Perfil V3 3.01.5.003 · Doppler materno-fetal · *Práctica*

Embarazada de 34 semanas con feto de peso estimado en percentil 2. Doppler: arteria umbilical con índice de pulsatilidad sobre el percentil 95 con flujo diastólico presente, arteria cerebral media con índice de pulsatilidad bajo el percentil 5, índice cerebro-placentario bajo el percentil 5 y ductus venoso normal. Velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media normal.

¿Qué indica el hallazgo en la arteria cerebral media?

A) Anemia fetal severa

B) Insuficiencia cardíaca fetal descompensada

C) Hallazgo normal para la edad gestacional

D) Malformación vascular cerebral

E) Vasodilatación cerebral por hipoxemia (redistribución o centralización del flujo)

> **Respuesta E.** En la insuficiencia placentaria la hipoxemia fetal provoca vasodilatación cerebral para proteger el cerebro: baja el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y cae el índice cerebro-placentario (redistribución de flujo). La anemia fetal se evalúa con la velocidad sistólica máxima de la cerebral media, no con su pulsatilidad. La descompensación cardíaca se refleja en el ductus venoso alterado.

417 ob-03 · Perfil V3 3.01.5.005 · Evaluación anteparto · *Práctica*

Embarazada de 36 semanas, sin patología, con controles normales y feto con crecimiento adecuado en la ecografía de las 32 semanas. Pregunta cómo debe vigilar el bienestar de su hijo en las semanas que faltan para el parto.

¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Registro basal no estresante semanal desde ahora hasta el parto

B) Perfil biofísico 2 veces por semana

C) Doppler de arteria umbilical semanal

D) Percepción y registro diario de los movimientos fetales, consultando de inmediato si disminuyen

E) Ecografía de crecimiento cada semana

> **Respuesta D.** En el embarazo de bajo riesgo la vigilancia anteparto se basa en los controles habituales y en la percepción materna de los movimientos fetales: ante su disminución debe consultar de inmediato para evaluación con registro basal no estresante. Las pruebas seriadas (RBNE, perfil biofísico, Doppler) se reservan para embarazos de alto riesgo, como RCF, diabetes, SHE o embarazo prolongado.

Oftalmología

418 oftal-18 · Perfil V3 1.10.5.001 · Papiloscopia (fondo de ojo) · *Práctica*

Mujer de 28 años con obesidad presenta cefalea holocránea progresiva de 2 meses, peor en la mañana y con maniobras de Valsalva, y oscurecimientos visuales transitorios. Examen neurológico sin déficit focal. Se realiza oftalmoscopía directa (fondo de ojo).

¿Qué hallazgo del fondo de ojo indica hipertensión intracraneana?

A) Microaneurismas y exudados duros

B) Excavación papilar aumentada, con relación copa/disco de 0,8

C) Mancha rojo cereza en la mácula

D) Papilas solevantadas, de bordes borrosos, sin pulso venoso y con hemorragias peripapilares bilaterales

E) Palidez papilar unilateral sin edema

> **Respuesta D.** El edema de papila es el signo cardinal de hipertensión intracraneana: papilas solevantadas de bordes borrosos, pérdida del pulso venoso espontáneo, ingurgitación venosa y hemorragias peripapilares, habitualmente bilateral. En esta paciente sugiere hipertensión intracraneana idiopática, que requiere neuroimagen antes de la punción lumbar. La excavación aumentada es propia del glaucoma.

419 oftal-09 · Perfil V3 2.01.1.098 · Vicios de refracción · *Práctica*

Un escolar de 9 años refiere que no ve bien la pizarra desde hace meses y entrecierra los ojos para mirar de lejos. Lee bien de cerca. La agudeza visual es 20/80 en ambos ojos y mejora a 20/25 con el agujero estenopeico. El resto del examen ocular es normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miopía

B) Hipermetropía

C) Presbicia

D) Ambliopía

E) Catarata congénita

> **Respuesta A.** Mala visión de lejos con buena visión de cerca, que mejora con el agujero estenopeico (indica un defecto refractivo), es miopía, el vicio de refracción más frecuente en escolares. Se corrige con lentes divergentes indicados por oftalmólogo. La hipermetropía afecta más la visión cercana y da astenopia; la ambliopía no mejora con el estenopeico; la presbicia es del adulto.

420 oftal-15 · Perfil V3 4.01.2.015 · Trauma maxilofacial · *Práctica*

Hombre de 30 años recibe un puñetazo en el ojo izquierdo. Consulta por diplopía al mirar hacia arriba. Al examen presenta hematoma periorbitario, enoftalmos, limitación de la elevación del ojo izquierdo e hipoestesia de la mejilla y del labio superior ipsilaterales. Agudeza visual conservada.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura del piso de la órbita (por estallido)

B) Fractura de huesos propios nasales

C) Fractura de mandíbula

D) Parálisis del VI par craneal

E) Desprendimiento de retina traumático

> **Respuesta A.** Un golpe directo sobre el globo aumenta la presión intraorbitaria y fractura el piso orbitario (blow-out), con atrapamiento del recto inferior (diplopía en la mirada superior), enoftalmos e hipoestesia infraorbitaria por lesión del nervio infraorbitario. Se confirma con TAC de órbitas. La parálisis del VI par limita la abducción, no la elevación.

421 oftal-09 · Perfil V3 6.01.2.006 · Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido · *Práctica*

Lactante de 6 semanas con un hemangioma infantil en el párpado superior derecho que apareció a los pocos días de vida y ha crecido rápidamente. Hoy cubre parcialmente la pupila e impide la apertura completa del ojo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observación, ya que todos los hemangiomas involucionan

B) Láser ablativo inmediato en atención primaria

C) Derivar con urgencia para inicio de propranolol oral y evaluación oftalmológica por riesgo de ambliopía

D) Cirugía de exéresis electiva a los 5 años

E) Corticoide tópico de alta potencia

> **Respuesta C.** Los hemangiomas infantiles crecen sobre todo en los primeros meses. Los periorbitarios que ocluyen el eje visual o deforman la córnea causan ambliopía (deprivación o astigmatismo) y requieren tratamiento precoz: propranolol oral, primera línea, iniciado por especialista. La observación solo es adecuada para hemangiomas pequeños sin riesgo funcional ni estético.

422 oftal-03 · Perfil V3 6.02.1.002 · Blefaritis · *Práctica*

Hombre de 60 años, con rosácea, consulta por ardor y sensación de cuerpo extraño en ambos ojos de varios meses, peor al despertar. Al examen hay bordes palpebrales eritematosos y engrosados, con escamas adheridas a la base de las pestañas y orificios de las glándulas de Meibomio obstruidos. Agudeza visual normal.

¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Antibiótico oral por 7 días y alta

B) Drenaje quirúrgico de las glándulas de Meibomio

C) Colirio de corticoide de alta potencia en forma permanente

D) Derivación urgente a oftalmología

E) Higiene palpebral diaria con compresas tibias y masaje del borde palpebral, más lágrimas artificiales

> **Respuesta E.** La blefaritis es una inflamación crónica del borde palpebral, asociada a dermatitis seborreica y rosácea. La base del tratamiento es la higiene palpebral diaria: compresas tibias, masaje y limpieza del borde, con lágrimas artificiales. En casos persistentes se agregan antibióticos tópicos, o doxiciclina oral en la disfunción de Meibomio.

423 oftal-02 · Perfil V3 6.02.1.007 · Conjuntivitis no infecciosa · *Práctica*

Mujer de 24 años, con rinitis alérgica, consulta en primavera por ojo rojo bilateral de 1 semana, con prurito intenso, lagrimeo y secreción mucosa filante. Al examen hay hiperemia conjuntival leve, quemosis y papilas en la conjuntiva tarsal, con agudeza visual normal y sin adenopatía preauricular.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Colirio de cloranfenicol cada 6 horas

B) Colirio antihistamínico estabilizador de mastocitos, como olopatadina, y compresas frías

C) Colirio de corticoide de alta potencia por 1 mes

D) Colirio de aciclovir

E) Oclusión ocular por 48 horas

> **Respuesta B.** Prurito intenso, bilateral, estacional, con secreción mucosa y antecedente atópico es una conjuntivitis alérgica. Se trata con evitar el alérgeno, compresas frías, lágrimas artificiales y antihistamínicos tópicos de acción dual, como olopatadina. Los corticoides tópicos se reservan al especialista por el riesgo de glaucoma, catarata y queratitis herpética.

424 oftal-15 · Perfil V3 6.02.1.014 · Hifema · *Práctica*

Hombre de 22 años recibe un pelotazo de fútbol en el ojo izquierdo hace 3 horas. Refiere visión borrosa. Al examen: agudeza visual 20/50, nivel de sangre de 2 mm en la cámara anterior inferior, córnea transparente, sin laceraciones ni deformación pupilar. No tiene antecedentes de anemia de células falciformes ni usa anticoagulantes.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reposo con cabecera elevada a 30-45 grados, protector ocular rígido, evitar AINE y derivar a oftalmología para control de presión intraocular

B) Alta con ibuprofeno para el dolor y control en una semana

C) Masaje ocular para redistribuir la sangre y parche compresivo

D) Drenaje inmediato de la cámara anterior en el servicio de urgencia

E) Colirio de pilocarpina cada 6 horas y control en 48 horas

> **Respuesta A.** El hifema traumático se maneja con reposo semisentado, protector rígido (sin compresión), evitar AINE y aspirina por riesgo de resangrado y derivación a oftalmología, que vigila la presión intraocular y la tinción hemática corneal. El drenaje quirúrgico se reserva para casos complicados.

425 oftal-04 · Perfil V3 6.02.1.015 · Leucoma corneal · *Práctica*

Hombre de 50 años con antecedente de úlcera corneal bacteriana en el ojo derecho hace 1 año, tratada. Consulta por visión borrosa persistente de ese ojo. Al examen se observa una opacidad blanca, densa y bien delimitada en el centro de la córnea, que no tiñe con fluoresceína. El ojo está blanco y sin dolor.

¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?

A) Úlcera corneal activa; antibiótico tópico

B) Catarata; facoemulsificación

C) Leucoma corneal central; derivar a oftalmología para evaluar queratoplastía (trasplante de córnea)

D) Pterigion; exéresis

E) Queratitis herpética; aciclovir

> **Respuesta C.** El leucoma es una cicatriz corneal blanca y densa, secuela de úlceras, traumas o queratitis. Si es central, disminuye la agudeza visual y en niños puede causar ambliopía. Se diferencia de la úlcera activa porque no tiñe con fluoresceína y el ojo está tranquilo. El tratamiento de un leucoma central que compromete la visión es la queratoplastía.

426 oftal-01 · Perfil V3 6.02.1.020 · Pterigion · *Práctica*

Hombre de 52 años, pescador, consulta por sensación de cuerpo extraño y enrojecimiento del ojo derecho. Al examen se observa un pliegue fibrovascular triangular de conjuntiva bulbar nasal que invade 2 mm la córnea. La agudeza visual es normal.

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Exéresis quirúrgica inmediata

B) Biopsia urgente

C) Corticoide tópico crónico

D) Antibiótico tópico

E) Lubricantes tópicos, protección solar con lentes con filtro UV y control; cirugía si progresa hacia el eje visual o produce astigmatismo

> **Respuesta E.** El pterigion es una proliferación fibrovascular de la conjuntiva que invade la córnea, asociada a exposición UV, viento y polvo. Se maneja con lubricantes, antiinflamatorios en reagudizaciones y protección solar. La cirugía (con autoinjerto conjuntival para reducir recidiva) se indica si amenaza el eje visual, induce astigmatismo, limita la motilidad o por estética.

427 oftal-18 · Perfil V3 6.02.1.026 · Tumores de la vía óptica · *Práctica*

Niña de 5 años con neurofibromatosis tipo 1 (múltiples manchas café con leche y efélides axilares). En control se detecta disminución de la agudeza visual del ojo derecho, defecto pupilar aferente relativo y palidez del disco óptico en el fondo de ojo.

¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio indicado?

A) Glioma de la vía óptica; resonancia magnética de cerebro y órbitas

B) Ambliopía refractiva; lentes

C) Retinoblastoma; ecografía ocular

D) Neuritis óptica desmielinizante; punción lumbar

E) Catarata congénita; facoemulsificación

> **Respuesta A.** El glioma de la vía óptica (astrocitoma pilocítico) es el tumor de vía óptica más frecuente en la infancia y se asocia a NF1. Produce pérdida visual, defecto pupilar aferente, atrofia óptica, estrabismo o proptosis. Se estudia con resonancia magnética de cerebro y órbitas. En NF1 se recomienda control oftalmológico anual en la infancia.

428 oftal-17 · Perfil V3 6.02.1.027 · Tumores de órbita · *Práctica*

Niño de 7 años con proptosis unilateral del ojo izquierdo de rápida progresión en 3 semanas, desplazamiento del globo hacia abajo y edema palpebral, sin fiebre, sin dolor importante y sin antecedente de sinusitis ni trauma. Hemograma y PCR normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibiótico endovenoso por celulitis orbitaria

B) TAC o resonancia de órbitas urgente y derivación a oftalmología por sospecha de tumor orbitario maligno (rabdomiosarcoma)

C) Compresas tibias y control en 1 mes

D) Corticoide oral por orbitopatía tiroidea

E) Antihistamínico por edema alérgico

> **Respuesta B.** Una proptosis unilateral rápidamente progresiva en un niño, sin fiebre ni foco infeccioso, debe hacer sospechar rabdomiosarcoma, el tumor orbitario maligno primario más frecuente de la infancia. Requiere imagen urgente (TAC o RM) y biopsia. En adultos, la causa más frecuente de proptosis es la orbitopatía tiroidea y el tumor benigno más común, el hemangioma cavernoso.

429 oftal-09 · Perfil V3 6.02.1.031 · Vicios de refracción en personas de 65 años o más · *Práctica*

Hombre de 68 años, beneficiario de FONASA, consulta en su CESFAM porque desde hace 2 años debe alejar el diario para leer y ve borroso de cerca, sin dolor ni ojo rojo. La agudeza visual de lejos es 20/30 bilateral y mejora con agujero estenopeico. El rojo pupilar es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar colirio lubricante y control en 1 año

B) Derivar de urgencia por sospecha de glaucoma agudo

C) Derivar con sospecha GES de vicio de refracción en mayores de 65 años para evaluación y entrega de lentes ópticos

D) Solicitar resonancia magnética de cerebro

E) Derivar a cirugía de catarata

> **Respuesta C.** Dificultad para la visión cercana que se corrige alejando el texto es presbicia, y la mejoría con estenopeico confirma un vicio de refracción. Las personas de 65 años o más tienen garantía GES para el diagnóstico y la entrega de lentes ópticos. El rojo pupilar normal hace improbable una catarata significativa.

430 oftal-15 · Perfil V3 6.02.2.002 · Contusión ocular · *Práctica*

Mujer de 35 años recibe un puñetazo en el ojo derecho hace 2 horas. Presenta equimosis y edema palpebral. Al examen: agudeza visual 20/25, diplopía al mirar hacia arriba, limitación de la elevación del ojo derecho e hipoestesia de la mejilla y el labio superior derecho. Cámara anterior sin sangre y pupilas isocóricas reactivas.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento de retina traumático

B) Fractura por estallido del piso de la órbita con atrapamiento del recto inferior

C) Parálisis del tercer par craneano

D) Hifema traumático

E) Neuropatía óptica traumática

> **Respuesta B.** Tras una contusión orbitaria, la diplopía con limitación de la mirada hacia arriba (atrapamiento del recto inferior) y la hipoestesia infraorbitaria (lesión del nervio infraorbitario) son típicas de la fractura por estallido del piso orbitario. Se confirma con tomografía computada de órbitas.

431 oftal-08 · Perfil V3 6.02.2.004 · Disminución de la visión (lenta vs súbita) · *Práctica*

Mujer de 74 años con catarata bilateral conocida, en lista de espera de cirugía, consulta porque hace 6 horas perdió casi por completo la visión del ojo derecho, en forma brusca y sin dolor. Hasta ayer veía con dificultad, pero en forma estable. Agudeza visual: cuenta dedos a 1 metro en el ojo derecho.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Atribuirlo a progresión de la catarata y mantener la espera habitual

B) Adelantar la cirugía de catarata en forma electiva

C) Indicar lentes nuevos y control en 3 meses

D) Derivar a oftalmología de urgencia el mismo día

E) Colirio lubricante y control en 1 semana

> **Respuesta D.** La catarata produce pérdida visual lenta y progresiva en meses o años, nunca en horas. Una disminución súbita e indolora obliga a buscar otra causa, como oclusión arterial o venosa retiniana, hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, y requiere evaluación oftalmológica urgente.

432 oftal-10 · Perfil V3 6.02.2.004 · Disminución de la visión (lenta vs súbita) · *Práctica*

Hombre de 70 años, fumador, consulta porque hace 4 días nota en el ojo derecho que las líneas rectas, como los marcos de las puertas, se ven onduladas, y una mancha oscura en el centro de la visión. No tiene dolor ni ojo rojo. Agudeza visual 20/100 en el ojo derecho, que no mejora con agujero estenopeico.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Catarata senil

B) Glaucoma crónico

C) Degeneración macular relacionada con la edad neovascular

D) Vicio de refracción

E) Conjuntivitis viral

> **Respuesta C.** Metamorfopsia y escotoma central de instalación en días, en un adulto mayor fumador, sugieren degeneración macular neovascular, o húmeda. Es una pérdida visual subaguda que requiere derivación urgente a oftalmología para terapia antiangiogénica intravítrea. La catarata y el glaucoma crónico producen pérdida lenta y sin metamorfopsia.

433 oftal-15 · Perfil V3 6.02.2.008 · Heridas de párpados · *Práctica*

Niño de 6 años sufre mordedura de perro en la cara. Tiene una herida de espesor completo en el tercio medial del párpado inferior derecho, entre el punto lagrimal y el canto interno. El globo ocular parece indemne.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Sutura simple de piel en el servicio de urgencia

B) Parche ocular compresivo y control en 1 semana

C) Dejar cicatrizar por segunda intención

D) Cierre con adhesivo tisular

E) Aseo, profilaxis antibiótica y antirrábica según corresponda, y derivación a oftalmología para reparación con evaluación y reconstrucción de la vía lagrimal (canalículo)

> **Respuesta E.** Las heridas palpebrales mediales al punto lagrimal pueden seccionar el canalículo, y las que comprometen el borde libre o son de espesor completo requieren reparación por especialista para evitar epífora crónica y deformidades. Ante una herida palpebral siempre se descarta lesión del globo. Las mordeduras requieren además aseo, antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y evaluación de profilaxis antirrábica y antitetánica.

434 oftal-15 · Perfil V3 6.02.3.001 · Accidentes del trabajo · *Práctica*

Hombre de 35 años, trabajador de una maestranza, consulta en urgencia por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho tras usar un esmeril sin lentes de protección hace 3 horas. Al examen hay un cuerpo extraño metálico superficial en la córnea con anillo de óxido incipiente.

Además del manejo del cuerpo extraño, ¿cuál es la conducta administrativa y preventiva correcta?

A) Considerarlo accidente del trabajo: emitir la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) y derivar a su organismo administrador (mutual o ISL); reforzar el uso obligatorio de protección ocular

B) Licencia por enfermedad común con cargo a su previsión de salud

C) No requiere notificación porque es una lesión leve

D) Derivar a COMPIN para calificar enfermedad profesional

E) Recomendar al trabajador cambiar de oficio

> **Respuesta A.** Las lesiones oculares por esmeril, soldadura o químicos en el trabajo son accidentes del trabajo (Ley 16.744): se emite la DIAT y la atención, licencia y prestaciones son de cargo del organismo administrador. Son prevenibles con elementos de protección personal (lentes o careta), que el empleador debe proporcionar. Con radiografía se descarta cuerpo extraño intraocular si hubo alta velocidad.

435 oftal-12 · Perfil V3 6.02.3.002 · Diabetes · *Práctica*

Hombre de 50 años, recién diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 con glicemia de 380 mg/dL, consulta por visión borrosa bilateral fluctuante de 3 semanas, sin dolor ni ojo rojo. La agudeza visual mejora con agujero estenopeico y el fondo de ojo con dilatación pupilar es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su visión?

A) Recetar lentes ópticos de inmediato con la refracción actual

B) Solicitar angiografía con fluoresceína

C) Derivar de urgencia por sospecha de retinopatía proliferativa

D) Iniciar fotocoagulación láser preventiva

E) Lograr el control glicémico y diferir la receta de lentes hasta que la glicemia se estabilice, manteniendo el fondo de ojo anual

> **Respuesta E.** La hiperglicemia cambia la hidratación del cristalino y produce cambios refractivos transitorios y fluctuantes, que mejoran con estenopeico. No se deben recetar lentes hasta estabilizar la glicemia, porque la refracción volverá a cambiar. Con fondo de ojo normal, corresponde control anual de por vida.

436 oftal-09 · Perfil V3 6.02.3.003 · Examen visual en adulto · *Práctica*

Mujer de 45 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace unos meses debe alejar el celular y los textos para poder leer, especialmente con poca luz. La agudeza visual de lejos es 20/20 en ambos ojos, el segmento anterior es normal y la presión intraocular es normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

A) Catarata; cirugía

B) Degeneración macular; antiangiogénicos

C) Miopía; lentes negativos

D) Glaucoma crónico; colirios hipotensores

E) Presbicia; corrección con lentes positivos (convergentes) para visión cercana

> **Respuesta E.** La presbicia es la pérdida de acomodación del cristalino con la edad; desde los 40 a 45 años dificulta la visión cercana y obliga a alejar el texto. Se corrige con lentes positivos para lectura. El examen visual del adulto incluye agudeza visual lejana y cercana y, desde los 40 años, presión intraocular y fondo de ojo.

437 oftal-09 · Perfil V3 6.02.3.004 · Examen visual preventivo en niños · *Práctica*

En el control de salud de un niño de 4 años, sano, se realiza tamizaje de agudeza visual con cartilla adecuada a su edad. Obtiene 20/40 en el ojo derecho y 20/20 en el izquierdo. El rojo pupilar es simétrico y el test de Hirschberg es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tranquilizar: a esta edad es normal una diferencia de dos líneas entre ambos ojos

B) Repetir el tamizaje en 2 años, al ingreso escolar

C) Solicitar resonancia magnética de órbitas

D) Indicar parche en el ojo izquierdo sin evaluación previa

E) Derivar a oftalmología para evaluación de ambliopía y vicio de refracción

> **Respuesta E.** En el tamizaje preescolar se deriva si la agudeza es peor de lo esperado para la edad o si hay una diferencia de 2 líneas o más entre ambos ojos, porque sugiere ambliopía por anisometropía. La ambliopía solo es tratable en la ventana de plasticidad visual, por lo que no se debe esperar.

438 oftal-13 · Perfil V3 6.02.3.005 · Hipertensión arterial · *Práctica*

Hombre de 66 años, hipertenso con mal control, consulta por visión borrosa súbita e indolora en el ojo derecho desde ayer. Al fondo de ojo se observan hemorragias en llama y exudados algodonosos limitados al cuadrante temporal superior, distales a un cruce arteriovenoso, con la vena de ese sector dilatada y tortuosa. Papila sin edema.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinopatía hipertensiva grado IV

B) Oclusión de la arteria central de la retina

C) Retinopatía diabética proliferativa

D) Oclusión de rama venosa retiniana

E) Desprendimiento de retina regmatógeno

> **Respuesta D.** Hemorragias en llama sectoriales, limitadas al territorio drenado por una vena, distales a un cruce arteriovenoso, son una oclusión de rama venosa. La hipertensión arterial es su principal factor de riesgo: la arteriola esclerosada comprime la vena en el cruce. La retinopatía hipertensiva es bilateral y difusa, y el grado IV exige edema de papila.

439 oftal-07 · Perfil V3 6.02.4.001 · Campo visual · *Práctica*

Hombre de 64 años con glaucoma crónico de ángulo abierto, con mala adherencia a sus colirios, refiere que choca con objetos que están a sus lados, aunque lee bien. Agudeza visual 20/25 en ambos ojos. Se solicita campimetría computarizada.

¿Cuál es el patrón de campo visual más característico de su enfermedad avanzada?

A) Escotoma central con pérdida precoz de la visión de lectura

B) Escotomas arciformes que progresan a una visión en túnel, con conservación de la visión central hasta etapas tardías

C) Hemianopsia bitemporal

D) Hemianopsia homónima derecha

E) Metamorfopsia central

> **Respuesta B.** El glaucoma daña las fibras del nervio óptico y produce escotomas arciformes y escalón nasal, que avanzan hacia la periferia hasta dejar solo una isla central: la visión en túnel. Por eso la agudeza visual se conserva hasta muy tarde y la campimetría es clave para el diagnóstico y el seguimiento.

440 oftal-02 · Perfil V3 6.02.4.002 · Cultivo de secreción conjuntival · *Práctica*

Recién nacido de 3 días con secreción conjuntival purulenta abundante, bilateral, con edema palpebral marcado y quemosis. La madre no tuvo control prenatal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lavado con suero y control en 1 semana

B) Masaje del saco lagrimal

C) Colirio de cloranfenicol y alta

D) Tomar Gram y cultivo de secreción conjuntival (incluyendo medios para gonococo y estudio de Chlamydia) e iniciar ceftriaxona sistémica

E) Corticoide tópico

> **Respuesta D.** La conjuntivitis neonatal hiperaguda en los primeros días sugiere Neisseria gonorrhoeae, que puede perforar la córnea. Se toma Gram y cultivo de la secreción (y estudio de Chlamydia, más típica entre los 5 y 14 días) antes de tratar, y se inicia ceftriaxona sistémica con lavados frecuentes. Se estudia y trata a la madre y su pareja.

441 oftal-02 · Perfil V3 6.02.5.001 · Aplicación de ungüentos · *Práctica*

Se indica ungüento oftálmico de cloranfenicol a un paciente con conjuntivitis bacteriana y se le enseña cómo aplicarlo.

¿Cuál es la técnica correcta?

A) Aplicar el ungüento directamente sobre la córnea con la punta del tubo apoyada en el ojo

B) Aplicar sobre la piel del párpado superior

C) Lavarse las manos, traccionar suavemente el párpado inferior hacia abajo, depositar una franja de 1 cm de ungüento en el fondo de saco conjuntival inferior sin tocar el ojo con el tubo, y cerrar suavemente los párpados

D) Frotar el ojo después de aplicarlo para distribuirlo

E) Aplicar antes de los colirios para que actúen mejor

> **Respuesta C.** El ungüento se aplica con manos limpias en el fondo de saco conjuntival inferior, traccionando el párpado inferior, en una franja de 1 cm, sin que la punta toque el ojo ni las pestañas. Luego se cierra el ojo suavemente, sin frotar. Si se usan colirios, el ungüento va al final, porque impide su absorción.

442 oftal-15 · Perfil V3 6.02.5.003 · Colocación de sello ocular · *Práctica*

Hombre de 30 años, soldador, consulta en el SAPU por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho. Se le extrae un cuerpo extraño corneal superficial y la tinción con fluoresceína muestra una erosión corneal de 2 mm. No usa lentes de contacto. Se decide ocluir el ojo para su traslado y comodidad.

Respecto de la colocación del sello ocular, ¿cuál afirmación es correcta?

A) Se debe ocluir con el ojo abierto para permitir la salida de lágrimas

B) Se recomienda en usuarios de lentes de contacto con erosión corneal

C) Está indicado en toda causticación ocular antes de irrigar

D) Se pone con el párpado cerrado, gasas sobre el ojo y tela adhesiva oblicua desde la frente al pómulo, sin presionar el globo si se sospecha perforación

E) Debe mantenerse al menos 7 días sin retirarlo

> **Respuesta D.** El sello se coloca con el párpado cerrado, gasa doblada sobre el ojo y cintas adhesivas oblicuas de frente a pómulo, firme pero sin presión si existe riesgo de perforación (en ese caso, concha rígida). Está contraindicado en usuarios de lentes de contacto por riesgo de Pseudomonas y nunca reemplaza la irrigación en causticaciones.

443 oftal-09 · Perfil V3 6.02.5.004 · Cover test · *Práctica*

Niño de 3 años; los padres notan que a veces "se le va un ojo". El reflejo corneal es simétrico. Al realizar el cover test, al tapar el ojo izquierdo, el ojo derecho no se mueve; al tapar el ojo derecho, el ojo izquierdo hace un movimiento de afuera hacia adentro para fijar.

¿Cuál es la interpretación del examen?

A) Examen normal

B) Exotropia del ojo izquierdo (estrabismo divergente); derivar a oftalmología

C) Endotropia del ojo izquierdo

D) Pseudoestrabismo por epicanto

E) Exotropia del ojo derecho

> **Respuesta B.** En el cover test (oclusión unilateral) se tapa un ojo y se observa el otro: si el ojo descubierto se mueve para tomar la fijación, estaba desviado. Un movimiento de afuera hacia adentro indica que estaba desviado hacia afuera (exotropia); de adentro hacia afuera, endotropia. Todo estrabismo en un niño se deriva por riesgo de ambliopía.

444 oftal-09 · Perfil V3 6.02.5.006 · Examen de rojo pupilar con oftalmoscopio · *Práctica*

En el control de un lactante de 2 meses se realiza el examen del rojo pupilar con oftalmoscopio directo a 50 cm, en penumbra, iluminando ambos ojos simultáneamente (test de Brückner). El ojo derecho muestra rojo pupilar normal y el izquierdo un reflejo blanco.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el examen en el próximo control a los 6 meses

B) Tranquilizar, porque es normal en lactantes

C) Indicar colirio antibiótico

D) Derivación urgente a oftalmología por leucocoria (descartar catarata congénita y retinoblastoma)

E) Solicitar ecografía cerebral

> **Respuesta D.** El rojo pupilar se examina en todo recién nacido y en los controles de salud. Un reflejo ausente, blanco (leucocoria) o asimétrico obliga a derivación urgente a oftalmología para descartar catarata congénita (que debe operarse precozmente para evitar ambliopía profunda), retinoblastoma, retinopatía del prematuro u otras causas.

445 oftal-15 · Perfil V3 6.02.5.007 · Extracción de cuerpo extraño tarsal · *Práctica*

Mujer de 30 años con sensación de arenilla en el ojo derecho tras andar en bicicleta. Al evertir el párpado superior se observa una partícula negra adherida a la conjuntiva tarsal. La córnea muestra erosiones lineales superficiales con fluoresceína.

¿Cuál es la técnica de extracción más adecuada?

A) Extraer con una aguja de calibre 18 sin anestesia

B) Lavar con agua de la llave y no evertir

C) Bajo anestesia tópica, retirar la partícula con un hisopo de algodón humedecido en suero, luego indicar antibiótico tópico

D) Dejar que salga sola con el parpadeo y control en 48 horas

E) Indicar corticoide tópico y parche

> **Respuesta C.** El cuerpo extraño tarsal superior se extrae evirtiendo el párpado y barriéndolo con un hisopo de algodón húmedo, tras anestesia tópica. Las agujas se reservan para cuerpos extraños corneales incrustados y en manos entrenadas. Después se indica antibiótico tópico y se controla la erosión corneal. Los corticoides tópicos y el uso de anestésico como tratamiento están contraindicados.

446 oftal-03 · Perfil V3 6.02.5.008 · Extracción de pestañas distiquiásicas · *Práctica*

Mujer de 60 años con sensación de cuerpo extraño crónico y ojo rojo derecho. Al examen con lupa se observan 3 pestañas que nacen desde la línea de las glándulas de Meibomio, dirigidas hacia el globo ocular, rozando la córnea, que muestra erosiones puntiformes con fluoresceína.

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Antibiótico tópico crónico

B) Cortar las pestañas con tijera a ras de piel

C) Corticoide tópico

D) Parche ocular permanente

E) Depilación (extracción) de las pestañas aberrantes con pinza y lubricación; derivar para tratamiento definitivo (electrólisis, crioterapia) si recurren

> **Respuesta E.** La distiquiasis (pestañas que nacen de los orificios de las glándulas de Meibomio) roza la córnea y causa erosiones, úlceras y leucomas. El manejo inicial es depilar con pinza bajo lupa y lubricar; como vuelven a crecer en semanas, el tratamiento definitivo destruye el folículo (electrólisis, crioterapia o cirugía). Cortarlas deja una punta rígida dañina.

447 oftal-07 · Perfil V3 6.02.5.009 · Instilación de colirios · *Práctica*

Hombre de 70 años con glaucoma crónico y asma leve inicia timolol en colirio. Se le enseña la técnica de instilación.

¿Cuál es la técnica que además reduce la absorción sistémica del fármaco?

A) Instilar 3 gotas para asegurar el efecto

B) Aplicar 2 colirios distintos al mismo tiempo

C) Parpadear rápidamente varias veces tras la instilación

D) Instilar directamente sobre la córnea con el gotario apoyado

E) Instilar 1 gota en el fondo de saco inferior y luego cerrar los ojos y presionar el canto interno (oclusión del punto lagrimal) durante 1 a 2 minutos

> **Respuesta E.** Se instila 1 gota (el fondo de saco solo retiene una) traccionando el párpado inferior, sin tocar el ojo. Luego se cierran los ojos y se comprime el canto interno 1 a 2 minutos: aumenta el contacto y disminuye el paso a la mucosa nasal, reduciendo efectos sistémicos como broncoespasmo y bradicardia por betabloqueadores.

448 oftal-18 · Perfil V3 6.02.5.011 · Reflejos pupilares · *Práctica*

Hombre de 58 años consulta por caída del párpado derecho y visión doble de 1 día de evolución, con cefalea intensa. Al examen, el ojo derecho está desviado hacia abajo y afuera, con ptosis completa. La pupila derecha mide 7 mm y no reacciona a la luz directa ni consensual; la pupila izquierda mide 3 mm y reacciona a la luz directa y consensual.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de estos hallazgos?

A) Defecto pupilar aferente relativo derecho por neuritis óptica

B) Síndrome de Horner derecho

C) Lesión eferente del tercer par derecho, sospechar aneurisma de comunicante posterior

D) Pupila de Argyll Robertson

E) Anisocoria fisiológica

> **Respuesta C.** Si la pupila afectada no responde ni a la luz directa ni a la consensual, el defecto es eferente (tercer par). Un tercer par con midriasis y cefalea obliga a descartar aneurisma de comunicante posterior con angio-TC urgente. En el defecto aferente, la pupila sí contrae con la luz del ojo sano.

449 oftal-06 · Perfil V3 6.02.5.012 · Tensión ocular palpatoria · *Práctica*

Mujer de 66 años, hipermétrope, consulta en un servicio de urgencia sin tonómetro por dolor ocular izquierdo intenso, náuseas y visión de halos alrededor de las luces. Se decide estimar la presión intraocular por palpación bidigital.

¿Cuál es la técnica e interpretación correctas?

A) Con la paciente mirando hacia abajo y los ojos cerrados, palpar alternadamente con ambos índices sobre el párpado superior, comparando con el otro ojo; un ojo duro como piedra sugiere presión muy elevada

B) Con la paciente mirando hacia arriba, presionar directamente la córnea con ambos índices

C) Presionar el globo ocular con fuerza durante 1 minuto para evaluar el reflejo oculocardíaco

D) Palpar el párpado inferior con la paciente mirando hacia arriba; un ojo blando sugiere glaucoma agudo

E) La palpación permite medir la presión exacta en milímetros de mercurio

> **Respuesta A.** La tensión ocular palpatoria se realiza con la mirada hacia abajo y los párpados cerrados, presionando suave y alternadamente con ambos índices sobre el párpado superior, comparando ambos ojos. Es solo una estimación grosera: un ojo duro como piedra, asimétrico respecto al otro, apoya un glaucoma agudo. Nunca se presiona la córnea.

450 oftal-09 · Perfil V3 6.02.5.013 · Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea) · *Práctica*

Niño de 2 años en control sano. Se ilumina con una linterna desde 30 cm frente a su cara mientras fija la luz. En el ojo derecho el reflejo luminoso corneal está centrado en la pupila; en el ojo izquierdo está desplazado hacia el borde temporal de la pupila.

¿Cuál es la interpretación?

A) Endotropia (estrabismo convergente) del ojo izquierdo

B) Normal

C) Exotropia del ojo izquierdo

D) Hipertropia del ojo derecho

E) Ambliopía sin estrabismo

> **Respuesta A.** En el test de Hirschberg el reflejo corneal debe estar centrado y simétrico. Si en un ojo el reflejo está desplazado hacia temporal, la córnea apunta hacia nasal: endotropia; si está desplazado hacia nasal, exotropia. Cada milímetro de desplazamiento equivale a unos 7 grados de desviación. Ante asimetría se deriva a oftalmología por riesgo de ambliopía.

451 oftal-09 · Perfil V3 6.02.5.014 · Toma de visión · *Práctica*

Niño de 5 años en control de salud escolar. Se toma la agudeza visual con tabla de Snellen (optotipos) a 6 metros, con buena iluminación, cada ojo por separado. Resultado: ojo derecho 20/20 y ojo izquierdo 20/50; con agujero estenopeico el ojo izquierdo mejora a 20/25.

¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?

A) Normal para la edad; control en 2 años

B) Disminución de agudeza visual del ojo izquierdo probablemente por vicio de refracción, con diferencia de 2 o más líneas entre ojos; derivar a oftalmología para refracción por riesgo de ambliopía

C) Ambliopía irreversible; no requiere estudio

D) Catarata; derivar para cirugía

E) Repetir la toma con ambos ojos abiertos

> **Respuesta B.** La agudeza visual se toma monocularmente a la distancia indicada. A los 5 años se espera 20/30 a 20/20; una diferencia de 2 o más líneas entre ojos es anormal. La mejoría con agujero estenopeico indica un vicio de refracción corregible. Por el riesgo de ambliopía (anisometropía), se deriva para refracción y corrección óptica.

Otorrinolaringología

452 orl-13 · Perfil V3 1.01.1.008 · Enfermedad reumática activa · *Práctica*

Un niño de 9 años consulta por dolor e inflamación de la rodilla derecha que luego migra al codo izquierdo y al tobillo, de 5 días de evolución, con fiebre de 38,5 °C. Hace 3 semanas tuvo odinofagia febril que no fue tratada. Al examen se ausculta un soplo holosistólico apical leve, nuevo. La VHS es 80 mm/h y la ASO está elevada.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amoxicilina por 7 días y paracetamol

B) Reposo y AINE por 5 días, sin seguimiento

C) Prednisona sola por 2 semanas, sin antibióticos

D) Ceftriaxona endovenosa por 4 semanas

E) Penicilina benzatina, ácido acetilsalicílico en dosis antiinflamatorias y luego profilaxis secundaria con penicilina benzatina

> **Respuesta E.** Cumple criterios de Jones: poliartritis migratoria y carditis (mayores), fiebre y VHS alta (menores), con infección estreptocócica previa (ASO). Se erradica el estreptococo con penicilina benzatina, se trata la inflamación y se indica profilaxis secundaria prolongada, porque las recurrencias agravan la valvulopatía.

453 orl-13 · Perfil V3 1.01.3.005 · Prevención de enfermedad reumática · *Práctica*

Un niño de 8 años presenta fiebre de 39 °C, odinofagia, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos. El test rápido para estreptococo grupo A es positivo. No tiene alergias.

¿Cuál es el tratamiento que, además de aliviar los síntomas, previene la fiebre reumática?

A) Azitromicina por 3 días

B) Ibuprofeno y control en 48 horas

C) Cefadroxilo por 3 días

D) Amoxicilina por 10 días

E) Amoxicilina por 3 días

> **Respuesta D.** La prevención primaria de la fiebre reumática es tratar la faringoamigdalitis estreptocócica con amoxicilina por 10 días o penicilina benzatina intramuscular en dosis única; previene la enfermedad aun iniciada hasta 9 días después del inicio. Los cursos de 3 días no erradican de forma confiable el estreptococo; los macrólidos se reservan para alérgicos.

454 orl-13 · Perfil V3 1.04.4.014 · Pruebas rápidas para diagnóstico de estreptococo grupo A · *Práctica*

Una niña de 7 años presenta fiebre de 38,8 °C, odinofagia, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas, sin tos ni coriza. El test rápido de antígeno para estreptococo grupo A resulta negativo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar amoxicilina de todas formas

B) Solicitar cultivo faríngeo, por la sensibilidad imperfecta del test rápido en niños

C) Descartar definitivamente la etiología estreptocócica

D) Indicar azitromicina

E) Solicitar ASO

> **Respuesta B.** El test rápido tiene alta especificidad (cerca de 95%), por lo que un positivo permite tratar, pero su sensibilidad es menor (70-90%). En niños, con alta prevalencia de estreptococo y riesgo de fiebre reumática, un negativo con clínica sugerente se confirma con cultivo faríngeo; en adultos no suele ser necesario. La ASO no sirve en el cuadro agudo.

455 orl-09 · Perfil V3 1.05.4.013 · Pruebas cutáneas de alergia · *Práctica*

Un hombre de 28 años con rinorrea acuosa, estornudos y prurito nasal estacionales será sometido a un prick test para identificar alérgenos. Usa loratadina diaria y mometasona intranasal.

¿Cuál es la indicación más adecuada antes del examen?

A) Suspender la loratadina al menos 5 a 7 días antes del test

B) Aumentar la dosis de loratadina el día del examen

C) Suspender el corticoide intranasal 1 mes antes

D) Realizar el test durante una anafilaxia

E) No requiere preparación

> **Respuesta A.** Los antihistamínicos orales inhiben la roncha y causan falsos negativos, por lo que se suspenden 5 a 7 días antes del prick test. El control positivo con histamina verifica que la piel responda y el control negativo con suero descarta dermografismo. Los corticoides intranasales no alteran la prueba. Un positivo indica sensibilización, que debe correlacionarse con la clínica.

456 orl-11 · Perfil V3 2.01.1.099 · Epistaxis · *Práctica*

Un niño de 7 años presenta sangrado nasal por la fosa derecha de 5 minutos, tras rascarse la nariz. Está tranquilo, hemodinámicamente estable y no tiene antecedentes de sangrado ni de uso de fármacos.

¿Cuál es la primera medida?

A) Inclinar la cabeza hacia atrás y aplicar hielo en la frente

B) Taponamiento posterior

C) Compresión digital continua de las alas nasales por 10 minutos, con la cabeza inclinada hacia adelante

D) Cauterización con nitrato de plata como primera medida

E) Solicitar pruebas de coagulación urgentes

> **Respuesta C.** La epistaxis en niños es casi siempre anterior, del plexo de Kiesselbach, gatillada por grataje o sequedad. La primera medida es comprimir las alas nasales contra el tabique en forma continua por 10 minutos, con la cabeza inclinada hacia adelante para no deglutir sangre. Si persiste o recurre se cauteriza.

457 orl-05 · Perfil V3 2.01.1.101 · Hipoacusia · *Práctica*

Una madre pregunta por el tamizaje auditivo de su recién nacido de término sano, que no tiene factores de riesgo de hipoacusia.

¿Cuál es el examen de tamizaje auditivo neonatal más utilizado en recién nacidos sanos?

A) Audiometría tonal

B) Resonancia magnética de oído

C) Impedanciometría

D) Prueba de diapasones

E) Emisiones otoacústicas

> **Respuesta E.** El tamizaje auditivo neonatal busca detectar hipoacusia antes de los 3 meses e intervenir antes de los 6 meses. En recién nacidos sanos se usan las emisiones otoacústicas (rápidas, no invasivas); en prematuros o de alto riesgo se prefieren los potenciales evocados auditivos automatizados, porque detectan neuropatía auditiva. La audiometría tonal requiere cooperación, desde aproximadamente los 4 años.

458 orl-14 · Perfil V3 2.01.2.002 · Absceso amigdalino · *Práctica*

Un adolescente de 15 años con odinofagia de 5 días, tratada con paracetamol, presenta empeoramiento con odinofagia unilateral intensa, fiebre, trismus, sialorrea y voz apagada (en papa caliente). Al examen se observa abombamiento del pilar amigdalino izquierdo con desplazamiento de la úvula hacia la derecha.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amoxicilina oral y control en 48 horas

B) Drenaje del absceso (punción o incisión) y antibiótico

C) Amigdalectomía de urgencia

D) Corticoides endovenosos como único tratamiento

E) Solicitar TAC y diferir el drenaje una semana

> **Respuesta B.** Odinofagia unilateral, trismus, voz en papa caliente y desplazamiento de la úvula contralateral son el absceso periamigdalino, la complicación supurativa más frecuente de la faringoamigdalitis en adolescentes. El tratamiento es drenaje (punción aspirativa o incisión) más antibiótico (ej. amoxicilina-ácido clavulánico o clindamicina) y analgesia. El TAC se reserva si se sospecha extensión profunda.

459 orl-11 · Perfil V3 2.01.2.008 · Epistaxis · *Práctica*

Un adolescente varón de 14 años consulta por epistaxis recurrentes unilaterales por la fosa derecha, abundantes, asociadas a obstrucción nasal progresiva de ese lado en los últimos meses. A la rinoscopía se observa una masa rojiza en la región posterior de la fosa nasal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Biopsia de la masa en el box

B) Cauterización con nitrato de plata

C) Estudio con imágenes (TAC o RM con contraste) y derivación a otorrinolaringología, sin biopsiar

D) Corticoide nasal y control en 3 meses

E) Taponamiento anterior y alta

> **Respuesta C.** Epistaxis recurrente unilateral con obstrucción nasal en un adolescente varón sugiere angiofibroma nasofaríngeo juvenil, un tumor benigno muy vascularizado. Se diagnostica con TAC o RM con contraste y su manejo es quirúrgico, a menudo con embolización previa. La biopsia está contraindicada por el riesgo de hemorragia masiva.

460 orl-15 · Perfil V3 2.01.4.004 · Radiografía de cavum · *Práctica*

Un niño de 4 años ronca todas las noches, respira por la boca, tiene voz nasal y rinorrea persistente. Sus padres han notado pausas respiratorias durante el sueño. A la orofaringe las amígdalas son pequeñas.

¿Qué examen permite evaluar el tamaño del tejido adenoideo?

A) Radiografía de senos paranasales

B) Radiografía de tórax

C) Radiografía lateral de cavum

D) TAC de cerebro

E) Audiometría

> **Respuesta C.** Ronquido, respiración bucal, voz nasal y apneas con amígdalas pequeñas sugieren hipertrofia adenoidea. La radiografía lateral de cavum permite estimar la relación adenoides/nasofaringe y la obstrucción de la vía aérea; también puede usarse la nasofibroscopía. Con SAHOS y adenoides obstructivos, el tratamiento es la adenoidectomía (o adenoamigdalectomía).

461 orl-10 · Perfil V3 2.01.4.008 · Radiografía de senos paranasales · *Práctica*

Un niño de 6 años presenta rinorrea purulenta y tos diurna persistente de 12 días de evolución, sin mejoría. Está afebril y en buenas condiciones generales, sin edema periorbitario. La madre pide una radiografía de senos paranasales.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la radiografía?

A) Solicitarla para confirmar el diagnóstico de sinusitis

B) Solicitar radiografía y esperar el resultado para indicar antibiótico

C) Solicitar TAC de senos paranasales

D) No solicitarla: el diagnóstico de rinosinusitis aguda es clínico

E) Solicitar resonancia magnética

> **Respuesta D.** La rinosinusitis bacteriana aguda en niños se diagnostica clínicamente: síntomas persistentes más de 10 días sin mejoría, empeoramiento tras mejoría inicial o inicio grave. La radiografía de senos paranasales no se recomienda porque tiene baja especificidad (se altera en resfríos comunes) y los senos están en desarrollo. La TAC se reserva para sospecha de complicaciones orbitarias o intracraneanas.

462 orl-19 · Perfil V3 4.01.1.001 · Patología glándulas salivales · *Práctica*

Hombre de 45 años consulta por aumento de volumen submandibular derecho, doloroso, que aparece al comer y cede en 1 a 2 horas, de 3 meses de evolución. Al examen se palpa la glándula submandibular aumentada de tamaño y una induración en el piso de la boca.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parotiditis viral

B) Adenoma pleomorfo

C) Sialolitiasis submandibular

D) Linfadenitis cervical bacteriana

E) Síndrome de Sjögren

> **Respuesta C.** El dolor y aumento de volumen glandular desencadenados por la comida (cólico salival) son típicos de sialolitiasis, que afecta principalmente a la glándula submandibular por su saliva más espesa y su conducto ascendente (Wharton). El adenoma pleomorfo es indoloro y no cambia con la ingesta.

463 orl-15 · Perfil V3 6.03.1.003 · Amigdalitis crónica · *Práctica*

Niño de 8 años con 8 episodios de faringoamigdalitis estreptocócica documentados y tratados en el último año, con ausentismo escolar importante. Entre episodios está asintomático.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Penicilina benzatina mensual indefinida

B) Tratar cada episodio y controlar sin otra medida

C) Derivar a otorrinolaringología para evaluar amigdalectomía

D) Amigdalectomía solo si presenta absceso periamigdalino

E) Solicitar ASO mensual

> **Respuesta C.** La amigdalitis recurrente documentada con 7 o más episodios en 1 año, 5 o más por año en 2 años o 3 o más por año en 3 años (criterios de Paradise) indica evaluar amigdalectomía, al igual que el SAHOS por hipertrofia o el absceso periamigdalino recurrente. La penicilina profiláctica es para prevenir recurrencia de fiebre reumática.

464 orl-20 · Perfil V3 6.03.1.004 · Cáncer de boca, labios y orofaringe · *Práctica*

Un hombre de 64 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor diario, consulta por una úlcera indolora de 1,5 cm, de bordes indurados, en el borde lateral izquierdo de la lengua, de 6 semanas de evolución. Hace 3 semanas se retiró una prótesis dental que la rozaba, pero la lesión no ha cicatrizado. No se palpan adenopatías cervicales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Enjuagues con clorhexidina y control en 3 meses

B) Cauterización con nitrato de plata

C) Aciclovir oral por 7 días

D) Nistatina en suspensión oral

E) Biopsia de la lesión

> **Respuesta E.** Una úlcera, leucoplaquia o eritroplasia que no cicatriza en 2 semanas, sobre todo indurada, en el borde lateral de la lengua de un fumador y bebedor, es un carcinoma escamoso hasta demostrar lo contrario. Se biopsia y se deriva a cabeza y cuello para etapificar. Observar o tratar empíricamente retrasa el diagnóstico.

465 orl-20 · Perfil V3 6.03.1.006 · Cáncer nasosinusal · *Práctica*

Hombre de 62 años, carpintero por 40 años, con obstrucción nasal izquierda progresiva de 4 meses, epistaxis unilateral recurrente, rinorrea fétida y parestesia de la mejilla izquierda. La rinoscopía muestra una masa friable en la fosa nasal izquierda.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Corticoide nasal y control en 3 meses

B) Antibiótico por sinusitis bacteriana

C) Cauterización de la epistaxis y alta

D) Derivación prioritaria a otorrinolaringología para TAC o RM de cavidades paranasales y biopsia por sospecha de cáncer nasosinusal

E) Polipectomía en atención primaria

> **Respuesta D.** Síntomas nasales unilaterales y progresivos (obstrucción, epistaxis, rinorrea fétida) con signos de invasión (hipoestesia del infraorbitario, diplopía, proptosis) en un adulto mayor son banderas rojas de cáncer nasosinusal. La exposición a polvo de madera se asocia a adenocarcinoma etmoidal. Requiere imagen y biopsia. Los pólipos inflamatorios suelen ser bilaterales.

466 orl-11 · Perfil V3 6.03.1.011 · Epistaxis a repetición · *Práctica*

Niño de 9 años con episodios de epistaxis anterior derecha 2 a 3 veces por semana en el último mes, autolimitados con compresión, especialmente en invierno. Se rasca la nariz con frecuencia. Al examen hay vasos prominentes y costras en el área de Kiesselbach derecha. Sin hematomas ni otros sangrados, hemograma normal.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Taponamiento posterior

B) Humectación nasal (vaselina o suero), evitar el rascado y cauterización química con nitrato de plata del área de Kiesselbach si persiste

C) Estudio de coagulación completo y derivación a hematología de inmediato

D) Ligadura de la arteria esfenopalatina

E) TAC de cavidades paranasales

> **Respuesta B.** La epistaxis recurrente anterior en niños se origina en el plexo de Kiesselbach, favorecida por sequedad, rascado y rinitis. Se maneja con humectación, tratamiento de la rinitis y cauterización con nitrato de plata de los vasos visibles. Se estudia coagulación ante sangrados en otros sitios, antecedentes familiares o anemia; en un adolescente varón con epistaxis unilateral grave, sospechar nasoangiofibroma.

467 orl-12 · Perfil V3 6.03.1.016 · Obstrucción nasal crónica · *Práctica*

Un hombre de 32 años consulta por obstrucción nasal derecha constante de varios años, que no fluctúa, sin estornudos, prurito ni rinorrea. En la adolescencia tuvo un golpe en la nariz. A la rinoscopía anterior, el tabique está desviado hacia la derecha y contacta el cornete inferior; en la fosa izquierda hay hipertrofia del cornete inferior. No hay pólipos.

¿Cuál es el tratamiento definitivo?

A) Oximetazolina nasal diaria

B) Septoplastia electiva, con turbinoplastia del cornete hipertrófico

C) Polipectomía endoscópica

D) Antihistamínicos orales por 3 meses

E) Amoxicilina con ácido clavulánico por 14 días

> **Respuesta B.** Obstrucción unilateral, fija y constante tras un trauma, con tabique desviado, es una desviación septal. Los corticoides intranasales alivian el componente mucoso, pero la corrección definitiva es la septoplastia electiva, asociando turbinoplastia del cornete compensatorio. Los descongestionantes de uso crónico producen rinitis medicamentosa.

468 orl-13 · Perfil V3 6.03.1.017 · Odinofagias agudas · *Práctica*

Una mujer de 24 años consulta por odinofagia de 2 días, con temperatura de 37,8 °C, rinorrea, tos, disfonía y conjuntivas enrojecidas. Al examen tiene faringe eritematosa sin exudado y no hay adenopatías cervicales dolorosas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amoxicilina oral por 10 días

B) Penicilina benzatina intramuscular

C) Tratamiento sintomático, hidratación y consulta si aparecen signos de alarma

D) Hemograma y serología para virus Epstein-Barr

E) Azitromicina oral por 5 días

> **Respuesta C.** La mayoría de las odinofagias agudas son virales. Tos, rinorrea, disfonía y conjuntivitis orientan a virus, y con McIsaac de 0 no se estudia ni se dan antibióticos: solo sintomáticos. Se educa en signos de alarma: trismus, sialorrea, voz apagada, disnea o fiebre que persiste más de 3 a 5 días.

469 orl-20 · Perfil V3 6.03.1.018 · Odinofagias crónicas · *Práctica*

Hombre de 60 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor intenso, con odinofagia derecha de 2 meses, otalgia refleja derecha y baja de 6 kg de peso. No tiene fiebre. Se palpa una adenopatía cervical derecha dura de 3 cm.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amoxicilina por 10 días y control

B) Ecografía tiroidea

C) Inhibidor de bomba de protones por reflujo

D) Antiinflamatorios y control en 3 meses

E) Derivación prioritaria a otorrinolaringología para nasofibrolaringoscopía y biopsia por sospecha de cáncer de orofaringe, hipofaringe o laringe

> **Respuesta E.** La odinofagia persistente (más de 3 semanas), unilateral, con otalgia refleja, baja de peso y adenopatía cervical dura en un fumador y bebedor es un carcinoma escamoso de cabeza y cuello hasta demostrar lo contrario. Requiere examen endoscópico, biopsia de la lesión primaria y TAC cervical con contraste. No se debe tratar empíricamente con antibióticos de forma reiterada.

470 orl-06 · Perfil V3 6.03.1.031 · Tinitus · *Práctica*

Mujer de 55 años con tinnitus en el oído izquierdo de 6 meses, asociado a hipoacusia progresiva del mismo lado y leve inestabilidad. La otoscopía es normal. La audiometría muestra hipoacusia sensorioneural izquierda con discriminación de palabras desproporcionadamente baja.

¿Cuál es el estudio más adecuado?

A) Ninguno; indicar enmascaradores de ruido

B) TAC de oídos sin contraste

C) Resonancia magnética de conductos auditivos internos y ángulo pontocerebeloso con gadolinio

D) Ecografía Doppler carotídea

E) Impedanciometría

> **Respuesta C.** El tinnitus unilateral con hipoacusia sensorioneural asimétrica y mala discriminación es la forma de presentación típica del schwannoma vestibular (neurinoma del acústico). Debe estudiarse con resonancia magnética con gadolinio de conductos auditivos internos. El tinnitus pulsátil orienta a causas vasculares. El tinnitus bilateral con presbiacusia simétrica no requiere imágenes.

471 orl-18 · Perfil V3 6.03.2.007 · Cuerpo extraño en el oído · *Práctica*

Un niño de 5 años se introdujo un poroto en el oído derecho hace 1 día. Coopera con el examen. A la otoscopía se observa un cuerpo extraño redondo y liso que ocupa el conducto auditivo externo, sin visualizar el tímpano.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Extracción en seco con gancho romo o microaspiración bajo visión directa, derivando a otorrinolaringología si falla

B) Lavado ótico con agua tibia

C) Gotas de agua oxigenada para disolverlo

D) Extracción con pinza cocodrilo

E) Esperar su expulsión espontánea

> **Respuesta A.** Semillas y legumbres absorben agua y se hinchan, así que el lavado está prohibido. Se extraen en seco, con gancho romo pasado por detrás del objeto o con microaspirador, bajo visión. La pinza resbala sobre un objeto redondo y lo empuja hacia el tímpano. Si el niño no coopera o falla el intento, se deriva para extracción bajo microscopio.

472 orl-18 · Perfil V3 6.03.2.008 · Cuerpo extraño en el esófago · *Práctica*

Un niño de 2 años es traído a urgencia porque hace 1 hora se tragó una pila de botón del control remoto. Presenta sialorrea y rechaza los líquidos, sin dificultad respiratoria. La radiografía muestra una imagen redonda radiopaca con doble contorno en el tercio superior del esófago.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Esperar 24 horas a que pase al estómago y controlar con radiografía

B) Dar una bebida carbonatada para empujarla al estómago

C) Inducir el vómito

D) Indicar laxantes y revisar las deposiciones

E) Endoscopía digestiva alta de urgencia para extraer la pila de inmediato

> **Respuesta E.** Una pila de botón en el esófago es una emergencia: la corriente eléctrica produce necrosis por licuefacción en unas 2 horas, con riesgo de perforación y de fístula traqueoesofágica o aortoesofágica. Se extrae por endoscopía urgente. El doble contorno la distingue de una moneda. Inducir el vómito está contraindicado.

473 orl-18 · Perfil V3 6.03.2.009 · Cuerpo extraño en vía aérea · *Práctica*

Un niño de 3 años, mientras comía maní, presentó tos asfíctica súbita con cianosis que cedió en pocos minutos. Ahora tiene tos ocasional, está eupneico y saturando 96%. Al examen hay murmullo pulmonar disminuido y sibilancias localizadas en la base derecha. La radiografía en inspiración y espiración muestra atrapamiento aéreo en el pulmón derecho.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Salbutamol inhalado y alta con control

B) Broncoscopía rígida urgente en pabellón, bajo anestesia general

C) Fibrobroncoscopía flexible ambulatoria en 2 semanas

D) Kinesioterapia respiratoria con drenaje postural

E) Amoxicilina oral y control en 7 días

> **Respuesta B.** Un síndrome de penetración seguido de signos focales (hipoventilación y sibilancias unilaterales) y atrapamiento aéreo es aspiración de cuerpo extraño hasta demostrar lo contrario, incluso con radiografía normal. La conducta es la broncoscopía rígida urgente, diagnóstica y terapéutica. La kinesioterapia puede movilizar el cuerpo extraño y obstruir la vía aérea.

474 orl-12 · Perfil V3 6.03.2.012 · Fractura nasal reciente · *Práctica*

Un hombre de 22 años recibió un puñetazo en la nariz hace 2 horas. Tuvo epistaxis que ya cedió. Al examen hay edema y dolor del dorso nasal, laterorrinia hacia la izquierda y crepitación ósea. En la rinoscopía anterior el tabique no está abombado, la mucosa es normal y no hay hematoma septal. Respira bien por ambas fosas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Radiografía de huesos propios para decidir la cirugía

B) Reducción abierta urgente hoy en pabellón

C) Esperar 3 meses y realizar rinoseptoplastia

D) Drenaje del tabique nasal

E) Frío local, analgesia y reevaluación por otorrinolaringología a los 5 a 7 días, para reducción cerrada si persiste la deformidad

> **Respuesta E.** En la fractura nasal lo urgente es descartar un hematoma septal, ya hecho. Si no hay hematoma, se indica frío y analgesia, y se reevalúa cuando baja el edema, a los 5 a 7 días, para reducción cerrada antes de las 2 semanas. El diagnóstico es clínico; la radiografía solo tiene valor médico-legal.

475 orl-09 · Perfil V3 6.03.3.003 · Prevención de alergias nasosinusales · *Práctica*

Niño de 10 años con rinitis alérgica persistente moderada, con pruebas cutáneas positivas solo para ácaros del polvo doméstico (Dermatophagoides).

¿Cuál de las siguientes medidas de control ambiental es más adecuada?

A) Mantener alfombras y peluches en el dormitorio

B) Uso de antibióticos profilácticos en invierno

C) Evitar el consumo de leche

D) Mantener la casa cerrada y sin ventilar

E) Usar fundas antiácaros en colchón y almohada, lavar ropa de cama semanalmente con agua caliente, reducir alfombras y peluches y mantener baja la humedad del dormitorio

> **Respuesta E.** La prevención en rinitis alérgica se basa en identificar y evitar el alérgeno. Para ácaros se recomiendan fundas antiácaros, lavado de ropa de cama con agua caliente, retirar alfombras, cortinas gruesas y peluches del dormitorio, ventilar y reducir la humedad, además de evitar el humo de tabaco. Se combina con corticoide intranasal e inmunoterapia en casos seleccionados.

476 orl-20 · Perfil V3 6.03.3.004 · Prevención de cáncer laríngeo · *Práctica*

Hombre de 50 años, fumador de 30 paquetes-año y consumidor de alcohol diario, consulta en APS por un control preventivo. No tiene síntomas.

¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir el cáncer de laringe en este paciente?

A) Nasofibrolaringoscopía anual de tamizaje

B) Antiinflamatorios diarios

C) Vitamina E diaria

D) Cesación tabáquica y reducción del consumo de alcohol

E) Reposo vocal

> **Respuesta D.** El tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer de laringe y el alcohol potencia su efecto en forma sinérgica. La prevención primaria es la cesación tabáquica y la reducción del alcohol. No existe tamizaje poblacional recomendado; la clave es la detección precoz de síntomas: toda disfonía de más de 3 semanas en un fumador debe evaluarse con laringoscopía.

477 orl-18 · Perfil V3 6.03.3.005 · Prevención de cuerpo extraño en niños · *Práctica*

En el control sano de los 12 meses, la madre pregunta qué alimentos y objetos debe evitar para prevenir la aspiración de cuerpos extraños.

¿Cuál es la recomendación más adecuada?

A) Ofrecer maní y frutos secos enteros desde el año para estimular la masticación

B) Evitar frutos secos enteros, uvas y salchichas enteras, caramelos duros y juguetes con piezas pequeñas hasta al menos los 4 a 5 años, y supervisar siempre la alimentación sentado

C) Permitir que coma mientras corre para que no se distraiga

D) Los juguetes con pilas de botón son seguros si están cerrados con pegamento

E) Solo los globos de látex son peligrosos

> **Respuesta B.** La aspiración de cuerpo extraño es más frecuente entre 1 y 3 años. Se previene evitando frutos secos enteros, semillas, uvas y salchichas enteras (cortarlas en trozos pequeños longitudinalmente), dulces duros, globos y objetos pequeños; con pilas de botón en compartimentos asegurados con tornillo; y comiendo sentado y supervisado, sin correr ni reír con comida en la boca.

478 orl-03 · Perfil V3 6.03.3.006 · Prevención de otitis externa · *Práctica*

Nadador de 16 años con 3 episodios de otitis externa difusa en el último verano, tratados con gotas antibióticas. Consulta para prevenir nuevos episodios.

¿Cuál es la recomendación más adecuada?

A) Limpiar diariamente el conducto con cotonito después de nadar

B) Secar el pabellón y la entrada del conducto tras nadar (inclinando la cabeza o con secador a baja temperatura), usar tapones y evitar introducir cotonitos u objetos

C) Usar gotas antibióticas profilácticas diarias durante todo el verano

D) Lavarse los oídos con agua a presión semanalmente

E) Antibiótico oral profiláctico

> **Respuesta B.** La otitis externa se favorece por la humedad, la pérdida del cerumen protector y el trauma del conducto (cotonitos, rascado). Se previene manteniendo el conducto seco tras el baño (inclinar la cabeza, secador tibio, gotas acidificantes o alcohol boricado si no hay perforación), usando tapones y evitando la manipulación. Los antibióticos profilácticos favorecen resistencia y otomicosis.

479 orl-06 · Perfil V3 6.03.3.007 · Prevención de trauma acústico y daño por exposición a ruidos · *Práctica*

Un hombre de 30 años ingresa a trabajar a una maestranza donde el ruido medido en su puesto es de 92 dB durante la jornada de 8 horas. Su audiometría de ingreso es normal y no tiene síntomas.

¿Cuál es la medida preventiva más adecuada?

A) Protectores auditivos durante toda la exposición y audiometrías periódicas de vigilancia

B) Ninguna, hasta que aparezca hipoacusia

C) Corticoides orales profilácticos en los períodos de más ruido

D) Audífonos desde el ingreso

E) Lavados óticos mensuales

> **Respuesta A.** Sobre 85 dB por 8 horas hay riesgo de hipoacusia laboral, cuyo daño no revierte. Se previene reduciendo el ruido en la fuente, usando protectores auditivos durante toda la exposición y vigilando con audiometrías periódicas (protocolo PREXOR del MINSAL), buscando precozmente la muesca en 4000 Hz.

480 orl-10 · Perfil V3 6.03.4.001 · Radiografía de cavidades perinasales · *Práctica*

Mujer de 30 años con rinorrea purulenta, congestión nasal y dolor facial maxilar de 4 días, tras un resfrío. Afebril, en buen estado general, sin signos orbitarios ni neurológicos. Solicita una radiografía de cavidades perinasales.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a las imágenes?

A) No solicitar imágenes; el diagnóstico de rinosinusitis aguda es clínico, y las imágenes se reservan para complicaciones, falla de tratamiento o enfermedad crónica

B) Radiografía de cavidades perinasales para confirmar sinusitis

C) TAC de cavidades perinasales urgente

D) Resonancia magnética

E) Radiografía de cavum

> **Respuesta A.** La rinosinusitis aguda es un diagnóstico clínico. La radiografía de cavidades perinasales tiene baja sensibilidad y especificidad (el velamiento también ocurre en resfríos virales) y no cambia el manejo. Si se requiere imagen (complicación orbitaria o intracraneana, cronicidad, planificación quirúrgica), el examen de elección es la TAC.

481 orl-10 · Perfil V3 6.03.4.003 · TAC de cavidades perinasales · *Práctica*

Niño de 7 años con rinosinusitis aguda de 5 días que presenta edema palpebral izquierdo, proptosis, dolor a la movilización ocular y disminución de la agudeza visual. Temperatura 39 °C.

¿Cuál es el examen de imagen de elección?

A) Radiografía de cavidades perinasales

B) Ecografía ocular

C) TAC de cavidades perinasales y órbitas con contraste

D) Radiografía de cavum

E) No requiere imágenes

> **Respuesta C.** Proptosis, oftalmoplejía dolorosa y disminución visual en un niño con sinusitis indican celulitis orbitaria o absceso subperióstico, complicaciones de la etmoiditis. Requiere TAC de cavidades perinasales y órbitas con contraste urgente para identificar abscesos que necesitan drenaje, antibióticos endovenosos y evaluación por ORL y oftalmología. La TAC es también el examen para sinusitis crónica y planificación quirúrgica.

482 orl-14 · Perfil V3 6.03.4.004 · TAC cervical con contraste · *Práctica*

Hombre de 35 años con odontalgia molar inferior hace 1 semana, ahora con fiebre de 39 °C, trismus, aumento de volumen submandibular y cervical lateral izquierdo doloroso y odinofagia. Sin estridor ni dificultad respiratoria.

¿Cuál es el examen de elección para evaluar este cuadro?

A) Radiografía de cuello lateral

B) Ecografía Doppler carotídea

C) TAC de cuello con contraste endovenoso

D) Resonancia magnética sin contraste

E) Panorámica dental exclusivamente

> **Respuesta C.** La sospecha de infección profunda del cuello (absceso parafaríngeo, submandibular, angina de Ludwig) requiere TAC cervical con contraste: distingue celulitis de absceso, muestra su extensión (mediastino) y su relación con la vía aérea y los vasos. Se acompaña de antibióticos endovenosos y drenaje si hay colección. Antes, siempre asegurar la vía aérea.

483 orl-02 · Perfil V3 6.03.4.005 · TAC de oídos sin medio de contraste · *Práctica*

Hombre de 40 años con otorrea fétida crónica del oído derecho e hipoacusia progresiva. La otoscopía muestra una perforación timpánica marginal posterosuperior con material blanquecino descamativo. Se planifica cirugía.

¿Cuál es el examen de imagen de elección para evaluar la extensión de la lesión?

A) Audiometría solamente

B) Radiografía de Schüller

C) Resonancia magnética de cerebro con contraste como primer examen

D) Ecografía de mastoides

E) TAC de oídos (hueso temporal) sin medio de contraste

> **Respuesta E.** Una perforación marginal o atical con escamas blanquecinas y otorrea fétida es un colesteatoma. La TAC de hueso temporal sin contraste, de alta resolución, es el examen de elección para evaluar la erosión ósea (cadena osicular, canal semicircular lateral, tegmen, canal del facial) y planificar la cirugía. La resonancia se usa ante sospecha de complicación intracraneana o recidiva.

484 orl-09 · Perfil V3 6.03.4.010 · Pruebas cutáneas de alergia · *Práctica*

Mujer de 25 años con rinitis persistente con estornudos, prurito nasal y rinorrea acuosa. Se solicitan pruebas cutáneas de alergia (prick test) para identificar alérgenos.

¿Cuál de los siguientes fármacos debe suspenderse días antes del examen porque produce falsos negativos?

A) Corticoide intranasal

B) Antihistamínicos orales (por ejemplo, loratadina o cetirizina)

C) Paracetamol

D) Lavados nasales con suero fisiológico

E) Anticonceptivos orales

> **Respuesta B.** El prick test detecta sensibilización mediada por IgE con alta sensibilidad; se usa control positivo (histamina) y negativo. Los antihistamínicos H1 suprimen la roncha y deben suspenderse alrededor de 5 a 7 días antes, al igual que algunos antidepresivos tricíclicos. Los corticoides intranasales no interfieren. Un resultado positivo debe correlacionarse con la clínica.

485 orl-06 · Perfil V3 6.03.4.011 · Estudio de VIII par · *Práctica*

Hombre de 45 años con hipoacusia súbita del oído izquierdo de 2 días, con tinnitus y sensación de oído tapado. Otoscopía normal. Weber lateraliza a la derecha y Rinne positivo bilateral.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lavado de oídos

B) Antibiótico oral

C) Audiometría urgente, corticoides sistémicos precoces y resonancia magnética de conductos auditivos internos con gadolinio para descartar patología retrococlear

D) Observación por 1 mes

E) Descongestionante nasal

> **Respuesta C.** Weber hacia el oído sano con Rinne positivo indica hipoacusia sensorioneural del oído afectado. La hipoacusia sensorioneural súbita es una urgencia: se confirma con audiometría, se inician corticoides sistémicos precozmente y se estudia el VIII par con resonancia con gadolinio por la posibilidad de schwannoma vestibular. El estudio puede complementarse con potenciales evocados auditivos.

486 orl-04 · Perfil V3 6.03.5.001 · Drenaje de absceso mastoídeo · *Práctica*

Un niño de 3 años, con otitis media aguda izquierda hace 10 días, presenta fiebre de 39 °C, tumefacción retroauricular fluctuante y pabellón auricular desplazado hacia adelante. Lleva 24 horas con ceftriaxona endovenosa. El TAC de peñasco con contraste muestra ocupación de las celdillas mastoídeas y un absceso subperióstico de 2 cm, sin complicaciones intracraneales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cambiar a amoxicilina con ácido clavulánico oral y dar de alta

B) Mastoidectomía radical con vaciamiento del oído medio

C) Mastoidectomía simple con drenaje del absceso, miringotomía y mantener el antibiótico endovenoso

D) Solo gotas óticas de ciprofloxacino

E) Observar 7 días más con el mismo antibiótico, sin procedimientos

> **Respuesta C.** Un absceso subperióstico documentado es indicación de cirugía: mastoidectomía simple, cortical, con drenaje de la colección, junto con miringotomía para descomprimir el oído medio y cultivar, manteniendo el antibiótico endovenoso. La mastoidectomía radical es para el colesteatoma, no para la mastoiditis aguda.

487 orl-14 · Perfil V3 6.03.5.003 · Drenaje de absceso retrofaríngeo · *Práctica*

Niño de 3 años con fiebre alta, odinofagia, sialorrea, rechazo alimentario y tortícolis con dolor a la extensión del cuello, tras una infección respiratoria alta. La radiografía lateral de cuello muestra aumento del espacio prevertebral. La TAC con contraste confirma una colección retrofaríngea con realce periférico de 2,5 cm. Respira sin dificultad.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Antibiótico oral y control ambulatorio

B) Amigdalectomía de urgencia

C) Punción del absceso en el servicio de urgencia por vía externa

D) Corticoides y observación

E) Hospitalización, antibióticos endovenosos y drenaje quirúrgico (habitualmente transoral) por otorrinolaringología, con protección de la vía aérea

> **Respuesta E.** El absceso retrofaríngeo predomina bajo los 5 años, por supuración de ganglios retrofaríngeos: fiebre, odinofagia, tortícolis o limitación de la extensión y espacio prevertebral aumentado. Se hospitaliza con antibióticos endovenosos (amoxicilina-clavulánico o clindamicina) y, si hay colección significativa, se drena en pabellón por vía transoral con la vía aérea protegida.

488 orl-12 · Perfil V3 6.03.5.004 · Drenaje de hematoma nasoseptal · *Práctica*

Adolescente de 15 años recibe un golpe nasal jugando fútbol hace 24 horas. Presenta obstrucción nasal bilateral completa y dolor. La rinoscopía anterior muestra un abombamiento violáceo, blando y fluctuante a ambos lados del tabique.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reducción de la fractura nasal en 7 días y antiinflamatorios

B) Corticoide oral

C) Descongestionante nasal y control en 48 horas

D) Drenaje urgente del hematoma septal, taponamiento nasal anterior bilateral y antibiótico

E) Esperar reabsorción espontánea

> **Respuesta D.** El hematoma septal separa el mucopericondrio del cartílago, que depende de él para su nutrición. Sin drenaje urgente se produce necrosis del cartílago, absceso septal y deformidad en silla de montar. Se drena mediante incisión, se coloca taponamiento anterior para evitar la recolección y se indica antibiótico antiestafilocócico. Toda fractura nasal requiere examinar el tabique.

489 orl-18 · Perfil V3 6.03.5.006 · Extracción de cuerpo extraño del oído · *Práctica*

Niño de 4 años con un poroto seco introducido en el conducto auditivo externo derecho hace 1 día. Coopera parcialmente. La otoscopía muestra el cuerpo extraño en la porción lateral del conducto, con tímpano no visible.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lavado de oído con agua tibia a presión

B) Extraerlo con pinza de punta lisa empujando hacia adentro

C) Instilar gotas de agua para ablandarlo

D) Extracción bajo visión directa con gancho o cureta, pasando por detrás del objeto, o derivar a ORL si no coopera o el objeto está en la porción medial

E) Esperar expulsión espontánea

> **Respuesta D.** Los cuerpos extraños del oído se extraen bajo visión directa con gancho o cureta pasado por detrás del objeto, con el niño inmovilizado o sedado. Las semillas y granos no se lavan con agua porque se hinchan. Las pinzas pueden empujar objetos redondos hacia el tímpano. Las pilas de botón son una urgencia.

490 orl-18 · Perfil V3 6.03.5.007 · Extracción de cuerpo extraño nasal · *Práctica*

Niño de 3 años con rinorrea purulenta, fétida y unilateral derecha de 2 semanas que no ha mejorado con antibióticos. A la rinoscopía anterior se ve un objeto plástico en la fosa nasal anterior derecha.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir antibióticos por 10 días

B) Extracción del cuerpo extraño bajo visión directa con gancho romo o pinza, previa vasoconstricción tópica, o con técnica de presión positiva ("beso de la madre"), derivando si no se logra

C) Instilar suero para empujar el objeto hacia la faringe

D) TAC de cavidades perinasales y control

E) Lavado nasal a presión

> **Respuesta B.** La rinorrea unilateral fétida en un niño es un cuerpo extraño nasal hasta demostrar lo contrario. Se extrae bajo visión directa con gancho romo o pinza, con vasoconstrictor tópico e inmovilización, o con presión positiva por la boca ocluyendo la fosa contralateral. Empujarlo hacia atrás arriesga aspiración. Pilas de botón e imanes son urgentes.

491 orl-16 · Perfil V3 6.03.5.009 · Laringoscopía indirecta · *Práctica*

Un hombre de 58 años, fumador, consulta en un servicio de urgencia rural por disfonía de 5 semanas. No hay nasofibroscopio disponible, por lo que decides examinar su laringe mediante laringoscopía indirecta con espejo laríngeo.

¿Cuál es la técnica correcta?

A) Paciente en decúbito supino con el cuello flectado y el espejo frío

B) Pedir al paciente que trague durante el examen para ver las cuerdas vocales

C) Introducir el espejo hasta apoyarlo en la pared posterior de la faringe para ver mejor

D) Paciente sentado e inclinado hacia adelante, lengua traccionada con una gasa, espejo entibiado apoyado en la úvula y el velo, pidiéndole que diga «i»

E) Si la laringoscopía indirecta es normal, se descarta un cáncer laríngeo y no requiere derivación

> **Respuesta D.** En la laringoscopía indirecta el paciente se sienta erguido e inclinado hacia adelante; se tracciona la lengua con una gasa, se entibia el espejo para que no se empañe y se apoya en la úvula, sin tocar la faringe, para no gatillar náuseas. Al decir «i» las cuerdas se aducen. Una disfonía persistente en fumador igual se deriva a otorrinolaringología.

492 orl-03 · Perfil V3 6.03.5.010 · Lavado de oídos · *Práctica*

Hombre de 60 años con hipoacusia derecha de 1 semana. La otoscopía muestra un tapón de cerumen que ocluye el conducto. Se planifica lavado de oído.

¿Cuál de los siguientes antecedentes contraindica el lavado?

A) Antecedente de perforación timpánica o cirugía de oído

B) Hipertensión arterial

C) Uso de audífonos

D) Edad mayor de 60 años

E) Tapón de cerumen duro

> **Respuesta A.** El lavado de oídos con agua a temperatura corporal (para no provocar vértigo) es eficaz para tapones de cerumen. Está contraindicado ante perforación timpánica conocida o sospechada, cirugía otológica previa, otitis con otorrea, cuerpos extraños vegetales o pilas. El cerumen duro se ablanda antes con gotas cerumenolíticas.

493 orl-11 · Perfil V3 6.03.5.012 · Taponamiento nasal anterior · *Práctica*

Una mujer de 45 años consulta por epistaxis izquierda activa de 30 minutos. Está hemodinámicamente estable. Se realizó compresión bidigital por 15 minutos con la cabeza hacia adelante y luego se dejó un algodón con vasoconstrictor, pero persiste el sangrado y con espéculo nasal no se logra ubicar el vaso sangrante. No cae sangre por la orofaringe.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cauterización a ciegas con nitrato de plata de ambos lados del tabique

B) Ligadura quirúrgica de la arteria esfenopalatina

C) Taponamiento posterior con sonda Foley

D) Taponamiento nasal anterior con gasa vaselinada o Merocel por 48 horas

E) Inclinar la cabeza hacia atrás y dar de alta

> **Respuesta D.** Si la compresión y el vasoconstrictor fallan y no se ubica el vaso para cauterizarlo, sigue el taponamiento anterior: gasa orillada con vaselina en capas hacia el piso de la fosa nasal, o Merocel, por 48 horas, con control ambulatorio. El taponamiento posterior se reserva para cuando falla el anterior y la sangre cae a la faringe.

Pediatría

494 ped-01 · Perfil V3 1.02.3.008 · Prevención de la obesidad · *Práctica*

En el control de salud de un niño de 4 años, el IMC está en percentil 80 (normal). Los padres refieren que toma bebidas azucaradas a diario y ve pantallas 4 horas al día.

¿Cuál es la intervención preventiva más adecuada?

A) Indicar una dieta hipocalórica estricta

B) Consejería familiar: reemplazar bebidas azucaradas por agua, limitar pantallas a 1 hora diaria y promover juego activo diario

C) Iniciar metformina

D) Derivar a cirugía

E) No intervenir, porque aún no tiene sobrepeso

> **Respuesta B.** La prevención de la obesidad infantil se basa en cambiar hábitos de toda la familia: agua en vez de bebidas azucaradas, frutas y verduras, comidas en familia, al menos 60 minutos diarios de actividad física y limitar pantallas (máximo 1 hora en preescolares). Esperar el sobrepeso pierde la oportunidad preventiva; las dietas restrictivas no se indican en niños.

495 ped-03 · Perfil V3 1.04.3.013 · Vacunas incluidas en el PNI (Plan Nacional de Inmunizaciones) · *Práctica*

Una mujer de 26 años, con 12 semanas de embarazo, consulta por su calendario de vacunas. No recuerda haber recibido la vacuna contra el sarampión.

¿Cuál de las siguientes vacunas del PNI es de virus vivos atenuados y está contraindicada durante el embarazo?

A) Tres vírica (sarampión, rubéola y parotiditis)

B) dTpa

C) Influenza inactivada

D) Hepatitis B

E) Neumocócica conjugada

> **Respuesta A.** La tres vírica es de virus vivos atenuados y está contraindicada en el embarazo; se administra en el postparto. En la gestante, el PNI indica influenza inactivada en campaña y dTpa desde la semana 28, para proteger al recién nacido de la tos convulsiva. Las vacunas inactivadas son seguras en el embarazo.

496 ped-05 · Perfil V3 1.04.4.005 · Detección de agentes virales por inmunofluorescencia · *Práctica*

Un lactante de 4 meses es hospitalizado en julio por bronquiolitis con requerimiento de oxígeno. Se solicita panel viral por inmunofluorescencia en aspirado nasofaríngeo.

¿Cuál es la principal utilidad de este examen en este paciente?

A) Decidir el uso de antibióticos de rutina

B) Identificar el virus (VRS, influenza, adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus) para aislar y cohortar pacientes, y para vigilancia epidemiológica

C) Confirmar el diagnóstico de bronquiolitis, que no puede hacerse sin él

D) Indicar corticoides

E) Evaluar la gravedad del cuadro

> **Respuesta B.** La bronquiolitis es un diagnóstico clínico. En hospitalizados, la inmunofluorescencia del aspirado nasofaríngeo identifica el virus en horas, lo que permite cohortar pacientes, aplicar precauciones de contacto o gotitas y hacer vigilancia epidemiológica; si muestra influenza, orienta a oseltamivir. No define la gravedad ni justifica antibióticos o corticoides.

497 ped-13 · Perfil V3 1.04.4.017 · Urocultivo y antibiograma · *Práctica*

Una lactante de 8 meses, sin control de esfínter, presenta fiebre de 39 °C sin foco de 2 días de evolución. Se sospecha infección urinaria.

¿Cuál es el método más adecuado para obtener la muestra de urocultivo?

A) Bolsa recolectora adhesiva

B) No es necesario urocultivo si la tira reactiva es positiva

C) Muestra obtenida del pañal

D) Orina de segundo chorro espontánea

E) Cateterismo vesical (sondeo) con técnica estéril

> **Respuesta E.** En niños sin control de esfínter, el urocultivo se toma por cateterismo vesical (o punción suprapúbica) con técnica estéril. La bolsa recolectora tiene alta tasa de contaminación y falsos positivos; solo es útil si resulta negativa. El urocultivo es indispensable para confirmar la ITU y guiar el antibiótico; la tira reactiva solo orienta.

498 ped-08 · Perfil V3 1.05.2.002 · Aspiración de cuerpo extraño con asfixia · *Práctica*

Un hombre de 50 años se atraganta con un trozo de carne en un restaurante. Se toma el cuello, no puede hablar ni toser y está cianótico. Tras varias compresiones abdominales, pierde la conciencia y cae al suelo.

¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Continuar las compresiones abdominales en el suelo

B) Darle agua para desatascar

C) Realizar barrido digital a ciegas

D) Esperar a que recupere la conciencia

E) Activar el sistema de emergencia e iniciar RCP con compresiones torácicas, revisando la boca antes de ventilar

> **Respuesta E.** En la obstrucción completa de vía aérea con paciente consciente se hacen compresiones abdominales. Si pierde la conciencia, se activa la emergencia y se inicia RCP con compresiones torácicas, que también ayudan a expulsar el cuerpo extraño. Antes de ventilar se mira la boca y se retira el objeto solo si es visible; el barrido digital a ciegas está contraindicado.

499 ped-08 · Perfil V3 1.05.2.003 · Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia · *Práctica*

Un niño de 2 años, mientras comía maní, presentó un episodio súbito de tos intensa y ahogo. Ahora está consciente, rosado, tose en forma efectiva y llora. A la auscultación hay disminución del murmullo pulmonar y sibilancias en el hemitórax derecho.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar la maniobra de Heimlich de inmediato

B) No interferir con su tos y derivar para broncoscopía rígida

C) Dar golpes interescapulares

D) Realizar barrido digital

E) Indicar salbutamol y control ambulatorio

> **Respuesta B.** Si el niño respira y tose en forma efectiva, la obstrucción es parcial: no se hacen maniobras de desobstrucción, que podrían volverla completa. Se le deja toser, en la posición que prefiera, y se traslada con oxígeno. El síndrome de penetración con signos unilaterales obliga a broncoscopía rígida, diagnóstica y terapéutica. El salbutamol no resuelve un cuerpo extraño.

500 ped-03 · Perfil V3 1.06.3.001 · Vacunación de hepatitis A y B · *Práctica*

Recién nacido de término, sano, cuya madre tiene antígeno de superficie del virus hepatitis B (HBsAg) positivo detectado en el control prenatal.

¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la transmisión vertical?

A) Vacuna contra hepatitis B e inmunoglobulina anti-hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida

B) Solo vacuna hexavalente a los 2 meses según el calendario habitual

C) Suspender la lactancia materna

D) Inmunoglobulina anti-hepatitis B a los 2 meses

E) Vacuna contra hepatitis A al nacer

> **Respuesta A.** Al hijo de madre HBsAg positiva se le administra vacuna contra hepatitis B e inmunoglobulina específica dentro de las primeras 12 horas; luego completa el esquema y se controla serología posvacunal. Esto previene más del 90% de la transmisión. La lactancia no está contraindicada y esperar la hexavalente deja al niño desprotegido.

501 ped-03 · Perfil V3 1.07.3.006 · Inmunizaciones en personas mayores · *Práctica*

Mujer de 66 años, sana, consulta en su CESFAM en abril y pregunta qué vacunas le corresponden según el Programa Nacional de Inmunizaciones. No ha recibido vacunas en la adultez.

¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Solo vacuna antitetánica cada 5 años

B) Vacuna anual contra influenza y vacuna antineumocócica

C) Vacuna contra hepatitis A y tres vírica

D) Refuerzo de vacuna BCG

E) Ninguna, porque las vacunas no son eficaces en adultos mayores

> **Respuesta B.** El PNI chileno indica a las personas de 65 años y más la vacuna antineumocócica y la vacunación anual contra influenza en la campaña de invierno, además de COVID-19 según campaña. Reducen neumonía, hospitalización y muerte. BCG y tres vírica no corresponden a esta edad, y la antitetánica se indica según heridas y esquemas previos.

502 ped-04 · Perfil V3 1.08.3.009 · Prevención de anemias por carencias nutricionales · *Práctica*

Lactante de 4 meses, nacido de término con peso adecuado, recibe lactancia materna exclusiva y crece normalmente. La madre consulta en el control de salud.

Según la norma MINSAL, ¿cuál es la indicación para prevenir la anemia ferropénica?

A) No requiere suplementación por recibir lactancia materna

B) Hierro 6 mg/kg/día desde el nacimiento

C) Suspender la lactancia e iniciar fórmula fortificada

D) Hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses hasta el año

E) Iniciar carne a los 2 meses de vida

> **Respuesta D.** Las reservas de hierro del lactante de término se agotan hacia los 4 a 6 meses y la leche materna aporta poco hierro. La norma indica hierro 1 mg/kg/día desde los 4 hasta los 12 meses en lactancia materna exclusiva (en prematuros, 2 mg/kg/día desde los 2 meses), junto con alimentación complementaria rica en hierro desde los 6 meses.

503 ped-13 · Perfil V3 1.09.4.007 · Cintigrama renal · *Práctica*

Lactante de 10 meses con una primera pielonefritis aguda por E. coli, tratada con buena respuesta. La ecografía renal fue normal.

¿Cuál es el examen indicado para detectar cicatrices renales y cuándo debe realizarse?

A) Cintigrama renal DMSA, 4 a 6 meses después de la infección

B) Cintigrama renal DMSA durante la fase aguda en todos los casos

C) Uretrocistografía miccional en las primeras 24 horas

D) Pielo TAC de control al terminar el tratamiento

E) Urografía de eliminación a los 2 meses

> **Respuesta A.** El cintigrama renal con DMSA es el examen de elección para detectar daño del parénquima renal. Para evaluar cicatrices se realiza 4 a 6 meses después de la pielonefritis, porque antes puede mostrar defectos inflamatorios reversibles. La uretrocistografía busca reflujo vesicoureteral y no se hace en la fase aguda.

504 ped-01 · Perfil V3 2.01.1.001 · Desnutrición · *Práctica*

Niña de 3 años, traída a control. Ha tenido diarreas a repetición los últimos 2 meses. En las curvas OMS: Peso para la Edad –2,4 DE, Talla para la Edad –1,3 DE y Peso para la Talla –2,1 DE.

¿Cuál es su diagnóstico nutricional?

A) Desnutrición

B) Riesgo de desnutrición

C) Eutrófica con talla normal

D) Talla baja

E) Desnutrición crónica con talla baja

> **Respuesta A.** En menores de 5 años el diagnóstico nutricional lo define el Peso para la Talla: –2 DE o menos es desnutrición. La Talla para la Edad en –1,3 DE está en rango normal, así que no hay talla baja. El Peso para la Edad no define el diagnóstico.

505 ped-01 · Perfil V3 2.01.1.003 · Obesidad · *Práctica*

Niño de 7 años, en control de salud. Toma 2 vasos de bebida azucarada al día y juega pocas horas al aire libre. En las curvas OMS: Talla para la Edad +0,5 DE e IMC para la Edad +2,4 DE. Su Peso para la Talla calculado por la madre en una aplicación es +1,6 DE.

¿Cuál es su diagnóstico nutricional?

A) Eutrófico

B) Sobrepeso, según el Peso para la Talla

C) Obesidad

D) Obesidad severa

E) Talla alta constitucional

> **Respuesta C.** Desde los 5 hasta los 19 años se usa el IMC para la Edad, no el Peso para la Talla. Entre +2 y +2,9 DE corresponde a obesidad; la obesidad severa parte en +3 DE. Usar el Peso para la Talla a esta edad lleva al error de diagnosticar sobrepeso.

506 ped-18 · Perfil V3 2.01.1.021 · Enfermedad pulmonar crónica · *Práctica*

Un recién nacido de 26 semanas de edad gestacional y 850 g recibió surfactante y ventilación mecánica por enfermedad de membrana hialina. Al llegar a las 36 semanas de edad gestacional corregida aún requiere oxígeno suplementario para mantener saturaciones adecuadas.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Taquipnea transitoria del recién nacido

B) Síndrome de aspiración meconial

C) Displasia broncopulmonar

D) Hipertensión pulmonar persistente aislada

E) Fibrosis quística

> **Respuesta C.** La displasia broncopulmonar es la enfermedad pulmonar crónica del prematuro: requerimiento de oxígeno a las 36 semanas de edad corregida en un prematuro menor de 32 semanas, tras ventilación mecánica u oxígeno. Se asocia a prematurez extrema, barotrauma, toxicidad por oxígeno e infección.

507 ped-06 · Perfil V3 2.01.1.022 · Estridor · *Práctica*

Lactante de 2 meses, traído porque desde las 2 semanas de vida tiene un ruido inspiratorio agudo que aumenta con el llanto, al alimentarse y en decúbito supino, y disminuye en decúbito prono. Afebril, sin coriza, sin tos ni disfonía. Buen incremento de peso y saturación de 98%.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Laringomalacia congénita

B) Laringitis aguda obstructiva

C) Cuerpo extraño en la vía aérea

D) Epiglotitis

E) Absceso retrofaríngeo

> **Respuesta A.** Estridor inspiratorio desde las primeras semanas, que empeora con el llanto, la alimentación y el decúbito supino, sin fiebre ni cuadro catarral y con buen crecimiento, es típico de laringomalacia: la causa más frecuente de estridor crónico del lactante, benigna y que suele resolverse sola.

508 ped-05 · Perfil V3 2.01.1.028 · Síndrome bronquial obstructivo · *Práctica*

Lactante de 18 meses, con 4 episodios de obstrucción bronquial con sibilancias en los últimos 12 meses, todos tratados con salbutamol y uno que requirió hospitalización. Entre los episodios está asintomático y con buen incremento ponderal. Hoy consulta en control, sin dificultad respiratoria.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Salbutamol inhalado diario de forma permanente

B) Amoxicilina profiláctica durante el invierno

C) Prednisona oral diaria por 3 meses

D) Corticoide inhalado de mantención con aerocámara y seguimiento

E) No requiere tratamiento, porque hoy está asintomático

> **Respuesta D.** Tres o más episodios obstructivos en el año en un menor de 2 años definen un síndrome bronquial obstructivo recurrente. Con episodios frecuentes o severos se indica corticoide inhalado de mantención con aerocámara. El salbutamol es solo de rescate y el corticoide oral crónico no se usa.

509 ped-13 · Perfil V3 2.01.1.065 · Malformaciones urogenitales · *Práctica*

Niña de 2 años, con su segunda infección urinaria febril en 6 meses, confirmada por sondeo vesical y ya tratada con buena respuesta. La ecografía renal y vesical muestra dilatación de la pelvis renal y del uréter izquierdos.

¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Cintigrama renal con DMSA en fase aguda

B) Pielografía endovenosa

C) Urocultivo mensual por 1 año

D) Uretrocistografía miccional

E) TAC de abdomen con contraste

> **Respuesta D.** Una ecografía alterada (ureterohidronefrosis) o una infección urinaria febril recurrente obligan a buscar reflujo vesicoureteral, la malformación más asociada a infección urinaria. La uretrocistografía miccional lo diagnostica y clasifica en grados.

510 ped-15 · Perfil V3 2.01.1.078 · Encefalopatía hipóxico-isquémica · *Práctica*

Un recién nacido de 39 semanas nace tras un desprendimiento de placenta, con Apgar 2 al minuto y 4 a los 10 minutos, requiriendo ventilación con presión positiva. El pH de cordón es 6,9 con exceso de base -18. A las 2 horas de vida está letárgico, hipotónico, con succión débil y reflejos disminuidos.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observar en puerperio con su madre

B) Iniciar hipotermia terapéutica antes de las 6 horas de vida

C) Iniciar fenobarbital profiláctico

D) Administrar bicarbonato endovenoso en bolo

E) Calentar activamente hasta 38 °C

> **Respuesta B.** Asfixia perinatal (evento centinela, Apgar bajo prolongado, acidosis grave de cordón) con encefalopatía moderada a grave en un recién nacido de 36 semanas o más es indicación de hipotermia terapéutica (33 a 34 °C por 72 horas), iniciada antes de las 6 horas de vida, porque reduce muerte y discapacidad.

511 ped-01 · Perfil V3 2.01.1.079 · Macro y microcefalia · *Práctica*

Un lactante de 5 meses, en control sano, tiene un perímetro cefálico que ha cruzado dos carriles de percentil, desde p50 al nacer hasta sobre p98 ahora. La fontanela anterior está amplia y tensa, y presenta mirada en sol poniente. Su desarrollo psicomotor muestra pobre sostén cefálico.

¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

A) Radiografía de cráneo

B) Ecografía cerebral transfontanelar

C) Electroencefalograma

D) Medición del perímetro cefálico de los padres y control en 3 meses

E) Cariograma

> **Respuesta B.** Macrocefalia progresiva (cruce de percentiles) con fontanela tensa, signo de sol poniente y retraso del desarrollo sugiere hidrocefalia con hipertensión endocraneana. Con fontanela abierta, el examen inicial rápido y sin radiación es la ecografía transfontanelar, seguida de RM. Medir a los padres sirve para la macrocefalia familiar benigna, que crece en su percentil y con desarrollo normal.

512 ped-02 · Perfil V3 2.01.1.084 · Síndrome hipotónico · *Práctica*

Un lactante de 4 meses es traído porque no sostiene la cabeza. Al examen está alerta y sigue con la mirada, pero tiene hipotonía generalizada marcada, con postura en batracio, arreflexia osteotendínea, respiración paradojal abdominal y fasciculaciones de la lengua.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atrofia muscular espinal

B) Síndrome de Down

C) Hipotiroidismo congénito

D) Parálisis cerebral hipotónica

E) Síndrome de Prader-Willi

> **Respuesta A.** Hipotonía con debilidad marcada, arreflexia y fasciculaciones linguales, en un lactante alerta y con buena conexión, indica hipotonía periférica por compromiso de la segunda motoneurona: atrofia muscular espinal tipo 1. La hipotonía central (Down, Prader-Willi, parálisis cerebral, hipotiroidismo) conserva o aumenta los reflejos y suele asociar compromiso de conciencia o del desarrollo cognitivo.

513 ped-02 · Perfil V3 2.01.1.086 · Trastornos del lenguaje · *Práctica*

Un niño de 2 años es traído porque solo dice 2 palabras. Comprende instrucciones simples cuando lo miran, mantiene contacto visual, juega de forma simbólica y señala lo que quiere. Tuvo varias otitis medias el último año. Su examen físico y el resto del desarrollo son normales.

¿Cuál es el primer examen a solicitar?

A) Resonancia magnética cerebral

B) Cariograma

C) Electroencefalograma

D) Evaluación auditiva (audiometría o potenciales evocados auditivos)

E) Test de detección de autismo como único estudio

> **Respuesta D.** A los 2 años se espera un vocabulario de unas 50 palabras y frases de 2 palabras. Ante todo retraso del lenguaje, el primer paso es descartar hipoacusia con una evaluación auditiva objetiva, más aún con otitis a repetición (otitis media con efusión). La buena interacción social y el juego simbólico hacen menos probable un trastorno del espectro autista.

514 ped-18 · Perfil V3 2.01.1.113 · Apneas · *Práctica*

Un recién nacido prematuro de 29 semanas, al tercer día de vida, presenta episodios repetidos de pausas respiratorias de más de 20 segundos, con bradicardia y desaturación, que ceden con estímulo táctil. Se han descartado hipoglicemia, sepsis, anemia, alteraciones electrolíticas y hemorragia intraventricular.

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección?

A) Cafeína (citrato de cafeína)

B) Fenobarbital

C) Salbutamol

D) Surfactante

E) Naloxona

> **Respuesta A.** Las apneas de más de 20 segundos, o menores con bradicardia o desaturación, en un prematuro menor de 34 semanas, tras descartar causas secundarias, corresponden a apnea del prematuro por inmadurez del centro respiratorio. El tratamiento de elección es el citrato de cafeína, un estimulante respiratorio, más medidas de soporte o CPAP si persisten. El fenobarbital deprime la respiración.

515 ped-15 · Perfil V3 2.01.1.114 · Asfixia neonatal · *Práctica*

Recién nacido de 39 semanas, por cesárea de urgencia por desprendimiento de placenta. Requirió ventilación a presión positiva y masaje cardíaco. Apgar 2 al minuto y 4 a los 5 minutos. Gases de cordón: pH 6,88 y exceso de base –18. A las 2 horas de vida está hipotónico, letárgico, con reflejos primitivos débiles.

¿Cuál es la intervención que más reduce la mortalidad y las secuelas neurológicas en este paciente?

A) Bicarbonato de sodio endovenoso para corregir la acidosis

B) Fenobarbital profiláctico

C) Hiperventilación para bajar el CO2

D) Hipotermia terapéutica iniciada antes de las 6 horas de vida

E) Hidratación con aporte hídrico alto para mejorar la perfusión renal

> **Respuesta D.** Acidosis grave en cordón, Apgar bajo persistente, reanimación avanzada y encefalopatía moderada a severa definen asfixia neonatal con encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipotermia terapéutica, iniciada antes de las 6 horas, es la única intervención que reduce muerte y discapacidad. El bicarbonato y el fenobarbital profiláctico no están indicados.

516 ped-20 · Perfil V3 2.01.1.115 · Convulsiones neonatales · *Práctica*

Un recién nacido de término, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta a las 6 horas de vida movimientos de pedaleo de extremidades y desviación ocular sostenida, de 1 minuto de duración. Está en buenas condiciones generales, sin fiebre.

¿Cuál es la primera medida diagnóstica?

A) Electroencefalograma

B) Punción lumbar

C) Glicemia capilar

D) Ecografía cerebral

E) Resonancia magnética cerebral

> **Respuesta C.** Ante una convulsión neonatal, lo primero es medir la glicemia capilar, porque la hipoglicemia es una causa frecuente, rápidamente tratable y que deja secuelas si no se corrige; el hijo de madre diabética tiene alto riesgo. Luego se miden calcio, magnesio y electrolitos y se buscan otras causas (encefalopatía hipóxico-isquémica, infección, hemorragia). El EEG y las imágenes vienen después.

517 ped-20 · Perfil V3 2.01.1.119 · Hipocalcemia · *Práctica*

Recién nacido de 37 semanas, hijo de madre diabética pregestacional, de 30 horas de vida. Presenta temblores de extremidades e irritabilidad. Glicemia 62 mg/dL. Calcio total 6,6 mg/dL. El electrocardiograma muestra un intervalo QT prolongado.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Bolo de suero glucosado al 10% 2 mL/kg

B) Fenobarbital endovenoso por sospecha de convulsión

C) Gluconato de calcio en bolo rápido sin monitorización

D) Gluconato de calcio al 10% 1 a 2 mL/kg endovenoso lento, con monitor cardíaco

E) Solo observación, porque es esperable en el hijo de madre diabética

> **Respuesta D.** Calcio bajo 8 mg/dL en un recién nacido de término es hipocalcemia; el hijo de madre diabética es grupo de riesgo. Con síntomas o QT prolongado se trata con gluconato de calcio al 10% endovenoso lento con monitor, porque pasarlo rápido causa bradicardia y arritmias. La glicemia es normal.

518 ped-20 · Perfil V3 2.01.1.122 · Poliglobulia · *Práctica*

Un recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, a las 12 horas de vida se ve pletórico, con letargia, temblores y succión débil. Exámenes: hematocrito venoso 71% y glicemia 38 mg/dL.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado de la poliglobulia?

A) Flebotomía simple sin reposición

B) Exsanguinotransfusión parcial con suero fisiológico

C) Hidratación oral exclusiva y control

D) Transfusión de plaquetas

E) Fototerapia

> **Respuesta B.** Poliglobulia neonatal es un hematocrito venoso mayor a 65%; en pequeños para la edad gestacional se debe a hipoxia crónica intrauterina. Causa hiperviscosidad, con letargia, hipoglicemia, dificultad respiratoria o enterocolitis. Si es sintomática (o el hematocrito es mayor a 70 a 75%), se realiza exsanguinotransfusión parcial con suero fisiológico para bajar el hematocrito a 55%, además de corregir la glicemia.

519 ped-16 · Perfil V3 2.01.1.123 · Prematurez · *Práctica*

Recién nacido de 30 semanas, con peso de nacimiento de 1.250 gramos, hospitalizado en neonatología. Recibió surfactante y oxígeno durante las primeras 2 semanas. Hoy tiene 4 semanas de vida, está estable, sin apoyo ventilatorio y en ganancia de peso.

Según las garantías GES para el prematuro, ¿qué evaluación corresponde realizar ahora?

A) Electroencefalograma de rutina

B) Cariograma

C) Fondo de ojo por oftalmólogo para pesquisa de retinopatía del prematuro

D) Densitometría ósea

E) Resonancia magnética de cerebro de rutina

> **Respuesta C.** El prematuro menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos tiene garantía GES de pesquisa de retinopatía del prematuro con fondo de ojo por oftalmólogo, habitualmente desde las 4 semanas de vida; el oxígeno recibido es un factor de riesgo adicional. También tiene garantía de pesquisa de hipoacusia.

520 ped-18 · Perfil V3 2.01.1.123 · Prematurez · *Práctica*

Recién nacido de 28 semanas, de 3 días de vida, en CPAP nasal. Presenta episodios repetidos de pausas respiratorias de más de 20 segundos, acompañados de bradicardia y desaturación, que ceden con estimulación táctil. Está normotérmico, con glicemia y hemograma normales y PCR negativa.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Citrato de cafeína endovenoso u oral

B) Ampicilina más gentamicina por 10 días

C) Fenobarbital endovenoso

D) Intubación y ventilación mecánica inmediatas

E) Suspender la alimentación enteral por 1 semana

> **Respuesta A.** Pausas de más de 20 segundos con bradicardia o desaturación en un prematuro, sin otra causa, son apneas del prematuro por inmadurez del centro respiratorio. El tratamiento de elección es la cafeína. Descartada la sepsis, los antibióticos no corresponden, y la intubación queda para la falla del tratamiento.

521 ped-18 · Perfil V3 2.01.1.125 · Síndrome aspirativo meconial · *Práctica*

Recién nacido de 41 semanas y 5 días, por parto vaginal con registro fetal alterado y líquido amniótico con meconio espeso. A los 20 minutos de vida presenta taquipnea de 80 rpm, retracción intercostal, tórax en tonel y saturación de 86%. La radiografía muestra infiltrados gruesos y parcheados bilaterales, con zonas de atelectasia alternadas con zonas de hiperinsuflación.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de membrana hialina

B) Taquipnea transitoria del recién nacido

C) Hernia diafragmática congénita

D) Neumonía connatal por estreptococo grupo B

E) Síndrome de aspiración meconial

> **Respuesta E.** Postérmino con sufrimiento fetal y meconio espeso, dificultad respiratoria precoz y tórax hiperinsuflado, con infiltrados gruesos que alternan atelectasias y enfisema, es aspiración meconial: el meconio actúa como válvula. La membrana hialina es del prematuro, con vidrio esmerilado y volumen pulmonar disminuido.

522 ped-12 · Perfil V3 2.01.2.001 · Abdomen agudo · *Práctica*

Lactante de 8 meses, previamente sano, con crisis de llanto intenso y encogimiento de piernas cada 15 a 20 minutos desde hace 8 horas; entre las crisis está pálido y decaído. Ha vomitado 3 veces y hace 1 hora tuvo una deposición con sangre y mucosidad. Se palpa una masa alargada en el hemiabdomen derecho.

¿Cuál es el diagnóstico más probable y su manejo inicial?

A) Invaginación intestinal; ecografía abdominal y reducción con enema hidrostático o neumático

B) Cólico del lactante; tranquilizar y control

C) Diarrea disentérica; cotrimoxazol oral

D) Estenosis hipertrófica del píloro; piloromiotomía

E) Apendicitis aguda; apendicectomía sin estudio

> **Respuesta A.** Crisis de dolor cólico intermitente con palidez entre episodios, vómitos, deposición en jalea de grosella y masa palpable entre los 3 y 24 meses es invaginación intestinal. La ecografía muestra la imagen en diana y, sin peritonitis ni perforación, se reduce con enema; si falla, cirugía.

523 ped-06 · Perfil V3 2.01.2.018 · Obstrucción de vía aérea superior · *Práctica*

Niño de 4 años, sin vacunas desde el año de vida, con fiebre de 39,8 °C de 6 horas. Llega sentado inclinado hacia adelante con el cuello extendido, babeando, con estridor inspiratorio suave y aspecto tóxico. No tiene tos perruna.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Examinar la faringe con bajalenguas para confirmar el diagnóstico

B) Mantenerlo tranquilo con su madre, dar oxígeno sin incomodarlo y asegurar la vía aérea en pabellón con anestesista

C) Acostarlo para tomar una radiografía lateral de cuello

D) Dexametasona oral y alta con control en 24 horas

E) Nebulizar adrenalina y observar 4 horas en urgencia

> **Respuesta B.** Fiebre alta, aspecto tóxico, sialorrea, posición en trípode y ausencia de tos perruna en un niño no vacunado sugieren epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo b. No se examina la faringe ni se acuesta al niño: se asegura la vía aérea en pabellón y luego se inicia ceftriaxona.

524 ped-12 · Perfil V3 2.01.2.019 · Obstrucción intestinal · *Práctica*

Recién nacido de 5 días, de término, que venía alimentándose bien, presenta bruscamente vómitos de color verde, irritabilidad y distensión abdominal leve. Eliminó meconio el primer día. Está taquicárdico y con llene capilar de 3 segundos.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cambiar a fórmula sin lactosa y control en 48 horas

B) Indicar domperidona y posición semisentada

C) Régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y estudio urgente con tránsito intestinal y evaluación por cirugía

D) Ecografía de píloro electiva

E) Enema con suero fisiológico y alta

> **Respuesta C.** Todo vómito bilioso en un recién nacido es una urgencia quirúrgica: hay que descartar un vólvulo por malrotación intestinal, que puede necrosar el intestino en horas. Se descomprime, se hidrata, se estudia de inmediato y va a cirugía. La estenosis del píloro no da vómito bilioso.

525 ped-01 · Perfil V3 2.01.3.011 · Promoción de salud y estilos de vida saludables · *Práctica*

En el control de salud de un escolar de 8 años, la madre pregunta cuánta actividad física y tiempo frente a pantallas son recomendables.

¿Cuál es la recomendación correcta?

A) Al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa y limitar el tiempo recreativo frente a pantallas

B) 30 minutos de actividad física 2 veces por semana

C) Actividad física solo si tiene sobrepeso

D) Pantallas sin límite si realiza deporte

E) Evitar la actividad vigorosa antes de los 12 años

> **Respuesta A.** La OMS y MINSAL recomiendan que niños y adolescentes de 5 a 17 años realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, incluyendo actividades de fortalecimiento muscular 3 veces por semana, y limitar el tiempo sedentario recreativo frente a pantallas (idealmente menos de 2 horas al día).

526 ped-01 · Perfil V3 2.01.3.017 · Supervisión de salud- escolar · *Práctica*

En el control de salud de un niño de 7 años, sano, se revisan los exámenes y mediciones que deben realizarse.

¿Cuál de las siguientes mediciones debe incluirse en el control de salud del escolar?

A) Radiografía de columna anual

B) Electrocardiograma anual

C) Hemograma anual

D) Presión arterial, al menos una vez al año desde los 3 años

E) Glicemia de ayuno anual

> **Respuesta D.** El control de salud escolar incluye antropometría con diagnóstico nutricional, presión arterial (desde los 3 años, anual), agudeza visual y auditiva, salud bucal, desarrollo puberal, evaluación de escoliosis al examen físico y aspectos psicosociales y escolares. Los exámenes de laboratorio o radiografías no se solicitan de rutina en un niño sano.

527 ped-02 · Perfil V3 2.01.3.019 · Supervisión de salud- pre-escolar · *Práctica*

Un niño de 3 años acude a su control de salud en atención primaria. Corresponde evaluar su desarrollo psicomotor con un instrumento estandarizado.

¿Qué instrumento corresponde aplicar a esta edad?

A) EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor)

B) TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor)

C) Test de Denver como único instrumento obligatorio

D) Escala de Wechsler

E) Score de Apgar

> **Respuesta B.** En Chile, el desarrollo psicomotor se evalúa con EEDP entre los 0 y 2 años (en controles de 8 y 18 meses) y con TEPSI entre los 2 y 5 años (en el control de 3 años), que evalúa coordinación, lenguaje y motricidad. Un resultado de riesgo o retraso requiere estimulación y reevaluación o derivación.

528 ped-07 · Perfil V3 2.01.4.001 · Radiografía de tórax · *Práctica*

Niño de 3 años con diagnóstico clínico de neumonía, en tratamiento con amoxicilina oral en dosis alta. Tras 48 horas persiste con fiebre de 39 °C y dolor en el costado derecho. Al examen: FR 40 rpm, saturación 94%, matidez y murmullo pulmonar disminuido en la base derecha.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cambiar a azitromicina oral y control en 48 horas

B) Solicitar TAC de tórax ambulatoria

C) Mantener la amoxicilina y esperar 48 horas más

D) Agregar salbutamol inhalado

E) Hospitalizar y solicitar radiografía de tórax por sospecha de derrame pleural

> **Respuesta E.** La radiografía de tórax no es de rutina en la neumonía infantil, pero está indicada si no hay respuesta a las 48 horas o se sospecha una complicación. Fiebre persistente con matidez y murmullo disminuido sugieren derrame pleural paraneumónico, que obliga a hospitalizar.

529 ped-13 · Perfil V3 2.01.4.003 · Ecotomografía abdominal · *Práctica*

Lactante de 10 meses, sin antecedentes, con su primer episodio de infección urinaria febril, confirmado por urocultivo tomado por sondeo vesical. Evolucionó afebril a las 36 horas de tratamiento y completó el antibiótico. No tiene antecedentes prenatales de malformaciones.

¿Cuál es el estudio de imágenes más adecuado?

A) Ninguno, porque respondió bien al tratamiento

B) Ecografía renal y vesical

C) Uretrocistografía miccional como primer examen

D) TAC de abdomen y pelvis

E) Radiografía simple de abdomen

> **Respuesta B.** A todo niño con una primera infección urinaria febril comprobada se le pide ecografía renal y vesical, para buscar malformaciones y dilatación de la vía urinaria. La uretrocistografía se reserva para cuando la ecografía sale alterada o el cuadro es atípico o recurrente.

530 ped-01 · Perfil V3 2.01.4.006 · Radiografía de edad ósea · *Práctica*

Un niño de 10 años consulta por talla baja. Crece en el percentil 3 con velocidad de crecimiento normal y está sano. Su padre mide 160 cm y su madre 148 cm. Se solicita radiografía de carpo para edad ósea.

Si el diagnóstico es talla baja familiar, ¿cuál es el resultado esperado de la edad ósea?

A) Retrasada en más de 2 años respecto de la edad cronológica

B) Muy retrasada con epífisis abiertas e irregulares

C) Adelantada en más de 2 años

D) Acorde a la edad cronológica

E) No es posible estimarla antes de la pubertad

> **Respuesta D.** La edad ósea ayuda a diferenciar las variantes normales de talla baja. En la talla baja familiar la edad ósea concuerda con la cronológica, la velocidad de crecimiento es normal y la talla es acorde a la talla diana. En el retraso constitucional la edad ósea está retrasada y la pubertad será tardía.

531 ped-13 · Perfil V3 2.01.4.011 · Cultivos y antibiograma · *Práctica*

Un lactante de 8 meses con fiebre de 39 °C sin foco tiene orina completa con leucocituria y nitritos positivos. El urocultivo, tomado por cateterismo vesical, informa Escherichia coli 50.000 UFC/mL, sensible a cefalosporinas de primera generación y resistente a ampicilina.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Contaminación, porque es menor a 100.000 UFC/mL

B) Es necesario un hemocultivo para confirmar

C) Bacteriuria asintomática que no requiere tratamiento

D) Debe repetirse con bolsa recolectora

E) Infección urinaria confirmada

> **Respuesta E.** El punto de corte del urocultivo depende de la técnica: por punción suprapúbica cualquier recuento; por cateterismo vesical 10.000 UFC/mL o más (algunos usan 50.000); por segundo chorro 100.000 o más. Con fiebre, sedimento inflamatorio y 50.000 UFC/mL por cateterismo, la ITU está confirmada. El antibiograma permite ajustar el tratamiento, en este caso a cefalosporina.

532 ped-05 · Perfil V3 2.01.4.014 · Gases en sangre arterial · *Práctica*

Un lactante de 10 meses con síndrome bronquial obstructivo lleva 3 horas en tratamiento con salbutamol y oxígeno. Está cada vez más somnoliento, con menor esfuerzo respiratorio y murmullo pulmonar disminuido. Los gases arteriales muestran pH 7,22, $PaCO_2$ 62 mmHg, HCO_3^- 24 mEq/L y PaO_2 58 mmHg.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Acidosis respiratoria aguda con hipoxemia: falla respiratoria global

B) Alcalosis respiratoria compensada

C) Acidosis metabólica compensada

D) Gases normales para la edad

E) Alcalosis metabólica

> **Respuesta A.** pH bajo con $PaCO_2$ elevada y bicarbonato normal es acidosis respiratoria aguda (sin compensación renal). Junto con hipoxemia, somnolencia y menor esfuerzo, indica insuficiencia respiratoria global por agotamiento. En una obstrucción bronquial, una $PaCO_2$ normal o alta es signo de gravedad. Requiere unidad de paciente crítico y probable soporte ventilatorio.

533 ped-09 · Perfil V3 2.01.4.020 · Proteína C reactiva cuantitativa · *Práctica*

Un lactante de 4 meses presenta fiebre de 39 °C de 3 horas de evolución, sin foco al examen. Está en buenas condiciones. Se solicita hemograma, orina completa y proteína C reactiva, que resulta 0,6 mg/dL.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de la PCR?

A) Descarta infección bacteriana grave

B) Permite dar el alta sin control

C) Confirma una infección viral

D) Indica que no se requiere orina completa

E) Puede estar aún normal por el poco tiempo de evolución de la fiebre

> **Respuesta E.** La proteína C reactiva se eleva entre 6 y 12 horas tras el inicio del proceso inflamatorio y alcanza su máximo a las 36 a 48 horas. Con fiebre de menos de 6 a 12 horas puede ser normal aun en una infección bacteriana grave. Debe interpretarse con la clínica y la evolución; la procalcitonina sube más precozmente.

534 ped-17 · Perfil V3 2.01.4.023 · Pruebas hepáticas · *Práctica*

Un lactante de 5 semanas, de término, presenta ictericia desde la segunda semana de vida, deposiciones de color blanco masilla (acolia) y orinas oscuras. Está con buen incremento ponderal. Al examen tiene hepatomegalia firme. Exámenes: bilirrubina total 8 mg/dL con directa 6 mg/dL y GGT elevada.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Fototerapia

B) Suspender la lactancia materna por 48 horas

C) Derivación urgente para estudio de atresia de vías biliares

D) Control en 1 mes

E) Exanguinotransfusión

> **Respuesta C.** Una bilirrubina directa elevada (mayor a 1 mg/dL o 20% del total) es colestasia y nunca es fisiológica; con acolia, coluria y GGT alta sugiere atresia de vías biliares. Requiere derivación urgente, porque la portoenteroestomía de Kasai rinde mejor antes de los 45 a 60 días de vida.

535 ped-05 · Perfil V3 2.01.4.025 · Serología y técnicas de aislamiento viral y bacteriano · *Práctica*

Un lactante de 3 meses, en época invernal, presenta coriza, tos y luego dificultad respiratoria con sibilancias y crepitaciones difusas. Se hospitaliza y se desea identificar el agente viral para cohortear a los pacientes.

¿Cuál es el examen más adecuado?

A) Serología IgM para virus respiratorios

B) Inmunofluorescencia o PCR viral en aspirado o hisopado nasofaríngeo

C) Hemocultivo

D) Cultivo de expectoración

E) Recuento de eosinófilos

> **Respuesta B.** El diagnóstico etiológico de las infecciones respiratorias virales agudas se realiza con detección de antígenos (inmunofluorescencia) o PCR en muestra nasofaríngea, rápida y sensible. En la bronquiolitis el agente más frecuente es el virus respiratorio sincicial. La serología es tardía y poco útil en infecciones agudas; el hemocultivo y el cultivo de expectoración son para bacterias.

536 ped-01 · Perfil V3 2.01.5.001 · Antropometría en la edad pediátrica · *Práctica*

Niño de 20 meses acude a su control de salud. La interna lo mide de pie en el estadiómetro, porque el niño ya camina, y registra su estatura en la curva de Talla para la Edad de la OMS.

¿Cuál es la corrección más adecuada a esta técnica?

A) Ninguna: desde que camina se mide de pie

B) Medirlo acostado recién desde los 3 años

C) Medirlo de pie, pero restar 2 cm al valor obtenido

D) Medir solo el perímetro cefálico, que reemplaza a la talla en esta edad

E) Medirlo acostado con infantómetro, porque hasta los 2 años se registra la longitud

> **Respuesta E.** Hasta los 2 años se mide al niño acostado con infantómetro (longitud); desde los 2 años cumplidos, de pie con estadiómetro (estatura). Que el niño camine no cambia la técnica, y las curvas OMS están construidas así.

537 ped-13 · Perfil V3 2.01.5.003 · Cateterismo vesical · *Práctica*

Un lactante de 9 meses, sin control de esfínteres, presenta fiebre de 39 °C sin foco. Se decide estudiar una posible infección urinaria.

¿Cuál es el método más adecuado para obtener la muestra de urocultivo?

A) Cateterismo vesical con técnica estéril

B) Bolsa recolectora adhesiva

C) Recolección del pañal

D) Segundo chorro espontáneo

E) Orina de 24 horas

> **Respuesta A.** En niños sin control de esfínteres, el urocultivo debe tomarse por cateterismo vesical estéril (o punción suprapúbica), porque la bolsa recolectora tiene una alta tasa de contaminación: solo es útil si resulta negativa. El segundo chorro se usa en niños con control miccional. La técnica requiere aseo genital, sonda fina y desechar las primeras gotas.

538 ped-05 · Perfil V3 2.01.5.006 · Oxigenoterapia · *Práctica*

Lactante de 4 meses con bronquiolitis de 3 días de evolución. Al examen: FR 62 rpm, tiraje subcostal e intercostal, sibilancias espiratorias y saturación de 89% con aire ambiental. Está alerta y se alimenta con dificultad.

Respecto del oxígeno, ¿cuál es la indicación más adecuada?

A) No indicar oxígeno hasta que la saturación baje de 85%

B) Nebulizar salbutamol con aire comprimido en vez de oxígeno

C) Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio para lograr saturación de 100%

D) Intubación y ventilación mecánica inmediatas

E) Oxígeno por naricera de bajo flujo, ajustado para mantener saturación de 93% o más

> **Respuesta E.** Una saturación bajo 93% en un lactante con bronquiolitis es criterio de hospitalización y de oxigenoterapia. Se usa naricera de bajo flujo, titulada para saturar 93% o más. No se busca saturar 100% y el niño está alerta, sin criterio de ventilación mecánica.

539 ped-14 · Perfil V3 2.01.5.008 · Punción lumbar · *Práctica*

Lactante de 11 meses, con vacunas al día, con otitis media aguda en tratamiento con amoxicilina desde hace 3 días. Hoy, con fiebre de 39 °C, presenta una crisis tónico-clónica generalizada de 2 minutos que cede sola. A los 30 minutos está algo irritable, sin rigidez de nuca ni focalidad, con fontanela normotensa.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Alta con antipiréticos y educación, porque es una convulsión febril simple

B) Realizar punción lumbar, porque venía recibiendo antibióticos

C) Solicitar electroencefalograma urgente

D) Iniciar fenobarbital de mantención

E) Realizar TAC de cerebro y dar el alta si es normal

> **Respuesta B.** En un lactante con convulsión febril, el tratamiento antibiótico previo puede enmascarar una meningitis decapitada: es indicación de punción lumbar, igual que los signos meníngeos, la letargia persistente o las vacunas incompletas. El EEG y la neuroimagen no están indicados de rutina.

540 ped-13 · Perfil V3 2.01.5.010 · Punción suprapúbica · *Práctica*

Un lactante de 2 meses con fiebre sin foco requiere urocultivo. No fue posible realizar cateterismo vesical por fimosis estrecha, por lo que se obtiene la muestra mediante punción suprapúbica, que informa Escherichia coli 2.000 UFC/mL.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Contaminación, porque el recuento es bajo

B) Bacteriuria asintomática

C) Requiere repetir con bolsa recolectora

D) Infección urinaria confirmada, ya que por punción suprapúbica cualquier recuento es significativo

E) Se necesitan más de 100.000 UFC/mL para confirmar

> **Respuesta D.** La punción suprapúbica obtiene orina directamente de la vejiga, normalmente estéril, por lo que cualquier recuento de bacterias gramnegativas es significativo. Se indica en lactantes cuando no es posible el cateterismo (fimosis estrecha, sinequias), preferentemente guiada por ecografía con vejiga llena. Los puntos de corte de mayor recuento son para cateterismo y segundo chorro.

541 ped-15 · Perfil V3 3.01.3.016 · Vínculo y apego · *Práctica*

Recién nacido de término, de 3.300 g, nace por parto vaginal, vigoroso, llorando y con buen tono. La madre está estable y desea tenerlo consigo.

¿Qué intervención inmediata favorece más el vínculo y el apego temprano?

A) Aspirar de rutina las secreciones orofaríngeas y gástricas

B) Bañar al recién nacido antes de entregárselo a la madre

C) Trasladarlo a observación en cuna radiante por 2 horas

D) Administrar fórmula láctea para prevenir hipoglicemia

E) Contacto piel a piel inmediato con su madre e inicio de lactancia en la primera hora

> **Respuesta E.** En el recién nacido vigoroso se recomienda contacto piel a piel inmediato e ininterrumpido y lactancia en la primera hora: favorece el apego, la termorregulación, la estabilidad glicémica y el éxito de la lactancia. Separarlo para baño, observación o aspiración rutinaria no tiene beneficio y lo interrumpe.

542 ped-03 · Perfil V3 4.01.5.020 · Inyecciones subcutáneas, intramusculares e intravenosas · *Práctica*

Lactante de 2 meses acude al vacunatorio para recibir las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, incluida la hexavalente por vía intramuscular.

¿Cuál es el sitio de elección para la inyección intramuscular a esta edad?

A) Región glútea, cuadrante superior externo

B) Músculo deltoides

C) Región ventroglútea

D) Cara anterolateral del muslo (vasto lateral)

E) Cara anterior del antebrazo

> **Respuesta D.** En lactantes menores de 12 a 18 meses, el sitio de elección para inyecciones intramusculares es el vasto lateral, en la cara anterolateral del muslo, por su mayor masa muscular y ausencia de grandes vasos y nervios. El deltoides es pequeño a esta edad, y el glúteo se evita por riesgo de lesionar el nervio ciático.

543 ped-13 · Perfil V3 4.03.1.021 · Reflujo vésico ureteral · *Práctica*

Lactante de 8 meses cursa su segundo episodio de pielonefritis aguda por E. coli. La ecografía renal muestra dilatación pielocalicial bilateral leve. La uretrocistografía miccional muestra reflujo vésico-ureteral grado IV bilateral.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Profilaxis antibiótica continua y derivación a nefrología o urología infantil, con cintigrama DMSA para evaluar cicatrices

B) Cirugía de reimplante ureteral inmediata

C) Alta sin seguimiento, ya que el reflujo se resuelve siempre espontáneamente

D) Repetir la uretrocistografía en 1 semana

E) Tratamiento antibiótico solo durante los episodios febriles

> **Respuesta A.** El RVU de alto grado (IV a V) con ITU febril recurrente en un lactante tiene alto riesgo de cicatrices renales. Se indica profilaxis antibiótica (nitrofurantoína o cefadroxilo), DMSA diferido para evaluar daño parenquimatoso y manejo por especialista; la corrección endoscópica o quirúrgica se reserva para ITU de brecha o daño progresivo.

544 ped-13 · Perfil V3 4.03.4.009 · Cintigrama renal · *Práctica*

Niña de 2 años que tuvo una pielonefritis aguda febril hace 5 meses, tratada adecuadamente. Su ecografía renal fue normal. Se desea evaluar si quedaron cicatrices en el parénquima renal.

¿Cuál es el examen de elección?

A) TAC de abdomen sin contraste

B) Cintigrama renal con MAG3 y diurético

C) Uretrocistografía miccional

D) Urocultivo de control

E) Cintigrama renal con DMSA (ácido dimercaptosuccínico)

> **Respuesta E.** El cintigrama estático con DMSA es el estándar para detectar cicatrices renales; se realiza 4 a 6 meses después de la pielonefritis para no confundir inflamación aguda con cicatriz. El cintigrama dinámico (MAG3 o DTPA con diurético) evalúa obstrucción y función diferencial con curva de eliminación. La uretrocistografía evalúa reflujo, no cicatrices.

545 ped-02 · Perfil V3 5.01.3.003 · Desarrollo cognitivo, afectivo y social a lo largo del ciclo vital · *Práctica*

Niña de 4 años, con desarrollo normal. Su madre cuenta que cree que la luna la sigue cuando van en auto, que sus muñecas sienten frío y que, si ella cierra los ojos, nadie puede verla.

Según Piaget, ¿en qué etapa del desarrollo cognitivo se encuentra?

A) Sensoriomotora

B) Operaciones concretas

C) Preoperacional

D) Operaciones formales

E) Latencia

> **Respuesta C.** La etapa preoperacional de Piaget, aproximadamente de 2 a 7 años, se caracteriza por pensamiento simbólico, egocentrismo, animismo (atribuir vida a objetos) y pensamiento mágico, sin lógica de conservación. La sensoriomotora va de 0 a 2 años, las operaciones concretas de 7 a 11 y las formales desde los 12. La latencia es una etapa de Freud.

546 ped-04 · Perfil V3 5.01.3.004 · Higiene de la alimentación · *Práctica*

Madre de un niño sano de 4 años, con peso y talla normales, consulta porque es mañoso para comer. Para que coma le promete postre como premio, lo deja comer frente a la televisión y, si no termina el plato, le prepara otra comida.

¿Cuál es la recomendación más adecuada?

A) Comidas en familia en horarios regulares, sin pantallas, sin usar alimentos como premio o castigo, respetando su saciedad

B) Obligarlo a terminar el plato en cada comida

C) Indicar suplementos nutricionales

D) Permitir colaciones libres durante el día para asegurar la ingesta

E) Ofrecerle solo los alimentos que acepta

> **Respuesta A.** La higiene de la alimentación busca hábitos saludables y una relación sana con la comida: horarios regulares, comer en familia, sin pantallas, ofrecer variedad repetidamente y respetar la saciedad. Usar la comida como premio, forzar o preparar menús alternativos refuerza la selectividad y se asocia a malnutrición por exceso y conductas alimentarias alteradas.

547 ped-16 · Perfil V3 6.02.1.022 · Retinopatía del prematuro · *Práctica*

Recién nacido de 29 semanas de gestación y 1.150 g de peso al nacer, que requirió oxigenoterapia prolongada. Se encuentra en la unidad de neonatología a las 4 semanas de vida.

Respecto de la retinopatía del prematuro, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) No requiere evaluación, porque está en oxígeno controlado

B) Evaluar al alta, a los 6 meses de edad

C) Evaluar solo si presenta leucocoria

D) Examen de fondo de ojo con pupila dilatada por oftalmólogo, según GES, en prematuros menores de 32 semanas o menores de 1.500 g

E) Indicar vitamina A como tratamiento

> **Respuesta D.** La retinopatía del prematuro es una vasculopatía proliferativa de la retina inmadura, favorecida por prematurez, bajo peso e hiperoxia. Es GES: se tamiza con fondo de ojo dilatado por oftalmólogo a todo prematuro menor de 1.500 g o de 32 semanas, desde las 4 semanas de vida, y se trata con láser o antiangiogénicos.

548 ped-02 · Perfil V3 6.03.1.033 · Trastornos de habla y lenguaje · *Práctica*

Niño de 2 años y medio en control sano. Su madre refiere que dice solo 8 palabras aisladas y no combina 2 palabras. Comprende órdenes simples, mira a los ojos, juega con otros niños e imita. El examen físico es normal y no tiene antecedentes perinatales relevantes.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Tranquilizar y controlar a los 4 años

B) Electroencefalograma

C) Resonancia magnética cerebral

D) Evaluación auditiva (descartar hipoacusia) y derivación a fonoaudiología

E) Iniciar metilfenidato

> **Respuesta D.** A los 2 años se esperan al menos 50 palabras y frases de 2 palabras. Un retraso del lenguaje expresivo requiere primero descartar hipoacusia con evaluación auditiva objetiva (potenciales evocados o audiometría según edad), además de evaluar desarrollo global y signos de trastorno del espectro autista, y derivar a fonoaudiología para estimulación precoz.

549 ped-15 · Perfil V3 6.03.2.005 · Atresia coanal congénita · *Práctica*

Recién nacido de término presenta episodios de cianosis y dificultad respiratoria que empeoran al alimentarse y mejoran con el llanto. Al intentar pasar una sonda nasogástrica por ambas fosas nasales, esta no progresa más allá de 3 cm.

¿Cuál es el diagnóstico y la medida inmediata?

A) Laringomalacia; posición prona

B) Taquipnea transitoria; oxígeno

C) Hernia diafragmática; intubación y sonda

D) Fístula traqueoesofágica; régimen cero

E) Atresia de coanas bilateral; asegurar vía aérea oral (cánula de Guedel o chupete de McGovern) y derivar para TAC y cirugía

> **Respuesta E.** El recién nacido es respirador nasal obligado: la atresia de coanas bilateral da cianosis cíclica que mejora con el llanto (respira por la boca) y empeora al alimentarse. Se sospecha si la sonda no pasa por las fosas nasales. Se asegura una vía aérea oral, se confirma con TAC y se corrige quirúrgicamente. Se asocia a CHARGE.

550 ped-21 · Perfil V3 6.03.3.001 · Detección de hipoacusia y sordera en niños · *Práctica*

Recién nacido de término sano, con tamizaje auditivo universal con emisiones otoacústicas que resultó "refiere" en el oído derecho en 2 ocasiones antes del alta.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir las emisiones a los 2 años

B) Tranquilizar, porque la hipoacusia unilateral no tiene importancia

C) Confirmar con potenciales evocados auditivos de tronco cerebral antes de los 3 meses, para iniciar intervención antes de los 6 meses

D) Esperar a que el niño comience a hablar

E) Solicitar TAC de oídos inmediatamente

> **Respuesta C.** El tamizaje auditivo neonatal universal (GES hipoacusia del prematuro y programa nacional) busca la meta 1-3-6: tamizaje antes del mes, confirmación diagnóstica con potenciales evocados auditivos antes de los 3 meses e intervención (audífonos, implante) antes de los 6 meses, para preservar el desarrollo del lenguaje. Un tamizaje alterado nunca debe esperar.

551 ped-02 · Perfil V3 6.03.3.002 · Pesquisa de trastornos del lenguaje · *Práctica*

En el control sano de los 18 meses se evalúa el lenguaje de un niño. Su madre dice que no dice ninguna palabra con significado, aunque balbucea.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Normal; a los 18 meses aún no se espera ninguna palabra

B) Señal de alerta: a los 18 meses se esperan al menos varias palabras con significado; requiere evaluación auditiva, del desarrollo (incluida pesquisa de autismo) y derivación a fonoaudiología

C) Normal si es varón

D) Esperar hasta los 3 años para evaluar

E) Indicar que la madre le hable en un solo idioma y controlar a los 4 años

> **Respuesta B.** Son señales de alerta: no balbucear a los 12 meses, no decir palabras a los 16 a 18 meses, no combinar 2 palabras a los 24 meses o cualquier pérdida de lenguaje. Ante ellas se descarta hipoacusia, se pesquisa trastorno del espectro autista (M-CHAT) y se deriva a fonoaudiología. En Chile se pesquisa con EEDP y TEPSI.

552 ped-21 · Perfil V3 6.03.4.007 · Emisiones otoacústicas · *Práctica*

Respecto al uso de emisiones otoacústicas en el tamizaje auditivo neonatal, se discute en una reunión clínica de neonatología.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Evalúan toda la vía auditiva hasta la corteza

B) Un resultado normal descarta toda hipoacusia, incluida la retrococlear

C) Requieren sedación profunda

D) Evalúan la función de las células ciliadas externas de la cóclea; son rápidas e indoloras, pero no detectan la neuropatía auditiva, por lo que en recién nacidos de UCI se prefieren los potenciales evocados

E) No se ven afectadas por líquido en el oído medio

> **Respuesta D.** Las emisiones otoacústicas registran sonidos generados por las células ciliadas externas de la cóclea. Son un tamizaje rápido, no invasivo y sin sedación, pero se alteran con vérnix o líquido en el oído medio y no evalúan la vía retrococlear (neuropatía auditiva). En recién nacidos de UCI se usan potenciales evocados automatizados.

553 ped-08 · Perfil V3 6.03.5.011 · Maniobra de Heimlich · *Práctica*

Hombre de 40 años se atraganta comiendo carne en un restaurante. Se lleva las manos al cuello, no puede hablar ni toser y se pone cianótico, pero sigue consciente.

¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Darle agua para que trague

B) Barrido digital a ciegas

C) Realizar compresiones abdominales subdiafragmáticas (maniobra de Heimlich) desde atrás, repetidas hasta expulsar el cuerpo extraño o que pierda la conciencia

D) Esperar a que tosa espontáneamente

E) Iniciar compresiones torácicas de inmediato aunque esté consciente

> **Respuesta C.** Obstrucción grave de la vía aérea (no habla, no tose) en un adulto consciente: compresiones abdominales (Heimlich) desde atrás, con el puño sobre el epigastrio; algunas guías intercalan golpes interescapulares. En embarazadas y obesos, compresiones torácicas. Si pierde la conciencia, RCP. Si la tos es efectiva, solo estimularla. No hacer barrido digital a ciegas.

Psiquiatría

554 psiq-01 · Perfil V3 1.07.1.004 · Depresión · *Práctica*

Mujer de 79 años con glaucoma de ángulo estrecho y constipación crónica presenta ánimo bajo, anhedonia, insomnio y baja de peso de 2 meses. Escala de Yesavage de 11 puntos. Sin ideación suicida ni síntomas psicóticos.

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?

A) Amitriptilina

B) Litio

C) Clonazepam

D) Imipramina

E) Sertralina

> **Respuesta E.** En el adulto mayor con depresión, los ISRS como sertralina o escitalopram son de primera línea por su buena tolerancia. Los tricíclicos (amitriptilina, imipramina) producen efectos anticolinérgicos, hipotensión y arritmias, y empeoran el glaucoma de ángulo estrecho y la constipación. Las benzodiacepinas no tratan la depresión y aumentan caídas y confusión.

555 psiq-01 · Perfil V3 2.01.1.136 · Depresión · *Práctica*

Una adolescente de 15 años presenta desde hace 2 meses ánimo bajo e irritable, anhedonia, insomnio, baja de rendimiento escolar, aislamiento y sentimientos de culpa. Niega ideación suicida. Ha recibido 8 sesiones de psicoterapia sin mejoría y los síntomas son de intensidad moderada a grave.

¿Cuál es el fármaco de elección?

A) Amitriptilina

B) Fluoxetina

C) Clonazepam

D) Litio

E) Quetiapina

> **Respuesta B.** Depresión moderada a grave en adolescentes que no responde a psicoterapia requiere agregar antidepresivo. El de elección, con mejor evidencia y recomendado por la guía GES de depresión, es la fluoxetina, manteniendo psicoterapia y vigilando ideación suicida al inicio. Los tricíclicos no son eficaces en adolescentes y son letales en sobredosis.

556 psiq-03 · Perfil V3 2.01.1.137 · Ideación suicida · *Práctica*

Un adolescente de 16 años es traído por su madre, que encontró una carta de despedida. En la entrevista a solas reconoce que desde hace semanas piensa en morir, ha planificado tomar los medicamentos de su abuela este fin de semana y no ve otra salida. Tiene antecedente de un intento previo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar fluoxetina y control en 2 semanas

B) Derivar a psicólogo en atención primaria

C) Hospitalización o evaluación psiquiátrica urgente, sin dejarlo solo

D) Firmar un contrato de no suicidio y enviar a domicilio

E) Mantener la confidencialidad y no informar a la madre

> **Respuesta C.** Ideación suicida con plan estructurado, método accesible, intención, carta de despedida e intento previo constituyen riesgo suicida alto. Requiere evaluación psiquiátrica urgente y, en general, hospitalización, con supervisión permanente y restricción de medios letales. En riesgo vital se rompe la confidencialidad para informar a la familia. Los contratos de no suicidio no son efectivos.

557 psiq-07 · Perfil V3 2.01.1.140 · Trastornos de ansiedad generalizada · *Práctica*

Un niño de 10 años presenta desde hace 8 meses preocupación excesiva y difícil de controlar por su rendimiento escolar, la salud de sus padres y eventos futuros. Se asocia a inquietud, dolor abdominal recurrente, cefalea tensional e insomnio de conciliación. Su examen físico es normal y el estudio de dolor abdominal fue negativo.

¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Clonazepam diario

B) Metilfenidato

C) Terapia cognitivo-conductual

D) Risperidona

E) Propranolol

> **Respuesta C.** Preocupación excesiva y generalizada, de más de 6 meses, con síntomas somáticos (dolor abdominal, cefalea, insomnio), corresponde a trastorno de ansiedad generalizada. En niños, el tratamiento de primera línea es la terapia cognitivo-conductual, incluyendo a la familia; si es moderado a grave o no responde, se agrega un ISRS. Las benzodiacepinas no se recomiendan de mantención en niños.

558 psiq-03 · Perfil V3 5.01.1.029 · Intento de suicidio en niños y adolescentes · *Práctica*

Adolescente de 15 años es traída a urgencia tras ingerir 20 comprimidos de paracetamol después de una discusión con su pareja. Está estable, sin compromiso de conciencia, y ya recibió manejo toxicológico. En la entrevista refiere que quería morir, que lo planificó por una semana, que lamenta seguir viva y que lo volvería a intentar.

Una vez estabilizada médicamente, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar solo a psicólogo del colegio

B) Alta con control en CESFAM en un mes

C) Alta con sertralina y control en 2 semanas

D) Alta a su domicilio si los padres se comprometen a vigilarla

E) Hospitalización con evaluación psiquiátrica urgente y supervisión continua

> **Respuesta E.** Todo intento suicida en un adolescente requiere evaluación psiquiátrica antes del alta. Planificación, intención de morir, arrepentimiento de sobrevivir e ideación persistente indican alto riesgo, por lo que corresponde hospitalizar con supervisión continua. Los antidepresivos no protegen en el corto plazo y el compromiso familiar no basta con este nivel de riesgo.

559 psiq-01 · Perfil V3 5.01.1.034 · Trastornos del ánimo en niños · *Práctica*

Adolescente de 14 años, desde hace 2 meses está irritable, con explosiones de rabia en casa, ha dejado el fútbol que le gustaba, duerme mal, bajó sus notas y dice que nada vale la pena. Niega ideación suicida. Se diagnostica un episodio depresivo moderado y se decide, junto a la psicoterapia, iniciar un antidepresivo.

¿Cuál es el fármaco de elección?

A) Amitriptilina

B) Fluoxetina

C) Paroxetina

D) Venlafaxina

E) Carbonato de litio

> **Respuesta B.** En niños y adolescentes la depresión puede manifestarse con irritabilidad en vez de tristeza. El tratamiento es psicoterapia y, en cuadros moderados a graves, un ISRS, siendo la fluoxetina el de mayor evidencia y de elección según la guía GES. Los tricíclicos no son eficaces y son letales en sobredosis; paroxetina y venlafaxina tienen peor perfil en jóvenes.

560 psiq-02 · Perfil V3 5.01.4.003 · Niveles plasmáticos de estabilizadores del ánimo · *Práctica*

Mujer de 45 años con trastorno bipolar tipo I, en tratamiento con carbonato de litio 900 mg al día, con litemia previa de 0,8 mEq/L. Hace 10 días su médico le inició hidroclorotiazida por hipertensión. Consulta por temblor grueso de manos, diarrea, vómitos y marcha inestable. Está somnolienta.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de litio porque el temblor indica descompensación

B) Suspender el litio y la tiazida, medir litemia, función renal y electrolitos, e hidratar

C) Agregar propranolol para el temblor y mantener el esquema

D) Cambiar la tiazida por enalapril y control en 1 mes

E) Iniciar haloperidol por probable episodio mixto

> **Respuesta B.** Las tiazidas (y también IECA y AINE) reducen la excreción renal de litio y elevan su nivel plasmático. Temblor grueso, síntomas digestivos, ataxia y compromiso de conciencia sugieren intoxicación: se suspende el litio, se mide litemia (rango terapéutico 0,6 a 1,2 mEq/L), creatinina y electrolitos, y se hidrata; la hemodiálisis se reserva para casos graves.

561 psiq-10 · Perfil V3 5.01.5.002 · Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito · *Práctica*

Hombre de 52 años con esquizofrenia, estable hace 8 años con flufenazina decanoato intramuscular cada 3 semanas. En su control de inyección en el CESFAM, la enfermera nota que mueve la lengua y los labios en forma repetitiva, como si masticara, y que tamborilea los dedos. El paciente no lo percibe. Sin síntomas psicóticos activos.

¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?

A) Discinesia tardía; registrar con un examen neurológico dirigido, no agregar anticolinérgicos y derivar a psiquiatría para evaluar el cambio a un antipsicótico atípico o clozapina

B) Distonía aguda; administrar biperideno intramuscular y mantener igual

C) Recaída psicótica con estereotipias; aumentar la dosis de flufenazina

D) Acatisia; indicar propranolol

E) Síndrome neuroléptico maligno; hospitalizar en UCI

> **Respuesta A.** Movimientos coreoatetósicos orolinguales y de dedos tras años de un neuroléptico típico de depósito son discinesia tardía. Por eso cada control de depósito incluye examen neurológico buscando extrapiramidalismo y discinesias. Los anticolinérgicos la empeoran; se deriva para reducir o cambiar el antipsicótico.

562 psiq-03 · Perfil V3 5.01.5.003 · Intervención en crisis · *Práctica*

Mujer de 38 años llega al SAPU 2 horas después de que su casa se incendiara por completo. Nadie resultó herido. Está llorando, temblorosa, dice que no sabe dónde dormirá esta noche con sus 2 hijos y repite que no puede pensar. No tiene antecedentes psiquiátricos ni ideas de muerte, está orientada y su examen físico es normal.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Realizar intervención en crisis: escucha activa, contención, asegurar necesidades básicas y activar redes de apoyo, con seguimiento cercano

B) Indicar diazepam endovenoso y derivar a psiquiatría

C) Pedirle que relate en detalle el incendio para procesar el trauma (debriefing obligatorio)

D) Iniciar sertralina para prevenir el trastorno de estrés postraumático

E) Hospitalizar en psiquiatría por reacción aguda a estrés

> **Respuesta A.** La intervención en crisis (primera ayuda psicológica) busca restablecer el equilibrio: escuchar sin forzar el relato, contener, cubrir necesidades básicas como seguridad y alojamiento, conectar con redes de apoyo y evaluar riesgo. El debriefing forzado y los fármacos preventivos no han demostrado beneficio y pueden empeorar la evolución.

563 psiq-09 · Perfil V3 5.01.5.003 · Intervención en crisis · *Práctica*

Hombre de 45 años presenció hace 3 horas un accidente de tránsito en que murió su compañero de trabajo. Llega al CESFAM acompañado de su esposa: está inquieto, llora a ratos, dice sentirse aturdido y teme no poder dormir. Está orientado, sin consumo de alcohol, sin ideas de muerte ni síntomas psicóticos.

¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a una adecuada intervención en crisis?

A) Indicarle que olvide lo ocurrido y retome su trabajo al día siguiente

B) Realizar una sesión única obligatoria de relato detallado del accidente

C) Iniciar clonazepam por 3 meses para prevenir un trastorno de estrés postraumático

D) Derivarlo de urgencia a hospitalización psiquiátrica

E) Escucharlo sin presionarlo a relatar detalles, validar su reacción como esperable, reforzar el apoyo de su esposa y acordar un control cercano

> **Respuesta E.** La intervención en crisis es breve y focalizada: contacto empático, escucha sin forzar el relato, normalizar la reacción, evaluar riesgo, cubrir necesidades inmediatas, activar la red de apoyo y asegurar seguimiento. Las benzodiacepinas prolongadas y el debriefing obligatorio no previenen el estrés postraumático y pueden empeorarlo.

Respiratorio

564 resp-04 · Perfil V3 1.01.3.007 · Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud · *Práctica*

Una mujer de 52 años fuma 20 cigarrillos al día desde los 18 años. En el control refiere que quiere dejar de fumar en las próximas semanas. Fuma el primer cigarrillo a los 5 minutos de despertar. No tiene antecedentes de convulsiones ni de enfermedad psiquiátrica.

Además de la consejería, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Fijar una fecha de cese e indicar farmacoterapia (vareniclina o terapia de reemplazo de nicotina)

B) Indicar reducir gradualmente a 10 cigarrillos y reevaluar en 1 año

C) Cambiar a cigarrillo electrónico en forma indefinida

D) Indicar benzodiacepinas para la ansiedad

E) Esperar que lo intente sola antes de indicar fármacos

> **Respuesta A.** Está en etapa de preparación y tiene alta dependencia (primer cigarrillo antes de 30 minutos). Se indica consejería, fecha de cese y farmacoterapia de primera línea: vareniclina, terapia de reemplazo de nicotina o bupropión. Combinar consejería y fármacos multiplica las tasas de abstinencia; solo reducir no es cesación.

565 resp-22 · Perfil V3 1.01.4.003 · Radiografía de tórax · *Práctica*

Un hombre de 70 años con antecedente de infarto antiguo consulta por disnea progresiva y ortopnea. La radiografía de tórax muestra índice cardiotorácico de 0,6, redistribución de flujo hacia los vértices, líneas B de Kerley y derrame pleural bilateral pequeño.

¿Cuál es la interpretación más probable de la radiografía?

A) Edema pulmonar cardiogénico por insuficiencia cardíaca

B) Neumonía bilateral

C) Síndrome de distrés respiratorio agudo

D) Fibrosis pulmonar

E) Derrame pleural tuberculoso

> **Respuesta A.** Cardiomegalia (índice cardiotorácico sobre 0,5), redistribución de flujo a los vértices, líneas B de Kerley y derrame bilateral son signos clásicos de congestión por insuficiencia cardíaca. En el SDRA el edema es no cardiogénico: corazón de tamaño normal, sin redistribución ni líneas de Kerley y con infiltrados más periféricos.

566 resp-22 · Perfil V3 1.04.2.011 · Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19 · *Práctica*

Una mujer de 68 años, diabética, cursa su día 8 de COVID-19. Presenta disnea, FR 30 por minuto y saturación de 88% ambiental. La radiografía muestra infiltrados bilaterales periféricos en vidrio esmerilado. Se inicia oxígeno.

¿Cuál de las siguientes terapias ha demostrado reducir la mortalidad en este contexto?

A) Azitromicina

B) Hidroxicloroquina

C) Dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días

D) Ivermectina

E) Plasma convaleciente de rutina

> **Respuesta C.** En COVID-19 con hipoxemia que requiere oxígeno o ventilación, la dexametasona 6 mg diarios por hasta 10 días redujo la mortalidad (estudio RECOVERY). Se asocia tromboprofilaxis y, en casos seleccionados, inmunomoduladores como tocilizumab. Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina y plasma convaleciente de rutina no mostraron beneficio.

567 resp-02 · Perfil V3 1.05.1.002 · Asma bronquial grave · *Práctica*

Mujer de 35 años con asma desde la adolescencia, en tratamiento con budesonida/formoterol en dosis alta más tiotropio. Se verificó adherencia y técnica inhalatoria correctas, y se trataron su rinosinusitis y su reflujo. Aun así tuvo 3 cursos de prednisona oral en el último año. Eosinófilos en sangre 480/μL, IgE total elevada.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener prednisona oral 20 mg/día indefinidamente

B) Agregar teofilina como única medida

C) Cambiar a salbutamol en horario cada 4 horas

D) Suspender el corticoide inhalado por falta de respuesta

E) Derivar a broncopulmonar para evaluar terapia biológica

> **Respuesta E.** Asma grave: no controlada pese a corticoide inhalado en dosis alta con LABA, habiendo corregido adherencia, técnica y comorbilidades. Con fenotipo eosinofílico corresponde derivar a especialista para biológicos (anti-IL5 o anti-IgE). El corticoide oral crónico es la última opción por su toxicidad.

568 resp-03 · Perfil V3 1.05.1.002 · Asma bronquial grave · *Práctica*

Hombre de 42 años con asma, en tratamiento con fluticasona/salmeterol en dosis media. Refiere síntomas diurnos casi diarios, despertares nocturnos semanales y 2 crisis en el año. Al observarlo usar su inhalador presurizado, dispara sin coordinar con la inspiración y no hace apnea. Retira sus inhaladores en forma irregular.

Antes de catalogarlo como asma grave y subir de escalón, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar prednisona oral en dosis bajas permanentes

B) Corregir la técnica inhalatoria (por ejemplo, con aerocámara) y reforzar la adherencia

C) Derivar de inmediato para terapia biológica

D) Agregar montelukast y teofilina

E) Cambiar a salbutamol nebulizado en horario

> **Respuesta B.** La mayoría del asma 'difícil' no es grave: es mala técnica, mala adherencia o comorbilidades no tratadas. Antes de subir de escalón o hablar de asma grave hay que corregir la técnica (aerocámara con el presurizado), reforzar la adherencia y reevaluar en semanas.

569 resp-06 · Perfil V3 1.05.1.005 · Bronquitis aguda · *Práctica*

Una mujer de 40 años, sin comorbilidades, consulta por tos con expectoración amarillenta de 10 días, posterior a un cuadro de coriza. Está afebril, con FC 80 por minuto, FR 16 por minuto y saturación 97%; al examen pulmonar hay roncus aislados, sin crépitos.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Amoxicilina por 7 días por la expectoración amarilla

B) Corticoides orales

C) Radiografía de tórax y levofloxacino

D) Manejo sintomático, sin antibióticos, explicando que la tos puede durar hasta 3 semanas

E) Azitromicina por 5 días

> **Respuesta D.** Es una bronquitis aguda: tos, con o sin expectoración incluso purulenta, tras una infección viral, sin signos de neumonía (afebril, signos vitales normales, sin focalización). Es mayormente viral y autolimitada, y la tos puede durar 2 a 3 semanas. No requiere radiografía ni antibióticos; el color del esputo no indica infección bacteriana.

570 resp-04 · Perfil V3 1.05.1.008 · Corazón pulmonar crónico · *Práctica*

Un hombre de 70 años con EPOC grave presenta edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular y hepatomegalia. El ecocardiograma muestra dilatación del ventrículo derecho y presión de arteria pulmonar estimada de 55 mmHg, con FEVI normal. Gases arteriales en reposo: PaO2 52 mmHg.

¿Cuál es la intervención que ha demostrado mejorar la sobrevida en esta condición?

A) Digoxina

B) Oxigenoterapia crónica domiciliaria más de 15 horas al día

C) Betabloqueadores

D) Anticoagulación oral

E) Sildenafil en todos los casos

> **Respuesta B.** El cor pulmonale por EPOC con hipoxemia crónica (PaO2 ≤55 mmHg, o 56-59 con cor pulmonale o poliglobulia) tiene indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria más de 15 horas al día, única intervención que mejora la sobrevida al revertir la vasoconstricción hipóxica. Los diuréticos alivian el edema; la digoxina no se indica salvo FA.

571 resp-20 · Perfil V3 1.05.1.019 · Hemoptisis leve y mediana · *Práctica*

Hombre de 58 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por 1 semana de expectoración con estrías de sangre, menos de 20 mL al día. Hemodinámicamente estable, SatO2 97 % ambiental, sin fiebre. Examen pulmonar normal. Radiografía de tórax normal. Pruebas de coagulación normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Estudio ambulatorio con TAC de tórax y fibrobroncoscopía

B) Alta sin estudio, porque la radiografía es normal

C) Hospitalizar en UCI y embolización de arterias bronquiales

D) Ácido tranexámico y control solo si se repite

E) Antibiótico por bronquitis y alta sin control

> **Respuesta A.** Hemoptisis leve en un paciente estable se estudia en forma ambulatoria. Mayor de 40 años y gran fumador tiene alto riesgo de cáncer bronquial aun con radiografía normal: se completa con TAC de tórax y fibrobroncoscopía. La embolización se reserva para la hemoptisis masiva.

572 resp-21 · Perfil V3 1.05.1.023 · Insuficiencia respiratoria crónica · *Práctica*

Un hombre de 68 años con EPOC grave, estable y sin exacerbación reciente, tiene gases arteriales en reposo: pH 7,37, PaCO2 58 mmHg, PaO2 58 mmHg y HCO3 33 mEq/L.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Insuficiencia respiratoria crónica global (hipoxémica e hipercápnica) con compensación metabólica

B) Acidosis respiratoria aguda descompensada

C) Alcalosis metabólica primaria

D) Gases arteriales normales

E) Acidosis metabólica

> **Respuesta A.** PaO2 bajo 60 mmHg y PaCO2 sobre 45 mmHg definen insuficiencia respiratoria global. El pH casi normal con bicarbonato elevado refleja retención renal de bicarbonato, propia de un proceso crónico compensado; en una acidosis respiratoria aguda el pH estaría claramente bajo. En hipercápnicos crónicos el oxígeno se titula a saturación de 88 a 92%.

573 resp-24 · Perfil V3 1.05.1.024 · Intoxicación leve por CO y otros gases · *Práctica*

Hombre de 40 años, sano, consulta junto a su familia por cefalea leve y náuseas tras pasar la noche con un calefactor a gas en una pieza cerrada. Consciente, orientado, sin focalidad, sin dolor torácico. PA 125/80 mmHg, SatO2 98 % por oxímetro de pulso. ECG normal. Co-oximetría: COHb 9 %.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Alta inmediata, porque la saturación es normal

B) Derivar a cámara hiperbárica de inmediato

C) Oxígeno al 100 % normobárico con mascarilla con reservorio hasta resolver los síntomas, y evaluar a los convivientes

D) Oxígeno por naricera a 1 L/min por 1 hora

E) Azul de metileno endovenoso

> **Respuesta C.** Intoxicación leve por CO: síntomas menores, sin compromiso de conciencia, sin isquemia ni embarazo, y COHb menor de 25 %. Se trata con oxígeno al 100 % normobárico (mascarilla con reservorio), que acorta la vida media de la COHb, hasta que cedan los síntomas. Se estudia a los expuestos y se elimina la fuente.

574 resp-16 · Perfil V3 1.05.1.025 · Metástasis pulmonares · *Práctica*

Una mujer de 58 años, operada de un cáncer de colon hace 2 años, presenta en una TAC de control múltiples nódulos pulmonares bilaterales, redondeados, bien definidos, de distintos tamaños y de predominio periférico y basal. Está asintomática.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis miliar

B) Neumonía multifocal

C) Cáncer pulmonar primario múltiple

D) Granulomatosis con poliangeítis

E) Metástasis pulmonares hematógenas

> **Respuesta E.** Nódulos múltiples, redondeados, bien definidos, de distintos tamaños, periféricos y basales en un paciente con cáncer previo son metástasis hematógenas hasta demostrar lo contrario (imagen en 'suelta de globos'). El pulmón es sitio frecuente de metástasis de colon, mama, riñón, sarcomas y testículo. La TBC miliar da micronódulos uniformes de 1 a 3 mm con síntomas sistémicos.

575 resp-17 · Perfil V3 1.05.1.034 · Síndromes mediastínicos · *Práctica*

Hombre de 63 años, fumador de 50 paquetes-año, con 3 semanas de edema facial y de ambos brazos que empeora al agacharse, disnea leve y cefalea matinal. Ingurgitación yugular sin pulso y circulación colateral en la pared torácica anterior. Sin estridor ni compromiso de conciencia. Radiografía: ensanchamiento mediastínico superior derecho.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Radioterapia de urgencia antes de cualquier estudio

B) Esternotomía exploradora de urgencia

C) Corticoides en altas dosis y alta

D) Trombólisis sistémica

E) TAC de tórax con contraste y obtener diagnóstico histológico antes de tratar

> **Respuesta E.** Síndrome de vena cava superior subagudo, sin estridor ni edema cerebral: no es una emergencia que impida estudiar. Se hace TAC con contraste y se obtiene histología (broncoscopía, biopsia de adenopatía) antes de tratar, porque linfoma y cáncer microcítico se tratan con quimioterapia. La radioterapia empírica arruina la biopsia.

576 resp-03 · Perfil V3 1.05.1.035 · Tos crónica · *Práctica*

Una mujer de 58 años, no fumadora, consulta por tos seca persistente de 3 meses. Hace 4 meses inició enalapril por hipertensión arterial. Su radiografía de tórax es normal y no tiene síntomas de reflujo, rinitis ni sibilancias.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar omeprazol empírico

B) Solicitar TAC de tórax

C) Iniciar un corticoide inhalado

D) Suspender el enalapril y cambiar a un ARA II (como losartán)

E) Iniciar codeína a permanencia

> **Respuesta D.** La tos crónica (más de 8 semanas) en no fumadores con radiografía normal se debe principalmente a goteo postnasal, asma y reflujo, pero siempre debe descartarse el uso de IECA, que causa tos seca en 5 a 20% de los usuarios por acumulación de bradicinina. Se cambia a un ARA II y la tos cede en 1 a 4 semanas.

577 resp-21 · Perfil V3 1.05.2.009 · Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada, · *Práctica*

Una mujer de 72 años con EPOC grave presenta una exacerbación con disnea intensa, FR 30 por minuto y uso de musculatura accesoria. Está vigil y cooperadora. Gases arteriales: pH 7,28, PaCO2 68 mmHg, PaO2 50 mmHg, HCO3 31 mEq/L.

Además de broncodilatadores, corticoides y oxígeno controlado, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Intubación inmediata en todos los casos

B) Oxígeno con mascarilla de reservorio al 100%

C) Ventilación mecánica no invasiva (BiPAP)

D) Bicarbonato endovenoso

E) Sedación con benzodiacepinas

> **Respuesta C.** La insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda sobre crónica con acidosis (pH bajo 7,35, PaCO2 sobre 45 mmHg) en una exacerbación de EPOC, con paciente vigil y cooperador, es la principal indicación de ventilación no invasiva: reduce intubación y mortalidad. El oxígeno se titula a 88-92%, porque al 100% empeora la hipercapnia. Se intuba si fracasa.

578 resp-14 · Perfil V3 1.05.2.011 · Neumotórax hipertensivo · *Práctica*

Hombre de 25 años, motociclista, traído tras una caída a alta velocidad. Agitado, FR 36/min, SatO2 82 %, PA 70/40 mmHg, FC 140 lpm. Yugulares ingurgitadas, tráquea desviada a la izquierda, hemitórax derecho hiperinsuflado, timpánico y sin murmullo pulmonar.

¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Radiografía de tórax portátil para confirmar el diagnóstico

B) Intubación orotraqueal y ventilación con presión positiva antes de cualquier otra medida

C) Pericardiocentesis subxifoidea

D) Descompresión inmediata con aguja en el hemitórax derecho y luego tubo pleural

E) Tubo pleural en el hemitórax izquierdo

> **Respuesta D.** Shock obstructivo con yugulares ingurgitadas, tráquea desviada al lado contrario y hemitórax timpánico sin murmullo: neumotórax a tensión. Es un diagnóstico clínico y se descomprime de inmediato con aguja (2.º espacio intercostal en la línea medioclavicular, o 5.º en la axilar), seguido de tubo pleural. La radiografía no debe retrasarlo.

579 resp-18 · Perfil V3 1.05.3.002 · Prevención de daño pulmonar por inhalantes domésticos y laborales · *Práctica*

Un hombre de 50 años trabaja hace 20 años en una mina subterránea perforando roca sin protección respiratoria. Presenta disnea progresiva. La radiografía muestra múltiples nódulos pequeños en lóbulos superiores y adenopatías hiliares con calcificación 'en cáscara de huevo'.

¿Cuál es la medida más importante para prevenir esta enfermedad en los demás trabajadores?

A) Antibióticos profilácticos

B) Corticoides inhalados preventivos

C) Vacunación BCG anual

D) Control de la exposición (técnicas húmedas y ventilación), protección respiratoria certificada y vigilancia médica con radiografía periódica

E) Suplementos de vitamina D

> **Respuesta D.** La silicosis es una neumoconiosis por inhalación de sílice cristalina, sin tratamiento curativo, que predispone a tuberculosis y cáncer pulmonar. Se previene controlando la exposición (técnicas húmedas, ventilación, encierro de procesos), con protección respiratoria adecuada y vigilancia ocupacional con radiografía periódica. Debe notificarse como enfermedad profesional.

580 resp-04 · Perfil V3 1.05.3.004 · Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud · *Práctica*

Hombre de 62 años, fumador activo de 20 cigarrillos al día (40 paquetes-año), con EPOC GOLD 2 recién diagnosticada. Pregunta qué puede hacer para que su enfermedad avance más lento.

¿Cuál de las siguientes intervenciones ha demostrado enlentecer la caída anual del VEF1?

A) Tiotropio inhalado

B) Corticoide inhalado en dosis alta

C) Dejar de fumar

D) Vacuna antineumocócica

E) Rehabilitación pulmonar

> **Respuesta C.** La cesación tabáquica es la única intervención que normaliza la velocidad de caída del VEF1 y, junto al oxígeno domiciliario en hipoxémicos, la que reduce mortalidad. Broncodilatadores y corticoides mejoran síntomas y exacerbaciones, pero no cambian la historia natural. Se debe ofrecer consejería más fármacos.

581 resp-10 · Perfil V3 1.05.3.005 · Vacunación (tuberculosis, influenza, Coronavirus SARS-CoV-2 y neumococo) · *Práctica*

Una madre consulta en el control de su hijo de 1 mes por la vacuna BCG que este recibió antes del alta de la maternidad.

¿Cuál es el principal beneficio de la vacuna BCG?

A) Previene totalmente la tuberculosis pulmonar del adulto

B) Protege contra las formas graves de tuberculosis en la infancia, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar

C) Previene la infección por micobacterias atípicas

D) Reemplaza el estudio y tratamiento de los contactos

E) Protege contra la influenza

> **Respuesta B.** La BCG, incluida en el PNI chileno, se administra al recién nacido. Su principal beneficio demostrado es la protección contra las formas graves y diseminadas de tuberculosis en niños (meningitis tuberculosa y miliar); su protección contra la tuberculosis pulmonar del adulto es variable y limitada. Por ser de bacterias vivas atenuadas, se contraindica en inmunodeficiencias.

582 resp-06 · Perfil V3 1.05.4.001 · Radiografía de tórax · *Práctica*

Mujer de 66 años con 3 días de fiebre y tos productiva. En la radiografía de tórax posteroanterior se observa una opacidad de tipo alveolar con broncograma aéreo que borra el contorno del borde derecho de la silueta cardíaca; el hemidiafragma derecho se ve nítido.

¿Cuál es la localización más probable de la condensación?

A) Lóbulo medio

B) Lóbulo superior derecho

C) Segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho

D) Língula

E) Segmento apical del lóbulo inferior derecho

> **Respuesta A.** Signo de la silueta: una opacidad que borra un borde indica que está en contacto anatómico con él. El borde cardíaco derecho (aurícula derecha) limita con el lóbulo medio; si se borrara el hemidiafragma, sería el lóbulo inferior. Borrar el borde cardíaco izquierdo orienta a la língula.

583 resp-11 · Perfil V3 1.05.4.003 · Ecografía pleural · *Práctica*

Un hombre de 65 años hospitalizado por neumonía presenta en la radiografía un leve velamiento del seno costofrénico derecho. Se planea una toracocentesis diagnóstica.

¿Cuál es la principal utilidad de la ecografía pleural en este caso?

A) Medir el pH del líquido

B) Confirmar y cuantificar el derrame, detectar tabiques y guiar la punción para reducir complicaciones

C) Reemplazar el análisis del líquido pleural

D) Diagnosticar cáncer pulmonar

E) Ninguna, porque la radiografía es superior

> **Respuesta B.** La ecografía pleural es más sensible que la radiografía para detectar derrames pequeños, permite estimar su volumen, detectar tabiques o loculaciones (sugerentes de derrame complicado) y elegir el sitio de punción. La toracocentesis guiada por ecografía reduce neumotórax y punciones fallidas. No reemplaza el estudio citoquímico y microbiológico del líquido.

584 resp-03 · Perfil V3 1.05.4.005 · Espirometría · *Práctica*

Mujer de 24 años con episodios de tos nocturna, sibilancias y disnea con el ejercicio desde hace 1 año. Espirometría: VEF1/CVF 0,68; VEF1 2,10 L (74 % del predicho). Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1 2,46 L.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Espirometría normal

B) Patrón restrictivo

C) Obstrucción con respuesta broncodilatadora significativa, compatible con asma

D) EPOC por VEF1/CVF menor de 0,70

E) Obstrucción fija sin respuesta broncodilatadora

> **Respuesta C.** Hay obstrucción (VEF1/CVF bajo 0,70) y el VEF1 sube 360 mL, un 17 %: supera el umbral de respuesta broncodilatadora significativa (12 % y 200 mL). En una joven con síntomas variables, confirma asma. En la EPOC la obstrucción persiste tras el broncodilatador.

585 resp-04 · Perfil V3 1.05.4.005 · Espirometría · *Práctica*

Hombre de 58 años, fumador de 30 paquetes-año, con tos matinal y disnea de grandes esfuerzos. Espirometría basal: VEF1/CVF 0,66; VEF1 82 % del predicho. Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1/CVF 0,74; VEF1 91 % del predicho.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) EPOC GOLD 1 confirmada

B) Patrón restrictivo

C) EPOC GOLD 2 por VEF1 basal bajo 85 %

D) No se confirma EPOC: la relación VEF1/CVF posbroncodilatador es mayor de 0,70

E) Asma grave

> **Respuesta D.** El diagnóstico de EPOC exige obstrucción persistente: VEF1/CVF menor de 0,70 después del broncodilatador. Aquí la obstrucción revierte (0,74), así que no se confirma EPOC. Igual corresponde indicar cesación tabáquica y reevaluar, porque tiene síntomas y factor de riesgo.

586 resp-06 · Perfil V3 1.05.4.006 · Examen microbiológico de expectoración · *Práctica*

Se envía una muestra de expectoración de un paciente hospitalizado por neumonía para Gram y cultivo. El informe señala más de 25 células epiteliales y menos de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo de bajo aumento.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Muestra de buena calidad: se debe tratar el germen que crezca

B) Confirma neumonía neumocócica

C) Muestra no representativa (saliva), no apta para cultivo: se debe repetir

D) Indica tuberculosis

E) Indica infección viral

> **Respuesta C.** La calidad de la expectoración se evalúa con el criterio de Murray-Washington: una muestra útil tiene más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo de bajo aumento. Muchas células epiteliales indican contaminación con saliva y flora orofaríngea, por lo que el cultivo no es interpretable y la muestra debe repetirse.

587 resp-12 · Perfil V3 1.05.4.008 · Examen microbiológico de líquido pleural · *Práctica*

Un hombre de 55 años con neumonía basal derecha persiste febril al 4° día de tratamiento. La toracocentesis obtiene líquido turbio, no purulento, con pH 7,10, glucosa 35 mg/dL y LDH 1.500 U/L. El Gram del líquido muestra diplococos grampositivos.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener los antibióticos sin otra intervención

B) Suspender los antibióticos y observar

C) Repetir la toracocentesis en 1 semana

D) Instalar drenaje pleural (tubo pleural) además de los antibióticos

E) Iniciar corticoides

> **Respuesta D.** Un Gram o cultivo positivo del líquido pleural, o pH bajo 7,20, glucosa bajo 60 mg/dL o pus, definen un derrame paraneumónico complicado o empiema, que requiere drenaje pleural además de antibióticos. Si hay loculaciones que impiden el drenaje, se consideran fibrinolíticos intrapleurales o videotoracoscopía.

588 resp-02 · Perfil V3 1.05.4.009 · Flujo espiratorio máximo (PEF: Peak Expiratory Flow) · *Práctica*

Mujer de 26 años con crisis asmática en el SAPU. Ingresó con PEF de 45 % del predicho. Recibió oxígeno, 3 nebulizaciones de salbutamol con ipratropio y prednisona 40 mg oral. Una hora después: habla frases completas, FR 18/min, SatO2 96 % ambiental, sibilancias escasas y PEF 78 % del predicho.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar en sala para tratamiento endovenoso

B) Alta sin tratamiento, ya que el PEF es normal

C) Sulfato de magnesio endovenoso antes del alta

D) Mantener en observación 24 horas aunque esté estable

E) Alta con prednisona por 5 a 7 días, corticoide inhalado y control precoz

> **Respuesta E.** El PEF objetiva la respuesta: sobre 70 % del predicho a la hora, con clínica estable y SatO2 normal, permite el alta. Debe irse con corticoide oral 5 a 7 días, inicio o ajuste del corticoide inhalado, plan de acción y control precoz. Bajo 50 % tras tratamiento obliga a hospitalizar.

589 resp-02 · Perfil V3 1.05.4.010 · Gases en sangre arterial · *Práctica*

Hombre de 19 años con crisis asmática de 6 horas. Tras 1 hora de salbutamol con ipratropio está somnoliento, con FR 30/min, uso de musculatura accesoria y murmullo pulmonar muy disminuido, casi sin sibilancias. Gases con oxígeno: pH 7,35, PaCO2 45 mmHg, PaO2 62 mmHg, HCO3 24 mEq/L.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de los gases?

A) Signo de agotamiento respiratorio inminente; manejo en UCI y preparar intubación

B) Gases tranquilizadores: la PaCO2 es normal

C) Alcalosis respiratoria esperable en la crisis

D) Acidosis metabólica por uso de salbutamol

E) Hipoxemia leve que solo requiere más oxígeno

> **Respuesta A.** En la crisis asmática el paciente hiperventila y la PaCO2 debe estar baja. Una PaCO2 normal o alta, con somnolencia y tórax silencioso, indica fatiga muscular y paro respiratorio inminente: crisis de riesgo vital que requiere UCI y preparar intubación.

590 resp-05 · Perfil V3 1.05.4.010 · Gases en sangre arterial · *Práctica*

Hombre de 69 años con EPOC GOLD 3 consulta por exacerbación de 3 días. Somnoliento pero obedece órdenes, FR 30/min, SatO2 87 % con oxígeno por cánula a 2 L/min. Gases: pH 7,31, PaCO2 62 mmHg, PaO2 56 mmHg, HCO3 30 mEq/L.

¿Cuál es la interpretación de los gases y la conducta más adecuada?

A) Acidosis respiratoria crónica compensada; aumentar el oxígeno a 6 L/min

B) Acidosis respiratoria crónica compensada; alta con broncodilatadores

C) Acidosis metabólica; bicarbonato endovenoso

D) Alcalosis metabólica; suspender los corticoides

E) Acidosis respiratoria aguda sobre crónica; iniciar ventilación mecánica no invasiva

> **Respuesta E.** El HCO3 alto indica retención crónica de CO2, pero el pH bajo 7,35 muestra que la compensación no alcanza: hay un componente agudo. Acidosis respiratoria aguda sobre crónica con pH entre 7,25 y 7,35 es la indicación clásica de ventilación no invasiva en la exacerbación de EPOC.

591 resp-21 · Perfil V3 1.05.4.010 · Gases en sangre arterial · *Práctica*

Hombre de 35 años con síndrome de Guillain-Barré en progresión, con debilidad de extremidades y tos débil. Murmullo pulmonar normal, radiografía de tórax normal. Gases arteriales con aire ambiental (FiO2 21 %, a nivel del mar): pH 7,32, PaCO2 58 mmHg, PaO2 66 mmHg, HCO3 29 mEq/L.

¿Cuál es el mecanismo de la hipoxemia?

A) Alteración ventilación/perfusión por neumonía

B) Disminución de la FiO2 por altura

C) Cortocircuito intrapulmonar por SDRA

D) Trastorno de difusión por fibrosis

E) Hipoventilación alveolar pura, con gradiente alvéolo-arterial normal

> **Respuesta E.** PAO2 = 150 – (58 / 0,8) ≈ 77 mmHg; gradiente A-a = 77 – 66 ≈ 11 mmHg, normal. Hipercapnia con gradiente normal y pulmón sano indica hipoventilación pura, aquí por debilidad neuromuscular. El tratamiento es ventilatorio; el oxígeno solo no corrige la causa.

592 resp-24 · Perfil V3 1.05.4.014 · Saturometría arterial · *Práctica*

Una familia de 4 personas consulta en invierno por cefalea, náuseas y mareos que comenzaron en la noche, en una casa calefaccionada con brasero. Una mujer de 40 años está somnolienta y tiene saturometría de pulso de 99% ambiental.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de la saturometría?

A) Puede estar falsamente normal, porque el oxímetro convencional no distingue carboxihemoglobina de oxihemoglobina: se debe medir carboxihemoglobina

B) Descarta una intoxicación por monóxido de carbono

C) Indica que no requiere oxígeno

D) Indica hiperventilación

E) Indica anemia

> **Respuesta A.** El oxímetro de pulso convencional usa 2 longitudes de onda y lee la carboxihemoglobina como oxihemoglobina, por lo que la saturación aparece falsamente normal en la intoxicación por CO. Se mide carboxihemoglobina por cooximetría en gases arteriales o venosos y se inicia de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de alto flujo, sin esperar el resultado.

593 resp-15 · Perfil V3 1.05.5.002 · Biopsia pleural · *Práctica*

Mujer de 68 años, exfumadora, con baja de peso y derrame pleural derecho recidivante. Dos toracocentesis muestran exudado linfocitario con ADA 18 U/L y citología negativa para células neoplásicas en ambas muestras. TAC de tórax: engrosamiento pleural nodular derecho.

¿Cuál es el procedimiento más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Toracoscopía (pleuroscopía) con biopsia pleural dirigida

B) Pleurodesis con talco sin diagnóstico histológico

C) Tercera citología del líquido pleural

D) Tratamiento antituberculoso empírico

E) Marcadores tumorales en sangre

> **Respuesta A.** Ante sospecha de derrame neoplásico con 2 citologías negativas, una tercera rinde poco. La toracoscopía permite ver la pleura y biopsiar los nódulos bajo visión directa, con rendimiento superior a 90 % para neoplasia, y en el mismo acto hacer pleurodesis. El ADA bajo hace improbable la tuberculosis.

594 resp-12 · Perfil V3 1.05.5.004 · Drenaje pleural · *Práctica*

Hombre de 45 años con empiema pleural izquierdo confirmado. Se decide instalar un tubo de drenaje pleural en decúbito supino con el brazo en abducción.

¿Cuál es el sitio de inserción recomendado?

A) 2.º espacio intercostal, línea medioclavicular

B) 8.º espacio intercostal, línea escapular

C) 4.º o 5.º espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media (triángulo de seguridad)

D) Región subxifoidea

E) Borde inferior de la 5.ª costilla, línea axilar posterior

> **Respuesta C.** El tubo se instala en el triángulo de seguridad: borde lateral del pectoral mayor, borde anterior del dorsal ancho y línea del pezón (4.º a 5.º espacio), sobre el borde superior de la costilla inferior. Evita la arteria mamaria, el diafragma y las vísceras abdominales, y se conecta a trampa de agua.

595 resp-09 · Perfil V3 1.05.5.005 · Fibrobroncoscopia · *Práctica*

Hombre de 67 años, fumador de 50 paquetes-año, desdentado total, sin alcoholismo ni trastornos de conciencia ni de deglución. Consulta por 4 semanas de fiebre y tos purulenta. Radiografía: cavidad de 5 cm con nivel hidroaéreo en el lóbulo superior derecho. Baciloscopías negativas.

Además de iniciar antibióticos, ¿cuál es el estudio más adecuado?

A) Ninguno: es un absceso por aspiración típico

B) Fibrobroncoscopía para descartar una neoplasia endobronquial obstructiva

C) Cintigrafía pulmonar

D) Ecocardiograma transesofágico

E) Prueba de tuberculina

> **Respuesta B.** Un absceso sin factores de aspiración, en un desdentado (sin dientes no hay flora anaerobia gingival abundante), en un gran fumador mayor, obliga a descartar un cáncer bronquial que obstruye y abscede el pulmón distal, o un carcinoma cavitado. La fibrobroncoscopía visualiza la vía aérea y permite biopsia.

596 resp-03 · Perfil V3 1.05.5.006 · Inhalación de aerosoles presurizados · *Práctica*

Un niño de 6 años con asma usa salbutamol en inhalador presurizado de dosis medida. La madre refiere que no mejora durante las crisis. Al observar la técnica, el niño dispara el inhalador directamente en la boca y respira rápidamente.

¿Cuál es la indicación más adecuada para mejorar la técnica?

A) Cambiar a salbutamol en jarabe

B) Indicar nebulizaciones diarias permanentes

C) Aumentar el número de puffs sin cambiar la técnica

D) Usar aerocámara (espaciador), con mascarilla o boquilla según la edad, y realizar varias respiraciones tras cada puff

E) Disparar el inhalador hacia la nariz

> **Respuesta D.** La mayoría de los pacientes, especialmente los niños, no coordina el disparo con la inspiración, y gran parte del fármaco queda en la orofaringe. La aerocámara mejora el depósito pulmonar y reduce efectos locales: se agita el inhalador, se dispara un puff en la aerocámara y se respira 5 a 6 veces por puff. Los jarabes no se recomiendan.

597 resp-21 · Perfil V3 1.05.5.007 · Intubación traqueal · *Práctica*

Se intuba a un paciente de 60 años por insuficiencia respiratoria aguda. Tras pasar el tubo se ausculta murmullo pulmonar bilateral, pero se requiere confirmar en forma objetiva que el tubo está en la tráquea.

¿Cuál es el método más confiable para confirmar de inmediato la intubación traqueal?

A) Empañamiento del tubo

B) Ausencia de ruidos en el epigastrio

C) Expansión torácica

D) Saturometría a los 5 minutos

E) Capnografía con curva de CO2 espirado persistente

> **Respuesta E.** La capnografía de onda continua, que muestra CO2 espirado en ciclos sucesivos, es el método más confiable para confirmar la posición traqueal del tubo y detectar desplazamientos. Los signos clínicos pueden engañar y la saturación cae tardíamente en una intubación esofágica. Luego se verifica la altura del tubo con radiografía de tórax.

598 resp-02 · Perfil V3 1.05.5.008 · Nebulizaciones · *Práctica*

Mujer de 32 años, asmática, consulta en urgencia por disnea progresiva de 6 horas. Habla en palabras sueltas, FR 32/min, FC 124/min, SatO2 87% con aire ambiental, uso de musculatura accesoria y sibilancias difusas. Está muy ansiosa y no logra coordinar la inhalación.

¿Cuál es la forma más adecuada de administrar el broncodilatador inicial?

A) Salbutamol más bromuro de ipratropio nebulizados con oxígeno a 6-8 L/min

B) Salbutamol en polvo seco inhalado

C) Salbutamol en inhalador de dosis medida sin aerocámara

D) Salbutamol nebulizado con aire comprimido, agregando oxígeno solo si persiste la hipoxemia

E) Salbutamol endovenoso como primera línea

> **Respuesta A.** Crisis asmática grave con hipoxemia en una paciente que no coordina: la nebulización impulsada por oxígeno a 6-8 L/min entrega el broncodilatador y corrige la hipoxemia a la vez, y en crisis grave se asocia ipratropio. Nebulizar con aire comprimido en una paciente hipoxémica empeora la desaturación. La vía endovenosa no es primera línea.

599 resp-11 · Perfil V3 1.05.5.009 · Punción pleural · *Práctica*

Mujer de 70 años con derrame pleural derecho de causa no aclarada que ocupa un tercio del hemitórax. Se planifica toracocentesis diagnóstica con la paciente sentada, guiada por ecografía.

¿Cuál es el sitio y la técnica correctos de punción?

A) Borde inferior de la costilla superior, en la línea medioclavicular

B) Borde superior de la costilla inferior, en la línea axilar posterior o escapular, un espacio bajo el nivel del derrame

C) 2.º espacio intercostal en la línea medioclavicular

D) Bajo el 10.º espacio intercostal para asegurar el máximo de líquido

E) Sitio indistinto si se usa aguja fina

> **Respuesta B.** El paquete vasculonervioso intercostal corre por el borde inferior de cada costilla; por eso se punciona sobre el borde superior de la costilla inferior. Con la paciente sentada, en la línea axilar posterior o escapular, idealmente guiado por ecografía, y sin bajar demasiado para no puncionar hígado o bazo.

600 resp-21 · Perfil V3 1.05.5.011 · Ventilación mecánica invasiva · *Práctica*

Hombre de 72 años con exacerbación de EPOC, en ventilación mecánica no invasiva desde hace 2 horas. Ahora está en sopor, Glasgow 8, con abundantes secreciones que no logra expectorar y vómitos. FR 36/min. Gases: pH 7,17, PaCO2 88 mmHg (al ingreso pH 7,28 y PaCO2 68 mmHg).

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener la ventilación no invasiva y aumentar la presión inspiratoria

B) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva

C) Bicarbonato de sodio endovenoso

D) Cambiar a oxígeno con mascarilla de alto flujo al 100 %

E) Naloxona endovenosa

> **Respuesta B.** Fracaso de la ventilación no invasiva: empeoramiento del pH y la PaCO2 tras 1 a 2 horas, compromiso de conciencia, incapacidad de manejar secreciones y vómitos. Son contraindicaciones para continuarla y obligan a intubar y conectar a ventilación invasiva. Insistir con la máscara retrasa la intubación y aumenta la mortalidad.

601 resp-17 · Perfil V3 1.08.1.016 · Síndrome paraneoplásico · *Práctica*

Hombre de 64 años, fumador de 50 paquetes-año, con masa hiliar central en la radiografía de tórax, presenta náuseas y somnolencia. Sodio 119 mEq/L, osmolalidad plasmática 250 mOsm/kg, osmolalidad urinaria 520 mOsm/kg, sodio urinario 60 mEq/L. Está euvolémico y la función tiroidea y el cortisol son normales.

¿Cuál es el tipo histológico más probablemente asociado?

A) Adenocarcinoma

B) Carcinoma escamoso

C) Carcinoma de células pequeñas

D) Carcinoma de células grandes

E) Tumor carcinoide periférico

> **Respuesta C.** Hiponatremia hipotónica euvolémica con orina concentrada y sodio urinario alto es un SIADH, síndrome paraneoplásico clásico del carcinoma pulmonar de células pequeñas, tumor central de fumadores, que también produce ACTH ectópica y síndrome de Lambert-Eaton. El carcinoma escamoso se asocia típicamente a hipercalcemia por PTHrP.

602 resp-17 · Perfil V3 1.08.2.008 · Síndrome vena cava superior · *Práctica*

Hombre de 58 años, fumador, consulta por edema de cara y cuello, plétora facial y disnea leve de 2 semanas, que empeora al agacharse. Se observa circulación colateral en la pared torácica anterior. Está vigil, sin estridor. La radiografía muestra ensanchamiento mediastínico superior derecho. No tiene diagnóstico oncológico previo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Radioterapia de urgencia antes de cualquier estudio

B) TAC de tórax con contraste y obtención de diagnóstico histológico antes de tratar

C) Corticoides empíricos en dosis altas y alta

D) Diuréticos endovenosos como tratamiento definitivo

E) Trombolisis sistémica

> **Respuesta B.** Un síndrome de vena cava superior sin compromiso de vía aérea ni edema cerebral permite estudiar: se realiza TAC de tórax con contraste y biopsia, porque el tratamiento depende de la histología (quimioterapia en células pequeñas o linfoma). La radioterapia o los corticoides empíricos pueden impedir el diagnóstico. Si hay estridor o confusión, se instala un stent endovascular.

603 resp-19 · Perfil V3 1.08.3.004 · Actividad física en pacientes con riesgo de trombosis · *Práctica*

Mujer de 45 años con trombosis venosa profunda femoropoplítea izquierda, hemodinámicamente estable y sin signos de TEP, inicia anticoagulación ambulatoria con rivaroxabán. Pregunta si debe guardar reposo en cama.

¿Cuál es la recomendación más adecuada?

A) Reposo absoluto en cama por 2 semanas para evitar una embolia

B) Reposo con la pierna en declive

C) No caminar hasta que desaparezca el edema

D) Deambulación precoz según tolerancia, con anticoagulación efectiva

E) Ejercicio intenso de alto impacto desde el primer día

> **Respuesta D.** Con anticoagulación efectiva, la deambulación precoz en la TVP es segura: no aumenta el riesgo de TEP y reduce dolor, edema y síndrome postrombótico. El reposo en cama favorece la estasis venosa. En personas con riesgo de trombosis, como en viajes largos o en el posoperatorio, se recomienda movilización, ejercicios de pantorrilla e hidratación.

604 resp-17 · Perfil V3 1.10.1.029 · Tumores primarios y metastásicos SNC · *Práctica*

Hombre de 61 años, fumador, con adenocarcinoma pulmonar recién diagnosticado, consulta por cefalea matinal progresiva, vómitos y paresia leve de la mano derecha. La resonancia cerebral muestra 3 lesiones redondeadas con realce en anillo en la unión córtico-subcortical, rodeadas de extenso edema vasogénico.

¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado de los síntomas?

A) Dexametasona

B) Manitol en infusión continua por 2 semanas

C) Antibióticos por absceso cerebral

D) Anticoagulación

E) Punción lumbar evacuadora

> **Respuesta A.** Lesiones múltiples con realce en anillo en la unión córtico-subcortical, en un paciente con cáncer pulmonar, corresponden a metástasis cerebrales, los tumores intracraneales más frecuentes del adulto. Los síntomas por edema vasogénico se tratan con dexametasona; luego se define radiocirugía, radioterapia o cirugía. La punción lumbar está contraindicada por el efecto de masa.

605 resp-03 · Perfil V3 2.01.1.019 · Asma bronquial · *Práctica*

Un niño de 8 años con asma usa salbutamol inhalado a demanda. En el último mes ha tenido síntomas diurnos 4 días por semana, despertares nocturnos por tos 2 veces por semana y limitación para hacer deporte. Su técnica inhalatoria con aerocámara es correcta.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener salbutamol a demanda

B) Iniciar corticoide inhalado en dosis baja de mantención

C) Iniciar prednisona oral por 5 días

D) Iniciar montelukast como monoterapia de primera línea

E) Iniciar teofilina oral

> **Respuesta B.** Un asma no controlada (síntomas más de 2 veces por semana, despertares nocturnos, limitación de actividad) requiere tratamiento de mantención. De acuerdo con la guía GES de asma en menores de 15 años y GINA, el pilar es el corticoide inhalado en dosis baja (ej. budesonida o fluticasona) con aerocámara, más salbutamol de rescate.

606 resp-12 · Perfil V3 2.01.4.010 · Citoquímico de líquido cefaloraquídeo y pleural · *Práctica*

Un niño de 5 años con neumonía en tratamiento antibiótico persiste febril al cuarto día. La radiografía muestra derrame pleural moderado. Se realiza toracocentesis, que obtiene líquido turbio con pH 7,0, glucosa 25 mg/dL y LDH 1.800 UI/L. La tinción de Gram muestra cocáceas grampositivas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener el mismo antibiótico y controlar con radiografía en 1 semana

B) Agregar corticoides sistémicos

C) Instalar drenaje pleural y mantener antibiótico endovenoso

D) Repetir la toracocentesis en 1 semana

E) Cambiar a antibiótico oral y alta

> **Respuesta C.** Un líquido pleural con pH menor a 7,2, glucosa menor a 40 mg/dL, LDH muy elevada o gérmenes en el Gram (o pus) corresponde a derrame paraneumónico complicado o empiema. Requiere drenaje pleural con tubo (eventualmente con fibrinolíticos o videotoracoscopía) además de antibiótico endovenoso. El neumococo es el agente más frecuente en niños.

607 resp-20 · Perfil V3 2.01.4.026 · Test del sudor · *Práctica*

Un niño de 2 años presenta neumonías y bronquitis obstructivas a repetición, tos productiva crónica, deposiciones abundantes, grasosas y malolientes, y mal incremento ponderal pese a buen apetito. Su madre nota que su piel es muy salada al besarlo.

¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Cuantificación de inmunoglobulinas

B) Espirometría

C) TAC de tórax

D) Anticuerpos antitransglutaminasa

E) Test del sudor (cloro en sudor)

> **Respuesta E.** Infecciones respiratorias recurrentes con tos productiva, esteatorrea por insuficiencia pancreática, falla de crecimiento y piel salada sugieren fibrosis quística. El examen de elección es el test del sudor por iontoforesis con pilocarpina: cloro en sudor de 60 mmol/L o más en dos muestras confirma; entre 30 y 59 es limítrofe y requiere estudio genético del gen CFTR.

608 resp-12 · Perfil V3 2.01.5.009 · Punción pleural · *Práctica*

Se realizará una punción pleural diagnóstica en un niño de 7 años con derrame pleural paraneumónico moderado, sentado e inclinado hacia adelante, con ecografía que marca el sitio de punción.

¿Cuál es la técnica correcta para introducir la aguja?

A) Por el borde superior de la costilla inferior

B) Por el borde inferior de la costilla superior

C) Por el centro del espacio intercostal, sin referencia costal

D) En la línea medioclavicular, segundo espacio intercostal

E) Por debajo de la décima costilla posterior

> **Respuesta A.** El paquete vasculonervioso intercostal (vena, arteria y nervio) discurre por el borde inferior de cada costilla. Por eso la aguja se introduce rasando el borde superior de la costilla inferior, en la línea axilar media o posterior, idealmente guiada por ecografía. El segundo espacio en la línea medioclavicular se usa para descomprimir un neumotórax a tensión, no para derrames.

609 resp-15 · Perfil V3 4.01.1.042 · Mesotelioma pleural · *Práctica*

Hombre de 68 años, que trabajó 25 años instalando aislantes de asbesto, consulta por disnea progresiva, dolor torácico sordo persistente y baja de peso de 3 meses. La radiografía muestra derrame pleural derecho y la TAC revela engrosamiento pleural nodular y circunferencial. El líquido pleural es un exudado hemático con citología negativa.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Biopsia pleural por toracoscopía

B) Repetir la citología del líquido pleural

C) Fibrobroncoscopía

D) Marcadores tumorales en sangre

E) Adenosina deaminasa en líquido pleural

> **Respuesta A.** Exposición a asbesto con derrame unilateral y engrosamiento pleural nodular y circunferencial sugiere mesotelioma pleural maligno. La citología tiene baja sensibilidad para este tumor; el diagnóstico requiere histología con inmunohistoquímica, idealmente por biopsia pleural toracoscópica. La ADA orienta a tuberculosis pleural, que no explica el engrosamiento nodular.

610 resp-09 · Perfil V3 4.01.2.017 · Supuración pulmonar · *Práctica*

Hombre de 50 años, alcohólico, en tratamiento por absceso pulmonar periférico del lóbulo inferior derecho. Al día 6 presenta bruscamente dolor torácico derecho intenso, disnea y fiebre de 39 °C. FR 30/min, SatO2 89 %. Radiografía: nivel hidroaéreo amplio en el espacio pleural derecho, con colapso pulmonar parcial.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener antibióticos y repetir radiografía en 48 horas

B) Punción con aguja en el 2.º espacio intercostal y alta

C) Fibrobroncoscopía para drenar el absceso

D) Instalar tubo de drenaje pleural de urgencia

E) Lobectomía inferior derecha de urgencia como primera medida

> **Respuesta D.** La ruptura de un absceso periférico a la pleura produce un pioneumotórax: aire y pus en el espacio pleural, con nivel hidroaéreo pleural. Es una supuración pleuropulmonar que exige drenaje pleural con tubo grueso de inmediato, además de antibióticos. La cirugía queda para fracaso del drenaje.

611 resp-20 · Perfil V3 4.01.2.018 · Hemoptisis masiva · *Práctica*

Hombre de 50 años con bronquiectasias en el lóbulo inferior izquierdo presenta hemoptisis de aproximadamente 400 mL en 6 horas. Está consciente, con SatO2 de 91% y PA 120/75 mmHg.

¿Cuál es la medida inicial más adecuada mientras se gestiona el estudio y tratamiento definitivo?

A) Posición de Trendelenburg

B) Posición en decúbito lateral derecho

C) Posición en decúbito lateral izquierdo, sobre el lado que sangra

D) Nebulización con broncodilatadores

E) Kinesioterapia respiratoria con percusión

> **Respuesta C.** En la hemoptisis masiva lo prioritario es proteger la vía aérea del pulmón sano: se ubica al paciente en decúbito lateral sobre el lado que sangra para evitar la aspiración de sangre al pulmón contralateral, con oxígeno y eventual intubación. Luego, broncoscopía y angioTAC permiten localizar la lesión para embolización de arterias bronquiales o cirugía.

612 resp-19 · Perfil V3 4.01.4.010 · TAC de tórax · *Práctica*

Mujer de 45 años, en su décimo día postoperatorio de una artroplastía de cadera, presenta disnea súbita y dolor pleurítico. FC 110 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 89% ambiental. Tiene edema de la pantorrilla izquierda. Su score de Wells indica alta probabilidad clínica.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) AngioTAC de tórax (angiografía pulmonar por TAC)

B) Dímero D

C) Radiografía de tórax

D) TAC de tórax sin contraste

E) Espirometría

> **Respuesta A.** Con alta probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar en un paciente estable, se solicita directamente una angioTAC de tórax, examen de elección para confirmar el diagnóstico. El dímero D solo es útil para descartar en pacientes de probabilidad baja o intermedia. La TAC sin contraste no visualiza los trombos dentro de las arterias pulmonares.

613 resp-21 · Perfil V3 4.01.5.023 · Manejo ventilatorio básico · *Práctica*

Hombre de 55 años es encontrado en apnea tras una intoxicación por opioides. Tiene pulso carotídeo palpable. Mientras se prepara la naloxona, usted inicia ventilación con bolsa-mascarilla y oxígeno.

¿Cuál es la técnica de ventilación más adecuada?

A) Solo oxígeno por mascarilla de alto flujo, sin ventilar

B) 30 ventilaciones por minuto con el máximo volumen posible

C) 2 ventilaciones cada 30 compresiones torácicas

D) 1 ventilación por minuto para evitar hiperventilación

E) 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto), con volumen suficiente para elevar visiblemente el tórax

> **Respuesta E.** En un adulto en paro respiratorio con pulso, se ventila 1 vez cada 6 segundos, aproximadamente 10 por minuto, con volumen suficiente para elevar el tórax y durante 1 segundo cada una, sellando bien la mascarilla y abriendo la vía aérea con maniobra frente-mentón o tracción mandibular. La hiperventilación aumenta la presión intratorácica y la distensión gástrica.

614 resp-11 · Perfil V3 4.01.5.029 · Punción pleural · *Práctica*

Mujer de 65 años con un derrame pleural derecho moderado requiere una toracocentesis diagnóstica. Se ubica sentada, inclinada hacia adelante, y se identifica el nivel del derrame por percusión y ecografía.

¿Dónde debe introducirse la aguja respecto de la costilla?

A) Por el borde inferior de la costilla superior

B) En el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular

C) Por el centro del cuerpo costal

D) Por el borde superior de la costilla inferior

E) Por cualquier borde, ya que no hay estructuras relevantes

> **Respuesta D.** El paquete vasculonervioso intercostal (vena, arteria y nervio) transcurre por el surco del borde inferior de cada costilla. Por eso la punción pleural se realiza rozando el borde superior de la costilla inferior del espacio elegido, habitualmente en la línea axilar posterior, uno o dos espacios bajo el nivel del derrame, idealmente guiada por ecografía.

615 resp-21 · Perfil V3 4.01.5.030 · Traqueostomía y cricoidostomía · *Práctica*

Hombre de 58 años con neumonía grave lleva 14 días en ventilación mecánica invasiva por tubo orotraqueal, con varios intentos fallidos de desconexión. Se estima que requerirá soporte ventilatorio prolongado.

¿Cuál es el procedimiento más adecuado para su vía aérea?

A) Cricotiroidotomía quirúrgica

B) Mantener indefinidamente el tubo orotraqueal

C) Traqueostomía electiva

D) Punción cricotiroidea con aguja

E) Cambio a mascarilla laríngea

> **Respuesta C.** En pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada, la traqueostomía electiva, quirúrgica o percutánea, facilita el destete, mejora el confort, la higiene oral y la aspiración de secreciones, y disminuye el daño laríngeo por intubación prolongada. La cricotiroidotomía es un procedimiento de urgencia para el escenario de no intubable y no oxigenable, y debe convertirse luego en traqueostomía.

616 resp-23 · Perfil V3 6.03.4.009 · Polisomnografía · *Práctica*

Hombre de 52 años, IMC 36 kg/m2, hipertenso con 3 fármacos, con ronquido intenso, pausas respiratorias presenciadas por su pareja y somnolencia diurna (Epworth 15). Sin enfermedad cardiopulmonar ni neuromuscular significativa.

¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Polisomnografía (o poligrafía respiratoria domiciliaria en alta probabilidad), que permite calcular el índice de apnea-hipopnea

B) Espirometría

C) Gases arteriales en vigilia

D) Ecocardiograma

E) TAC de cuello

> **Respuesta A.** La polisomnografía nocturna es el estándar para el diagnóstico de SAHOS: registra EEG, flujo, esfuerzo, saturación y otras variables, y permite calcular el índice de apnea-hipopnea (IAH: 5 a 14 leve, 15 a 29 moderado, 30 o más grave). En pacientes con alta probabilidad clínica y sin comorbilidad relevante, la poligrafía domiciliaria es una alternativa válida.

Reumatología

617 reuma-21 · Perfil V3 1.01.4.010 · Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS) · *Práctica*

Una mujer de 74 años consulta por cefalea temporal derecha de 3 semanas, claudicación mandibular y malestar general. Tiene la arteria temporal engrosada y dolorosa. Hemograma: hemoglobina 10,8 g/dL normocítica, plaquetas 480.000/mm³.

¿Qué resultado de laboratorio apoya con mayor fuerza la sospecha diagnóstica?

A) Eosinofilia de 15%

B) Leucopenia con linfocitosis

C) VHS de 95 mm/h

D) VHS de 8 mm/h

E) Policitemia

> **Respuesta C.** Cefalea temporal, claudicación mandibular y arteria temporal engrosada en mayor de 50 años sugieren arteritis de células gigantes. Una VHS muy elevada (habitualmente sobre 50 mm/h) la apoya, junto a anemia de enfermedad crónica y trombocitosis; una VHS normal la hace improbable. Se inicia prednisona sin esperar la biopsia.

618 reuma-22 · Perfil V3 1.08.1.013 · Púrpuras vasculares · *Práctica*

Niño de 6 años, con infección respiratoria alta hace 2 semanas, presenta lesiones purpúricas palpables en glúteos y extremidades inferiores, dolor abdominal cólico y artralgias de tobillos. Plaquetas 320.000/mm3 y pruebas de coagulación normales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénica inmune

B) Meningococcemia

C) Leucemia linfoblástica aguda

D) Púrpura de Schönlein-Henoch (vasculitis por IgA)

E) Hemofilia A

> **Respuesta D.** Púrpura palpable con plaquetas y coagulación normales indica una púrpura vascular. En un niño, con distribución en glúteos y piernas, dolor abdominal y artralgias, corresponde a vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch). Deben controlarse orina y presión arterial por riesgo de nefritis. La PTI cursa con plaquetopenia y púrpura no palpable.

619 reuma-16 · Perfil V3 1.11.1.006 · Columna dolorosa · *Práctica*

Hombre de 26 años consulta por dolor lumbar de 6 meses, de inicio insidioso, que lo despierta en la segunda mitad de la noche y se acompaña de rigidez matinal de 1 hora.

¿Cuál característica adicional apoya más un origen inflamatorio del dolor?

A) Mejoría con el reposo

B) Inicio súbito tras levantar peso

C) Mejoría con el ejercicio

D) Dolor que aumenta al final del día con la actividad

E) Irradiación por el dermatoma L5 con Lasègue positivo

> **Respuesta C.** El dolor lumbar inflamatorio (criterios ASAS) se caracteriza por inicio antes de los 40 años, comienzo insidioso, duración mayor de 3 meses, dolor nocturno, rigidez matinal prolongada y mejoría con el ejercicio pero no con el reposo. Sugiere espondiloartritis y se estudia con HLA-B27 y resonancia de sacroilíacas. El dolor mecánico empeora con la actividad y mejora con el reposo.

620 reuma-19 · Perfil V3 1.11.1.016 · Oligoartritis · *Práctica*

Mujer de 22 años, sexualmente activa sin preservativo, con 4 días de fiebre de 38,4 °C y poliartralgias migratorias, que evoluciona con artritis de la rodilla derecha y la muñeca izquierda, tenosinovitis dorsal de la mano izquierda y 4 pústulas hemorrágicas en las extremidades. La artrocentesis de rodilla muestra 35.000 leucocitos por mm3 con predominio polimorfonuclear y Gram sin bacterias.

¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?

A) Artritis reactiva; AINEs

B) Infección gonocócica diseminada; ceftriaxona endovenosa, estudio de otras ITS y tratamiento de la pareja

C) Artritis reumatoide; metotrexato

D) Gota; colchicina

E) Fiebre reumática; penicilina benzatina

> **Respuesta B.** Oligoartritis asimétrica febril en una joven sexualmente activa, con tenosinovitis y pústulas hemorrágicas, es una infección gonocócica diseminada. El Gram y el cultivo del líquido suelen ser negativos; se cultivan sangre, cuello uterino, recto y faringe. Se trata con ceftriaxona endovenosa. La artritis reactiva aparece semanas después y no da pústulas.

621 reuma-05 · Perfil V3 1.11.1.019 · Poliartritis · *Práctica*

Mujer de 32 años, educadora de párvulos, consulta por dolor y aumento de volumen simétrico de muñecas y articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, de 6 días de evolución, con rigidez matinal y un rash reticular leve en los muslos. Dos semanas antes, varios niños de su sala tuvieron fiebre y las mejillas muy rojas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar metotrexato semanal por sospecha de artritis reumatoide

B) AINEs y control clínico, porque probablemente es una poliartritis viral por parvovirus B19 que se autolimita

C) Prednisona 1 mg/kg/día

D) Cloxacilina endovenosa

E) Alopurinol oral

> **Respuesta B.** Una poliartritis simétrica aguda, de menos de 6 semanas, tras contacto con niños con eritema infeccioso, orienta a parvovirus B19, que suele autolimitarse en semanas. Se maneja con AINEs y observación; la IgM para parvovirus confirma. Iniciar metotrexato es prematuro: antes de 6 semanas una poliartritis puede ser viral y transitoria.

622 reuma-06 · Perfil V3 1.11.1.019 · Poliartritis · *Práctica*

Mujer de 63 años consulta por dolor en ambas manos de 3 años, que empeora con el uso. Tiene rigidez matinal de 15 minutos. Al examen presenta nódulos duros en las interfalángicas distales y proximales de varios dedos, sin sinovitis de metacarpofalángicas ni de muñecas. La VHS y la PCR son normales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reumatoide

B) Artritis psoriásica

C) Artrosis nodal de manos

D) Lupus eritematoso sistémico

E) Gota tofácea

> **Respuesta C.** Compromiso de interfalángicas distales y proximales con nódulos óseos de Heberden y Bouchard, rigidez matinal breve y reactantes normales es artrosis nodal de manos. La artritis reumatoide afecta metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas, respeta las distales y da rigidez matinal mayor de 1 hora.

623 reuma-23 · Perfil V3 1.11.3.002 · Prevención de complicaciones de la terapia esteroidal · *Práctica*

Mujer de 70 años con polimialgia reumática inicia prednisona 15 mg al día, con un plan de disminución lenta durante al menos 1 año. Su densitometría muestra un T-score de -2,1 en cadera.

¿Cuál es la medida más adecuada para prevenir complicaciones de la terapia esteroidal?

A) Ninguna medida preventiva, por tratarse de una dosis moderada

B) Calcio, vitamina D y bisfosfonato, además de control de glicemia y presión arterial

C) Suspender bruscamente la prednisona al mes

D) Antibiótico profiláctico permanente

E) Duplicar la dosis de prednisona ante cualquier estrés menor sin indicación

> **Respuesta B.** El uso de prednisona de 2,5 mg o más por más de 3 meses causa osteoporosis, diabetes, hipertensión, cataratas, infecciones e insuficiencia suprarrenal al suspender. En adultos mayores con osteopenia se indica calcio, vitamina D y bisfosfonato, se controlan glicemia, presión y peso, y el descenso es gradual, nunca brusco. La profilaxis antibiótica no es rutinaria.

624 reuma-06 · Perfil V3 1.11.4.003 · Exámenes inmunológicos del diagnóstico diferencial de mesenquimopatías (AAN, aDNA, aENA1, C3, C4, YGS, FR, Anti CCP, ANCA) · *Práctica*

Hombre de 72 años, asintomático, sin dolor ni aumento de volumen articular, trae exámenes de un chequeo con factor reumatoide positivo de 40 UI/mL (valor normal menor de 14). Su examen articular es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar metotrexato precoz

B) Diagnosticar artritis reumatoide seropositiva y derivar para terapia biológica

C) Hidroxicloroquina preventiva

D) No hace diagnóstico: el factor reumatoide puede ser positivo en adultos mayores sanos y en otras enfermedades, y sin artritis no se trata

E) Repetir el factor reumatoide cada mes

> **Respuesta D.** El factor reumatoide es poco específico: aparece en adultos mayores sanos y en hepatitis C, Sjögren, endocarditis o tuberculosis. Sin artritis clínica no tiene valor diagnóstico ni se trata. Los exámenes inmunológicos apoyan una sospecha clínica, no la reemplazan; el anti-CCP es el más específico para artritis reumatoide.

625 reuma-04 · Perfil V3 1.11.4.004 · Radiografía de columna y articulaciones · *Práctica*

Mujer de 68 años con dolor mecánico de rodilla derecha de 3 años, rigidez matinal menor de 30 minutos y crépitos al examen. Se solicita radiografía de rodilla con carga.

¿Cuál conjunto de hallazgos radiológicos es característico de la artrosis?

A) Disminución asimétrica del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral y quistes subcondrales

B) Osteopenia yuxtaarticular, disminución simétrica del espacio y erosiones marginales

C) Erosiones en sacabocado con borde sobresaliente

D) Calcificación lineal del cartílago sin otros cambios

E) Reacción perióstica en capas de cebolla

> **Respuesta A.** La radiografía con carga es el examen de imagen inicial en la artrosis: muestra disminución asimétrica del espacio articular, osteofitos, esclerosis y quistes subcondrales. La osteopenia yuxtaarticular con erosiones marginales y estrechamiento simétrico es propia de la artritis reumatoide; las erosiones en sacabocado, de la gota, y la condrocalcinosis, de la pseudogota.

626 reuma-02 · Perfil V3 1.11.5.001 · Punción articular de rodilla · *Práctica*

Hombre de 55 años, usuario de aspirina 100 mg al día, presenta una monoartritis aguda de la rodilla derecha con gran derrame. La piel de la cara medial de la rodilla tiene eritema por una celulitis. Se decide realizar una artrocentesis diagnóstica.

¿Cuál es la técnica correcta?

A) Decúbito supino con rodilla extendida y cuádriceps relajado, asepsia, abordaje lateral bajo el borde superolateral de la rótula, con aguja gruesa

B) Punzar por la cara medial, donde el derrame es más fluctuante, aunque la piel tenga celulitis

C) Abordaje posterior por el hueco poplíteo

D) Iniciar antibióticos 48 horas antes de la punción

E) Está contraindicada por el uso de aspirina en dosis bajas

> **Respuesta A.** Con el paciente en decúbito supino, rodilla extendida y cuádriceps relajado, bajo técnica aséptica se punza por vía lateral, entre la rótula y el fémur, con aguja gruesa. Nunca a través de piel infectada ni por el hueco poplíteo, donde están los vasos. La aspirina no la contraindica, y el antibiótico va después de obtener el líquido.

627 reuma-04 · Perfil V3 4.02.3.003 · Factores de riesgo de artrosis · *Práctica*

Mujer de 62 años consulta por dolor mecánico de ambas rodillas de 2 años de evolución, rigidez matinal menor de 30 minutos y crujidos. IMC 34 kg/m2. Trabajó 30 años como empleada doméstica. Su madre tuvo artrosis de rodillas.

¿Cuál de sus factores de riesgo de artrosis de rodilla es modificable y su intervención tiene mayor impacto en los síntomas?

A) Sexo femenino

B) Obesidad

C) Edad mayor de 60 años

D) Antecedente familiar de artrosis

E) Antecedente laboral

> **Respuesta B.** La obesidad es el principal factor de riesgo modificable de artrosis de rodilla: aumenta la carga articular y tiene efecto inflamatorio. Bajar al menos 5% a 10% del peso, junto con ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps, reduce dolor y mejora función. Edad, sexo y genética no son modificables.

628 reuma-24 · Perfil V3 4.02.3.004 · Factores de riesgo de osteoporosis · *Práctica*

Mujer de 58 años, menopausia a los 50 años, consulta para control. Es delgada (IMC 19 kg/m2) y tiene los antecedentes que se listan abajo.

¿Cuál de los siguientes antecedentes constituye el factor de riesgo de osteoporosis y fractura más relevante?

A) Uso de anticonceptivos orales durante 10 años en la juventud

B) Consumo de 2 tazas de café al día

C) Hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida

D) Uso de prednisona 10 mg al día durante los últimos 6 meses por polimialgia reumática

E) Sobrepeso en la adolescencia

> **Respuesta D.** Los glucocorticoides orales en dosis de 5 mg o más de prednisona por 3 meses o más son la causa más frecuente de osteoporosis secundaria y elevan el riesgo de fractura desde los primeros meses; obligan a densitometría y prevención. Las tiazidas incluso reducen la calciuria; el café moderado y los anticonceptivos no son factores relevantes.

629 reuma-02 · Perfil V3 4.02.4.008 · Cultivo y antibiograma en infecciones osteoarticulares y heridas · *Práctica*

Hombre de 55 años, diabético, consulta por rodilla derecha caliente, roja y con derrame de 2 días, fiebre de 38,8 °C. Está hemodinámicamente estable. Se planifica tratamiento antibiótico endovenoso.

¿Qué se debe hacer antes de iniciar los antibióticos?

A) Nada; el inicio de antibióticos no debe retrasarse por ningún examen

B) Tomar cultivo de un hisopado de la piel sobre la rodilla

C) Solicitar resonancia magnética de rodilla

D) Tomar hemocultivos y artrocentesis con Gram y cultivo del líquido articular

E) Esperar resultado de la VHS y PCR

> **Respuesta D.** En la sospecha de artritis séptica en un paciente estable, se toman hemocultivos y se punciona la articulación (Gram, cultivo, recuento celular y cristales) antes del primer antibiótico, porque este negativiza los cultivos. El antibiograma permite ajustar el esquema empírico. El hisopado de piel no representa al germen articular.

630 reuma-01 · Perfil V3 4.02.4.009 · Gram líquido articular · *Práctica*

Mujer de 70 años con monoartritis aguda de rodilla izquierda y fiebre. La artrocentesis obtiene líquido turbio con 65.000 leucocitos/mm3, 92% polimorfonucleares. Se observan cristales romboidales con birrefringencia positiva débil. El Gram es negativo (no se observan bacterias).

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Pseudogota; el Gram negativo descarta infección

B) Artritis séptica descartada; iniciar colchicina

C) No se puede descartar artritis séptica: el Gram tiene baja sensibilidad; iniciar antibióticos empíricos hasta el resultado del cultivo

D) Gota aguda; indicar AINE

E) Artritis reactiva; buscar infección genitourinaria

> **Respuesta C.** El Gram del líquido sinovial es específico pero poco sensible (cerca de 50%): un Gram negativo no descarta artritis séptica. Además, cristales e infección pueden coexistir. Con líquido de más de 50.000 leucocitos y fiebre, se trata empíricamente como séptica hasta que el cultivo resulte negativo.

631 reuma-22 · Perfil V3 6.01.1.033 · Vasculitis cutáneas · *Práctica*

Hombre de 40 años con lesiones en ambas piernas de 5 días, que aparecieron 1 semana después de iniciar amoxicilina por una sinusitis. Al examen se observan pápulas purpúricas palpables, que no desaparecen a la vitropresión, en ambas piernas y tobillos. Plaquetas normales, función renal y sedimento urinario normales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

A) Púrpura trombocitopénica inmune; corticoides

B) Vasculitis leucocitoclástica (de pequeño vaso) por fármacos; suspender el antibiótico y confirmar con biopsia de piel

C) Meningococcemia; ceftriaxona

D) Escorbuto; vitamina C

E) Dermatitis de contacto; corticoide tópico

> **Respuesta B.** La púrpura palpable en extremidades inferiores con plaquetas normales es la lesión típica de la vasculitis cutánea de pequeño vaso (leucocitoclástica), frecuentemente por fármacos o infecciones. Se suspende el agente gatillante, se confirma con biopsia y se buscan compromiso renal, digestivo y articular. La púrpura de la trombocitopenia no es palpable.

Salud Pública

632 sp-02 · Perfil V3 1.07.3.012 · Derecho GES a ayudas técnicas para personas de 65 años o más, como órtesis · *Práctica*

Hombre de 72 años, beneficiario de FONASA, con artrosis de cadera y alteración del equilibrio, tiene dificultad para desplazarse en forma segura. Su médico considera que necesita una ayuda técnica.

¿Cuál de los siguientes elementos está garantizado por el GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más?

A) Silla salvaescaleras

B) Cama clínica eléctrica

C) Andador

D) Scooter eléctrico

E) Plantillas ortopédicas de silicona

> **Respuesta C.** El GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más garantiza, según indicación médica, bastones, andadores (incluido el andador de paseo), sillas de ruedas y cojín y colchón antiescaras, con plazos definidos de entrega. Camas eléctricas, salvaescaleras y scooters no forman parte de esta garantía.

633 sp-14 · Perfil V3 1.11.3.001 · Condiciones de trabajo · *Práctica*

Mujer de 38 años, operaria de una planta de packing, consulta por dolor en el borde radial de la muñeca derecha de 2 meses, que relaciona con movimientos repetitivos en su trabajo. Prueba de Finkelstein positiva.

Además del manejo clínico, ¿qué corresponde según la legislación chilena?

A) Derivar a la mutualidad u organismo administrador de la Ley 16.744 como posible enfermedad profesional

B) Licencia médica común por enfermedad (FONASA o ISAPRE)

C) Indicarle que cambie de trabajo por su cuenta

D) Ninguna gestión, porque es una patología común

E) Notificar a la SEREMI como enfermedad de notificación obligatoria

> **Respuesta A.** La tenosinovitis de De Quervain por movimientos repetitivos puede ser una enfermedad profesional. Según la Ley 16.744, las enfermedades profesionales y los accidentes laborales se atienden en el organismo administrador (mutualidad o ISL), que cubre tratamiento, licencia y prestaciones y evalúa el puesto de trabajo. Corresponde la denuncia individual de enfermedad profesional, no una licencia común.

634 sp-13 · Perfil V3 2.01.3.010 · Prevención de maltrato y abuso infantil · *Práctica*

Una niña de 6 años es traída por su madre, quien relata que la niña le contó que un familiar le tocó los genitales. Al examen no hay lesiones físicas.

¿Cuál es la conducta más adecuada del médico?

A) Interrogar a la niña en detalle varias veces para confirmar el relato

B) Descartar el abuso por la ausencia de lesiones

C) Proteger a la niña, registrar el relato textual y realizar la denuncia dentro de las 24 horas

D) Citar al familiar para confrontarlo

E) Esperar a que la madre decida si denuncia

> **Respuesta C.** Ante sospecha de abuso sexual infantil, el médico debe proteger al niño, registrar textualmente lo relatado sin interrogatorios repetidos (para evitar revictimización) y denunciar: el Código Procesal Penal obliga a los profesionales de salud a hacerlo dentro de 24 horas. La ausencia de lesiones no descarta el abuso, que con frecuencia no deja hallazgos.

635 sp-11 · Perfil V3 2.01.3.013 · Relación médico-paciente-familia · *Práctica*

Un niño de 8 años llega a urgencia con hemorragia masiva tras un accidente y requiere transfusión inmediata para salvar su vida. Sus padres, por motivos religiosos, se oponen a la transfusión.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Respetar la decisión de los padres y no transfundir

B) Transfundir, ya que en una urgencia con riesgo vital de un menor prima su derecho a la vida, informando y dejando registro

C) Esperar una orden judicial antes de cualquier acción

D) Trasladar al niño a otro centro

E) Pedir al niño que decida

> **Respuesta B.** Los padres representan a sus hijos, pero su decisión debe resguardar el mejor interés del niño. La Ley 20.584 permite actuar sin consentimiento ante una urgencia con riesgo vital inminente. Se debe intentar dialogar con la familia, transfundir, registrar en la ficha y, si la situación no es urgente, solicitar autorización judicial o del comité de ética.

636 sp-07 · Perfil V3 2.01.3.014 · Salud infantil en Chile y el mundo · *Práctica*

En un informe sobre salud infantil en Chile se analiza la tasa de mortalidad infantil, que actualmente es cercana a 6 por 1.000.

¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil y cuál es su principal causa en Chile?

A) Muertes de menores de 5 años por 1.000 habitantes; causa principal: infecciones respiratorias

B) Muertes de menores de 1 año por 1.000 habitantes; causa principal: diarrea

C) Muertes de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos; causa principal: afecciones originadas en el período perinatal

D) Muertes de menores de 28 días por 1.000 nacidos vivos; causa principal: accidentes

E) Muertes fetales por 1.000 partos; causa principal: malformaciones

> **Respuesta C.** La tasa de mortalidad infantil es el número de muertes de menores de 1 año en un período, dividido por los nacidos vivos del mismo período, por 1.000. Chile tiene una de las tasas más bajas de Latinoamérica. Sus principales causas son las afecciones originadas en el período perinatal (prematurez) y las malformaciones congénitas; las infecciones disminuyeron drásticamente.

637 sp-02 · Perfil V3 2.01.3.015 · Salud oral · *Práctica*

Una madre consulta qué atención dental cubre el GES para su hijo.

¿Qué grupo de edad pediátrico tiene garantizada por el GES la salud oral integral?

A) Preescolares de 4 años solamente

B) Lactantes de 6 meses

C) Adolescentes de 15 años

D) Todos los menores de 18 años

E) Niños y niñas de 6 años

> **Respuesta E.** El GES incluye "Salud oral integral para niños y niñas de 6 años", que cubre examen, educación, prevención (sellantes, flúor) y tratamiento de caries, en el momento en que erupcionan los primeros molares definitivos. Otras garantías odontológicas son la salud oral de la embarazada y la urgencia odontológica ambulatoria.

638 sp-12 · Perfil V3 2.01.3.016 · Supervisión de salud- adolescente · *Práctica*

Una adolescente de 15 años acude a control de salud con su madre. Usted planea aplicar la entrevista psicosocial HEADSSS.

¿Cuál es la forma más adecuada de realizar la entrevista?

A) Una parte a solas con la adolescente, explicando la confidencialidad y sus límites

B) Siempre con la madre presente para validar la información

C) Solo con la madre, porque la adolescente es menor de edad

D) Por escrito, sin conversación

E) Prometer confidencialidad absoluta en cualquier circunstancia

> **Respuesta A.** En el control de salud del adolescente se entrevista primero con el acompañante y luego a solas, explicando que la información es confidencial excepto si existe riesgo para su vida o la de otros, o abuso. La entrevista HEADSSS explora hogar, educación, actividades, drogas, sexualidad, suicidio y seguridad. Prometer confidencialidad absoluta es incorrecto.

639 sp-07 · Perfil V3 3.01.3.007 · Mortalidad perinatal y materna · *Práctica*

El equipo de estadísticas de un Servicio de Salud debe calcular la mortalidad materna regional del último año, considerando las muertes de mujeres durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a su término, por causas relacionadas con este o agravadas por él.

¿Cuál es el denominador utilizado para calcular la razón de mortalidad materna?

A) Nacidos vivos, expresado por 100.000

B) Mujeres en edad fértil

C) Total de embarazos registrados

D) Total de partos atendidos, por 1.000

E) Población femenina total

> **Respuesta A.** La razón (habitualmente llamada tasa) de mortalidad materna se calcula como muertes maternas dividido por nacidos vivos del mismo período y lugar, por 100.000. Se usa nacidos vivos porque el total de embarazos no se conoce con exactitud. Incluye muertes hasta 42 días posparto por causas obstétricas directas o indirectas.

640 sp-07 · Perfil V3 3.01.3.012 · Salud pública perinatal · *Práctica*

En las últimas décadas Chile redujo drásticamente su mortalidad infantil gracias al control de la desnutrición y de las infecciones, y hoy tiene tasas cercanas a las de países desarrollados.

¿Qué componente concentra actualmente la mayor parte de la mortalidad infantil en Chile?

A) Mortalidad por enfermedades diarreicas

B) Mortalidad postneonatal (28 días a 11 meses)

C) Mortalidad neonatal (menores de 28 días)

D) Mortalidad por desnutrición

E) Mortalidad por accidentes en el hogar

> **Respuesta C.** En Chile, como en países desarrollados, la mayor parte de la mortalidad infantil es neonatal, asociada a prematurez, malformaciones congénitas y afecciones perinatales. Por eso las estrategias actuales apuntan al período perinatal: control prenatal precoz, atención profesional del parto, regionalización neonatal y Chile Crece Contigo.

641 sp-14 · Perfil V3 4.02.3.001 · Accidentes del trabajo · *Práctica*

Trabajadora de 40 años, contratada en una empresa, sufre una caída en la vía pública mientras se dirigía directamente desde su casa a su lugar de trabajo. Consulta en el servicio de urgencia de un hospital público por dolor en el tobillo; la radiografía muestra una fractura de maléolo lateral.

Según la Ley 16.744, ¿cómo se clasifica y maneja este evento?

A) Enfermedad común; licencia médica tipo 1 cubierta por FONASA o ISAPRE

B) No tiene cobertura porque ocurrió fuera del lugar de trabajo

C) Accidente de trayecto; se considera accidente del trabajo y debe ser cubierto por su organismo administrador (mutualidad o ISL)

D) Enfermedad profesional; requiere evaluación por COMPIN

E) Accidente escolar; cubierto por el seguro escolar

> **Respuesta C.** La Ley 16.744 considera accidente del trabajo al ocurrido en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo. Se notifica (DIAT) y la atención, el subsidio y la licencia tipo 5-6 son de cargo del organismo administrador del seguro (mutualidad o ISL), no de la previsión común.

642 sp-13 · Perfil V3 5.01.3.008 · Maltrato infantil · *Práctica*

Lactante de 4 meses es traído a urgencia por llanto e inmovilidad de la pierna derecha. Los padres refieren que se cayó del sofá hace 2 días. La radiografía muestra una fractura espiroidea de fémur. El lactante aún no logra girarse solo y tiene equimosis en el tórax.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar para protección y estudio (serie ósea y fondo de ojo), registrar los hallazgos y denunciar

B) Inmovilizar y dar de alta con control en traumatología

C) Dar de alta y citar a control en una semana

D) Realizar la denuncia y dar de alta con los padres

E) Descartar osteogénesis imperfecta antes de adoptar cualquier medida

> **Respuesta A.** Fractura de fémur en un lactante que no se desplaza, con mecanismo incoherente, consulta tardía y equimosis, es altamente sugerente de maltrato. Se hospitaliza para protegerlo y estudiarlo (serie ósea, fondo de ojo, eventual neuroimagen), se registra en la ficha y se denuncia, deber legal del médico. El estudio de diagnósticos diferenciales no retrasa la protección.

643 sp-13 · Perfil V3 5.01.3.013 · Violencia intrafamiliar · *Práctica*

Mujer de 35 años consulta en el servicio de urgencia de un hospital público por contusiones en la cara y los brazos. Relata que su pareja la golpea hace un año, que anoche la amenazó con un cuchillo y que teme por su vida. Tiene 2 hijos pequeños en casa.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Recomendar terapia de pareja

B) Tratar las lesiones, evaluar el riesgo, registrar en la ficha, realizar la denuncia y activar la red de protección

C) Tratar las lesiones y dar de alta sin registrar para proteger su privacidad

D) Citar a la pareja para conversar con ambos

E) Derivar a psicología con hora en 3 meses

> **Respuesta B.** Ante violencia intrafamiliar se atiende la lesión, se evalúa el riesgo (amenaza con arma y temor por su vida son de alto riesgo), se registra en la ficha y se activa la red de protección. En un establecimiento público el médico tiene deber de denuncia de lesiones por delito. La terapia de pareja está contraindicada en violencia activa.

644 sp-05 · Perfil V3 7.01.3.001 · Conceptos y definiciones de Salud Pública · *Práctica*

Un médico recién llegado a una Dirección de Salud comunal pregunta en qué se diferencia su nuevo trabajo de la atención clínica que realizaba en el hospital.

¿Qué característica define mejor a la salud pública?

A) Su objeto es el diagnóstico y tratamiento de cada paciente individual

B) Su objeto es la salud de la población, mediante esfuerzos organizados de la sociedad

C) Es la medicina ejercida exclusivamente en establecimientos estatales

D) Se limita al control de enfermedades infecciosas

E) Se ocupa principalmente de la gestión hospitalaria

> **Respuesta B.** La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud mediante esfuerzos organizados de la sociedad (Winslow). Su sujeto es la población, no el individuo, e incluye determinantes sociales, promoción, prevención y organización de servicios. No se restringe al sector estatal ni a las infecciones.

645 sp-01 · Perfil V3 7.01.3.002 · Funciones esenciales de la Salud Pública · *Práctica*

La Organización Panamericana de la Salud definió las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), que son responsabilidad indelegable del Estado y permiten evaluar el desempeño de la autoridad sanitaria.

¿Cuál de las siguientes corresponde a una Función Esencial de Salud Pública?

A) Comercialización de seguros de salud

B) Realización de cirugías electivas en clínicas privadas

C) Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud de la población

D) Fabricación de medicamentos genéricos

E) Atención odontológica estética

> **Respuesta C.** Las FESP describen las acciones colectivas que el Estado debe garantizar: monitoreo y análisis de la situación de salud, vigilancia y control de riesgos, promoción de la salud, participación social, políticas y regulación, acceso equitativo, desarrollo del recurso humano, calidad, investigación y gestión de emergencias. Las prestaciones individuales comerciales no forman parte de ellas.

646 sp-10 · Perfil V3 7.01.3.003 · Historia natural de la enfermedad · *Práctica*

Mediante el Papanicolau de tamizaje se detecta una lesión intraepitelial de alto grado en una mujer de 32 años completamente asintomática, que luego es tratada con conización.

Según el modelo de Leavell y Clark, ¿en qué período de la historia natural de la enfermedad se intervino?

A) Período prepatogénico

B) Período de secuelas o resultado final

C) Período patogénico clínico, con síntomas

D) Período patogénico subclínico o presintomático

E) Período de convalecencia

> **Respuesta D.** La historia natural de la enfermedad distingue un período prepatogénico (agente, huésped y ambiente antes del inicio) y uno patogénico, subclínico y luego clínico. El tamizaje detecta la enfermedad en la fase subclínica, cuando ya existe pero no da síntomas: es prevención secundaria. La vacuna contra VPH actuaría en el período prepatogénico (prevención primaria).

647 sp-05 · Perfil V3 7.01.3.005 · Promoción de salud y prevención de enfermedades · *Práctica*

Un municipio, junto a vecinos y organizaciones sociales, construye ciclovías y plazas activas, y establece ferias libres con alimentos saludables a bajo costo, para mejorar la calidad de vida de toda la población comunal.

¿A qué tipo de estrategia corresponde esta iniciativa?

A) Prevención cuaternaria

B) Prevención primaria específica

C) Prevención secundaria

D) Prevención terciaria

E) Promoción de la salud

> **Respuesta E.** La promoción de la salud (Carta de Ottawa) busca dar a la población los medios para mejorar su salud y controlar sus determinantes, con participación social y entornos saludables, sin dirigirse a una enfermedad específica. La prevención primaria apunta a evitar una enfermedad determinada (por ejemplo, vacunar), la secundaria a detectarla precozmente y la terciaria a limitar secuelas.

648 sp-05 · Perfil V3 7.01.3.008 · Diagnóstico de situación de salud: · *Práctica*

El equipo de un CESFAM urbano, con 32.000 inscritos, necesita planificar sus actividades del próximo año. Para ello quiere caracterizar el perfil epidemiológico, sociodemográfico y de determinantes sociales de toda la población de su territorio, usando censos, estadísticas vitales y registros del establecimiento, e incorporando la opinión de la comunidad.

¿Cómo se denomina este proceso?

A) Diagnóstico o análisis de situación de salud

B) Estudio de brote

C) Ecomapa comunitario

D) Vigilancia epidemiológica centinela

E) Auditoría clínica

> **Respuesta A.** El diagnóstico o análisis de situación de salud (ASIS) caracteriza la salud de una población de un territorio y sus determinantes, con datos objetivos y participación comunitaria, para priorizar problemas y planificar. El ecomapa evalúa a una familia, no a una comunidad, y el estudio de brote investiga un evento puntual.

649 sp-07 · Perfil V3 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de salud: cálculo e interpretación · *Práctica*

En una comuna, durante un año, hubo 2.000 nacidos vivos y 16 defunciones de menores de 1 año. De estas, 10 ocurrieron en menores de 28 días.

¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de la comuna?

A) 0,8 por 1.000 nacidos vivos

B) 5 por 1.000 nacidos vivos

C) 3 por 1.000 nacidos vivos

D) 8 por 100.000 nacidos vivos

E) 8 por 1.000 nacidos vivos

> **Respuesta E.** Tasa de mortalidad infantil = defunciones de menores de 1 año / nacidos vivos del mismo período × 1.000 = 16/2.000 × 1.000 = 8 por mil. La neonatal (menores de 28 días) sería 10/2.000 × 1.000 = 5 por mil, y la postneonatal 6/2.000 × 1.000 = 3 por mil.

650 sp-13 · Perfil V3 7.01.3.011 · Fuentes de información para el diagnóstico · *Práctica*

Un equipo de salud pública quiere conocer las principales causas de muerte de la región en los últimos 5 años para su diagnóstico de situación de salud.

¿Cuál es la fuente primaria de las estadísticas oficiales de mortalidad en Chile?

A) El certificado médico de defunción

B) La Encuesta Nacional de Salud

C) El Censo de población

D) Las fichas clínicas hospitalarias

E) La encuesta CASEN

> **Respuesta A.** Las estadísticas de mortalidad se construyen a partir del certificado médico de defunción, inscrito en el Registro Civil y procesado por el DEIS del Ministerio de Salud y el INE. La Encuesta Nacional de Salud entrega prevalencias de enfermedades y factores de riesgo; el Censo, datos poblacionales; y la CASEN, datos socioeconómicos.

651 sp-05 · Perfil V3 7.01.3.012 · Ejecución de un diagnóstico · *Práctica*

El equipo de un CESFAM debe realizar el diagnóstico de situación de salud de su población a cargo, conforme al Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria.

¿Qué característica es esencial en la ejecución de este diagnóstico?

A) Limitarse a las enfermedades de notificación obligatoria

B) Basarse exclusivamente en los egresos hospitalarios

C) Ser elaborado únicamente por la dirección del establecimiento

D) Incorporar la participación de la comunidad e integrar información cuantitativa y cualitativa

E) Realizarse una sola vez, al inaugurar el centro

> **Respuesta D.** El diagnóstico de situación de salud debe ser participativo: combina datos cuantitativos (demográficos, morbimortalidad, factores de riesgo, recursos) con la percepción de la comunidad sobre sus problemas. Culmina en la priorización de problemas y la programación de acciones, y se actualiza periódicamente.

652 sp-06 · Perfil V3 7.01.3.013 · Concepto y campo de la epidemiología · *Práctica*

En la primera clase de epidemiología se pide a los alumnos elegir la definición más completa de la disciplina.

¿Cuál es la mejor definición de epidemiología?

A) Estudio exclusivo de las epidemias de enfermedades infecciosas

B) Estudio de la distribución y de los determinantes de los estados de salud en poblaciones, y su aplicación al control de los problemas de salud

C) Ciencia que trata a los pacientes individuales según la evidencia

D) Rama de la estadística que estudia los ensayos clínicos

E) Disciplina que administra los recursos de los servicios de salud

> **Respuesta B.** La epidemiología estudia la frecuencia y distribución (epidemiología descriptiva) y los determinantes (epidemiología analítica) de los eventos de salud en poblaciones, y aplica ese conocimiento al control de los problemas. No se limita a las infecciones: incluye enfermedades crónicas, lesiones, factores de riesgo y evaluación de servicios.

653 sp-05 · Perfil V3 7.01.3.017 · Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud · *Práctica*

Un equipo comunal, en su diagnóstico de situación de salud, quiere identificar qué grupos de edad, sectores de la comuna y períodos del año concentran la mayor obesidad infantil, para orientar sus recursos.

¿Qué herramienta epidemiológica es la más adecuada para este fin?

A) Análisis de costo-efectividad

B) Ensayo clínico aleatorizado

C) Epidemiología descriptiva, según persona, lugar y tiempo

D) Auditoría clínica

E) Estudio de cohortes a 20 años

> **Respuesta C.** En el diagnóstico de situación, la epidemiología describe la magnitud y distribución de los problemas de salud según persona, lugar y tiempo, identificando grupos de riesgo para priorizar y focalizar intervenciones. Los diseños analíticos o experimentales buscan causas o evalúan intervenciones, lo que no es el objetivo aquí.

654 sp-06 · Perfil V3 7.01.3.021 · Estudios de prevalencia · *Práctica*

La Encuesta Nacional de Salud mide, en un período breve, la presión arterial de una muestra representativa de la población chilena adulta y pregunta si la persona conoce su diagnóstico de hipertensión.

¿Qué medida de frecuencia entrega directamente este tipo de estudio?

A) Prevalencia

B) Incidencia acumulada

C) Densidad de incidencia

D) Riesgo relativo

E) Letalidad

> **Respuesta A.** Un estudio de prevalencia (transversal) mide exposición y enfermedad en un mismo momento, sin seguimiento, por lo que entrega la proporción de personas que tienen la condición: la prevalencia. Para calcular incidencia o riesgo relativo se requiere seguir en el tiempo a personas inicialmente sanas, como en un estudio de cohortes.

655 sp-04 · Perfil V3 7.01.3.027 · Investigación epidemiológica · *Práctica*

La SEREMI de Salud recibe la notificación de 25 personas con diarrea y vómitos 6 a 12 horas después de asistir a un matrimonio. Se decide iniciar una investigación epidemiológica.

Tras organizar el equipo de terreno, ¿cuál es el primer paso de la investigación del brote?

A) Publicar los resultados en la prensa

B) Confirmar el diagnóstico y verificar la existencia del brote

C) Diseñar un ensayo clínico con antibióticos

D) Calcular odds ratio antes de definir qué es un caso

E) Clausurar el local sin investigar

> **Respuesta B.** La investigación de un brote sigue pasos ordenados: confirmar el diagnóstico y la existencia del brote (más casos que lo esperado), definir caso, buscar casos, describir según persona, lugar y tiempo, plantear y probar hipótesis (por ejemplo, con casos y controles), aplicar medidas de control y comunicar los resultados.

656 sp-07 · Perfil V3 7.01.3.029 · Descripción sistemática de problemas · *Práctica*

Un equipo de salud detecta un aumento de casos de tuberculosis en su comuna y decide describir sistemáticamente el problema antes de plantear hipótesis sobre su causa.

¿Qué variables utiliza la epidemiología para describir sistemáticamente un problema de salud?

A) Persona, lugar y tiempo

B) Sensibilidad, especificidad y valores predictivos

C) Riesgo relativo, odds ratio y riesgo atribuible

D) Agente, vector y reservorio exclusivamente

E) Costo, beneficio y utilidad

> **Respuesta A.** La descripción sistemática de un problema responde quién se enferma (persona: edad, sexo, ocupación), dónde (lugar) y cuándo (tiempo: tendencias, estacionalidad, conglomerados). Esto cuantifica su magnitud, identifica grupos de riesgo y genera hipótesis. Las medidas de asociación corresponden a la etapa analítica y la sensibilidad a la evaluación de pruebas diagnósticas.

657 sp-05 · Perfil V3 7.01.3.030 · Criterios de priorización de problemas · *Práctica*

Tras su diagnóstico de situación, un CESFAM debe priorizar sus problemas de salud usando criterios clásicos: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad.

¿Qué evalúa el criterio de vulnerabilidad?

A) La gravedad del problema y su impacto social y económico

B) El número de personas afectadas

C) Si existen intervenciones eficaces capaces de modificar el problema

D) La disponibilidad de recursos y la aceptación de la comunidad

E) La tendencia del problema en los últimos años

> **Respuesta C.** En la priorización: magnitud es cuántos afecta (prevalencia, incidencia); trascendencia, su gravedad e impacto (mortalidad, discapacidad, años de vida perdidos, costo social); vulnerabilidad, la existencia de intervenciones eficaces para modificarlo; y factibilidad, si hay recursos, aceptabilidad y viabilidad para aplicarlas.

658 sp-01 · Perfil V3 7.01.3.033 · Bases conceptuales de la seguridad social · *Práctica*

En un sistema de seguridad social en salud, las personas de mayores ingresos cotizan más, y los aportes de los sanos y de quienes más ganan financian la atención de los enfermos y de quienes menos tienen.

¿Qué principio de la seguridad social describe esta situación?

A) Unidad

B) Universalidad

C) Integralidad

D) Suficiencia

E) Solidaridad

> **Respuesta E.** Los principios clásicos de la seguridad social son: universalidad (cubre a toda la población), integralidad (cubre todas las contingencias), solidaridad (cada uno aporta según su capacidad y recibe según su necesidad), suficiencia (prestaciones adecuadas a la necesidad) y unidad (coordinación administrativa). El subsidio cruzado entre ingresos y riesgos es solidaridad.

659 sp-01 · Perfil V3 7.01.3.034 · Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud · *Práctica*

En la historia de la salud chilena, en 1952 se integraron diversos servicios asistenciales, sanitarios y de beneficencia en una única institución estatal que pasó a atender a obreros e indigentes y a desarrollar programas de salud pública a nivel nacional.

¿Qué institución se creó en ese año?

A) El Fondo Nacional de Salud (FONASA)

B) El Servicio Nacional de Salud (SNS)

C) Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE)

D) La Caja del Seguro Obrero Obligatorio

E) El Régimen de Garantías Explícitas en Salud

> **Respuesta B.** En 1924 se creó la Caja del Seguro Obrero Obligatorio; en 1952, el Servicio Nacional de Salud, que unificó la atención estatal. A partir de 1979 y 1981 se reorganizó el sistema, creando el Sistema Nacional de Servicios de Salud, FONASA y las ISAPRE. En 2005 comenzó el régimen GES (AUGE).

660 sp-01 · Perfil V3 7.01.3.035 · Funciones de los sistemas de atención de salud · *Práctica*

Según la OMS, todo sistema de salud cumple funciones de rectoría, financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios. En Chile, estas funciones están separadas entre distintas instituciones.

¿Qué institución ejerce la función de rectoría del sistema de salud chileno?

A) Los Servicios de Salud

B) El Fondo Nacional de Salud (FONASA)

C) El Ministerio de Salud

D) La Superintendencia de Salud

E) La Central de Abastecimiento (CENABAST)

> **Respuesta C.** La rectoría (conducción, formulación de políticas y normas) corresponde al Ministerio de Salud, a través de sus subsecretarías y las SEREMI. FONASA ejerce el financiamiento y aseguramiento público; los Servicios de Salud gestionan la red asistencial que provee las prestaciones; la Superintendencia fiscaliza a FONASA, ISAPRE y prestadores; y CENABAST abastece de fármacos e insumos.

661 sp-01 · Perfil V3 7.01.3.037 · Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile · *Práctica*

El Ministerio de Salud define, para el período 2021-2030, los objetivos de impacto que el país espera lograr en salud de la población, junto con sus metas e indicadores, para orientar la planificación de toda la red.

¿Qué instrumento contiene estos objetivos sanitarios?

A) El arancel de FONASA

B) La Ley Ricarte Soto

C) El Código Sanitario

D) El Plan de Salud Comunal

E) La Estrategia Nacional de Salud

> **Respuesta E.** Los Objetivos Sanitarios de la Década se formalizan en la Estrategia Nacional de Salud, que fija ejes estratégicos, metas de impacto e indicadores para el período y orienta la planificación de la red. El Código Sanitario regula materias sanitarias, la Ley Ricarte Soto financia tratamientos de alto costo y el Plan Comunal es la programación local.

662 sp-13 · Perfil V3 7.01.3.050 · Rol del médico en la generación y uso de la información · *Práctica*

Paciente de 74 años con diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución, que desarrolló enfermedad renal crónica terminal. Fallece por una hiperkalemia grave que le produjo un paro cardiorrespiratorio. El médico debe llenar el certificado de defunción.

¿Cuál debe registrarse como causa básica de muerte?

A) Diabetes mellitus tipo 2

B) Paro cardiorrespiratorio

C) Hiperkalemia

D) Enfermedad renal crónica

E) Vejez

> **Respuesta A.** La causa básica es la enfermedad que inició la cadena de acontecimientos que llevó a la muerte, y es la que se usa en las estadísticas de mortalidad. Se anota en la última línea de la parte I, con las causas intermedias y la inmediata por encima. El paro cardiorrespiratorio es un mecanismo, no una causa, y no debe registrarse.

663 sp-02 · Perfil V3 7.01.3.053 · Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda · *Práctica*

Mujer de 22 años consulta en un servicio de urgencia 12 horas después de haber sido víctima de una violación con penetración vaginal sin preservativo, por un desconocido. Está hemodinámicamente estable, con lesiones leves.

Según la garantía GES de atención integral en agresión sexual aguda, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivarla al Servicio Médico Legal sin atenderla

B) Atención integral: anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, vacuna de hepatitis B, toma de muestras forenses, apoyo psicológico y denuncia

C) Esperar un test de embarazo en 2 semanas antes de indicar anticoncepción

D) Indicar profilaxis de VIH solo si se confirma que el agresor es VIH positivo

E) Indicar solo analgesia y control en atención primaria

> **Respuesta B.** La garantía GES asegura atención integral oportuna a víctimas de agresión sexual aguda: manejo de lesiones, anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS, VIH (idealmente antes de 72 horas) y hepatitis B, toma y custodia de muestras, apoyo psicosocial y seguimiento. La atención de salud no se posterga por el peritaje, y el establecimiento debe hacer la denuncia.

Traumatología

664 trauma-15 · Perfil V3 1.10.1.010 · Lumbago mecánico · *Práctica*

Hombre de 38 años, trabajador de bodega, presenta dolor lumbar de 4 días tras levantar una caja, sin irradiación bajo la rodilla. No tiene fiebre, baja de peso, alteración de esfínteres ni déficit neurológico.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Resonancia magnética de columna lumbar

B) Radiografía de columna lumbosacra y reposo absoluto por 2 semanas

C) Derivación a neurocirugía

D) Analgesia con AINE o paracetamol y mantener la actividad según tolerancia, sin imágenes

E) Corticoides sistémicos en dosis altas

> **Respuesta D.** El lumbago mecánico agudo sin signos de alarma evoluciona favorablemente en 4 a 6 semanas. No requiere imágenes y se maneja con analgesia, calor local, educación y mantenerse activo, porque el reposo en cama retrasa la recuperación. Las imágenes se indican ante banderas rojas o persistencia mayor de 6 semanas.

665 trauma-15 · Perfil V3 1.10.1.011 · Lumbociáticas y cervicobraquialgias. · *Práctica*

Mujer de 45 años con dolor lumbar irradiado por la cara posterior del muslo y la pierna hasta la planta y el borde lateral del pie. Al examen presenta Lasègue positivo a 40°, hipoestesia del borde lateral del pie, debilidad de la flexión plantar y reflejo aquiliano disminuido.

¿Cuál es la raíz más probablemente comprometida?

A) L3

B) S1

C) L5

D) L4

E) S3

> **Respuesta B.** La radiculopatía S1, típicamente por hernia discal L5-S1, produce dolor hacia la planta y el borde lateral del pie, debilidad de la flexión plantar y reflejo aquiliano disminuido. L5 compromete el dorso del pie y la extensión del ortejo mayor, sin alterar los reflejos clásicos, y L4 se asocia a reflejo rotuliano disminuido.

666 trauma-11 · Perfil V3 1.11.1.008 · Epicondilalgia, epitroclealgias · *Práctica*

Mujer de 42 años, que trabaja en una fábrica de empaque con movimientos repetitivos de la muñeca, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho de 2 meses. Al examen presenta dolor a la palpación del epicóndilo lateral y al extender la muñeca contra resistencia.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Epitrocleítis (codo de golfista)

B) Artritis reumatoide

C) Bursitis olecraneana

D) Síndrome del túnel carpiano

E) Epicondilitis lateral (codo de tenista)

> **Respuesta E.** Dolor en el epicóndilo lateral que aumenta con la extensión resistida de la muñeca (prueba de Cozen) es una epicondilitis lateral, tendinopatía del extensor radial corto del carpo por sobreuso. Se trata con modificación de la actividad, AINE, ortesis y ejercicios excéntricos. La epitrocleítis duele en la cara medial y con la flexión resistida de la muñeca.

667 trauma-15 · Perfil V3 1.11.1.011 · Hombro doloroso · *Práctica*

Hombre de 52 años, pintor, con dolor de hombro derecho de 3 meses que aumenta al levantar el brazo y de noche al dormir sobre ese lado. Al examen presenta arco doloroso entre 60° y 120° de abducción y pruebas de Neer y Hawkins positivas, con fuerza y rango pasivo conservados.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Capsulitis adhesiva

B) Rotura masiva del manguito rotador

C) Síndrome de pinzamiento subacromial (tendinopatía del supraespinoso)

D) Luxación glenohumeral

E) Artrosis acromioclavicular

> **Respuesta C.** Arco doloroso entre 60° y 120°, dolor nocturno y pruebas de Neer y Hawkins positivas, con fuerza y movilidad pasiva conservadas, sugieren pinzamiento subacromial con tendinopatía del supraespinoso. La capsulitis adhesiva limita el rango pasivo y el activo, y una rotura masiva produce debilidad o incapacidad de elevar el brazo.

668 trauma-11 · Perfil V3 1.11.1.012 · Lumbago infeccioso y tumoral · *Práctica*

Hombre de 45 años, usuario de drogas endovenosas, presenta dolor lumbar progresivo de 3 semanas, que no cede con el reposo y es peor de noche, con fiebre intermitente. Al examen hay dolor a la percusión de la apófisis espinosa de L3. PCR 120 mg/L, VHS 85 mm/h.

¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico?

A) Radiografía de columna lumbar

B) Solo analgesia y control en 6 semanas

C) Densitometría ósea

D) Electromiografía

E) Resonancia magnética de columna lumbar con gadolinio

> **Respuesta E.** Un lumbago con banderas rojas (fiebre, drogas endovenosas, dolor nocturno, reactantes elevados) sugiere espondilodiscitis o absceso epidural. La resonancia con gadolinio es el examen de elección por su sensibilidad precoz; la radiografía se altera tarde. Además se toman hemocultivos y, si son negativos, biopsia. Otras banderas rojas son el antecedente de cáncer y la baja de peso.

669 trauma-08 · Perfil V3 1.11.3.003 · Riesgos deportivos · *Práctica*

Futbolista de 22 años que, al cambiar bruscamente de dirección con el pie apoyado, siente un chasquido en la rodilla derecha y no puede seguir jugando. En las horas siguientes la rodilla aumenta de volumen. Al examen hay derrame y la prueba de Lachman es positiva.

¿Cuál es la lesión más probable?

A) Tendinopatía rotuliana

B) Rotura aislada del ligamento colateral medial

C) Lesión del ligamento cruzado posterior

D) Rotura del ligamento cruzado anterior

E) Condromalacia patelar

> **Respuesta D.** El mecanismo de pivote con pie fijo, el chasquido, la imposibilidad de continuar y la hemartrosis precoz son típicos de la rotura del ligamento cruzado anterior, confirmada por Lachman positivo; se estudia con resonancia. El cruzado posterior se lesiona por golpe directo en la tibia y da cajón posterior. Los programas de prevención neuromuscular reducen este riesgo deportivo.

670 trauma-14 · Perfil V3 2.01.1.091 · Alteraciones de los pies · *Práctica*

Recién nacido de término, de 2 días de vida, en puerperio. Al examen, el pie derecho está en equino, varo, aducto y cavo, con un pliegue medial profundo, y no se logra llevar a posición neutra con la manipulación suave. El resto del examen, incluidas caderas y columna, es normal.

¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?

A) Pie metatarso aducto postural; observar y tranquilizar

B) Pie bot; esperar hasta el año de vida para cirugía

C) Pie plano flexible; plantillas desde el inicio de la marcha

D) Pie talo valgo; ejercicios de elongación por los padres

E) Pie bot (equinovaro congénito); derivar precozmente a traumatología infantil para tratamiento con método de Ponseti (yesos seriados)

> **Respuesta E.** El pie bot o equinovaro congénito tiene equino, varo, aducto y cavo rígidos, que no se corrigen con la manipulación. Debe derivarse en las primeras semanas para el método de Ponseti con yesos seriados, habitualmente con tenotomía del Aquiles y férula de abducción. Las deformidades posturales, en cambio, se corrigen pasivamente.

671 trauma-04 · Perfil V3 2.01.2.009 · Fracturas · *Práctica*

Un niño de 6 años cae de un columpio sobre la mano con el codo en extensión. Presenta dolor, aumento de volumen y deformidad del codo. La radiografía muestra una fractura supracondílea del húmero desplazada. La mano está pálida, fría y no se palpa el pulso radial.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inmovilización con yeso braquiopalmar y control en una semana

B) Solicitar angiografía y esperar el resultado antes de cualquier maniobra

C) Analgesia y cirugía electiva en 7 días

D) Reducción e inmovilización urgente, con evaluación vascular inmediata

E) Vendaje elástico y elevación de la extremidad

> **Respuesta D.** La fractura supracondílea es la fractura de codo más frecuente en niños. Si está desplazada y hay compromiso vascular (lesión o compresión de la arteria braquial), es una urgencia: se reduce de inmediato, habitualmente en pabellón con fijación percutánea, y se reevalúa el pulso y la perfusión. Si no se resuelve, se explora la arteria.

672 trauma-03 · Perfil V3 4.01.1.049 · Trombosis venosa profunda y tromboflebitis · *Práctica*

Hombre de 64 años, operado hace 12 días de una fractura de cadera, sin profilaxis antitrombótica desde el alta. Consulta por aumento de volumen y dolor de la pantorrilla izquierda de 2 días. Al examen, la pierna izquierda tiene 4 cm más de circunferencia que la derecha, edema con fóvea y dolor a la palpación del trayecto venoso. Sin disnea, saturación 97%.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar dímero D y, si es positivo, repetirlo en 1 semana

B) Instalar un filtro de vena cava inferior como primera medida

C) Indicar AINE y reposo con la pierna elevada

D) Solicitar flebografía antes de cualquier tratamiento

E) Ecografía doppler venosa de la extremidad e iniciar anticoagulación, por ejemplo con heparina de bajo peso molecular

> **Respuesta E.** Con alta probabilidad clínica (cirugía traumatológica reciente, edema asimétrico, dolor en el trayecto venoso), el dímero D no aporta: se confirma con ecografía doppler y se anticoagula, iniciando sin esperar si hay demora y no hay contraindicación. El filtro de cava se reserva para quienes no pueden anticoagularse.

673 trauma-09 · Perfil V3 4.01.1.049 · Trombosis venosa profunda y tromboflebitis · *Práctica*

Mujer de 48 años con várices en ambas piernas consulta por un cordón indurado, rojo, caliente y doloroso en la cara medial de la pierna derecha, bajo la rodilla, de 3 días de evolución, tras un golpe con el pedal de la bicicleta. Sin fiebre ni edema de la extremidad. La ecografía doppler muestra trombosis de un segmento de la vena safena mayor a 15 cm de la unión safenofemoral, con venas profundas permeables.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibióticos endovenosos por celulitis

B) Anticoagulación oral con warfarina por 6 meses

C) Calor local, AINE, compresión elástica y deambulación, con control clínico

D) Reposo absoluto en cama con la pierna en alto por 2 semanas

E) Instalar un filtro de vena cava inferior

> **Respuesta C.** Una tromboflebitis superficial corta, alejada más de 3 cm de la unión safenofemoral y sin trombosis profunda, se trata con calor local, AINE, compresión y deambulación. Se anticoagula si el segmento mide 5 cm o más, está cerca del cayado o se asocia a TVP. El reposo absoluto favorece la progresión.

674 trauma-04 · Perfil V3 4.01.2.023 · Traumatismos vasculares · *Práctica*

Hombre de 22 años sufre una herida por arma blanca en la cara medial del muslo derecho. Ingresa con un hematoma pulsátil que aumenta de tamaño, frémito palpable y ausencia de pulsos poplíteo y pedio en esa extremidad. PA 110/70 mmHg tras la reanimación inicial.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Medir el índice tobillo-brazo y reevaluar en 6 horas

B) Exploración quirúrgica vascular inmediata

C) AngioTAC electiva al día siguiente

D) Vendaje compresivo y alta con control

E) Ecografía Doppler venosa

> **Respuesta B.** Los signos duros de lesión vascular (hemorragia pulsátil, hematoma expansivo, frémito o soplo, ausencia de pulsos distales o isquemia) indican exploración quirúrgica inmediata, sin necesidad de imágenes previas. El índice tobillo-brazo o la angioTAC se usan ante signos blandos, como un hematoma estable o un déficit neurológico vecino.

675 trauma-15 · Perfil V3 4.01.4.005 · Radiografía de columna dorsal y lumbar · *Práctica*

Hombre de 35 años, oficinista, consulta por dolor lumbar de 5 días tras levantar una caja. El dolor es mecánico, sin irradiación bajo la rodilla. No tiene fiebre, baja de peso, antecedentes de cáncer, trauma mayor ni alteraciones esfinterianas. El examen neurológico es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Radiografía de columna lumbar AP y lateral

B) Resonancia magnética lumbar

C) No solicitar imágenes; analgesia, mantener la actividad y control

D) TAC de columna lumbar

E) Reposo absoluto en cama por 2 semanas

> **Respuesta C.** El lumbago agudo mecánico sin signos de alarma (edad mayor de 50 o menor de 20 años, cáncer, fiebre, baja de peso, trauma mayor, déficit neurológico o síntomas esfinterianos) no requiere imágenes, porque no cambian el manejo y suelen mostrar hallazgos inespecíficos. Se trata con analgesia y manteniendo la actividad; el reposo prolongado empeora la evolución.

676 trauma-10 · Perfil V3 4.01.4.006 · Radiografía de pelvis y cadera · *Práctica*

Mujer de 82 años sufre una caída a nivel. Presenta dolor inguinal derecho e imposibilidad de caminar. La radiografía de pelvis AP y la axial de cadera derecha no muestran fractura, pero el dolor persiste al día siguiente e impide la marcha.

¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Repetir la radiografía en 3 semanas

B) Ecografía de cadera

C) Densitometría ósea

D) Resonancia magnética de cadera

E) Cintigrafía ósea en 1 mes

> **Respuesta D.** Ante sospecha clínica de fractura de cadera con radiografías iniciales normales, el examen de elección es la resonancia magnética, que detecta fracturas ocultas del cuello femoral en las primeras horas (la TAC es alternativa si no hay acceso). Esperar semanas expone a desplazamiento de la fractura y necrosis avascular. La densitometría evalúa osteoporosis, no fracturas agudas.

677 trauma-07 · Perfil V3 4.01.4.007 · Radiografía de extremidades · *Práctica*

Mujer de 28 años sufre un esguince por inversión del tobillo derecho jugando básquetbol. Presenta dolor y edema en la zona lateral. No puede dar 4 pasos al llegar a urgencia y tiene dolor a la palpación del borde posterior del maléolo lateral.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magnética de tobillo

B) Solicitar radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja

C) Inmovilizar sin estudio radiológico

D) Solicitar TAC de tobillo

E) Solicitar radiografía de pie exclusivamente

> **Respuesta B.** Según las reglas de Ottawa, se solicita radiografía de tobillo si hay dolor en la zona maleolar con dolor a la palpación del borde posterior o la punta de cualquiera de los maléolos, o incapacidad de dar 4 pasos. Esta paciente cumple ambos criterios. La radiografía de extremidades debe incluir al menos 2 proyecciones ortogonales.

678 trauma-01 · Perfil V3 4.01.5.032 · Vendajes e inmovilizaciones con férulas · *Práctica*

Hombre de 30 años sufre una fractura de radio distal no desplazada hace 3 horas. Presenta edema moderado de la muñeca y antebrazo. Se decide tratamiento ortopédico.

¿Cuál es la inmovilización inicial más adecuada?

A) Yeso circular cerrado ajustado

B) Sin inmovilización, con analgesia

C) Vendaje elástico compresivo exclusivo

D) Férula (valva) de yeso antebraquiopalmar, no circular, con extremidad elevada

E) Yeso braquiopalmar circular cerrado

> **Respuesta D.** En una fractura aguda con edema, la inmovilización inicial debe ser una férula o valva no circular, que inmoviliza las articulaciones vecinas y permite el aumento de volumen sin comprimir, previniendo un síndrome compartimental. Se indica elevar la extremidad, mover los dedos y vigilar dolor y perfusión; el yeso circular se coloca cuando cede el edema.

679 trauma-07 · Perfil V3 4.02.2.003 · Esguince grado1 · *Práctica*

Mujer de 24 años se dobla el tobillo derecho hacia adentro jugando básquetbol hace 3 horas. Pudo caminar 4 pasos al llegar al SAPU. Al examen: leve aumento de volumen y dolor a la palpación del ligamento peroneoastragalino anterior, sin dolor en el borde posterior ni la punta de los maléolos, ni en la base del quinto metatarsiano ni en el navicular. Cajón anterior negativo.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja antes de indicar tratamiento

B) Bota de yeso por 4 semanas

C) Reposo relativo, hielo, compresión y elevación, analgesia, carga precoz según tolerancia y ejercicios de propiocepción

D) Resonancia magnética para evaluar rotura ligamentosa

E) Derivación a traumatología para reparación quirúrgica

> **Respuesta C.** Por las reglas de tobillo de Ottawa (camina 4 pasos, sin dolor óseo en maléolos, quinto metatarsiano ni navicular) no requiere radiografía. Es un esguince grado 1 del peroneoastragalino anterior, que se trata con medidas RICE, analgesia, movilización y carga precoz y rehabilitación propioceptiva; el yeso no está indicado.

680 trauma-09 · Perfil V3 4.02.2.003 · Esguince grado1 · *Práctica*

Hombre de 29 años recibe un golpe en la cara externa de la rodilla derecha jugando fútbol hace 1 día. Camina con leve cojera. Al examen: dolor a la palpación del ligamento colateral medial, sin derrame articular. El bostezo en valgo a 30 grados de flexión es doloroso pero sin apertura de la interlínea y con tope firme. Lachman y cajón anterior negativos, sin bloqueo.

¿Cuál es el diagnóstico y el manejo más adecuados?

A) Esguince grado 3 del colateral medial; cirugía de reparación

B) Esguince grado 1 del colateral medial; frío local, analgesia, carga según tolerancia y fortalecimiento precoz, sin inmovilización rígida

C) Rotura de menisco medial; resonancia magnética urgente

D) Rotura del ligamento cruzado anterior; derivar a cirugía artroscópica

E) Esguince grado 2; yeso inguinopédico por 6 semanas

> **Respuesta B.** En el esguince grado 1 hay distensión de fibras sin pérdida de continuidad: dolor a la palpación y al estrés, pero sin laxitud y con tope firme. Se maneja con frío, analgesia, carga precoz y ejercicios, sin inmovilización rígida. La laxitud con tope firme sería grado 2 y sin tope, grado 3.

681 trauma-11 · Perfil V3 4.02.3.005 · Lumbociática radicular · *Práctica*

Hombre de 38 años presenta lumbago de inicio tras levantar peso hace 10 días, irradiado por la cara posterolateral del muslo y la pierna hasta el dorso del pie y el ortejo mayor derechos, con parestesias en esa zona. Lasègue positivo a 40°. Debilidad leve de la dorsiflexión del ortejo mayor. Reflejos aquilianos simétricos. Sin alteración esfinteriana ni anestesia en silla de montar.

¿Qué raíz está más probablemente comprometida y cuál es la conducta inicial?

A) S1; resonancia magnética urgente

B) S1; reposo absoluto en cama por 2 semanas

C) L4; cirugía descompresiva electiva

D) L5; resonancia magnética urgente y cirugía

E) L5; tratamiento médico con analgesia y actividad según tolerancia

> **Respuesta E.** Dolor hasta el dorso del pie y ortejo mayor, debilidad del extensor del hallux y aquiliano normal indican radiculopatía L5 (hernia L4-L5). Sin déficit progresivo ni síndrome de cauda equina, el manejo inicial es médico por 4 a 6 semanas, con analgesia y mantenerse activo; la resonancia se reserva para banderas rojas o falla del tratamiento.

682 trauma-15 · Perfil V3 4.02.4.001 · Radiografía de columna vertebral · *Práctica*

Hombre de 35 años consulta por lumbago de 5 días tras levantar una caja. Sin irradiación, sin fiebre, sin baja de peso, sin antecedente de cáncer ni de trauma mayor, sin déficit neurológico. Pide que le tomen una radiografía de columna lumbar.

¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a las imágenes?

A) No solicitar imágenes; reevaluar si persiste más de 4 a 6 semanas o aparecen banderas rojas

B) Resonancia magnética lumbar

C) Radiografía lumbar AP y lateral para descartar fractura

D) TAC de columna lumbar

E) Radiografía lumbar con proyecciones oblicuas

> **Respuesta A.** El lumbago agudo inespecífico sin banderas rojas no requiere imágenes: la radiografía no cambia el manejo, irradia y detecta hallazgos degenerativos irrelevantes. Se indica radiografía ante trauma significativo, edad avanzada con sospecha de fractura osteoporótica, sospecha de cáncer o infección, o dolor persistente pese a tratamiento.

683 trauma-14 · Perfil V3 4.02.4.004 · Radiografía de displasia cadera · *Práctica*

Lactante de 3 meses, sexo femenino, primera hija, nacida en presentación podálica, asiste a control de salud. El examen de caderas muestra leve limitación de la abducción izquierda, sin signos de Ortolani ni Barlow. Según la normativa ministerial, corresponde el tamizaje por imagen a esta edad.

¿Qué hallazgo de la radiografía de pelvis apoya el diagnóstico de displasia de cadera?

A) Índice acetabular aumentado, sobre 30 grados, con la metáfisis femoral desplazada hacia afuera de la línea de Perkins y ruptura del arco de Shenton

B) Índice acetabular de 20 grados con el núcleo femoral en el cuadrante inferior interno

C) Ausencia de núcleo de osificación de la cabeza femoral, que siempre indica luxación

D) Línea de Hilgenreiner que pasa por ambos cartílagos trirradiados

E) Densidad ósea disminuida en ambas caderas

> **Respuesta A.** En Chile se tamiza con radiografía de pelvis a los 3 meses. Sugieren displasia un índice acetabular mayor de 30 grados, la metáfisis o el núcleo femoral fuera del cuadrante inferointerno formado por las líneas de Hilgenreiner y Perkins, y la ruptura del arco de Shenton. La ausencia del núcleo de osificación puede ser normal a esta edad.

684 trauma-13 · Perfil V3 4.02.4.005 · Radiografía en tumores oseos · *Práctica*

Adolescente de 15 años consulta por dolor en la rodilla izquierda de 2 meses, que lo despierta en la noche, y aumento de volumen. La radiografía muestra en la metáfisis distal del fémur una lesión de bordes mal definidos, con destrucción cortical, formación de hueso en rayos de sol y un triángulo de Codman.

¿Cuál es la interpretación radiológica y el diagnóstico más probable?

A) Lesión benigna de márgenes escleróticos; osteocondroma

B) Nidus radiolúcido menor de 1 cm con esclerosis; osteoma osteoide

C) Lesión lítica central bien delimitada; quiste óseo simple

D) Lesión agresiva con reacción perióstica maligna; osteosarcoma

E) Lesión epifisaria en pompas de jabón; tumor de células gigantes

> **Respuesta D.** Bordes mal definidos, rotura cortical, reacción perióstica en rayos de sol y triángulo de Codman son signos radiológicos de agresividad. En la metáfisis de un adolescente, el diagnóstico más probable es osteosarcoma; se deriva para resonancia de todo el hueso, TC de tórax y biopsia en centro especializado.

685 trauma-12 · Perfil V3 4.02.4.007 · Citoquimico de líquido articular · *Práctica*

Hombre de 60 años, diabético, consulta por dolor, calor y aumento de volumen de la rodilla izquierda de 2 días, con fiebre de 38,6 grados. Se realiza artrocentesis, que obtiene líquido turbio. Citoquímico: 85.000 leucocitos por mm3 con 92% de polimorfonucleares, glucosa 20 mg/dL (glicemia 160 mg/dL). No se observan cristales. Gram pendiente.

¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?

A) Líquido no inflamatorio por artrosis; paracetamol y kinesioterapia

B) Líquido séptico; hospitalizar, tomar hemocultivos, iniciar antibióticos endovenosos empíricos y drenaje articular

C) Gota aguda; colchicina y alta

D) Líquido hemorrágico; reposo y frío local

E) Líquido inflamatorio leve; infiltrar corticoides intraarticulares

> **Respuesta B.** Un líquido articular turbio con más de 50.000 leucocitos por mm3, predominio polimorfonuclear sobre 90% y glucosa muy baja respecto de la sangre es séptico hasta demostrar lo contrario. Se hospitaliza, se cultiva, se inician antibióticos empíricos con cobertura de Staphylococcus aureus y se drena. Los corticoides intraarticulares están contraindicados.

686 trauma-01 · Perfil V3 4.02.5.001 · Inmovilizaciones de urgencia · *Práctica*

Mujer de 34 años se cae de una bicicleta y llega al SAPU con dolor y deformidad en el tercio medio de la pierna izquierda. La piel está indemne, pulsos pedios presentes, llene capilar menor de 2 segundos y sensibilidad conservada. Debe ser trasladada al hospital, a 40 minutos.

¿Cuál es la inmovilización de urgencia más adecuada antes del traslado?

A) Yeso circular cerrado desde el muslo hasta el pie

B) Vendaje elástico compresivo solo sobre el foco de fractura

C) Férula que incluya la articulación proximal y distal (rodilla y tobillo), previa alineación suave y con control neurovascular antes y después

D) No inmovilizar para no retrasar el traslado

E) Reducción forzada bajo anestesia local y luego traslado sin férula

> **Respuesta C.** La inmovilización de urgencia debe incluir la articulación por encima y por debajo de la fractura, alinear con tracción suave, usar férulas acolchadas no circulares y registrar el estado neurovascular antes y después. El yeso circular en agudo está contraindicado por el edema y el riesgo de síndrome compartimental.

687 trauma-02 · Perfil V3 4.02.5.001 · Inmovilizaciones de urgencia · *Práctica*

Hombre de 26 años cae de una escalera sobre la mano extendida. Llega al SAPU con dolor y deformidad en dorso de tenedor en la muñeca derecha. Piel indemne, llene capilar normal y sensibilidad conservada en los dedos. Se decide inmovilizar antes de derivarlo para radiografía y manejo definitivo.

¿Cuál es la inmovilización de urgencia más adecuada?

A) Yeso circular braquiopalmar cerrado

B) Vendaje elástico compresivo apretado desde la mano al codo

C) Solo cabestrillo, sin férula

D) Valva o férula antebraquiopalmar acolchada, sin cerrar en forma circular, con cabestrillo y control neurovascular

E) Reducción forzada sin analgesia y luego vendaje

> **Respuesta D.** En urgencia se inmoviliza con férulas o valvas acolchadas no circulares que incluyan las articulaciones vecinas, dejando espacio para el edema, con elevación y registro neurovascular antes y después. El yeso circular cerrado y los vendajes compresivos en agudo arriesgan un síndrome compartimental.

688 trauma-12 · Perfil V3 4.02.5.002 · Punción articular de rodilla · *Práctica*

Hombre de 45 años con derrame a tensión de rodilla derecha de 24 horas, sin trauma. Se decide artrocentesis diagnóstica en el servicio de urgencia.

¿Cuál de las siguientes condiciones contraindica realizar la punción por la vía planificada?

A) Fiebre de 38,5 °C

B) Celulitis de la piel en el sitio de punción

C) Uso de aspirina en dosis baja

D) Antecedente de gota

E) Derrame mayor de 50 mL

> **Respuesta B.** La única contraindicación absoluta habitual de la artrocentesis es la infección de piel o celulitis sobre el sitio de punción, porque se puede inocular la articulación; se elige otro abordaje. La fiebre es una indicación (descartar artritis séptica). La antiagregación o anticoagulación en rango no la contraindica. Se usa técnica aséptica, habitualmente por abordaje suprapatelar lateral.

689 trauma-04 · Perfil V3 4.02.5.003 · Reducción de luxaciones de codo, hombro e interfalángicas · *Práctica*

Hombre de 30 años con luxación posterior de codo izquierdo tras caída, sin fracturas en la radiografía. Antes de reducir, el pulso radial está presente y la sensibilidad de la mano es normal. Se reduce mediante tracción longitudinal del antebrazo con contratracción del brazo y flexión progresiva.

Inmediatamente después de la reducción, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Dar de alta con analgesia, sin inmovilización

B) Solicitar resonancia magnética urgente

C) Inmovilizar con yeso en extensión por 6 semanas

D) Reevaluar pulsos y función neurológica, controlar con radiografía y dejar férula braquiopalmar por un período corto

E) Iniciar ejercicios de fuerza inmediatamente

> **Respuesta D.** Tras toda reducción de una luxación se debe reexaminar el estado neurovascular (la arteria braquial y los nervios mediano y cubital pueden quedar atrapados), confirmar la reducción con radiografía e inmovilizar brevemente en flexión, con movilización precoz para evitar rigidez. Inmovilizar en extensión o por largo tiempo produce rigidez.

690 trauma-10 · Perfil V3 4.02.5.004 · Tracción de partes blandas · *Práctica*

Mujer de 82 años con fractura pertrocantérea de cadera derecha espera cirugía, programada en 48 horas. Se instala tracción de partes blandas (cutánea) en la extremidad, con vendaje y peso de 3 kg.

¿Cuál es la complicación que más se debe vigilar por esta tracción?

A) Trombosis arterial femoral

B) Osteomielitis del trayecto de los clavos

C) Síndrome de embolia grasa causado por la tracción

D) Luxación de la rodilla

E) Lesión de la piel (flictenas, úlceras por presión) y compresión del nervio peroneo a nivel de la cabeza del peroné

> **Respuesta E.** La tracción de partes blandas usa vendas adheridas a la piel con pesos bajos (hasta 3 a 5 kg en adultos). Sus complicaciones típicas son lesiones cutáneas por fricción o presión y neuropraxia del peroneo común en la cabeza del peroné; se vigilan piel, sensibilidad y dorsiflexión. La infección del trayecto es propia de la tracción esquelética.

691 trauma-02 · Perfil V3 4.02.5.005 · Traslado del traumatizado · *Práctica*

Un motociclista de 30 años choca a alta velocidad en una carretera rural. Al llegar el equipo de rescate, está confuso con Glasgow 13, se queja de dolor cervical y tiene deformidad del muslo derecho. Respira espontáneamente, presión arterial 110/70 mmHg y frecuencia cardíaca 105 por minuto. Aún tiene el casco puesto.

¿Cuál es la conducta más adecuada para su traslado?

A) Sentarlo en el auto de un testigo para llegar más rápido al hospital

B) Mantener la vía aérea, retirar el casco entre dos personas con estabilización manual de la columna, colocar collar cervical, tabla espinal y férula de la extremidad, y trasladar monitorizado al centro adecuado

C) Retirar el casco tirando de él rápidamente para evaluar la cara

D) Esperar en el lugar a tener radiografías antes de movilizarlo

E) Trasladarlo en decúbito lateral sin inmovilización cervical para evitar aspiración

> **Respuesta B.** Todo politraumatizado con mecanismo de alta energía, compromiso de conciencia o dolor cervical se traslada con restricción de movimiento espinal: vía aérea primero, retiro del casco entre dos operadores con estabilización manual, collar, tabla, férulas en las fracturas, oxígeno y monitorización, hacia el centro con capacidad resolutiva.

Urología

692 uro-15 · Perfil V3 1.02.4.013 · Examen de orina completa · *Práctica*

Un hombre de 30 años presenta orina color 'coca-cola' y edema palpebral 2 semanas después de una faringitis. Su presión arterial es 150/95 mmHg.

¿Qué hallazgo en el examen de orina completa confirma el origen glomerular de la hematuria?

A) Cristales de oxalato de calcio

B) Leucocitos abundantes con bacterias

C) Nitritos positivos

D) Cilindros hemáticos y glóbulos rojos dismórficos

E) Hematuria con coágulos

> **Respuesta D.** Los cilindros hemáticos y los glóbulos rojos dismórficos (acantocitos) indican sangrado de origen glomerular, aquí una probable glomerulonefritis postestreptocócica. La hematuria con coágulos sugiere origen urológico (vía urinaria), y nitritos con leucocitos y bacterias orientan a infección urinaria.

693 uro-01 · Perfil V3 1.03.4.011 · Calciuria · *Práctica*

Un hombre de 38 años ha tenido 3 episodios de cólico renal en 2 años por cálculos de oxalato de calcio. Su calcemia, PTH y función renal son normales.

¿Qué examen es el más importante para orientar la prevención de nuevos cálculos y cuál es el hallazgo más frecuente?

A) Uricemia: hiperuricemia

B) Calciuria de 24 horas: hipercalciuria idiopática

C) Cistinuria: cistinuria

D) Urocultivo: infección por Proteus

E) Cintigrama renal: hidronefrosis

> **Respuesta B.** La litiasis recurrente amerita estudio metabólico en orina de 24 horas (calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, volumen). La alteración más frecuente en la litiasis cálcica es la hipercalciuria idiopática, con calcemia y PTH normales. Se maneja con abundante agua, dieta baja en sodio con calcio normal y, si persiste, tiazidas.

694 uro-08 · Perfil V3 1.08.4.002 · Cintigrafía ósea y cintigrafía con galio · *Práctica*

Hombre de 68 años con antígeno prostático específico de 62 ng/mL y biopsia prostática con adenocarcinoma Gleason 8 (4+4). Refiere dolor lumbar leve.

¿Cuál es el examen más adecuado para el estudio de extensión ósea?

A) Radiografía de columna lumbar

B) Cintigrafía ósea

C) Densitometría ósea

D) Cintigrafía con galio

E) No requiere estudio de extensión

> **Respuesta B.** En cáncer de próstata de alto riesgo (APE mayor de 20 o Gleason 8 o más) se estudia la extensión ósea con cintigrafía ósea, muy sensible para metástasis osteoblásticas, junto con TAC de abdomen y pelvis o PET-PSMA. La radiografía es poco sensible y la densitometría mide masa ósea. La cintigrafía con galio se usa en linfomas e infecciones.

695 uro-02 · Perfil V3 1.09.1.025 · Uropatía obstructiva · *Práctica*

Hombre de 79 años con síntomas urinarios obstructivos de años presenta tenesmo vesical, goteo y dolor hipogástrico. Al examen se palpa globo vesical. Creatinina 3,8 mg/dL (basal 1,1). La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral y vejiga distendida.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Instalación de sonda vesical Foley

B) Nefrostomía percutánea bilateral

C) Hemodiálisis de urgencia

D) Iniciar tamsulosina y control en 1 semana

E) Resección transuretral de próstata de urgencia

> **Respuesta A.** Es una uropatía obstructiva baja con insuficiencia renal posrenal por hiperplasia prostática con retención crónica. Lo primero es descomprimir la vejiga con sonda Foley, lo que resuelve la hidronefrosis bilateral, vigilando la poliuria posobstructiva. La nefrostomía se usa en la obstrucción alta y la diálisis no corresponde si se corrige la causa.

696 uro-01 · Perfil V3 1.09.2.001 · Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones: · *Práctica*

Mujer de 40 años consulta por dolor lumbar derecho cólico irradiado a la ingle, con náuseas. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 6 mm en el uréter distal derecho con hidronefrosis leve.

¿Cuál de los siguientes hallazgos obliga a hospitalizar y resolver la obstrucción en forma urgente?

A) Hematuria microscópica

B) Dolor que cede con ketorolaco

C) Fiebre de 38,8 °C con escalofríos

D) Cálculo menor de 10 mm

E) Antecedente de un cólico renal previo

> **Respuesta C.** Un cólico renal con fiebre sugiere uropatía obstructiva infectada, que puede evolucionar rápido a sepsis: requiere hospitalización, antibióticos y drenaje urgente de la vía urinaria con catéter doble J o nefrostomía. Otras indicaciones de hospitalizar son monorreno, falla renal, dolor refractario o vómitos incoercibles. La hematuria es esperable en el cólico.

697 uro-01 · Perfil V3 1.09.4.003 · Pielo TAC · *Práctica*

Hombre de 38 años con dolor lumbar izquierdo cólico intenso de inicio súbito, irradiado a la fosa ilíaca y al testículo, con hematuria microscópica. Afebril, con función renal normal.

¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Radiografía simple de abdomen

B) Pielo TAC (TAC de abdomen y pelvis sin contraste)

C) Pielografía de eliminación

D) Cintigrama renal

E) Resonancia magnética de abdomen

> **Respuesta B.** La pielo TAC, tomografía sin contraste, es el examen de elección en el cólico renal: tiene sensibilidad y especificidad cercanas al 95% y muestra cálculos de cualquier composición, su tamaño y ubicación, la hidronefrosis y diagnósticos diferenciales. La radiografía no ve cálculos radiolúcidos y la pielografía requiere contraste y está en desuso. En embarazadas se prefiere la ecografía.

698 uro-01 · Perfil V3 1.09.4.004 · Radiografía renal y vesical simple · *Práctica*

Hombre de 55 años con gota tofácea presenta un cólico renal. La pielo TAC muestra un cálculo de 7 mm en el uréter proximal derecho, pero en la radiografía simple renal y vesical no se observan imágenes radioopacas.

¿Cuál es la composición más probable del cálculo?

A) Oxalato de calcio

B) Fosfato de calcio

C) Estruvita

D) Ácido úrico

E) Cistina

> **Respuesta D.** Los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos: no se ven en la radiografía simple de riñón y vejiga, pero sí en la TAC. Se asocian a gota, hiperuricemia y orina ácida, y pueden disolverse alcalinizando la orina con citrato de potasio. Los cálculos de calcio y la estruvita son radioopacos, y la cistina es débilmente opaca.

699 uro-03 · Perfil V3 1.09.4.006 · Ecografía vésico-prostática básica · *Práctica*

Hombre de 70 años con síntomas urinarios bajos moderados: chorro débil, nicturia y sensación de vaciado incompleto. Al tacto rectal, la próstata está aumentada de tamaño, lisa y elástica. Función renal normal.

¿Cuál es el examen de imagen más útil en la evaluación inicial?

A) Pielografía de eliminación

B) Resonancia magnética de pelvis

C) Cistografía miccional

D) TAC de abdomen con contraste

E) Ecografía vésico-prostática con medición del residuo postmiccional

> **Respuesta E.** En la hiperplasia prostática benigna, la ecografía vésico-prostática estima el volumen prostático, evalúa la pared vesical y la presencia de litiasis, y mide el residuo postmiccional; un residuo significativo (mayor de 100-150 mL) indica vaciamiento incompleto y riesgo de retención. La RM se usa ante sospecha de cáncer, y la TAC y la pielografía no son rutinarias.

700 uro-01 · Perfil V3 1.09.4.011 · Estudio metabólico de urolitiasis · *Práctica*

Distintos pacientes consultan tras expulsar su primer cálculo urinario.

¿En cuál de ellos está indicado un estudio metabólico completo de urolitiasis (orina de 24 horas, calcemia, PTH)?

A) Hombre de 40 años con un primer cálculo de 4 mm expulsado, sin otros antecedentes

B) Hombre de 50 años con un único cólico hace 10 años

C) Mujer de 35 años monorrena con un primer cálculo

D) Mujer de 45 años con un cálculo único sin hidronefrosis

E) Ningún paciente con litiasis requiere estudio metabólico

> **Respuesta C.** El estudio metabólico completo se indica en pacientes de alto riesgo: litiasis recurrente, monorrenos, niños, cálculos bilaterales o múltiples, cálculos de ácido úrico, cistina o estruvita, enfermedades asociadas como hiperparatiroidismo, gota o malabsorción, y nefrocalcinosis. En un primer episodio no complicado basta un estudio básico y medidas generales como la hidratación.

701 uro-12 · Perfil V3 1.09.5.001 · Cistoscopia · *Práctica*

Hombre de 66 años, fumador de 40 paquetes-año, presenta en 2 ocasiones hematuria macroscópica total, indolora, con coágulos. Urocultivo negativo y función renal normal.

¿Cuál es el examen fundamental para el diagnóstico?

A) Cistoscopía

B) Citología urinaria como único examen

C) Repetir orina completa en 3 meses

D) Antígeno prostático específico

E) Ecografía renal sin otro estudio

> **Respuesta A.** La hematuria macroscópica indolora en un fumador mayor de 40 años es cáncer vesical hasta demostrar lo contrario. La cistoscopía visualiza directamente la vejiga y permite biopsiar; se complementa con uro-TAC para evaluar el tracto urinario alto. La citología tiene baja sensibilidad en tumores de bajo grado y no reemplaza la cistoscopía.

702 uro-02 · Perfil V3 1.09.5.002 · Cistostomía de urgencia · *Práctica*

Hombre de 30 años, motociclista, con fractura de pelvis tras una colisión. Presenta sangre en el meato uretral, hematoma perineal y globo vesical palpable, y no puede orinar.

¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?

A) Instalar sonda Foley forzando el paso

B) Nefrostomía percutánea bilateral

C) Esperar la micción espontánea

D) Sonda Foley de menor calibre bien lubricada

E) Cistostomía suprapúbica

> **Respuesta E.** Sangre en el meato con fractura de pelvis sugiere lesión de la uretra posterior: está contraindicado instalar una sonda uretral, que puede completar la rotura. Se estudia con uretrografía retrógrada y la vejiga se drena con cistostomía suprapúbica, idealmente guiada por ecografía. La nefrostomía corresponde a obstrucción alta, no vesical.

703 uro-01 · Perfil V3 1.09.5.003 · Instalación pigtail · *Práctica*

Mujer de 45 años con un cálculo de 8 mm en el uréter proximal izquierdo e hidronefrosis moderada presenta fiebre de 39 °C, escalofríos, PA 95/60 mmHg y leucocitosis.

Además de antibióticos y fluidos, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Litotripsia extracorpórea urgente

B) Nefrectomía de urgencia

C) Tamsulosina y esperar la expulsión

D) Drenaje urgente de la vía urinaria con catéter ureteral doble J (pigtail) o nefrostomía

E) Ureteroscopía con litotricia láser inmediata

> **Respuesta D.** La pielonefritis obstructiva es una emergencia urológica: además de antibióticos, requiere descompresión urgente con catéter doble J (pigtail) por vía cistoscópica o con nefrostomía percutánea. El tratamiento definitivo del cálculo se difiere hasta resolver la infección, porque la litotripsia o la ureteroscopía en este contexto aumentan el riesgo de sepsis.

704 uro-02 · Perfil V3 1.09.5.005 · Nefrostomia percutánea · *Práctica*

Mujer de 52 años con cáncer cervicouterino avanzado presenta oliguria y creatinina de 5,2 mg/dL. La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral por compresión tumoral de ambos uréteres distales, y la cistoscopía muestra infiltración tumoral del trígono que impide identificar los meatos ureterales.

¿Cuál es la conducta más adecuada para descomprimir la vía urinaria?

A) Sonda Foley

B) Nefrostomía percutánea

C) Catéter doble J por vía cistoscópica

D) Cistostomía suprapúbica

E) Hemodiálisis como único tratamiento

> **Respuesta B.** En la obstrucción ureteral bilateral, cuando no es posible pasar un catéter doble J por vía retrógrada porque los meatos están infiltrados por tumor, se realiza una nefrostomía percutánea guiada por imágenes, que drena directamente la pelvis renal. La sonda Foley y la cistostomía drenan solo la vejiga y no resuelven una obstrucción ureteral.

705 uro-03 · Perfil V3 1.09.5.007 · Tacto rectal para reconocimiento básico de crecimiento prostático · *Práctica*

Hombre de 68 años con nicturia y chorro débil. Se realiza tacto rectal para evaluar la próstata.

¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico de la hiperplasia prostática benigna?

A) Próstata aumentada de tamaño, de superficie lisa, consistencia elástica y surco medio borrado

B) Nódulo pétreo e irregular en un lóbulo

C) Próstata muy dolorosa, caliente y fluctuante

D) Próstata fija a planos profundos

E) Próstata de tamaño normal con induración difusa

> **Respuesta A.** En la hiperplasia prostática benigna el tacto muestra una próstata aumentada de volumen, simétrica y lisa, de consistencia elástica (similar a la eminencia tenar) y con surco medio borrado. Un nódulo pétreo, irregular o fijo sugiere cáncer y obliga a biopsia aun con APE normal. Una próstata muy dolorosa sugiere prostatitis aguda, en la que no se debe masajear.

706 uro-05 · Perfil V3 2.01.2.025 · Testículo agudo · *Práctica*

Un adolescente de 13 años presenta dolor testicular izquierdo súbito e intenso de 2 horas de evolución, que lo despertó, con náuseas y vómitos. Al examen el testículo izquierdo está elevado, horizontalizado y muy doloroso, con reflejo cremastérico ausente.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Exploración quirúrgica urgente

B) Antibióticos y analgesia, control en 24 horas

C) Ecografía Doppler diferida para el día siguiente

D) Elevación escrotal y antiinflamatorios

E) Urocultivo y esperar resultado

> **Respuesta A.** Dolor testicular súbito con testículo alto y horizontal y ausencia de reflejo cremastérico en un adolescente es torsión testicular, una emergencia: la viabilidad cae marcadamente después de 6 horas. Ante sospecha clínica alta se explora quirúrgicamente de urgencia (detorsión y orquidopexia bilateral), sin retrasar por imágenes; el Doppler solo se usa si hay duda y está disponible de inmediato.

707 uro-02 · Perfil V3 4.01.5.005 · Instalación y cuidado de sonda Foley · *Práctica*

Hombre de 70 años con retención urinaria aguda requiere la instalación de una sonda Foley. Se realiza técnica aséptica con lubricante con lidocaína.

¿En qué momento debe inflarse el balón de la sonda?

A) Apenas la punta de la sonda pasa el meato

B) Al sentir resistencia en la uretra prostática, sin esperar salida de orina

C) Antes de introducir la sonda, para comprobar el balón dentro de la uretra

D) Después de observar salida de orina y avanzar la sonda hasta su bifurcación

E) Solo si el paciente refiere dolor

> **Respuesta D.** El balón debe inflarse solo cuando se confirma que está en la vejiga: tras ver salir orina, se avanza la sonda hasta la bifurcación y luego se infla con agua destilada. Inflarlo en la uretra produce dolor, sangrado y lesión uretral (falsa vía). Ante resistencia que no cede o sangre en el meato, no se debe forzar.

708 uro-10 · Perfil V3 4.03.1.004 · Criptorquídea · *Práctica*

Lactante de 9 meses en control de salud. Desde el nacimiento no se palpa el testículo derecho en el escroto; se palpa en el canal inguinal y no logra descenderse al escroto con maniobras suaves. El testículo izquierdo está en posición normal. Pene y meato normales.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observar hasta los 5 años, porque puede descender espontáneamente

B) Orquiectomía derecha inmediata

C) Tratamiento con gonadotrofina coriónica como terapia de elección y control en la pubertad

D) Derivar a cirugía infantil para orquidopexia, idealmente antes de los 12 a 18 meses de vida

E) Tranquilizar porque es un testículo retráctil

> **Respuesta D.** El descenso espontáneo ocurre casi siempre en los primeros 6 meses. Un testículo no descendido después de esa edad se deriva para orquidopexia, idealmente entre los 6 y 18 meses, para preservar la fertilidad, facilitar el autoexamen y disminuir el riesgo de cáncer y torsión. El testículo retráctil, en cambio, sí desciende con la maniobra.

709 uro-06 · Perfil V3 4.03.1.006 · Enfermedades de transmisión sexual · *Práctica*

Hombre de 30 años consulta por una úlcera en el glande de 10 días, indolora, de bordes indurados y fondo limpio, de 1 cm, con adenopatías inguinales bilaterales firmes e indoloras. Tuvo relaciones sexuales sin preservativo hace 4 semanas. No es alérgico a medicamentos. VDRL reactivo 1:16.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular por una vez, más estudio de VIH y tratamiento de la pareja

B) Aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7 días

C) Ceftriaxona 500 mg intramuscular más doxiciclina

D) Azitromicina 1 g oral por una vez

E) Penicilina sódica endovenosa por 14 días

> **Respuesta A.** Úlcera genital única, indolora e indurada, con adenopatías inguinales indoloras, es un chancro de sífilis primaria. El tratamiento es penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular en dosis única, con notificación, estudio de VIH y otras ITS, y tratamiento de los contactos. La penicilina sódica endovenosa es para neurosífilis.

710 uro-07 · Perfil V3 4.03.1.011 · Hidrocele · *Práctica*

Hombre de 45 años consulta por aumento de volumen del hemiescroto izquierdo, indoloro, de crecimiento lento en 1 año. Al examen se palpa una masa quística, lisa, que no permite palpar bien el testículo, transilumina y no se reduce. Se puede palpar el cordón espermático por encima de la masa.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Punción evacuadora repetida como tratamiento definitivo

B) Ecografía testicular para confirmar el diagnóstico y descartar una causa secundaria, como tumor o infección, y luego cirugía electiva si es sintomático

C) Herniorrafia inguinal urgente

D) Orquiectomía inguinal radical

E) Antibióticos por 14 días

> **Respuesta B.** Una masa quística que transilumina, envuelve al testículo y permite palpar el cordón por encima es un hidrocele. En el adulto siempre se solicita ecografía, porque el testículo no se palpa bien y el hidrocele puede ser secundario a tumor o infección. Si molesta, se trata con hidrocelectomía; la punción tiene alta recidiva.

711 uro-01 · Perfil V3 4.03.1.026 · Uropatía alta · *Práctica*

Mujer de 48 años con dolor lumbar derecho tipo cólico de 2 días, ahora con fiebre de 39 °C, calofríos y PA 95/60 mmHg. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 8 mm en el uréter proximal derecho con hidronefrosis moderada. Creatinina 1,6 mg/dL. Se inician hemocultivos, volumen y antibióticos endovenosos.

¿Cuál es la conducta más importante a continuación?

A) Tamsulosina y esperar expulsión espontánea

B) Litotricia extracorpórea de urgencia

C) Derivación urgente de la vía urinaria (catéter doble J o nefrostomía percutánea)

D) Ureteroscopía con extracción del cálculo en el mismo acto

E) Completar 14 días de antibióticos y luego reevaluar

> **Respuesta C.** Una pielonefritis obstructiva (uropatía obstructiva alta infectada) es una urgencia urológica: además de antibióticos y soporte, requiere descomprimir la vía urinaria de inmediato con catéter doble J o nefrostomía. El tratamiento definitivo del cálculo (litotricia o ureteroscopía) se difiere hasta resolver la infección, porque manipularlo infectado agrava la sepsis.

712 uro-03 · Perfil V3 4.03.1.027 · Uropatía obstructiva baja · *Práctica*

Hombre de 76 años con síntomas urinarios bajos de años, sin tratamiento, consulta por goteo urinario continuo, día y noche, de 2 meses, y decaimiento. Al examen hay un globo vesical palpable indoloro. Creatinina 2,8 mg/dL (hace 1 año 1,0 mg/dL). La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral y vejiga distendida con 900 mL.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Descompresión vesical con sonda Foley, control de diuresis y electrolitos por riesgo de poliuria postobstructiva, y derivar a urología

B) Oxibutinina por incontinencia de urgencia

C) Nefrostomía percutánea bilateral urgente

D) Iniciar tamsulosina y control en 3 meses

E) Biopsia renal por insuficiencia renal de causa desconocida

> **Respuesta A.** El goteo continuo con globo vesical es incontinencia por rebalse, y la hidronefrosis bilateral con alza de creatinina indica uropatía obstructiva baja con daño renal. Se descomprime la vejiga con sonda, vigilando la poliuria postobstructiva y los electrolitos, y luego se trata la causa. La nefrostomía no es necesaria si la obstrucción es infravesical.

713 uro-15 · Perfil V3 4.03.2.002 · Hematuria masiva · *Práctica*

Hombre de 72 años, fumador, consulta por hematuria macroscópica con coágulos de 12 horas y ahora no puede orinar. Al examen tiene globo vesical doloroso. Está hemodinámicamente estable, Hb 11 g/dL.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Instalar sonda Foley de 2 vías de calibre fino

B) Instalar sonda vesical de 3 vías de grueso calibre, evacuar coágulos e iniciar irrigación vesical continua con suero fisiológico

C) Cistostomía suprapúbica por punción

D) Indicar ácido tranexámico y alta con control urológico

E) Cistoscopía diagnóstica ambulatoria en 1 mes

> **Respuesta B.** La hematuria masiva con retención por coágulos se maneja con sonda de 3 vías de grueso calibre (20 a 24 Fr), lavado manual para evacuar coágulos e irrigación continua, además de soporte y corrección de coagulopatía. Una sonda fina se obstruye con coágulos. Luego se estudia la causa (en fumador mayor, descartar cáncer vesical con cistoscopía y uroTAC).

714 uro-02 · Perfil V3 4.03.2.003 · Parafimosis · *Práctica*

Hombre de 70 años hospitalizado con sonda Foley. Al día siguiente de instalada, la enfermera nota el glande edematoso y violáceo con un anillo prepucial retraído y tenso detrás del glande, muy doloroso.

¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?

A) Balanitis; antifúngico tópico

B) Parafimosis; circuncisión inmediata en todos los casos

C) Fimosis; corticoide tópico

D) Parafimosis; reducción manual del prepucio previa compresión del edema y analgesia

E) Gangrena de Fournier; aseo quirúrgico

> **Respuesta D.** La parafimosis es el prepucio retraído que no vuelve a su posición y forma un anillo constrictor, típicamente iatrogénica tras sonda o examen sin reponer el prepucio. Es una urgencia: se reduce manualmente tras analgesia y compresión del edema; si fracasa, incisión dorsal del anillo. La circuncisión se plantea en forma diferida.

715 uro-08 · Perfil V3 4.03.3.001 · Epidemiología del cáncer de próstata · *Práctica*

En una charla de salud del hombre en un CESFAM, se discuten datos epidemiológicos del cáncer de próstata en Chile.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Es una neoplasia poco frecuente, principalmente de hombres jóvenes

B) Su incidencia es mayor en hombres asiáticos que en afrodescendientes

C) El tabaquismo es su principal factor de riesgo

D) La vasectomía es un factor de riesgo demostrado

E) Es una de las primeras causas de muerte por cáncer en hombres en Chile, y su incidencia aumenta con la edad; la historia familiar y la ascendencia africana son factores de riesgo

> **Respuesta E.** El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres en Chile y una de sus principales causas de muerte oncológica. Sus factores de riesgo establecidos son la edad (raro antes de 50 años), la historia familiar de primer grado (y BRCA2) y la ascendencia africana. No se ha demostrado relación causal con vasectomía ni tabaco.

716 uro-03 · Perfil V3 4.03.3.002 · Epidemiología del adenoma de próstata · *Práctica*

En una charla para la comunidad, un médico de un CESFAM explica los aspectos epidemiológicos de la hiperplasia prostática benigna a un grupo de hombres adultos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Es una lesión premaligna que evoluciona a cáncer de próstata en la mayoría de los casos

B) Es más frecuente en hombres castrados antes de la pubertad

C) Se origina principalmente en la zona periférica de la próstata

D) Su prevalencia histológica aumenta con la edad, alcanzando alrededor de 50% a los 60 años y cerca de 80 a 90% a los 80 años, y requiere andrógenos testiculares para desarrollarse

E) El tamaño de la próstata se correlaciona estrechamente con la intensidad de los síntomas

> **Respuesta D.** La hiperplasia prostática benigna es muy frecuente y dependiente de la edad y de la dihidrotestosterona: no ocurre en castrados prepuberales. Nace en la zona de transición, no es premaligna, y el tamaño glandular se correlaciona mal con los síntomas. El cáncer, en cambio, nace en la zona periférica.

717 uro-10 · Perfil V3 4.03.3.003 · Epidemiologia del cáncer testicular · *Práctica*

En una clase de urología, el docente revisa la epidemiología del cáncer testicular para orientar la sospecha clínica en la atención primaria.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Más del 90% corresponde a tumores de estroma gonadal, como el de células de Leydig

B) Su incidencia máxima ocurre sobre los 70 años

C) Es el tumor sólido más frecuente en hombres de 15 a 35 años, y la criptorquidia es su principal factor de riesgo

D) La orquidopexia precoz elimina por completo el riesgo de cáncer en el testículo descendido

E) Tiene baja tasa de curación incluso en etapas precoces

> **Respuesta C.** El cáncer testicular es el tumor sólido más frecuente en hombres jóvenes, de 15 a 35 años. Alrededor del 95% son tumores de células germinales. El principal factor de riesgo es la criptorquidia; la orquidopexia reduce pero no elimina el riesgo. Tiene tasas de curación sobre 90% incluso con enfermedad avanzada, y en Chile tiene garantía GES.

718 uro-01 · Perfil V3 4.03.4.001 · Radiografía renal y vesical simple · *Práctica*

Hombre de 40 años con cólico renal derecho. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 6 mm en el uréter distal derecho, de densidad alta. Se decide manejo médico expulsivo y seguimiento.

¿Cuál es el examen más adecuado para el seguimiento de la expulsión de este cálculo?

A) Radiografía simple renal, ureteral y vesical (de abdomen), ya que la mayoría de los cálculos son radiopacos

B) Pielografía de eliminación semanal

C) Resonancia magnética de abdomen

D) Cintigrama renal

E) Cistoscopía

> **Respuesta A.** Cerca del 90% de los cálculos urinarios (oxalato y fosfato de calcio) son radiopacos, por lo que la radiografía simple de abdomen (riñón, uréter y vejiga) sirve para el seguimiento de un cálculo visible, con menor radiación que repetir TAC. Los de ácido úrico son radiolúcidos y no se ven en la radiografía.

719 uro-01 · Perfil V3 4.03.4.002 · Pielografía de eliminación · *Práctica*

Se evalúa a un paciente para un estudio de la vía urinaria con medio de contraste yodado endovenoso (pielografía de eliminación o uroTAC).

¿Cuál de las siguientes condiciones es la principal limitación o contraindicación relativa para este estudio?

A) Hipertensión arterial controlada

B) Infección urinaria baja tratada

C) Litiasis renal

D) Hematuria macroscópica

E) Insuficiencia renal con VFG menor de 30 mL/min o antecedente de reacción alérgica grave al medio de contraste

> **Respuesta E.** La pielografía de eliminación (urografía excretora) depende de la excreción renal de contraste yodado, por lo que en insuficiencia renal la imagen es pobre y hay riesgo de nefropatía por contraste; la alergia grave al contraste también la contraindica. Hoy ha sido reemplazada en gran medida por el uroTAC, que comparte estas limitaciones.

720 uro-03 · Perfil V3 4.03.4.007 · Ecotomografía de vejiga y próstata · *Práctica*

Hombre de 68 años con síntomas urinarios bajos obstructivos moderados (IPSS 18), tacto rectal con próstata aumentada de tamaño, lisa, elástica y sin nódulos. Creatinina normal.

¿Qué información principal aporta la ecotomografía vesical y prostática en este paciente?

A) Diagnóstico histológico de cáncer de próstata

B) Volumen prostático, residuo postmiccional y repercusión vesical (engrosamiento de pared, divertículos, cálculos)

C) Medición del flujo urinario máximo

D) Presión del detrusor durante la micción

E) Etapificación ganglionar

> **Respuesta B.** En la HPB, la ecografía vesicoprostática (suprapúbica) mide el volumen prostático, el residuo postmiccional y muestra repercusión vesical (vejiga de lucha, divertículos, litiasis); la ecografía renal descarta hidronefrosis. No diagnostica cáncer (requiere APE y biopsia) ni mide flujo (uroflujometría) ni presiones (urodinamia).

721 uro-05 · Perfil V3 4.03.4.008 · Ecotomografía testicular · *Práctica*

Escolar de 11 años consulta por dolor testicular derecho de 20 horas, de inicio gradual, moderado, sin vómitos. Afebril. El testículo derecho está en posición normal, levemente sensible en su polo superior, con reflejo cremastérico presente. El cuadro es dudoso, por lo que se solicita ecografía Doppler testicular inmediata.

Si la ecografía Doppler muestra flujo arterial intratesticular conservado y simétrico, con una imagen nodular avascular en el polo superior, ¿cuál es la interpretación y conducta más adecuada?

A) Torsión testicular; exploración quirúrgica inmediata

B) Hidrocele a tensión; punción evacuadora

C) Tumor testicular; orquiectomía inguinal

D) Orquiepididimitis bacteriana; ceftriaxona más doxiciclina

E) Torsión de hidátide (apéndice testicular); reposo, AINE, frío local y control

> **Respuesta E.** La ecografía Doppler testicular es útil cuando el escroto agudo es dudoso: flujo intratesticular conservado descarta razonablemente la torsión, y un nódulo avascular en el polo superior es típico de la torsión de hidátide, que se trata en forma conservadora. Si la clínica es clara de torsión, no se debe retrasar la cirugía por la ecografía.

722 uro-10 · Perfil V3 4.03.4.008 · Ecotomografía testicular · *Práctica*

Hombre de 28 años nota hace 3 semanas un nódulo en el testículo izquierdo, levemente molesto. Al examen se palpa un nódulo duro de 1,5 cm que parece depender del testículo, no transilumina, sin signos inflamatorios. Afebril y sin síntomas urinarios.

¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

A) Biopsia testicular por punción transescrotal

B) Ecografía testicular con Doppler

C) TAC de tórax, abdomen y pelvis

D) Tratamiento antibiótico por 2 semanas y luego reevaluar

E) Resonancia magnética de pelvis

> **Respuesta B.** Ante toda masa escrotal, el examen inicial es la ecografía testicular: distingue lesión intratesticular sólida, sospechosa de cáncer, de lesiones extratesticulares benignas como quistes del epidídimo o hidrocele, con sensibilidad cercana a 100%. La punción transescrotal está contraindicada por riesgo de diseminación.

723 uro-15 · Perfil V3 4.03.4.011 · Examen de orina completo, urocultivo · *Práctica*

Mujer de 28 años, no embarazada, consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 2 días, sin fiebre ni dolor lumbar. Se toma orina de segundo chorro con aseo genital previo. Orina completa: nitritos positivos, leucocitos 25 a 30 por campo, bacterias abundantes. El urocultivo informa Escherichia coli 10.000 UFC/mL sensible a nitrofurantoína.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Urocultivo negativo porque no alcanza 100.000 UFC/mL; no corresponde tratar

B) Contaminación de la muestra; repetir con punción suprapúbica

C) Infección urinaria baja; en una mujer sintomática con piuria, un recuento desde 1.000 a 10.000 UFC/mL de un uropatógeno es significativo y se trata, por ejemplo con nitrofurantoína

D) Bacteriuria asintomática; no requiere tratamiento

E) Pielonefritis aguda; hospitalizar para antibióticos endovenosos

> **Respuesta C.** El punto de corte de 100.000 UFC/mL se diseñó para bacteriuria asintomática. En una mujer con síntomas de cistitis y piuria, recuentos menores (desde 1.000 a 10.000 UFC/mL) de un uropatógeno como E. coli son significativos. Los nitritos positivos y la piuria apoyan el diagnóstico de cistitis, que se trata ambulatoriamente.

724 uro-04 · Perfil V3 4.03.4.012 · Urodinamia · *Práctica*

Mujer de 55 años con incontinencia urinaria mixta (esfuerzo y urgencia) que no mejoró con ejercicios de piso pélvico ni con antimuscarínicos. Se plantea cirugía antiincontinencia.

¿Cuál es la principal utilidad del estudio urodinámico en esta paciente?

A) Confirmar infección urinaria

B) Objetivar el tipo de incontinencia (hiperactividad del detrusor vs incompetencia esfinteriana) y la función de vaciamiento antes de la cirugía

C) Medir el volumen de la vejiga en reposo por ecografía

D) Diagnosticar cáncer vesical

E) Reemplazar el examen físico ginecológico

> **Respuesta B.** La urodinamia (cistometría, estudio de flujo-presión) mide presiones vesicales y abdominales durante llenado y vaciamiento. No es necesaria en la incontinencia de esfuerzo pura no complicada, pero sí en la incontinencia mixta, refractaria o antes de cirugía, para documentar hiperactividad del detrusor o incompetencia esfinteriana y evitar cirugías que empeoren la urgencia o produzcan retención.

725 uro-03 · Perfil V3 4.03.4.013 · Uroflujometría · *Práctica*

Hombre de 65 años con chorro débil y sensación de vaciamiento incompleto. Se realiza uroflujometría con volumen miccional de 250 mL.

¿Qué resultado sugiere obstrucción del tracto urinario inferior?

A) Flujo máximo (Qmáx) mayor de 15 mL/s con curva en campana

B) Volumen miccional de 250 mL

C) Flujo máximo menor de 10 mL/s con curva aplanada y prolongada

D) Residuo postmiccional de 10 mL

E) Tiempo miccional de 15 segundos

> **Respuesta C.** La uroflujometría mide el flujo urinario; es válida con volumen miccional mayor de 150 mL. Un Qmáx menor de 10 mL/s con curva aplanada y prolongada sugiere obstrucción (HPB, estenosis uretral) o hipocontractilidad del detrusor; mayor de 15 mL/s es normal. Para diferenciarlas se requiere estudio de flujo-presión.

726 uro-02 · Perfil V3 4.03.5.003 · Cistostomía abierta · *Práctica*

Hombre de 30 años, tras caída a horcajadas sobre una viga, presenta sangre en el meato uretral, hematoma perineal en alas de mariposa y no puede orinar. Tiene globo vesical palpable. Está estable.

¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?

A) Instalar sonda Foley por vía uretral con fuerza

B) Sondeo con sonda metálica

C) Esperar micción espontánea

D) Cistostomía suprapúbica (por punción o abierta) y luego estudio con uretrografía retrógrada

E) Uretroplastía inmediata

> **Respuesta D.** Uretrorragia, hematoma perineal y retención tras trauma a horcajadas indican lesión de uretra bulbar. Está contraindicado el sondeo uretral a ciegas porque puede completar la rotura. La vejiga se drena con cistostomía suprapúbica (percutánea o abierta si la vejiga no es puncionable con seguridad), y se estudia con uretrografía retrógrada; la reparación es diferida.

727 uro-02 · Perfil V3 4.03.5.004 · Cistostomía por punción · *Práctica*

Hombre de 25 años sufre una caída a horcajadas sobre una viga. Consulta por imposibilidad de orinar de 6 horas. Al examen hay sangre en el meato uretral, hematoma perineal en alas de mariposa y globo vesical palpable a 3 cm bajo el ombligo. Hemodinámicamente estable.

¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?

A) Sonda Foley transuretral con lubricación abundante

B) Punción vesical con aguja y aspiración repetida cada 6 horas

C) Sondeo con sonda metálica para vencer la estrechez

D) Furosemida endovenosa y esperar micción espontánea

E) Cistostomía suprapúbica por punción, idealmente guiada por ecografía, y estudio posterior con uretrografía retrógrada

> **Respuesta E.** Sangre en el meato y hematoma perineal tras caída a horcajadas sugieren lesión de uretra bulbar: está contraindicado el sondeo transuretral. Con globo vesical palpable, la vejiga se drena mediante cistostomía suprapúbica por punción, y la uretra se estudia con uretrografía retrógrada.

728 uro-02 · Perfil V3 4.03.5.005 · Instalación y cuidado de sonda Foley · *Práctica*

Hombre de 70 años hospitalizado por neumonía requiere sonda Foley para medir diuresis horaria. Al instalarla, después de introducir unos 10 cm, aún no sale orina.

Respecto de la técnica y cuidados de la sonda Foley, ¿cuál afirmación es correcta?

A) Inflar el balón en cuanto se sienta resistencia, para fijarla

B) Mantener la bolsa sobre el nivel de la vejiga para facilitar el drenaje

C) Cambiar la bolsa abriendo el sistema cada 8 horas para evitar infecciones

D) Introducir la sonda hasta la bifurcación y verificar la salida de orina antes de inflar el balón con agua destilada, con técnica aséptica y sistema de drenaje cerrado

E) Indicar profilaxis antibiótica permanente mientras dure la sonda

> **Respuesta D.** En el hombre se lubrica con lidocaína en gel, se introduce la sonda hasta la bifurcación y solo después de ver orina se infla el balón, para no inflarlo en la uretra. Se usa técnica aséptica, sistema cerrado, bolsa bajo el nivel vesical y se retira apenas no se necesite. La profilaxis antibiótica no está indicada.

729 uro-02 · Perfil V3 4.03.5.006 · Reducción de parafimosis · *Práctica*

Niño de 10 años con parafimosis de 3 horas tras retraer el prepucio al bañarse. Glande edematoso, rosado, con anillo constrictor retraído. Se decide reducción manual en urgencia.

¿Cuál es la técnica adecuada?

A) Tirar del prepucio hacia adelante sin preparar el glande

B) Analgesia, compresión manual sostenida del glande para reducir el edema, y luego empujar el glande con los pulgares mientras los índices y medios traccionan el prepucio hacia distal

C) Incisión dorsal del prepucio como primera medida

D) Aplicar calor local y esperar reducción espontánea

E) Indicar corticoide tópico y control en 1 semana

> **Respuesta B.** La reducción manual de la parafimosis requiere analgesia (bloqueo peneano o anestesia tópica), compresión sostenida del glande para disminuir el edema y luego presión del glande con los pulgares mientras los dedos índice y medio llevan el anillo prepucial sobre él. Si falla, se realiza incisión dorsal. El calor aumenta el edema.

Banco · sin clase · Cardiología

730 sin clase · Perfil V3 1.01.1.007 · Endocarditis infecciosa y no infecciosa · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 63*

Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general y fiebre hasta 39 °C. Al examen físico tiene un soplo pansistólico III/VI en el precordio izquierdo, además de petequias en los pulpejos y algunas petequias subconjuntivales.

¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?

A) Ecocardiograma

B) Hemocultivos

C) Hemograma

D) Coronariografía

E) ANA y complemento

> **Respuesta B.** Fiebre, soplo y fenómenos embólicos sugieren endocarditis infecciosa. El diagnóstico etiológico, es decir el germen, lo dan los hemocultivos seriados (3 sets antes de antibióticos). El ecocardiograma muestra vegetaciones y es criterio mayor, pero no identifica el agente.

731 sin clase · Perfil V3 1.01.1.011 · Extrasistolía ventricular benigna · *Práctica*

Un hombre de 35 años, sin antecedentes, consulta por sensación de 'saltos' en el pecho en reposo, que desaparecen al hacer ejercicio. Examen físico normal. El ECG muestra extrasístoles ventriculares aisladas, monomorfas, sin otras alteraciones. El ecocardiograma es normal y el Holter muestra 2% de extrasístoles ventriculares aisladas, sin taquicardia ventricular.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tranquilizar, reducir cafeína y alcohol, y control clínico

B) Amiodarona oral

C) Derivar para ablación urgente

D) Implantar un desfibrilador

E) Iniciar flecainida

> **Respuesta A.** Extrasístoles ventriculares aisladas y monomorfas que desaparecen con el ejercicio, con corazón estructuralmente normal y baja carga en el Holter, son benignas: basta educar y suprimir gatillantes. Si son muy molestas, se usa un betabloqueador. Amiodarona o flecainida no están indicadas y son proarrítmicas.

732 sin clase · Perfil V3 1.01.3.002 · Cardiopatía y embarazo · *Práctica*

Una mujer de 28 años, con una cardiopatía conocida, consulta en control preconcepcional porque desea embarazarse.

¿En cuál de las siguientes condiciones se debe desaconsejar el embarazo por su alta mortalidad materna?

A) Comunicación interauricular reparada

B) Prolapso de válvula mitral sin insuficiencia significativa

C) Hipertensión arterial pulmonar severa (síndrome de Eisenmenger)

D) Extrasistolía ventricular benigna

E) Insuficiencia mitral leve

> **Respuesta C.** La hipertensión arterial pulmonar severa, incluido el síndrome de Eisenmenger, tiene mortalidad materna muy alta (clase IV de la OMS modificada) y contraindica el embarazo. Las lesiones reparadas, el prolapso mitral sin insuficiencia y las insuficiencias valvulares leves se toleran bien, porque el embarazo disminuye la resistencia vascular sistémica.

733 sin clase · Perfil V3 1.01.4.011 · Holter de presión arterial · *Práctica*

Una mujer de 55 años tiene presiones en la consulta de 152/94 y 148/92 mmHg en dos controles, pero refiere que en la farmacia y en su casa sus mediciones son de 120/78 mmHg. No tiene daño de órgano blanco.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Ecocardiograma

B) Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas (MAPA)

C) Holter de ritmo

D) Prueba de esfuerzo

E) Fondo de ojo

> **Respuesta B.** Ante sospecha de hipertensión de bata blanca (PA alta en consulta y normal fuera de ella), el MAPA de 24 horas es el estándar para confirmar o descartar hipertensión: un promedio de 24 horas bajo 130/80 mmHg la descarta. También detecta hipertensión enmascarada y ausencia de descenso nocturno.

734 sin clase · Perfil V3 1.01.4.014 · Holter de ritmo · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 7*

Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y acenocumarol, consulta porque presenta repetidos episodios de malestar, sudoración y ortostatismo, que duran algunos segundos y revierten espontáneamente. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca de 60 por minuto, irregular, y presión arterial 110/70 mmHg. Su examen cardiopulmonar es normal.

¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Test de esfuerzo

B) Ecocardiograma

C) Ecografía doppler de extremidades inferiores

D) Tilt test

E) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

> **Respuesta E.** Episodios presincopales breves y recurrentes en una paciente con fibrilación auricular y dos frenadores del nodo (atenolol más verapamilo, combinación riesgosa) sugieren bradiarritmia: pausas o síndrome taquicardia-bradicardia. El Holter de 24 horas correlaciona síntomas con el ritmo. El tilt test estudia el síncope vasovagal.

735 sin clase · Perfil V3 1.01.5.008 · Punción venosa · *Práctica*

Una mujer de 62 años, con antecedente de mastectomía izquierda con disección axilar por cáncer de mama, requiere toma de exámenes de sangre.

¿Cuál es la indicación más adecuada para la punción venosa?

A) Puncionar el brazo izquierdo, porque tiene venas más visibles

B) Mantener el torniquete apretado más de 3 minutos para facilitar la punción

C) Puncionar el brazo derecho, evitando el brazo con disección axilar

D) Retirar la aguja antes de soltar el torniquete

E) Puncionar siempre la vena femoral

> **Respuesta C.** Se evita puncionar la extremidad con disección axilar (riesgo de linfedema e infección), con fístula arteriovenosa o con una vía venosa en curso. El torniquete debe mantenerse menos de 1 minuto para no alterar resultados (hemoconcentración, potasio) y soltarse antes de retirar la aguja, para evitar hematomas.

Banco · sin clase · Diabetes y nutrición

736 sin clase · Perfil V3 1.02.1.018 · Trastornos de conducta alimentaria · *Práctica*

Una adolescente de 17 años es traída por su madre, que encontró envoltorios de comida escondidos. Refiere episodios de ingesta de grandes cantidades de comida con sensación de pérdida de control, 3 veces por semana desde hace 4 meses, seguidos de vómitos autoinducidos. Su IMC es 22 kg/m². Al examen tiene hipertrofia parotídea y callosidades en el dorso de la mano.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Anorexia nerviosa restrictiva

B) Trastorno de rumiación

C) Trastorno por atracón

D) Bulimia nerviosa

E) Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos

> **Respuesta D.** Atracones con pérdida de control y conductas compensatorias (vómitos) al menos una vez por semana durante 3 meses, con peso normal, definen bulimia nerviosa; la hipertrofia parotídea y el signo de Russell son típicos. En el trastorno por atracón no hay conductas compensatorias y en la anorexia el peso es bajo. Se debe controlar el potasio.

737 sin clase · Perfil V3 1.02.3.002 · Anorexia nerviosa · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 4*

Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nerviosa desde hace 5 años, actualmente pesa 29 kg y mide 1,68 m, con IMC de 10,3 kg/m².

¿Con cuántas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?

A) 300

B) 600

C) 1200

D) 1500

E) 2400

> **Respuesta A.** Con desnutrición extrema (IMC bajo 12) el riesgo de síndrome de realimentación es muy alto: hipofosfemia, hipokalemia, hipomagnesemia, insuficiencia cardíaca y arritmias. Se inicia con un aporte bajo, alrededor de 10 kcal/kg/día (unas 300 kcal en 29 kg), con tiamina y control de electrolitos, y se aumenta progresivamente.

738 sin clase · Perfil V3 1.02.4.012 · Evaluación nutricional · *Práctica*

Un hombre de 45 años mide 1,75 m y pesa 75 kg (IMC 24,5 kg/m²), pero su circunferencia de cintura es de 104 cm. Tiene una glicemia de ayuno alterada.

¿Cuál es la interpretación más adecuada de su evaluación nutricional?

A) Estado nutricional normal, sin riesgo adicional

B) Desnutrición leve

C) IMC normal con obesidad abdominal, que implica mayor riesgo cardiometabólico

D) Obesidad grado II

E) La cintura no tiene valor si el IMC es normal

> **Respuesta C.** El IMC no distingue grasa de músculo ni su distribución. Una cintura sobre 102 cm en hombres (o sobre 90 cm con criterios para población latinoamericana) indica obesidad abdominal, con mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular aun con IMC normal. La evaluación nutricional del adulto incluye peso, talla, IMC y cintura.

739 sin clase · Perfil V3 1.02.4.020 · Nitrogeno urinario · *Práctica*

Un paciente de 40 años, en UCI por politraumatismo, recibe nutrición enteral con 75 g de proteínas al día (12 g de nitrógeno). Para evaluar si el aporte proteico es suficiente, se mide el nitrógeno ureico urinario de 24 horas: 18 g/día.

¿Cuál es la interpretación del balance nitrogenado?

A) Balance positivo: está en anabolismo

B) Balance neutro

C) Balance negativo de unos 10 g/día: hipercatabolismo con aporte proteico insuficiente

D) El nitrógeno urinario no sirve para evaluar el estado nutricional

E) Indica insuficiencia renal aguda

> **Respuesta C.** Balance nitrogenado = nitrógeno aportado (proteínas / 6,25) – (nitrógeno ureico urinario + 4 g de pérdidas no urinarias). Aquí: 12 – (18 + 4) = –10 g/día. Un balance negativo indica catabolismo proteico mayor que el aporte, típico del trauma y la sepsis, y obliga a aumentar el aporte proteico.

740 sin clase · Perfil V3 1.02.4.023 · Test de esfuerzo · *Práctica*

Un hombre de 58 años, diabético e hipertenso, refiere desde hace 2 meses opresión retroesternal al subir 2 pisos de escalera, que cede en 3 minutos con el reposo. Su ECG de reposo es normal y puede caminar sin limitaciones ortopédicas.

¿Cuál es el examen inicial más adecuado para el estudio de isquemia?

A) Coronariografía de urgencia

B) Test de esfuerzo (ergometría)

C) Holter de ritmo

D) Troponinas seriadas en urgencia

E) Ecocardiograma transesofágico

> **Respuesta B.** Es una angina estable: de esfuerzo, cede con el reposo y su patrón no ha cambiado en 2 meses. Si el paciente puede ejercitarse y su ECG basal es interpretable, el test de esfuerzo es el examen inicial no invasivo para detectar isquemia y estratificar riesgo. Si no, se usan pruebas con imagen.

Banco · sin clase · Endocrinología

741 sin clase · Perfil V3 1.03.1.023 · Ginecomastia · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 45*

Adolescente masculino de 14 años con aumento bilateral del tejido mamario subareolar, sensible al tacto, sin secreción. No usa medicamentos. Su desarrollo puberal es Tanner 3.

¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuados?

A) Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar

B) Cáncer de mama masculino; biopsia urgente

C) Hiperprolactinemia; solicitar prolactina

D) Hipogonadismo; solicitar testosterona

E) Tumor testicular; solicitar ecografía testicular

> **Respuesta A.** La ginecomastia puberal aparece en la mitad o más de los varones en Tanner 2 a 4; es bilateral, subareolar, a veces sensible, y regresa sola en 1 a 2 años. Se examinan los testículos y se revisan fármacos o drogas; si todo es normal, basta tranquilizar y controlar. El cáncer de mama es excepcional a esta edad.

Banco · sin clase · Enfermedades infecciosas

742 sin clase · Perfil V3 1.04.1.016 · Influenza · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 141*

En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta temperatura de 39 °C, con examen pulmonar normal.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Oseltamivir

B) Zanamivir

C) Aciclovir

D) Valaciclovir

E) Paracetamol

> **Respuesta E.** En un adulto joven sin factores de riesgo ni signos de gravedad, la guía MINSAL indica tratamiento sintomático (paracetamol, reposo e hidratación). El oseltamivir se reserva para grupos de riesgo (embarazadas, adultos mayores, comorbilidades, inmunosupresión) o influenza grave. Aciclovir y valaciclovir actúan sobre herpesvirus, no sobre influenza.

743 sin clase · Perfil V3 1.04.1.029 · Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19 · *Práctica*

Un hombre de 30 años, sin comorbilidades y con esquema de vacunación completo, presenta fiebre, odinofagia, tos seca y mialgias de 2 días. El test de antígeno para SARS-CoV-2 es positivo. Saturación 98%, FR 16 por minuto, examen pulmonar normal.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hospitalizar e iniciar dexametasona

B) Manejo ambulatorio sintomático, aislamiento y educación sobre signos de alarma

C) Azitromicina por 5 días

D) Ivermectina

E) TAC de tórax y anticoagulación

> **Respuesta B.** COVID-19 leve en un paciente sin factores de riesgo ni hipoxemia se maneja en domicilio con antipiréticos, hidratación, aislamiento y educación sobre signos de alarma (disnea, saturación bajo 94%, compromiso de conciencia). La dexametasona solo beneficia a quienes requieren oxígeno y puede dañar sin hipoxemia. Antibióticos e ivermectina no están indicados.

744 sin clase · Perfil V3 1.04.2.003 · Endocarditis bateriana · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 123*

Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T° 38,2 °C, PA 120/80 mmHg y FC 94 por minuto; se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas petequias en las extremidades inferiores, y en el examen cardíaco se ausculta un soplo diastólico de intensidad IV/VI. En los exámenes destaca PCR 12 mg/L, VHS 70 mm/h y leucocitosis de 16.000/mm³. Se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas grampositivas en cadena.

¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?

A) Penicilina sódica

B) Cloxacilina

C) Clindamicina

D) Ceftazidima

E) Gentamicina

> **Respuesta A.** Endocarditis subaguda en una prótesis valvular tardía con cocáceas grampositivas en cadena (estreptococos del grupo viridans) se trata con penicilina sódica (o ceftriaxona) endovenosa por 6 semanas, a la que puede asociarse gentamicina. La cloxacilina es para estafilococos (cocos en racimos) y la gentamicina sola no es tratamiento.

745 sin clase · Perfil V3 1.04.3.007 · Profilaxis de endocarditis infecciosa · *Práctica*

Un hombre de 60 años, portador de una prótesis valvular aórtica mecánica, debe someterse a una extracción dental. No tiene alergias.

¿Cuál es la profilaxis de endocarditis infecciosa más adecuada?

A) No requiere profilaxis

B) Ciprofloxacino oral

C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 7 días después del procedimiento

D) Amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes del procedimiento

E) Vancomicina endovenosa por 5 días

> **Respuesta D.** La profilaxis está indicada en pacientes de alto riesgo (prótesis valvular, endocarditis previa, ciertas cardiopatías congénitas) sometidos a procedimientos dentales con manipulación gingival o periapical. Se usa una dosis única de amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes; en alérgicos, un macrólido. No se recomiendan cursos prolongados posteriores.

746 sin clase · Perfil V3 1.04.4.001 · Antigenemia · *Práctica*

Un hombre de 50 años, con trasplante renal hace 2 meses y en tratamiento inmunosupresor, presenta fiebre, leucopenia, alza de transaminasas y deterioro de la función renal.

¿Cuál es el examen más útil para confirmar precozmente la sospecha diagnóstica?

A) Serología IgG para citomegalovirus

B) Hemocultivos aeróbicos

C) Antigenemia pp65 o carga viral (PCR) de citomegalovirus en sangre

D) Gota gruesa

E) Test de tinta china

> **Respuesta C.** El citomegalovirus es la infección oportunista más frecuente entre el primer y sexto mes post trasplante: fiebre, leucopenia, hepatitis y disfunción del injerto. Se diagnostica con antigenemia pp65 (antígeno viral en leucocitos) o PCR cuantitativa en sangre, que también guían la terapia con ganciclovir. La IgG solo indica infección pasada.

Banco · sin clase · Enfermedades respiratorias

747 sin clase · Perfil V3 1.05.2.001 · Asfixia por inmersión · *Práctica*

Un niño de 6 años es rescatado de una piscina tras estar sumergido unos 3 minutos. No responde, no respira y no se palpa pulso. Hay 2 rescatadores capacitados.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Iniciar RCP comenzando con ventilaciones de rescate y continuar con compresiones, en relación 15:2

B) Realizar la maniobra de Heimlich para expulsar el agua

C) Colocar al niño boca abajo para drenar el agua

D) Esperar la llegada de la ambulancia sin intervenir

E) Realizar solo compresiones, sin ventilaciones

> **Respuesta A.** En el ahogamiento el paro es por hipoxia, por lo que la ventilación es prioritaria: se inicia la RCP con ventilaciones de rescate y luego compresiones; con 2 rescatadores en niños la relación es 15:2. No se intenta drenar agua (Heimlich, posiciones), porque retrasa la RCP y aumenta el riesgo de aspiración.

748 sin clase · Perfil V3 1.05.2.012 · Paro cardiorespiratorio · *Práctica*

Un hombre de 58 años colapsa en la sala de espera. No responde y no respira normalmente. Se activa el código de paro y se inicia RCP. Al conectar el monitor desfibrilador se observa fibrilación ventricular.

¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Administrar adrenalina 1 mg antes de cualquier descarga

B) Verificar el pulso durante 1 minuto

C) Intubar antes de desfibrilar

D) Administrar amiodarona y esperar su efecto

E) Desfibrilar de inmediato y reanudar las compresiones por 2 minutos sin verificar pulso

> **Respuesta E.** La fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable: se desfibrila lo antes posible y se reanudan de inmediato las compresiones de alta calidad por 2 minutos antes de reevaluar el ritmo. La adrenalina se administra después de la segunda descarga y la amiodarona después de la tercera. Intubar o buscar pulso por mucho tiempo retrasa la descarga y reduce la sobrevida.

749 sin clase · Perfil V3 1.05.3.001 · Contaminación ambiental · *Práctica*

Durante el invierno se decreta preemergencia ambiental en Santiago por niveles elevados de material particulado fino (MP2,5). La madre de un niño asmático de 8 años consulta qué medidas tomar.

¿Cuál es la recomendación más adecuada?

A) Evitar la actividad física intensa al aire libre, no usar leña ni braseros en el hogar y mantener el tratamiento controlador

B) Realizar ejercicio intenso al aire libre para fortalecer los pulmones

C) Suspender los inhaladores para evitar dependencia

D) Ventilar la casa con las ventanas abiertas todo el día

E) Calefaccionar con brasero

> **Respuesta A.** El material particulado fino (MP2,5), de la combustión de leña, vehículos e industria, llega hasta los alvéolos y aumenta las exacerbaciones de asma y EPOC, las consultas respiratorias y los eventos cardiovasculares. En episodios críticos se evita el ejercicio intenso al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y enfermos crónicos, no se usa leña y se mantiene el tratamiento.

750 sin clase · Perfil V3 1.05.5.001 · Aspiración traqueal · *Práctica*

Un paciente de 70 años, intubado en UCI, presenta secreciones abundantes, roncus y caída de la saturación a 89%. Se decide aspirar las secreciones por el tubo endotraqueal.

¿Cuál es la técnica más adecuada?

A) Aspirar en forma continua durante 1 minuto mientras se introduce la sonda

B) Preoxigenar, usar técnica estéril y aspirar en forma intermitente al retirar la sonda, por no más de 10 a 15 segundos

C) Instilar suero fisiológico de rutina antes de cada aspiración

D) Aspirar cada 1 hora aunque no haya secreciones

E) Usar la misma sonda para aspirar primero la boca y luego la tráquea

> **Respuesta B.** La aspiración traqueal se realiza solo cuando es necesaria, con técnica estéril, preoxigenación y sonda de calibre adecuado, aplicando aspiración solo al retirar y por no más de 10 a 15 segundos, para evitar hipoxemia, bradicardia y trauma de mucosa. No se recomienda instilar suero de rutina, y la tráquea se aspira antes que la boca.

751 sin clase · Perfil V3 1.05.5.010 · Resucitación cardiorespiratoria · *Práctica*

Hombre de 58 años colapsa en la sala de espera. No responde, no respira normalmente y no se palpa pulso carotídeo. Se activa el sistema de emergencia y se pide el desfibrilador.

Mientras llega el desfibrilador, ¿cuál es la técnica correcta de compresiones torácicas?

A) 60-80 compresiones por minuto, profundidad de 2-3 cm, relación 15:2

B) Más de 140 compresiones por minuto, profundidad de 7 cm, relación 30:2

C) 100-120 compresiones por minuto, profundidad de 3-4 cm, relación 15:1

D) 100-120 compresiones por minuto, profundidad de 5-6 cm, relación 30:2

E) Ventilar durante 2 minutos antes de iniciar compresiones

> **Respuesta D.** La RCP de alta calidad en el adulto consiste en compresiones a 100-120 por minuto, con 5-6 cm de profundidad, reexpansión completa del tórax y mínimas interrupciones, con relación 30:2 sin vía aérea avanzada. Se prioriza iniciar compresiones antes que ventilar (secuencia C-A-B) y desfibrilar apenas se disponga del equipo.

Banco · sin clase · Geriatría

752 sin clase · Perfil V3 1.07.1.009 · Hipertensión arterial · *Práctica*

Hombre de 82 años, autovalente, sin diabetes ni enfermedad renal, presenta en el perfil de presión arterial promedios de 168/78 mmHg. Está asintomático y no tiene hipotensión ortostática.

¿Cuál es la afirmación más adecuada?

A) Es una hipertensión sistólica aislada fisiológica de la edad y no requiere tratamiento

B) Debe iniciarse atenolol como primera línea

C) Corresponde tratar con fármacos, ya que reduce ACV e insuficiencia cardíaca aun en mayores de 80 años

D) La meta es una PA sistólica menor de 110 mmHg

E) Debe descartarse primero una causa secundaria con angiografía renal

> **Respuesta C.** La hipertensión sistólica aislada es la forma más frecuente en el adulto mayor por rigidez arterial y no es benigna. El estudio HYVET mostró que tratarla en mayores de 80 años reduce ACV, insuficiencia cardíaca y mortalidad. Se inicia con dosis bajas de tiazida, calcioantagonista o IECA/ARA II, evitando la hipotensión ortostática.

753 sin clase · Perfil V3 1.07.1.011 · Hipotermia · *Práctica*

Mujer de 88 años que vive sola es encontrada en el suelo de su casa en invierno, tras una caída nocturna. Está somnolienta, con piel fría, temperatura rectal de 30 °C, FC 44/min y PA 95/60 mmHg. El ECG muestra bradicardia sinusal con ondas J de Osborn.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Recalentamiento solo con frazadas a temperatura ambiente

B) Atropina y marcapaso transcutáneo inmediato

C) Iniciar compresiones torácicas

D) Baño de agua caliente a 45 °C

E) Recalentamiento activo externo y con fluidos endovenosos tibios, con monitorización y manipulación cuidadosa

> **Respuesta E.** Una temperatura de 30 °C es hipotermia moderada (28-32 °C), con bradicardia y ondas de Osborn típicas. Requiere recalentamiento activo externo con mantas térmicas y fluidos tibios, con monitor por riesgo de fibrilación ventricular ante una manipulación brusca. La bradicardia es fisiológica y no responde a atropina; con pulso presente no se hacen compresiones.

754 sin clase · Perfil V3 1.07.2.002 · Evento coronario en adulto mayor · *Práctica*

Mujer de 86 años, diabética e hipertensa, es traída por disnea súbita, sudoración y confusión de 1 hora. No refiere dolor torácico. PA 100/60 mmHg, FC 105/min, SatO2 92%.

¿Cuál es el examen que debe realizarse primero?

A) Dímero D

B) TAC de cerebro sin contraste

C) Radiografía de tórax

D) Electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos

E) Ecocardiograma transtorácico

> **Respuesta D.** En adultos mayores, diabéticos y mujeres, el síndrome coronario agudo suele presentarse sin dolor torácico, con disnea, confusión, síncope o sudoración. Ante esta sospecha se realiza un ECG de 12 derivaciones en menos de 10 minutos, junto con troponinas, porque un supradesnivel del ST cambia la conducta de inmediato.

755 sin clase · Perfil V3 1.07.3.003 · Manejo, cuidado y acompañamiento de final de vida · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 14*

Un paciente de 80 años en cuidados paliativos por cáncer de glotis presenta, desde hace un mes, tos y regurgitación de alimentos. No ha presentado neumonías aspirativas ni otras complicaciones.

¿Cuál es la vía de administración de medicamentos más adecuada para este paciente?

A) Rectal

B) Sublingual

C) Intramuscular

D) Endovenosa

E) Subcutánea

> **Respuesta E.** En cuidados paliativos, cuando la vía oral no es segura, la vía de elección es la subcutánea: es poco dolorosa, permite bolos o infusión continua de morfina, antieméticos y otros fármacos, y la familia puede manejarla en domicilio. La intramuscular es dolorosa, la endovenosa requiere acceso venoso y es más invasiva, y la rectal y la sublingual tienen absorción errática.

Banco · sin clase · Hémato-oncología

756 sin clase · Perfil V3 1.08.3.007 · Manejo del dolor crónico y paliativo · *Práctica*

Mujer de 70 años con cáncer de páncreas metastásico presenta dolor abdominal intenso (EVA 8/10) pese a paracetamol y tramadol en dosis máximas. Se decide iniciar morfina oral de liberación inmediata.

¿Qué indicación debe asociarse siempre al inicio de la morfina?

A) Naloxona profiláctica

B) Antihistamínico para evitar la dependencia

C) Benzodiacepina nocturna

D) Suspender todos los coadyuvantes

E) Laxante en forma regular

> **Respuesta E.** La constipación es el efecto adverso más frecuente de los opioides y no genera tolerancia, por lo que debe indicarse un laxante regular desde el inicio, como lactulosa o polietilenglicol con un estimulante. Según la escalera analgésica de la OMS, ante dolor intenso se pasa a un opioide fuerte, manteniendo paracetamol y coadyuvantes. La naloxona solo se usa en sobredosis.

757 sin clase · Perfil V3 1.08.3.008 · Manejo del paciente terminal oncológico · *Práctica*

Hombre de 81 años con cáncer pulmonar avanzado, en sus últimas horas de vida e inconsciente, presenta respiración ruidosa con estertores por secreciones en la vía aérea superior. La familia está angustiada.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aspiración traqueal profunda frecuente

B) Furosemida endovenosa en dosis altas

C) Butilbromuro de escopolamina subcutáneo, posición lateral y explicación a la familia

D) Intubación orotraqueal

E) Antibióticos de amplio espectro

> **Respuesta C.** Los estertores premortem se deben a secreciones que el paciente ya no puede deglutir. Se manejan con posición lateral, reducción de la hidratación parenteral y antimuscarínicos como butilbromuro de escopolamina subcutáneo, explicando a la familia que no implican sufrimiento. La aspiración profunda es molesta y poco eficaz, y la intubación o los antibióticos no corresponden al final de vida.

Banco · sin clase · Pediatría general

758 sin clase · Perfil V3 2.01.1.014 · Infecciones recurrentes · *Práctica*

Un niño de 2 años asiste a sala cuna desde los 12 meses. En el último año ha tenido 8 resfríos, 2 otitis medias agudas y 1 episodio de gastroenteritis, todos de evolución favorable y manejo ambulatorio. Su peso y talla progresan en percentil 50 y el examen físico es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar inmunoglobulinas séricas

B) Solicitar test de VIH y subpoblaciones linfocitarias

C) Tranquilizar a los padres: es un patrón esperable para su edad

D) Indicar profilaxis antibiótica

E) Derivar a inmunología

> **Respuesta C.** Los niños que asisten a sala cuna pueden tener 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año. Infecciones leves, de buena evolución, con crecimiento normal, no sugieren inmunodeficiencia. Las señales de alarma son infecciones graves, por gérmenes oportunistas, 2 o más neumonías al año, necesidad de antibióticos endovenosos, falla de crecimiento o antecedentes familiares.

759 sin clase · Perfil V3 2.01.1.044 · Hepatomegalia · *Práctica*

Un lactante de 6 meses es traído por irritabilidad, sudoración y temblor cuando pasa más de 3 a 4 horas sin alimentarse. Al examen tiene facies de muñeca, abdomen prominente y hepatomegalia de 6 cm bajo el reborde costal, sin esplenomegalia. Exámenes en ayuno corto: glicemia 35 mg/dL, lactato elevado, triglicéridos y ácido úrico elevados.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atresia de vías biliares

B) Enfermedad de Gaucher

C) Hepatitis viral aguda

D) Glucogenosis tipo I

E) Hiperinsulinismo congénito

> **Respuesta D.** Hepatomegalia aislada sin esplenomegalia, hipoglicemia de ayuno corto, acidosis láctica, hipertrigliceridemia e hiperuricemia es la glucogenosis tipo I (déficit de glucosa-6-fosfatasa). El hígado no puede liberar glucosa. El hiperinsulinismo da hipoglicemia sin hepatomegalia; Gaucher da esplenomegalia marcada; la atresia biliar cursa con ictericia y acolia.

760 sin clase · Perfil V3 2.01.1.049 · Arritmias · *Práctica*

Un lactante de 4 meses es traído por rechazo alimentario, palidez y sudoración. Al examen está soporoso, con llene capilar de 5 segundos, pulsos periféricos débiles y frecuencia cardíaca de 280/min. El monitor muestra una taquicardia regular de QRS estrecho, sin ondas P visibles.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Maniobras vagales con hielo en la cara

B) Adenosina en bolo endovenoso rápido como única opción, aunque demore la vía

C) Cardioversión eléctrica sincronizada

D) Amiodarona oral

E) Observar y controlar con ECG en 24 horas

> **Respuesta C.** La taquicardia supraventricular es la arritmia sintomática más frecuente en lactantes (FC habitualmente sobre 220/min, QRS estrecho, sin P). Con signos de shock o compromiso de conciencia es inestable: se trata con cardioversión eléctrica sincronizada (0,5 a 1 J/kg, luego 2 J/kg). Puede usarse adenosina si hay vía venosa inmediata, sin retrasar la cardioversión.

761 sin clase · Perfil V3 2.01.1.051 · Endocarditis infecciosa · *Práctica*

Un niño de 9 años con antecedente de comunicación interventricular no operada presenta fiebre de 2 semanas, decaimiento y baja de peso. Hace un mes se realizó una extracción dental. Al examen tiene soplo holosistólico de mayor intensidad que en controles previos, esplenomegalia leve y hemorragias en astilla subungueales.

¿Cuál es el examen más importante para iniciar el estudio?

A) Electrocardiograma

B) Proteína C reactiva

C) Radiografía de tórax

D) Serología para Bartonella

E) Hemocultivos seriados antes de iniciar antibióticos

> **Respuesta E.** Fiebre prolongada en un niño con cardiopatía congénita, con soplo que cambia, esplenomegalia y fenómenos vasculares, sugiere endocarditis infecciosa (criterios de Duke). Lo fundamental es obtener 3 hemocultivos de punciones separadas antes de los antibióticos, y luego ecocardiograma. Los agentes más frecuentes son estreptococos del grupo viridans y Staphylococcus aureus.

762 sin clase · Perfil V3 2.01.1.052 · Insuficiencia cardíaca · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 173*

Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna exclusiva, es traído por bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, con saturación arterial de 90%, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos y soplo sistólico, y examen pulmonar con murmullo disminuido en bases y crepitaciones finas bilaterales.

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Administrar furosemida endovenosa

B) Administrar vasodilatadores endovenosos

C) Administrar epinefrina endovenosa

D) Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica

E) Administrar betabloqueadores endovenosos

> **Respuesta A.** Cansancio al alimentarse, mal incremento ponderal, soplo y crepitaciones en un lactante sugieren insuficiencia cardíaca por cortocircuito izquierda-derecha (ej. CIV) con congestión pulmonar. El manejo inicial es diurético (furosemida) y oxígeno, y luego ecocardiograma. Los vasodilatadores pueden aumentar el cortocircuito y el paciente no tiene criterios de intubación.

763 sin clase · Perfil V3 2.01.1.054 · Soplos · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 154*

Un niño de 13 años acude a control médico por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Soplo inocente

B) Ductus arterioso persistente

C) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

D) Estenosis aórtica

E) Coartación aórtica

> **Respuesta A.** Un soplo sistólico suave (grado II/VI o menor), paraesternal izquierdo, en un niño asintomático y en contexto febril o infeccioso (estado hiperdinámico), sin otros hallazgos, es un soplo inocente. Signos de soplo patológico: diastólico, holosistólico, grado III o más, frémito, clic, síntomas o pulsos alterados. El ductus da un soplo continuo.

764 sin clase · Perfil V3 2.01.1.056 · Inmunodeficiencias · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 136*

Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero desde entonces ha presentado candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias agudas y dos neumonías que han requerido hospitalización.

¿Cuál es la causa más probable de su inmunodepresión?

A) Inmunodeficiencia humoral

B) Inmunodeficiencia combinada severa

C) Alteración de la fagocitosis

D) Déficit de complemento

E) Inmunodeficiencia celular

> **Respuesta A.** Infecciones bacterianas sinopulmonares recurrentes (otitis, neumonías) que comienzan después de los 6 meses, cuando desaparece la IgG materna transferida, sugieren una inmunodeficiencia humoral (ej. agammaglobulinemia ligada al X). La inmunodeficiencia combinada severa se manifiesta desde los primeros meses con infecciones oportunistas graves y falla de crecimiento. Se estudia con cuantificación de inmunoglobulinas.

765 sin clase · Perfil V3 2.01.1.059 · Enuresis · *Práctica*

Un niño de 7 años moja la cama casi todas las noches desde siempre. Durante el día controla la micción sin urgencia ni incontinencia, no tiene constipación y el examen físico, incluido el examen de orina, es normal. Nunca ha recibido tratamiento.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Ecografía renal y vesical y uretrocistografía

B) Educación y medidas conductuales (micción antes de dormir, reducir líquidos nocturnos, calendario)

C) Imipramina oral

D) Derivar a urología pediátrica

E) Indicar pañales hasta la adolescencia

> **Respuesta B.** Enuresis primaria monosintomática: incontinencia nocturna en mayores de 5 años que nunca han logrado control, sin síntomas diurnos. Es frecuente y benigna. El manejo inicial es desculpabilizar, educar y aplicar medidas conductuales; si fracasan, alarma de enuresis o desmopresina. No requiere imágenes si el examen y la orina son normales. La imipramina está en desuso por su toxicidad.

766 sin clase · Perfil V3 2.01.1.089 · Fimosis · *Real EUNACOM · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 21*

Niño de 3 años con prepucio estrecho que no permite retraerlo completamente. Logró el control de esfínteres hace 6 meses. No ha tenido infecciones urinarias, balanitis ni dificultad miccional.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Circuncisión inmediata

B) Aplicar corticoide tópico

C) Control en un año

D) Dilatación manual bajo anestesia

E) Derivar a urología pediátrica urgente

> **Respuesta C.** La fimosis es fisiológica en la mayoría de los niños pequeños: el prepucio se va despegando espontáneamente y suele ser retráctil entre los 3 y 5 años o más. Sin complicaciones (balanitis, ITU, obstrucción miccional), la conducta es observar y no retraer a la fuerza. Los corticoides tópicos se usan si persiste más allá de esa edad o es sintomática.

767 sin clase · Perfil V3 2.01.1.094 · Patología de columna · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 132*

En el examen físico de un recién nacido se evalúa la región lumbosacra en busca de marcadores cutáneos de disrafia espinal.

¿Qué alteración del examen físico obliga a descartar una disrafia espinal de tipo espina bífida oculta?

A) Melanocitosis dérmica congénita (mancha mongólica)

B) Nevus flammeus sacro

C) Nevo congénito pequeño en la zona sacra

D) Hoyuelo sacro o fosita pilonidal típica

E) Seno dérmico sacrococcígeo

> **Respuesta E.** Un seno dérmico (trayecto que comunica la piel con planos profundos, sobre la zona sacra alta o lumbar) obliga a estudiar disrafia espinal oculta y médula anclada, y tiene riesgo de meningitis. Otros marcadores son hipertricosis localizada, lipoma o hemangioma lumbosacro. La fosita pilonidal simple, baja y con fondo visible, y la mancha mongólica son hallazgos benignos.

768 sin clase · Perfil V3 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares cutáneas · *Real EUNACOM · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 83*

Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente el eje visual.

¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Administrar propranolol

B) Administrar betametasona

C) Realizar embolización

D) Derivar a cirujano plástico

E) Observar evolución

> **Respuesta A.** La mayoría de los hemangiomas infantiles involucionan solos y se observan, pero los periorbitarios que ocluyen el eje visual tienen riesgo de ambliopía y deben tratarse precozmente, antes de la fase proliferativa máxima. El tratamiento de primera línea es propranolol oral, con evaluación oftalmológica. Los corticoides quedaron como segunda línea y la cirugía deja cicatriz.

769 sin clase · Perfil V3 2.01.1.131 · Sinequias vulvares · *Real EUNACOM · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 154*

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar que une gran parte de los labios menores, por lo que impide ver el introito y el himen. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias ni genitales. El resto de su examen físico es normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar lavados con ácido acético

B) Aplicar corticoides tópicos

C) Remover las sinequias de manera quirúrgica

D) Realizar separación manual bajo anestesia local

E) Indicar lubricación diaria con vaselina

> **Respuesta E.** Las sinequias de labios menores son frecuentes en niñas prepuberales por el hipoestrogenismo fisiológico y suelen resolverse espontáneamente con la pubertad. Si son asintomáticas se manejan con aseo y lubricación (vaselina); si dan síntomas se usa estrógeno tópico. La separación manual o quirúrgica se reserva para casos complicados (retención urinaria) por la alta recurrencia.

770 sin clase · Perfil V3 2.01.1.132 · Dismorfias · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 76*

Un niño de 14 años, cuyo padre murió de muerte súbita, presenta talla alta, con dedos y extremidades muy largos y algo desproporcionados. Además, presenta hiperlaxitud articular y un soplo diastólico en la auscultación cardíaca.

¿Cuál es el síndrome más probable?

A) Neurofibromatosis

B) Síndrome alcohólico fetal

C) Síndrome de Miller

D) Síndrome de Marfan

E) Síndrome de Ehlers-Danlos

> **Respuesta D.** Talla alta con extremidades largas (dolicostenomelia), aracnodactilia, hiperlaxitud, soplo diastólico (insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz) y antecedente familiar de muerte súbita (disección aórtica) es síndrome de Marfan, autosómico dominante por mutación de fibrilina 1. Ehlers-Danlos da hiperlaxitud y piel hiperelástica, pero sin hábito marfanoide.

771 sin clase · Perfil V3 2.01.1.134 · Trisomía 21 · *Práctica*

Un recién nacido de término presenta hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, pliegue palmar único y occipucio plano. Se sospecha síndrome de Down y se solicita cariograma.

Además del cariograma, ¿qué examen debe realizarse precozmente en todo recién nacido con esta sospecha?

A) Resonancia magnética cerebral

B) Electroencefalograma

C) Radiografía de columna cervical

D) Ecocardiograma

E) Densitometría ósea

> **Respuesta D.** Cerca de la mitad de los niños con síndrome de Down tiene cardiopatía congénita, siendo característico el canal auriculoventricular, que puede ser asintomático al nacer y causar hipertensión pulmonar precoz. Por ello se indica ecocardiograma a todos en el período neonatal. También se controlan hemograma, función tiroidea, audición y visión.

772 sin clase · Perfil V3 2.01.1.138 · Maltrato infantil · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 150*

Un lactante de 6 meses es traído por su madre porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está poco reactivo y presenta múltiples equimosis, algunas de color morado y otras de color verde. Además, tiene dos fracturas costales posteriores. Su TAC de cerebro muestra un hematoma subdural.

¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

A) PTH y calcio

B) Tiempos de coagulación

C) Exámenes para descartar osteogénesis imperfecta

D) Fondo de ojo

E) Ecografía abdominal

> **Respuesta D.** Lesiones en distinto estado de evolución, fracturas costales posteriores y hematoma subdural en un lactante con un mecanismo que no las explica son altamente sugerentes de maltrato físico (traumatismo craneal por abuso o niño sacudido). El fondo de ojo busca hemorragias retinales, muy características. Además de estabilizar y tratar el hematoma, debe protegerse al niño y denunciarse.

773 sin clase · Perfil V3 2.01.2.012 · Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar · *Práctica*

Un escolar de 9 años, que hace 10 días tuvo un cuadro respiratorio viral, consulta por cansancio, disnea progresiva, ortopnea y dolor abdominal. Al examen tiene FC 140/min, ritmo de galope, crepitaciones bibasales y hepatomegalia dolorosa. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y congestión pulmonar.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocarditis viral con insuficiencia cardíaca

B) Neumonía bilateral

C) Crisis asmática

D) Pericarditis aguda sin compromiso miocárdico

E) Hepatitis viral aguda

> **Respuesta A.** Insuficiencia cardíaca aguda (taquicardia desproporcionada, galope, congestión pulmonar, hepatomegalia y cardiomegalia) en un niño previamente sano tras una infección viral sugiere miocarditis viral. El dolor abdominal por congestión hepática es una forma de presentación frecuente en niños. Se confirma con troponinas, ECG y ecocardiograma; se maneja con diuréticos, soporte y en unidad crítica si hay shock.

774 sin clase · Perfil V3 2.01.2.014 · Intoxicaciones · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 108*

Un niño de 4 años ingirió hace 24 horas 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Los exámenes muestran GOT 403 UI/L, GPT 390 UI/L y bilirrubina total 5,2 mg/dL.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar L-carnitina endovenosa

B) Administrar deferoxamina endovenosa

C) Administrar N-acetilcisteína endovenosa

D) Administrar carbón activado vía oral

E) Administrar piridoxina vía oral

> **Respuesta C.** Vómitos seguidos de daño hepatocelular a las 24 horas de una ingesta medicamentosa sugieren intoxicación por paracetamol, el fármaco más disponible en los hogares. El antídoto es N-acetilcisteína, más efectiva antes de 8 a 10 horas pero indicada aun tardíamente si hay hepatotoxicidad. El carbón activado solo sirve en la primera hora.

775 sin clase · Perfil V3 2.01.2.020 · Paro cardiorrespiratorio · *Práctica*

Un lactante de 8 meses es encontrado en paro cardiorrespiratorio después de un episodio de atoro. Se inicia reanimación con compresiones y ventilación. El monitor muestra asistolia. Se logra un acceso intraóseo.

¿Cuál es el fármaco y dosis inicial más adecuados?

A) Atropina 0,02 mg/kg

B) Desfibrilación con 4 J/kg

C) Amiodarona 5 mg/kg

D) Bicarbonato de sodio 1 mEq/kg como primera medida

E) Adrenalina 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de solución 1:10.000), repetida cada 3 a 5 minutos

> **Respuesta E.** En pediatría el paro suele ser secundario a hipoxia y el ritmo más frecuente es no desfibrilable (asistolia o actividad eléctrica sin pulso). Se mantiene RCP de alta calidad y se administra adrenalina 0,01 mg/kg endovenosa o intraósea lo antes posible, repitiendo cada 3 a 5 minutos.

776 sin clase · Perfil V3 2.01.2.144 · SARS Cov 2 COVID 19 · *Real EUNACOM · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 36*

Un adolescente de 14 años presenta fiebre de 39 °C desde hace 3 días, malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso del estado general. Al examen físico tiene compromiso hemodinámico, con FC 120/min y PA 90/50 mmHg, con respuesta parcial al suero fisiológico. Tuvo una PCR positiva para COVID-19 hace 30 días. Exámenes: hematocrito 33%, leucocitos 14.000/mm3, plaquetas 80.000/mm3, VHS 76 mm/h, PCR 15,5 mg/dL, dímero D 670 ng/mL y troponinas elevadas.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sepsis bacteriana

B) Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico

C) Insuficiencia suprarrenal aguda

D) Reinfección por COVID-19

E) Enfermedad de Kawasaki

> **Respuesta B.** Fiebre, síntomas gastrointestinales, shock con compromiso miocárdico (troponinas), marcadores inflamatorios elevados, trombocitopenia y dímero D alto, 2 a 6 semanas después de una infección por SARS-CoV-2, es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS o MIS-C). Se trata con inmunoglobulina endovenosa y corticoides. El Kawasaki afecta a menores de 5 años y rara vez da shock.

777 sin clase · Perfil V3 2.01.3.004 · Entrevista y comunicación efectiva · *Práctica*

Usted debe comunicar a los padres de un niño de 5 años que el mielograma confirmó una leucemia linfoblástica aguda.

¿Cuál es la forma más adecuada de iniciar esta conversación?

A) En el pasillo, para no retrasar la información

B) Esperar a que los padres pregunten por el resultado

C) Entregar la información técnica completa con estadísticas de sobrevida desde el inicio

D) En un lugar privado y sin interrupciones, explorando primero qué saben y qué desean saber

E) Informar solo al padre para que él se lo comunique a la madre

> **Respuesta D.** Para comunicar malas noticias se recomienda el protocolo SPIKES: preparar un lugar privado y sin interrupciones, explorar lo que la familia sabe y quiere saber, dar la información en forma gradual, con lenguaje simple y sin tecnicismos, acoger las emociones con empatía y acordar un plan. Ambos padres tienen derecho a ser informados.

778 sin clase · Perfil V3 2.01.3.008 · Prevención de accidentes · *Práctica*

En el control de salud de un lactante de 6 meses, los padres preguntan cómo deben trasladarlo en el automóvil.

¿Cuál es la recomendación correcta?

A) En brazos de un adulto en el asiento trasero

B) En silla de auto en el asiento delantero frente al airbag

C) En silla de auto mirando hacia adelante, en el asiento delantero

D) Con el cinturón de seguridad del adulto

E) En silla de auto mirando hacia atrás, en el asiento trasero

> **Respuesta E.** Los accidentes son una causa principal de muerte en niños mayores de 1 año. Los lactantes deben viajar en un sistema de retención infantil mirando hacia atrás, en el asiento trasero, idealmente hasta los 2 años o más, porque protege cabeza y cuello. Nunca en brazos ni frente a un airbag activo.

779 sin clase · Perfil V3 2.01.3.009 · Prevención de conductas de riesgo · *Práctica*

Un adolescente de 15 años acude a control de salud. En la entrevista a solas, refiere que consume alcohol los fines de semana con sus amigos. No tiene síntomas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Informar inmediatamente a los padres

B) No abordar el tema porque no tiene síntomas

C) Derivar directamente a un centro de rehabilitación

D) Realizar tamizaje estructurado de consumo (ej. CRAFFT) e intervención breve motivacional

E) Solicitar test de drogas en orina sin su consentimiento

> **Respuesta D.** La prevención de conductas de riesgo en adolescentes se basa en la entrevista confidencial (HEADSSS), el tamizaje estructurado de consumo de sustancias (CRAFFT) y la intervención breve con enfoque motivacional, ajustando el seguimiento al riesgo. La confidencialidad se mantiene salvo riesgo vital. Derivar a rehabilitación sin evaluar el nivel de consumo es desproporcionado.

780 sin clase · Perfil V3 2.01.3.012 · Psiquiatría de enlace · *Práctica*

Una adolescente de 14 años con diabetes mellitus tipo 1 ha tenido tres hospitalizaciones por cetoacidosis en 6 meses. Reconoce que omite dosis de insulina. Refiere ánimo bajo, aislamiento y conflictos familiares desde el diagnóstico.

Además de reforzar la educación en diabetes, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de insulina basal

B) Hospitalizar hasta que cumpla 18 años

C) Indicar que cumpla mejor el tratamiento y control en 3 meses

D) Cambiar a hipoglicemiantes orales

E) Solicitar interconsulta a salud mental (psiquiatría de enlace) para evaluación integral

> **Respuesta E.** La mala adherencia en adolescentes con enfermedades crónicas se asocia frecuentemente a depresión, trastornos de la conducta alimentaria (omisión de insulina para bajar de peso) y conflictos familiares. La psiquiatría de enlace evalúa y trata en conjunto con el equipo tratante, mejorando el control metabólico.

781 sin clase · Perfil V3 2.01.4.012 · Electrocardiograma · *Práctica*

Un adolescente de 14 años consulta por episodios de palpitaciones de inicio y término brusco. Entre crisis, el electrocardiograma muestra intervalo PR corto, onda delta (empastamiento inicial del QRS) y QRS levemente ensanchado.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Bloqueo auriculoventricular de primer grado

B) Síndrome de Wolff-Parkinson-White

C) Síndrome de QT largo

D) Hipertrofia ventricular izquierda

E) Bloqueo completo de rama derecha

> **Respuesta B.** PR corto con onda delta y QRS ancho es la preexcitación ventricular por una vía accesoria (síndrome de Wolff-Parkinson-White) que, junto a taquicardias paroxísticas, constituye una causa importante de taquicardia supraventricular en niños. Debe derivarse a cardiología para estratificación y eventual ablación, por riesgo de muerte súbita si se asocia a fibrilación auricular.

782 sin clase · Perfil V3 2.01.4.015 · Hemograma · *Práctica*

Un lactante de 14 meses, sano, tiene un hemograma solicitado en su control: hemoglobina 11,8 g/dL, leucocitos 10.500/mm3 con 30% de neutrófilos y 62% de linfocitos, y plaquetas 320.000/mm3. El frotis no muestra células anormales.

¿Cuál es la interpretación más adecuada?

A) Sugiere leucemia linfática; derivar a hematología

B) Hemograma normal para la edad

C) Neutropenia grave que requiere estudio

D) Infección viral que requiere tratamiento

E) Anemia que requiere suplementar hierro

> **Respuesta B.** En lactantes y preescolares predominan normalmente los linfocitos en la fórmula leucocitaria; esta inversión fisiológica se mantiene aproximadamente hasta los 4 a 6 años. Con 30% de neutrófilos de 10.500 leucocitos, el recuento absoluto (3.150/mm3) es normal. La hemoglobina es normal a esta edad (mayor a 11 g/dL), igual que las plaquetas.

783 sin clase · Perfil V3 2.01.5.012 · Reanimación cardiopulmonar pediátrica · *Práctica*

Usted y un colega encuentran a un lactante de 6 meses que no responde, no respira y no tiene pulso braquial. Inician la reanimación cardiopulmonar.

¿Cuál es la relación compresiones-ventilaciones y la técnica de compresión recomendada para dos reanimadores?

A) 30:2 con el talón de una mano sobre el esternón

B) 15:2 con técnica de dos pulgares y manos rodeando el tórax, comprimiendo un tercio del diámetro anteroposterior

C) 5:1 con dos dedos

D) 3:1 como en el recién nacido

E) Solo compresiones, sin ventilaciones

> **Respuesta B.** En RCP pediátrica, con un reanimador la relación es 30:2; con dos reanimadores, 15:2. En lactantes se prefiere la técnica de dos pulgares con manos rodeando el tórax (con dos reanimadores), comprimiendo al menos un tercio del diámetro anteroposterior (unos 4 cm), a 100 a 120 por minuto. La relación 3:1 es para la reanimación neonatal en sala de partos.

Banco · sin clase · Obstetricia y ginecología

784 sin clase · Perfil V3 3.01.1.007 · Embarazo múltiple · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 59*

Paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Está en buenas condiciones generales, sin síntomas, con signos vitales normales. La ecografía muestra al primer gemelo con peso fetal estimado de 2.850 g y al segundo con 2.750 g, con líquido amniótico normal.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar control ecográfico en una semana

B) Programar cesárea electiva a las 38 semanas

C) Inducir el parto de inmediato

D) Solicitar ecografía Doppler de arterias uterinas

E) Realizar cesárea de urgencia

> **Respuesta A.** Gemelar bicorial no complicado, con crecimiento concordante y bienestar conservado: se mantiene vigilancia seriada y se interrumpe alrededor de las 37 a 38 semanas. A las 36 semanas no hay indicación de interrupción inmediata, y la vía de parto depende de la presentación del primer gemelo, no del embarazo gemelar en sí.

785 sin clase · Perfil V3 3.01.2.007 · Hiperemesis gravídica · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 177*

Paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentes desde el inicio del embarazo, que han ido en aumento. En las últimas 24 horas ha empeorado al punto de no poder ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Gastroparesia gestacional

B) Cólico biliar

C) Hepatitis

D) Hiperemesis gravídica

E) Síndrome de HELLP

> **Respuesta D.** Vómitos persistentes del primer trimestre que impiden la ingesta y llevan a deshidratación definen la hiperemesis gravídica. Se maneja con hospitalización, hidratación endovenosa, reposición de electrolitos, tiamina y antieméticos. El HELLP aparece en la segunda mitad del embarazo con hipertensión, hemólisis y trombocitopenia.

786 sin clase · Perfil V3 3.01.3.014 · Sexualidad, género y diversidad · *Práctica*

Adolescente de 16 años, asignada mujer al nacer, consulta en control de salud. Refiere que se identifica como mujer, se siente cómoda con su cuerpo y desde los 13 años siente atracción afectiva y sexual solo hacia otras mujeres.

¿Qué concepto describe la atracción que relata la paciente?

A) Identidad de género

B) Sexo asignado al nacer

C) Expresión de género

D) Orientación sexual

E) Disforia de género

> **Respuesta D.** La orientación sexual es hacia quién se dirige la atracción afectiva y sexual. La identidad de género es la vivencia interna de ser mujer, hombre u otra; la expresión de género, cómo se manifiesta externamente. Ser lesbiana no es un trastorno; la disforia implica malestar por incongruencia con el sexo asignado, ausente aquí.

Banco · sin clase · Cirugía general y anestesia

787 sin clase · Perfil V3 4.01.1.044 · Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea · *Práctica*

Hombre de 70 años, hipertenso y exfumador, consulta por una masa pulsátil asintomática en el hueco poplíteo derecho. La ecografía Doppler confirma un aneurisma de la arteria poplítea de 3 cm, con trombo mural.

¿Cuál es la complicación más frecuente de esta patología?

A) Trombosis o embolia distal con isquemia aguda de la pierna

B) Rotura con hemorragia masiva

C) Compresión del nervio ciático

D) Fístula arteriovenosa

E) Insuficiencia cardíaca de alto débito

> **Respuesta A.** A diferencia del aneurisma de aorta abdominal, cuya complicación temida es la rotura, el aneurisma poplíteo se complica principalmente con trombosis o embolización distal, con isquemia aguda y riesgo de amputación. Por eso se reparan los sintomáticos o mayores de 2 cm, y se busca un aneurisma contralateral y aórtico asociado.

788 sin clase · Perfil V3 4.01.1.048 · Várices. Insuficiencia venosa crónica · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 26*

Mujer de 45 años con várices bilaterales en extremidades inferiores, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos.

¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Anticoagulación oral

B) Flebectomía inmediata

C) Escleroterapia de urgencia

D) Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias compresivas

E) Derivación vascular urgente

> **Respuesta D.** En la insuficiencia venosa crónica no complicada, el manejo inicial es conservador: control de peso, ejercicio, elevación de piernas y medias de compresión graduada. La cirugía o los procedimientos ablativos se plantean en forma electiva si persisten síntomas o aparecen complicaciones; ninguno es urgente, y la anticoagulación no tiene indicación.

789 sin clase · Perfil V3 4.01.1.050 · Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas) · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 61*

Hombre de 58 años, con várices de gran tamaño en ambas piernas, consulta porque hace 2 semanas sufrió un pequeño trauma en la extremidad inferior izquierda y evolucionó con una lesión ulcerada que ha aumentado de tamaño hasta 1,5 cm, ubicada a 2 cm del maléolo interno. Al examen se aprecia oscurecimiento de la piel circundante, además de las várices.

¿Cuál es la etiología más probable de la lesión?

A) Infecciosa

B) Isquémica

C) Venosa

D) Neuropática

E) Por presión

> **Respuesta C.** Una úlcera en la zona perimaleolar interna, en un paciente con várices e hiperpigmentación (dermatitis ocre), es típicamente venosa. Las úlceras isquémicas son distales (ortejos, talón), muy dolorosas y con pulsos ausentes; las neuropáticas aparecen en zonas de apoyo plantar.

790 sin clase · Perfil V3 4.01.1.059 · Onicocriptosis · *Práctica*

Adolescente de 16 años consulta por dolor en el borde lateral del ortejo mayor derecho de 1 semana, con eritema leve y edema del pliegue ungueal, sin secreción purulenta ni tejido de granulación. Refiere que se corta las uñas en forma curva y usa zapatillas estrechas.

¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Onicectomía total

B) Onicectomía parcial con matricectomía

C) Antibiótico oral por 14 días

D) Manejo conservador: baños tibios, levantar el borde ungueal con algodón, calzado holgado y corte recto de la uña

E) Antifúngico tópico

> **Respuesta D.** La onicocriptosis leve (dolor, eritema y edema, sin pus ni granuloma) se maneja en forma conservadora: higiene, baños tibios, elevar el borde con algodón, calzado amplio y cortar la uña recta. La onicectomía parcial con matricectomía se reserva para casos moderados a severos o recurrentes.

791 sin clase · Perfil V3 4.01.1.060 · Obesidad mórbida · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 75*

Mujer de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace 1 año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipoglicemias reactivas

B) Síndrome de dumping

C) Hernia del espacio de Petersen

D) Estenosis de la anastomosis

E) Déficit de vitamina B12

> **Respuesta B.** Síntomas vasomotores (mareo, palpitaciones) y digestivos (diarrea) poco después de comer, tras un bypass gástrico, son típicos del síndrome de dumping precoz, por llegada rápida de contenido hiperosmolar al intestino. Se maneja con comidas pequeñas y frecuentes, evitando azúcares simples. La hipoglicemia reactiva es más tardía y no explica la diarrea.

792 sin clase · Perfil V3 4.01.2.030 · Paro cardiorespiratorio · *Práctica*

Hombre de 65 años presenta un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Se inicia reanimación con compresiones de alta calidad y ventilación. Al conectar el monitor desfibrilador, el ritmo es una asistolia, confirmada en más de una derivación.

Además de mantener las compresiones, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Desfibrilar con 200 J bifásicos

B) Administrar adrenalina 1 mg endovenosa lo antes posible y repetir cada 3 a 5 minutos

C) Administrar amiodarona 300 mg endovenosa

D) Cardioversión sincronizada

E) Administrar atropina 1 mg endovenosa

> **Respuesta B.** La asistolia es un ritmo no desfibrilable: el manejo es RCP de alta calidad, adrenalina 1 mg endovenosa o intraósea lo antes posible y cada 3 a 5 minutos, y búsqueda de causas reversibles (las 5H y 5T). La desfibrilación y la amiodarona son para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso; la atropina ya no se recomienda.

793 sin clase · Perfil V3 4.01.5.021 · Manejo de drenajes · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 6*

Hombre de 76 años, con secuela de un accidente vascular encefálico, se alimenta mediante una gastrostomía realizada por vía endoscópica hace 2 meses. Accidentalmente se retiró la sonda.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar radiografía simple de abdomen

B) Solicitar ecografía abdominal

C) Solicitar TAC de abdomen

D) Instalar una nueva sonda por el ostoma

E) Realizar una nueva gastrostomía

> **Respuesta D.** Pasadas 4 a 6 semanas, el trayecto gastrocutáneo de una gastrostomía ya está maduro, por lo que ante un retiro accidental debe reinstalarse una sonda por el mismo ostoma lo antes posible, ya que el orificio puede cerrarse en pocas horas. Si el trayecto es reciente, el riesgo de falsa vía exige reinstalación bajo visión endoscópica o radiológica.

794 sin clase · Perfil V3 4.01.5.024 · Onicectomía · *Práctica*

Hombre de 30 años presenta su cuarto episodio en 1 año de onicocriptosis del borde lateral del ortejo mayor izquierdo, con dolor, secreción purulenta y tejido de granulación hipertrófico, pese a manejo conservador y cuidados adecuados.

¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Onicectomía parcial del borde afectado con matricectomía (quirúrgica o química con fenol)

B) Antibiótico oral y repetir manejo conservador

C) Onicectomía total sin tratar la matriz

D) Amputación de la falange distal

E) Antifúngico oral por 3 meses

> **Respuesta A.** La onicocriptosis recurrente o con granuloma se trata con onicectomía parcial del borde afectado, bajo anestesia troncular digital, asociada a destrucción de la matriz ungueal correspondiente (matricectomía quirúrgica o química con fenol) para evitar la recurrencia. La onicectomía total sin tratar la matriz tiene alta recidiva y peor resultado estético.

795 sin clase · Perfil V3 4.01.5.027 · Punción venosa · *Práctica*

Un interno realiza una punción venosa en el pliegue del codo para tomar exámenes de sangre a un paciente adulto.

¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta?

A) Mantener la ligadura más de 3 minutos para mejorar el llenado venoso

B) Reencapuchar la aguja con ambas manos después de la extracción

C) Puncionar sobre una zona con hematoma reciente

D) Pedir al paciente que abra y cierre el puño repetidamente durante toda la extracción

E) Introducir la aguja con el bisel hacia arriba, en ángulo de 15 a 30 grados, y soltar la ligadura antes de retirarla

> **Respuesta E.** La punción venosa se realiza con el bisel hacia arriba, en un ángulo de 15 a 30 grados, y se suelta la ligadura antes de retirar la aguja para evitar hematomas. La ligadura no debe mantenerse más de 1 minuto, y el bombeo del puño produce falsa hiperkalemia. Nunca se reencapucha la aguja.

796 sin clase · Perfil V3 4.01.5.028 · Resucitación cardiorrespiratoria · *Práctica*

Hombre de 60 años colapsa en la calle. No responde y no respira normalmente. Usted pide ayuda, solicita un desfibrilador externo automático e inicia la reanimación cardiopulmonar.

¿Cuáles son las características correctas de las compresiones torácicas en el adulto?

A) Frecuencia de 60 a 80 por minuto, profundidad de 2 a 3 cm

B) Frecuencia de 150 por minuto, profundidad de 8 cm

C) Frecuencia de 100 a 120 por minuto, profundidad de 5 a 6 cm, permitiendo la reexpansión completa del tórax, con relación 30:2

D) Relación 15:2 con pausas largas para evaluar pulso cada minuto

E) Frecuencia de 100 por minuto sobre el tercio superior del esternón

> **Respuesta C.** Las compresiones de alta calidad en el adulto se realizan en la mitad inferior del esternón, a 100 a 120 por minuto, con profundidad de 5 a 6 cm, permitiendo la reexpansión completa del tórax y minimizando interrupciones; sin vía aérea avanzada, la relación es de 30 compresiones por 2 ventilaciones. La relación 15:2 corresponde a 2 reanimadores en niños.

Banco · sin clase · Urología

797 sin clase · Perfil V3 4.03.1.001 · Balanitis, balano postitis · *Práctica*

Hombre de 58 años, obeso, no circuncidado, consulta por ardor y prurito del glande de 2 semanas. Al examen se observa eritema del glande y del prepucio con pápulas satélites y un exudado blanquecino. No tiene secreción uretral. Nunca se ha controlado la glicemia.

Además del tratamiento tópico, ¿qué examen es más importante solicitar?

A) Glicemia en ayunas

B) VDRL

C) Cultivo de secreción uretral para gonococo

D) Biopsia del glande

E) Ecografía testicular

> **Respuesta A.** Eritema del glande con pápulas satélites y exudado blanquecino sugiere balanopostitis candidiásica, que se trata con antifúngico tópico (clotrimazol) e higiene. Es frecuente en diabéticos y puede ser su primera manifestación, por lo que debe solicitarse glicemia. La biopsia se reserva para lesiones persistentes pese a tratamiento.

798 sin clase · Perfil V3 4.03.1.005 · Disfunción sexual de causa orgánica · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 112*

Hombre de 55 años con disfunción eréctil de 6 meses de evolución, sin causa aparente. HTA controlada con enalapril. Sin síntomas de hipogonadismo.

¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (sildenafil o tadalafil)

B) Testosterona intramuscular

C) Alprostadil intracavernoso

D) Prótesis de pene

E) Solo consejería psicológica

> **Respuesta A.** Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 son la primera línea en la disfunción eréctil orgánica (vascular, diabética). Están contraindicados con nitratos. La testosterona solo si hay hipogonadismo demostrado; alprostadil y prótesis son segunda y tercera línea. La disfunción eréctil es además un marcador de riesgo cardiovascular que debe evaluarse.

799 sin clase · Perfil V3 4.03.1.009 · Fimosis, parafimosis · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 62*

Niño de 5 años con incapacidad de retraer el prepucio sobre el glande. Sin dolor ni infecciones previas.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Circuncisión electiva inmediata

B) Tranquilizar: fimosis fisiológica normal hasta los 6-7 años; observar

C) Corticoides tópicos en el prepucio

D) Derivar a urología

E) Dilatación manual bajo anestesia

> **Respuesta B.** La fimosis fisiológica es normal en la infancia y se resuelve espontáneamente en la mayoría. Sin balanitis recurrente, ITU, cicatriz (fimosis patológica) ni globo prepucial con obstrucción, se observa. La retracción forzada está contraindicada porque produce fisuras y fimosis cicatricial. Si persiste o hay síntomas, los corticoides tópicos son la primera opción.

800 sin clase · Perfil V3 4.03.2.004 · Priapismo · *Real EUNACOM · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 62*

Hombre de 34 años presenta erección dolorosa desde hace 8 horas. Al examen se corrobora erección completa, con turgencia solo de los cuerpos cavernosos y glande y cuerpo esponjoso blandos.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Aplicar hielo en la zona genital

B) Realizar derivación cavernoesponjosa de urgencia

C) Administrar atropina intracavernosa

D) Administrar analgésicos endovenosos

E) Administrar fenilefrina intracavernosa

> **Respuesta E.** Erección dolorosa de más de 4 horas con cuerpos cavernosos rígidos es un priapismo isquémico (de bajo flujo), una urgencia. Se trata con aspiración de sangre de los cuerpos cavernosos e inyección intracavernosa de fenilefrina (agonista alfa). Los shunts quirúrgicos se reservan para el fracaso del manejo intracavernoso.

Banco · sin clase · Psiquiatría general

801 sin clase · Perfil V3 5.01.1.017 · Disfunción sexual · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 162*

Paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno orgásmico femenino

B) Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración

C) Trastorno depresivo mayor

D) Trastorno por somatización

E) Trastorno del deseo sexual hipoactivo

> **Respuesta B.** El DSM-5 agrupa la dispareunia y el vaginismo en el trastorno por dolor genito-pélvico/penetración: dolor o temor a la penetración por al menos 6 meses, con malestar significativo, sin causa orgánica que lo explique. La evitación de las relaciones es secundaria al dolor, no a falta primaria de deseo.

802 sin clase · Perfil V3 5.01.1.019 · Sexualidad humana y sus alteraciones · *Práctica*

Hombre de 30 años, derivado por orden judicial. Desde hace 2 años presenta fantasías e impulsos sexuales intensos y recurrentes de mostrar sus genitales a mujeres desconocidas en la vía pública, y lo ha hecho en varias ocasiones. Refiere culpa posterior.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno frotteurista

B) Trastorno voyeurista

C) Trastorno exhibicionista

D) Trastorno fetichista

E) Trastorno de travestismo

> **Respuesta C.** Las parafilias son intereses sexuales atípicos; se diagnostican como trastorno parafílico cuando por al menos 6 meses causan malestar, deterioro o se han ejecutado con personas que no consienten. Exponer los genitales a desconocidos es exhibicionismo; observar a otros desnudarse es voyeurismo y tocar o rozar a alguien sin consentimiento es frotteurismo.

803 sin clase · Perfil V3 5.01.1.022 · Trastornos facticios · *Real EUNACOM · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 163*

Paciente de 22 años es hospitalizada por un cuadro de diarrea, vómitos y dolor abdominal de difícil manejo. Durante la hospitalización es sorprendida ingiriendo laxantes, autoinduciéndose vómitos y adulterando la temperatura del termómetro. Los exámenes descartan patología orgánica y, luego de indagar, no se encuentra ninguna ganancia evidente con estos síntomas.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno conversivo

B) Trastorno facticio

C) Trastorno delirante

D) Trastorno bipolar

E) Trastorno de la conducta alimentaria

> **Respuesta B.** En el trastorno facticio la persona produce o finge síntomas de forma intencional para asumir el rol de enfermo, sin incentivos externos evidentes. Si hubiera ganancia externa (licencia, dinero) sería simulación; en el conversivo los síntomas no son voluntarios. Los laxantes y vómitos no buscan bajar de peso, sino parecer enfermo.

804 sin clase · Perfil V3 5.01.3.001 · Clasificaciones en psiquiatría · *Práctica*

Un médico de un CESFAM debe registrar el diagnóstico de un paciente con depresión para efectos estadísticos, de licencia médica y de notificación GES, según el sistema oficial usado por el Ministerio de Salud de Chile.

¿Qué sistema de clasificación corresponde utilizar?

A) Escala de depresión de Hamilton

B) Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría

C) Escala de Evaluación de la Actividad Global (GAF)

D) Clasificación de Kraepelin

E) Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS

> **Respuesta E.** En Chile, las estadísticas oficiales, licencias médicas y registros del sistema de salud usan la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS. El DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, es muy usado en clínica e investigación, y abandonó el sistema multiaxial. Las escalas GAF y Hamilton miden gravedad, no clasifican.

805 sin clase · Perfil V3 5.01.3.005 · Higiene del sueño · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 94*

Enfermera que, luego de sus turnos de urgencia, tiene dificultad para dormir y se automedica con diazepam.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Clotiazepam antes de dormir

B) Quetiapina

C) Higiene del sueño y control ambiental

D) Zolpidem

E) Observación clínica

> **Respuesta C.** El insomnio por trabajo en turnos se maneja primero con medidas no farmacológicas: higiene del sueño, oscuridad y silencio al dormir de día, horarios regulares, evitar cafeína y pantallas. Se debe suspender la automedicación con benzodiacepinas por riesgo de tolerancia y dependencia; cambiarla por otra benzodiacepina, un hipnótico Z o quetiapina no resuelve el problema.

806 sin clase · Perfil V3 5.01.3.006 · Disforia de género · *Práctica*

Adolescente de 15 años, asignado hombre al nacer, consulta con su madre. Desde hace más de 2 años se identifica de manera persistente como mujer, siente intenso malestar con sus caracteres sexuales secundarios y ha bajado su rendimiento escolar. Su madre la apoya. Niega ideación suicida.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar una terapia orientada a cambiar su identidad de género

B) Derivar a evaluación especializada multidisciplinaria, con acompañamiento psicosocial y evaluación de salud mental

C) Iniciar estrógenos en atención primaria

D) Esperar que la situación se resuelva con la madurez

E) Iniciar antipsicóticos por sospecha de delirio

> **Respuesta B.** La incongruencia de género no es una enfermedad mental; la disforia de género alude al malestar asociado. Corresponde acompañamiento respetuoso y derivación a un equipo especializado multidisciplinario (en Chile, programa de acompañamiento de identidad de género), evaluando comorbilidad como depresión o riesgo suicida. Las terapias de conversión son dañinas y la terapia hormonal requiere evaluación especializada.

807 sin clase · Perfil V3 5.01.3.009 · Nociones de psiquiatría forense · *Práctica*

Hombre de 28 años con esquizofrenia, sin tratamiento hace 6 meses, agrede gravemente a su vecino. En el peritaje se constata que al momento del hecho cursaba un episodio psicótico agudo, con delirio de persecución en el que el vecino lo iba a matar, y alucinaciones auditivas que le ordenaban defenderse.

¿Qué concepto pericial corresponde a su condición al momento del delito?

A) Simulación

B) Inimputabilidad por enajenación mental

C) Imputabilidad plena

D) Trastorno facticio

E) Responsabilidad penal agravada por la enfermedad

> **Respuesta B.** La imputabilidad es la capacidad de comprender la ilicitud de un acto y autodeterminarse según esa comprensión. Un episodio psicótico agudo que priva totalmente de razón al momento del hecho determina inimputabilidad (Código Penal, loco o demente). No exime de consecuencias: el tribunal puede imponer medidas de seguridad, como internación o tratamiento.

808 sin clase · Perfil V3 5.01.3.012 · Respuesta sexual humana · *Práctica*

En una clase sobre el modelo de respuesta sexual humana de Masters y Johnson se describen cuatro fases sucesivas: excitación, meseta, orgasmo y resolución.

¿En qué fase aparece el período refractario masculino, durante el cual no es posible un nuevo orgasmo?

A) Excitación

B) Meseta

C) Orgasmo

D) Resolución

E) Deseo

> **Respuesta D.** Según Masters y Johnson, tras el orgasmo viene la resolución, en que el organismo vuelve al estado basal; en el hombre incluye un período refractario, que se prolonga con la edad. La mujer puede tener orgasmos múltiples sin período refractario. La fase de deseo fue incorporada después por Kaplan y no es parte del modelo original.

Banco · sin clase · Dermatología

809 sin clase · Perfil V3 6.01.1.013 · Hemangiomas cutáneos infantiles · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 125*

Lactante de 6 meses presenta 8 hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda.

¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Solicitar ecografía abdominal

B) Iniciar propranolol oral

C) Iniciar corticoides intralesionales

D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro

E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

> **Respuesta A.** Cinco o más hemangiomas cutáneos se asocian a hemangiomas hepáticos, que pueden causar insuficiencia cardíaca o hipotiroidismo, por lo que se indica ecografía abdominal. El propranolol se indica según localización, tamaño o complicación de las lesiones, no por su número. La resonancia cerebral se piensa en hemangiomas segmentarios faciales (PHACE).

810 sin clase · Perfil V3 6.01.1.028 · Tumores benignos de piel · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 83*

Paciente de 24 años presenta una cicatriz de gran tamaño en la zona esternal, secundaria a una cirugía torácica realizada hace 6 meses, que no ha respondido a la terapia compresiva. Al examen físico se observa una cicatriz que sobrepasa los bordes de la herida inicial, de aspecto rojo-violáceo y dolorosa a la palpación.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cicatriz hipertrófica en fase activa

B) Queloide

C) Cuerpo extraño

D) Úlcera de Marjolin

E) Granuloma piógeno

> **Respuesta B.** El queloide es una proliferación fibrosa benigna que sobrepasa los límites de la herida original, no regresa espontáneamente y predomina en zona esternal, hombros y lóbulos auriculares. La cicatriz hipertrófica se mantiene dentro de los bordes y tiende a mejorar. El tratamiento incluye corticoides intralesionales, presoterapia y silicona; la exéresis aislada recidiva.

811 sin clase · Perfil V3 6.01.2.008 · Loxocelismo · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 89*

Paciente consulta por una lesión en el antebrazo que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico se aprecia una placa livedoide en el antebrazo, con zonas violáceas e isquémicas alternadas con áreas pálidas y halo eritematoso.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Loxoscelismo cutáneo

B) Necrosis grasa

C) Ectima

D) Pioderma gangrenoso

E) Fasceítis necrotizante

> **Respuesta A.** Una lesión inicialmente dolorosa que en horas evoluciona a placa livedoide (zonas violáceas, pálidas y eritematosas) es la mordedura de araña de rincón (Loxosceles laeta). Se maneja con frío local, analgesia, antihistamínico y profilaxis antitetánica, y se controla a las 24 a 48 horas buscando hemólisis y hematuria (loxoscelismo cutáneo-visceral).

812 sin clase · Perfil V3 6.01.3.002 · Higiene de la vivienda y profilaxis del loxoscelismo · *Práctica*

Familia de una zona rural consulta por haber encontrado arañas de rincón (Loxosceles laeta) en su casa. Preguntan cómo prevenir mordeduras.

¿Cuál es la medida de prevención más adecuada?

A) Mantener la casa a oscuras y cerrada

B) Usar insecticida una vez al año como única medida

C) Aseo frecuente detrás de muebles y cuadros, separar camas de la pared, sacudir ropa, zapatos y toallas antes de usarlas, y evitar acumular objetos

D) Dormir con la ropa del día

E) Eliminar a las arañas tigre (Scytodes), que son sus predadoras

> **Respuesta C.** La araña de rincón es nocturna y vive en lugares oscuros y tranquilos (detrás de cuadros, muebles, ropa guardada); la mayoría de las mordeduras ocurren al vestirse o en la cama. Se previene con aseo frecuente moviendo muebles, camas separadas de la pared y sacudir ropa y calzado. La araña tigre es su predador natural.

Banco · sin clase · Oftalmología

813 sin clase · Perfil V3 6.02.1.025 · Tumores de conjuntiva · *Práctica*

Hombre de 65 años, agricultor, con una lesión en la conjuntiva bulbar temporal del ojo izquierdo, en el limbo, de crecimiento progresivo en 6 meses. Es gelatinosa, blanquecina, con vasos nutricios prominentes y áreas de leucoplaquia. Tiene antecedente de VIH.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lubricantes y control anual, porque es un pterigion

B) Antibiótico tópico por 7 días

C) Derivar a oftalmología para biopsia excisional por sospecha de neoplasia escamosa de la superficie ocular

D) Corticoide tópico

E) Crioterapia en atención primaria

> **Respuesta C.** Una lesión conjuntival limbar gelatinosa o leucoplásica, con vasos nutricios y crecimiento progresivo, en un adulto mayor con exposición solar o inmunosupresión (VIH), sugiere neoplasia escamosa de la superficie ocular (displasia a carcinoma). Se deriva para biopsia excisional. A diferencia del pterigion, no es triangular nasal ni típicamente horizontal, y crece rápido.

Banco · sin clase · Otorrinolaringología

814 sin clase · Perfil V3 6.03.2.014 · Otohematoma · *Práctica*

Hombre de 22 años, practicante de lucha libre, consulta por aumento de volumen fluctuante, violáceo y doloroso en la cara anterior del pabellón auricular derecho, tras un golpe hace 24 horas. Borra los relieves del pabellón.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Drenaje del hematoma (punción o incisión) y vendaje compresivo, para evitar la deformidad en "oreja en coliflor"

B) Hielo y control en 1 semana

C) Antibiótico oral solamente

D) Esperar reabsorción espontánea

E) Cirugía reconstructiva electiva en 6 meses

> **Respuesta A.** El otohematoma es la colección de sangre entre el pericondrio y el cartílago auricular tras un trauma. Como el cartílago se nutre del pericondrio, si no se drena precozmente se produce necrosis, infección (pericondritis) y fibrosis con deformidad permanente (oreja en coliflor). Se drena y se aplica compresión para evitar la recolección, con control y antibiótico según el caso.

815 sin clase · Perfil V3 6.03.5.005 · Drenaje de otohematoma · *Práctica*

Se decide drenar en el servicio de urgencia un otohematoma de 12 horas de evolución en la cara anterior del pabellón auricular de un adulto.

¿Cuál es el paso más importante después de evacuar el contenido?

A) Aplicar un vendaje compresivo moldeado al relieve del pabellón (o puntos de colchonero con soporte) para evitar la recolección, y control en 24 a 48 horas

B) Dejar el pabellón descubierto para vigilar

C) Aplicar calor local

D) Indicar gotas óticas

E) Cerrar la incisión con sutura continua hermética sin compresión

> **Respuesta A.** El drenaje del otohematoma se realiza con técnica aséptica, bajo anestesia local, mediante punción-aspiración o incisión siguiendo los pliegues del pabellón. Lo más importante después es la compresión moldeada (gasas, férulas o puntos de colchonero transfixiantes con rollos) para que el pericondrio vuelva a adherirse al cartílago y no se reacumule la sangre. Se controla precozmente y se considera antibiótico.

Banco · sin clase · Salud pública

816 sin clase · Perfil V3 7.01.3.007 · Demografía y salud pública · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 13*

Una localidad de la zona norte del país experimenta un aumento significativo de migrantes debido a un programa de incentivos laborales y subsidios económicos, el cual exige una permanencia mínima de 5 años y atrae principalmente a parejas jóvenes y niños.

¿Cuál de los siguientes cambios demográficos es esperable?

A) Aumento de la expectativa de vida de la población

B) Aumento de la tasa bruta de mortalidad

C) Aumento de la tasa bruta de natalidad

D) Aumento de la tasa de mortalidad infantil

E) Aumento de la prevalencia de cánceres ginecológicos

> **Respuesta C.** La llegada de población joven en edad reproductiva rejuvenece la estructura por edad: aumentan los nacimientos respecto de la población total, elevando la tasa bruta de natalidad, y tiende a bajar la tasa bruta de mortalidad. La esperanza de vida y la mortalidad infantil dependen de las condiciones de vida y atención, no de la estructura etaria.

817 sin clase · Perfil V3 7.01.3.041 · Conceptos de administración y gestión · *Práctica*

Dos CESFAM implementan el mismo programa de control de hipertensión y ambos logran que el 70% de sus pacientes alcance la meta de presión arterial. Sin embargo, el CESFAM A lo consigue con la mitad del costo y de horas profesionales que el CESFAM B.

¿Qué atributo de gestión es mayor en el CESFAM A?

A) Eficacia

B) Equidad

C) Efectividad

D) Eficiencia

E) Cobertura

> **Respuesta D.** Eficacia es lograr el resultado en condiciones ideales; efectividad, lograrlo en condiciones reales; y eficiencia, la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Ambos centros tienen igual efectividad, pero el A obtiene el mismo resultado con menos recursos, por lo que es más eficiente.

818 sin clase · Perfil V3 7.01.3.042 · Planificación y programación en salud · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 4*

En la gestión de salud se distinguen distintos niveles de planificación de las acciones.

En gestión de salud, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación?

A) La planificación se refiere a objetivos y recursos específicos, mientras que la programación es global

B) La planificación es a largo plazo, mientras que la programación es anual

C) La programación, a diferencia de la planificación, debe ser concordante con la misión y la visión de la institución

D) La planificación se basa en lo determinado con la programación

E) La planificación se relaciona con los costos y recursos de actividades concretas y la programación con el presupuesto general del proyecto

> **Respuesta B.** La planificación es el proceso global y estratégico, a mediano o largo plazo, que define objetivos y prioridades. La programación la operacionaliza en el corto plazo, habitualmente anual, detallando actividades, metas, recursos y responsables. Por eso la programación deriva de la planificación, y no al revés.

819 sin clase · Perfil V3 7.01.3.043 · Formulación de programas · *Práctica*

Un CESFAM formula su programa de inmunizaciones de invierno. Entre sus componentes escribe: vacunar contra la influenza al 85% de los adultos de 65 años y más inscritos, antes del 30 de junio.

¿A qué componente del programa corresponde este enunciado?

A) Misión institucional

B) Objetivo general

C) Actividad

D) Meta

E) Diagnóstico

> **Respuesta D.** Un programa se formula con diagnóstico, objetivos (general y específicos), metas, actividades, recursos y evaluación. La meta es un objetivo cuantificado en magnitud, plazo y población: cuánto, a quiénes y para cuándo. El objetivo general es más amplio (reducir la morbimortalidad por influenza) y la actividad es la acción concreta (vacunar en operativos).

820 sin clase · Perfil V3 7.01.3.044 · Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones · *Práctica*

En un hospital, los técnicos en enfermería de un servicio reciben instrucciones contradictorias de la enfermera supervisora, del jefe de servicio y del jefe de turno médico, lo que genera confusión y errores.

¿Qué principio de la organización se está vulnerando?

A) Delegación de autoridad

B) Tramo de control

C) Descentralización

D) Especialización

E) Unidad de mando

> **Respuesta E.** La unidad de mando establece que cada trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe directo, para evitar instrucciones contradictorias. El tramo de control se refiere al número de subordinados que un jefe puede dirigir eficazmente; la delegación, a transferir autoridad hacia niveles inferiores; y la especialización, a la división del trabajo.

821 sin clase · Perfil V3 7.01.3.045 · Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación · *Real EUNACOM · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 120*

Se produce un accidente de tránsito de alta energía fuera del horario laboral, en el que un grupo de pacientes resulta lesionado de gravedad. Son trasladados al servicio de urgencia, donde los recibe el médico de turno y son hospitalizados para su tratamiento médico y quirúrgico. La prensa exige información inmediata sobre el estado de los pacientes.

¿Quién debe realizar esta comunicación?

A) El médico de turno

B) El director del hospital

C) El encargado de relaciones públicas del hospital

D) La enfermera jefe del servicio de urgencia

E) El personal administrativo del hospital

> **Respuesta B.** La comunicación oficial de la institución hacia los medios es una función de la dirección: corresponde al director del hospital o a quien él designe como vocero, resguardando la confidencialidad de los pacientes (Ley 20.584). El médico de turno informa a los pacientes y familiares, no a la prensa; relaciones públicas apoya, pero no es la autoridad.

822 sin clase · Perfil V3 7.01.3.055 · Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud · *Práctica*

El director de un hospital revisa los indicadores de gestión de camas del último trimestre. Quiere conocer qué porcentaje de las camas disponibles estuvo efectivamente ocupado durante el período.

¿Qué indicador debe revisar?

A) Índice de rotación

B) Promedio de días de estada

C) Índice ocupacional

D) Letalidad hospitalaria

E) Intervalo de sustitución

> **Respuesta C.** El índice ocupacional es días-cama ocupados dividido por días-cama disponibles, por 100. El promedio de días de estada mide cuántos días permanece cada paciente; el índice de rotación, cuántos egresos genera cada cama en el período; y el intervalo de sustitución, el tiempo que una cama queda desocupada entre un egreso y el siguiente ingreso.

Banco · sin clase · Diabetes y nutrición

823 psiq-15 · Perfil V3 1.02.2.004 · Déficit agudo de tiamina · *Práctica*

Un hombre de 45 años, con consumo crónico de alcohol y operado de bypass gástrico hace 1 año, es traído por confusión, marcha atáxica y visión doble de 1 semana. Al examen tiene nistagmo y paresia bilateral del VI par. La glicemia capilar es 65 mg/dL.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Administrar suero glucosado y luego evaluar

B) Administrar tiamina endovenosa antes o junto con la glucosa

C) Solicitar RM de encéfalo y esperar el resultado

D) Iniciar vitamina B12 intramuscular

E) Indicar haloperidol para la confusión

> **Respuesta B.** Confusión, ataxia y oftalmoplejía en un alcohólico o post cirugía bariátrica es encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, una urgencia. Se da tiamina endovenosa en dosis altas antes o junto con la glucosa, porque la glucosa sola consume la tiamina residual y puede empeorar el cuadro. El diagnóstico es clínico.

Banco · sin clase · Neurología

824 psiq-16 · Perfil V3 1.10.2.002 · Complicaciones neurológicas de abuso de sustancias · *Práctica*

Hombre de 29 años es traído a urgencia 1 hora después de consumir cocaína por cefalea súbita intensa y hemiparesia izquierda. PA 210/120 mmHg.

¿Cuál es el examen más importante a realizar de inmediato?

A) Electroencefalograma

B) Punción lumbar

C) TAC de cerebro sin contraste

D) Toxicológico en orina como único examen

E) Ecocardiograma

> **Respuesta C.** La cocaína produce vasoconstricción, crisis hipertensivas y vasculitis, causando ACV isquémico, hemorragia intracerebral y subaracnoidea en jóvenes, además de convulsiones. Ante un déficit focal agudo se realiza de inmediato una TAC de cerebro sin contraste para distinguir hemorragia de isquemia. La agitación y la hipertensión se manejan con benzodiacepinas, evitando betabloqueadores.

Banco · sin clase · Pediatría general

825 psiq-18 · Perfil V3 2.01.1.082 · Síndrome déficit atencional · *Práctica*

Un niño de 7 años es derivado por su profesora porque no termina sus tareas, se distrae, se levanta constantemente y interrumpe en clases desde hace un año. Los padres refieren que en la casa es igual: pierde sus cosas, no espera turnos y no logra jugar tranquilo.

Para diagnosticar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿qué elemento es indispensable?

A) Un electroencefalograma alterado

B) Una resonancia magnética cerebral alterada

C) Síntomas presentes en dos o más contextos, por al menos 6 meses, con inicio antes de los 12 años

D) Una respuesta positiva a una prueba con metilfenidato

E) Rendimiento escolar insuficiente en todas las asignaturas

> **Respuesta C.** El diagnóstico de TDAH es clínico (DSM-5): síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad persistentes por 6 meses o más, presentes en al menos dos ambientes (casa y colegio), iniciados antes de los 12 años y con deterioro funcional, no explicados por otro trastorno. No requiere exámenes. La respuesta al metilfenidato no confirma el diagnóstico.

826 psiq-18 · Perfil V3 2.01.1.085 · Trastornos aprendizaje · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 87*

Un niño de 7 años perdió el año escolar. Presenta dificultades en la lectoescritura, invierte fonemas con frecuencia, es muy lento para leer y le cuesta deletrear. Su padre no terminó el colegio porque tenía problemas similares.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Coeficiente intelectual limítrofe

B) Trastorno oposicionista desafiante

C) Trastorno por déficit atencional

D) Dislexia

E) Trastorno del desarrollo

> **Respuesta D.** Dificultad específica y persistente en la lectura (lenta, con inversiones y errores de decodificación) y en el deletreo, con antecedente familiar, corresponde a dislexia, el trastorno específico del aprendizaje más frecuente. Su base es fonológica y tiene fuerte componente hereditario. El TDAH afecta el rendimiento global por inatención, no específicamente la decodificación lectora.

827 psiq-18 · Perfil V3 2.01.1.139 · Trastornos de alimentación · *Práctica*

Una adolescente de 15 años ha bajado 12 kg en 5 meses mediante restricción alimentaria y ejercicio excesivo. Se percibe gorda pese a tener IMC de 15. Tiene amenorrea de 3 meses. Al examen: FC 42/min, PA 80/50 mmHg, temperatura 35,6 °C y ortostatismo. Exámenes: potasio 2,9 mEq/L y fósforo 2,4 mg/dL.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Manejo ambulatorio con nutricionista y psicólogo

B) Indicar anticonceptivos orales por la amenorrea

C) Iniciar fluoxetina y control en un mes

D) Indicar suplemento hipercalórico en domicilio y control en 2 semanas

E) Hospitalizar para estabilización médica y realimentación progresiva

> **Respuesta E.** Anorexia nerviosa con inestabilidad médica (bradicardia menor a 50/min, hipotensión, hipotermia, ortostatismo, hipokalemia e hipofosfemia) es indicación de hospitalización. La realimentación debe ser progresiva y monitorizada por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia, hipokalemia, arritmias e insuficiencia cardíaca), con equipo multidisciplinario. Los anticonceptivos no tratan la amenorrea hipotalámica.

828 psiq-18 · Perfil V3 2.01.1.142 · Trastornos neuropsiquiátricos · *Práctica*

Un niño de 9 años presenta desde hace 18 meses parpadeo repetitivo, muecas faciales y movimientos bruscos del cuello, además de carraspeo y emisión de sonidos guturales. Los movimientos aumentan con el estrés, disminuyen al concentrarse y puede suprimirlos brevemente. Su examen neurológico es normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Corea de Sydenham

B) Trastorno obsesivo compulsivo

C) Epilepsia mioclónica juvenil

D) Síndrome de Tourette

E) Distonía aguda

> **Respuesta D.** Tics motores múltiples y al menos un tic vocal, de más de 1 año de evolución, iniciados antes de los 18 años, que pueden suprimirse voluntariamente en forma transitoria, corresponden a síndrome de Tourette. Se asocia frecuentemente a TDAH y TOC. La corea de Sydenham da movimientos irregulares no suprimibles tras una infección estreptocócica; las mioclonías epilépticas no son suprimibles.

Banco · sin clase · Psiquiatría general

829 psiq-18 · Perfil V3 5.01.1.023 · Trastorno del espectro autista · *Real EUNACOM · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 1*

Paciente de 20 años presenta episodios de descontrol y agresividad en los que rompe objetos, grita y amenaza con agredir y autoagredirse. Se molesta mucho cuando le cambian sus cosas de lugar y tiene rutinas muy marcadas que le cuesta modificar. Abandonó la secundaria tras reprobar dos veces primero medio. Tiene muy buena memoria, al punto de memorizar códigos de barras de productos. Desde niño fue considerado raro, no entablaba amistades, jugaba solo siempre con el mismo juguete y veía repetidamente sus dos películas favoritas. Saluda de manera extraña, con aleteo de sus extremidades superiores.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia

B) Trastorno bipolar

C) Trastorno de personalidad limítrofe

D) Trastorno del espectro autista

E) Trastorno estereotipado del movimiento

> **Respuesta D.** El trastorno del espectro autista combina déficit persistente en la comunicación e interacción social desde la infancia con patrones restringidos y repetitivos: rutinas rígidas, intereses intensos, estereotipias motoras como el aleteo. Los episodios de descontrol ante cambios son frecuentes. El trastorno estereotipado del movimiento no explica el déficit social.

830 psiq-18 · Perfil V3 5.01.1.024 · Trastorno específico del aprendizaje escolar · *Práctica*

Niño de 8 años, en tercero básico, derivado por bajo rendimiento en lenguaje. Lee lento, con omisiones e inversiones de letras y mala comprensión lectora, pese a apoyo escolar por un año. Su rendimiento en matemáticas es adecuado. La evaluación con WISC muestra un coeficiente intelectual de 102, y su audición y visión son normales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Discapacidad intelectual leve

B) Trastorno del espectro autista

C) Trastorno por déficit atencional

D) Trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura

E) Trastorno del desarrollo del lenguaje expresivo

> **Respuesta D.** El trastorno específico del aprendizaje es una dificultad persistente en una habilidad académica (lectura, escritura o cálculo), muy por debajo de lo esperado, pese a intervención, con inteligencia normal y sin déficit sensorial que lo explique. La dislexia es la forma más frecuente. Un CI normal descarta discapacidad intelectual.

831 psiq-18 · Perfil V3 5.01.1.025 · Retardo mental · *Práctica*

Niño de 7 años con retraso del lenguaje desde los 2 años. En el colegio no logra aprender a leer, requiere ayuda para vestirse y le cuesta seguir instrucciones de 2 pasos. La evaluación con WISC muestra un coeficiente intelectual total de 60, con perfil homogéneamente descendido.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Discapacidad intelectual leve

B) Discapacidad intelectual moderada

C) Discapacidad intelectual grave

D) Inteligencia limítrofe

E) Trastorno específico del aprendizaje

> **Respuesta A.** La discapacidad intelectual (antes retardo mental) requiere déficit intelectual y adaptativo de inicio en el desarrollo. Por CI se clasifica en leve (50-69), moderada (35-49), grave (20-34) y profunda (bajo 20); la inteligencia limítrofe es 70-84. DSM-5 gradúa además por funcionamiento adaptativo. Con CI de 60 y déficit adaptativo, es leve.

832 psiq-18 · Perfil V3 5.01.1.026 · Enuresis · *Práctica*

Niño de 7 años, traído porque moja la cama 4 noches por semana. Nunca ha estado seco por más de 6 meses. No tiene síntomas urinarios diurnos ni constipación, su examen físico es normal y el examen de orina es normal. La familia lo reta cada mañana.

¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Derivar a urología para cistoscopía

B) Iniciar imipramina

C) Solicitar ecografía renal y uretrocistografía miccional

D) Iniciar oxibutinina

E) Educación a la familia, eliminar castigos y medidas conductuales como calendario y micción antes de dormir

> **Respuesta E.** Enuresis nocturna primaria monosintomática: se diagnostica desde los 5 años. Con examen y orina normales no requiere estudio de imágenes. Se inicia con educación, eliminar castigos y medidas conductuales; si persiste, la alarma de enuresis o la desmopresina son las terapias de primera línea. La imipramina ya no se usa por su cardiotoxicidad.

833 psiq-18 · Perfil V3 5.01.1.030 · Trastorno conducta oposicionista desafiante · *Práctica*

Niño de 8 años traído por sus padres porque, desde hace 8 meses, discute constantemente con los adultos, se niega a cumplir normas en casa y en el colegio, molesta deliberadamente a otros, se enoja con facilidad, es rencoroso y culpa a los demás de sus errores. No ha agredido físicamente a personas ni animales, no ha robado ni destruido propiedad.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno explosivo intermitente

B) Trastorno disocial

C) Trastorno por déficit atencional

D) Trastorno negativista desafiante (oposicionista)

E) Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

> **Respuesta D.** El trastorno negativista desafiante es un patrón de al menos 6 meses de ánimo irritable, conducta desafiante y vengativa contra figuras de autoridad, sin violar derechos básicos de otros. Si hubiera agresión, robos, destrucción o crueldad sería trastorno disocial. El tratamiento de primera línea es el entrenamiento parental.

834 psiq-18 · Perfil V3 5.01.1.031 · Trastorno conducta disocial · *Real EUNACOM · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 145*

En el servicio de urgencia usted evalúa a un niño de 11 años que se ha comportado muy agresivo, autoagrediéndose y golpeando a su madre. Ella fue citada al colegio por las malas notas y el comportamiento inapropiado de su hijo: el director le informó que había insultado y agredido a sus compañeros y a uno de sus profesores. Tras ser confrontado por su madre, el niño la agredió y luego se infligió cortes en los brazos. Además, su abuela refiere que el niño miente y le ha robado alcohol y cigarrillos de su tienda.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disocial

B) Trastorno de personalidad limítrofe

C) Trastorno del espectro autista

D) Trastorno por déficit atencional

E) Trastorno oposicionista desafiante

> **Respuesta A.** El trastorno disocial es un patrón persistente de violación de los derechos de otros y de normas sociales: agresión a personas, destrucción, engaño o robo. Aquí hay agresión a pares, profesor y madre, mentiras y robos. El oposicionista desafiante no incluye agresión física ni robos, y los trastornos de personalidad no se diagnostican a los 11 años.

835 psiq-18 · Perfil V3 5.01.1.033 · Trastornos ansiosos en niños · *Práctica*

Niño de 7 años, desde hace 3 meses llora intensamente y se queja de dolor de estómago cada vez que debe separarse de su madre para ir al colegio. Teme que a ella le pase algo malo mientras está lejos, no quiere dormir solo y tiene pesadillas sobre perderse. En casa, junto a su madre, juega con normalidad.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada

B) Trastorno de ansiedad social

C) Trastorno de ansiedad por separación

D) Mutismo selectivo

E) Trastorno de pánico

> **Respuesta C.** La ansiedad por separación es miedo excesivo e inapropiado para la edad a separarse de las figuras de apego, con preocupación por que les ocurra algo, rechazo escolar, negativa a dormir solo, pesadillas y síntomas somáticos; en niños dura al menos 4 semanas. Se trata con terapia cognitivo-conductual y trabajo con padres.

836 psiq-16 · Perfil V3 5.01.1.035 · Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes · *Práctica*

Adolescente de 15 años, en su control de salud joven, refiere que fuma marihuana con amigos los fines de semana desde hace 6 meses y que a veces bebe alcohol en fiestas. Usted quiere tamizar el riesgo de consumo problemático con un instrumento validado para su edad.

¿Qué instrumento es el más adecuado?

A) Test de Fagerström

B) AUDIT

C) CAGE

D) CRAFFT

E) Minimental

> **Respuesta D.** El CRAFFT es el instrumento de tamizaje validado para consumo de alcohol y drogas en adolescentes; 2 o más respuestas positivas indican riesgo y requieren intervención breve o derivación. El AUDIT y el CAGE fueron diseñados para alcohol en adultos y el Fagerström mide dependencia a la nicotina.

837 psiq-17 · Perfil V3 5.01.3.010 · Personalidad: Concepto y medición. Principales teorías en psicología de la personalidad · *Práctica*

En una clase sobre personalidad se explica que esta resulta de la interacción de dos componentes: uno de base biológica, heredable, presente desde los primeros meses de vida y relativamente estable, y otro adquirido por aprendizaje, cultura y experiencias.

¿Cómo se denomina el componente biológico y heredable de la personalidad?

A) Rasgo patológico

B) Carácter

C) Mecanismo de defensa

D) Estado de ánimo

E) Temperamento

> **Respuesta E.** La personalidad integra temperamento y carácter. El temperamento es la base constitucional, heredable y observable desde la infancia (por ejemplo, reactividad o búsqueda de novedad, según Cloninger). El carácter se moldea por el aprendizaje y el entorno. Los rasgos de personalidad se evalúan con instrumentos como el MMPI o el modelo de los cinco grandes factores.

838 psiq-16 · Perfil V3 5.01.3.011 · Prevención: Alcohol, tabaco, drogas. Modelo de prevención primaria. · *Práctica*

Una comuna implementa en todos sus colegios, desde quinto básico, un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales y de información sobre alcohol y drogas, dirigido a todos los estudiantes, la mayoría de los cuales nunca ha consumido.

¿A qué tipo de prevención corresponde esta estrategia?

A) Prevención secundaria

B) Prevención primaria indicada

C) Prevención primaria universal

D) Prevención terciaria

E) Reducción de daños

> **Respuesta C.** La prevención primaria busca evitar o retrasar el inicio del consumo. Es universal cuando se dirige a toda una población sin seleccionar por riesgo, como un programa escolar; selectiva si apunta a grupos de riesgo, e indicada si se dirige a personas con consumo inicial o señales tempranas. La detección y tratamiento precoz es prevención secundaria.

839 psiq-16 · Perfil V3 5.01.4.002 · Exámenes de orina para el control de drogas de abuso · *Práctica*

Hombre de 25 años, en un programa de tratamiento por consumo de sustancias, refiere estar abstinente de todas las drogas desde hace 3 semanas. Sin embargo, su examen de orina resulta positivo. Previamente era consumidor diario de varias sustancias.

¿Qué sustancia puede mantenerse positiva en orina por varias semanas después del último consumo en un consumidor crónico?

A) Alcohol

B) Cocaína

C) Cannabis

D) Anfetaminas

E) Heroína

> **Respuesta C.** Los metabolitos del cannabis (THC-COOH) son liposolubles y se acumulan en el tejido graso, por lo que en consumidores crónicos pueden detectarse en orina hasta 4 semanas o más. La cocaína (benzoilecgonina), las anfetaminas y los opioides suelen detectarse 2 a 4 días, y el alcohol solo horas.

840 psiq-18 · Perfil V3 5.01.4.004 · Tests WAIS y WISC · *Práctica*

Niño de 9 años, en cuarto básico, con bajo rendimiento global y dificultad para adquirir aprendizajes. El equipo decide medir formalmente su coeficiente intelectual para descartar discapacidad intelectual.

¿Cuál es el instrumento más adecuado?

A) TEPSI

B) Escala de inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS)

C) Minimental test

D) Escala de inteligencia de Wechsler para niños (WISC)

E) EEDP

> **Respuesta D.** El WISC mide el coeficiente intelectual entre los 6 y 16 años, con índices de comprensión verbal, razonamiento, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. El WAIS se aplica desde los 16 años. El TEPSI (2 a 5 años) y la EEDP (0 a 2 años) tamizan desarrollo psicomotor, y el Minimental evalúa deterioro cognitivo en adultos.